

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-07) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Aiuta a controllare sulle fonti ufficiali le novità rilevanti per il bando e per la prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-07

SANITÀ AMMINISTRATIVA E PROFESSIONI SANITARIE

Norme, organizzazione, casi e strumenti per
preparare le prove dei profili amministrativi e sanitari
del servizio sanitario.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per ASL,
aziende ospedaliere, professioni sanitarie, dirigenza e
tecnici sanitari.

Capitale Personale

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Per la tua candidatura controlla sempre il bando, gli allegati e gli avvisi ufficiali della procedura. Per l'uso professionale verifica le disposizioni vigenti e le regole applicabili al caso concreto.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Sanità amministrativa e professioni sanitarie.

Sommario

Norme, organizzazione, casi e strumenti per preparare le prove dei profili amministrativi e sanitari del servizio sanitario.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-SA01	Sanità amministrativa	5 sezioni
M-SA02	Professioni sanitarie	9 sezioni
M-SA03	Dirigenza medica e sanitaria	7 sezioni
M-SA04	Tecnici sanitari e prevenzione	4 sezioni

Verticali del volume

- Infermieristica e professioni sanitarie
- Dirigenza medica/non medica
- TSLB, TSRM, prevenzione

Premessa

Questo volume accompagna la preparazione per sanità amministrativa e professioni sanitarie. I percorsi M-SA01, M-SA02, M-SA03, M-SA04 collegano le materie specialistiche alle prove e agli strumenti di lavoro.

Parti dal bando: individua requisiti, materie, prove e criteri di valutazione. Usa l'indice per scegliere il percorso pertinente e le schede per trasformare lo studio in esercizi, ripassi e simulazioni.

Il volume specialistico si affianca al Metodo BANDO per le basi comuni. I rinvii indicano quali argomenti riprendere; gli strumenti cartacei permettono di lavorare anche senza piattaforma digitale.

Indice completo

M-SA01

Sanità amministrativa

Cap. 1	SSN, aziende sanitarie, atti e flussi informativi	9
Cap. 2	Documentazione sanitaria, accesso, privacy e conservazione	41
Cap. 3	Front-office e comunicazione con l'utenza sanitaria	62
Cap. 4	Contabilità, budget e controllo di gestione nelle aziende sanitarie	82
Cap. 5	Procurement sanitario, farmaci, dispositivi e magazzino	112

M-SA02

Professioni sanitarie

Cap. 6	Professioni sanitarie: profili, requisiti e prove	143
Cap. 7	Discipline professionali: autonomia, responsabilità e deontologia	155
Cap. 8	Assistenza infermieristica, tecniche assistenziali e supporto OSS	173
Cap. 9	Valutazione clinica, triage, urgenza ed emergenza	197
9.1	Valutazione iniziale, priorità e rivalutazione	198
9.2	Deterioramento clinico, NEWS2 e sepsi	200
9.3	Triage e gestione dinamica della priorità	203
9.4	Team dell'emergenza, comunicazione e sicurezza	206
9.5	Arresto cardiaco nell'adulto: quadro BLS e ALS	209
9.6	Neonato e supporto vitale	211
9.7	Allarmi ostetrici e risposta multidisciplinare	213
Cap. 10	Prevenzione, continuità assistenziale e presa in carico	222
Cap. 11	Evidenze scientifiche, PICO, GRADE e applicabilità	244
Cap. 12	Igiene pubblica, epidemiologia, sorveglianza e screening	266
Cap. 13	Controlli TPALL, verbalizzazione, campionamento e sanzioni	280
Cap. 14	Prova pratica e casi professionali	298

CAPITALE PERSONALE

M-SA03

Dirigenza medica e sanitaria

Cap. 15	Profili, requisiti e prove della dirigenza sanitaria	315
Cap. 16	Programmazione sanitaria e organizzazione dei servizi	331
Cap. 17	Linee guida, appropriatezza e decisioni cliniche	338
Cap. 18	Governo clinico, HTA, qualità, accreditamento e rischio	342
Cap. 19	Epidemiologia e sanità pubblica per la dirigenza	350
Cap. 20	Dirigenza medica: discipline e casi	361
Cap. 21	Dirigenza sanitaria non medica: discipline e casi	368

M-SA04

Tecnici sanitari e prevenzione

Cap. 22	TSLB e TSRM: profili, requisiti, prove e responsabilità	381
Cap. 23	TSLB: processo di laboratorio, qualità e biosicurezza	395
Cap. 24	TSRM: imaging, dosimetria e radioprotezione	416
Cap. 25	Tecnologie, dispositivi, apparecchiature e rischio tecnologico	439

M-SA01

Sanità amministrativa

Sezione interna del volume VOL-07 — Sanità amministrativa e professioni sanitarie.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 SSN, aziende sanitarie, atti e flussi informativi; 2 Documentazione sanitaria, accesso, privacy e conservazione
Sviluppo	3 Front-office e comunicazione con l'utenza sanitaria; 4 Contabilità, budget e controllo di gestione nelle aziende sanitarie
Allenamento	5 Procurement sanitario, farmaci, dispositivi e magazzino

SSN, aziende sanitarie, atti e flussi informativi

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Il Servizio sanitario nazionale definisce garanzie di assistenza, distribuisce responsabilità tra Stato, Regioni e aziende e collega risorse, servizi e controlli. Il capitolo parte da questi fondamenti: principi del SSN, vertici aziendali, LEA, integrazione sociosanitaria e rapporti con gli erogatori. Da qui passa agli strumenti con cui l'azienda opera ogni giorno: competenze, procedimenti, atti e flussi informativi.

In un'azienda sanitaria la decisione amministrativa e il dato non percorrono strade separate. Un provvedimento può dipendere da informazioni su attività, costi o prestazioni; un flusso informativo, a sua volta, nasce da operazioni svolte da strutture e persone alle quali sono attribuiti compiti e responsabilità. Se non è chiaro chi deve fare che cosa, il procedimento diventa opaco. Se il dato è incompleto o incoerente, anche una decisione formalmente ben scritta può poggiare su una base fragile.

Per un candidato a un profilo amministrativo non serve memorizzare il nome di ogni ufficio o il calendario di ogni trasmissione. Nomi, deleghe, passaggi operativi e specifiche tecniche possono cambiare tra Regioni, enti e versioni dei disciplinari. Deve invece padroneggiare due catene di ragionamento:

1. funzione → competenza → procedimento → atto → motivazione → conoscibilità → controllo;
2. finalità informativa → origine del dato → alimentazione → controllo → validazione → trasmissione → uso.

Con queste due catene si possono affrontare una domanda orale, una risposta sintetica, uno schema di procedimento, la predisposizione guidata di un atto o un caso su un'anomalia informativa. Una risposta corretta non inventa la soluzione locale: distingue ciò che deriva dalla cornice nazionale, ciò che dipende dalla disciplina regionale e ciò che deve essere verificato nell'organizzazione della singola azienda.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo dovrai saper:

- spiegare principi del SSN, aziendalizzazione, funzioni dei vertici e differenze tra gli organi aziendali;
- collegare LEA, servizi territoriali e ospedalieri, programmazione e integrazione sociosanitaria;
- distinguere autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale anche nei casi sulla remunerazione;
- distinguere il livello nazionale, regionale e aziendale di una regola organizzativa;

- usare correttamente i concetti di ente, organo, ufficio, struttura, responsabile e competenza;
- spiegare la funzione dell'atto aziendale senza confonderlo con un singolo provvedimento;
- ricostruire le fasi essenziali di un procedimento nel contesto sanitario;
- separare attività istruttoria, proposta, controllo, decisione e adozione dell'atto;
- costruire una motivazione essenziale collegando presupposti, istruttoria e scelta;
- bilanciare pubblicità e trasparenza con riservatezza e minimizzazione dei dati;
- spiegare che cosa sono il Nuovo sistema informativo sanitario e un flusso informativo;
- distinguere la Scheda di dimissione ospedaliera dai modelli economici CE e SP;
- valutare completezza, coerenza, correttezza, tempestività e tracciabilità di un dato;
- riconoscere la differenza tra immissione, controllo, correzione, validazione e trasmissione;
- indicare quali elementi richiedono una verifica normativa, regionale, aziendale o tecnica prima di chiudere un caso.

La disciplina generale del procedimento amministrativo è sviluppata in Il Metodo BANDO (VOL-01), Capitolo 5 — Diritto amministrativo operativo. Qui ne riprendiamo gli elementi indispensabili e li applichiamo alla specificità organizzativa e informativa delle aziende sanitarie.

Mappa BANDO

BANDO

Nel programma di concorso cerca formule come: organizzazione del Servizio sanitario nazionale, legislazione sanitaria, atti amministrativi, procedimento, trasparenza, protezione dei dati, sistemi informativi, flussi sanitari, predisposizione di atti, lettura di tabelle o prova teorico-pratica. La presenza di una di queste espressioni non autorizza a studiare ogni dettaglio possibile. Devi collegarla al tipo di profilo, alle prove previste e al livello di approfondimento richiesto.

Nei profili di Assistente ricorrono soprattutto supporto istruttorio, gestione documentale, segreteria, front-office e corretta esecuzione delle attività assegnate. Nei profili di Collaboratore assumono maggior peso elaborazione di atti, analisi, programmazione, acquisti, sistemi informativi o controllo di gestione. La distinzione orienta la complessità dell'output, non elimina la necessità di comprendere l'intera sequenza.

AREE

Il capitolo collega quattro aree:

- organizzazione del Servizio sanitario nazionale e delle aziende;
- diritto amministrativo generale;
- trasparenza, protezione dei dati e documentazione;
- sistemi e flussi informativi sanitari.

Queste quattro aree si tengono insieme: la competenza nasce dall'organizzazione; il procedimento ordina l'azione; l'atto esprime o documenta la decisione; il dato sostiene istruttoria, monitoraggio e controllo.

NUCLEI

Concentrati su livelli delle fonti, atto aziendale, competenza, fasi del procedimento, motivazione, tracciabilità, conoscibilità dell'atto, finalità del flusso, origine del dato, qualità, validazione, trasmissione e uso. SDO, CE e SP servono ad applicare questa mappa; non studiarli come sigle isolate.

DIARIO

Nel diario degli errori registra soprattutto le generalizzazioni:

- «lo decide sempre il direttore generale»;
- «l'atto aziendale è uguale in tutte le aziende»;
- «trasparenza significa pubblicare tutto»;
- «il dato inserito è già validato»;
- «NSIS è un'unica banca dati»;
- «CE e SP coincidono con il bilancio aziendale»;
- «periodicità e scadenze sono sempre le stesse».

Per ogni errore annota la domanda che avresti dovuto porti: quale fonte? quale livello? quale finalità? quale responsabilità?

OUTPUT

Gli output da allenare sono cinque:

1. risposta orale di due minuti sulle due catene;
2. schema verticale di un procedimento;
3. traccia di motivazione di un atto;
4. mappa di un flusso informativo;
5. scheda di controllo della qualità del dato.

ATTENZIONE

Una norma nazionale, una legge regionale e un atto aziendale non sono intercambiabili. La prima definisce la cornice generale; la seconda organizza il servizio nel territorio entro le competenze regionali; il terzo disciplina l'assetto del singolo ente nel rispetto delle fonti sovraordinate. Prima di attribuire una competenza concreta, identifica sempre fonte, territorio, ente e versione applicabile.

I principi del SSN e il riordino delle aziende

LA SALUTE COME DIRITTO E RESPONSABILITÀ PUBBLICA

L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale dell'individuo sia come interesse della collettività. La prima dimensione riguarda la persona che necessita di assistenza; la seconda comprende, per esempio, prevenzione e contrasto dei rischi che interessano la popolazione. La tutela deve rispettare dignità e libertà della persona. La legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha istituito il Servizio sanitario nazionale per dare una risposta pubblica e unitaria ai bisogni di salute, superando il precedente sistema mutualistico legato alle categorie lavorative.

Il SSN comprende prevenzione, cura e riabilitazione. La prevenzione riduce probabilità o conseguenze della malattia; la cura affronta un bisogno già presente; la riabilitazione mira al recupero e al mantenimento delle capacità della persona. Questa ampiezza spiega perché un'amministrazione sanitaria gestisca ospedali ma anche vaccinazioni, assistenza domiciliare, consultori, controlli sugli alimenti e percorsi territoriali.

Tre principi aiutano a risolvere le domande d'esame. L'universalità collega la tutela al bisogno di salute, senza farla dipendere dall'appartenenza a una categoria professionale. L'uguaglianza impedisce discriminazioni nell'accesso; l'equità richiede di considerare bisogni e ostacoli differenti, perché offrire a tutti la stessa modalità formale può lasciare alcune persone prive di assistenza effettiva. La solidarietà sostiene il finanziamento collettivo: il costo delle cure non è posto integralmente sulla singola persona che si ammala.

Per esempio, un servizio accessibile soltanto tramite un'app può risultare formalmente aperto a tutti, ma creare un ostacolo per chi non dispone delle competenze o degli strumenti necessari. Prevedere un canale assistito rende l'accesso più equo. Il personale amministrativo contribuisce alla tutela della salute anche attraverso informazioni corrette, percorsi comprensibili e continuità della presa in carico.

Universalità non significa che qualunque prestazione richiesta sia sempre gratuita. Il sistema garantisce prestazioni definite secondo le regole sui livelli essenziali di assistenza, le condizioni di appropriatezza e gli eventuali ticket, con le esenzioni previste. Una domanda su questo punto richiede di distinguere il diritto di accesso, l'indicazione alla prestazione e la partecipazione al costo. Confonderli porta a promettere al cittadino ciò che l'ufficio non può riconoscere.

STATO, REGIONI E SOGGETTI DEL SISTEMA

Lo Stato determina i livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale, secondo l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La tutela della salute appartiene alla legislazione concorrente: lo Stato stabilisce i principi fondamentali e le Regioni esercitano le proprie competenze legislative e organizzative entro quella cornice. I servizi sanitari regionali attuano la garanzia attraverso aziende, professionisti e altri erogatori ammessi secondo la disciplina applicabile.

Il Ministero della Salute svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale e di tutela della salute nel proprio ambito. L'Istituto superiore di sanità svolge ricerca, controllo e supporto tecnico-scientifico; AGENAS sostiene le politiche e la valutazione dei servizi sanitari; AIFA esercita le funzioni nazionali sui medicinali attribuite dalla legge. Sono ruoli diversi: una valutazione scientifica, un provvedimento sul farmaco e l'organizzazione di un servizio aziendale non provengono necessariamente dallo stesso soggetto.

La Regione programma la rete e governa il proprio sistema sanitario; l'azienda organizza ed eroga servizi, acquista prestazioni e gestisce risorse nel perimetro assegnato. I Comuni partecipano all'integrazione sociosanitaria e rappresentano i bisogni delle comunità nelle sedi previste. Un Comune non assume per questo le funzioni del direttore generale dell'ASL, così come una direttiva nazionale non sostituisce automaticamente tutti gli atti organizzativi aziendali.

CHE COSA CAMBIA CON L'AZIENDALIZZAZIONE

Il D.Lgs. 502/1992, modificato fra l'altro dal D.Lgs. 517/1993 e dal D.Lgs. 229/1999, introduce e sviluppa il riordino aziendale. Le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. L'azienda è quindi un soggetto che assume obblighi e responsabilità, dispone di una propria organizzazione e deve rendere conto della gestione.

L'autonomia consente di organizzare persone, strutture e mezzi per raggiungere gli obiettivi assistenziali. Si accompagna a programmazione, controlli, vincoli economici e responsabilità sui risultati. L'efficacia riguarda il raggiungimento degli obiettivi; l'efficienza il rapporto tra risorse impiegate e risultati; l'economicità la sostenibilità dell'impiego delle risorse nella missione dell'ente. Un ambulatorio che riduce i costi cancellando prestazioni necessarie non dimostra, per ciò solo, una buona gestione sanitaria.

La natura pubblica e la finalità di tutela della salute restano ferme. Il termine aziendalizzazione non autorizza a descrivere l'ASL come un'impresa privata orientata alla distribuzione di utili. Anche l'atto aziendale di diritto privato, previsto per organizzazione e funzionamento, opera nel rispetto dei principi e criteri regionali e della normativa sovraordinata. La sua natura non rende privatistici tutti i provvedimenti dell'azienda.

Occorre poi distinguere i soggetti. L'ASL assicura assistenza alla popolazione del territorio attraverso i servizi e i rapporti previsti dal sistema regionale. L'azienda ospedaliera è un ente autonomo centrato sulla funzione ospedaliera; un presidio ospedaliero inserito in un'ASL resta invece una sua articolazione. L'azienda ospedaliero-universitaria integra assistenza, didattica e ricerca secondo la disciplina specifica. Gli IRCCS svolgono assistenza e ricerca di particolare rilievo e possono avere natura pubblica o privata. Il nome ospedale, da solo, non identifica la personalità giuridica dell'ente.

Direzione aziendale, organi e controlli

IL DIRETTORE GENERALE E I DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO

Nel quadro nazionale del D.Lgs. 502/1992 sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione complessiva e la rappresentanza legale; adotta l'atto aziendale e nomina i responsabili delle strutture operative secondo le regole applicabili. Traduce gli obiettivi assegnati in scelte organizzative e di impiego delle risorse, rispondendo dei risultati.

Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari sul piano organizzativo e igienico-sanitario. Entrambi coadiuvano il direttore generale, partecipano alla direzione dell'azienda e concorrono alle decisioni mediante proposte e pareri, assumendo responsabilità per le funzioni loro attribuite. Il direttore sanitario aziendale non va confuso con il direttore medico di un singolo presidio ospedaliero.

La presenza di un vertice responsabile dell'insieme non elimina le competenze dei dirigenti e dei professionisti. Se un ufficio acquisti istruisce una pratica, la necessità clinica deve essere rappresentata dal servizio competente, la sostenibilità economica deve essere verificata e l'atto deve essere adottato dal soggetto titolare del potere. Dire che il direttore generale risponde della gestione non basta per attribuirgli personalmente ogni firma o ogni valutazione tecnica.

Il D.Lgs. 171/2016 disciplina la selezione dei vertici. Per il direttore generale il sistema parte dall'elenco nazionale degli idonei e prosegue con la selezione regionale per l'incarico; l'iscrizione nell'elenco non attribuisce da sola la nomina. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario attingendo agli elenchi regionali degli idonei, anche di altre Regioni, secondo la disciplina prevista. Il direttore dei servizi sociosanitari va considerato dove sia previsto dalla legislazione regionale, senza trasformarlo in un identico quarto componente obbligatorio di ogni direzione aziendale italiana.

COLLEGIO SINDACALE E COLLEGIO DI DIREZIONE

Il collegio sindacale controlla la regolarità amministrativa e contabile della gestione. Verifica l'amministrazione sotto il profilo economico, vigila sull'osservanza della legge, controlla la tenuta della contabilità e svolge le ulteriori verifiche e relazioni previste. Nel modello nazionale dell'articolo 3-ter dura tre anni ed è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della salute. Gli ordinamenti speciali dei diversi enti vanno sempre qualificati quando il quesito li indica.

La parola sindacale riguarda qui la funzione di controllo. Il collegio non rappresenta i sindacati dei lavoratori e non negozia il contratto collettivo. Neppure sostituisce il servizio che registra le operazioni: chi controlla la regolarità deve poter distinguere il proprio compito dalla gestione controllata.

Il collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, alla programmazione e valutazione dell'attività tecnico-sanitaria e allo sviluppo dell'organizzazione. Offre un apporto collegiale alle scelte che coinvolgono le competenze professionali. Composizione e funzionamento sono disciplinati a livello regionale nel quadro dell'articolo 17; non va inventata una composizione uniforme per tutte le aziende.

Soggetto	Domanda alla quale risponde il suo ruolo
Direttore generale	Quali decisioni complessive e quali risultati gestionali assume l'azienda?
Direttori amministrativo e sanitario	Come sono diretti i rispettivi servizi e quali proposte o pareri competono loro?
Collegio sindacale	La gestione rispetta le regole amministrative e contabili?
Collegio di direzione	Quale contributo delle competenze sanitarie serve a programmare e valutare le attività?

Domanda-trappola: il collegio di direzione approva qualsiasi spesa perché conosce i bisogni clinici? No. Il contributo alla programmazione e al governo clinico non gli trasferisce tutte le competenze amministrative o contabili dell'azienda. Per una spesa concreta restano necessari istruttoria, copertura, competenza e controlli.

LEA e articolazione dei servizi

LA GARANZIA DELLE PRESTAZIONI

I livelli essenziali di assistenza, LEA, individuano le attività, i servizi e le prestazioni che il SSN deve assicurare nelle condizioni definite dalla disciplina nazionale. Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 li organizza in tre macroaree. La prevenzione collettiva e sanità pubblica comprende interventi rivolti alla popolazione e ai rischi collettivi; l'assistenza distrettuale raccoglie una vasta parte dei servizi di prossimità, ambulatoriali e territoriali; l'assistenza ospedaliera riguarda le attività erogate nel relativo ambito.

Le macroaree classificano l'assistenza, non assegnano da sole le firme sugli atti. Una prestazione può inoltre richiedere condizioni specifiche di erogabilità o indicazioni di appropriatezza. Essenziale non significa elementare: una prestazione complessa può rientrare nei LEA, mentre una richiesta semplice può essere estranea alla garanzia o non appropriata nel caso concreto.

L'appropriatezza riguarda la corrispondenza tra bisogno, intervento e modalità di erogazione. Il personale amministrativo verifica i presupposti di propria competenza e indirizza correttamente la pratica; non sostituisce la valutazione clinica con un giudizio personale. Per esempio, può rilevare l'assenza di un documento richiesto, ma non inventare una diversa indicazione medica per far accedere l'utente alla prestazione.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO: PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA

Il D.P.C.M. 7 agosto 2026 e il D.M. 3 agosto 2026, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2026, aggiornano il quadro dei LEA con entrata in vigore il 30 ottobre 2026. Al riferimento temporale del 2 ottobre 2026 sono pubblicati ma non ancora efficaci. Nei quesiti riferiti a questa data non si devono applicare anticipatamente i nuovi elenchi. Per le prove successive conta la disciplina efficace alla data richiesta dal bando.

DISTRETTO, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E OSPEDALE

Il distretto è l'articolazione territoriale attraverso cui l'azienda organizza l'assistenza primaria e coordina servizi sanitari e sociosanitari. Raccorda medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica territoriale, assistenza domiciliare e altre attività pertinenti ai bisogni della popolazione. La sua funzione supera il singolo sportello: deve favorire continuità, accessibilità e integrazione dei percorsi.

Il dipartimento di prevenzione tutela la salute collettiva mediante attività quali prevenzione delle malattie, igiene pubblica, sicurezza degli alimenti, sanità pubblica veterinaria e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nel riparto di competenze previsto. Una campagna vaccinale o un controllo igienico-sanitario vanno quindi collocati nella rete di prevenzione, senza confonderli con la cura ospedaliera del singolo paziente.

L'ospedale assicura attività diagnostiche, terapeutiche e assistenziali che richiedono il relativo livello organizzativo. Il D.M. 70/2015 definisce standard della rete ospedaliera. L'ospedale può essere un presidio di un'azienda oppure appartenere a un ente autonomo: l'organizzazione e la personalità giuridica non si ricavano dal fatto che vi siano reparti e posti letto.

Il D.M. 77/2022 definisce modelli e standard dell'assistenza territoriale. La Casa della comunità facilita accesso e assistenza di prossimità con il concorso di più professioni. La Centrale operativa territoriale, COT, coordina la presa in carico e i passaggi fra servizi e livelli assistenziali. L'Ospedale di comunità offre assistenza intermedia territoriale per bisogni che richiedono un ricovero appropriato a quel setting; non coincide con l'ospedale per acuti. Un nome simile non rende equivalenti le funzioni.

La COT non va presentata al cittadino come un pronto soccorso né la Casa della comunità come un servizio che svolge necessariamente ogni prestazione specialistica. Gli standard nazionali orientano la costruzione della rete; disponibilità, sedi, orari e canali del singolo servizio devono essere verificati nell'organizzazione effettiva. Questo controllo evita un errore amministrativo concreto: inviare una persona verso una prestazione che quella struttura non offre.

Programmazione e integrazione sociosanitaria

DAI BISOGNI AI PROGRAMMI

La programmazione sanitaria parte dai bisogni della popolazione e definisce obiettivi, servizi, risorse e criteri di verifica. Il livello nazionale stabilisce garanzie e indirizzi; quello regionale organizza la rete e distribuisce le risorse nel proprio sistema; quello aziendale traduce tali scelte in attività e responsabilità. Il Piano sanitario nazionale è un istituto previsto dal D.Lgs. 502/1992: citarlo non consente di attribuire automaticamente attualità a un documento relativo a un periodo trascorso. Anche piani settoriali, intese e atti di programmazione hanno un proprio orizzonte temporale.

Il programma delle attività territoriali raccorda bisogni distrettuali, localizzazione dei servizi e risorse, comprese quelle per l'integrazione sociosanitaria. La partecipazione dei Comuni serve a collegare la programmazione sanitaria con le condizioni della comunità. Il budget aziendale, approfondito nel capitolo sulla contabilità sanitaria, assegna poi obiettivi e mezzi ai centri di responsabilità. Scrivere un programma senza risorse o assegnare risorse senza obiettivi rende impossibile valutarne l'esito.

Esempio: aumentano le dimissioni di persone fragili che necessitano di supporto domiciliare. La risposta programmatica deve considerare numero e caratteristiche dei bisogni, capacità dei servizi territoriali, collegamento con i servizi sociali, personale disponibile e tempi di presa in carico. Il solo aumento delle visite non dimostra che il problema sia risolto: occorre verificare se i pazienti ricevono effettivamente un percorso continuo.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIALI NELLO STESSO PERCORSO

L'integrazione sociosanitaria, disciplinata dall'articolo 3-septies del D.Lgs. 502/1992, riguarda i bisogni che richiedono insieme assistenza sanitaria e protezione sociale. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 precisano il quadro delle prestazioni e dei percorsi. L'integrazione evita che una persona venga trattata come una somma di pratiche indipendenti, ciascuna incapace di affrontare il bisogno complessivo.

Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono attività sanitarie che incidono anche sull'autonomia e sulla partecipazione della persona, per esempio attraverso prevenzione o contenimento degli esiti invalidanti di una malattia. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria appartengono al sistema sociale e sostengono la persona in condizioni che influenzano la salute. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria presentano una forte componente terapeutica e sanitaria, rientrano nella garanzia dei LEA e sono assicurate dalle aziende sanitarie.

Questa distinzione orienta competenze e oneri. Non autorizza a dividere sempre la spesa a metà fra ASL e Comune, né ad addebitare indistintamente tutto all'assistito. Tipologia della prestazione, intensità dell'assistenza, fase del percorso e disciplina applicabile determinano il regime. Il personale amministrativo deve identificare questi elementi prima di applicare una quota o indicare chi paga.

La valutazione multidimensionale considera bisogni clinici, funzionali e sociali. Il progetto assistenziale individuale collega obiettivi e interventi, individua responsabilità e prevede verifiche. La componente amministrativa sostiene il percorso acquisendo i documenti necessari, verificando i presupposti di accesso, assicurando i raccordi tra servizi e trattando i dati nei limiti delle rispettive funzioni. Non formula diagnosi e non decide autonomamente l'intensità clinica dell'assistenza.

Caso breve. Una persona dimessa necessita di cure domiciliari e di aiuto nella vita quotidiana. L'ufficio non può rispondere che la dimissione chiude ogni competenza sanitaria. Deve verificare il percorso di presa in carico, il raccordo con il distretto e la valutazione dei bisogni sociali. Le prestazioni vanno qualificate e coordinate; gli oneri si individuano dopo tale qualificazione. La soluzione corretta conserva la continuità senza attribuire all'ASL qualsiasi intervento sociale.

Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali

TRE CONDIZIONI CON EFFETTI DIVERSI

Una struttura che eroga prestazioni sanitarie deve possedere i titoli richiesti per la propria attività. Gli articoli 8-bis e seguenti del D.Lgs. 502/1992 distinguono l'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali. Si tratta di istituti collegati, ma ciascuno risponde a una domanda diversa.

L'autorizzazione riguarda la realizzazione delle strutture e l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie nei casi previsti dall'articolo 8-ter. La realizzazione comporta anche la valutazione di compatibilità con la programmazione; l'esercizio richiede requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. Non è sufficiente verificare l'esistenza materiale dei locali. Né si può generalizzare a ogni intervento la medesima procedura: tipologia, disciplina nazionale e attuazione regionale determinano l'iter.

L'accreditamento istituzionale riconosce l'idoneità a operare per conto del SSN secondo requisiti ulteriori di qualificazione, coerenza con la programmazione e verifiche previste. È distinto sia dall'autorizzazione sia da una certificazione volontaria di qualità. Una struttura autorizzata a esercitare non è automaticamente accreditata; una struttura accreditata non ha automaticamente diritto a essere pagata dal SSN per tutte le prestazioni che decide di produrre.

Gli accordi contrattuali definiscono il rapporto per l'erogazione a carico del SSN: attività, volumi, requisiti di qualità, corrispettivi, limiti e controlli. Consentono di collegare la capacità dell'erogatore ai bisogni programmati e alle risorse disponibili. L'amministrazione deve verificare che la prestazione rendicontata rientri nel rapporto e nelle condizioni applicabili, oltre alla sua effettiva esecuzione.

Istituto	Effetto da ricordare
Autorizzazione	Consente realizzazione o esercizio nel perimetro del titolo e dei requisiti richiesti.
Accreditamento istituzionale	Qualifica il soggetto per operare per conto del SSN.
Accordo contrattuale	Regola attività e remunerazione a carico del SSN.

L'acquisto di prestazioni presso un erogatore accreditato va inoltre distinto dalla fornitura di beni all'azienda. Una gara per dispositivi medici e un accordo per prestazioni ambulatoriali hanno oggetti e discipline differenti, pur richiedendo entrambi programmazione, correttezza dell'istruttoria e controlli.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA DA LEGGERE CON PRECISIONE

L'articolo 36 della legge 193/2024, nel testo coordinato con gli interventi successivi, prevede una sospensione dell'efficacia di specifiche disposizioni: l'articolo 8-quater, comma 7, l'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, e il D.M. 19 dicembre 2022. La collega agli esiti del lavoro nazionale di revisione da sottoporre a intesa e pone come limite il 31 dicembre 2026. Questa previsione non sospende l'intero sistema di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.

Per un quesito che chieda la procedura applicabile in una data concreta, occorre coordinare la disposizione temporale con gli atti nel frattempo efficaci. La distinzione fra i tre istituti resta necessaria: una disciplina transitoria sulla selezione non trasforma un'autorizzazione in un contratto e non crea un diritto automatico al rimborso.

CASO GUIDATO: UNA FATTURA NON BASTA

Un centro privato è autorizzato e accreditato per determinate prestazioni. Presenta all'ASL una fattura e dichiara: «L'accreditamento dimostra che tutte le prestazioni eseguite devono essere pagate». La pratica contiene l'elenco delle prestazioni, ma non l'accordo contrattuale né il periodo di validità dei titoli.

Il primo controllo riguarda l'identità dell'erogatore, l'attività autorizzata e accreditata e la validità dei titoli nel periodo interessato. Si acquisisce poi l'accordo applicabile per verificare oggetto, volumi, limiti economici, condizioni di erogazione e rendicontazione. L'effettiva esecuzione è necessaria, ma non esaurisce l'istruttoria: occorre anche stabilire a quale titolo il relativo onere possa gravare sul SSN.

La nota dell'ufficio deve quindi segnalare l'insufficienza della documentazione e chiedere l'integrazione pertinente. Non può liquidare il totale soltanto perché il centro è accreditato; non può neppure negare indistintamente il pagamento senza ricostruire il rapporto. La conclusione segue l'accertamento dei presupposti. Nel diario degli errori annota: «qualificazione dell'erogatore e diritto alla remunerazione richiedono verifiche distinte».

Verifica: organizzazione sanitaria e garanzie di assistenza

Per ogni quesito scegli una risposta e spiega quale concetto rende errate le altre.

1. Universalità del SSN significa: A) prestazioni riservate ai lavoratori assicurati; B) tutela collegata al bisogno senza appartenenza a una categoria lavorativa; C) gratuità di qualunque prestazione richiesta. Risposta B. A ripropone una logica categoriale; C confonde accesso universale, appropriatezza e disciplina di ticket/esenzioni.
2. L'aziendalizzazione comporta: A) personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa e gestionale nel quadro sanitario; B) trasformazione obbligatoria in società privata; C) soppressione della programmazione regionale. Risposta A. L'autonomia imprenditoriale si esercita per finalità pubbliche e resta accompagnata da indirizzi, vincoli e controlli.
3. Gli organi previsti dalla cornice nazionale aziendale sono: A) DG, DA e DS; B) DG, collegio di direzione e collegio sindacale; C) Regione, ASL e Comune. Risposta B. A indica figure della direzione, ma non l'elenco degli organi; C confonde soggetti istituzionali e organi dell'azienda.
4. Il collegio sindacale: A) negozia il CCNL; B) controlla la regolarità amministrativa e contabile; C) decide le terapie. Risposta B. Il nome non indica rappresentanza dei lavoratori; il controllo non coincide con la responsabilità clinica.
5. Il distretto: A) è sempre un ente con personalità giuridica distinta; B) organizza e coordina l'assistenza territoriale nel sistema aziendale; C) coincide con un reparto ospedaliero. Risposta B. A attribuisce un'autonomia soggettiva non derivante dalla qualifica; C confonde livelli organizzativi.
6. L'integrazione sociosanitaria richiede: A) attribuzione di ogni intervento al Comune; B) divisione automatica della spesa a metà; C) valutazione del bisogno e coordinamento di prestazioni, responsabilità e oneri. Risposta C. La qualificazione della prestazione e del percorso precede l'individuazione del regime economico.

7. Una struttura accreditata presenta prestazioni fuori dall'accordo contrattuale. L'accreditamento: A) basta sempre a imporre il pagamento; B) rende superflua l'autorizzazione; C) non crea da solo un diritto alla remunerazione di quelle prestazioni. Risposta C. Autorizzazione, accreditamento e accordo hanno effetti diversi; la verifica del titolo del pagamento rimane necessaria.
8. Una norma sui LEA è pubblicata ma prevede un'entrata in vigore futura. In un quesito riferito al periodo intermedio: A) si applica subito ogni nuovo elenco; B) si distingue la disciplina efficace dalla modifica futura; C) i LEA sono sospesi. Risposta B. Pubblicazione ed efficacia possono avere date diverse; il nuovo atto non elimina anticipatamente la disciplina applicabile.
9. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli idonei DG: A) attribuisce immediatamente un incarico; B) consente di partecipare alla selezione per il conferimento secondo le regole previste; C) abilita a firmare gli atti di qualsiasi ASL. Risposta B. Idoneità, selezione e nomina sono passaggi distinti.
10. Il collegio di direzione e quello sindacale: A) sono due nomi dello stesso organo; B) svolgono rispettivamente funzioni di apporto al governo delle attività e di controllo amministrativo-contabile; C) sostituiscono entrambi il DG. Risposta B. La distinzione riguarda funzione e responsabilità; il confronto collegiale non elimina la gestione del direttore generale.

Mini-esercizio. Una traccia descrive un ospedale appartenente a un'ASL, un paziente da prendere in carico a domicilio e un centro accreditato disponibile a erogare prestazioni. Scrivi dodici righe che distinguano ente e presidio, individuino il raccordo territoriale e precisino quale rapporto serve a porre le prestazioni del centro a carico del SSN. Autovalutazione: la risposta deve identificare l'ASL come ente, il presidio come articolazione, il distretto e gli eventuali servizi di coordinamento come raccordo della continuità, la valutazione del bisogno come base del percorso e l'accordo contrattuale come elemento da verificare per la remunerazione. Non basta elencare le sigle.

L'azienda sanitaria e la distribuzione delle competenze

INQUADRAMENTO TEORICO: DAL SSN AL LIVELLO AZIENDALE

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha istituito il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 costituisce il riferimento centrale per il processo di aziendalizzazione, l'autonomia, gli organi e l'atto aziendale. Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 individua i livelli essenziali di assistenza nelle grandi aree della prevenzione collettiva e sanità pubblica, dell'assistenza distrettuale e dell'assistenza ospedaliera. Gli standard ospedalieri e territoriali orientano reti, fabbisogni e organizzazione, ma non attribuiscono automaticamente la competenza ad adottare uno specifico provvedimento.

Per ragionare senza confondere i piani, usa questa griglia:

Funzioni e fonti

Livello	Funzione prevalente	Esempio di fonte
Nazionale	definisce principi, cornici, livelli essenziali e regole generali	legge, decreto legislativo, decreto ministeriale, D.P.C.M.
Regionale	programma e organizza il servizio sanitario nel territorio	legge regionale, atto di programmazione o indirizzo
Aziendale	traduce la cornice nell'assetto e nei processi dell'ente	atto aziendale, regolamento, delega o procedura interna

Limiti per livello

Livello	Limite da ricordare
Nazionale	non descrive ogni passaggio interno della singola azienda
Regionale	non può essere esteso automaticamente a un'altra Regione
Aziendale	vale nel perimetro dell'ente e nella versione vigente

Quando una traccia usa un'espressione generica come «azienda sanitaria», non presumere che indichi sempre lo stesso tipo di ente. Azienda sanitaria, azienda ospedaliera, azienda ospedaliero-universitaria e istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sinonimi. Presentano missioni, assetti e fonti organizzative che vanno qualificati nel caso concreto.

ENTE, ORGANO, UFFICIO E STRUTTURA

L'ente è il soggetto organizzato al quale l'ordinamento attribuisce funzioni. L'organo è il centro che può imputare all'ente una volontà o una decisione. L'ufficio è un'unità organizzativa nella quale persone e risorse svolgono attività istruttorie, tecniche, amministrative o di supporto. La struttura è una componente dell'assetto organizzativo, che può essere articolata secondo criteri definiti dalle fonti applicabili. Il responsabile del procedimento cura i compiti attribuiti dalla disciplina del procedimento; non coincide necessariamente con chi adotta l'atto finale.

La competenza delimita il potere o il compito per materia, funzione, territorio, valore o grado. In una prova non basta scrivere che «l'ufficio competente provvede». Occorre indicare come si accerta la competenza:

1. si identifica la funzione da esercitare;
2. si ricostruiscono le fonti nazionali e regionali pertinenti;
3. si consulta l'atto aziendale nella versione applicabile;
4. si verificano regolamenti, deleghe e attribuzioni interne;
5. si distingue il responsabile dell'istruttoria dal soggetto che decide;
6. si registra la fonte organizzativa utilizzata.

Seguendo questi passaggi eviti sia di attribuire ogni decisione all'organo di vertice sia di considerare decisore chi ha soltanto predisposto la pratica.

FUNZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

L'atto aziendale è lo strumento organizzativo con cui l'azienda definisce il proprio assetto entro la cornice nazionale e regionale. Serve a rendere riconoscibili organi, strutture, funzioni e relazioni organizzative. Non è la legge fondamentale del SSN, non è un provvedimento identico per tutte le aziende e non resta immutabile nel tempo.

Per leggerlo in modo professionale prepara una scheda con cinque campi: Regione, ente, data, versione, funzione organizzativa cercata. Se manca uno di questi elementi, la risposta sulla competenza è ancora incompleta. Anche quando l'atto aziendale individua una struttura, potrebbero essere necessari ulteriori atti per conoscere deleghe, sostituzioni, responsabilità e modalità operative.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'atto aziendale organizza il singolo ente entro la cornice nazionale e regionale. La competenza non si ricava dal solo nome dell'ufficio. Chi istruisce può essere diverso da chi propone, controlla o decide. Una fonte organizzativa va letta nella versione vigente e nel suo territorio. Il candidato corretto distingue sempre regola generale e soluzione locale.

Atti aziendali e provvedimenti amministrativi

ATTO AZIENDALE, ATTI ISTRUTTORI E DECISIONE FINALE

La parola atto può indicare oggetti diversi. L'atto aziendale disegna l'organizzazione. Gli atti istruttori raccolgono, verificano o rappresentano elementi utili alla decisione. La proposta formula una soluzione all'esito dell'istruttoria. Il provvedimento finale esprime la decisione del soggetto competente e può produrre effetti esterni o interni secondo la disciplina applicabile.

In un caso concorsuale devi quindi chiederti:

- l'atto che sto esaminando è organizzativo, istruttorio o decisorio?
- chi ne è autore e quale funzione esercita?
- quali presupposti di fatto e di diritto sono stati accertati?
- quale istruttoria sostiene la decisione?
- quali controlli o pareri sono richiesti?
- quali effetti produce e verso chi?

Il nome «determinazione» o «deliberazione» non basta a rispondere. Denominazioni, forme, numerazioni, competenze e sequenze dipendono dall'ordinamento e dall'assetto dell'ente. In assenza di una fonte verificata, è più corretto descrivere l'output come schema di provvedimento e lasciare esplicito il controllo sulla competenza.

LA MOTIVAZIONE COME PONTE

La motivazione collega presupposti, istruttoria e decisione. Deve spiegare perché l'amministrazione ha adottato quella soluzione e su quali elementi ha fondato il proprio ragionamento.

Una traccia essenziale può seguire questa sequenza:

1. competenza: fonte che abilita il soggetto ad agire;
2. presupposti: fatto, esigenza o obiettivo da affrontare;
3. quadro applicabile: norme e atti organizzativi pertinenti;
4. istruttoria: documenti, dati, verifiche, pareri e partecipazione;
5. valutazione: collegamento logico tra elementi raccolti e scelta;
6. decisione: contenuto dell'atto;
7. conoscibilità e tutela dei dati: pubblicazione, comunicazione o accesso nei limiti applicabili;
8. controllo: registrazione, esecuzione e verifiche successive.

Se un dato quantitativo è determinante, la motivazione deve consentire di comprenderne origine, versione e qualità. Una percentuale priva di perimetro, periodo e fonte non diventa affidabile solo perché è inserita nell'atto.

RUBRICA DI CONTROLLO DI UN PROVVEDIMENTO

Prima di consegnare uno schema, assegna un punto a ciascuna voce:

Voce	Domanda di controllo
Competenza	Ho indicato la fonte da verificare per stabilire chi decide?
Presupposti	Ho descritto il problema senza introdurre fatti non disponibili?

Voce	Domanda di controllo
Istruttoria	Ho separato documenti, verifiche, pareri e dati?
Motivazione	La scelta deriva davvero dagli elementi raccolti?
Dispositivo	È chiaro che cosa viene deciso?
Conoscibilità	Ho distinto pubblicazione, comunicazione e accesso?
Riservatezza	Ho escluso o minimizzato dati non necessari?
Controllo	È possibile ricostruire versione, passaggi ed esito?

Una risposta è solida se non nasconde le informazioni mancanti. Se la competenza dipende da una delega non fornita, scrivi che l'adozione è subordinata alla sua verifica; non assegnare una firma per intuizione.

Il procedimento applicato al contesto sanitario

LA SEQUENZA GENERALE

Il procedimento amministrativo è la sequenza ordinata di attività attraverso la quale l'amministrazione prepara e assume una decisione. La Legge 7 agosto 1990, n. 241 ne disciplina gli elementi generali: principi dell'attività, dovere di conclusione, individuazione del responsabile, istruttoria, partecipazione, motivazione, semplificazione, accesso documentale e istituti relativi all'efficacia e alla validità del provvedimento.

Nel contesto sanitario lo schema generale rimane valido, ma va ricordato con l'organizzazione del servizio e con la possibile presenza di valutazioni tecniche, dati relativi alla salute, flussi informativi e regole regionali o aziendali. Diventa quindi ancora più importante identificare competenze, responsabilità e fonti.

La mappa minima è:

avvio → assegnazione della responsabilità → istruttoria → eventuale partecipazione → proposta o determinazione conclusiva → adozione → comunicazione/pubblicità nei limiti applicabili → esecuzione → controllo.

L'avvio può derivare da un'istanza o da un'iniziativa d'ufficio. Il responsabile cura gli adempimenti attribuiti, verifica gli elementi necessari e coordina l'istruttoria. L'istruttoria acquisisce fatti, documenti, pareri e dati. La partecipazione consente agli interessati di far valere elementi pertinenti quando prevista. La decisione deve provenire dal soggetto competente ed essere motivata. Gli adempimenti successivi rendono l'atto conoscibile ed eseguibile secondo le regole applicabili.

ISTRUTTORIA, PROPOSTA, VALIDAZIONE E ADOZIONE

Quattro attività non vanno confuse:

- istruire significa raccogliere e valutare gli elementi necessari;
- proporre significa formulare una soluzione motivata per il decisore;
- validare un dato significa attestare, secondo ruoli e controlli del flusso, che il dato può proseguire nel processo informativo;
- adottare significa assumere la decisione attribuita al soggetto competente.

Una stessa persona può svolgere più attività solo se l'organizzazione lo consente, ma le funzioni restano concettualmente distinte. Distinguere le funzioni rende il processo controllabile e impedisce che un errore di immissione diventi, senza verifica, presupposto della decisione.

IL DELTA SANITARIO

In una pratica sanitaria amministrativa possono entrare bisogni assistenziali, organizzazione di servizi, standard, dati di attività o economici. Il candidato non deve sostituirsi alla valutazione clinica né inventare una competenza tecnica. Deve invece:

1. qualificare l'oggetto amministrativo;
2. individuare quali contributi tecnici sono necessari;
3. verificare chi può produrli o controllarli;
4. distinguere il dato originario dal dato riepilogato;
5. documentare anomalie, correzioni e versioni;
6. motivare la decisione entro le competenze disponibili.

Un parere tecnico non trasferisce automaticamente la competenza ad adottare il provvedimento. Il soggetto decisore, dal canto suo, non dovrebbe presentare come propria una valutazione tecnica non verificata.

GRIGLIA DEL PROCEDIMENTO

Passaggio	Domanda da porre
Funzione	Quale interesse o attività pubblica è coinvolta?
Fonte	La regola è nazionale, regionale o aziendale?

Passaggio	Domanda da porre
Competenza	Chi istruisce, chi propone, chi controlla e chi adotta?
Avvio	Il procedimento nasce d'ufficio o da istanza?
Istruttoria	Quali fatti, documenti, pareri e dati servono?
Partecipazione	Chi deve essere informato o può intervenire?
Decisione	Quale atto conclude la sequenza?
Motivazione	Come si collegano presupposti, istruttoria e scelta?
Conoscibilità	Che cosa va comunicato, pubblicato o reso accessibile?
Controllo	Come si ricostruiscono esecuzione, versioni e responsabilità?

DA RICORDARE

Il responsabile del procedimento è il punto di coordinamento dell'istruttoria, ma non è per ciò solo il soggetto competente ad adottare l'atto finale. La coincidenza o la separazione dei ruoli deve risultare dalle fonti applicabili.

Trasparenza, riservatezza e tracciabilità

CONOSCIBILITÀ NON SIGNIFICA DIFFUSIONE INDISCRIMINATA

Pubblicità, trasparenza, comunicazione e accesso sono forme diverse di conoscibilità. Non autorizzano la diffusione indiscriminata di informazioni. Prima di rendere conoscibile un atto occorre verificare la base giuridica, l'oggetto, i destinatari, gli obblighi di pubblicazione, i limiti applicabili e la presenza di dati personali.

Nel settore sanitario la cautela è particolarmente importante quando compaiono dati relativi alla salute. Il principio operativo è la minimizzazione: trattare e rendere visibili solo i dati adeguati, pertinenti e necessari rispetto alla finalità. Una motivazione può essere completa senza riportare dettagli sanitari non necessari. Quando l'atto può essere pubblicato, va comunque valutato se il testo o gli allegati richiedano accorgimenti coerenti con la disciplina applicabile.

Non devi risolvere ogni caso con la frase «per ragioni di privacy non si pubblica». Anche questa è una generalizzazione. La risposta corretta identifica l'obbligo o la finalità di conoscibilità, valuta dati e rischi, applica i limiti e documenta la decisione.

PROTOCOLLO, FASCICOLO E VERSIONI

La tracciabilità rende verificabile il percorso:

- il protocollo colloca il documento nel sistema di gestione;
- il fascicolo riunisce gli atti e i documenti pertinenti;
- la registrazione delle versioni distingue il dato originario, quello corretto e quello utilizzato;
- l'indicazione dei passaggi mostra chi ha svolto l'attività e con quale esito;
- la conservazione degli esiti di controllo permette verifiche successive.

La tracciabilità non richiede di accumulare copie, ma di poter rispondere a sei domande: chi, che cosa, quando, su quale fonte, con quale controllo, con quale esito.

IL CONTROLLO COME FASE E COME FUNZIONE

Il controllo può intervenire prima, durante o dopo l'adozione e può riguardare competenza, regolarità, completezza, coerenza, esecuzione o risultati. La sua configurazione concreta dipende dalle regole applicabili. In prova, descrivi sempre oggetto, soggetto, criterio, evidenza ed esito del controllo.

Una check-list utile comprende:

- fonte organizzativa e competenza verificate;
- documenti essenziali presenti;
- dati collegati alla loro origine;
- versioni riconoscibili;
- motivazione coerente con l'istruttoria;
- passaggi autorizzativi registrati;
- conoscibilità valutata;
- dati personali minimizzati;
- esito ed eventuali anomalie documentati.

NSIS e principali famiglie di flussi

SISTEMA, PATRIMONIO INFORMATIVO E SINGOLO FLUSSO

Il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sostiene attività di conoscenza, monitoraggio e governo attraverso un patrimonio composto da flussi differenti. Non va descritto come un'unica tabella o una banca dati indistinta. Per orientarsi servono tre livelli:

1. il sistema, cioè l'insieme organizzato di funzioni, soggetti, regole e infrastrutture;
2. il patrimonio informativo, composto da famiglie di dati gestionali, organizzativi, economici, relativi alle prestazioni o agli assistiti;
3. il singolo flusso, definito da una finalità, da dati e unità di rilevazione, da soggetti coinvolti e da regole di alimentazione, controllo e trasmissione.

Per ogni flusso, parti dalla funzione e costruisci questa carta d'identità prima di memorizzare la sigla:

- finalità;
- oggetto e unità di rilevazione;
- soggetto o sistema che origina il dato;
- soggetto che alimenta o trasmette;
- periodicità prevista;
- controlli;
- responsabilità e validazione;
- destinatario;
- uso del dato.

Periodicità, tracciati, campi, scadenze e modalità tecniche devono essere verificati nel decreto o disciplinare vigente e nelle istruzioni applicabili. Non sono caratteristiche da ricostruire per analogia.

SCHEDA VERTICALE 1 — SDO: ASSISTENZA OSPEDALIERA

Finalità. La Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) raccoglie informazioni sugli episodi di ricovero erogati negli istituti pubblici e privati. Sostiene programmazione, monitoraggio dell'assistenza ospedaliera e dei LEA, analisi organizzativo-gestionali e clinico-epidemiologiche, valutazioni di appropriatezza, qualità ed esito. Non è un rendiconto economico e non può essere separata dal processo assistenziale che origina le informazioni.

Soggetto alimentante. La scheda è compilata dal medico che ha avuto in cura il paziente. L'istituto di ricovero trasmette i dati alla Regione o Provincia autonoma; il livello regionale effettua controlli di qualità e invia al Ministero della Salute. Sistemi, ruoli intermedi e passaggi di validazione interni dipendono dall'organizzazione applicabile.

Unità di rilevazione. L'unità è il singolo episodio di ricovero riferito a un paziente dimesso. La SDO sintetizza informazioni della cartella clinica secondo il tracciato vigente; non descrive l'azienda nel suo complesso.

Periodicità. La pagina istituzionale corrente ricorda che l'invio nazionale è divenuto mensile dal 2011. Questo dato non sostituisce la verifica operativa: calendario, scadenze, finestre di correzione e ritrasmissione devono essere controllati nel disciplinare nazionale e nelle istruzioni regionali vigenti.

Controlli. Occorre verificare completezza, coerenza logica, accuratezza rispetto alla cartella clinica, correttezza della codifica, validità dei valori e tracciabilità delle versioni. Un dato può superare un controllo formale e restare incoerente con la fonte.

Responsabilità. Il medico compila; l'istituto presidia produzione e invio; Regione o Provincia autonoma controlla e trasmette; il Ministero raccoglie, controlla ed elabora nel proprio ambito. Correzione, validazione ed escalation interne vanno ricostruite nelle regole del setting.

Uso. Prima di impiegare una SDO o un aggregato derivato occorre verificare periodo, perimetro, classificazione, completezza e versione. La trasmissione non rende il dato automaticamente idoneo a ogni decisione.

SCHEDA VERTICALE 2 — CE: IL FLUSSO ECONOMICO

Finalità. Il modello Conto economico (CE) rileva costi e ricavi degli enti del Servizio sanitario regionale. Serve al monitoraggio della spesa, al consolidamento, alle comparazioni, alle proiezioni e alla verifica degli equilibri. È un modello standardizzato di comunicazione economico-finanziaria: non sostituisce il bilancio, la contabilità generale, la contabilità analitica o il reporting direzionale.

Soggetto alimentante. Ciascun ente del Servizio sanitario regionale e la Regione alimentano il flusso verso il NSIS, con le necessarie operazioni di consolidamento. Il perimetro comprende gli enti individuati dalla disciplina applicabile; ruoli, firme e passaggi interni devono risultare dalle procedure vigenti.

Unità di rilevazione. L'unità è l'ente o l'aggregato regionale per un determinato periodo contabile. Le voci rappresentano componenti economiche, in particolare costi e ricavi, secondo lo schema vigente; non rappresentano episodi assistenziali individuali.

Periodicità. OpenBDAP descrive rilevazioni CE a preventivo, trimestrali e a consuntivo annuale; la banca dati pubblica ministeriale espone dati annuali a consuntivo. Scadenze, versioni, rettifiche e calendari regionali sono elementi mobili da verificare per l'esercizio considerato.

Controlli. La verifica collega il modello alla fonte contabile e riguarda completezza, quadratura delle voci, coerenza temporale, corretto perimetro e consolidamento. Un'anomalia non si corregge modificando il solo prospetto finale: va individuato il punto della catena che l'ha generata.

Responsabilità. L'ente alimenta e valida secondo il proprio assetto; la Regione consolida e trasmette nel quadro previsto; Ministero e organismi di monitoraggio usano i dati nelle rispettive funzioni. Le responsabilità aziendali non possono essere attribuite senza la fonte organizzativa.

Uso. Il CE sostiene monitoraggio infrannuale e annuale, proiezioni del risultato, comparazioni e controllo degli equilibri. L'uso in una decisione richiede sempre perimetro, periodo, versione e stato di validazione.

SCHEDA VERTICALE 3 — SP: IL FLUSSO PATRIMONIALE

Finalità. Il modello Stato patrimoniale (SP) rileva attività e passività e completa la lettura della gestione con la dimensione patrimoniale. È distinto dal CE: SP rappresenta consistenze patrimoniali a una data, mentre CE rappresenta componenti economiche maturate nel periodo.

Soggetto alimentante. Ogni ente del Servizio sanitario regionale e la Regione inviano il modello al NSIS secondo il perimetro applicabile. L'alimentazione parte dalla contabilità dell'ente e attraversa i passaggi di controllo e consolidamento previsti.

Unità di rilevazione. L'unità è l'ente o l'aggregato regionale per l'esercizio e la data di riferimento del modello. Le voci descrivono consistenze patrimoniali secondo lo schema vigente: SP non è un inventario informale e non descrive singoli ricoveri.

Periodicità. La documentazione della Ragioneria generale dello Stato descrive SP come rendicontazione annuale a consuntivo; anche la banca dati ministeriale pubblica dati SP annuali. Data di riferimento, scadenze, finestre di rettifica e calendario regionale devono essere ricontrollati nelle istruzioni correnti.

Controlli. Sono necessari completezza e quadratura del modello, corrispondenza con la fonte contabile, coerenza dei saldi e raccordi pertinenti con le variazioni economiche. Anche qui il controllo deve lasciare evidenza dell'anomalia, della correzione e della versione validata.

Responsabilità. L'ente alimenta e valida secondo il proprio assetto; la Regione consolida e trasmette; il livello nazionale usa il flusso per monitoraggio e comparazione. Le procedure locali precisano ruoli, autorizzazioni ed escalation.

Uso. SP consente di analizzare struttura patrimoniale, attività, passività e variazioni. Va letto insieme al CE e al bilancio, ma non li sostituisce.

La teoria di bilancio, budget, centri di costo e scostamenti appartiene al capitolo dedicato alla contabilità sanitaria. Qui interessa comprendere come i dati economici e patrimoniali entrano in flussi governati e restano distinti dai dati sull'assistenza ospedaliera.

CHE COSA RESTA MOBILE

Per SDO, CE, SP e altri flussi possono cambiare classificazioni, tracciati, controlli, periodicità, calendari, modalità di invio e istruzioni. Possono inoltre esistere passaggi regionali o aziendali specifici. Davanti a una domanda tecnica, indica il metodo di verifica:

1. identifica il flusso esatto e la sua finalità;
2. individua la fonte istitutiva e il disciplinare vigente;
3. verifica eventuali istruzioni regionali;
4. ricostruisci responsabilità e sistemi aziendali;

5. documenta versione e data delle regole applicate.

In prova, questo metodo evita di citare dettagli tecnici fuori contesto.

Qualità, validazione e uso del dato

LE DIMENSIONI DELLA QUALITÀ

Valuta la qualità attraverso cinque dimensioni:

- completezza: sono presenti tutti gli elementi richiesti?
- coerenza: i dati sono compatibili tra loro e con le regole logiche?
- correttezza: il dato rappresenta fedelmente la fonte e l'evento?
- tempestività: è disponibile nel momento utile e secondo i tempi previsti?
- tracciabilità: si possono ricostruire origine, trasformazioni, controlli e responsabili?

Un dato mancante non è uguale a un dato incoerente. Il primo richiede di verificare se l'informazione esiste e può essere acquisita. Il secondo impone un confronto tra campi, regole o fonte originaria. Un dato corretto ma non validato non dovrebbe essere trattato come se avesse completato il processo. Un dato trasmesso può essere scartato o accettato con segnalazioni, a seconda delle regole del flusso.

DAL DATO ORIGINARIO ALLA TRASMISSIONE

La catena operativa è:

origine → alimentazione → controllo → anomalia → correzione o escalation → validazione → trasmissione → esito → uso.

L'alimentazione inserisce o acquisisce il dato. Il controllo applica verifiche formali, logiche o sostanziali previste. La correzione interviene sulla fonte o sulla registrazione secondo le responsabilità attribuite; non consiste nel modificare informalmente un numero per far superare il controllo. L'escalation porta l'anomalia al ruolo competente quando chi la rileva non può risolverla o quando il problema è sistemico. La validazione assume la responsabilità prevista sul dato o sul pacchetto informativo. La trasmissione invia al destinatario e produce un esito da registrare.

Ogni passaggio deve preservare il collegamento con la fonte. Se un dato riepilogativo cambia, occorre capire se è stato corretto l'evento originario, una regola di aggregazione o soltanto il prospetto finale.

ESITO E USO

Dopo l'invio, verifica ricevuta, accettazione, scarto, segnalazioni e necessità di ritrasmissione. L'esito alimenta il controllo interno e consente di prevenire errori ricorrenti.

Il dato può sostenere monitoraggio, programmazione, valutazione e controllo, ma l'uso deve restare coerente con finalità, qualità e livello di aggregazione. La trasmissione formale, da sola, non rende il dato adatto a qualsiasi decisione. Prima di usarlo in un provvedimento chiedi:

- descrive davvero il fenomeno rilevante?
- il periodo e il perimetro sono corretti?
- la versione è quella validata?
- le anomalie sono state risolte?
- il livello di aggregazione consente la conclusione proposta?

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Inserire non significa controllare. Controllare non significa correggere. Correggere non significa validare. Validare non significa che l'invio sia stato accettato. Trasmettere non rende il dato idoneo a ogni uso.

Caso guidato

SCENARIO E DOCUMENTI DISPONIBILI

Un ufficio amministrativo sta predisponendo uno schema di provvedimento organizzativo. La motivazione richiama un prospetto riepilogativo ricavato da un flusso sanitario per dimostrare l'aumento di una determinata attività. Prima della firma, un addetto rileva due problemi: manca un gruppo di registrazioni e il totale del prospetto non coincide con la fonte da cui sarebbe stato estratto.

Sono disponibili:

- la bozza dell'atto;
- un estratto dell'atto aziendale, privo però dell'indicazione della versione;
- il prospetto riepilogativo;
- l'evidenza della fonte originaria;
- una registrazione del controllo che segnala l'anomalia;
- una procedura interna che descrive alcuni passaggi, ma non chiarisce chi adotta il provvedimento.

Non sono indicati Regione, ente, disciplina regionale, deleghe vigenti, flusso esatto, periodicità o disciplinare tecnico applicabile.

PRIMA CATENA: COMPETENZA E PROCEDIMENTO

La prima operazione non è correggere l'atto. Occorre qualificare la funzione organizzativa e verificare la competenza. L'estratto dell'atto aziendale non è sufficiente perché manca la versione; inoltre una procedura interna non può attribuire da sola un potere che dipende da fonti organizzative diverse.

Il candidato deve quindi:

1. identificare l'oggetto e la funzione del provvedimento;
2. acquisire la versione applicabile dell'atto aziendale;
3. verificare disciplina regionale, regolamenti e deleghe pertinenti;
4. distinguere chi istruisce, chi propone, chi controlla e chi adotta;
5. sospendere la chiusura dell'istruttoria finché il presupposto informativo decisivo non è chiarito.

La bozza può continuare a essere lavorata, ma non deve presentare come accertato il dato contestato.

SECONDA CATENA: QUALITÀ DEL DATO

L'anomalia va qualificata in due componenti. Le registrazioni mancanti pongono un problema di completezza. La mancata coincidenza del totale con la fonte pone un problema di coerenza o correttezza. Prima di intervenire occorre ricostruire:

- quale sia la fonte originaria;
- chi abbia prodotto il prospetto;
- quale regola di estrazione o aggregazione sia stata usata;
- quale versione sia entrata nell'istruttoria;
- quali controlli preveda il flusso;
- chi possa correggere e chi debba validare.

L'addetto che rileva l'errore non deve alterare il totale nel prospetto senza intervenire secondo la procedura sulla fonte o sulla trasformazione che ha generato il dato. Se non possiede la competenza, registra l'anomalia ed effettua l'escalation al ruolo previsto.

SOLUZIONE MOTIVATA

La soluzione corretta integra le due catene:

1. si registra formalmente l'anomalia e si collega al fascicolo;
2. si identifica e preserva la versione del dato usata nella bozza;
3. si confrontano prospetto, fonte e regola di aggregazione;
4. il soggetto competente corregge o completa il dato;

5. si ripetono i controlli;
6. il ruolo previsto valida la nuova versione;
7. si registra l'esito dell'eventuale trasmissione;
8. l'istruttoria valuta se il dato corretto sostiene ancora il provvedimento;
9. si aggiorna la motivazione;
10. si verifica chi è competente all'adozione e quali forme di conoscibilità siano applicabili.

Se il dato non può essere corretto in tempo o resta incerto, il decisore deve esserne informato. Non è lecito mascherare l'incertezza. Potrà essere necessario rinviare l'adozione, integrare l'istruttoria o ridimensionare la conclusione, secondo la rilevanza del dato e le regole applicabili.

Quanto alla pubblicità, il prospetto deve essere valutato rispetto a finalità e contenuto. Se contiene dati riferibili a persone o informazioni non necessarie alla conoscibilità dell'atto, occorre applicare minimizzazione e limiti pertinenti. Anche un dato aggregato richiede attenzione se, nel contesto, consente di risalire a interessati.

VARIABILI ANCORA DA VERIFICARE

Il caso non può essere chiuso su questi punti senza ulteriori elementi:

- soggetto competente ad adottare il provvedimento;
- validità e versione dell'atto aziendale;
- eventuale delega;
- flusso e disciplinare tecnico applicabile;
- ruoli di correzione e validazione;
- obblighi di comunicazione o pubblicazione;
- eventuali istruzioni regionali;
- idoneità del dato alla specifica finalità decisionale.

In una risposta d'esame, separa quindi il metodo generale dalla regola locale.

Domanda da commissario

Domanda: Come si collegano competenza, atto aziendale, procedimento amministrativo e qualità del dato in un'azienda sanitaria?

Risposta modello: L'atto aziendale organizza il singolo ente entro la cornice nazionale e regionale e aiuta a individuare strutture e funzioni, ma la competenza concreta richiede anche la verifica delle ulteriori fonti organizzative e delle deleghe applicabili. Il procedimento ordina l'avvio, l'assegnazione della responsabilità, l'istruttoria, la partecipazione, la decisione e i controlli. Se la motivazione usa dati sanitari o economici, l'istruttoria deve dimostrarne origine, completezza, coerenza, correttezza, versione e validazione. Chi istruisce o valida il dato non coincide necessariamente con chi adotta l'atto.

Pubblicità e trasparenza vanno poi bilanciate con minimizzazione e tutela dei dati. Poiché organizzazione e flussi possono avere regole regionali, aziendali o tecniche specifiche, la risposta deve indicare quali fonti vigenti occorre verificare.

Follow-up: Perché un dato già trasmesso potrebbe non essere sufficiente?

Risposta: Perché la trasmissione è un passaggio del processo, non una garanzia assoluta di qualità o adeguatezza all'uso. Vanno considerati esito, eventuali scarti, coerenza con la fonte, versione validata, finalità e livello di aggregazione.

Domanda-trappola

Domanda: L'atto aziendale stabilisce in modo uniforme per tutte le aziende sanitarie chi adotta ogni provvedimento e il NSIS prescrive un'unica procedura di validazione?

Risposta corretta: No. L'atto aziendale appartiene a uno specifico ente e opera entro una cornice nazionale e regionale. Va letto nella versione applicabile e può richiedere il raccordo con regolamenti o deleghe. Il patrimonio informativo sanitario comprende flussi diversi, ciascuno con proprie fonti, finalità e regole; ruoli e procedure operative devono essere verificati nel disciplinare e nel contesto organizzativo vigente.

La trappola consiste nel trasformare due architetture differenziate, quella organizzativa e quella informativa, in regole uniformi.

Errore tipico

L'errore più frequente è partire dal nome dell'atto o dalla sigla del flusso. Il candidato vede «determinazione» e attribuisce la competenza; legge «SDO» e descrive una trasmissione senza chiarire finalità e controlli.

La correzione consiste nell'applicare sempre quattro domande:

1. Quale livello? Individua fonte nazionale, regionale o aziendale.
2. Quale funzione? Chiarisci ciò che l'atto o il dato deve realizzare.
3. Quale responsabilità? Separa istruttoria, proposta, controllo, validazione e decisione.
4. Quale evidenza? Collega documento o dato a origine, versione, controllo ed esito.

Nel diario degli errori trasforma la frase sbagliata in una regola operativa. Esempio: da «il dato è nel sistema, quindi è corretto» a «verifico origine, dimensioni di qualità, validazione, esito e idoneità all'uso».

Mini-esercizio

Un prospetto economico utilizzato per motivare una scelta organizzativa presenta un valore diverso da quello registrato nel sistema originario. L'ufficio che prepara l'atto propone di sostituire manualmente il valore e inviare subito la bozza al soggetto indicato come firmatario in un modello dell'anno precedente.

SCHEDA A — ATTO E PROCEDIMENTO

Compila:

Campo	Risposta
Funzione amministrativa	
Fonte nazionale pertinente	
Disciplina regionale da verificare	
Atto aziendale: ente e versione	
Competenza all'istruttoria	
Competenza alla proposta	
Competenza all'adozione	
Presupposti del provvedimento	
Controlli necessari	
Regola di conoscibilità	
Misure di minimizzazione	

SCHEDA B — FLUSSO E QUALITÀ

Compila:

Campo	Risposta
Finalità del dato	
Flusso esatto	
Fonte originaria	
Unità di rilevazione	

Campo	Risposta
Periodo e perimetro	
Tipo di anomalia	
Controllo da ripetere	
Soggetto che può correggere	
Soggetto che valida	
Esito della trasmissione	
Uso consentito	

CONSEGNA

Scrivi una risposta di dodici righe che:

1. rifiuti la correzione informale;
2. indichi la sequenza corretta;
3. separi dato, istruttoria e decisione;
4. elenchi almeno tre elementi mancanti che impediscono di chiudere il caso;
5. distingua ciò che puoi affermare in base ai principi generali da ciò che richiede verifica locale o tecnica.

Traccia di autovalutazione: la risposta è completa se qualifica l'anomalia, preserva la fonte, richiede la correzione da parte del ruolo competente, ripete controllo e validazione, aggiorna motivazione e fascicolo, verifica competenza e versione dell'atto aziendale, non inventa scadenze né attribuzioni.

Checklist finale

Prima della prova verifica se sai rispondere senza appunti:

- So distinguere livello nazionale, regionale e aziendale?
- So spiegare perché LEA e standard non attribuiscono da soli la competenza a firmare?
- So distinguere ente, organo, ufficio, struttura e responsabile?
- So spiegare la funzione dell'atto aziendale?

- So separare atto aziendale, atto istruttorio, proposta e provvedimento?
- So ricostruire avvio, istruttoria, decisione, conoscibilità e controllo?
- So motivare una scelta senza inventare fatti o competenze?
- So spiegare perché trasparenza non significa diffusione indiscriminata?
- So distinguere sistema informativo, patrimonio informativo e singolo flusso?
- So distinguere SDO, CE e SP per oggetto e finalità?
- So definire completezza, coerenza, correttezza, tempestività e tracciabilità?
- So separare alimentazione, controllo, correzione, validazione e trasmissione?
- So spiegare perché un dato trasmesso può non essere idoneo alla decisione?
- So indicare quali dettagli devono essere verificati sul disciplinare vigente?
- So registrare le variabili mancanti invece di colmarle con ipotesi?

Se una risposta è negativa, non aggiungere nuove sigle. Torna alle due catene iniziali e produci uno schema completo.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833: istituzione del Servizio sanitario nazionale e quadro dei principi.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: aziendalizzazione, autonomia, organizzazione, organi e atto aziendale, da consultare nel testo vigente.
- D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171: selezione e conferimento degli incarichi dei vertici sanitari.
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001: indirizzo e coordinamento sulle prestazioni sociosanitarie, in raccordo con il decreto sui LEA.
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017: definizione dei livelli essenziali di assistenza.
- D.P.C.M. 7 agosto 2026 e D.M. 3 agosto 2026: aggiornamenti LEA pubblicati il 30 settembre 2026, con efficacia dal 30 ottobre 2026.
- Legge 16 dicembre 2024, n. 193, articolo 36, e successive modifiche: disciplina temporale delle specifiche disposizioni su accreditamento e accordi contrattuali.
- D.M. 2 aprile 2015, n. 70: standard della rete ospedaliera.
- D.M. 23 maggio 2022, n. 77: modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: principi e disciplina generale del procedimento amministrativo, responsabile, istruttoria, partecipazione, motivazione e accesso documentale.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: obblighi di pubblicità, trasparenza e accesso civico, da coordinare con i limiti applicabili.
- Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: quadro generale per la protezione dei dati personali, con particolare attenzione ai dati relativi alla salute.

- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Titolo II: principi e regole contabili del settore sanitario, rilevanti per comprendere il contesto dei dati economico-finanziari.
- Ministero della Salute, patrimonio informativo NSIS: riferimento istituzionale per l'architettura dei flussi sanitari.

Prima di applicare queste regole a un ente o a un flusso concreto, controlla norme, atti aziendali, disciplinari tecnici e istruzioni regionali nella versione vigente. In ogni caso: qualifica fonte e finalità, verifica competenza e responsabilità, ricostruisci procedimento e dato, documenta controllo ed esito.

Documentazione sanitaria, accesso, privacy e conservazione

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Per consegnare una copia di documentazione sanitaria, l'ufficio deve svolgere prima una serie di verifiche. Occorre chiarire quale documento viene richiesto, chi lo chiede e se agisce per sé o per un'altra persona. Vanno poi individuati il diritto esercitato e gli eventuali dati di terzi, così da stabilire l'ampiezza dell'accoglimento e scegliere un canale che garantisca identificazione, sicurezza e prova dell'esito.

Al candidato serve un metodo che resti valido quando cambiano ente, procedura e tecnologia, non la memorizzazione di un modulo aziendale come se fosse una regola nazionale:

oggetto → finalità → richiedente → regime giuridico → dati e limiti → istruttoria → decisione → consegna → tracciamento → conservazione.

Seguire questa sequenza evita di trattare ogni domanda come accesso documentale o di invocare la privacy come divieto assoluto. La richiesta va qualificata bilanciando il diritto esercitato, i doveri dell'amministrazione e la protezione delle persone coinvolte.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo dovrai saper:

- distinguere documentazione sanitaria, cartella clinica, Fascicolo sanitario elettronico e dossier sanitario;
- riconoscere accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e diritti dell'interessato sui dati personali;
- verificare identità, delega, rappresentanza e legittimazione;
- individuare dati relativi alla salute e dati riferiti a terzi;
- spiegare quando occorre valutare oscuramento, estrazione o rilascio parziale;
- distinguere consultazione, comunicazione, diffusione e consegna di copia;
- ricostruire formazione, registrazione, fascicolazione, gestione e conservazione del documento informatico;
- motivare una richiesta di integrazione, un accoglimento, un accoglimento parziale, un differimento o un diniego;
- scegliere un canale di consegna coerente con identità, sicurezza e tracciabilità;
- indicare quali elementi devono essere controllati nel regolamento e nelle istruzioni vigenti dell'ente.

Per la disciplina generale puoi richiamare Il Metodo BANDO (VOL-01), Capitolo 5 — Diritto amministrativo operativo, Capitolo 7 — Trasparenza, anticorruzione e privacy e Capitolo 10 — Informatica, PA digitale e competenze digitali. Qui trovi gli elementi indispensabili e la loro applicazione al contesto sanitario.

Mappa BANDO

BANDO

Nel programma di concorso cerca espressioni come: documentazione sanitaria, cartella clinica, accesso agli atti, accesso civico, protezione dei dati personali, GDPR, Fascicolo sanitario elettronico, dossier sanitario, documento informatico, protocollo, fascicolazione e conservazione. Collega ogni voce al profilo e alla prova: un assistente amministrativo può dover classificare una richiesta, predisporre una risposta, ricostruire l'istruttoria o spiegare un istituto al colloquio.

AREE

Il capitolo collega cinque aree:

- diritto amministrativo e accessi;
- organizzazione e documentazione sanitaria;
- protezione dei dati personali;
- amministrazione digitale;
- comunicazione dell'esito all'utente.

Le cinque aree sono collegate, ma restano distinte. Il diritto di accesso a un documento, il diritto dell'interessato sui propri dati e la consultazione del FSE possono riguardare informazioni simili, ma rispondono a presupposti e regole differenti.

NUCLEI

Concentrati su oggetto della richiesta, identità del richiedente, legittimazione, regime applicabile, dati di terzi, minimizzazione, decisione motivata, canale, tracciamento e conservazione. Usa questa griglia per collocare correttamente le denominazioni dei singoli strumenti.

DIARIO

Nel diario degli errori registra le generalizzazioni:

- «chiunque sia parente può ritirare la documentazione»;
- «ogni richiesta di copia è accesso documentale»;
- «il consenso è sempre necessario»;
- «i dati sanitari non sono mai accessibili»;

- «FSE, dossier e cartella clinica sono la stessa cosa»;
- «oscurare e anonimizzare sono sinonimi»;
- «inviare una scansione significa conservare il documento»;
- «una e-mail ordinaria è sempre sufficiente per la consegna».

Per ogni errore annota la domanda correttiva: che cosa? chi? perché? secondo quale regime? con quali limiti? con quale prova dell'esito?

OUTPUT

Gli output da allenare sono:

1. risposta orale di due minuti sui regimi di accesso;
2. checklist istruttoria di una richiesta;
3. parere breve su legittimazione e dati di terzi;
4. risposta chiara all'utente;
5. schema del ciclo documentale dalla ricezione alla conservazione.

ATTENZIONE

La parola «accesso» non identifica da sola l'istituto applicabile. Prima di citare una norma, qualifica oggetto, finalità e richiedente. Solo dopo puoi stabilire se si tratta di accesso documentale, accesso civico, esercizio di un diritto sui dati personali o uso di uno strumento sanitario specifico.

Inquadramento teorico: che cosa comprende la documentazione sanitaria

DOCUMENTO, INFORMAZIONE E INSIEME DOCUMENTALE

Un documento rappresenta atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Può essere formato su supporto analogico o informatico e può entrare in un insieme organizzato di documenti. L'informazione è il contenuto conoscitivo; il dato personale è l'informazione riferita a una persona identificata o identificabile. Queste categorie si sovrappongono, ma non coincidono.

Una richiesta può avere per oggetto:

- la visione o la copia di un documento;
- uno specifico dato personale;
- un insieme documentale riferito a un episodio assistenziale;
- un'informazione soggetta a pubblicazione;
- dati o documenti detenuti dall'amministrazione per finalità di controllo diffuso;
- l'uso o la consultazione di un sistema informativo sanitario.

L'ufficio identifica anzitutto con precisione l'oggetto. Se la domanda è generica, può chiedere un'integrazione che consenta di individuare documenti, periodo, struttura o episodio di riferimento.

FUNZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

La documentazione sanitaria nasce nel processo di assistenza e svolge più funzioni. Rende conoscibili attività e decisioni, permette continuità informativa, sostiene adempimenti amministrativi, consente controlli e conserva evidenza di quanto è avvenuto. Può assumere rilievo anche per l'esercizio di diritti e per la ricostruzione delle responsabilità.

Poiché la documentazione svolge più funzioni, la sua gestione deve rispettare alcune condizioni operative:

- la documentazione deve essere riconducibile al contesto nel quale è stata formata;
- completezza e integrità non sono qualità meramente grafiche;
- correzioni e integrazioni non possono cancellare la storia del documento;
- accessi e copie devono essere gestiti senza alterare l'originale;
- reperibilità e conservazione devono accompagnarsi a riservatezza e controllo degli accessi.

Ogni documento sanitario conserva natura, origine, finalità e regole proprie: l'appartenenza allo stesso insieme documentale non rende uniformi tutti gli elementi che lo compongono.

CARTELLA CLINICA E ALTRI DOCUMENTI

La cartella clinica raccoglie e organizza la documentazione relativa a un episodio di ricovero. Non coincide con ogni documento sanitario e non può essere usata come sinonimo di referto, certificazione, verbale, immagine diagnostica, prescrizione o documentazione amministrativa collegata alla prestazione.

In prova, evita definizioni che elenchino campi o componenti come se fossero invariabili. È più solido spiegare la funzione: la cartella consente di documentare in modo unitario il percorso relativo al ricovero, mantenendo la sequenza delle informazioni e delle attività che devono risultare secondo le regole applicabili.

Prima di trattare una richiesta, identifica quindi:

Domanda	Perché serve
Qual è il documento o l'insieme richiesto?	Delimita l'oggetto dell'istruttoria.
Chi lo ha formato e chi lo detiene?	Orienta competenza e reperimento.
A quale persona e periodo si riferisce?	Evita omonimie e richieste indeterminate.
Qual è la finalità dichiarata o ricavabile?	Aiuta a qualificare il regime.

Domanda	Perché serve
Contiene dati di altre persone?	Impone di valutare limiti e selezione.
In quale forma deve essere consegnato?	Incide su copia, canale, sicurezza ed evidenze.

IL CICLO DI VITA

Il documento attraversa un ciclo: formazione o acquisizione, registrazione, classificazione, assegnazione, fascicolazione, uso, eventuale selezione e conservazione. Non tutte le fasi sono svolte dalla stessa persona o dallo stesso sistema, ma devono restare coordinate.

Per una richiesta di copia, il ciclo produce almeno due insiemi di evidenze:

1. la documentazione oggetto della richiesta, che non va alterata;
2. il fascicolo della richiesta, con istanza, identificazione, delega, integrazioni, istruttoria, decisione, comunicazioni e prova della consegna.

Confondere i due insiemi rende difficile dimostrare che l'ufficio ha deciso correttamente e che il destinatario era legittimato.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La documentazione sanitaria non coincide con il solo contenuto clinico. È un insieme organizzato di documenti formato nel processo assistenziale e amministrativo. Ogni documento conserva origine, funzione e regole di accesso. La cartella clinica riguarda l'episodio di ricovero e non è sinonimo di ogni documento sanitario. L'ufficio gestisce la richiesta senza alterare l'originale e conserva le evidenze dell'istruttoria e della consegna.

Qualificare la richiesta e scegliere il regime

IDENTITÀ, DELEGA E RAPPRESENTANZA

Verificare l'identità significa accertare chi presenta o riceve la richiesta. Verificare la legittimazione significa stabilire se quella persona può esercitare il diritto o ottenere il documento. Le due verifiche sono collegate, ma non equivalenti: una persona può essere identificata con certezza e non avere titolo a ricevere la documentazione di un'altra.

Quando il richiedente agisce per un terzo, occorre qualificare il rapporto. Può esserci una delega, una rappresentanza legale o un altro titolo previsto dalla disciplina applicabile. La dichiarazione «sono un familiare» non dimostra la legittimazione: l'ufficio deve controllare documenti, poteri e limiti pertinenti al caso.

Acquisire la delega non basta: occorre leggerla e controllare almeno:

- identità di delegante e delegato;
- oggetto e ampiezza dell'incarico;
- riconducibilità della dichiarazione al delegante;
- documentazione richiesta per verificare le identità;

- eventuali limiti temporali o materiali;
- coerenza fra delega, istanza e persona cui si riferiscono i dati.

Moduli e formalità possono variare. Il metodo non cambia: identificare il titolo, verificarne l'idoneità e registrare l'esito.

ACCESSO DOCUMENTALE

L'accesso documentale, disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, tutela chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento del quale chiede visione o copia. Il centro dell'istituto è il rapporto tra documento e situazione giuridicamente tutelata del richiedente.

L'istruttoria deve verificare:

1. quale documento viene richiesto e se è detenuto dall'amministrazione;
2. quale interesse viene fatto valere e quale collegamento ha con il documento;
3. se la richiesta è sufficientemente determinata;
4. se sono coinvolti controinteressati o dati di terzi;
5. se ricorrono limiti, esclusioni o ragioni di differimento;
6. se l'accesso può essere assicurato integralmente o in forma parziale;
7. quale ufficio decide e come deve essere motivato l'esito.

Nel contesto sanitario, l'interesse del richiedente non annulla la protezione degli altri soggetti presenti nel documento. L'amministrazione deve delimitare ciò che è pertinente e valutare le misure che consentono di soddisfare il diritto senza comunicare dati eccedenti.

Se l'accesso riguarda la salute di un'altra persona, si applica anche l'articolo 60 del Codice privacy: il diritto che il richiedente vuole tutelare deve avere rango almeno pari a quello dell'interessato, oppure essere un diritto della personalità o un'altra libertà fondamentale e inviolabile. La valutazione riguarda i diritti effettivamente in gioco e la necessità dei dati, nel raccordo con l'articolo 24, comma 7, della legge 241/1990. Dichiarare «mi serve per una causa» non basta a ottenere un'intera cartella. L'ufficio verifica quali informazioni siano strettamente indispensabili per quella difesa e motiva la scelta.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'accesso civico semplice riguarda dati, documenti o informazioni che l'amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare e che non risultano pubblicati. Può essere esercitato da chiunque e svolge una funzione diversa dall'accesso documentale.

Se una persona chiede la propria cartella clinica, la sola parola «accesso» non trasforma la domanda in accesso civico semplice. Questo istituto presuppone un obbligo di pubblicazione inadempito; non è il canale ordinario per ottenere documenti sanitari personali.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato consente a chiunque di chiedere dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, per favorire forme diffuse di controllo. Non richiede lo stesso interesse qualificato dell'accesso documentale, ma incontra limiti a tutela di interessi pubblici e privati.

L'ufficio verifica prima le esclusioni assolute. I dati che rivelano la salute di persone identificate o identificabili sono soggetti al divieto di diffusione dell'articolo 2-septies, comma 8, del Codice privacy, richiamato dall'articolo 7-bis, comma 6, del D.Lgs. 33/2013. Opera quindi l'esclusione dell'accesso civico prevista dall'articolo 5-bis, comma 3: un interesse al controllo pubblico non supera questo divieto.

La parte residua del documento può essere rilasciata se non rivela indirettamente salute e identità. Togliere il nome può essere insufficiente: in un piccolo Comune, età, data del ricovero e patologia possono identificare il paziente. Se il divieto non ricorre, l'ufficio applica gli altri limiti, compreso il test del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, e motiva l'eventuale rilascio parziale, differimento o diniego. Accesso documentale e accesso civico richiedono dunque istruttorie diverse.

DIRITTI DELL'INTERESSATO SUI DATI PERSONALI

Il GDPR riconosce all'interessato diritti relativi al trattamento dei propri dati personali. Il diritto di accesso ai dati consente di sapere se è in corso un trattamento e di ottenere accesso ai dati e alle informazioni previste. Può accompagnarsi, nei casi applicabili, a richieste di rettifica, limitazione o esercizio di altri diritti.

Questo diritto non coincide automaticamente con l'accesso a un documento amministrativo nella sua interezza. L'oggetto immediato è il dato personale e il trattamento; il documento può essere uno strumento attraverso il quale l'amministrazione rende comprensibili i dati, ma la qualificazione dipende dalla richiesta concreta.

RETTIFICA DEL DATO E INTEGRITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Il diritto alla rettifica riguarda dati personali inesatti e, nei casi previsti, l'integrazione di dati incompleti. Non autorizza l'ufficio a riscrivere informalmente la documentazione sanitaria né a cancellare la sequenza degli eventi documentati.

Quando viene segnalata un'inesattezza, occorre distinguere almeno tre situazioni:

- errore materiale nel dato identificativo o amministrativo;
- informazione incompleta che può essere integrata secondo le regole applicabili;
- contenuto professionale o sanitario che richiede la valutazione del soggetto competente e non può essere modificato dall'ufficio amministrativo.

L'istruttoria verifica il dato contestato, la fonte originaria, il soggetto competente e il modo con cui la correzione o l'integrazione deve restare tracciabile. Se la richiesta non può essere accolta nei termini proposti, l'esito va motivato e comunicato secondo la disciplina applicabile.

In termini operativi, occorre correggere il dato senza distruggere la storia del documento. La rettifica tutela l'esattezza; la tracciabilità consente di preservare integrità e responsabilità e di ricostruire che cosa è cambiato.

Il confronto tra i quattro istituti può essere sintetizzato così:

Istituto	Centro della richiesta	Richiedente	Domanda guida
Accesso documentale	documento collegato a una posizione tutelata	soggetto con interesse diretto, concreto e attuale	Quale interesse collega il richiedente al documento?
Accesso civico semplice	obbligo di pubblicazione non adempiuto	chiunque	Che cosa doveva essere pubblicato?
Accesso civico generalizzato	dati o documenti per controllo diffuso	chiunque	Quali limiti pubblici o privati incidono sull'accesso?
Diritto sui dati personali	dati dell'interessato e informazioni sul trattamento	interessato o soggetto che lo rappresenta	Quali dati e quale trattamento riguardano la persona?

UNA SEQUENZA DI CLASSIFICAZIONE

Davanti a un'istanza, procedi in questo ordine:

1. trascrivi l'oggetto con parole precise;
2. identifica la finalità e ciò che il richiedente vuole ottenere;
3. verifica se agisce per sé o per un'altra persona;
4. individua documento, dato, obbligo di pubblicazione o sistema coinvolto;

5. confronta i presupposti dei quattro regimi;
6. scegli il regime principale e indica eventuali raccordi;
7. avvia l'istruttoria su limiti, terzi, esito e canale.

Una richiesta formulata con il nome sbagliato non deve essere respinta meccanicamente se il suo contenuto consente di comprenderne la sostanza. L'ufficio qualifica la domanda secondo la disciplina applicabile, chiede le integrazioni necessarie e comunica con chiarezza il percorso seguito.

Dati di salute, terzi e decisione sulla richiesta

PERCHÉ I DATI RELATIVI ALLA SALUTE RICHIEDONO CAUTELE RAFFORZATE

Il GDPR include i dati relativi alla salute tra le categorie particolari di dati personali. La loro protezione non dipende soltanto dal carattere riservato dell'informazione: una comunicazione impropria può incidere in modo significativo sulla dignità, sulla vita privata e sui diritti della persona.

La presenza di dati di salute non implica che ogni trattamento richieda il consenso, né che ogni accesso o comunicazione sia vietato.

La PA e le strutture sanitarie trattano spesso dati sulla base di obblighi di legge, compiti di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, nel quadro delle condizioni previste per le categorie particolari. Occorre quindi individuare la base applicabile, la finalità e le garanzie, senza trasformare il consenso in una formula universale.

I principi da usare nell'istruttoria sono:

- liceità, correttezza e trasparenza: il trattamento deve avere un fondamento e modalità comprensibili;
- limitazione della finalità: i dati sono usati per finalità determinate e compatibili;
- minimizzazione: si trattano e comunicano soltanto i dati adeguati, pertinenti e necessari;
- esattezza: dati inesatti devono essere gestiti secondo le regole applicabili;
- limitazione della conservazione: i dati non sono mantenuti più a lungo del necessario rispetto alle finalità e agli obblighi;
- integrità e riservatezza: accessi, alterazioni, perdite o divulgazioni non autorizzate devono essere prevenuti;
- responsabilizzazione: l'organizzazione deve poter dimostrare le scelte compiute.

Ogni principio deve tradursi in una verifica operativa: serve davvero consegnare l'intero documento? Il recapito è verificato? L'esito è registrato? I dati di terzi possono essere separati? La copia è leggibile e completa senza contenere parti eccedenti?

DATI DEL RICHIEDENTE E DATI DI TERZI

Un documento sanitario può contenere informazioni riferite a più persone. Nella documentazione di un paziente possono comparire dati del familiare, del donatore, di altri assistiti o di professionisti. Non ogni nome di terzo ha lo stesso peso, ma la presenza deve essere rilevata e valutata.

La corretta sequenza è:

1. individuare le informazioni riferite al richiedente o alla persona rappresentata;
2. rilevare le informazioni riferite a terzi;
3. stabilire se tali informazioni sono pertinenti e necessarie rispetto al diritto esercitato;
4. verificare la disciplina specifica e l'eventuale posizione dei controinteressati;
5. valutare se sia possibile soddisfare la richiesta con selezione, estrazione o oscuramento;
6. motivare l'esito e registrare le operazioni compiute.

L'oscuramento rende non conoscibile una parte del documento nella copia rilasciata. L'anonimizzazione mira invece a impedire l'identificazione della persona in modo non reversibile, tenendo conto delle informazioni ragionevolmente utilizzabili. Non sono sinonimi e non vanno scelti in modo automatico.

Anche la pseudonimizzazione è diversa: sostituisce o separa gli identificativi, ma consente una possibile riassociazione attraverso informazioni aggiuntive conservate separatamente. In una risposta d'esame è sufficiente mostrare che oscurare una parte per il rilascio non equivale necessariamente ad anonimizzare un insieme di dati.

CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

La consultazione consente a un soggetto autorizzato di conoscere dati o documenti in un sistema o fascicolo. La comunicazione rende i dati conoscibili a uno o più destinatari determinati. La diffusione li rende conoscibili a soggetti indeterminati, per esempio mediante pubblicazione online liberamente accessibile.

Consegnare una copia all'interessato identificato e pubblicare lo stesso documento sul sito non sono operazioni equivalenti. La trasparenza amministrativa non trasforma l'albo o la sezione «Amministrazione trasparente» in un archivio indiscriminato di dati sanitari.

Prima di comunicare una copia, verifica:

- chi è il destinatario effettivo;
- se il recapito appartiene o è stato indicato in modo attendibile dalla persona legittimata;
- se il canale offre protezioni coerenti con la natura dei dati;
- se occorre separare credenziali, collegamento e documento;

- se l'invio produce evidenze utili di consegna o accesso;
- se copie temporanee o allegati restano in luoghi non controllati.

La soluzione tecnica concreta dipende dai sistemi disponibili e dalle regole dell'ente. Il candidato deve descrivere i requisiti, non inventare una piattaforma obbligatoria.

ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Una richiesta può concludersi in modi diversi:

- accoglimento integrale, quando presupposti e oggetto consentono il rilascio completo;
- accoglimento parziale, quando il diritto può essere soddisfatto escludendo parti non pertinenti o protette;
- differimento, quando l'accesso viene rinviato per una ragione prevista e motivata;
- diniego, quando un limite o l'assenza dei presupposti impedisce l'accoglimento.

La richiesta di integrazione è invece un atto interlocutorio: acquisisce elementi indispensabili e indica che cosa manca e perché, senza concludere l'istruttoria. I suoi effetti sui termini dipendono dalla disciplina applicabile; non si presume una sospensione automatica né si chiede al cittadino di ripartire da zero. Anche il diniego richiede una motivazione riferita ai dati e agli interessi concretamente coinvolti; la formula generica «per privacy» non è sufficiente.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE: SETTE GIORNI, INTEGRAZIONI ENTRO TRENTA

L'articolo 4, comma 2, della legge 24/2017 impone alla direzione sanitaria della struttura pubblica o privata di fornire agli interessati aventi diritto la documentazione sanitaria disponibile entro sette giorni dalla richiesta, preferibilmente in formato elettronico. Le eventuali integrazioni devono arrivare entro trenta giorni dalla stessa richiesta. Il secondo termine non decorre dalla prima consegna. Restano necessari il controllo della legittimazione e il rispetto delle regole di accesso e protezione dei dati.

Caso breve. Un paziente identificato chiede la documentazione del ricovero. Sono disponibili cartella e referti, mentre un accertamento non è ancora completato. La struttura consegna la parte disponibile entro sette giorni e integra entro trenta dalla richiesta. Non rinvia l'intero rilascio per attendere l'ultimo referto e non consegna automaticamente al familiare privo di titolo. Nell'istruttoria registra richiesta, verifiche, prima consegna e integrazione.

Una motivazione essenziale segue questa struttura:

1. richiesta ricevuta e oggetto;
2. richiedente e titolo verificato;
3. regime applicato;
4. documenti e dati esaminati;
5. interessi e limiti valutati;
6. esito e sua ragione;
7. modalità operative e indicazioni previste dalla disciplina applicabile.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

I dati relativi alla salute richiedono protezione rafforzata, ma non sono né liberamente diffondibili né sempre inaccessibili. L'ufficio qualifica il diritto, verifica la base e applica minimizzazione e sicurezza. I dati di terzi vanno individuati prima della decisione.

Oscuramento, anonimizzazione e pseudonimizzazione hanno funzioni diverse.

Accoglimento parziale, differimento e diniego devono essere motivati sul caso concreto.

Cartella clinica, FSE e dossier sanitario

TRE OGGETTI DA NON CONFONDERE

La cartella clinica documenta in modo unitario un episodio di ricovero secondo la disciplina applicabile. È formata e detenuta nel contesto della struttura che ha erogato l'assistenza e conserva il legame con quello specifico episodio.

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) è un ambiente informativo digitale che raccoglie dati e documenti sanitari e socio-sanitari riferiti all'assistito secondo il quadro nazionale e regionale vigente. Ha un perimetro, finalità, modalità di alimentazione e regole di consultazione proprie. Non coincide con la cartella conservata dalla singola struttura.

Il dossier sanitario organizza informazioni relative agli eventi di cura di una persona nel contesto del titolare o della struttura che lo utilizza, per rendere disponibili informazioni utili alla cura secondo le regole applicabili. Non è automaticamente il FSE e non coincide con un singolo documento.

ALIMENTAZIONE, CONSENSO E OSCURAMENTO

Nel FSE l'alimentazione è automatica e non richiede consenso. Per la consultazione a fini di cura il consenso resta necessario e revocabile; rifiuto o revoca non impediscono di ricevere le prestazioni. In emergenza, se il paziente non può esprimersi e vi è un rischio grave, imminente e irreparabile, la disciplina consente accesso prioritario al profilo sintetico e, se necessario, ad altri documenti, limitatamente alle cure urgenti e con esclusione dei dati oscurati. L'assistito può oscurare documenti e conoscere gli accessi registrati. Queste sono regole nazionali del FSE, non opzioni lasciate alla singola piattaforma.

Il dossier sanitario della struttura segue una disciplina distinta: il trattamento mediante dossier richiede consenso informato. La revoca interrompe ulteriore alimentazione e condivisione fra reparti; i documenti restano disponibili al professionista che li ha prodotti. Anche qui il rifiuto non esclude le cure. Il personale amministrativo accede alle sole informazioni necessarie alla propria funzione, non all'intera storia clinica per il solo fatto di lavorare nell'azienda.

Domanda-trappola. «Il paziente ha negato la consultazione del FSE: il laboratorio deve omettere l'alimentazione?» No: alimentazione e consultazione hanno presupposti diversi. Non trasferire questa risposta al dossier, per il quale consenso e revoca seguono le regole appena descritte.

La distinzione può essere ricordata così:

Oggetto	Domanda centrale	Errore da evitare
Cartella clinica	Quale episodio di ricovero documenta?	Usarla come nome di ogni documento sanitario.
FSE	Quale insieme informativo della persona è reso disponibile nel sistema disciplinato?	Trattarlo come archivio della sola azienda.
Dossier sanitario	Quali eventi sono organizzati nel contesto del titolare o della struttura?	Confonderlo con il FSE nazionale o regionale.

FINALITÀ E ACCESSI

Per ciascuno strumento, studia cinque elementi:

1. finalità: perché l'insieme viene formato e usato;
2. origine: quali soggetti e processi producono i dati;
3. perimetro: quali documenti o eventi possono rientrare;
4. soggetti: chi può alimentare, consultare o ricevere informazioni;
5. garanzie: identificazione, autorizzazione, tracciamento, informazione, sicurezza e diritti.

La consultazione da parte dell'assistito, l'accesso da parte di un professionista autorizzato e la richiesta amministrativa di una copia sono operazioni diverse. La piattaforma non elimina la necessità di verificare ruolo, finalità e autorizzazione.

I servizi disponibili in una determinata Regione o in un dato momento possono cambiare insieme a decreti attuativi, funzionalità e modalità di oscuramento, alimentazione e consultazione. In prova, esponi il principio stabile e indica la fonte vigente da controllare per il dettaglio.

UNA SCHEDA DI CONFRONTO

Quando il quesito nomina uno dei tre strumenti, compila mentalmente questa scheda:

- oggetto e funzione;
- contesto organizzativo;
- persona cui si riferiscono i dati;
- soggetti che alimentano;
- soggetti che consultano;
- base e finalità dell'operazione;
- tracciamento degli accessi;
- diritti esercitabili;
- disciplina nazionale, regionale e aziendale da verificare.

La scheda impedisce di rispondere con sole sigle e consente di affrontare anche una domanda che descrive il sistema senza nominarlo.

Documento informatico, gestione e conservazione

FORMAZIONE E ACQUISIZIONE

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Una scansione può quindi essere un documento informatico, pur avendo efficacia diversa dall'originale. Formazione, sottoscrizione, integrità e conformità incidono sul valore probatorio; metadati, formato e gestione ne sostengono identificazione e conservazione secondo il Codice dell'amministrazione digitale e le Linee guida AgID. Occorre distinguere la definizione dell'oggetto dalla prova che esso fornisce.

Un documento può essere:

- formato direttamente in modalità informatica;
- ricevuto attraverso un canale digitale;
- prodotto come copia o duplicato secondo le regole applicabili;
- acquisito a partire da un originale analogico.

La scansione rende disponibile un'immagine digitale, ma non prova da sola autenticità, integrità o conformità. Perciò l'ufficio deve sapere quale oggetto sta gestendo: originale informatico, duplicato, copia informatica, copia per immagine o semplice riproduzione di lavoro.

REGISTRAZIONE, CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE

La registrazione di protocollo attribuisce al documento le informazioni previste per identificarne ingresso o uscita e collocarlo nel sistema documentale. La classificazione collega il documento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione. La fascicolazione riunisce documenti relativi allo stesso procedimento, affare o attività, mantenendone le relazioni.

Nel caso di una richiesta sanitaria, il fascicolo deve permettere di ricostruire:

- quando e come è arrivata l'istanza;
- chi l'ha presentata e come è stato identificato;
- quali documenti di delega o rappresentanza sono stati acquisiti;
- quale ufficio ha curato l'istruttoria;
- quali integrazioni sono state richieste;
- quali limiti e dati di terzi sono stati valutati;
- chi ha assunto la decisione;
- che cosa è stato consegnato, quando e con quale canale;
- quale esito o ricevuta è stato registrato.

Il fascicolo della richiesta non sostituisce la documentazione sanitaria originale e non autorizza a duplicarla senza necessità.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

L'archiviazione colloca e organizza i documenti per l'uso corrente o il deposito. La conservazione a norma li inserisce invece in un processo regolato che mira a mantenerne nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità secondo ruoli, procedure e regole tecniche applicabili.

Una cartella condivisa, un disco o un allegato conservato nella posta elettronica non costituiscono, da soli, un sistema di conservazione. Occorrono gestione organizzata, metadati, responsabilità definite, verifiche e garanzie nel tempo.

La conservazione non impone di trattenere ogni copia per sempre. Il principio di limitazione della conservazione dei dati personali va coordinato con obblighi documentali, sanitari, archivistici e probatori. Tempi e massimari dipendono dalla tipologia documentale e dalle fonti applicabili; non possono essere dedotti da una regola generica.

CONSEGNA E PROVA DELL'ESITO

La consegna deve garantire quattro proprietà:

1. identificazione: il destinatario è quello legittimato;
2. integrità: il contenuto consegnato corrisponde a quanto deciso;
3. riservatezza: soggetti non autorizzati non possono conoscere i dati;
4. tracciabilità: restano evidenze della consegna e dell'esito.

Se la consegna avviene allo sportello, l'ufficio registra identificazione e ritiro secondo la procedura vigente. Se avviene a distanza, verifica recapito, strumenti di autenticazione, protezione del documento ed evidenze disponibili. Non basta scrivere «inviare per e-mail»: occorre motivare perché quel canale è adeguato al caso.

La catena documentale completa è:

ricezione → identificazione → registrazione → fascicolazione → istruttoria → decisione → preparazione della copia → consegna → evidenza dell'esito → gestione e conservazione.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il documento informatico non è un file qualsiasi. Protocollo, classificazione e fascicolazione ne organizzano la gestione. La scansione non equivale automaticamente a originale, firma o copia conforme. Archiviazione e conservazione a norma hanno funzioni diverse. Anche la consegna produce evidenze da gestire: destinatario, contenuto, canale, data ed esito devono poter essere ricostruiti.

Caso guidato: richiesta di copia con delega incompleta

SCENARIO

Un ufficio riceve da un indirizzo di posta elettronica ordinaria una richiesta di copia della documentazione relativa a un ricovero. Il mittente dichiara di essere un familiare dell'assistito e allega una delega priva di indicazione precisa dei documenti richiesti. La copia del documento di identità del delegante non è leggibile. Nella documentazione possono comparire informazioni riferite a terzi. Il richiedente chiede l'invio immediato allo stesso indirizzo e-mail.

Sono disponibili:

- l'istanza ricevuta;
- la delega incompleta;
- una copia illeggibile del documento del delegante;
- il riferimento al ricovero;
- l'indirizzo e-mail del mittente;
- la procedura interna, ma senza evidenza della versione applicabile.

PRIMA FASE: DEFINIRE OGGETTO E SOGGETTI

Prima di inviare la copia, l'ufficio deve chiarire:

1. quale documentazione viene richiesta;
2. a quale persona ed episodio si riferisce;
3. chi è il richiedente;
4. per conto di chi agisce;
5. quale titolo documenta il potere di ricevere la copia.

La parentela dichiarata non sostituisce la verifica della legittimazione. La delega deve essere leggibile, riferibile alle persone coinvolte e coerente con l'oggetto. Se mancano elementi necessari, l'ufficio chiede un'integrazione circoscritta, spiegando quali dati o documenti servono.

SECONDA FASE: QUALIFICARE LA RICHIESTA

Lo scenario descrive una richiesta individuale di documentazione riferita all'assistito. Mancano sia un obbligo di pubblicazione omesso sia una finalità di controllo diffuso: l'accesso civico semplice e quello generalizzato vanno quindi esclusi come qualificazioni iniziali.

Resta da qualificare, sulla base del contenuto dell'istanza e della disciplina applicabile, il rapporto tra richiesta di copia, accesso documentale e diritti sui dati personali. La risposta d'esame non deve scegliere un'etichetta soltanto perché la richiesta usa la parola «accesso». Deve descrivere i presupposti e indicare quali elementi dell'istanza consentono la qualificazione.

TERZA FASE: ESAMINARE DATI E LIMITI

Prima di predisporre la copia, l'ufficio verifica se la documentazione contiene dati di terzi e se tali informazioni sono necessarie rispetto al diritto esercitato. Se una parte non è pertinente o è protetta, va valutata la possibilità di selezione o oscuramento secondo le regole applicabili.

L'originale non va modificato. L'eventuale intervento riguarda la copia destinata al rilascio e deve essere documentato. L'ufficio conserva evidenza di che cosa è stato escluso, da chi e per quale ragione, nei limiti consentiti.

QUARTA FASE: SCEGLIERE IL CANALE

L'indirizzo dal quale proviene la richiesta non è automaticamente un recapito idoneo per la consegna. Occorre verificare:

- se il destinatario è stato identificato;
- se l'indirizzo è stato indicato o confermato dalla persona legittimata;
- se il canale protegge adeguatamente il contenuto;
- se esistono modalità aziendali previste per ritiro o consegna digitale;
- se restano evidenze dell'accesso o del ritiro.

L'urgenza dichiarata non consente di saltare questi controlli. L'ufficio comunica l'eventuale integrazione e i passaggi successivi con linguaggio comprensibile, senza anticipare dati sanitari nella comunicazione.

SOLUZIONE MOTIVATA

Con gli elementi disponibili, il rilascio va sospeso in attesa dell'integrazione. L'ufficio procede in questo ordine:

1. registrare e fascicolare l'istanza;
2. individuare l'ufficio competente secondo l'assetto vigente;
3. chiedere l'integrazione necessaria per oggetto, identità e delega;
4. qualificare il regime applicabile in base alla richiesta completa;
5. reperire la documentazione senza alterarla;
6. esaminare dati di terzi e limiti;
7. assumere una decisione motivata;
8. predisporre la copia secondo l'esito adottato;
9. utilizzare un canale previsto e adeguato;
10. registrare consegna, ricevuta o mancato ritiro;
11. gestire e conservare il fascicolo della richiesta.

Non è possibile determinare senza ulteriori fonti il termine concreto, l'eventuale costo, il modulo, il ruolo che firma la decisione, le modalità di autenticazione o il canale aziendale. Questi elementi vanno verificati nella normativa, nel regolamento e nelle istruzioni vigenti.

RISPOSTA BREVE ALL'UTENTE

Una comunicazione corretta può seguire questo schema:

NOTA

La richiesta è stata acquisita. Per completare l'istruttoria occorre precisare la documentazione richiesta e trasmettere una delega completa con documenti di identificazione leggibili secondo le modalità indicate dall'ente. Dopo la verifica della legittimazione e degli eventuali dati riferiti a terzi, sarà comunicato l'esito e, in caso di accoglimento, la modalità sicura di consegna prevista.

La risposta non promette un esito prima dell'istruttoria, non espone dati sanitari e indica in modo concreto che cosa deve essere integrato.

Domanda da commissario

Domanda: Come deve essere istruita una richiesta di documentazione sanitaria presentata dall'interessato o da un delegato?

Risposta modello: L'ufficio deve anzitutto identificare oggetto, finalità e richiedente. Verifica identità, delega o altro titolo di rappresentanza e qualifica il regime applicabile, distinguendo accesso documentale, accessi civici e diritti sui dati personali. Reperisce la documentazione senza alterarla, individua dati di terzi e valuta pertinenza, minimizzazione ed eventuale rilascio parziale. La decisione deve essere motivata. In caso di accoglimento, la copia viene consegnata con un canale idoneo a identificazione, riservatezza, integrità e tracciabilità. Istanza, istruttoria, esito e prova della consegna confluiscono nel fascicolo e sono gestiti e conservati secondo le regole vigenti.

Follow-up: Perché la delega non basta se il documento di identità è illeggibile?

Risposta: Perché l'ufficio deve verificare la riconducibilità della delega e l'identità delle persone coinvolte. Acquisire un allegato non leggibile non dimostra che il controllo sia stato effettuato.

Domanda-trappola

Domanda: La presenza di dati sanitari impedisce sempre l'accesso e una richiesta di copia è sempre accesso documentale?

Risposta: No. I dati relativi alla salute richiedono cautele rafforzate, ma l'esito dipende dal diritto esercitato, dalla base applicabile, dal richiedente, dai dati coinvolti e dai limiti. Anche la richiesta di copia deve essere qualificata: può riguardare un documento, l'esercizio di diritti sui dati o un altro regime. L'amministrazione valuta accoglimento integrale o parziale, differimento o diniego e motiva la decisione.

Errore tipico

L'errore più comune è partire dal canale o dal modulo: «è arrivata per e-mail, quindi rispondo per e-mail»; «ha compilato il modulo di accesso, quindi è accesso documentale».

Correggilo con quattro passaggi:

1. descrivi la sostanza della richiesta;
2. verifica chi agisce e con quale titolo;
3. confronta i presupposti dei regimi;
4. scegli esito e canale soltanto dopo l'istruttoria.

Il modulo raccoglie le informazioni, mentre la qualificazione giuridica spetta all'ufficio. Allo stesso modo, il canale trasporta la comunicazione senza attribuire al destinatario la legittimazione.

Mini-esercizio

Classifica le richieste seguenti. Per ciascuna compila: oggetto-finalità-richiedente-regime-dati di terzi-integrazioni-esito-canale-conservazione.

RICHIESTA A

Una persona identificata chiede di conoscere i dati personali che l'azienda tratta su di lei e le informazioni essenziali sul trattamento.

Nucleo da riconoscere: diritto dell'interessato sui dati personali. Va verificato il perimetro della richiesta e il modo di fornire dati e informazioni senza compromettere diritti altrui.

RICHIESTA B

Un concorrente chiede documenti collegati a una procedura che incide sulla propria posizione e indica l'interesse che intende tutelare.

Nucleo da riconoscere: accesso documentale, da istruire verificando interesse diretto, concreto e attuale, oggetto, controinteressati e limiti.

RICHIESTA C

Un cittadino segnala che un dato soggetto a pubblicazione obbligatoria non compare nella sezione prevista.

Nucleo da riconoscere: accesso civico semplice, collegato all'obbligo di pubblicazione omesso.

RICHIESTA D

Un soggetto chiede documenti per una finalità di controllo diffuso senza indicare un interesse personale qualificato; i documenti possono contenere dati personali.

Nucleo da riconoscere: accesso civico generalizzato, con valutazione dei limiti e dell'eventuale accesso parziale.

CONSEGNA

Per ogni richiesta indica:

- due elementi che puoi affermare dalla descrizione;
- due elementi che devi ancora verificare;
- un errore che l'ufficio deve evitare;
- l'evidenza da conservare al termine.

Checklist finale

Prima di considerare completa la preparazione, verifica:

- So distinguere documento, informazione e dato personale?
- So spiegare la funzione della documentazione sanitaria?
- So distinguere cartella clinica, FSE e dossier sanitario?
- So separare accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato?

- So spiegare perché il diritto sui dati personali non coincide sempre con la copia integrale di un documento?
- So verificare identità, delega, rappresentanza e legittimazione?
- So riconoscere dati di terzi e valutare un rilascio parziale?
- So distinguere oscuramento, anonimizzazione e pseudonimizzazione?
- So distinguere consultazione, comunicazione e diffusione?
- So motivare integrazione, accoglimento, differimento e diniego?
- So distinguere protocollo, fascicolazione, archiviazione e conservazione?
- So descrivere i requisiti di una consegna sicura e tracciabile?
- So indicare quali dettagli dipendono dalla normativa e dal regolamento vigenti?

Se una risposta è negativa, torna alla catena iniziale. Non aggiungere una norma o una sigla: completa il passaggio mancante.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 4, comma 2: rilascio della documentazione sanitaria disponibile entro sette giorni e integrazioni entro trenta dalla richiesta degli aventi diritto.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: disciplina generale del procedimento e dell'accesso ai documenti amministrativi.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: obblighi di pubblicazione, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, con i relativi limiti.
- Regolamento (UE) 2016/679: principi, categorie particolari di dati, basi del trattamento, diritti, sicurezza e responsabilizzazione.
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101: disciplina nazionale di protezione dei dati personali nel quadro GDPR.
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale, documento informatico e gestione digitale dell'azione amministrativa.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: documentazione amministrativa e quadro di riferimento per dichiarazioni, copie e controlli.
- Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: regole organizzative e tecniche del ciclo documentale digitale.
- Provvedimenti e indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali: FSE, dossier sanitario, diritti, trasparenza, accesso civico, dati relativi alla salute e sicurezza.

Prima di applicare il metodo a una pratica concreta, verifica il testo vigente delle norme, la disciplina nazionale e regionale del FSE, il regolamento dell'azienda, le istruzioni documentali e privacy e le modalità di consegna disponibili. Nella pratica, segui sempre la stessa sequenza: qualifica oggetto e richiedente, individua il regime, limita i dati al necessario, motiva l'esito, proteggi la consegna e conserva le evidenze.

Front-office e comunicazione con l'utenza sanitaria

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Una persona che si rivolge a un'azienda sanitaria non presenta sempre una domanda già ordinata. Può chiedere «notizie sulla pratica», lamentare un ritardo, domandare un documento, riferire un disservizio o cercare informazioni su un familiare. L'operatore deve capire il bisogno, verificare che cosa possa trattare nel proprio ruolo e accompagnare la persona verso il percorso corretto, invece di rispondere in fretta alla prima frase ascoltata.

Nel settore sanitario questo compito richiede un equilibrio particolarmente rigoroso. L'utente deve ricevere una risposta utile e comprensibile, ma il desiderio di aiutarlo non autorizza a comunicare dati relativi alla salute, anticipare decisioni, promettere priorità o consultare informazioni senza una ragione di servizio.

Il metodo operativo del capitolo segue questa sequenza:

ascolto → qualificazione del bisogno → verifica della competenza → informazione verificata → risposta o instradamento → tutela dei dati → accessibilità → tracciamento → eventuale escalation.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo dovrai saper:

- distinguere informazione, comunicazione esterna, comunicazione interna e relazione di front-office;
- spiegare finalità e funzioni dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
- accogliere l'utente, ascoltarlo e riformulare il suo bisogno;
- distinguere informazione generale, stato di una pratica e comunicazione di dati riferiti a una persona;
- verificare competenza, identità, legittimazione, ambiente e canale prima di trattare informazioni individuali;
- formulare una risposta chiara, accessibile e operativa senza promettere l'esito;
- distinguere richiesta di informazioni, istanza, reclamo, segnalazione, suggerimento, encomio e richiesta documentale;
- scegliere se rispondere, prendere in carico, instradare o coinvolgere il responsabile;
- registrare il contatto secondo la procedura dell'ente senza raccogliere dati eccedenti;
- affrontare una domanda orale, un quesito situazionale e un breve caso di sportello.

ATTENZIONE

Essere orientati al servizio vuol dire offrire il massimo aiuto consentito da ruolo, competenza, legalità, imparzialità e protezione dei dati. Non vuol dire soddisfare qualsiasi richiesta.

Mappa BANDO

BANDO

Nel programma d'esame cerca espressioni come: comunicazione pubblica, Legge 7 giugno 2000, n. 150, Ufficio per le relazioni con il pubblico, URP, rapporti con l'utenza, carta dei servizi, reclami, accessibilità, privacy, comunicazione istituzionale, competenze trasversali e orientamento al servizio.

Considera anche la forma della prova. Il tema può essere verificato con un quesito teorico, un caso di front-office, la redazione di una risposta breve o una domanda situazionale nella quale occorre scegliere il comportamento più appropriato.

AREE

Il nucleo collega cinque aree:

- comunicazione pubblica e organizzazione amministrativa;
- relazione con cittadini e utenti;
- protezione dei dati, con particolare attenzione ai dati relativi alla salute;
- servizi digitali e accessibilità;
- competenze comportamentali del dipendente pubblico.

Le aree si integrano, ma non si confondono. Una buona capacità comunicativa non sostituisce la competenza dell'ufficio; la tecnologia non elimina l'obbligo di proteggere i dati; la cortesia non rende legittima una comunicazione.

NUCLEI

Concentrati su sei domande:

1. Che cosa chiede davvero la persona?
2. Quale ufficio o ruolo può occuparsene?
3. Si tratta di informazione generale o di dati individuali?
4. Quali verifiche sono necessarie?
5. Quale canale consente una risposta accessibile, riservata e tracciabile?
6. Che cosa deve essere registrato o trasferito al responsabile?

DIARIO

Nel diario degli errori annota le risposte automatiche:

- «non è competenza mia»;
- «è un familiare, quindi posso dirglielo»;
- «se è online, il servizio è accessibile»;
- «un reclamo è una richiesta di accesso»;
- «ricordo che la procedura è questa»;
- «per aiutare l'utente faccio una verifica nel sistema»;
- «rispondo subito e registro dopo».

Accanto a ogni errore scrivi la domanda correttiva: bisogno, competenza, persona, dato, canale, evidenza, escalation: che cosa manca?

OUTPUT

Gli output da allenare sono:

1. risposta orale di due minuti sulle funzioni dell'URP;
2. classificazione di un contatto;
3. risposta istituzionale breve e comprensibile;
4. scheda di presa in carico;
5. soluzione motivata di un caso con dati sanitari;
6. scelta dell'opzione più adeguata in un quesito situazionale.

Inquadramento teorico: comunicazione pubblica e funzione dell'URP

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ESTERNA E COMUNICAZIONE INTERNA

La Legge 7 giugno 2000, n. 150 inquadra le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni nel perseguimento della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. La disciplina distingue tre direttrici fondamentali.

L'informazione rivolta ai mezzi di comunicazione di massa cura il rapporto con giornali, televisioni, agenzie e altri mezzi d'informazione. Ha destinatari e strumenti diversi dalla relazione ordinaria con il singolo utente.

La comunicazione esterna è rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti. Rende conoscibili norme, attività, servizi e procedimenti; aiuta le persone a orientarsi e a utilizzare i servizi pubblici.

La comunicazione interna circola nell'amministrazione. Permette agli uffici di condividere informazioni coerenti e di coordinare l'attività. Se il front-office non riceve aggiornamenti dall'ufficio competente, anche una risposta esposta con cortesia può essere errata o superata.

La distinzione è funzionale. Un comunicato stampa, una pagina informativa per gli utenti e una circolare interna possono riguardare lo stesso servizio, ma hanno destinatari, finalità, linguaggi e responsabilità differenti.

Attività	Destinatario	Funzione prevalente	Limite da ricordare
Informazione ai media	mezzi di comunicazione e pubblico	rappresentare fatti e attività istituzionali	non coincide con la gestione della pratica individuale
Comunicazione esterna	cittadini, utenti, collettività, enti	rendere conoscibili servizi e percorsi	non autorizza la diffusione di dati personali
Comunicazione interna	uffici e personale	coordinare informazioni e attività	deve restare pertinente ai compiti e ai destinatari
Front-office	persona o gruppo che contatta l'ente	ascoltare, informare, orientare e prendere in carico	opera entro competenza, procedura e protezione dei dati

FINALITÀ DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

La comunicazione istituzionale non è pubblicità generica. Illustra norme e attività dell'amministrazione, favorisce l'accesso ai servizi, diffonde conoscenze di interesse pubblico, sostiene semplificazione e modernizzazione e rende conoscibili l'avvio e il percorso dei procedimenti.

Nel contesto sanitario queste finalità si traducono in azioni concrete: spiegare come accedere a un servizio, indicare quale ufficio tratta una domanda, chiarire quali documenti sono richiesti, rendere comprensibile un cambiamento organizzativo e offrire un'alternativa a chi non può utilizzare il canale digitale.

La comunicazione resta soggetta a segreto, riservatezza e protezione dei dati. La trasparenza, quindi, non rende qualsiasi informazione conoscibile a chiunque. Ciò che riguarda l'organizzazione o le modalità generali del servizio va distinto dalle informazioni riferite a una persona.

Prima di comunicare una risposta istituzionale, controlla cinque aspetti:

- correttezza: deriva da una regola, istruzione o informazione verificata;
- pertinenza: risponde al bisogno effettivo;
- comprensibilità: usa parole e passaggi che il destinatario può capire;
- utilità: indica che cosa fare dopo;

- coerenza: non cambia senza ragione tra sportello, telefono e canale digitale.

URP, FRONT-OFFICE E UFFICIO COMPETENTE

L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, o la struttura che ne svolge le funzioni, è orientato ai cittadini singoli e associati. La Legge n. 150/2000 collega l'URP all'esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione, all'agevolazione nell'uso dei servizi, all'ascolto degli utenti e allo scambio informativo con le altre strutture.

L'URP svolge una funzione di relazione e raccordo: spiega, orienta, riceve, registra e trasferisce. Contribuisce anche a rilevare disservizi e qualità percepita, ma non diventa per questo titolare di ogni procedimento né può decidere ogni istanza.

Il front-office è più ampio del banco fisico. È il punto di contatto tra amministrazione e utente, in presenza, per telefono o attraverso un canale digitale. Può essere collocato nell'URP o in un servizio specialistico. Ciò che lo definisce è la funzione svolta, non soltanto il luogo.

L'ufficio competente conserva la responsabilità della pratica o della decisione attribuitagli dall'organizzazione. Il front-office non deve sostituirlo. Deve invece sapere fino a dove può arrivare:

- se possiede un'informazione generale verificata, la fornisce;
- se può prendere in carico il contatto, lo registra secondo la procedura;
- se serve un'istruttoria, instrada la richiesta;
- se emergono rischio, urgenza o dubbio rilevante, coinvolge il responsabile;
- se viene chiesto un giudizio clinico, non lo formula e attiva il percorso competente.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'URP favorisce informazione, accesso, partecipazione, uso dei servizi e ascolto. Il front-office è il punto di relazione, anche telefonico o digitale. L'ufficio competente resta titolare della pratica e della decisione. Orientare non significa decidere al posto di altri. La risposta corretta unisce utilità per l'utente, rispetto del ruolo e tracciabilità.

Gestire il contatto: ascolto, qualificazione e presa in carico

ACCOGLIERE E ASCOLTARE SENZA GIUDICARE

L'accoglienza professionale crea le condizioni per comprendere la richiesta. Non richiede confidenza né adesione alla versione dell'utente. Richiede attenzione, rispetto e controllo del contesto.

L'operatore lascia esporre il problema senza interrompere prematuramente, osserva se l'ambiente è adatto alla conversazione e utilizza domande aperte per ricostruire il bisogno: «Quale risultato vorrebbe ottenere?», «A quale servizio si riferisce?», «Ha già presentato una domanda?».

Successivamente usa domande chiuse per precisare gli elementi necessari: data del contatto, ufficio coinvolto, eventuale numero di pratica, tipo di comunicazione ricevuta. Le domande devono essere proporzionate. Non si raccolgono dettagli sanitari solo perché la persona è disponibile a raccontarli.

L'ascolto non obbliga ad accettare offese o pressioni. Se il tono diventa aggressivo, l'operatore mantiene la calma, richiama le regole di relazione e riporta il colloquio sui fatti. Se la situazione presenta un rischio o supera il proprio ruolo, applica la procedura di sicurezza e coinvolge il responsabile.

RIFORMULARE IL BISOGNO E RACCOGLIERE GLI ELEMENTI NECESSARI

La riformulazione restituisce con parole neutre ciò che l'operatore ha compreso. Una formula utile è: «Se ho capito correttamente, lei desidera sapere come presentare un reclamo e, separatamente, come chiedere copia di un documento. È così?».

La riformulazione permette di:

1. consentire all'utente di correggere incomprensioni;
2. separare richieste diverse contenute nella stessa narrazione;
3. evitare di promettere una soluzione prima di aver verificato competenza e presupposti.

La qualificazione trasforma un racconto in uno o più oggetti amministrativi. «Nessuno mi risponde» può contenere una richiesta di informazioni, un reclamo sul servizio o entrambe. «Voglio la cartella di mio padre» può contenere una domanda documentale, ma non dimostra identità, rappresentanza o legittimazione.

Per ogni oggetto occorre individuare:

- risultato richiesto;
- persona interessata;
- servizio o pratica;
- informazioni già disponibili;

- verifiche necessarie;
- ufficio competente;
- canale appropriato;
- azione successiva.

RISPONDERE, INSTRADARE O EFFETTUARE ESCALATION

Dopo la qualificazione, l'operatore sceglie tra quattro azioni.

Rispondere è corretto quando l'informazione rientra nel proprio ruolo, è verificata e può essere comunicata attraverso quel canale. Una risposta utile indica regola generale, passaggi, documenti, ufficio, canale e ciò che l'utente deve fare.

Prendere in carico significa assumere il contatto nel percorso previsto: registrarlo, acquisire gli elementi necessari e comunicare all'utente che cosa avverrà dopo. Non significa garantire l'accoglimento della sua pretesa.

Instradare significa trasferire la richiesta al percorso competente, fornendo indicazioni precise. Non basta dire «si rivolga a un altro ufficio». Occorre spiegare quale ufficio o servizio, per quale parte della richiesta, con quali modalità e quali elementi.

Effettuare escalation significa coinvolgere il responsabile o una struttura competente quando il caso supera il ruolo, presenta un conflitto, espone dati o persone a rischio, richiede una valutazione specialistica oppure non può essere risolto con le istruzioni disponibili.

La scelta può essere combinata. L'operatore può fornire subito un'informazione generale, prendere in carico il reclamo e instradare separatamente la domanda documentale.

REGISTRARE IL CONTATTO SECONDO LA PROCEDURA

La registrazione rende ricostruibili contatto, azioni ed esito. Il sistema concreto varia tra enti, ma la logica resta stabile. Una scheda essenziale può includere:

Campo	Contenuto
Data e canale	quando e come è avvenuto il contatto
Oggetto	sintesi neutrale della richiesta
Bisogno qualificato	informazione, reclamo, istanza, segnalazione o altro
Verifiche	identità, legittimazione, competenza e altri controlli pertinenti

Campo	Contenuto
Azione	risposta, presa in carico, instradamento o escalation
Ufficio competente	destinazione individuata
Comunicazione resa	che cosa è stato spiegato all'utente
Esito	chiusura, trasferimento o attività ancora necessaria

La scheda non deve diventare un contenitore indiscriminato. Si annotano dati adeguati, pertinenti e necessari. Un giudizio sull'utente, dettagli clinici irrilevanti o commenti informali non servono a documentare l'attività e possono creare un trattamento eccedente.

ERRORE TIPICO

Rispondere subito alla frase letterale oppure limitarsi a «non è competenza mia». La correzione è: ascoltare, riformulare, qualificare, fornire ciò che è verificato, indicare il passaggio successivo e lasciare l'evidenza richiesta.

Comunicazione chiara, accessibile e multicanale

SCRIVERE E PARLARE PER FARSI COMPRENDERE

Una comunicazione è chiara quando il destinatario può capire che cosa è accaduto, che cosa deve fare e che cosa può attendersi. La precisione giuridica non richiede un linguaggio oscuro.

Per costruire una risposta efficace, usa questo ordine:

1. riconoscimento della richiesta;
2. informazione o decisione comunicabile;
3. ragione essenziale, se necessaria;
4. azione richiesta all'utente;
5. ufficio, canale o documento da utilizzare;
6. passaggio successivo;
7. recapito per un chiarimento pertinente.

Confronta le due formulazioni. La prima è debole: «La pratica non risulta perfezionata ai sensi delle disposizioni vigenti».

La seconda è utile: «La domanda non può ancora essere esaminata perché manca il documento indicato nel modulo. Può integrarla attraverso il portale oppure consegnarla all'ufficio indicato. Dopo l'acquisizione, l'ufficio competente proseguirà la verifica».

La seconda formulazione non promette l'esito, ma consente di agire. Evita sigle non spiegate, frasi impersonali troppo lunghe e rinvii generici. Quando un termine tecnico è necessario, lo accompagna con una spiegazione.

ACCESSIBILITÀ, INCLUSIONE E ALTERNATIVE

L'accessibilità è la possibilità di fruire di informazioni, documenti e servizi anche in presenza di disabilità o limitazioni. Non coincide con la sola bellezza grafica, con la cortesia o con la disponibilità online.

Per il front-office significa almeno:

- usare un linguaggio comprensibile;
- organizzare contenuti con titoli, passaggi e istruzioni riconoscibili;
- evitare che informazioni decisive siano trasmesse soltanto attraverso elementi non fruibili da tutti;
- conoscere le modalità alternative previste dall'ente;
- aiutare la persona a individuare il canale utilizzabile senza sostituirsi impropriamente a lei;
- segnalare ostacoli ricorrenti affinché il servizio possa essere migliorato.

L'inclusione richiede di rimuovere gli ostacoli e offrire modalità equivalenti nel rispetto delle regole, non di applicare a tutti la stessa soluzione. Se l'operatore conosce soltanto il modulo digitale e l'utente non riesce a utilizzarlo per una barriera di accessibilità, non basta rispondere «deve farlo online». Occorre verificare l'assistenza o l'alternativa prevista.

SCEGLIERE IL CANALE IN BASE ALLA FUNZIONE

Sportello, telefono, posta elettronica e portale non sono intercambiabili. La scelta dipende da funzione, destinatario, natura dei dati, necessità di identificazione, accessibilità, sicurezza e tracciabilità.

Canale	Utile soprattutto per	Controllo necessario
Sportello	ascolto articolato, orientamento, acquisizione prevista	ambiente, identità, riservatezza, registrazione
Telefono	informazione generale e chiarimenti compatibili	impossibilità di presumere l'identità dalla sola voce
E-mail	comunicazioni e documenti secondo regole dell'ente	destinatario, contenuto, allegati, sicurezza ed evidenza
Portale autenticato	servizi individuali progettati per l'accesso online	autenticazione, accessibilità, corretto servizio e ricevuta

Canale	Utile soprattutto per	Controllo necessario
Sito istituzionale	informazioni generali, moduli e percorsi	aggiornamento, comprensibilità e accessibilità

Un canale comodo non è automaticamente adeguato. L'operatore non trasferisce dati relativi alla salute attraverso un recapito non verificato soltanto perché l'utente lo chiede. Allo stesso modo, non obbliga a ripetere dati sensibili in una sala affollata quando può proteggere il colloquio.

TRACCIABILITÀ E COERENZA TRA CANALI

La tracciabilità consente di ricostruire che cosa è stato ricevuto, comunicato e trasferito. Non richiede di registrare ogni parola, ma di conservare le evidenze necessarie secondo la procedura applicabile.

La coerenza evita che l'utente riceva risposte incompatibili a seconda dell'operatore. Si ottiene attraverso istruzioni aggiornate, raccordo con gli uffici competenti, controllo delle pagine informative e segnalazione delle difformità.

Quando l'operatore non è certo dell'aggiornamento, non improvvisa. Dichiara il limite con professionalità: «Verifico l'indicazione con l'ufficio competente e le comunico il canale previsto». L'incertezza gestita e tracciata è preferibile a una sicurezza apparente.

Riservatezza e dati sanitari nel front-office

INFORMAZIONE GENERALE E INFORMAZIONE INDIVIDUALE

L'informazione generale riguarda organizzazione, orari, requisiti pubblici, modulistica e modalità di accesso al servizio. Può essere comunicata senza rivelare che una persona utilizzi quel servizio.

L'informazione individuale riguarda una pratica, una prenotazione, un ricovero, un documento o un altro elemento riferibile a una persona. Può contenere dati personali e, nel settore sanitario, dati relativi alla salute, appartenenti alle categorie particolari previste dal Regolamento (UE) 2016/679.

La differenza modifica il comportamento. Alla domanda «quali documenti servono per richiedere una copia?» si può rispondere in termini generali. Alla domanda «mio padre è ricoverato?» non si conferma né si smentisce l'informazione senza il percorso e le verifiche previsti.

ATTENZIONE

Anche confermare l'esistenza di un ricovero, una visita o una pratica può rivelare un dato personale. La riservatezza riguarda il contenuto e il contesto, non soltanto il documento completo.

IDENTITÀ, LEGITTIMAZIONE E RAGIONE DI SERVIZIO

L'identità risponde alla domanda «chi è la persona?». La legittimazione risponde alla domanda «ha titolo per ottenere questa informazione o compiere questa azione?». Le due verifiche non coincidono.

La dichiarazione «sono un familiare» non basta. Il rapporto familiare non produce automaticamente un'autorizzazione generale a ricevere dati sanitari. Occorre applicare la disciplina e la procedura pertinenti, verificando eventuale delega, rappresentanza o altro titolo.

Anche l'operatore deve possedere una ragione di servizio per accedere ai dati. La possibilità tecnica di consultare un sistema non equivale al potere di farlo. Accedere per curiosità, per cortesia o per aiutare un conoscente viola il principio secondo cui i dati devono essere trattati per finalità determinate e da soggetti autorizzati.

Il principio di minimizzazione impone di trattare dati adeguati, pertinenti e limitati a ciò che è necessario. In un contatto di orientamento può bastare conoscere il tipo di servizio; non occorre acquisire diagnosi, terapia o intera storia sanitaria.

AMBIENTE, TONO DI VOCE, SCHERMO, DOCUMENTI E RECAPITI

La riservatezza si protegge anche con comportamenti quotidiani:

- non chiamare ad alta voce informazioni sanitarie non necessarie;
- spostare il colloquio quando l'area affollata non consente riservatezza;
- non lasciare documenti visibili sul banco;
- bloccare o orientare lo schermo in modo da evitare visioni indebite;
- controllare il destinatario prima dell'invio;
- non ripetere dati sanitari in messaggi o oggetti dell'e-mail se non necessario;
- evitare appunti personali e canali non autorizzati;
- smaltire stampe e minute secondo le regole previste.

Il tono di voce è una misura organizzativa semplice ma importante. Una conversazione corretta nel contenuto può diventare illecita o inopportuna se viene resa udibile a persone estranee.

QUANDO INTERROMPERE E ATTIVARE IL PERCORSO COMPETENTE

L'operatore interrompe la comunicazione individuale quando non può verificare identità o legittimazione, il canale è inadeguato, il dato non è necessario, la richiesta supera la competenza o occorre una valutazione clinica.

Interrompere la comunicazione individuale protegge la persona, ma non lascia l'utente senza indicazioni. L'operatore spiega il percorso corretto: documenti necessari, ufficio competente, canale sicuro, eventuale appuntamento o coinvolgimento del responsabile.

Prima di procedere, scorri questa sequenza:

persona → titolo → oggetto → dato necessario → finalità → competenza → ambiente → canale → evidenza.

Se uno degli elementi essenziali manca, l'operatore non colma il vuoto con un'ipotesi.

Reclami, segnalazioni e miglioramento del servizio

QUALIFICARE IL CONTENUTO RICEVUTO

Le parole usate dall'utente non determinano da sole la natura del contatto. Occorre guardare a ciò che chiede di ottenere.

Il reclamo esprime insoddisfazione per un servizio, un comportamento o un disservizio e chiede che l'amministrazione lo esamini secondo la procedura prevista.

La segnalazione porta all'attenzione un problema, un rischio, un errore o una condizione meritevole di verifica. Può non contenere una pretesa individuale.

Il suggerimento propone un miglioramento. L'encomio manifesta apprezzamento. Entrambi possono fornire informazioni utili sulla qualità percepita.

La richiesta di informazioni mira a conoscere modalità, requisiti o stato comunicabile di un'attività. L'istanza chiede all'amministrazione un provvedimento o un'attività. La richiesta documentale mira a ottenere visione, copia o dati e deve essere qualificata secondo la disciplina applicabile.

Uno stesso contatto può contenere più oggetti. Una persona può lamentare il ritardo e, nello stesso tempo, chiedere copia della documentazione. Il reclamo e la richiesta documentale seguono percorsi distinti.

Contenuto	Domanda guida	Azione iniziale
Informazione	che cosa vuole sapere?	fornire informazione verificata o orientare
Reclamo	quale disservizio chiede di esaminare?	acquisire e instradare secondo procedura
Segnalazione	quale fatto o rischio porta all'attenzione?	registrare e trasferire alla funzione competente
Suggerimento	quale miglioramento propone?	acquisire nel canale previsto
Encomio	quale servizio o comportamento apprezza?	registrare e indirizzare
Istanza	quale attività o decisione richiede?	individuare procedimento e ufficio competente

Contenuto	Domanda guida	Azione iniziale
Richiesta documentale	quale documento o dato vuole ottenere e a quale titolo?	avviare il percorso specifico

ACQUISIRE, REGISTRARE E INSTRADARE

La procedura concreta per reclami e segnalazioni dipende dalla carta dei servizi, dal regolamento e dall'organizzazione dell'ente. In prova è scorretto inventare un termine uniforme o attribuire sempre la gestione allo stesso ufficio.

La sequenza generale è tuttavia ricostruibile:

1. ascoltare e distinguere i fatti dalle valutazioni;
2. chiarire ciò che l'utente chiede;
3. acquisire gli elementi necessari senza eccedenze;
4. classificare il contatto;
5. registrarlo nel canale previsto;
6. trasmetterlo alla struttura competente;
7. comunicare all'utente i passaggi verificati;
8. tracciare trasferimento ed esito secondo la procedura.

La registrazione deve essere neutrale. «L'utente riferisce di aver atteso senza ricevere informazioni» è diverso da «l'ufficio ha ignorato l'utente». La prima formula documenta una dichiarazione; la seconda presenta come accertato un fatto ancora da verificare.

RISPONDERE SENZA DIFENSIVISMO NÉ PROMESSE

Nel rispondere, l'operatore riconosce il disagio senza ammettere automaticamente responsabilità non accertate. Evita il tono difensivo e non fa promesse.

Può usare una formula come questa:

«Abbiamo acquisito la sua segnalazione relativa al servizio indicato. Sarà trasmessa alla struttura competente secondo la procedura dell'azienda. Per consentire la verifica sono necessari gli elementi elencati. L'acquisizione non anticipa l'esito, che le sarà comunicato con le modalità previste».

La risposta non deve colpevolizzare l'utente, svalutare altri uffici o assicurare sanzioni, rimborsi, priorità o accoglimento. Se la situazione presenta profili di rischio, urgenza o possibile danno, l'operatore non la tratta come un semplice problema relazionale: attiva immediatamente il percorso competente.

DALL'ASCOLTO AL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

Reclami e segnalazioni non servono soltanto a gestire il singolo episodio. Se raccolti e analizzati correttamente, possono evidenziare istruzioni poco chiare, risposte incoerenti, barriere di accessibilità, passaggi ridondanti o problemi ricorrenti.

L'URP può contribuire all'ascolto e al raccordo informativo, ma la valutazione dei dati e le decisioni organizzative spettano alle strutture competenti. Il miglioramento richiede informazioni attendibili: classificazioni coerenti, dati non duplicati, rispetto della riservatezza e distinzione tra percezione dell'utente e fatti accertati.

Caso guidato: richiesta sensibile e reclamo allo sportello

SCENARIO E INFORMAZIONI DISPONIBILI

In una sala d'attesa affollata, una persona si presenta allo sportello e dice: «Sono la figlia del signor Rossi. Voglio sapere se è ancora ricoverato e perché nessuno mi ha telefonato. Inoltre mi serve subito la sua cartella clinica: ho scritto una richiesta, ma non ho la delega. Voglio fare reclamo».

L'operatore può consultare alcune applicazioni dell'azienda, ma non sa se la persona sia delegata o rappresentante. La procedura locale prevede un canale per i reclami e un diverso ufficio per le richieste documentali.

QUALIFICAZIONE DEI BISOGNI

L'operatore non cerca subito il nome del paziente. Protegge la conversazione, abbassa il tono e, se possibile, propone un punto più riservato. Non conferma né smentisce il ricovero.

Riformula: «Lei sta presentando tre esigenze diverse: chiede informazioni riferite a una persona, vuole segnalare un disservizio nelle comunicazioni e desidera sapere come presentare una richiesta documentale. Le spiego quali passaggi posso gestire e quali verifiche sono necessarie».

La riformulazione separa:

1. richiesta di informazione individuale;
2. reclamo sul servizio;
3. richiesta di documentazione sanitaria.

TUTELA DEI DATI, PRESA IN CARICO ED ESCALATION

Per l'informazione individuale mancano identità verificata, legittimazione e certezza sul canale applicabile. L'operatore non consulta il sistema per curiosità e non comunica dati. Indica il percorso attraverso il quale la persona può dimostrare il proprio titolo o contattare la struttura autorizzata.

Per il reclamo raccoglie soltanto gli elementi richiesti dalla procedura. Distingue ciò che la persona riferisce dai fatti che dovranno essere verificati. Non promette che verrà riconosciuta una responsabilità.

Per la richiesta documentale spiega che il rapporto familiare dichiarato non sostituisce il titolo necessario. Indica l'ufficio, il modulo o il canale previsti e i documenti da verificare, senza svolgere al banco l'istruttoria riservata all'ufficio competente.

Se la persona riferisce un pericolo attuale, un'urgenza sanitaria o una situazione che supera la gestione amministrativa, l'operatore attiva immediatamente la funzione competente. Non offre valutazioni cliniche.

RISPOSTA E SCHEDA CONCLUSIVA

Allo sportello, l'operatore potrebbe dire:

«In questa area non posso confermare informazioni riferite alla persona indicata senza le verifiche previste. Posso però illustrarle il percorso corretto. Per le informazioni individuali occorre rivolgersi alla struttura autorizzata attraverso il canale indicato. Il reclamo può essere acquisito separatamente: registrerò i fatti che mi riferisce e lo trasmetterò all'ufficio competente. Per la documentazione sanitaria deve presentare la richiesta con il titolo e gli elementi richiesti; l'ufficio dedicato verificherà identità, legittimazione e contenuto della domanda. L'acquisizione non garantisce l'esito né una priorità».

La scheda di contatto riporta:

- canale e data;
- tre bisogni distinti;
- mancata disponibilità, allo sportello, degli elementi necessari per comunicare dati individuali;
- informazione generale fornita;
- reclamo acquisito o indirizzato secondo procedura;
- richiesta documentale instradata;
- eventuale coinvolgimento del responsabile;
- comunicazione resa all'utente.

Non riporta ipotesi cliniche né dettagli sanitari non necessari.

La soluzione resta valida anche se cambiano nomi degli uffici e moduli. Prima di operare realmente occorre conoscere carta dei servizi, regolamento, canali, orari, competenze, tempi e livelli di escalation dell'azienda.

Allenamento da concorso e verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: Quali sono le funzioni del front-office e dell'URP in un'azienda sanitaria e come si conciliano orientamento all'utente, competenza e riservatezza?

Traccia per la risposta:

1. definisci il front-office come punto di relazione, anche telefonico o digitale;
2. collega l'URP a informazione, accesso, partecipazione, uso dei servizi, ascolto e raccordo;
3. distingui URP e ufficio competente;
4. descrivi ascolto, qualificazione, verifica, risposta o instradamento;

5. separa informazione generale e dati individuali;
6. richiama identità, legittimazione, minimizzazione, ambiente e canale;
7. chiudi con tracciamento ed escalation;
8. precisa che procedura, tempi e ruoli concreti dipendono dall'ente.

All'orale non basta dire che l'URP «cura i rapporti con il pubblico». Occorre spiegare che cosa fa, fino a dove può arrivare e come protegge l'utente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: Per aiutare l'utente, l'operatore può comunicare al familiare le informazioni disponibili e regolarizzare successivamente la pratica?

Risposta: No. L'orientamento al servizio non elimina identità, legittimazione, competenza, minimizzazione e adeguatezza del canale. L'operatore evita di confermare dati individuali, protegge la conversazione e indica il percorso attraverso il quale compiere le verifiche. Regolarizzare dopo non cancella una comunicazione indebita già avvenuta.

MINI-ESERCIZIO DI CLASSIFICAZIONE

Classifica i contatti e indica l'azione iniziale.

1. «Quali sono gli orari dello sportello vaccinazioni?»
2. «Ho presentato una domanda e voglio sapere se è stata accolta».
3. «La rampa di accesso è ostruita da diversi giorni».
4. «Ieri ho atteso due ore senza ricevere spiegazioni e voglio una risposta».
5. «Vorrei una copia del referto di mia moglie».
6. «Una persona è caduta all'ingresso e sembra ferita».

Soluzione ragionata:

1. informazione generale: fornire dato verificato e fonte istituzionale;
2. pratica individuale: verificare identità, competenza e canale;
3. segnalazione, con possibile profilo di sicurezza e accessibilità: registrare e attivare la funzione competente;
4. reclamo: qualificare, acquisire e instradare senza promettere esito;
5. richiesta documentale con dati sanitari di terzi: non consegnare, verificare titolo e indirizzare al percorso specifico;
6. situazione urgente: attivare immediatamente il percorso di emergenza previsto, senza ridurla a reclamo.

ESERCIZIO DI RISCrittURA

Trasforma questa risposta:

«La S.V. deve produrre idonea documentazione; in difetto l'istanza non potrà essere esitata».

Una versione più chiara, in questo esempio fittizio di ritiro di documenti, è:

«Manca la delega firmata dalla persona cui si riferisce il referto. La consegni allo Sportello documentazione sanitaria insieme alla documentazione richiesta per verificare l'identità del delegante e del delegato. Se preferisce inviarla online, acceda con SPID alla sezione “Le mie richieste — Documentazione sanitaria” del portale dell'azienda e la alleggi alla pratica n. 125. Lo sportello verificherà i documenti prima di autorizzare il ritiro».

Nome dello sportello, percorso del portale e numero di pratica sono inventati per l'esercizio: in una risposta reale si sostituiscono con dati istituzionali verificati. La riscrittura nomina il documento mancante e rende eseguibile il passo successivo.

Controlla se la tua versione:

- identifica ciò che manca;
- indica un'azione possibile;
- nomina il canale o l'ufficio;
- spiega il passaggio successivo;
- evita promesse.

SCHEMA DI PRESA IN CARICO

Compila la scheda per uno dei sei contatti:

- bisogno espresso:
- bisogno qualificato:
- persona interessata:
- identità o titolo da verificare:
- competenza individuata:
- dato trattabile:
- canale adeguato:
- azione iniziale:
- evidenza da conservare:
- eventuale escalation:
- risposta resa all'utente:

RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE

Assegna un punto per ogni criterio rispettato:

Criterio	Domanda di controllo
Ascolto	ho compreso il risultato cercato dall'utente?
Qualificazione	ho separato richieste diverse?

Criterio	Domanda di controllo
Competenza	so chi può rispondere o decidere?
Correttezza	l'informazione è verificata?
Chiarezza	il passo successivo è comprensibile?
Accessibilità	il destinatario può utilizzare contenuto e canale?
Riservatezza	ho protetto dati, ambiente e destinatario?
Minimizzazione	ho raccolto solo ciò che serve?
Tracciabilità	l'azione può essere ricostruita?
Escalation	ho riconosciuto il limite del mio ruolo?

Da otto a dieci punti la risposta è ben strutturata; da cinque a sette richiede un controllo mirato; sotto cinque occorre ricostruire il caso partendo dal bisogno e non dalla soluzione intuitiva.

Il totale si usa soltanto dopo il controllo degli errori critici. Divulgare dati a chi non è legittimato, accedere a informazioni senza titolo o promettere un esito che esula dalla propria competenza rende la risposta insufficiente anche con otto o più punti. Correggi prima quell'azione e poi rivaluta gli altri criteri. La stessa priorità alla sicurezza compare nella rubrica dei casi professionali del modulo M-SA02, capitolo «Prova pratica e casi professionali».

CHECKLIST FINALE

Prima di chiudere un contatto verifica:

- ☐ Ho ascoltato senza anticipare la soluzione.
- ☐ Ho riformulato il bisogno.
- ☐ Ho separato informazione, istanza, reclamo, segnalazione e richiesta documentale.
- ☐ Ho controllato la competenza.
- ☐ Ho distinto informazione generale e dato individuale.
- ☐ Ho verificato identità e legittimazione quando necessarie.
- ☐ Ho trattato soltanto i dati necessari.
- ☐ Ho scelto un ambiente e un canale adeguati.

- ☐ Ho usato un linguaggio chiaro e accessibile.
- ☐ Ho indicato il passaggio successivo senza promettere l'esito.
- ☐ Ho registrato o instradato il contatto secondo la procedura.
- ☐ Ho attivato il responsabile quando il caso superava il mio ruolo.

Collegamenti con il volume base

Il capitolo contiene le conoscenze necessarie per affrontare il nucleo specialistico in modo autonomo. Per consolidare le tecniche trasversali puoi collegarlo a Il Metodo BANDO (VOL-01):

- Capitolo 7 — Trasparenza, anticorruzione e privacy, per il quadro generale sulla protezione dei dati e sui limiti alla comunicazione;
- Capitolo 10 — Informatica, PA digitale e competenze digitali, per i principi generali sui servizi digitali e sull'accessibilità;
- Capitolo 15 — La prova scritta e teorico-pratica, per la struttura generale di una comunicazione amministrativa;
- Capitolo 17 — Casi pratici e problem solving amministrativo, per il metodo di analisi e soluzione dei casi;
- Capitolo 18 — Quesiti situazionali e soft skills, per allenare comunicazione, collaborazione e orientamento al servizio.

Questi rinvii servono ad approfondire il metodo generale: definizioni, distinzioni e procedure necessarie per il front-office sanitario restano sviluppate nel presente capitolo.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 giugno 2000, n. 150: disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e inquadra le funzioni dell'URP.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: è il riferimento generale per procedimento, partecipazione e accesso documentale, quando il contatto assume tale natura.
- Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101: regolano la protezione dei dati personali e richiedono cautele rafforzate per i dati relativi alla salute.
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale: inquadra servizi e comunicazioni digitali della pubblica amministrazione.

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e disciplina collegata: costituiscono il riferimento nazionale per l'accessibilità degli strumenti informatici.
- Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 giugno 2023: approva il modello delle competenze trasversali del personale non dirigenziale, comprendente comunicazione, collaborazione, orientamento al servizio, affidabilità, accuratezza e inclusione.
- Carta dei servizi, regolamento URP, procedura per reclami e organizzazione dell'azienda: definiscono canali, uffici, fasi, tempi e livelli di escalation applicabili nel contesto concreto.

Nel front-office, aiutare bene richiede di comprendere, verificare, spiegare, proteggere e tracciare. Una risposta veloce ma impropria espone la persona e l'amministrazione; una risposta competente rende il servizio più accessibile senza oltrepassare i limiti del ruolo.

Contabilità, budget e controllo di gestione nelle aziende sanitarie

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Un'azienda sanitaria non può scoprire soltanto a fine anno quanto ha speso e che cosa ha ottenuto. Prima programma le attività e assegna le risorse; durante la gestione rileva costi, ricavi e risultati; quando emergono differenze rispetto agli obiettivi deve capirne le ragioni e decidere come intervenire. La contabilità descrive i fatti di gestione, il budget traduce i programmi in obiettivi e risorse, il controllo di gestione usa quei dati per decidere.

Nel Servizio sanitario nazionale le risorse sono pubbliche e limitate, mentre i bisogni assistenziali sono complessi. Perciò l'equilibrio economico va letto insieme alla capacità di assicurare i livelli di assistenza e alla qualità dell'organizzazione. Un buon risultato sanitario non autorizza a ignorare i costi; un costo contenuto, da solo, non prova che il servizio funzioni bene.

Nei concorsi il tema compare in forme diverse: domanda teorica, quesito a risposta multipla, tabella da leggere, prova con foglio di calcolo o breve nota da redigere. Le sigle da sole servono a poco. Bisogna sapere quale strumento si sta usando, che cosa misura e chi può agire sul risultato.

Obiettivo didattico, Mappa BANDO e catena del controllo

Al termine del capitolo saprai:

- inquadrare la specificità della contabilità delle aziende sanitarie;
- distinguere fonti del finanziamento, riparto, assegnazione aziendale, budget e disponibilità di cassa;
- riconoscere risorse vincolate, finanziamento corrente e investimenti, remunerazione degli erogatori e mobilità sanitaria;
- distinguere contabilità generale, contabilità analitica, bilancio d'esercizio, budget e reporting direzionale;
- spiegare la funzione di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario;
- distinguere il bilancio dai modelli economici NSIS CE, SP, LA e CP;
- collegare programmazione, budget, centri di responsabilità, indicatori e ciclo della performance;
- calcolare e interpretare uno scostamento assoluto e percentuale;
- separare il dato dalla causa ipotizzata, dal controllo da svolgere e dall'azione da proporre;
- costruire una risposta orale, una tabella commentata e una breve nota professionale.

DAL PROGRAMMA AL DATO E ALL'AZIONE

La sequenza da ricordare è:

programmazione → obiettivi → risorse → budget → rilevazione contabile → contabilità analitica → reporting → scostamento → causa da verificare → controllo → azione correttiva.

Ogni passaggio risponde a una domanda diversa. La programmazione stabilisce che cosa si vuole ottenere. Il budget collega gli obiettivi alle risorse. La contabilità rileva ciò che è avvenuto. La contabilità analitica attribuisce costi e risultati agli oggetti gestionali utili. Il reporting confronta attese e risultati. L'analisi ricerca spiegazioni verificabili. Il controllo accerta i fatti. L'azione corregge il processo o aggiorna responsabilmente le previsioni.

MAPPA BANDO

Domande e parole chiave

Passaggio	Domanda guida	Parole chiave
B — Bando	Quale competenza viene richiesta?	contabilità, budget, controllo di gestione, analisi dati
A — Aree	Quali sistemi devo distinguere?	bilancio, contabilità generale e analitica, NSIS, performance
N — Nuclei	Quali concetti non possono mancare?	obiettivi, risorse, centri, indicatori, scostamenti
D — Diario	Come controllo l'apprendimento?	formule, classificazioni, casi, errori
O — Output	Che cosa devo saper produrre?	risposta orale, tabella, nota, proposta

Output da prova

Passaggio	Output da prova
B — Bando	perimetro della risposta
A — Aree	mappa degli strumenti
N — Nuclei	scaletta teorica
D — Diario	esercizi e correzioni
O — Output	elaborato verificabile

ATTENZIONE

Uno scostamento segnala una differenza da approfondire. Prima di parlare di errore, inefficienza o responsabilità, confronta periodo, perimetro, volume di attività, qualità del dato e cause documentate.

CHE COSA PUÒ CHIEDERE LA PROVA

Una domanda teorica può chiedere di illustrare il rapporto tra budget e controllo di gestione. Un quesito può verificare se il modello CE rappresenti costi e ricavi o attività e passività. Una prova pratica può fornire valori programmati e consuntivi e chiedere di calcolare lo scostamento. Un caso può richiedere di proporre controlli senza attribuire colpe non accertate.

Una buona risposta segue quattro passaggi:

1. definire lo strumento;
2. distinguerlo dagli strumenti vicini;
3. mostrarne la funzione nella catena gestionale;
4. applicarlo a un dato o a una decisione.

Inquadramento teorico: perché la contabilità sanitaria è specifica**AZIENDA SANITARIA, ECONOMICITÀ E VINCOLO DI BILANCIO**

L'azienda sanitaria è un soggetto pubblico inserito nel sistema regionale e nazionale di tutela della salute. L'aziendalizzazione avviata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ha rafforzato autonomia organizzativa e responsabilità gestionale, collegandole a efficacia, efficienza, economicità e vincolo di bilancio.

Questi concetti non sono sinonimi.

- L'efficacia riguarda il grado di raggiungimento degli obiettivi.
- L'efficienza osserva il rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate.
- L'economicità esprime la capacità di mantenere nel tempo un rapporto sostenibile tra risorse, attività e risultati.
- L'equilibrio economico richiede che la gestione sia governata senza ignorare la relazione tra componenti positivi e negativi.

Nel settore sanitario la lettura economica deve restare collegata alla missione assistenziale. Ridurre una spesa può essere ragionevole se elimina sprechi; può essere dannoso se compromette un servizio necessario. Aumentare un costo può segnalare inefficienza, ma può anche derivare da più prestazioni, maggiore complessità dei casi, variazione dei prezzi, nuove prescrizioni normative o recupero di attività arretrate. Il dato economico apre l'analisi: non la chiude.

I livelli essenziali di assistenza costituiscono un riferimento sostanziale della programmazione sanitaria. Prevenzione collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera richiedono organizzazioni, risorse e sistemi di rilevazione differenti. Perciò il governo economico deve poter leggere sia l'azienda nel suo complesso sia le aree nelle quali si formano attività e costi.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'azienda sanitaria persegue finalità pubbliche, ma deve governare risorse e risultati. Efficacia, efficienza, economicità ed equilibrio sono concetti collegati ma distinti. Il costo non può essere letto senza volume, qualità e perimetro dell'attività. Il vincolo di bilancio non sostituisce la tutela della salute. Il controllo corretto integra dimensione assistenziale, organizzativa ed economica.

IL TITOLO II DEL D.LGS. 118/2011

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili pubblici. Il Titolo II riguarda i principi contabili generali e applicati del settore sanitario. La contabilità delle aziende sanitarie appartiene quindi al sistema pubblico, ma segue un perimetro specifico.

In sede d'esame sono frequenti due errori opposti. Il primo consiste nel trattare l'azienda sanitaria come un'impresa privata qualsiasi, ignorando finanziamento pubblico, programmazione regionale, obblighi informativi e controlli. Il secondo consiste nell'applicarle automaticamente tutti gli istituti della contabilità finanziaria degli enti locali.

Il candidato deve quindi dichiarare il perimetro: il capitolo generale di contabilità pubblica spiega principi, programmazione, bilanci e controlli comuni; qui interessa il loro adattamento al settore sanitario, in cui la contabilità economico-patrimoniale, i modelli di rilevazione economica e la contabilità analitica sostengono il governo aziendale e il monitoraggio del sistema.

**CONTABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE: I
CONFINI**

La contabilità finanziaria osserva autorizzazioni, entrate e spese secondo le regole proprie dell'amministrazione considerata. È centrale, con discipline specifiche, in numerosi enti pubblici. La contabilità economico-patrimoniale osserva invece costi, ricavi o proventi, componenti economiche, attività, passività e variazioni del patrimonio secondo il principio di competenza economica.

La competenza economica attribuisce gli effetti della gestione al periodo al quale si riferiscono, non semplicemente al momento in cui avviene un pagamento o un incasso. Per questo un costo non coincide necessariamente con un'uscita di denaro nello stesso momento. Analogamente, l'acquisto di un bene durevole produce effetti patrimoniali ed economici che non si esauriscono nel pagamento.

Prima di trasferire alle aziende sanitarie un istituto previsto per Comuni o altri enti territoriali, bisogna verificarne l'applicabilità. Fasi della spesa, fondi e documenti di programmazione degli enti locali appartengono al relativo ordinamento contabile. Per gli enti del SSN si parte invece dalla disciplina di settore, dagli atti regionali e dal sistema aziendale.

Errore tipico: affermare che «la contabilità pubblica funziona sempre per impegni e pagamenti» e applicare la frase a qualunque ente. Prima si identifica il soggetto; poi si individuano disciplina, sistema contabile e documento richiesto.

Come si finanzia il SSN e come le risorse arrivano ai servizi

FABBISOGNO, FONTI E RIPARTO

Il finanziamento sanitario mette a disposizione risorse per assicurare i servizi e le prestazioni. La contabilità registra gli effetti della loro gestione; il budget aziendale collega le risorse agli obiettivi operativi. Per comprendere un bilancio sanitario occorre quindi sapere anche da dove provengano le risorse e a quali condizioni possano essere impiegate.

Il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato individua il livello di finanziamento definito dalla legislazione per il sistema. Non coincide con tutta la spesa sanitaria pubblica: quest'ultima comprende anche altre risorse e programmi. In una domanda con importi numerici bisogna controllare anno, perimetro e natura della grandezza. Confrontare una previsione di finanziamento ordinario con la spesa complessiva di un altro esercizio produce un risultato privo di significato.

Nel sistema di finanziamento concorrono entrate proprie, come i ticket nei casi previsti, gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo le regole applicabili, compartecipazione all'IVA e risorse del bilancio statale. I meccanismi di perequazione e garanzia servono a sostenere il fabbisogno secondo il quadro normativo, evitando di identificare la capacità di assicurare assistenza con il solo gettito prodotto nel territorio. Il D.Lgs. 56/2000 e il D.Lgs. 68/2011 costituiscono riferimenti per questa architettura e per i fabbisogni standard. Le autonomie speciali presentano regimi specifici: uno schema generale non ne descrive tutte le particolarità.

Il riparto distribuisce le risorse tra i sistemi regionali attraverso le procedure previste, con il coinvolgimento dello Stato e delle Regioni e le deliberazioni del CIPESS. La popolazione e i bisogni assistenziali concorrono ai criteri applicabili. La quota capitaria esprime una risorsa riferita alla popolazione; quando è ponderata tiene conto dei fattori previsti per rappresentare bisogni differenti. Non si può però ridurre qualsiasi riparto alla moltiplicazione del numero dei residenti per una cifra identica: esistono componenti, vincoli e criteri specifici.

Le quote indistinte finanziano il sistema secondo la programmazione generale; le quote vincolate hanno una destinazione individuata. L'azienda non può considerare una risorsa vincolata come un fondo disponibile per qualunque esigenza. Il vincolo deve essere riconoscibile negli atti di assegnazione e nella gestione, fino alla rendicontazione richiesta.

DALL'ASSEGNAZIONE REGIONALE AL BUDGET AZIENDALE

La Regione assegna risorse alle aziende raccordandole agli obiettivi, ai servizi da assicurare e alle regole del proprio sistema. L'azienda le impiega nella programmazione e le traduce in budget per strutture e centri di responsabilità. La negoziazione interna verifica se attività richieste e mezzi disponibili siano coerenti. Avere ricevuto un obiettivo dalla direzione non significa disporre automaticamente di una nuova entrata: occorre individuare l'assegnazione e il relativo margine di gestione.

Il Titolo II del D.Lgs. 118/2011 richiede una rappresentazione riconoscibile del perimetro sanitario. Se la Regione gestisce direttamente una parte del finanziamento, la gestione sanitaria accentrata, GSA, ne assicura la rilevazione secondo le regole previste; il raccordo con i conti degli enti permette di rappresentare il sistema regionale evitando duplicazioni dei rapporti interni. GSA non è il nome di un ulteriore reparto dell'ASL.

Conviene tenere distinti quattro passaggi:

Passaggio	Che cosa stabilisce o osserva
Riparto	Distribuzione delle risorse secondo i criteri del sistema.
Assegnazione all'azienda	Risorse, destinazioni e condizioni attribuite all'ente.
Budget interno	Obiettivi e mezzi riferiti ai responsabili aziendali.
Gestione di cassa	Incassi, pagamenti e disponibilità liquide nel tempo.

Un'assegnazione prevista o formalizzata può essere incassata in un momento diverso. Per questo un equilibrio economico programmato non dimostra, da solo, che tutte le somme siano già in tesoreria. Il controllo amministrativo deve leggere titolo dell'assegnazione, competenza economica, calendario dei trasferimenti e fabbisogno di liquidità, senza confondere un ricavo o contributo con un incasso.

FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI E REMUNERAZIONE DEGLI EROGATORI

Il finanziamento corrente sostiene il funzionamento dei servizi, secondo destinazioni e regole applicabili. Il finanziamento per investimenti sostiene interventi come acquisto di attrezzature o realizzazione di strutture. Le due esigenze sono collegate: una nuova apparecchiatura può richiedere personale, manutenzione e materiali negli anni successivi. Il contributo che ne consente l'acquisto non finanzia automaticamente ogni costo futuro. La valutazione deve quindi considerare sostenibilità dell'intero servizio, oltre al prezzo iniziale.

Anche il modo in cui si remunerano gli erogatori richiede una distinzione. L'articolo 8-sexies del D.Lgs. 502/1992 considera funzioni assistenziali e prestazioni. La remunerazione di una funzione tiene conto dell'attività organizzata che deve essere garantita; quella a prestazione utilizza tariffe e regole di classificazione applicabili. La tariffa è un criterio di remunerazione: può differire dal costo effettivamente sostenuto dalla singola struttura.

Per gli erogatori contrattualizzati, volumi, condizioni economiche e controlli devono essere letti nell'accordo applicabile. Un aumento delle prestazioni prodotte non genera sempre un identico aumento della somma dovuta: rilevano limiti, appropriatezza, regole di riconoscimento e rendicontazione. Come spiegato nel capitolo sugli atti sanitari, l'accreditamento non sostituisce l'accordo contrattuale. Allo stesso modo, un budget interno assegnato a un reparto e il limite contrattuale riconosciuto a un erogatore esterno non sono il medesimo documento.

MOBILITÀ SANITARIA: ATTIVITÀ E COMPENSAZIONE ECONOMICA

Quando un assistito riceve prestazioni fuori dal territorio del proprio sistema di appartenenza, la mobilità sanitaria produce anche rapporti economici fra i sistemi coinvolti. Si parla di mobilità attiva dal punto di vista del sistema che eroga a persone provenienti da altri territori, e passiva dal punto di vista di quello cui appartengono gli assistiti curati altrove. Dati di attività, regole di valorizzazione e procedure di contestazione e compensazione consentono di riconciliare le relative partite.

Un saldo di mobilità non è, isolatamente, un voto sulla qualità del servizio. Può dipendere dalla presenza di centri specializzati, dalla posizione geografica, dalla disponibilità dell'offerta e dalle scelte degli assistiti. Il controllo di gestione deve chiedere quali prestazioni e quali popolazioni producano il saldo, in quale periodo e con quali regole. Prima di proporre di aumentare la capacità di una struttura, occorre capire il bisogno al quale si intende rispondere.

CASO GUIDATO: RISORSE ASSEGNATE E SOMME UTILIZZABILI

Un'azienda riceve, in un esempio esclusivamente didattico, un'assegnazione corrente di 8 milioni di euro e un contributo vincolato di 1 milione per una nuova attrezzatura. Il responsabile propone di utilizzare 300.000 euro del contributo per coprire servizi ordinari, sostenendo che «il totale delle entrate è 9 milioni». Nello stesso momento risultano incassati soltanto 6 milioni dell'assegnazione corrente.

La proposta confonde destinazione delle risorse e disponibilità complessiva. Il contributo per l'attrezzatura deve essere gestito secondo il suo vincolo; non diventa liberamente utilizzabile per il funzionamento solo perché compare fra le risorse dell'azienda. Occorre verificare il titolo di assegnazione, le spese ammesse e le eventuali modalità di variazione previste. L'ufficio non può rimuovere il vincolo con una semplice riclassificazione contabile.

Il secondo problema riguarda la cassa. La differenza di 2 milioni tra assegnazione corrente e incasso non dimostra automaticamente né una perdita né un errore: richiede di verificare scadenze, condizioni e trasferimenti attesi. La previsione dei pagamenti deve considerare la liquidità effettiva e il calendario attendibile degli incassi.

La nota al responsabile può concludere così: «Si propone di mantenere separata la destinazione del contributo per investimento e di ricostruire il fabbisogno corrente con le risorse pertinenti. Per i pagamenti si verifica il calendario dei trasferimenti ancora da incassare. La nuova attrezzatura richiede inoltre una stima dei costi futuri di utilizzo, da inserire nella programmazione». La soluzione risponde ai due problemi senza sommare impropriamente risorse diverse.

VERIFICA SUL FINANZIAMENTO SANITARIO

1. Fabbisogno sanitario standard e spesa sanitaria pubblica totale: A) sono sempre identici; B) hanno perimetri da distinguere; C) sono entrambi la cassa di una singola ASL. Risposta B. Il finanziamento ordinario non esaurisce tutte le componenti di spesa; la liquidità aziendale è un'altra grandezza.
2. Un contributo vincolato per investimento: A) può coprire liberamente qualunque costo corrente; B) si usa secondo destinazione e condizioni dell'assegnazione; C) elimina i futuri costi di funzionamento. Risposta B. Né l'esistenza del contributo né l'acquisto del bene risolvono da soli la sostenibilità della gestione.
3. La tariffa riconosciuta per una prestazione: A) coincide necessariamente con il costo effettivo dell'erogatore; B) è una regola di remunerazione da applicare nel rapporto pertinente; C) consente di superare qualsiasi limite contrattuale. Risposta B. Il confronto con il costo serve alla gestione; il riconoscimento economico resta soggetto alle condizioni applicabili.
4. Un'assegnazione è formalizzata ma non ancora incassata: A) si devono distinguere titolo, competenza e cassa; B) la somma è già disponibile sul conto; C) è certamente una perdita. Risposta A. Il ritardo o la scansione del trasferimento richiedono verifica; non autorizzano nessuna delle due conclusioni automatiche.

5. La mobilità passiva di un sistema sanitario: A) riguarda assistenza dei propri assistiti presso altri territori; B) misura esclusivamente assenza di qualità; C) coincide con debiti verso i fornitori di beni. Risposta A. Le cause della mobilità richiedono analisi; le compensazioni sanitarie vanno distinte dal ciclo passivo degli acquisti.

Mini-esercizio. Riprendi il caso degli 8 milioni correnti e del milione vincolato. Indica quale documento cercheresti per verificare la destinazione del contributo, quale dato serve per programmare i pagamenti e quale costo futuro dell'attrezzatura va stimato. Controllo: titolo di assegnazione e relative condizioni; calendario attendibile dei trasferimenti e delle uscite; per esempio manutenzione, personale o materiali. Rispondere soltanto «controllo il saldo di bilancio» non distingue i problemi.

Sistemi contabili e bilancio d'esercizio

CONTABILITÀ GENERALE E CONTABILITÀ ANALITICA

La contabilità generale registra in modo sistematico i fatti di gestione che hanno rilevanza economica e patrimoniale. Consente di determinare il risultato economico del periodo e di rappresentare la situazione patrimoniale dell'azienda. La sua prospettiva principale è complessiva: deve offrire una rappresentazione dell'ente secondo regole comuni e verificabili.

La contabilità analitica, o contabilità dei costi, rielabora i dati per finalità interne di programmazione e controllo. Cerca di rispondere a domande come:

- dove si forma il costo?
- quale attività o servizio assorbe le risorse?
- quale centro è collegato al risultato?
- come varia il costo rispetto al volume prodotto?
- quale parte dello scostamento richiede un approfondimento?

Le due contabilità svolgono compiti diversi. La contabilità generale rappresenta l'azienda nel suo complesso; quella analitica aggiunge il dettaglio necessario alla gestione. Per essere attendibile, il dettaglio deve raccordarsi alla base contabile e usare criteri di attribuzione dichiarati. Una ripartizione incoerente dei costi indiretti produce numeri precisi solo in apparenza.

Un centro di costo è un'unità alla quale vengono attribuiti costi per analizzarne la formazione. Un centro di responsabilità è un ambito organizzativo nel quale un responsabile riceve obiettivi e risorse ed è chiamato a rendere conto dei risultati entro le leve effettivamente governabili. Le due figure possono coincidere, ma non necessariamente.

Esempio: un laboratorio può essere osservato come centro di costo per misurare personale, reagenti e servizi assorbiti. La responsabilità del dirigente, però, deve essere valutata considerando obiettivi assegnati, volumi richiesti, qualità, vincoli tecnici e decisioni che dipendono da altri livelli. Attribuire un costo a un centro non significa attribuire automaticamente una colpa al suo responsabile.

CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO FINANZIARIO

Il conto economico rappresenta i componenti positivi e negativi del periodo e conduce alla determinazione del risultato economico. Aiuta a comprendere come costi e ricavi o proventi abbiano contribuito al risultato.

Lo stato patrimoniale rappresenta attività, passività e patrimonio alla data di riferimento. Risponde a una domanda diversa: non come si è formato il risultato nel periodo, ma quali risorse e obbligazioni compongono la situazione patrimoniale.

Il rendiconto finanziario descrive i flussi finanziari del periodo: mostra come la gestione abbia generato o assorbito disponibilità liquide. Non va confuso con il rendiconto della gestione previsto da altri ordinamenti pubblici.

I tre prospetti offrono dimensioni complementari:

- il conto economico legge la dinamica economica;
- lo stato patrimoniale legge le consistenze patrimoniali;
- il rendiconto finanziario legge i flussi finanziari.

Il bilancio d'esercizio è il sistema informativo formale composto dai prospetti e dagli altri elementi previsti dalla disciplina applicabile. Non coincide con un'esportazione del programma contabile o con una tabella preparata per il direttore di struttura. Documenti, allegati, criteri di valutazione, procedimento di adozione e controlli dipendono dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali applicabili.

I DOCUMENTI OBBLIGATORI E IL CICLO NAZIONALE

Il Titolo II del D.Lgs. 118/2011 disciplina specificamente il settore sanitario. L'art. 26 compone il bilancio d'esercizio di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; lo accompagna la relazione sulla gestione. La nota integrativa spiega criteri e voci dei prospetti; la relazione sulla gestione collega risultati, attività e andamento aziendale. Non sono documenti intercambiabili. Nei casi previsti, CE e SP sono contenuti nella nota integrativa e il modello LA nella relazione sulla gestione.

Passaggio	Responsabilità e documento	Termine ordinario
Previsione	Bilancio preventivo economico annuale, art. 25, coerente con programmazione e risorse	Secondo disciplina e calendario applicabili
Adozione del consuntivo	Direttore generale per gli enti dell'art. 19, comma 2, lettera c); relazione del collegio sindacale a corredo	30 aprile dell'anno successivo, art. 31
Approvazione dei bilanci degli enti	Giunta regionale, art. 32, comma 7	31 maggio dell'anno successivo
Approvazione del consolidato sanitario regionale	Giunta regionale, dopo le operazioni di consolidamento	30 giugno dell'anno successivo

Il responsabile della gestione sanitaria accentrata adotta il bilancio della GSA, ove prevista, e cura gli adempimenti di consolidamento. Il collegio sindacale esercita controllo e redige la propria relazione: non sostituisce il direttore generale nell'adozione o la Giunta nell'approvazione. Per un esercizio concreto si controllano anche eventuali deroghe legislative e istruzioni regionali; queste ultime non trasformano una scadenza organizzativa in una regola nazionale.

ESEMPIO: AMMORTAMENTO E CONTRIBUTO PER INVESTIMENTO

Un'azienda acquista un bene per 100.000 euro, interamente finanziato da un contributo in conto capitale. Per l'esercizio si ipotizzano cinque quote annue uguali, un anno intero di utilizzo e valore residuo nullo: la quota di ammortamento è $100.000 / 5 = 20.000$ euro. La durata è un dato didattico, non una regola per ogni apparecchiatura.

Il bene entra nelle immobilizzazioni. Il costo viene ripartito negli esercizi tramite ammortamento; il pagamento, invece, rileva nella dinamica finanziaria quando avviene. Secondo l'art. 29, comma 1, lettera c), il contributo è progressivamente stornato a proventi in misura commisurata all'ammortamento del bene finanziato. Nell'esempio, costo di ammortamento di 20.000 euro e quota di provento di 20.000 euro si compensano nel risultato economico: è la sterilizzazione dell'ammortamento. Dopo il primo anno, il valore contabile netto del bene e il contributo residuo sono entrambi 80.000 euro, nelle ipotesi date.

Domanda: l'incasso di 100.000 euro autorizza a registrare subito l'intero contributo come ricavo liberamente disponibile per spese correnti? Risposta: no. Destinazione del finanziamento, rilevazione patrimoniale, imputazione economica e cassa sono piani distinti. Il vincolo d'investimento non viene cancellato dall'incasso.

DAL FATTO DI GESTIONE ALL'INFORMAZIONE DIREZIONALE

Considera l'acquisto e l'impiego di materiali sanitari. Il fatto di gestione genera documenti, registrazioni e valori. La contabilità generale rileva gli effetti economici e patrimoniali. La contabilità analitica attribuisce i costi ai centri o alle attività secondo criteri definiti. Il reporting confronta i risultati con il budget. Il responsabile interpreta lo scostamento considerando quantità impiegate, prezzi, volumi, scorte e circostanze operative.

Il passaggio da un livello all'altro richiede controlli:

- 1. completezza, perché i fatti rilevanti devono essere acquisiti;
- 2. correttezza, perché classificazione e periodo devono essere appropriati;
- 3. riconciliazione, perché il dettaglio analitico deve raccordarsi con la base contabile;
- 4. coerenza, perché indicatori e confronti devono usare perimetri omogenei;
- 5. tempestività, perché un dato perfetto ma tardivo può perdere utilità decisionale.

Oggetto e funzione

Strumento	Oggetto principale	Funzione
Contabilità generale	fatti economici e patrimoniali	rappresentazione complessiva
Contabilità analitica	costi, attività, centri, oggetti di calcolo	programmazione e controllo
Bilancio d'esercizio	risultato e situazione aziendale	rendicontazione formale
Budget	obiettivi e risorse attese	guidare la gestione futura
Reporting direzionale	confronto tra obiettivi e risultati	supportare analisi e decisioni

Destinatari e limiti

Strumento	Destinatario prevalente	Limite
Contabilità generale	organi, controlli, soggetti istituzionali	non spiega da sola dove e perché nasce ogni costo
Contabilità analitica	direzione e responsabili	dipende da criteri di attribuzione e qualità dei dati

Strumento	Destinatario prevalente	Limite
Bilancio d'esercizio	organi aziendali e istituzionali	non coincide con il budget
Budget	direzione e centri di responsabilità	non è una previsione immutabile né un consuntivo
Reporting direzionale	responsabili e direzione	lo scostamento non spiega da solo la causa

Modelli economici NSIS: CE, SP, LA e CP

Il Nuovo sistema informativo sanitario raccoglie flussi informativi utili al governo del Servizio sanitario nazionale. I modelli economici consentono rilevazioni standardizzate e comparabili. Standardizzare non significa sostituire la contabilità dell'ente: significa ricondurre determinate informazioni a schemi e regole comuni per trasmissione, consolidamento, monitoraggio e confronto.

CE E SP

Il modello CE — Conto economico rileva costi e ricavi degli enti del Servizio sanitario regionale secondo uno schema standardizzato. I dati servono al monitoraggio economico, al consolidamento, alle comparazioni e alle proiezioni. Sono previste rilevazioni a preventivo, infrannuali e a consuntivo; versioni, scadenze, rettifiche e calendari vanno verificati per l'esercizio considerato.

Il modello SP — Stato patrimoniale rileva attività e passività secondo lo schema previsto e aggiunge la dimensione patrimoniale alla lettura economica. È riferito alla data e al periodo stabiliti. Nel quadro qui esaminato, la rilevazione a consuntivo è annuale; istruzioni e finestre operative possono cambiare.

CE e SP sono distinti per oggetto:

- CE: componenti economiche del periodo;
- SP: consistenze patrimoniali alla data di riferimento.

Un costo per manutenzione può concorrere alla dinamica economica del CE. Un debito verso un fornitore ancora esistente alla chiusura partecipa alla rappresentazione patrimoniale nello SP. I raccordi sono importanti, ma i due modelli non sono versioni alternative della stessa tabella.

Il controllo verifica completezza, quadratura, coerenza temporale, corrispondenza con la fonte contabile e correttezza del perimetro. Nel consolidamento regionale deve anche impedire duplicazioni o rappresentazioni improprie dei rapporti interni.

LA E CONTO DEL PRESIDIO

Il modello LA rileva a consuntivo i costi riferiti ai livelli di assistenza. La sua chiave di lettura non è semplicemente la natura economica del costo, ma la sua attribuzione alle aree assistenziali previste. Aiuta quindi a osservare come i costi si distribuiscano rispetto alle funzioni di assistenza.

Il modello CP — Conto del Presidio rileva a consuntivo annuale i costi dei presidi ospedalieri compresi nel perimetro definito dalla disciplina. Permette così di leggere i costi con riferimento al singolo presidio.

Il D.M. 24 maggio 2019 collega LA e CP alla contabilità analitica e al controllo di gestione. Per tali modelli prevede anche la sottoscrizione del responsabile del controllo di gestione, oltre alle sottoscrizioni richieste nel sistema dei modelli economici. Questo elemento mostra perché la qualità della contabilità analitica non è un fatto meramente interno: alimenta rappresentazioni utilizzate anche a livelli istituzionali.

Le distinzioni essenziali sono:

- LA non coincide con CE: LA distribuisce i costi per livelli di assistenza; CE rappresenta costi e ricavi secondo lo schema economico;
- CP non coincide con SP: CP riguarda i costi del presidio; SP rappresenta attività e passività;
- LA e CP non sono due bilanci d'esercizio;
- il dettaglio analitico deve raccordarsi alla base contabile e al perimetro dichiarato.

BILANCIO, MODELLO, CONSOLIDAMENTO E CONTROLLO

Per evitare confusione, usa questa scheda.

Oggetto e momento

Sigla o documento	Che cosa osserva	Momento essenziale
Bilancio d'esercizio	risultato, patrimonio e altri elementi previsti	chiusura dell'esercizio
CE	costi e ricavi standardizzati	preventivo, infrannuale e consuntivo nel quadro operativo
SP	attività e passività standardizzate	consuntivo annuale nel quadro verificato
LA	costi per livelli di assistenza	consuntivo

Sigla o documento	Che cosa osserva	Momento essenziale
CP	costi del presidio ospedaliero	consuntivo annuale

Domande utili

Sigla o documento	Domanda utile
Bilancio d'esercizio	qual è la rappresentazione formale dell'azienda?
CE	come si presenta l'andamento economico nel modello?
SP	qual è la situazione patrimoniale rilevata?
LA	come si distribuiscono i costi tra le aree di assistenza?
CP	quali costi sono riferiti al presidio?

Il consolidamento combina i dati dei soggetti compresi in un perimetro ed elimina gli effetti che rappresenterebbero i rapporti interni come rapporti con soggetti esterni. Non è una somma meccanica di tabelle: richiede un perimetro definito, regole comuni e controlli.

Le istruzioni tecniche dei modelli possono cambiare. In una prova senza indicazione temporale, è prudente spiegare funzione e distinzione; se il quesito richiede versione, codice o scadenza, si applica la disciplina indicata nel bando o quella vigente alla data stabilita.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il bilancio è la rappresentazione formale dell'azienda; i modelli NSIS sono flussi standardizzati. CE osserva costi e ricavi, SP attività e passività. LA distribuisce costi per livelli di assistenza, CP rileva costi dei presidi. I quattro modelli non si sostituiscono tra loro. Per versioni e scadenze serve sempre il riferimento temporale corretto.

Domanda-trappola: «Poiché il modello CE si chiama Conto economico, coincide con il conto economico del bilancio?»

Risposta: no. Sono collegati e devono essere coerenti, ma il CE è un modello standardizzato di rilevazione e trasmissione; il conto economico è un prospetto del bilancio d'esercizio. Oggetto, funzione, procedimento e regole di compilazione non vanno sovrapposti.

Programmazione, budget e centri di responsabilità

LIVELLO REGIONALE E LIVELLO AZIENDALE

La programmazione sanitaria si sviluppa su più livelli. Il livello nazionale definisce il quadro generale e i livelli essenziali di assistenza. La Regione programma il servizio nel proprio territorio, organizza e finanzia il sistema secondo le competenze attribuite e svolge funzioni di indirizzo e controllo. L'azienda traduce gli indirizzi in obiettivi, attività e impiego delle risorse.

Gli obiettivi regionali non passano all'azienda come una semplice cascata di numeri: devono diventare attività concretamente gestibili. L'azienda considera domanda assistenziale, strutture, personale, tecnologie, vincoli, rischi e capacità produttiva. I centri di responsabilità partecipano alla definizione degli obiettivi e li gestiscono secondo le procedure aziendali.

Il calendario concreto, i documenti e i soggetti della negoziazione dipendono dalla disciplina regionale e dagli atti dell'azienda. In una risposta generale non si inventano date universali né si attribuisce sempre la stessa competenza a un ufficio. Si descrive invece la funzione dei passaggi.

OBIETTIVI, RISORSE, VOLUMI, COSTI E INDICATORI

Il budget è un programma operativo che riferisce obiettivi, attività e risorse a un periodo. La parte economica è necessaria, ma non basta. Un semplice tetto di spesa non chiarisce quale risultato ottenere né come misurarlo.

Una scheda di budget ben costruita collega almeno:

- obiettivo, cioè il risultato atteso;
- attività o volume, cioè ciò che deve essere realizzato;
- risorse, come personale, beni, servizi e tecnologie;
- costi o ricavi attesi, quando pertinenti;
- indicatore, che rende osservabile il risultato;
- valore iniziale, se disponibile;
- valore atteso, riferito a periodo e perimetro;
- responsabilità, limitata alle leve effettivamente governabili;
- modalità e frequenza di monitoraggio;
- rischi o condizioni esterne rilevanti.

L'indicatore deve misurare l'obiettivo dichiarato. Se si vuole ridurre il tempo di lavorazione di una pratica, il numero delle pratiche chiuse non basta: il volume potrebbe crescere mentre i tempi restano invariati. Se si vogliono contenere i costi senza ridurre il servizio, bisogna leggere insieme costo, volume e una misura pertinente del risultato o della qualità.

Gli indicatori possono riguardare:

- risorse o input, per esempio ore lavorate;
- attività o output, per esempio prestazioni erogate;
- efficienza, per esempio costo medio per unità omogenea;
- tempo, per esempio durata media di un processo;
- qualità o appropriatezza, se misurate con criteri validi;
- risultato, quando è possibile collegarlo in modo attendibile all'azione.

Nessun indicatore è autosufficiente. Deve avere definizione, formula, fonte, periodo, perimetro e responsabile della rilevazione.

NEGOZIAZIONE, ASSEGNAZIONE E RESPONSABILITÀ

La negoziazione di budget è il confronto attraverso il quale direzione e responsabili raccordano obiettivi, risorse e capacità operative. Non è una trattativa privata sul «proprio» fondo. Serve a verificare che gli obiettivi siano comprensibili, misurabili, coerenti e compatibili con le risorse e i vincoli.

Dopo l'assegnazione, il responsabile governa le leve disponibili e partecipa al monitoraggio. La responsabilità va valutata con correttezza. Un centro può ricevere l'attribuzione contabile di costi decisi centralmente; può subire un aumento di prezzi non controllabile; può erogare volumi superiori su richiesta dell'azienda. Questi elementi non cancellano lo scostamento, ma ne modificano l'interpretazione.

Il controllo deve distinguere:

- costi direttamente governabili e costi attribuiti;
- variazioni di prezzo e variazioni di quantità;
- maggiore attività e consumo anomalo;
- fatti occasionali e tendenze strutturali;
- decisioni del centro e decisioni sovraordinate;
- errore di registrazione e fenomeno reale.

RACCORDO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 inquadra il ciclo di gestione della performance delle amministrazioni pubbliche attraverso obiettivi, indicatori, misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati. Nel settore sanitario il raccordo con budget e controllo di gestione deve rispettare la disciplina generale, gli atti regionali e il sistema aziendale di misurazione e valutazione.

Budget e performance sono collegati, ma non coincidono. Il budget governa operativamente obiettivi e risorse; il sistema della performance definisce anche modalità di misurazione e valutazione organizzativa e individuale. Un risultato economico può contribuire alla valutazione, ma non può essere trasformato automaticamente in giudizio individuale.

L'ordine logico è: obiettivo definito → indicatore pertinente → valore atteso → risorse coerenti → misurazione attendibile → analisi del risultato → valutazione secondo regole note. Se manca un passaggio, anche la valutazione perde solidità.

Errore tipico: scegliere l'indicatore dopo aver visto il risultato, per far apparire raggiunto l'obiettivo. Indicatore, formula, fonte e valore atteso devono essere definiti prima della misurazione, salvo modifiche motivate e tracciate.

Reporting e analisi degli scostamenti

BUDGET, CONSUNTIVO E SCOSTAMENTO

Il budget esprime il valore programmato. Il consuntivo esprime il valore effettivamente rilevato per lo stesso oggetto, periodo e perimetro. Lo scostamento è la differenza tra i due.

Formula dello scostamento assoluto:

scostamento assoluto = consuntivo – budget

Formula dello scostamento percentuale:

scostamento percentuale = (consuntivo – budget) / budget × 100

La seconda formula è utilizzabile quando il budget è diverso da zero e i valori sono confrontabili. Se il valore programmato è zero, non si forza una percentuale priva di significato: si rappresenta la variazione assoluta e si spiega il caso.

Il segno va interpretato in relazione all'oggetto. Per un costo, un valore positivo indica che il consuntivo supera il budget; per un ricavo o un volume desiderato, lo stesso segno può avere un significato diverso. Anche le parole favorevole e sfavorevole richiedono cautela. Un costo inferiore può sembrare favorevole, ma può derivare da attività non svolta. Un costo superiore può accompagnare una crescita di volume più che proporzionale.

Prima del calcolo verifica:

- stessa unità di misura;
- stesso periodo;
- stesso centro o perimetro;
- stessa definizione della voce;
- dati completi e validati;
- eventuali riclassificazioni;
- valore di budget non nullo per la percentuale.

DAL NUMERO ALLA CAUSA VERIFICABILE

Lo scostamento è un fatto numerico. La causa è una spiegazione che deve essere verificata. Confondere i due livelli produce risposte deboli.

Esempio: il costo dei materiali supera il budget di 40.000 euro. Il dato è lo scostamento. «C'è stato spreco» è un'ipotesi, non una conclusione. Le cause possibili includono:

- aumento del volume di attività;
- incremento del prezzo unitario;
- diversa composizione delle prestazioni;
- introduzione di un nuovo prodotto;
- consumo anomalo;
- errore di imputazione;
- slittamento temporale di costi;
- variazione delle scorte;
- obiettivo iniziale non realistico.

A ogni ipotesi deve corrispondere un controllo. Un possibile aumento dei prezzi si verifica confrontando prezzi unitari e condizioni contrattuali; una crescita dell'attività richiede volumi omogenei. Per cercare un errore contabile si esaminano registrazioni, centro, conto e periodo. Un consumo elevato, invece, richiede di analizzare quantità per attività e criteri di impiego con le competenze tecniche necessarie.

La spiegazione può essere scomposta in:

scostamento totale = effetto prezzo + effetto quantità + effetto composizione + altri effetti verificabili.

Questa è una mappa concettuale, non una formula universale già pronta. Il metodo di scomposizione dipende dai dati disponibili e dall'oggetto analizzato.

CONTROLLO E AZIONE CORRETTIVA

L'azione viene dopo la verifica. Può consistere nel:

- correggere una registrazione;
- aggiornare una previsione divenuta irrealistica;
- rivedere l'organizzazione di un processo;
- rafforzare un controllo;
- intervenire su approvvigionamento o consumo;
- riallocare risorse secondo le competenze;
- ridefinire un indicatore inadeguato per il ciclo successivo;
- attivare un approfondimento tecnico o direzionale.

L'azione correttiva non coincide sempre con un taglio. Se il dato è incompleto, ridurre la spesa non risolve il problema. Se il volume è aumentato per una decisione aziendale, può essere ragionevole aggiornare il budget. Se il costo unitario peggiora senza una spiegazione operativa, prima di intervenire bisogna ricostruire il processo.

Una proposta ben formulata indica:

1. il fatto osservato;
2. il rischio gestionale;
3. il controllo necessario;
4. il soggetto competente;
5. il tempo di verifica;
6. l'azione proposta, condizionata all'esito;
7. l'indicatore con cui misurare l'effetto.

SCRIVERE UN REPORT CONTABILE UTILE

Chi legge una breve nota direzionale deve trovare subito i dati necessari per decidere. Conviene ordinare il testo così:

- oggetto, periodo e perimetro;
- valore di budget e consuntivo;
- scostamento assoluto e percentuale;
- andamento del volume o dell'indicatore collegato;

- cause accertate e cause ancora da verificare;
- controlli svolti o richiesti;
- proposta e responsabilità;
- data del successivo monitoraggio.

Evita formule accusatorie come «il centro ha speso troppo» se non hai ricostruito le cause. Preferisci: «Il costo consuntivo supera il budget del 7,5%; nello stesso periodo il volume cresce del 12,5%. Si propone di verificare composizione dei costi, qualità del dato e sostenibilità del nuovo livello di attività».

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Lo scostamento confronta consuntivo e budget omogenei. La percentuale richiede un budget diverso da zero. Il segno non basta per definire il risultato favorevole o sfavorevole. La causa deve essere verificata con dati pertinenti. L'azione correttiva deriva dall'analisi, non da un automatismo.

Caso guidato: budget di un centro di responsabilità

DATASET E DOMANDA

Un centro di responsabilità di supporto ai servizi ambulatoriali riceve un budget annuale per costi operativi pari a 480.000 euro e un obiettivo di 24.000 pratiche lavorate. A consuntivo risultano costi per 516.000 euro e 27.000 pratiche lavorate.

I dati sono esclusivamente didattici. Non rappresentano standard nazionali, tariffe o benchmark di efficienza.

La direzione chiede:

1. calcolare gli scostamenti di costo e volume;
2. calcolare il costo medio per pratica;
3. interpretare i risultati;
4. indicare controlli e possibili azioni;
5. redigere una breve nota.

CALCOLO E LETTURA

Scostamento assoluto del costo:

$$516.000 - 480.000 = +36.000 \text{ euro}$$

Scostamento percentuale del costo:

$$36.000 / 480.000 \times 100 = +7,5\%$$

Scostamento assoluto del volume:

$$27.000 - 24.000 = +3.000 \text{ pratiche}$$

Scostamento percentuale del volume:

$$3.000 / 24.000 \times 100 = +12,5\%$$

Costo medio programmato:

$$480.000 / 24.000 = 20,00 \text{ euro per pratica}$$

Costo medio consuntivo:

$$516.000 / 27.000 = 19,11 \text{ euro per pratica, arrotondato a due decimali.}$$

Scostamento del costo medio:

$$516.000 / 27.000 - 20,00 = -0,8888... \text{ euro per pratica, cioè circa } -0,89 \text{ euro. La variazione percentuale, calcolata prima dell'arrotondamento, è } [(516.000 / 27.000) / 20 - 1] \times 100 = -4,4444... \%, \text{ cioè circa } -4,44\%.$$

Valori di confronto

Indicatore	Budget	Consuntivo
Costi operativi	€ 480.000	€ 516.000
Pratiche lavorate	24.000	27.000
Costo medio per pratica	€ 20,00	€ 19,11

Scostamenti

Indicatore	Scostamento	Scostamento %
Costi operativi	+ € 36.000	+7,5%
Pratiche lavorate	+3.000	+12,5%
Costo medio per pratica	- € 0,89	circa -4,44%

Il costo totale supera il budget, ma il volume cresce ancora di più e il costo medio diminuisce. Concludere che il centro sia inefficiente sarebbe affrettato. Anche il giudizio opposto, però, non è dimostrato: il numero di pratiche non misura da solo correttezza, complessità, tempi o qualità.

CAUSE DA VERIFICARE E CONTROLLI

Le principali domande sono:

- Le 27.000 pratiche sono conteggiate con la stessa definizione usata nel budget?
- Il periodo è identico e i dati sono completi?
- La composizione delle pratiche è cambiata?
- Sono aumentati straordinari, servizi esterni o altri costi?
- Una quota di costo appartiene a un altro centro o periodo?
- La crescita era prevista o deriva da una decisione successiva?
- I tempi e la qualità sono rimasti adeguati?

Il controllo può essere organizzato in una matrice.

EVIDENZE ED ESITI

Ipotesi	Evidenza da controllare	Possibile esito
maggiore volume reale	registro delle attività e definizione dell'unità	crescita confermata
aumento di lavoro straordinario	ore, autorizzazioni e carichi	costo aggiuntivo documentato
errore di imputazione	conti, centri e periodo	costo attribuito impropriamente
pratiche meno complesse	classificazione delle attività	volume non perfettamente omogeneo
peggioramento della qualità	errori, rilavorazioni, tempi	criticità confermata

AZIONI CONDIZIONATE

Ipotesi	Azione condizionata
maggiore volume reale	aggiornare capacità e previsione
aumento di lavoro straordinario	rivedere turni e fabbisogno
errore di imputazione	correggere la registrazione
pratiche meno complesse	separare le categorie
peggioramento della qualità	correggere il processo e monitorare

Questa matrice separa l'ipotesi dalla prova. Non presenta come certo ciò che deve ancora essere verificato.

NOTA CONCLUSIVA AL RESPONSABILE

Oggetto: andamento costi e attività del centro di supporto ai servizi ambulatoriali

Nel periodo esaminato il centro registra costi operativi pari a 516.000 euro, superiori di 36.000 euro al budget, con uno scostamento del 7,5%. Le pratiche lavorate sono 27.000, superiori di 3.000 unità all'obiettivo, con un incremento del 12,5%. Il costo medio passa da 20,00 a 19,11 euro per pratica.

I dati mostrano quindi un aumento del costo totale accompagnato da una maggiore crescita del volume e da una riduzione del costo medio. Non consentono, da soli, di formulare un giudizio definitivo sulla gestione. Si propone di verificare omogeneità delle pratiche, completezza delle registrazioni, composizione dei costi, ricorso a lavoro straordinario, tempi e rilavorazioni.

Se la crescita del volume e la qualità dei dati saranno confermate, la direzione potrà valutare l'aggiornamento della previsione e della capacità necessaria. Se emergeranno errori di imputazione o criticità organizzative, dovranno essere adottate le correzioni pertinenti. Il successivo monitoraggio dovrà presentare insieme costo totale, volume, costo medio e un indicatore di qualità o tempestività.

La nota tiene separati dati, interpretazione, verifiche e decisioni. Non attribuisce responsabilità prima dell'istruttoria e indica che cosa controllare dopo.

Allenamento da concorso e verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: Come si collegano budget, contabilità analitica e controllo di gestione in un'azienda sanitaria?

Traccia per una risposta completa:

1. definisci il budget come programma operativo di obiettivi e risorse;
2. spiega che la contabilità analitica attribuisce costi e dati ad attività, centri o altri oggetti utili;
3. collega i dati consuntivi al reporting;
4. definisci lo scostamento come differenza tra risultato e valore programmato;
5. precisa che la causa richiede verifica;
6. collega l'analisi alle decisioni correttive;
7. richiama centri di responsabilità e leve governabili;
8. chiudi con il raccordo tra risultato economico, attività e qualità.

Risposta modello sintetica: «Il budget traduce la programmazione in obiettivi, risorse, volumi e indicatori riferiti a un periodo e a centri di responsabilità. La contabilità analitica attribuisce costi e attività agli oggetti gestionali utili, raccordandosi alla contabilità generale. Il controllo di gestione confronta budget e consuntivo, individua gli scostamenti, ne verifica le cause e supporta le decisioni. Nel settore sanitario il dato economico va letto insieme a volume, qualità, appropriatezza e vincoli assistenziali. Lo scostamento non produce automaticamente un giudizio sul responsabile, ma richiede di considerare perimetro, qualità del dato e leve effettivamente governabili».

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: Uno scostamento sfavorevole dimostra sempre inefficienza del responsabile?

Risposta: no. Prima verifica che budget e consuntivo siano confrontabili, che il dato sia corretto e che lo scostamento sia davvero sfavorevole rispetto all'obiettivo. Esamina poi variazioni di volume, prezzo, composizione, qualità, decisioni sovraordinate e leve disponibili. Solo a quel punto puoi valutare la responsabilità secondo le regole, gli obiettivi e le competenze definite.

ESERCIZIO DI CLASSIFICAZIONE

Associa ogni elemento alla categoria corretta: documento di bilancio, sistema contabile, modello NSIS, centro, indicatore.

1. Contabilità analitica.
2. Stato patrimoniale del bilancio.
3. Modello LA.
4. Costo medio per pratica.
5. Centro di responsabilità.
6. Modello CP.
7. Contabilità generale.
8. Conto economico del bilancio.
9. Tempo medio di lavorazione.
10. Modello CE.

Soluzione ragionata:

1. sistema contabile: attribuisce e analizza costi;
2. documento di bilancio: rappresenta attività e passività;
3. modello NSIS: rileva costi per livelli di assistenza;
4. indicatore: collega costo e unità di attività;
5. centro: collega obiettivi, risorse e responsabilità;
6. modello NSIS: rileva costi del presidio;
7. sistema contabile: registra i fatti di gestione economici e patrimoniali;
8. documento di bilancio: rappresenta componenti economiche e risultato;
9. indicatore: misura una dimensione temporale;
10. modello NSIS: rileva costi e ricavi standardizzati.

MINI-ESERCIZIO SUGLI SCOSTAMENTI

Un servizio ha un budget di 150.000 euro e un consuntivo di 162.000 euro.

1. Calcola lo scostamento assoluto.
2. Calcola lo scostamento percentuale.
3. Indica tre informazioni necessarie prima di interpretarlo.

Soluzione:

- $162.000 - 150.000 = +12.000$ euro.
- $12.000 / 150.000 \times 100 = +8\%$.
- Sono necessari, per esempio, volume di attività, periodo e perimetro, qualità del dato, variazioni di prezzo, composizione del servizio e costi attribuiti. Il semplice +8% non prova inefficienza.

LABORATORIO DA FOGLIO DI CALCOLO

Costruisci una tabella con queste colonne:

Dati

Voce	Budget	Consuntivo
Materiali	80.000	92.000
Servizi	50.000	47.500
Ore lavorate	12.000	12.600
Pratiche	6.000	6.900

Calcoli

Voce	Scostamento assoluto	Scostamento %
Materiali		
Servizi		
Ore lavorate		
Pratiche		

Cause e controlli

Voce	Causa da verificare	Controllo
Materiali		
Servizi		
Ore lavorate		
Pratiche		

Azioni possibili

Voce	Azione possibile
Materiali	
Servizi	
Ore lavorate	
Pratiche	

Procedura:

1. calcola consuntivo – budget;
2. dividi lo scostamento per il budget;
3. formatta il risultato come percentuale;
4. non usare il colore come unica informazione;
5. formula almeno due ipotesi per la voce materiali;
6. indica quale dato potrebbe confermarle;
7. proponi un'azione solo dopo il controllo;
8. aggiungi costo medio per pratica, usando costi pertinenti e perimetro dichiarato.

Controllo dei risultati numerici:

- materiali: +12.000; +15%;
- servizi: -2.500; -5%;
- ore lavorate: +600; +5%;
- pratiche: +900; +15%.

Materiali e pratiche crescono entrambi del 15%, ma la stessa percentuale non prova un rapporto causale. Il dato suggerisce di controllare il consumo unitario, dopo aver verificato omogeneità delle pratiche, prezzi e composizione.

ERRORE TIPICO: LA FRASE CHE SALTA L'ANALISI

Leggi questa conclusione: «Il centro ha superato il budget, quindi il responsabile deve ridurre immediatamente gli acquisti».

La frase contiene tre salti:

1. trasforma lo scostamento in colpa;
2. presume che la causa siano gli acquisti;
3. propone un taglio senza valutarne gli effetti sul servizio.

Riscrittura corretta: «Il costo consuntivo supera il valore programmato. Prima di proporre interventi occorre verificare volume e composizione dell'attività, prezzi, quantità, imputazioni e vincoli sopravvenuti. In base all'esito si valuteranno correzioni contabili, organizzative o di approvvigionamento, salvaguardando gli obiettivi assistenziali».

RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE

Assegna un punto per ogni criterio rispettato.

Criterio	Domanda di controllo
Fonte	so da quale rilevazione proviene il dato?
Periodo	budget e consuntivo riguardano lo stesso intervallo?
Perimetro	centro, attività e voci sono omogenei?
Obiettivo	è definito il risultato atteso?
Risorsa	so quali mezzi sono stati assegnati?
Indicatore	formula e unità di misura sono chiare?
Scostamento	ho calcolato correttamente valore assoluto e percentuale?
Causa	distinguo fatto, ipotesi ed evidenza?
Controllo	ho indicato una verifica pertinente?
Azione	la proposta dipende dall'esito e rispetta le competenze?

Da otto a dieci punti l'analisi è ben strutturata. Da cinque a sette richiede un controllo mirato. Sotto cinque occorre ricostruire il caso partendo da periodo, perimetro e qualità del dato.

CHECKLIST FINALE

- ☐ So distinguere contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale senza trasferire regole tra enti diversi.
- ☐ So distinguere contabilità generale e contabilità analitica.
- ☐ So spiegare conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.
- ☐ So distinguere bilancio d'esercizio e modelli NSIS.

- ☐ Ricordo gli oggetti di CE, SP, LA e CP.
- ☐ So distinguere centro di costo e centro di responsabilità.
- ☐ So costruire una scheda con obiettivo, risorse, volume e indicatore.
- ☐ So calcolare scostamento assoluto e percentuale.
- ☐ Verifico l'omogeneità dei dati prima di confrontarli.
- ☐ Non confondo lo scostamento con la sua causa.
- ☐ Non attribuisco responsabilità senza considerare le leve governabili.
- ☐ Propongo un controllo prima dell'azione.
- ☐ Collego sempre costo, attività e risultato.

Collegamenti con il volume base e riferimenti essenziali

Il presente capitolo sviluppa il nucleo specialistico sanitario. Per i fondamenti trasversali puoi utilizzare Il Metodo BANDO (VOL-01):

- Capitolo 8 — Contabilità pubblica essenziale, per principi generali, programmazione e sistemi contabili pubblici;
- Capitolo 15 — La prova scritta e teorico-pratica, per organizzare una risposta, una tabella commentata e una nota breve;
- Capitolo 17 — Casi pratici e problem solving amministrativo, per il metodo generale di analisi dei fatti, individuazione delle competenze e formulazione delle soluzioni.

I rinvii integrano il metodo comune, ma non sostituiscono le distinzioni sanitarie sviluppate qui.

I riferimenti essenziali sono:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per aziendalizzazione, autonomia, organizzazione, programmazione e vincolo di bilancio;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Titolo II, per i principi contabili del settore sanitario;
- D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, e D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, per l'architettura del finanziamento regionale e dei fabbisogni standard;
- Atti di riparto e assegnazione dell'esercizio, accordi di remunerazione e regole di compensazione della mobilità sanitaria, per importi, destinazioni e condizioni concretamente applicabili;
- D.M. 24 maggio 2019, per gli schemi dei modelli economici CE, SP, LA e CP nel quadro verificato;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per il ciclo di gestione della performance;
- disposizioni regionali, regolamento di contabilità, manuale di budget, piano dei centri e sistema di misurazione e valutazione dell'azienda, per procedure, responsabilità e calendari concreti.

Schemi, codici, scadenze e istruzioni tecniche dei modelli economici possono essere aggiornati. In prova si usa il riferimento temporale stabilito dal bando; nell'attività professionale si controllano sempre le disposizioni applicabili all'esercizio.

Quando leggi un dato, chiediti sempre da dove proviene, con che cosa può essere confrontato e quale attività descrive. Solo dopo puoi collegarlo agli obiettivi, verificare le cause dello scostamento e proporre una decisione che tenga conto delle responsabilità effettive e delle conseguenze sul servizio.

Procurement sanitario, farmaci, dispositivi e magazzino

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Scegliere il fornitore è soltanto una parte dell'acquisto sanitario. Prima occorre capire che cosa serve, in quale quantità, per quale periodo e con quali caratteristiche. Dopo l'affidamento bisogna controllare consegna, conformità della prestazione, scorte, fattura e pagamento. Basta trascurare un passaggio per generare spesa inutile, interruzioni del servizio o dati contabili inattendibili.

Il procurement sanitario applica le regole dei contratti pubblici a fabbisogni che incidono sull'assistenza. Farmaci, dispositivi e altri beni devono essere disponibili quando servono. L'esigenza di continuità non elimina programmazione, concorrenza, tracciabilità e controlli: impone di prevenire ritardi, specifiche inadeguate, dipendenze da un solo fornitore e scorte non governate.

Nei concorsi il candidato può incontrare una domanda teorica, un caso su una fornitura, uno schema di decisione, una tabella di riconciliazione o un rapporto di anomalia. Non basta conoscere i nomi delle fasi. Occorre capire quale informazione nasce in ciascuna fase, chi deve controllarla e quale decisione è consentita dai documenti disponibili.

Obiettivo didattico, Mappa BANDO e ciclo operativo

Al termine del capitolo saprai:

- spiegare perché il procurement sanitario richiede un'applicazione specialistica delle regole generali;
- ricostruire il ciclo dal fabbisogno al pagamento;
- distinguere programmazione, affidamento, stipula, esecuzione e controllo;
- descrivere il ruolo del responsabile unico del progetto e degli altri soggetti senza sovrapporne le competenze;
- collegare ordine, consegna, ricevimento, carico, fattura, liquidazione e pagamento;
- riconoscere le principali anomalie documentali e quantitative;
- spiegare il ruolo informativo di AIFA e dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali;
- trattare farmaci e dispositivi entro il perimetro amministrativo, senza invadere quello clinico;
- costruire una checklist, una risposta orale, uno schema di decisione e un rapporto di anomalia.

DAL FABBISOGNO AL PAGAMENTO

La sequenza di riferimento è:

fabbisogno → programmazione → progettazione della fornitura → decisione di contrarre → affidamento → stipula → ordine o avvio dell'esecuzione → consegna → ricevimento e controllo → carico e tracciabilità → fattura → riconciliazione → liquidazione → pagamento → monitoraggio.

La sequenza non è sempre rappresentata da uffici o documenti identici. L'organizzazione concreta dipende dall'ente, dal contratto e dal bene. La logica di controllo, però, rimane stabile:

1. il bisogno deve essere motivato;
2. la prestazione deve essere definita;
3. la scelta del contraente deve seguire la disciplina applicabile;
4. ciò che viene consegnato deve essere confrontato con ciò che era dovuto;
5. ciò che viene fatturato deve essere confrontato con ordine, consegna e accettazione;
6. il pagamento deve riguardare una prestazione verificata e autorizzata;
7. ogni anomalia deve lasciare una traccia e ricevere un esito.

La catena impedisce di ridurre l'acquisto a una serie di firme isolate. Evita inoltre che un unico soggetto possa richiedere, scegliere, ricevere, liquidare e pagare senza controlli reciproci.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Nucleo da studiare	Output da prova
B — Bando	Quale competenza richiede il profilo?	contratti, acquisti, economato, farmacia, magazzino, contabilità	perimetro della risposta
A — Aree	Quali discipline si collegano?	contratti pubblici, organizzazione sanitaria, contabilità, digitale	mappa delle competenze
N — Nuclei	Quali passaggi non possono mancare?	fabbisogno, RUP, esecuzione, scorte, riconciliazione, controlli	scaletta teorica
D — Diario	Come controllo l'apprendimento?	sequenze, documenti, anomalie, competenze, errori	esercizi e correzioni

Passaggio	Domanda guida	Nucleo da studiare	Output da prova
O — Output	Che cosa devo saper produrre?	schema, decisione simulata, checklist, rapporto, risposta orale	elaborato verificabile

ATTENZIONE

La continuità della fornitura è un interesse da proteggere mediante programmazione, gestione del rischio e controllo dell'esecuzione. Non è una formula che consente automaticamente di saltare la disciplina dei contratti pubblici.

CHE COSA PUÒ CHIEDERE LA PROVA

Una domanda orale può chiedere di illustrare il ciclo di un acquisto sanitario. Un quesito può verificare la differenza tra aggiudicazione e stipula o tra liquidazione e pagamento. Un caso può presentare una fattura non coerente con la quantità ricevuta. Una prova pratica può chiedere una checklist del RUP, una tabella ordine-consegna-fattura o un breve rapporto al responsabile.

Per costruire una risposta completa:

1. identifica la fase del ciclo;
2. definisci la regola o la funzione;
3. distingui i documenti e i soggetti;
4. collega il rischio al controllo pertinente;
5. proponi un'azione proporzionata ai fatti accertati.

Inquadramento teorico: perché il procurement sanitario richiede un delta specialistico

INTERESSE PUBBLICO, BISOGNO ASSISTENZIALE E SOSTENIBILITÀ

Il procurement pubblico è l'insieme delle attività con cui l'amministrazione traduce un fabbisogno in un contratto e ne controlla il risultato. Nel settore sanitario il fabbisogno nasce da programmi, attività assistenziali, consumi, innovazioni, sostituzioni, scorte e rischi di continuità. Non è sufficiente scrivere che «serve un bene»: bisogna spiegare perché serve, a chi, per quanto tempo e con quale risultato atteso.

Un fabbisogno ben costruito contiene almeno:

- oggetto della fornitura;
- unità o servizi utilizzatori;
- quantità stimata e periodo;
- dati storici o previsionali impiegati;
- caratteristiche necessarie;
- livello di servizio richiesto;
- rischi di indisponibilità;
- risorse previste;
- modalità di controllo dell'esecuzione.

La quantità non deriva sempre dalla semplice ripetizione dei consumi precedenti. Un consumo storico può includere sprechi, carenze, eventi eccezionali o attività non più previste. La stima deve quindi combinare dati disponibili e programma futuro. Se aumenta l'attività, la previsione deve motivare il collegamento; se diminuisce, occorre verificare che il servizio resti assicurato.

La sostenibilità economica non coincide con il prezzo più basso. Il prezzo conta, ma la decisione deve considerare quanto richiedono la disciplina e i documenti di gara: qualità della prestazione, continuità, tempi, condizioni di esecuzione e possibilità di controllo. Requisiti e criteri devono essere coerenti con il bisogno e applicati in modo trasparente, non costruiti intorno a preferenze arbitrarie.

CONTINUITÀ, APPROPRIATEZZA DEL REQUISITO E RISCHIO

La continuità della fornitura esprime la capacità di rendere disponibile il bene necessario senza interruzioni incompatibili con il servizio. Può essere minacciata da stime insufficienti, ritardi, mancata consegna, concentrazione delle fonti, indisponibilità del prodotto, scorte non aggiornate o contestazioni non gestite.

Il rischio va affrontato prima dell'emergenza. Alcuni presidi possibili sono:

- programmazione tempestiva;
- durata contrattuale coerente con il fabbisogno;
- livelli di servizio e tempi di consegna verificabili;
- monitoraggio dei consumi e delle giacenze;
- regole per segnalare ritardi e non conformità;
- gestione documentata delle scorte;
- coordinamento tra unità richiedente, acquisti, magazzino e contabilità;
- misure previste dagli atti di gara e dal contratto per le criticità di esecuzione.

La soluzione cambia con l'oggetto dell'acquisto. Un prodotto a consumo regolare presenta rischi diversi da una tecnologia complessa o da un servizio continuativo. La progettazione deve partire dall'uso effettivo, non da un modello compilato automaticamente.

Un requisito tecnico è appropriato quando è collegato alla funzione richiesta, verificabile e proporzionato. Se è superfluo, restringe il mercato senza migliorare il risultato; se è vago, rende difficile confrontare le offerte e contestare una prestazione inadeguata.

Errore tipico: descrivere il prodotto già conosciuto invece del bisogno da soddisfare. Il candidato deve partire da funzione, prestazione, sicurezza, compatibilità e risultato richiesti, evitando caratteristiche arbitrarie o discriminatorie.

CONFINE TRA COMPETENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E CLINICA

Il procedimento di acquisto richiede competenze diverse. L'area amministrativa governa atti, procedura, tracciabilità, documenti e controlli. Le strutture utilizzatrici descrivono il bisogno e verificano gli aspetti di propria competenza. I professionisti tecnici o sanitari valutano le caratteristiche che richiedono conoscenze specialistiche. Magazzino e logistica presidiano ricevimento, movimentazioni e disponibilità secondo l'organizzazione aziendale. Contabilità e tesoreria intervengono nel ciclo passivo.

La collaborazione non elimina la distinzione delle responsabilità. Un amministrativo non decide autonomamente l'idoneità clinica di un prodotto. Un utilizzatore non sceglie liberamente il fornitore. Il magazzino non sostituisce il controllo tecnico quando questo è necessario. La contabilità non può ricostruire da sola una consegna non documentata.

Soggetto o funzione	Contributo tipico	Limite da ricordare
Unità richiedente	descrive bisogno, quantità e risultato atteso	non conduce da sola l'affidamento
RUP	coordina il progetto nelle fasi disciplinate dal Codice	non assorbe ogni competenza tecnica o contabile
Supporto tecnico o sanitario	definisce e verifica elementi specialistici	non sostituisce le decisioni amministrative
Direzione dell'esecuzione	controlla la prestazione secondo contratto e disciplina	ruolo e nomina dipendono dal caso applicabile
Magazzino o punto ricevente	rileva arrivo, quantità, integrità e movimenti	non certifica ciò che richiede una valutazione specialistica
Contabilità	verifica la documentazione del ciclo passivo	non sana una prestazione non eseguita
Tesoreria	esegue il pagamento autorizzato	non decide la regolarità della fornitura

Gli atti dell'ente stabiliscono come sono distribuiti i compiti. Se la traccia non offre informazioni sufficienti, il candidato può indicare la funzione competente e precisare quale atto organizzativo occorrerebbe verificare.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il procurement sanitario parte da un bisogno assistenziale o organizzativo motivato. Continuità e qualità si proteggono con programmazione, requisiti verificabili e controllo dell'esecuzione. Il prezzo non è l'unica informazione rilevante, ma ogni criterio deve rispettare la disciplina applicabile. Competenze amministrative, tecniche, sanitarie, logistiche e contabili collaborano senza confondersi. L'urgenza non sostituisce automaticamente la procedura.

Dal fabbisogno all'affidamento

RILEVARE E MOTIVARE IL FABBISOGNO

Il fabbisogno è la traduzione documentata di una necessità in una prestazione acquistabile. Deve essere sufficientemente preciso da consentire programmazione e progettazione, ma non deve anticipare una scelta non giustificata del contraente.

Una scheda essenziale può rispondere a queste domande:

Campo	Domanda di controllo
Oggetto	Quale bene o servizio è necessario?
Funzione	Quale attività o risultato deve sostenere?
Destinatario	Quali unità lo useranno?
Quantità	Come è stata stimata?
Periodo	Per quale durata occorre la fornitura?
Caratteristiche	Quali requisiti sono indispensabili e perché?
Continuità	Quale conseguenza produce l'indisponibilità?
Risorse	Qual è il quadro economico disponibile?
Dato	Quali consumi, scorte o previsioni sostengono la stima?
Controllo	Come sarà verificato il risultato?

La motivazione deve mostrare come si passa dal dato alla decisione. «Si acquista perché il materiale sta finendo» dice troppo poco. Occorrono la giacenza rilevata, il consumo medio riferito a un periodo, l'attività prevista, le consegne già programmate e il rischio di interruzione.

Il dato deve essere controllabile. Se la quantità viene estratta da un sistema, bisogna conoscere periodo, unità di misura e perimetro. Se più unità usano lo stesso bene, occorre evitare duplicazioni. Se sono presenti prodotti sostitutivi, il fabbisogno deve spiegare come vengono considerati.

PROGRAMMARE E PROGETTARE LA FORNITURA

La programmazione colloca l'acquisto nel tempo e lo coordina con risorse e priorità. Il D.Lgs. 36/2023 disciplina la programmazione dei lavori e degli acquisti, con rinvio agli allegati applicabili. Memorizzare una soglia destinata a cambiare, senza conoscere la data del bando, serve a poco. Bisogna capire la funzione della programmazione: evitare acquisti improvvisati, frammentati o incoerenti con i bisogni.

La progettazione definisce la prestazione che l'amministrazione vuole ottenere. Per una fornitura sanitaria può comprendere:

- oggetto e quantità;
- caratteristiche tecniche motivate;
- durata e articolazione delle consegne;
- livelli di servizio;
- modalità di ordine;
- controlli in ricevimento e in esecuzione;
- gestione di difetti, ritardi o sostituzioni;
- obblighi informativi e documentali;
- condizioni economiche;
- criteri di verifica della conformità.

La progettazione deve rendere misurabile ciò che conta. Se il requisito è «consegna tempestiva», non è chiaro quando inizi il termine né come si misuri. Se è definito il momento dell'ordine, il termine contrattuale e la prova della consegna, il controllo diventa possibile.

La suddivisione in lotti, quando pertinente, serve a organizzare l'oggetto dell'affidamento. Non va presentata come automatismo. Il candidato deve chiedersi se i lotti riflettano oggetti, funzioni, sedi, periodi o mercati distinti e se la scelta sia motivata.

RUP, SUPPORTI E RESPONSABILITÀ

Nel Codice del 2023 il RUP è il responsabile unico del progetto. L'articolo 15 e l'Allegato I.2 ne inquadrano funzioni e requisiti. La formula è importante: non si tratta di un mero addetto alla firma, ma di una figura che presidia il progetto nelle fasi rilevanti secondo la disciplina applicabile.

La parola «unico» non assegna al RUP ogni attività. Il RUP può operare con strutture di supporto e con gli altri responsabili o direttori previsti. Negli acquisti sanitari questa collaborazione è spesso necessaria, perché il progetto può richiedere competenze tecniche, cliniche, logistiche, informatiche e contabili.

Nella risposta conviene tenere distinti:

- coordinamento, che mantiene unitaria la gestione del progetto;
- istruttoria, che raccoglie e valuta gli elementi necessari;
- competenza tecnica, che valuta aspetti specialistici;
- decisione, che appartiene all'organo o dirigente competente;
- controllo dell'esecuzione, che verifica la prestazione;
- controllo contabile, che presidia il ciclo passivo.

La formula generica «decide il RUP» non risolve conflitti o interferenze. Bisogna identificare il fatto, la competenza, gli obblighi applicabili e il titolare della decisione.

DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO E STIPULA

La decisione di contrarre manifesta la scelta dell'amministrazione di avviare il percorso contrattuale e ne definisce gli elementi richiesti dalla disciplina. Nel D.Lgs. 36/2023 la formula da usare è «decisione di contrarre». Nel caso di affidamento diretto, l'atto individua gli elementi previsti, tra cui oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta e requisiti.

L'affidamento è il percorso con cui viene selezionato l'operatore economico secondo la procedura applicabile. Affidamento diretto, procedura aperta, ristretta e negoziata non sono sinonimi. Presupposti, pubblicità, confronto, documenti e modalità cambiano. Il candidato non deve scegliere una procedura basandosi soltanto su una sensazione di semplicità o urgenza.

L'aggiudicazione individua l'esito della selezione secondo le regole applicabili. La stipula conclude il contratto nella forma prevista. Confondere i due momenti porta a ritenere che ogni rapporto contrattuale sia già perfezionato con la sola aggiudicazione.

Il capitolato e gli altri documenti definiscono ciò che l'operatore dovrà eseguire. Una specifica tecnica chiara permette di confrontare le offerte e, in seguito, di controllare la prestazione. Se la specifica è ambigua, anche il risultato atteso diventa difficile da misurare.

DIGITALIZZAZIONE E TRACCIABILITÀ

Il ciclo dei contratti pubblici è digitalizzato. Il Codice disciplina l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale; le piattaforme certificate interagiscono con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. BDNCP, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, CIG e piattaforma non sono la stessa cosa:

- la BDNCP raccoglie dati e informazioni sui contratti pubblici secondo la disciplina applicabile;
- il FVOE supporta la verifica dei requisiti dell'operatore economico;
- il CIG identifica il contratto ai fini previsti;
- la piattaforma di approvvigionamento digitale gestisce attività e scambi del ciclo secondo le regole tecniche.

Dal 1° gennaio 2024 l'acquisizione del CIG avviene, di regola, tramite piattaforme certificate interoperabili con la BDNCP. La digitalizzazione, però, non si esaurisce nell'ottenimento di un codice. Riguarda la coerenza dei dati durante programmazione, affidamento, esecuzione, pubblicità e controllo.

La tracciabilità ha almeno tre dimensioni:

1. procedurale, perché deve risultare chi ha svolto ogni attività;
2. documentale, perché atti, comunicazioni e controlli devono essere reperibili;
3. informativa, perché i dati trasmessi devono essere coerenti con il contratto reale.

Un sistema digitale non corregge da solo un dato errato. Se automatizza una quantità sbagliata, accelera l'errore. Servono comunque controlli su completezza, qualità, autorizzazione e coerenza.

Dalla stipula all'esecuzione

ACQUISTI CENTRALIZZATI E ORDINE ELETTRONICO

Prima di avviare una procedura autonoma, l'ente verifica gli obblighi di acquisto centralizzato. L'art. 9 del D.L. 66/2014 e l'art. 1, commi 548–550, della L. 208/2015 raccordano gli acquisti sanitari a categorie di beni e servizi, condizioni previste dalla legge e disponibilità delle centrali di committenza. Per gli acquisti soggetti all'obbligo si utilizzano le centrali regionali di riferimento o Consip; nei casi previsti intervengono altri soggetti aggregatori. Una centrale svolge attività di committenza per più amministrazioni; un soggetto aggregatore appartiene allo specifico elenco disciplinato dalla legge. Le due espressioni non sono sinonimi in ogni contesto.

Il D.P.C.M. 11 febbraio 2026, pubblicato il 16 aprile 2026, aggiorna le categorie e le soglie del regime dei soggetti aggregatori, sostituendo il decreto del 2018. Per esempio, per farmaci e vaccini la soglia è 40.000 euro; altre categorie seguono la soglia europea prevista per le amministrazioni subcentrali. Non applicare un solo importo a tutti gli acquisti sanitari. L'art. 1, comma 2, considera l'importo massimo annuo per categoria e, per gare pluriennali, l'intero periodo.

Il mancato rilascio del CIG previsto per questo regime decorre dall'attivazione del contratto del soggetto aggregatore: categoria, importo e stato dello strumento vanno quindi verificati insieme. Questo aggiornamento non elimina gli altri obblighi di acquisto centralizzato.

Esempio: il servizio acquisti rileva un fabbisogno annuale di medicinali. Prima di scegliere come affidarlo, identifica la categoria, verifica disciplina e strumenti centralizzati applicabili, controlla la convenzione disponibile e confronta il fabbisogno con il suo oggetto. Una convenzione esistente per prodotti diversi non soddisfa da sola il bisogno; la sua inadeguatezza, però, non autorizza automaticamente qualunque acquisto diretto.

Il Nodo di smistamento degli ordini (NSO), disciplinato dal D.M. 7 dicembre 2018 e successive modifiche, riguarda i documenti elettronici di ordinazione degli acquisti di beni e servizi tra enti del SSN e fornitori. Non coincide con la piattaforma di gara, con il contratto o con il Sistema di interscambio delle fatture. L'ordine si collega al contratto; consegna e fattura devono essere riconciliabili con esso. Le richieste interne fra uffici non diventano per questo ordini fra distinti soggetti giuridici. Gli identificativi e gli scenari tecnici seguono le regole NSO correnti.

ORDINE O AVVIO DELL'ESECUZIONE

Con la stipula il lavoro non è finito. Il risultato pubblico si realizza quando la prestazione viene eseguita correttamente. Il D.Lgs. 36/2023 collega affidamento ed esecuzione e disciplina direzione, controllo, collaudo o verifica di conformità secondo il tipo di contratto.

L'avvio dell'esecuzione deve essere coerente con il contratto. Nelle forniture articolate, l'ordine può specificare quantità, luogo e tempo della singola consegna entro le condizioni contrattuali. Il documento di ordine non deve modificare liberamente oggetto, prezzo o condizioni.

Prima di emettere un ordine si controllano:

- validità e capienza del contratto;
- soggetto autorizzato;
- bene o servizio previsto;
- quantità e unità di misura;
- prezzo o condizione economica;
- luogo e termine di consegna;
- eventuali riferimenti necessari;
- fabbisogno e disponibilità già presenti.

La duplicazione di un ordine può produrre scorte e fatture non previste. L'omissione di un riferimento può rendere difficile attribuire consegna e costo. Per questo l'ordine deve essere identificabile e collegabile al contratto.

RICEVIMENTO, CONFORMITÀ E CONTESTAZIONE

Il ricevimento accerta che una consegna sia arrivata. Non equivale sempre all'accettazione definitiva della prestazione. Il controllo può articolarsi in livelli:

1. verifica del destinatario e del riferimento all'ordine;
2. controllo della quantità e dell'integrità apparente;
3. registrazione di data, documento di trasporto e soggetto ricevente;
4. controllo delle caratteristiche documentali richieste;
5. eventuale verifica tecnica o di conformità da parte del soggetto competente;
6. registrazione dell'esito e delle anomalie.

Firmare senza riserva un documento che non corrisponde alla realtà indebolisce la pista di controllo. Se mancano colli, se la quantità non coincide o se vi è un danno apparente, l'anomalia deve essere registrata secondo il contratto e la procedura applicabile.

La conformità riguarda la corrispondenza tra prestazione dovuta e prestazione eseguita. Può coinvolgere quantità, qualità, tempi, documenti e requisiti tecnici. Chi controlla deve conoscere il criterio di confronto. Non è sufficiente scrivere «merce conforme» se non è chiaro a quale ordine, lotto contrattuale o specifica ci si riferisca.

La contestazione deve essere tempestiva, documentata e collegata ai fatti. Deve indicare:

- contratto e ordine;
- consegna interessata;
- anomalia osservata;
- evidenze disponibili;

- clausola o requisito rilevante;
- azione richiesta;
- termine o passaggio successivo;
- responsabile del seguito.

La contestazione non anticipa automaticamente una sanzione. Registra il problema e attiva il percorso previsto. L'esito può essere sostituzione, integrazione, regolarizzazione, accettazione motivata nei limiti consentiti o altra conseguenza contrattuale.

CONTINUITÀ DELLA FORNITURA E MONITORAGGIO

Il controllo dell'esecuzione deve osservare non soltanto la singola consegna, ma anche l'andamento complessivo. Indicatori utili, se previsti e definiti, possono riguardare:

- consegne effettuate nei termini;
- quantità consegnate rispetto agli ordini;
- non conformità;
- tempi di sostituzione;
- ordini inevasi;
- consumo rispetto alla previsione;
- giacenza e rischio di esaurimento;
- fatture sospese per anomalie.

Un indicatore deve specificare formula, periodo, fonte e perimetro. «Il fornitore è spesso in ritardo» è un giudizio. «Tre consegne su dodici hanno superato il termine contrattuale nel trimestre» è un dato verificabile, purché date e termini siano omogenei.

Se emerge un rischio di interruzione, il responsabile non deve attendere l'esaurimento. Occorre:

1. validare la giacenza;
2. stimare il consumo nel periodo rilevante;
3. verificare ordini e consegne programmate;
4. accertare le ragioni del ritardo;
5. coinvolgere i soggetti competenti;
6. applicare le misure contrattuali e organizzative consentite;
7. documentare decisioni e monitoraggio.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La stipula apre la fase in cui il risultato deve essere realizzato. Ordine, consegna, ricevimento e conformità sono passaggi distinti. La firma del ricevimento non sostituisce sempre la verifica tecnica. Le anomalie vanno registrate e gestite secondo contratto e competenze. La continuità si monitora prima che la scorta si esaurisca.

Farmaci, dispositivi e magazzino nel perimetro amministrativo

FARMACI, CONSUMI E SPESA: IL RUOLO DI AIFA E OSMED

Un medicinale è qualificato dalla sua presentazione o dalla funzione farmacologica, immunologica o metabolica prevista dalla disciplina farmaceutica. L'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) segue la valutazione di qualità, sicurezza ed efficacia. Può derivare da procedure nazionali o europee: nella procedura centralizzata l'EMA esprime la valutazione scientifica e la Commissione europea autorizza. La decisione di autorizzare il medicinale è distinta da quella di porlo a carico del SSN.

Classe di rimborsabilità	Significato essenziale	Attenzione
A	Medicinali essenziali e per malattie croniche, a carico del SSN nelle condizioni ammesse	Possono operare Note AIFA e altre condizioni di rimborso
H	Medicinali a carico del SSN in ambito ospedaliero o nelle strutture ammesse	Non equivale a libera dispensazione nella farmacia territoriale
C	In via ordinaria, medicinali a carico del cittadino	Non significa necessariamente assenza di obbligo di ricetta

La classe C(nn) identifica medicinali non ancora valutati ai fini della negoziazione del rimborso. Per il singolo prodotto si verificano AIC, confezione, classe e regime di fornitura aggiornati: classe economica, modalità di prescrizione e indicazione terapeutica rispondono a domande diverse. L'AIC non prova da sola che ogni impiego sia rimborsato.

L'Agenzia italiana del farmaco svolge funzioni istituzionali nel settore dei medicinali. L'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, OsMed, monitora consumi e spesa dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale integrando più fonti informative.

Per il candidato amministrativo questo riferimento serve a comprendere che consumo e spesa farmaceutica non sono osservati soltanto dal singolo magazzino. I dati contribuiscono al governo a più livelli. Il capitolo non richiede di memorizzare un catalogo di banche dati o tracciati; richiede di capire la qualità dell'informazione:

- che cosa viene contato;
- quale periodo è osservato;
- quale soggetto alimenta il dato;
- quale unità di misura viene usata;
- come vengono gestite correzioni e riconciliazioni;
- per quale decisione il dato è impiegato.

Un aumento della spesa non prova da solo un consumo improprio. Può derivare da quantità, prezzi, composizione dei prodotti, nuovi bisogni o riclassificazioni. Analogamente, una riduzione non prova automaticamente efficienza. Il dato deve essere collegato ad attività, disponibilità e risultati.

Nel lavoro amministrativo farmaco, confezione, unità di impiego, ordine e valore economico non vanno confusi. Il sistema utilizzato deve rendere chiara l'unità di misura. Un errore tra confezioni e pezzi può alterare fabbisogno, giacenza e fattura.

DISPOSITIVI: CONFINE AMMINISTRATIVO E CONTROLLO

I dispositivi medici possono essere oggetto di programmazione, acquisto, ricevimento, inventario, distribuzione e controllo contrattuale. Il candidato amministrativo deve saper presidiare documenti, quantità, identificazione, competenze e anomalie.

La qualificazione di un dispositivo dipende dalla destinazione d'uso del fabbricante e dal suo meccanismo d'azione principale, che non è farmacologico, immunologico o metabolico. Un diagnostico in vitro esamina campioni provenienti dal corpo umano per fornire informazioni mediche. I regolamenti UE 2017/745 (MDR) e 2017/746 (IVDR) disciplinano questi prodotti; non si applica loro l'AIC propria dei medicinali. Classi di rischio, UDI, conformità e vigilanza sono sviluppati nel modulo M-SA04, capitolo «Tecnologie, dispositivi, apparecchiature e rischio tecnologico». Nell'acquisto occorre identificare quale regime riguarda il prodotto e richiedere documenti pertinenti, senza trattare marcatura CE e AIC come certificazioni equivalenti.

Non deve invece inventare classificazioni, campi di flussi nazionali, procedure di vigilanza o regole tecniche non fornite dal caso o dalla disciplina richiesta dal bando. Questi elementi possono cambiare e richiedono riferimenti istituzionali aggiornati.

Di fronte a una discrepanza, occorre:

1. identificare il bene e il contratto;
2. verificare ciò che i documenti richiedono;
3. registrare consegna e movimento;
4. coinvolgere la competenza tecnica per gli aspetti specialistici;
5. mantenere distinta l'idoneità amministrativa dalla valutazione clinica;
6. documentare l'esito.

Esempio: se una fornitura presenta un codice diverso da quello indicato nell'ordine, l'amministrativo non conclude automaticamente che il prodotto sia equivalente. Registra la discrepanza, sospende il passaggio che richiede certezza e attiva la verifica competente. L'equivalenza tecnica non si presume da una somiglianza commerciale.

RICEVIMENTO, CARICO, GIACENZA, LOTTO E SCADENZA

Il magazzino collega il flusso fisico al flusso informativo. Un bene entra, viene identificato, registrato, collocato e successivamente distribuito o impiegato. Ogni movimento deve poter essere ricostruito secondo le regole dell'ente e le caratteristiche del bene.

Il carico registra l'ingresso nella disponibilità gestita. La giacenza rappresenta la quantità risultante in un momento definito. Lo scarico registra l'uscita o l'attribuzione a una destinazione. L'inventario confronta disponibilità registrata e realtà fisica secondo le modalità applicabili.

La giacenza informatica non è necessariamente la quantità immediatamente utilizzabile. Possono esistere beni:

- riservati a ordini o unità;
- in verifica;
- contestati;
- danneggiati;
- prossimi alla scadenza;
- non disponibili per altre ragioni documentate.

Conviene quindi distinguere la giacenza registrata dalla quantità disponibile e da quella utilizzabile secondo le regole pertinenti.

Lotto e scadenza possono essere necessari per ricostruire la movimentazione e gestire anomalie. Il capitolo non stabilisce una procedura universale di conservazione o rotazione. In un caso concorsuale il candidato deve:

- leggere i requisiti del contratto;
- verificare i dati presenti sui documenti e sul bene;
- applicare la procedura aziendale indicata;
- non distribuire come regolare ciò che richiede una verifica;
- segnalare e tracciare l'anomalia.

Se il contratto richiede una determinata validità residua alla consegna, quel requisito diventa criterio di confronto. Non esiste un unico numero valido per ogni bene: il valore dipende dal contratto, dal prodotto e dalle regole applicabili.

SCORTE E CONTINUITÀ

La rotazione FEFO — first expiry, first out dà priorità ai prodotti che scadono prima, tra quelli utilizzabili e conformi. Non coincide con FIFO, che segue l'ordine di ingresso: un lotto arrivato dopo può scadere prima. Prodotti scaduti, ritirati, danneggiati o in attesa di valutazione devono essere identificati e separati dalle scorte distribuibili secondo il sistema di segregazione applicabile. La disponibilità fisica non prova l'utilizzabilità.

Le condizioni di conservazione derivano dal prodotto e dalle informazioni autorizzate del fabbricante. Per quelli che richiedono temperatura controllata, la catena del freddo consiste nel mantenerla e documentarla lungo conservazione e trasporto. Non esiste un intervallo valido per tutti i medicinali o dispositivi. Un'escursione termica richiede registrazione e valutazione competente: riportare il prodotto alla temperatura prevista non cancella l'evento.

Esempio di riordino. Consumo medio 100 confezioni al giorno, tempo di approvvigionamento 5 giorni, scorta di sicurezza ipotizzata 200 confezioni. Il punto di riordino didattico è $100 \times 5 + 200 = 700$ confezioni. Con 680 confezioni utilizzabili, nessun ordine aperto e consumo stabile, si è già scesi sotto quel livello. Il responsabile avvia il riordino previsto; non deduce da questi dati la quantità ottimale da acquistare. Se 150 delle 680 confezioni risultano in quarantena, la disponibilità effettiva scende a 530. La scorta di sicurezza dell'esempio non è una soglia sanitaria universale.

Verifica: arrivano oggi il lotto A, scadenza dicembre, e domani il lotto B, scadenza novembre. Quale usare prima? Soluzione: B, se entrambi sono conformi e utilizzabili e non operano altri vincoli, perché FEFO segue la scadenza. Se B è oggetto di ritiro, va segregato e non distribuito, anche se scade prima.

La scorta serve ad assorbire il tempo tra fabbisogno, ordine e nuova disponibilità. Una scorta troppo bassa espone a interruzioni; una scorta eccessiva immobilizza risorse e può aumentare obsolescenza, deterioramento o scadenze.

Per valutare il rischio occorrono almeno:

- giacenza validata;
- consumo riferito a un periodo;
- quantità già ordinate;
- data prevista di consegna;
- eventuali quantità non utilizzabili;
- variazioni previste dell'attività;
- criticità della fornitura.

Il tempo di copertura può essere stimato dividendo la quantità utilizzabile per un consumo medio coerente. Il risultato non è una soglia universale: è un indicatore da confrontare con tempi di consegna, variabilità del consumo e criticità del bene.

Esempio: 1.200 unità disponibili e un consumo medio di 300 unità a settimana indicano una copertura teorica di quattro settimane. Se la consegna è prevista tra due settimane, il dato può apparire sufficiente; se metà delle unità è in verifica, la copertura effettiva scende. Prima di decidere bisogna quindi validare disponibilità e tempi.

Errore tipico: ordinare soltanto perché la quantità è inferiore a quella del mese precedente. La decisione deve considerare consumo, attività, consegne, indisponibilità e periodo di copertura.

SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

La segregazione distribuisce attività incompatibili tra soggetti o controlli distinti. Lo scopo non è moltiplicare passaggi privi di valore, ma ridurre il rischio che una stessa persona possa generare e approvare un'operazione senza verifica.

Nel ciclo possono essere distinti:

- richiesta del bene;
- autorizzazione della spesa;
- emissione dell'ordine;
- ricevimento;
- verifica tecnica;
- registrazione del carico;
- controllo della fattura;
- liquidazione;
- pagamento;
- riconciliazione.

Negli enti piccoli non ogni funzione corrisponde a un ufficio separato. Se la separazione organizzativa non è possibile, servono controlli compensativi coerenti e tracciati. In prova è corretto proporre una verifica successiva, una doppia autorizzazione o un controllo incrociato, ma soltanto se pertinente al rischio descritto.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

AIFA e OsMed aiutano a leggere consumi e spesa farmaceutica a livello di sistema. Nel magazzino il dato deve corrispondere al movimento fisico. Giacenza registrata e quantità utilizzabile possono differire. Lotto, scadenza e caratteristiche tecniche si controllano secondo contratto e procedure applicabili. La segregazione separa richiesta, ricevimento, liquidazione e pagamento o introduce controlli compensativi.

Il ciclo passivo e la riconciliazione

CONTRATTO O ORDINE, CONSEGNA E FATTURA

Il ciclo passivo conduce dal rapporto contrattuale al pagamento e alla registrazione del debito e del costo secondo il sistema applicabile. La riconciliazione confronta ciò che è stato autorizzato, ciò che è stato eseguito e ciò che il fornitore chiede di pagare.

I documenti rispondono a domande diverse:

Documento o evidenza	Domanda
Contratto	Quale prestazione è dovuta e a quali condizioni?
Ordine	Quale quantità o attività è stata richiesta nel contratto?

Documento o evidenza	Domanda
Documento di consegna	Che cosa dichiara di aver consegnato il fornitore?
Ricevimento	Che cosa è materialmente arrivato?
Verifica di conformità	Che cosa è stato accettato come regolarmente eseguito?
Fattura	Quale importo chiede il fornitore?
Atto di liquidazione	Quale importo viene riconosciuto secondo i controlli svolti?
Mandato o disposizione di pagamento	Quale somma è autorizzata al pagamento?
Esito di tesoreria	Quale pagamento è stato effettivamente eseguito?

La fattura non dimostra da sola la regolare esecuzione; la consegna non conferma automaticamente la quantità fatturata; l'ordine non prova che il bene sia arrivato.

La riconciliazione confronta almeno:

- fornitore;
- contratto e ordine;
- bene o prestazione;
- quantità;
- unità di misura;
- prezzo e condizioni;
- data e periodo;
- consegna o esecuzione;
- esito della conformità;
- importo fatturato.

Quando un elemento non coincide, nasce un'eccezione da gestire. La causa può essere un ordine modificato, una consegna parziale, un errore di registrazione, un'unità di misura incoerente, un reso o una nota di credito. Non si presume un illecito, ma l'esito deve essere documentato.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La liquidazione è il passaggio in cui l'amministrazione, sulla base dei documenti e delle verifiche richieste, determina l'importo riconoscibile al creditore e autorizza la prosecuzione del ciclo secondo le competenze applicabili. Il pagamento è l'esecuzione dell'uscita finanziaria.

Confondere le due fasi porta a trascurare il controllo precedente al pagamento. Una fattura formalmente corretta può essere sospesa se la prestazione non è stata verificata o presenta una discrepanza. Anche una prestazione regolare deve seguire il percorso documentale e contabile previsto.

Prima della liquidazione si verificano, secondo il caso:

- rapporto con contratto e ordine;
- identità del fornitore;
- regolare esecuzione;
- quantità e prezzi;
- esito di consegne parziali, resi o contestazioni;
- presenza delle attestazioni richieste;
- correttezza dell'imputazione;
- autorizzazioni e controlli previsti.

Il soggetto che liquida deve poter ricostruire l'istruttoria. Una formula generica come «visto, si liquida» non sostituisce i presupposti. Nella prova pratica non è necessario riprodurre un atto aziendale reale; è necessario mostrare quali elementi dovrebbero sostenerlo.

CONTROLLI, ANOMALIE E PISTA DOCUMENTALE

Le anomalie più frequenti in un caso didattico sono:

- quantità fatturata superiore a quella ricevuta;
- prezzo diverso dal contratto;
- consegna riferita a un ordine errato;
- unità di misura non omogenea;
- bene non conforme;
- consegna parziale non registrata;
- fattura duplicata;
- reso non considerato;
- assenza della verifica necessaria;
- costo imputato a centro o periodo errato.

Ogni anomalia va collegata a un controllo:

Anomalia	Controllo	Possibile azione
Quantità diversa	ordine, consegna, carico e conformità	correggere dato, chiedere integrazione o contestare
Prezzo diverso	contratto, offerta e ordine	rettifica o chiarimento documentato

Anomalia	Controllo	Possibile azione
Bene non conforme	specifica e verifica competente	segregare, contestare, sostituire o altro esito previsto
Fattura duplicata	identificativi e storico	bloccare la duplicazione e verificare
Reso non registrato	movimento fisico e documento di reso	aggiornare giacenza e ciclo contabile
Imputazione errata	centro, conto e periodo	riclassificare secondo competenza

La pista documentale deve consentire di passare in entrambe le direzioni: dalla fattura al contratto e dal contratto ai pagamenti. Se un documento non è collegato agli altri, il controllo diventa manuale, lento e incerto.

La gestione dell'anomalia comprende:

1. rilevare;
2. bloccare cautelativamente il passaggio incompatibile con l'incertezza;
3. classificare il problema;
4. raccogliere documenti;
5. assegnare la verifica;
6. decidere secondo competenza;
7. correggere o contestare;
8. registrare l'esito;
9. monitorare la chiusura;
10. prevenire la ripetizione.

Errore tipico: pagare l'intera fattura e «sistemare dopo» una discrepanza nota. La soluzione deve seguire le regole applicabili e mantenere coerenza tra prestazione verificata e importo riconosciuto.

Caso guidato: fornitura con discrepanza e rischio di interruzione

SCENARIO E DOCUMENTI DISPONIBILI

Un'azienda sanitaria ha affidato, con dati interamente didattici, una fornitura annuale di kit assistenziali monouso. Il contratto prevede consegne mensili su ordine, prezzo unitario di 8,20 euro, identificazione del lotto e una validità residua alla consegna indicata negli atti contrattuali.

Per il mese di settembre il servizio competente emette un ordine di 36.000 kit. Il documento di consegna indica 31.000 kit. Al ricevimento risultano:

- 30.000 kit senza anomalie apparenti;
- 1.000 kit con validità residua inferiore a quella prevista dal contratto;
- 5.000 kit non consegnati.

La fattura riporta $36.000 \text{ kit} \times 8,20 \text{ euro} = 295.200 \text{ euro}$. I 1.000 kit contestati sono separati e non distribuiti in attesa della verifica competente. La giacenza utilizzabile precedente alla consegna era di 7.500 kit; il consumo medio recente è di 2.800 kit a settimana. Il fornitore comunica che completerà la consegna tra due settimane, ma la comunicazione deve essere formalmente verificata.

La direzione chiede:

1. classificare le anomalie;
2. indicare i controlli;
3. valutare il rischio di continuità;
4. proporre il trattamento documentale e contabile;
5. redigere un rapporto sintetico.

CLASSIFICAZIONE DELLE ANOMALIE

La prima anomalia è quantitativa: ordine per 36.000 unità, consegna documentata e fisica per 31.000. Mancano 5.000 kit.

La seconda è qualitativo-contrattuale: 1.000 kit non rispettano, secondo il primo controllo, il requisito di validità residua indicato nel contratto. L'esito definitivo spetta al soggetto competente sulla conformità.

La terza è contabile-documentale: la fattura richiede il pagamento di 36.000 unità, mentre la prestazione accettabile non è ancora determinata oltre le 30.000 unità senza anomalia apparente.

La quarta è gestionale: la consegna incompleta e la segregazione dei 1.000 kit possono incidere sulla continuità.

I quattro livelli vanno tenuti separati. La fattura non cancella la mancata consegna; la presenza fisica dei 1.000 kit non ne prova la conformità; la comunicazione del fornitore non sostituisce l'aggiornamento formale dell'esecuzione.

CONTROLLI E CALCOLI

Si parte da contratto e ordine:

- il prezzo unitario è 8,20 euro?
- l'ordine è valido e autorizzato?
- il requisito di validità residua è formulato come descritto?
- sono previste consegne parziali e con quali conseguenze?
- chi è competente per la verifica di conformità?

Poi si controllano ricevimento e tracciabilità:

- quantità fisica e documento di consegna coincidono?
- lotto e scadenza sono registrati correttamente?
- i 1.000 kit sono separati e non distribuiti?
- il carico distingue quantità disponibile e quantità in verifica?

Infine si esamina la fattura:

- quantità e prezzo coincidono con prestazione verificata?
- la fattura può essere regolarizzata o deve essere gestita secondo il percorso previsto?
- esistono consegne precedenti, resi o note che spieghino la differenza?

Valore delle 30.000 unità senza anomalia apparente:

$$30.000 \times 8,20 = 246.000 \text{ euro.}$$

Valore delle 1.000 unità in verifica:

$$1.000 \times 8,20 = 8.200 \text{ euro.}$$

Valore delle 5.000 unità non consegnate:

$$5.000 \times 8,20 = 41.000 \text{ euro.}$$

La somma è:

$$246.000 + 8.200 + 41.000 = 295.200 \text{ euro.}$$

Il calcolo ricostruisce la fattura, ma non autorizza la liquidazione. Serve a separare le componenti.

La quantità utilizzabile dopo l'ingresso delle 30.000 unità è, in prima approssimazione:

$$7.500 + 30.000 = 37.500 \text{ kit.}$$

Copertura teorica:

$$37.500 / 2.800 = \text{circa } 13,4 \text{ settimane.}$$

Il dato non segnala un esaurimento immediato, ma va interpretato con cautela. Il consumo medio deve essere aggiornato, la giacenza deve essere reale e possono esistere scorte riservate o variazioni dell'attività. Il rischio di continuità non giustifica quindi l'accettazione automatica dei kit contestati; richiede monitoraggio della consegna residua.

MATRICE DI GESTIONE

Problema	Evidenza	Competenza da attivare	Azione prudente
5.000 unità mancanti	ordine, documento e conteggio	RUP o funzione di esecuzione	registrare consegna parziale e richiedere completamento
1.000 unità con requisito dubbio	contratto, lotto, scadenza	verifica tecnica competente	segregare e sospendere l'uso fino all'esito
Fattura per 36.000	fattura, ordine, ricevimento	contabilità e responsabile competente	bloccare la quota non verificata e chiedere regolarizzazione secondo procedura
Rischio di ritardo	comunicazione del fornitore	gestione dell'esecuzione	formalizzare termine, controllare adempimento e applicare misure previste
Dato di giacenza	sistema e inventario	magazzino	riconciliare quantità registrata, disponibile e in verifica

La misura esatta dipende da contratto e procedure. Il metodo non cambia: nessuna quantità contestata viene trattata come regolare senza esito; nessuna somma viene riconosciuta soltanto perché fatturata; nessuna azione contrattuale viene inventata fuori dagli atti applicabili.

RAPPORTO CONCLUSIVO AL RESPONSABILE

Oggetto: anomalie nella consegna mensile dei kit assistenziali

L'ordine di settembre riguarda 36.000 kit al prezzo unitario di 8,20 euro. Il ricevimento ha rilevato 31.000 unità: 30.000 senza anomalie apparenti e 1.000 con validità residua inferiore al requisito contrattuale, attualmente segregate. Risultano non consegnate 5.000 unità. La fattura, pari a 295.200 euro, comprende l'intera quantità ordinata e non coincide con la prestazione finora verificabile.

Si propone di registrare formalmente la consegna parziale, affidare al soggetto competente la verifica dei 1.000 kit, richiedere al fornitore la regolarizzazione documentale e il completamento nei termini applicabili e sospendere il riconoscimento delle quote non verificate. Il magazzino dovrà mantenere distinte quantità utilizzabili e quantità in verifica.

La giacenza teoricamente utilizzabile dopo la consegna è di 37.500 kit, corrispondente a circa 13,4 settimane al consumo medio osservato. Il dato riduce il rischio immediato di esaurimento, ma deve essere confermato verificando giacenza reale, scorte riservate e attività prevista. Il successivo controllo dovrà registrare esito tecnico, completamento della consegna, rettifica della fattura e chiusura dell'anomalia.

Il rapporto espone fatti, calcoli, incertezze e azioni. Non attribuisce una colpa non accertata e non trasforma la necessità di continuità in accettazione automatica.

Allenamento da concorso e verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: Quali elementi distinguono il procurement sanitario dall'acquisto pubblico generale?

Traccia per una risposta completa:

1. definisci il procurement come ciclo dal fabbisogno al controllo del risultato;
2. richiama la disciplina generale dei contratti pubblici;
3. spiega che il fabbisogno sanitario nasce da attività e continuità del servizio;
4. collega requisiti tecnici e valutazioni specialistiche alle competenze appropriate;
5. descrivi programmazione, RUP, affidamento ed esecuzione;
6. collega consegna, magazzino e ciclo passivo;
7. chiudi con tracciabilità, segregazione e gestione delle anomalie.

Risposta modello sintetica: «Il procurement sanitario applica il Codice dei contratti pubblici a fabbisogni che incidono sull'assistenza. La specificità non elimina concorrenza, programmazione e tracciabilità, ma richiede di motivare quantità, requisiti, continuità e controlli dell'esecuzione. Il RUP coordina il progetto con competenze tecniche, sanitarie, logistiche e contabili distinte. Dopo l'affidamento occorre verificare ordine, consegna, conformità, carico, fattura e pagamento. Il risultato non è soltanto scegliere un fornitore, ma assicurare una prestazione conforme, disponibile e documentata».

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: Una fattura formalmente corretta è sufficiente per liquidare la spesa?

Risposta: no. La fattura esprime la richiesta di pagamento del fornitore. Prima della liquidazione occorre verificare il rapporto con contratto e ordine, la prestazione eseguita, quantità, prezzo, conformità, contestazioni e documenti richiesti. Se la fattura non coincide con la prestazione verificata, l'anomalia deve essere gestita secondo le competenze e la procedura applicabile.

ESERCIZIO 1 — ORDINARE LE FASI

Metti in ordine:

- pagamento;
- rilevazione del fabbisogno;
- controllo della consegna;
- stipula;
- fattura;
- programmazione;
- affidamento;
- liquidazione;
- ordine;
- riconciliazione.

Soluzione ragionata:

1. rilevazione del fabbisogno;
2. programmazione;
3. affidamento;
4. stipula;
5. ordine;
6. controllo della consegna;
7. fattura;
8. riconciliazione;
9. liquidazione;
10. pagamento.

La sequenza è semplificata. Il controllo dell'esecuzione accompagna più momenti e la riconciliazione può proseguire anche dopo il pagamento per chiusure e verifiche.

ESERCIZIO 2 — ATTRIBUIRE IL CONTROLLO

Associa il problema alla funzione da coinvolgere per prima, senza escludere la collaborazione:

1. requisito clinico non chiaro;
2. quantità fisica diversa dal documento;
3. prezzo in fattura diverso dal contratto;
4. consegna in ritardo;
5. giacenza negativa nel sistema;
6. bene apparentemente diverso dall'ordine.

Soluzione:

1. competenza sanitaria o tecnica, con il coordinamento amministrativo necessario;
2. ricevimento o magazzino, con gestione dell'esecuzione;
3. contabilità o controllo del ciclo passivo, verificando contratto e ordine;
4. responsabile dell'esecuzione o RUP secondo l'organizzazione;
5. magazzino e sistema informativo, con riconciliazione dei movimenti;
6. ricevimento e competenza tecnica, evitando di presumere equivalenza.

MINI-ESERCIZIO DI RICONCILIAZIONE

Una fornitura presenta:

- ordine: 2.400 unità a 12 euro;
- consegna: 2.250 unità;
- quantità accettata: 2.200 unità;
- quantità in verifica: 50 unità;
- fattura: 2.400 unità.

Calcola:

1. valore ordinato;
2. valore consegnato;
3. valore accettato;
4. valore in verifica;
5. valore non consegnato.

Soluzione:

1. $2.400 \times 12 = 28.800$ euro;
2. $2.250 \times 12 = 27.000$ euro;
3. $2.200 \times 12 = 26.400$ euro;
4. $50 \times 12 = 600$ euro;
5. $150 \times 12 = 1.800$ euro.

La somma di valore accettato, in verifica e non consegnato ricostruisce 28.800 euro. Il calcolo non decide da solo l'importo liquidabile: occorrono esito della verifica e disciplina applicabile.

ERRORE TIPICO: L'URGENZA SENZA ISTRUTTORIA

Leggi questa proposta: «Le scorte sono basse, quindi acquistiamo subito dallo stesso fornitore e regolarizziamo gli atti in seguito».

La frase contiene quattro problemi:

1. non quantifica la scorta né il consumo;
2. non verifica ordini o contratti disponibili;
3. sceglie il fornitore prima di individuare la base procedurale;
4. considera la documentazione un adempimento successivo.

Una riscrittura corretta è: «La giacenza validata e il consumo previsto indicano un rischio di esaurimento entro il periodo considerato. Occorre verificare consegne programmate, contratto disponibile, cause del ritardo e strumenti consentiti dalla disciplina applicabile. Il soggetto competente adotterà la soluzione motivata e tracciata che protegga la continuità senza eludere i controlli».

LABORATORIO: COSTRUIRE UN RAPPORTO DI ANOMALIA

Usa questa struttura:

Campo	Contenuto
Oggetto	fornitura, ordine e periodo
Fatto	differenza osservata
Documenti	contratto, ordine, consegna, verifica, fattura
Importo o quantità	valori riconciliati
Rischio	continuità, pagamento, dato, conformità
Competenza	soggetto che deve verificare o decidere
Misura cautelativa	passaggio da sospendere o dato da segregare
Azione	contestazione, rettifica, integrazione o altro esito consentito
Termine	prossimo controllo
Evidenza di chiusura	documento che prova la soluzione

Il rapporto deve distinguere:

- fatto accertato;
- ipotesi;
- documento mancante;
- controllo richiesto;
- decisione proposta.

RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE

Assegna un punto per ogni criterio rispettato.

Criterio	Domanda
Fabbisogno	so spiegare oggetto, quantità, periodo e motivazione?
Programmazione	collego l'acquisto a tempo, risorse e priorità?
Procedura	evito di scegliere la procedura per intuizione?
Competenza	distinguo RUP, tecnica, esecuzione, magazzino e contabilità?
Esecuzione	controllo ciò che è stato realmente consegnato?
Scorta	distinguo giacenza registrata e quantità utilizzabile?
Tracciabilità	collego atti, movimenti e dati?
Riconciliazione	confronto contratto, ordine, consegna e fattura?
Segregazione	evito che lo stesso soggetto generi e approvi tutto?
Azione	propongo una soluzione soltanto dopo la verifica?

Da otto a dieci punti il metodo è solido. Da cinque a sette occorre rivedere la fase non presidiata. Sotto cinque conviene ricostruire la catena dal fabbisogno al pagamento.

CHECKLIST FINALE

- ☐ So definire il procurement come ciclo e non come sola gara.
- ☐ So motivare un fabbisogno sanitario.
- ☐ Distinguo programmazione, progettazione, affidamento, stipula ed esecuzione.
- ☐ Uso la formula corretta «responsabile unico del progetto».
- ☐ So spiegare il ruolo di piattaforme, BDNCP, FVOE e CIG senza confonderli.
- ☐ Distinguo ordine, consegna, ricevimento e conformità.
- ☐ Distinguo giacenza registrata e quantità utilizzabile.
- ☐ Tratto farmaci e dispositivi nel perimetro delle competenze amministrative.
- ☐ Non invento classificazioni o procedure tecniche.
- ☐ Riconcilio contratto o ordine, consegna e fattura.
- ☐ Distinguo liquidazione e pagamento.
- ☐ Collego ogni anomalia a un controllo e a un soggetto competente.
- ☐ Uso la continuità della fornitura come obiettivo da programmare, non come scorciatoia.

Collegamenti con il volume base e riferimenti essenziali

Questo capitolo sviluppa l'applicazione sanitaria. Per il nucleo generale sono utili, in Il Metodo BANDO (VOL-01):

- Capitolo 9 — Contratti pubblici essenziali, per principi, soggetti, procedure, aggiudicazione, stipula, esecuzione e controlli;
- Capitolo 10 — Informatica, PA digitale e competenze digitali, per piattaforme, dati, interoperabilità e sicurezza;
- Capitolo 15 — La prova scritta e teorico-pratica, per costruire schemi, tabelle e atti simulati;
- Capitolo 17 — Casi pratici e problem solving amministrativo, per separare fatti, competenze, regole, vincoli e soluzione.

I rinvii forniscono il metodo comune, ma non sostituiscono le conoscenze sanitarie, logistiche e contabili sviluppate qui.

I riferimenti essenziali sono:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente, per principi, soggetti e ciclo dei contratti pubblici;
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, come correttivo rilevante del Codice, da coordinare con gli aggiornamenti successivi;
- atti e indicazioni istituzionali ANAC sull'ecosistema digitale dei contratti pubblici;
- informazioni istituzionali AIFA e OsMed su consumi e spesa dei medicinali;
- regolamenti, manuali, atti organizzativi, contratti e procedure dell'azienda considerata per ordini, ricevimento, magazzino, liquidazione e controlli.

Soglie, termini, regole tecniche delle piattaforme, classificazioni e procedure aziendali possono cambiare. In prova si usa il quadro temporale indicato dal bando; nell'attività professionale si verifica il testo vigente e l'atto applicabile. Per i dispositivi medici non si deducono per analogia campi informativi, obblighi o procedure specialistiche: si usano i riferimenti istituzionali correnti e la competenza tecnica richiesta.

Quando affronti un caso, chiediti sempre: quale bisogno è stato autorizzato, che cosa doveva essere consegnato, che cosa è realmente arrivato, che cosa è stato accettato e che cosa viene chiesto in pagamento. Questa sequenza trasforma un insieme di documenti in un controllo amministrativo completo.

M-SA02

Professioni sanitarie

Sezione interna del volume VOL-07 — Sanità amministrativa e professioni sanitarie.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	6 Professioni sanitarie: profili, requisiti e prove; 7 Discipline professionali: autonomia, responsabilità e deontologia; 8 Assistenza infermieristica, tecniche assistenziali e supporto OSS
Sviluppo	9 Valutazione clinica, triage, urgenza ed emergenza; 10 Prevenzione, continuità assistenziale e presa in carico; 11 Evidenze scientifiche, PICO, GRADE e applicabilità
Allenamento	12 Igiene pubblica, epidemiologia, sorveglianza e screening; 13 Controlli TPALL, verbalizzazione, campionamento e sanzioni; 14 Prova pratica e casi professionali

Professioni sanitarie: profili, requisiti e prove

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Un concorso sanitario non si legge come un elenco generico di materie. Si parte dal profilo: infermiere, ostetrica, fisioterapista e tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro hanno campi professionali, fonti e prove differenti. L'operatore sociosanitario rientra nel modulo, ma è un sub-verticale distinto e non va assimilato a una professione sanitaria ordinistica.

Due bandi pubblicati da enti sanitari possono richiedere lo stesso requisito generale e verificare conoscenze o output molto diversi. Studiare “sanità” come materia unica produce una preparazione ampia, ma difficile da usare in prova. Questo capitolo fornisce una mappa iniziale per riconoscere il profilo, risalire alla fonte che lo disciplina, separare gli elementi stabili da quelli mobili e scegliere l'allenamento adatto alla forma della prova.

Il quadro ordinario del D.P.R. 220/2001

Nei concorsi per titoli ed esami con tre prove, l'art. 8 ripartisce 100 punti in 30 per i titoli, 30 per la scritta, 20 per la pratica e 20 per l'orale. L'art. 14 richiede almeno 21/30 nella scritta e 14/20 sia nella pratica sia nell'orale. Nei concorsi per i quali sono previste soltanto pratica e orale, il quadro è diverso: 40 punti ai titoli, 30 a ciascuna prova e soglia di 21/30 per entrambe.

Il bando ripartisce i punti dei titoli fra carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni/titoli scientifici e curriculum. Occorre identificare la procedura e le norme speciali applicabili: il medesimo nome di una prova non implica il medesimo punteggio. Esempio: una pratica da 15/20 supera la soglia del concorso a tre prove, mentre una pratica da 20/30 non supera quella del concorso a due prove. I titoli non compensano l'insufficienza.

L'art. 37 del D.Lgs. 165/2001 prevede l'accertamento delle conoscenze informatiche diffuse e dell'inglese; modalità e livello si ricavano dalla disciplina e dal bando. Altre lingue possono essere aggiunte in relazione al profilo. Per gli OSS si identifica prima la disciplina di accesso effettivamente applicata, evitando di trasferire automaticamente le regole delle professioni sanitarie laureate.

Obiettivo del capitolo

Al termine saprai:

- distinguere le principali famiglie comprese in M-SA02;
- riconoscere il rapporto tra titolo, profilo, albo e bando;
- separare un requisito strutturale da un dato valido soltanto per la procedura concreta;
- capire che cosa richiedono prova scritta, pratica e orale;

- associare a ogni traccia l'output che la commissione può valutare;
- compilare una prima Mappa BANDO sanitaria senza anticipare materie non richieste.

La mappa serve a orientarsi. Le discipline assistenziali, cliniche, riabilitative, epidemiologiche e ispettive saranno sviluppate nei capitoli dedicati, con i rispettivi riferimenti e controlli professionali.

La mappa fondamentale: dalla fonte all'output

Per organizzare la preparazione conviene seguire una catena verificabile:

fonte del profilo → requisiti del bando → materie → forma della prova → output richiesto.

La fonte del profilo chiarisce il campo professionale; il bando stabilisce la procedura concreta; le materie delimitano ciò che va studiato; la prova stabilisce come quella conoscenza deve essere mostrata; l'output è ciò che il candidato deve effettivamente produrre.

Saltare un passaggio porta spesso ad allenarsi nel formato sbagliato. Una materia può essere ben conosciuta ma esposta male all'orale. Molti quiz non insegnano, da soli, a organizzare un caso. Anche una procedura memorizzata è inutile se appartiene a un altro profilo o a un setting diverso da quello indicato dal bando.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il profilo non coincide con il posto messo a concorso. Il titolo non basta senza verificare albo, equipollenza o equivalenza quando pertinenti. La frequenza osservata nei bandi non crea una regola nazionale. Scritta, pratica e orale richiedono output diversi. Punteggi, soglie, calendario e modalità operative si controllano sempre nella procedura concreta.

M-SA02 non è un profilo unico

Le fonti sull'ordinamento professionale distinguono aree e responsabilità. I decreti istitutivi dei singoli profili precisano attività e funzioni tipiche; non costituiscono, da soli, un programma completo di concorso. Il programma nasce dall'incrocio tra profilo, disciplina concorsuale, bando e fonti tecnico-scientifiche pertinenti.

INFERMIERE E AREA ASSISTENZIALE

Il profilo dell'infermiere comprende assistenza generale preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, con componenti tecniche, relazionali ed educative. Nel campo professionale rientrano l'identificazione dei bisogni, la definizione degli obiettivi, la pianificazione, la gestione e la valutazione dell'intervento, la corretta applicazione delle prescrizioni e la collaborazione con l'équipe e il personale di supporto.

Nei bandi esaminati, il programma ruota soprattutto attorno alle materie infermieristiche e alle tecniche assistenziali. Possono comparire anche legislazione sanitaria, sicurezza, igiene, epidemiologia, deontologia e discipline cliniche. Il peso effettivo di ciascun nucleo va ricavato dal proprio bando, senza estendere automaticamente il programma di un ente a tutti gli altri.

OSTETRICA E AREA OSTETRICA

Il profilo dell'ostetrica riguarda assistenza e consulenza durante gravidanza, parto e puerperio, assistenza al neonato, educazione sanitaria e attività di prevenzione nell'area di competenza. La fonte professionale include anche il riconoscimento delle situazioni potenzialmente patologiche e le misure di emergenza attribuite al profilo.

Il capitolo introduttivo, però, non può diventare un protocollo clinico. Nei concorsi, la prova può verificare teoria, caso, priorità, sicurezza e limiti professionali. Algoritmi, manovre e procedure dipendono da riferimenti aggiornati, setting e validazione specialistica.

FISIOTERAPISTA E AREA RIABILITATIVA

Il fisioterapista opera nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali. Il profilo comprende valutazione funzionale, programma riabilitativo, trattamento delle disabilità e verifica della rispondenza degli interventi, in collaborazione con le altre figure coinvolte.

Il candidato deve collegare valutazione, obiettivo, intervento, verifica e limiti del caso, anziché memorizzare un catalogo indistinto di tecniche. Nei bandi esaminati ricorrono metodologie e tecniche riabilitative, fragilità, disabilità e situazioni teorico-pratiche; la profondità richiesta dipende dalla procedura selezionata.

TPALL E AREA DELLA PREVENZIONE

Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro opera nella prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, alimenti e bevande, sanità pubblica e veterinaria. In determinati servizi esercita funzioni ispettive e di vigilanza nei limiti delle attribuzioni.

L'analisi dei bandi mostra due sottotracce da non confondere: prevenzione sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro; controllo ambientale presso enti come le ARPA. Cambiano materie, atti, campionamenti e output. Un verbale o un piano di campionamento richiede una preparazione diversa da un caso assistenziale.

OSS: UN SUB-VERTICALE DISTINTO

L'operatore sociosanitario è un operatore di interesse sanitario. Il profilo nazionale revisionato è stato recepito con il DPCM 25 marzo 2025, che ha disapplicato il precedente accordo del 2001 dalla propria entrata in vigore. La fonte corrente descrive attività rivolte ai bisogni primari, al benessere e all'autonomia della persona negli ambiti sanitario, sociosanitario e sociale.

M-SA02 comprende quindi l'OSS senza sovrapporlo all'infermiere. Sono diversi la fonte del profilo, le competenze, il contesto organizzativo e, spesso, il contratto applicato. Nei bandi OSS esaminati compaiono aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), altri enti e servizi residenziali. Oltre alla denominazione del posto, vanno controllati l'ente, il setting, il contratto, il programma e la disciplina regionale richiamata.

Percorso	Fonte che orienta il profilo	Domanda iniziale	Output ricorrente da allenare
Infermiere	D.M. 739/1994 e ordinamento professionale	Quale problema assistenziale va riconosciuto, pianificato e valutato?	risposta teorica, piano assistenziale, caso
Ostetrica	D.M. 740/1994 e fonti professionali	Quali priorità e limiti emergono nel percorso materno-neonatale?	risposta, caso, esposizione orale
Fisioterapista	D.M. 741/1994 e fonti riabilitative	Come si collegano valutazione funzionale, obiettivo e verifica?	caso riabilitativo, programma motivato
TPALL	D.M. 58/1997 e normativa del settore	Quali competenza, atto, controllo e garanzia richiede lo scenario?	verbale, rapporto, piano di controllo
OSS	DPCM 25 marzo 2025 e attuazione del contesto	Quale attività è propria, collaborativa o subordinata all'organizzazione?	sequenza motivata, caso assistenziale di base

La tabella orienta; non sostituisce le fonti verticali. Ogni output tecnico o clinico sarà sviluppato soltanto dove la matrice dispone di fonti sufficienti.

Requisiti: distinguere struttura e procedura concreta

Per leggere il bando sono utili tre categorie: strutturale, mobile, da verificare. Questa distinzione evita di trasformare l'esperienza fatta su una procedura in una regola generale.

TITOLO ABILITANTE, PROFILO E ALBO

Per le professioni sanitarie ordinistiche, titolo abilitante e iscrizione all'albo sono elementi centrali del percorso di accesso. Il campo professionale deriva dal coordinamento tra profilo, ordinamento didattico e codice deontologico. Le leggi 42/1999, 251/2000, 43/2006 e 3/2018 offrono il quadro dell'autonomia, delle aree professionali e del sistema ordinistico.

La formula generale non è sufficiente. Bisogna leggere la voce dei requisiti specifici, verificare la classe di laurea o il titolo indicato, controllare come il bando tratta titoli pregressi, equipollenze ed equivalenze e accertare il momento in cui il requisito deve essere posseduto. Una fonte generale non può correggere per intuizione un requisito scritto nella procedura: se emerge un dubbio, servono il testo ufficiale e una verifica giuridica.

Per l'OSS la logica è diversa. La qualifica e la formazione sono disciplinate dal profilo nazionale revisionato e dagli atti applicativi pertinenti; non si trasferisce automaticamente il ragionamento riservato agli albi delle professioni sanitarie.

EQUIPOLLENZA ED EQUIVALENZA NON SONO SINONIMI DI “TITOLO SIMILE”

Il candidato commette un errore frequente quando considera sufficiente una somiglianza nel nome del diploma o del corso. Equipollenza ed equivalenza sono categorie giuridiche e richiedono il riferimento applicabile al titolo posseduto. Anche i titoli conseguiti all'estero seguono un percorso di riconoscimento che non può essere dedotto dalla sola traduzione del certificato.

Nel Bando Decoder va quindi inserita una riga autonoma: titolo richiesto / titolo posseduto / fonte del riconoscimento / verifica effettuata. Se la quarta casella è vuota, il requisito non è ancora chiuso.

GLI ELEMENTI MOBILI DEL BANDO

Sono mobili, fra gli altri, il numero dei posti, le riserve, i termini, il contributo di partecipazione, la piattaforma, le modalità della domanda, il calendario, i punteggi, le soglie, l'eventuale banca dati, la lingua, gli strumenti informatici, la sede, requisiti locali come la patente e la specifica combinazione delle prove.

Anche una ricorrenza piena nel campione esaminato resta un dato del campione. È utile per stabilire priorità di studio, ma non autorizza la frase “in tutti i concorsi sanitari”. Il candidato usa la ricorrenza per prepararsi; usa il bando per decidere.

BANDO IN PRATICA — LA VERIFICA IN TRE PASSAGGI

1. Leggi la formula esatta del requisito nel bando integrale. 2. Collega il requisito alla fonte ufficiale del profilo o del titolo. 3. Registra ciò che resta da controllare: vigenza, riconoscimento, termine o disciplina locale.

Scritta, pratica e orale: tre prove, tre prestazioni

Il D.P.R. 220/2001 fornisce il contesto speciale per i concorsi del personale non dirigenziale del SSN; il quadro generale dei concorsi e il singolo bando completano la disciplina applicabile. Il nome del profilo, da solo, non permette di dedurre le prove: occorre leggere la sequenza prevista dalla procedura concreta.

PROVA SCRITTA

La scritta può assumere la forma di quiz, quesiti sintetici, tema, elaborato o combinazione teorico-pratica. Cambia quindi il tipo di allenamento.

Un quiz richiede riconoscimento rapido, controllo dei distrattori e gestione del tempo. Una risposta sintetica richiede selezione: definizione, elementi decisivi, conseguenza e, quando serve, riferimento alla fonte. Un elaborato richiede architettura. Una traccia teorico-pratica richiede di collegare regola, scenario, decisione e limiti.

Nei bandi M-SA02 esaminati la prova scritta ricorre spesso, ma non assume una forma uniforme. Il candidato deve annotare se la procedura prevede quesiti aperti o chiusi, quale estensione è plausibile, quali materie sono esplicite e se sono pubblicate istruzioni ulteriori.

PROVA PRATICA O TEORICO-PRATICA

“Pratica” non significa sempre eseguire una manovra. Nei bandi può indicare la descrizione di tecniche, la soluzione di quesiti connessi alla qualificazione, un caso, il riconoscimento o la predisposizione di un atto, una simulazione o l'uso controllato di attrezzature.

L'output cambia con il profilo. Un infermiere può dover impostare un piano assistenziale, mentre un fisioterapista può ragionare su valutazione e programma. Al TPALL può essere chiesto un verbale o un piano di controllo; all'OSS, una sequenza assistenziale di base. Nessuno di questi output diventa esecutivo senza una fonte tecnica, la procedura del setting e limiti professionali chiariti.

PROVA ORALE

L'orale verifica conoscenza, ma anche ordine, lessico, capacità di distinguere e risposta alle domande di approfondimento. Quando il bando lo prevede, può comprendere la verifica della lingua straniera e delle competenze informatiche.

Una risposta sanitaria ordinata non parte dal dettaglio più tecnico, ma dall'inquadramento del profilo e della fonte. Poi definisce il concetto, ne indica la funzione e distingue responsabilità e collaborazioni. L'applicazione allo scenario viene dopo; sicurezza, limiti e controlli chiudono la risposta. In questo modo il candidato evita di recitare nozioni o improvvisare collegamenti.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

“In che modo cambia la preparazione tra prova scritta, pratica e orale per un profilo sanitario?” La risposta deve collegare la forma della prova all'output: riconoscere o argomentare nello scritto; applicare e motivare nella pratica; spiegare, distinguere e sostenere domande incrociate nell'orale. Va aggiunto che il formato effettivo deriva dal bando e che ogni applicazione tecnica rispetta competenze e procedure del setting.

La Mappa BANDO sanitaria

Nel settore sanitario il Metodo BANDO conserva la propria funzione, ma cambiano le domande da porre. La mappa tiene insieme disciplina tecnica e procedura concorsuale, così nessuna delle due viene studiata isolatamente.

Passaggio	Domanda sanitaria	Prodotto
B — Bando	Qual è il profilo? Quali titolo, albo o qualifica? Quali prove e materie?	scheda della procedura
A — Aree	Quali blocchi appartengono al nucleo comune e quali al verticale?	mappa delle aree
N — Nuclei	Quali concetti ad alta resa servono per quel profilo e quella prova?	elenco prioritizzato
D — Diario	Quali errori riguardano fonte, contenuto, applicazione o formato?	diario degli errori
O — Output	Devo riconoscere, spiegare, pianificare, decidere, verbalizzare o simulare?	prova allenabile

B — PARTI DAL BANDO INTEGRALE

Registra ente, profilo, area o inquadramento, requisiti, materie, prove, titoli, termini e allegati. Le pagine informative aiutano a trovare la procedura, ma il lavoro si svolge sul bando integrale e sugli atti ufficiali collegati.

A — SEPARA LE AREE

Nel settore sanitario possono convivere disciplina professionale, organizzazione del SSN, sicurezza, deontologia, evidenze, igiene, materia clinica o tecnica e nuclei generali rinviabili al VOL-01. La separazione impedisce che il candidato studi con la stessa profondità tutto ciò che incontra.

Il nucleo comune del VOL-01 resta nei capitoli dedicati all'anatomia del bando, alla prova a quiz, alla prova scritta e teorico-pratica e alla prova orale. Qui interessa soltanto la loro applicazione al profilo sanitario.

N — SELEZIONA I NUCLEI

Un nucleo è un'unità che deve diventare conoscenza e prestazione: definizione, funzione, elementi, distinzioni, conseguenza, caso, errore e verifica. “Legislazione sanitaria” è un'area; “campo proprio di attività e responsabilità del profilo” è un nucleo. “Infermieristica” è un'area; “identificazione dei bisogni e pianificazione assistenziale” è un nucleo.

D — USA IL DIARIO PER CORREGGERE LA CAUSA

Segna se l'errore deriva da fonte sbagliata, confusione tra profili, norma non aggiornata, conoscenza incompleta, applicazione impropria o risposta disordinata. Due risposte errate uguali nel risultato possono richiedere correzioni diverse.

O — ALLENA IL PRODOTTO FINALE

Per ogni nucleo scrivi l'output: quiz, risposta in righe definite, esposizione orale, caso, piano, procedura illustrata, verbale o checklist. Un prodotto concreto permette di verificare il livello di preparazione.

Caso guidato: decodificare una procedura sanitaria

Considera una procedura didattica composta per un profilo infermieristico. Il bando richiede titolo abilitante e iscrizione all'albo, prevede prova scritta, pratica e orale e indica materie infermieristiche, sicurezza, igiene e organizzazione sanitaria. Non sono riportati qui punteggi, soglie o calendario, perché nel lavoro reale vanno estratti dal testo della procedura selezionata.

PASSAGGIO 1 — IDENTIFICARE IL PROFILO E LE FONTI

Il profilo è infermieristico. Le prime fonti da collegare sono il D.M. 739/1994, l'ordinamento professionale e il bando. Il D.P.R. 220/2001 offre il contesto concorsuale speciale; le fonti tecniche e deontologiche sosterranno le materie e i casi.

PASSAGGIO 2 — SEPARARE ELEMENTI STABILI E MOBILI

Sono strutturali il riferimento al profilo e, nel quadro applicabile, titolo abilitante e albo. Sono mobili posti, termini, punteggi, soglie, calendario, modalità operative e dettaglio delle materie. Anche la sequenza delle prove va verificata: non si presume dalla sola denominazione del posto.

PASSAGGIO 3 — TRADURRE LE PROVE IN ALLENAMENTO

Per la scritta servono domande e risposte sulle materie dichiarate. Per la pratica servono casi e output assistenziali non esecutivi, costruiti su fonti validate. Per l'orale servono risposte brevi e ordinate, con collegamenti, esempi e limiti. Informatica e lingua si preparano soltanto nella forma e nella profondità indicate dal bando.

PASSAGGIO 4 — COSTRUIRE IL PIANO MINIMO

Il candidato prepara una tabella con quattro colonne: materia, nucleo, prova, output. Per esempio, sicurezza della terapia può diventare un nucleo teorico nella scritta, un caso ragionato nella pratica e una risposta su responsabilità e barriere nell'orale. Il contenuto specifico sarà sviluppato nel verticale infermieristico, non inventato nel capitolo introduttivo.

PASSAGGIO 5 — REGISTRARE CIÒ CHE MANCA

Restano da verificare il testo vigente, gli eventuali allegati, la banca dati, i criteri di valutazione, le istruzioni della commissione, gli atti regionali o aziendali citati e le procedure del setting. La casella “da verificare” segnala un controllo ancora aperto e impedisce di trattare un dato incerto come acquisito.

Domanda da commissario

Perché una prova pratica sanitaria non coincide necessariamente con l'esecuzione di una manovra?

Una risposta completa parte dal bando: è la procedura a definire forma e oggetto della prova. Nel quadro dei concorsi sanitari, la pratica può consistere nell'esecuzione o illustrazione di tecniche, nella soluzione di quesiti connessi alla qualificazione, nell'analisi di un caso, nella predisposizione di un piano o nel riconoscimento di un atto. L'output dipende dal profilo: assistenziale, riabilitativo, ispettivo o di supporto. Qualunque applicazione deve rispettare competenze, sicurezza, fonti tecniche e procedure del setting. Il candidato non deve quindi preparare una sequenza universale, ma imparare a leggere la traccia, identificare responsabilità e produrre l'output richiesto.

La risposta è completa perché contiene inquadramento, distinzione, applicazione e limite. Dire soltanto che “dipende dal bando” non basta: bisogna spiegare che cosa cambia e come adeguare l'allenamento.

Domanda-trappola

Se tutti i bandi del tuo campione prevedono l'orale, puoi considerarlo obbligatorio in ogni futuro concorso dello stesso profilo?

No. Il campione documenta una ricorrenza osservata, utile per decidere le priorità di preparazione. Non crea una fonte normativa e non sostituisce il bando futuro. Conviene allenare l'orale se ricorre nel campione, ma presenza, struttura e collocazione si verificano nella procedura concreta.

La trappola consiste nel confondere l'evidenza editoriale con la disciplina della procedura. L'evidenza orienta il manuale; la disciplina vincola il candidato.

Errore tipico: studiare un concorso sanitario indistinto

Il candidato raccoglie appunti su SSN, infermieristica, sicurezza, privacy, emergenza, riabilitazione e prevenzione, poi li ripassa tutti allo stesso modo. Il volume di studio cresce, ma non esiste una relazione chiara tra materia e prova.

Per correggere il metodo di studio:

1. elimina ciò che non compare nel bando e non è una dipendenza necessaria;
2. assegna ogni nucleo al profilo e alla fonte corretti;
3. scrivi accanto a ogni nucleo l'output da allenare.

Se non sai dire quale risposta, caso, piano, verbale o esposizione deve nascere dallo studio, il nucleo non è ancora operativo.

Mini-esercizio: strutturale, mobile o da verificare?

Classifica ogni elemento. Usa S per strutturale, M per mobile della procedura e V quando il dato richiede una verifica giuridica o documentale prima di essere considerato acquisito.

1. Fonte normativa che definisce il profilo professionale.
2. Numero dei posti.
3. Termine di presentazione della domanda.
4. Iscrizione all'albo quando richiesta per la professione ordinistica.
5. Equipollenza di uno specifico titolo posseduto dal candidato.
6. Presenza di una prova pratica autonoma.
7. Calendario della prova orale.
8. Campo tipico di attività del profilo.
9. Patente B richiesta da un singolo ente.
10. Pubblicazione di una banca dati ufficiale.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. S: orienta stabilmente il campo professionale, salvo coordinamento con fonti successive.
2. M: vale per la procedura concreta.
3. M: si legge nel bando e nei successivi avvisi ufficiali.
4. S/V: è strutturale nel quadro applicabile, ma va verificata la formulazione e il momento del possesso nel bando.

5. V: non si deduce dal nome del titolo.
6. M: i bandi esaminati mostrano combinazioni diverse.
7. M: può essere fissato o modificato con comunicazione ufficiale.
8. S: deriva dalla fonte del profilo, coordinata con ordinamento e deontologia.
9. M: non è un requisito universale del profilo.
10. M: cambia il metodo di allenamento, ma esiste soltanto quando la procedura la prevede.

Mini-esercizio: dalla traccia all'output

Associa ogni traccia al prodotto principale da allenare.

Traccia	Output principale
Quesito a risposta multipla sul campo professionale	scelta motivata e controllo del distrattore
Scenario assistenziale con bisogni e priorità	piano o risposta assistenziale strutturata
Sopralluogo con irregolarità nel perimetro TPALL	rapporto, verbale o schema di controllo secondo la traccia
Colloquio sui limiti tra due ruoli	esposizione orale con fonte, distinzione, caso e limite

L'esercizio non valuta la procedura tecnica. Verifica se il candidato riconosce la prestazione richiesta dalla commissione.

Checklist del capitolo

Prima di costruire il piano di studio, controlla:

- ☐ ho scaricato il bando integrale e gli allegati ufficiali;
- ☐ ho identificato il profilo esatto e l'ente;
- ☐ ho copiato la formula dei requisiti senza parafrasarla;
- ☐ ho verificato titolo, albo o qualifica con la fonte pertinente;
- ☐ ho separato elementi strutturali e mobili;
- ☐ ho elencato prove e materie nell'ordine del bando;
- ☐ ho associato ogni materia a nuclei concreti;
- ☐ ho associato ogni nucleo a un output;
- ☐ ho segnato le informazioni ancora da verificare;
- ☐ ho distinto il nucleo comune del VOL-01 dal delta sanitario;
- ☐ ho evitato di trasferire regole da un profilo o setting a un altro;
- ☐ ho previsto una verifica finale su avvisi, calendario e istruzioni della commissione.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, per la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo vigente, per il quadro generale delle procedure concorsuali pubbliche.
- Legge 26 febbraio 1999, n. 42; legge 10 agosto 2000, n. 251; legge 1 febbraio 2006, n. 43; legge 11 gennaio 2018, n. 3, per professioni sanitarie, autonomia, formazione e ordinamento.
- D.M. 14 settembre 1994, nn. 739, 740 e 741, per i profili di infermiere, ostetrica/o e fisioterapista.
- D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, per il profilo del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
- DPCM 25 marzo 2025, per il profilo nazionale dell'operatore sociosanitario, da coordinare con gli atti regionali e con il bando applicabile.

Questi riferimenti definiscono il quadro generale; requisiti, prove, scadenze, punteggi, titoli ammessi e modalità operative devono sempre essere verificati nel bando e negli avvisi ufficiali della procedura scelta.

Discipline professionali: autonomia, responsabilità e deontologia

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Obiettivo del capitolo

Questo capitolo porta dal nome del profilo alla risposta da concorso. Davanti a infermiere, ostetrica, fisioterapista, TPALL o OSS, il candidato deve collegare fonte, campo di attività, autonomia, responsabilità, collaborazione e limite operativo.

Al termine saprai:

- distinguere le professioni sanitarie ordinistiche dal profilo dell'OSS;
- spiegare come profilo, ordinamento didattico e codice deontologico delimitano il campo professionale;
- collegare autonomia, responsabilità, collaborazione e limite senza confonderli;
- costruire una risposta scritta o orale partendo dalla fonte corretta;
- riconoscere quando un caso richiede comunicazione, collaborazione o escalation.

Mappa BANDO

La sequenza da applicare è: fonte → profilo → autonomia → responsabilità → collaborazione → limite. La fonte evita risposte intuitive; il profilo delimita il campo; l'autonomia individua ciò che il professionista governa con competenza propria; la responsabilità distingue il ruolo individuale dall'organizzazione e dalla struttura; collaborazione e limite collocano l'azione dentro il servizio, le consegne, la continuità e l'escalation.

Passaggio	Domanda da porsi	Risultato atteso in prova
B — Bando	Quale profilo e quale setting sono indicati?	Individuazione del perimetro della domanda
A — Aree	La questione riguarda assistenza, percorso nascita, riabilitazione, prevenzione o supporto?	Classificazione corretta della materia

Passaggio	Domanda da porsi	Risultato atteso in prova
N — Nuclei	Quali fonte, autonomia, responsabilità e limiti devo spiegare?	Risposta teorica completa
D — Diario	Ho confuso competenza propria, collaborazione, prescrizione o attribuzione?	Correzione dell'errore di ragionamento
O — Output	Devo rispondere a un quiz, esporre all'orale o analizzare un caso?	Prestazione coerente con la prova

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Autonomia non significa isolamento. La responsabilità non coincide sempre con responsabilità civile o penale. La collaborazione non cancella il dovere personale. Il profilo professionale delimita il campo di attività; il setting ne organizza l'esercizio concreto. L'OSS è un operatore di interesse sanitario e non una professione sanitaria ordinistica.

Il capitolo non autorizza procedure cliniche, manovre, trattamenti, dosaggi, sequenze assistenziali o decisioni medico-legali. Gli esempi hanno funzione concorsuale: aiutano a riconoscere confini, fonti e responsabilità. Per la tecnica generale di lettura del bando, della prova scritta, del quiz e dell'orale si rinvia al metodo generale del volume Anatomia del bando, La prova a quiz, La prova scritta e teorico-pratica e La prova orale. Qui il delta sanitario è diverso: non basta “studiare la materia”; bisogna saper dire chi può fare che cosa, con quale fonte, entro quale limite e con quale responsabilità.

Il quadro comune delle professioni sanitarie

PROFILO, ORDINAMENTO DIDATTICO E CODICE DEONTOLOGICO

Per le professioni sanitarie ordinistiche il punto di partenza non è il mansionario, ma il campo proprio di attività e responsabilità. Il quadro ordinamentale si costruisce attraverso quattro passaggi: la legge 42/1999 supera la categoria della professione sanitaria ausiliaria; la legge 251/2000 riconosce autonomia professionale, responsabilità e metodologie proprie; la legge 43/2006 collega la professione sanitaria al titolo abilitante statale; la legge 3/2018 riordina il sistema degli ordini e delle federazioni nazionali.

All'esame occorre coordinare profilo ministeriale, ordinamento didattico e codice deontologico, nel rispetto delle competenze delle altre professioni. Il criterio vale per infermiere, ostetrica, fisioterapista e TPALL, ciascuno con il proprio profilo e con i propri riferimenti deontologici.

Per rendere questo schema pratico, conviene preparare una matrice minima da ripetere per ogni profilo: fonte istitutiva, titolo abilitante o qualificazione, oggetto dell'attività, autonomia, responsabilità, relazione con prescrizioni, collaborazione, documentazione e limite di escalation. La matrice non sostituisce lo studio della disciplina, ma impedisce risposte confuse quando il quesito presenta più figure nello stesso caso. Se la domanda chiede "chi interviene", il candidato non deve inseguire la manovra: deve prima stabilire quale professione ha competenza propria, quale figura supporta, quale atto richiede prescrizione o procedura e quale passaggio va comunicato all'équipe.

Nel confronto con l'OSS la stessa matrice chiarisce il lessico. Per le professioni sanitarie ordinistiche "autonomia" è parola da collegare a profilo, ordinamento, responsabilità e deontologia; per l'OSS è più corretto parlare di attività di supporto, attribuzione, collaborazione e contesto organizzativo. All'orale questa distinzione produce una risposta sobria: nessuna figura è "senza responsabilità", ma la responsabilità non ha la stessa base giuridica, lo stesso livello di decisione professionale o lo stesso rapporto con l'albo.

In concorso, questa impostazione evita due errori ricorrenti: dedurre le competenze dal solo titolo del posto e leggere l'autonomia come isolamento. L'autonomia è esercizio responsabile di competenze proprie dentro l'équipe, nel rispetto delle prescrizioni previste e delle procedure aziendali; non autorizza a invadere campi altrui.

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA DELLE CURE E CASO CONCRETO

La responsabilità sanitaria va letta con cautela. La legge 24/2017 collega la sicurezza delle cure al diritto alla salute e alla prevenzione e gestione del rischio nelle attività assistenziali e organizzative; la legge 219/2017 collega consenso informato, relazione di cura, comunicazione e autodeterminazione della persona. Per il candidato, però, questo non autorizza conclusioni civilistiche o penali. In una risposta orale corretta si distingue il piano della struttura, il piano dell'équipe e il piano del singolo professionista.

All'orale può essere utile una formula come questa: "Il professionista agisce nel proprio campo, documenta o comunica secondo il setting, collabora con gli altri profili e segnala il rischio quando il caso supera il proprio perimetro". La commissione valuta la capacità di riconoscere fonte, regola, azione prudente, limite e verifica.

Responsabilità civile, penale e copertura assicurativa

La L. 24/2017 distingue il rapporto del paziente con la struttura da quello con il professionista. Per risolvere un quesito occorre prima identificare chi viene chiamato a rispondere e quale obbligazione abbia assunto; il semplice fatto che si sia verificato un danno non dimostra automaticamente la colpa di tutti i componenti dell'équipe.

Soggetto o piano	Regola essenziale	Errore da evitare
Struttura sanitaria o sociosanitaria	Art. 7: responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., anche per gli ausiliari di cui si avvale	Confondere l'assenza di rapporto di lavoro dipendente con assenza di responsabilità della struttura
Esercente senza obbligazione contrattuale propria verso il paziente	Art. 7: responsabilità ex art. 2043 c.c.	Attribuirgli automaticamente lo stesso regime della struttura
Esercente che assume un'obbligazione contrattuale verso il paziente	Opera l'eccezione prevista dall'art. 7, comma 3	Trattare ogni attività libero-professionale come se fosse identica al rapporto di dipendenza
Responsabilità penale	È personale; richiede elementi del reato, nesso causale e colpa nei casi previsti	Derivarla dalla sola domanda di risarcimento o dall'esito sfavorevole

L'art. 590-sexies c.p. riguarda morte o lesioni colpose nell'esercizio di una professione sanitaria. La disciplina delle linee guida non garantisce un'esenzione automatica: conta che le raccomandazioni siano adeguate al caso. Nell'interpretazione delle Sezioni unite n. 8770/2018, la causa di non punibilità riguarda l'imperizia lieve nella fase esecutiva di raccomandazioni correttamente scelte; non copre negligenza, imprudenza, scelta di raccomandazioni inadeguate o imperizia grave nell'esecuzione. Se manca una linea guida pertinente, non la si sostituisce con una citazione generica.

Disciplina temporanea al 3 ottobre 2026. L'art. 4, comma 8-septies, del D.L. 215/2023, come modificato, limita la punibilità ai casi di colpa grave per fatti degli artt. 589 e 590 c.p. commessi fino al 31 dicembre 2026 nell'esercizio sanitario in situazioni di grave carenza di personale sanitario. La condizione organizzativa va accertata: non basta dichiarare che il reparto lavora molto. Questa previsione non elimina responsabilità civile, obblighi professionali o necessità di valutare il caso e non va presentata come regola permanente.

La copertura assicurativa è un altro piano. L'art. 10 L. 24/2017 prevede coperture o analoghe misure per le strutture, obblighi per chi esercita nelle condizioni libero-professionali indicate dalla legge e una polizza personale per colpa grave per gli esercenti che operano nelle strutture. La polizza non autorizza condotte scorrette e non coincide con l'accertamento della responsabilità; condizioni e garanzie vanno confrontate con la disciplina attuativa applicabile.

Caso: una prestazione resa in una struttura produce un danno. Il candidato può concludere che risponde solo il dipendente? Soluzione: no. Deve distinguere la responsabilità della struttura, quella del professionista e l'eventuale piano penale; occorrono condotta, nesso e presupposti del regime pertinente. Non si individua il responsabile scegliendo semplicemente chi ha firmato per ultimo.

Consenso, rifiuto, DAT e pianificazione condivisa

La L. 219/2017 tutela l'autodeterminazione nella relazione di cura. Il consenso informato è una scelta preceduta da informazioni comprensibili su diagnosi, prospettive, benefici, rischi, alternative e conseguenze del rifiuto. La firma documenta un percorso: non lo sostituisce. La persona capace può rifiutare o revocare il trattamento; questo richiede informazione e accompagnamento, non abbandono. La comunicazione e il contributo dell'équipe sono approfonditi nel capitolo «Prevenzione, continuità assistenziale e presa in carico».

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sono espresse da una persona maggiorenne capace in previsione di una futura incapacità, dopo adeguata informazione medica. Possono indicare un fiduciario che la rappresenti nel rapporto con i curanti. Restano efficaci anche se manca il fiduciario; la legge disciplina come colmare l'eventuale esigenza di rappresentanza. Non sono un generico foglio con preferenze: sono previste forme di redazione, consegna, modifica e revoca.

Il medico deve rispettarle. L'art. 4 consente di disattenderle, d'accordo con il fiduciario, nelle condizioni tassative indicate: manifesta incongruenza, mancata corrispondenza alla condizione clinica attuale o terapie non prevedibili alla sottoscrizione capaci di concrete possibilità di miglioramento della vita. Il disaccordo segue il percorso del giudice tutelare. Non basta che un familiare preferisca un'altra scelta.

La pianificazione condivisa delle cure, art. 5, nasce invece nella relazione già in corso per una patologia cronica e invalidante o a evoluzione inarrestabile con prognosi infausta. Paziente e medico discutono evoluzione prevedibile, possibilità assistenziali e scelte future. La pianificazione documentata può essere aggiornata; medico ed équipe vi si attengono quando il paziente non può più esprimere il consenso. DAT e pianificazione condivisa anticipano scelte, ma partono da contesti differenti.

MINORE E PERSONA CON LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ

Il minore ha diritto a essere informato in modo adeguato e a vedere considerata la propria volontà secondo età e maturità. Il consenso è espresso o rifiutato da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, con lo scopo di tutelare salute, vita e dignità. La voce del minore non scompare perché firma un adulto.

Per la persona interdetta interviene il tutore, sentendola ove possibile; l'inabilitato esprime personalmente il consenso. Nell'amministrazione di sostegno si legge il decreto di nomina: assistenza o rappresentanza sanitaria non si presumono per qualunque amministratore. Il rifiuto del rappresentante di cure che il medico ritiene appropriate e necessarie può richiedere la decisione del giudice tutelare secondo l'art. 3. Le urgenze mantengono le regole dell'art. 1, comma 7, nel rispetto della volontà conoscibile del paziente.

Verifica ragionata: una persona capace con malattia cronica evolutiva concorda con il medico le cure future: è necessariamente una DAT? Risposta: no, il caso descrive la pianificazione condivisa. Una persona sana che dispone oggi per un'eventuale incapacità futura utilizza invece le DAT, rispettandone i presupposti. In entrambi i casi la volontà attuale della persona capace va ascoltata e non sostituita dalle preferenze dei familiari.

Professioni sanitarie e OSS: una distinzione decisiva

L'OSS appartiene al perimetro sanitario e sociosanitario del modulo, ma non va assimilato alle professioni sanitarie ordinistiche. La fonte nazionale corrente è il DPCM 25 marzo 2025, che recepisce gli accordi del 2024 e disapplica l'accordo del 2001 dalla propria entrata in vigore. L'OSS è qualificato come operatore di interesse sanitario: svolge attività indirizzate ai bisogni primari e al benessere e autonomia della persona assistita in ambito sanitario, sociosanitario e sociale.

I riferimenti cambiano secondo la figura. Per infermiere, ostetrica, fisioterapista e TPALL si parte da profilo, autonomia professionale, albo e codice deontologico. Per l'OSS contano invece il profilo nazionale, l'attuazione regionale, l'organizzazione del servizio e le attività attribuite nel setting. Gli atti di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto successivi al DPCM 2025 mostrano modelli regionali di formazione, tirocinio, supervisione e contenuti pratici, ma non definiscono uno standard nazionale unico.

I bandi esaminati confermano questa separazione. Nei concorsi per le professioni sanitarie ricorrono titolo professionale, albo, prove scritte, pratiche e orali, discipline del profilo e, in parte, deontologia o legislazione professionale. Nei bandi OSS emergono ruolo, competenze, assistenza di base, relazione, sicurezza, contesto socioassistenziale o SSN e prove pratiche, ma i programmi di esame non bastano da soli a insegnare procedure.

Cinque percorsi, fonti e confini differenti

INFERMIERE: PIANIFICAZIONE, ASSISTENZA E RAPPORTO CON IL SUPPORTO

Il profilo dell'infermiere è definito dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739. È il professionista dell'assistenza infermieristica generale negli ambiti preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo, con componenti tecniche, relazionali ed educative. Nel linguaggio da concorso, il nucleo non è “fare assistenza” in modo generico, ma identificare bisogni, definire obiettivi, pianificare, gestire e valutare l'intervento infermieristico, assicurare la corretta applicazione delle prescrizioni e collaborare con altri professionisti.

L'autonomia infermieristica non elimina il rapporto con il medico, con l'équipe o con il personale di supporto. Significa che l'infermiere risponde del proprio processo professionale: raccolta e interpretazione dei bisogni assistenziali, priorità, pianificazione, continuità, educazione, documentazione e segnalazione. Il Codice deontologico delle professioni infermieristiche FNOPI 2025 rafforza i nuclei di presa in carico, pianificazione, documentazione, continuità, educazione, sicurezza e relazione con persona, famiglia e comunità.

Nella prova scritta o orale, una risposta forte evita sia l'appiattimento esecutivo sia l'eccesso opposto. Dire che l'infermiere “esegue prescrizioni” è incompleto; dire che decide ogni cosa senza coordinamento è errato. La formulazione corretta è: l'infermiere esercita autonomia e responsabilità nel campo infermieristico, applica correttamente le prescrizioni quando presenti, governa il processo assistenziale di competenza, collabora con l'équipe e si rapporta al personale di supporto secondo organizzazione, attribuzioni e procedure del setting.

Il limite non esecutivo è essenziale: questo capitolo non insegna tecniche assistenziali, terapia, triage, manovre, gestione di presidi o piani clinici. Se il caso d'esame descrive un rischio, una richiesta impropria o una situazione non chiara, l'azione concorsuale da riconoscere è classificare il problema, verificare la regola applicabile, documentare o comunicare secondo procedura, coinvolgere il professionista competente e non oltrepassare il profilo. Gli aspetti tecnico-clinici appartengono ai capitoli dedicati e ogni applicazione concreta deve essere coordinata con linee guida vigenti e procedure del servizio.

OSTETRICA: PERCORSO MATERNO-NEONATALE, COMPETENZA ED ESCALATION

Il profilo dell'ostetrica/o è definito dal D.M. 14 settembre 1994, n. 740. Comprende assistenza e consulenza durante gravidanza, parto e puerperio, conduzione del parto eutocico, assistenza al neonato, educazione sanitaria e sessuale, preparazione al parto, assistenza ginecologica, prevenzione oncologica e programmi materno-neonatali. Questo insieme di attività descrive un campo professionale specifico, quello materno-neonatale, nel quale autonomia e responsabilità procedono insieme al riconoscimento dei confini del caso.

L'autonomia ostetrica va spiegata senza trasformarla in autosufficienza assoluta. La fonte indica anche il riconoscimento delle situazioni potenzialmente patologiche e le misure di emergenza di competenza; proprio per questo la risposta da concorso deve contenere la parola "escalation". Quando il caso esce dal perimetro fisiologico, presenta segnali di rischio o richiede decisioni di altra competenza, l'ostetrica non improvvisa un protocollo: riconosce il limite, attiva il percorso previsto, collabora con l'équipe e assicura comunicazione e tracciabilità secondo il setting.

Il confronto con l'infermiere aiuta a non sovrapporre due autonomie entrambe forti ma diverse. L'infermiere governa il processo assistenziale generale della persona, con continuità trasversale ai setting; l'ostetrica governa il percorso materno-neonatale e ginecologico di competenza, con centralità della fisiologia, della prevenzione e del riconoscimento precoce del rischio. In un caso concorsuale su donna in gravidanza ricoverata in reparto, quindi, non basta dire "collaborano": occorre indicare che la presa in carico può richiedere competenze infermieristiche e ostetriche distinte, coordinate dalla procedura aziendale e dal bisogno concreto.

La risposta migliore evita gerarchie improvvisate: parte dalle fonti dei profili, descrive l'area propria di ciascuno, mostra il punto di raccordo nell'équipe e chiude con escalation quando compaiono segnali non ordinari. Questo confronto è utile anche nei quiz: se l'alternativa confonde assistenza infermieristica generale, percorso nascita, prescrizione medica e supporto OSS, la chiave è il perimetro professionale, non il verbo operativo usato nella traccia.

Il codice deontologico FNOPO valorizza salute della donna e del neonato, assistenza al percorso nascita, consenso, emergenza di competenza, cartella ostetrica e rapporti nell'équipe. In sede orale, una risposta matura può seguire questa traccia: fonte del profilo; area materno-neonatale; autonomia nel percorso fisiologico e nelle attività professionali proprie; responsabilità nella relazione, nella comunicazione e nella documentazione; limite quando il setting, il rischio o la situazione patologica impongono collaborazione, segnalazione o intervento di altro professionista.

Anche qui il limite non esecutivo è netto. Il capitolo non descrive gestione del parto, manovre ostetriche, assistenza neonatale operativa, emergenze cliniche, protocolli di sala parto o criteri diagnostici. Per il concorso, il candidato deve imparare a distinguere profilo, fonte, autonomia e confine; le applicazioni che dipendono da linee guida, procedure aziendali, organizzazione del punto nascita o bando specifico vanno sempre verificate nel contesto applicabile.

FISIOTERAPISTA: VALUTAZIONE FUNZIONALE, PROGETTO E VERIFICA

Per il fisioterapista la fonte primaria del profilo è il [D.M. 14 settembre 1994, n. 741] (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/01/09/095G0003/sg>). Nel lessico da concorso, il candidato deve collegare questo profilo all'area riabilitativa, alla valutazione funzionale, al programma riabilitativo e alla verifica della risposta agli interventi. Non deve trasformare il capitolo in una sequenza di trattamento: qui interessa il perimetro professionale, non l'esecuzione di tecniche.

Il profilo comprende prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e delle funzioni viscerali. Comprende anche il trattamento delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e il ricorso a strumenti propri della fisioterapia, indicati dalla fonte come terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali. In una risposta scritta o orale conta soprattutto il nesso tra valutazione, progetto, responsabilità e verifica. Il fisioterapista opera nel proprio campo con autonomia e responsabilità, in coordinamento con il percorso clinico e organizzativo; non è il semplice esecutore di un segmento riabilitativo.

Questa autonomia si legge insieme alle leggi ordinamentali. La [legge 42/1999] (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42>) collega il campo proprio di attività e responsabilità a profilo professionale, ordinamento didattico e codice deontologico; la [legge 251/2000] (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-08-10;251>) riconosce autonomia professionale, responsabilità e metodologie proprie nelle aree professionali sanitarie. Per il fisioterapista questo significa che la risposta deve distinguere il progetto riabilitativo di competenza dal piano complessivo del servizio, dalle prescrizioni eventualmente rilevanti, dalle competenze mediche e dagli apporti di infermiere, OSS e altri professionisti.

Nei bandi rappresentativi 2025-2026 compaiono, per il fisioterapista, riabilitazione, metodologie e tecniche, rieducazione funzionale, disabilità, fragilità, continuità e casi teorico-pratici. Questi dati dimostrano la pertinenza concorsuale del nucleo, ma non sostituiscono le fonti tecnico-professionali. Il ragionamento collega profilo, valutazione funzionale, programma riabilitativo, verifica, collaborazione e limite. Quest'ultimo va esplicitato quando il caso richiede decisioni cliniche, diagnosi, procedure aziendali o validazione specialistica non presenti nella traccia.

TPALL: PREVENZIONE, VIGILANZA, IMPARZIALITÀ E ATTI

Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ha come fonte primaria il [D.M. 17 gennaio 1997, n. 58] (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/03/14/097G0086/sg>). Il profilo copre prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, alimenti e bevande, sanità pubblica e veterinaria. Nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza, nei limiti delle attribuzioni, può assumere funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Questa figura va studiata evitando due semplificazioni. La prima è ridurla a un tecnico “ambientale” generico; la seconda è considerarla soltanto un profilo sanitario interno all'azienda. I bandi esaminati mostrano due sottotracce: prevenzione sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro; controllo ambientale, anche presso ARPA, con autorizzazioni, emissioni, scarichi, matrici ambientali, campionamenti e profili sanzionatori. Il candidato deve quindi chiedersi quale contesto descrive il bando: azienda sanitaria, dipartimento di prevenzione, ente ambientale o struttura con compiti ispettivi.

Competenza tecnica e funzione pubblica di controllo non coincidono. Quando opera in vigilanza, il TPALL agisce nell'ambito di attribuzioni pubbliche e deve rispettare imparzialità, correttezza dell'accertamento e limiti dell'incarico; non svolge il ruolo generico di “consulente interno” dell'organizzazione. In un caso concorsuale occorre quindi chiarire da dove nasce il potere e, solo dopo, che cosa viene osservato, documentato o trasmesso. Soglie, qualificazioni di illecito, esiti sanzionatori e modelli di verbale non ricavabili dalle fonti disponibili non vanno inventati.

La deontologia rafforza il profilo. Il codice TPALL pubblicato dalla FNO TSRM e PSTRP nel 2025 insiste su indipendenza, imparzialità del controllo, vigilanza, verbalizzazione, campionamento, trasparenza, segreto d'ufficio o professionale, conflitti e rapporti con autorità ed enti. Questi elementi sono preziosi per i casi concorsuali perché spostano la risposta dal “che cosa controllare” al “come inquadrare correttamente il ruolo”: fonte dell'attribuzione, terzietà, correttezza dell'atto, tracciabilità e limite.

Anche per il TPALL il capitolo non deve diventare una guida ispettiva o un manuale di campionamento. L'output corretto è riconoscere il campo: quando si parla di vigilanza, il candidato deve indicare fonte, competenza, imparzialità, documentazione dell'attività e coordinamento con autorità o ente competente; quando si parla di ambiente, deve distinguere la matrice o l'autorizzazione richiamata dal bando senza inventare conseguenze tecniche o sanzionatorie non fondate.

OSS: PROFILO NAZIONALE 2025 E DIFFERENZE REGIONALI

L'OSS va trattato dentro il modulo sanitario, ma con una qualificazione distinta dalle professioni sanitarie ordinistiche. La fonte nazionale corrente è il [DPCM 25 marzo 2025](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=25A03429&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-21&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2025. Il decreto recepisce gli accordi del 2024 e disapplica l'accordo del 2001 dalla propria entrata in vigore.

L'OSS è operatore di interesse sanitario, svolge attività indirizzate ai bisogni primari e al benessere e autonomia della persona assistita in ambito sanitario, sociosanitario e sociale. Non è una professione sanitaria ordinistica e non va confuso con l'assistente infermiere, profilo distinto richiamato dalla stessa documentazione nazionale. La risposta deve quindi evitare sia la svalutazione del ruolo sia l'assimilazione all'infermiere.

La differenza non è solo formale. Per le professioni sanitarie ordinistiche il baricentro è il campo professionale letto con profilo, ordinamento didattico, albo e codice deontologico; per l'OSS il baricentro è l'attività attribuita nel contesto, in collaborazione e secondo l'organizzazione del servizio. Questo non significa assenza di responsabilità: significa responsabilità della corretta esecuzione di ciò che rientra nel profilo e viene concretamente assegnato, senza trasformare il supporto in valutazione clinica autonoma, pianificazione professionale o sostituzione del professionista sanitario.

Il piano di studio deve separare tre livelli. Il primo è nazionale: profilo, contesti, attività, competenze, formazione, tirocinio, esame e aggiornamento. Il secondo è regionale: attuazione, standard formativi, accesso, tirocinio, verifica e certificazione. Il terzo è aziendale o di setting: organizzazione del servizio, attribuzioni concrete, supervisione, regole operative e responsabilità dell'attività assegnata. Solo il primo livello può essere presentato come profilo nazionale.

Le fonti regionali disponibili sono esempi ufficiali, non uno standard unico. La Lombardia, con DGR XII/4920 del 1 agosto 2025, collega il profilo nazionale a standard formativo e professionale, collaborazione, supervisione e responsabilità della corretta esecuzione delle attività attribuite. Emilia-Romagna e Veneto aggiungono altri modelli: la DGR Emilia-Romagna n. 1307 del 4 agosto 2025 disciplina soggetti attuatori, accesso e percorso; la DGR Veneto n. 883 del 29 luglio 2025, con Allegato C, presenta programmi didattici e laboratori, da usare come elenco controllato di output formativi, non come sequenza esecutiva nazionale.

Nei bandi OSS 2025-2026 ricorrono ruolo, competenze, assistenza di base, relazione, sicurezza, contesti SSN o residenziali e prove pratiche o teorico-pratiche. I programmi di bando, però, non bastano per insegnare procedure: servono a capire che cosa viene chiesto, non a dedurre autorizzazioni operative.

Deontologia: campo professionale, non ornamento

La deontologia entra nel campo professionale perché le fonti ordinamentali richiedono di leggere profilo, ordinamento didattico e codice deontologico in modo coordinato. I codici disponibili non hanno la stessa data né la stessa struttura: FNOPI 2025 per le professioni infermieristiche, FNOPO 2017 per l'ostetrica, testo AIFI 2011 dichiarato ancora vigente nel percorso FNOFI per il fisioterapista, codice TPALL 2025 della FNO TSRM e PSTRP.

I nuclei comuni sono dignità e autodeterminazione della persona, competenza, responsabilità, autonomia, appropriatezza, relazione, consenso, riservatezza, documentazione, continuità, collaborazione, formazione continua, gestione dei conflitti di interesse e segnalazione dei rischi. Le differenze vanno però conservate: l'infermiere richiama presa in carico, pianificazione e continuità; l'ostetrica il percorso nascita e la cartella ostetrica; il fisioterapista progetto riabilitativo, valutazione e relazione terapeutica; il TPALL imparzialità, vigilanza, atti e rapporti con autorità.

La deontologia orienta condotta, responsabilità, relazione e limite, ma non amplia da sola le competenze. Un codice non consente di compiere atti estranei al profilo, sostituire un altro professionista o ignorare il setting. Anche la collaborazione lascia intatto il dovere personale: partecipare all'équipe non permette di scaricare su altri la decisione o coprire una richiesta impropria. Nei casi con consenso, riservatezza, conflitto di interessi o rischio per la persona, il candidato deve far emergere competenza, prudenza, comunicazione corretta e confine professionale.

Per l'OSS non va inventato un codice deontologico equivalente. La correttezza della risposta si fonda su profilo nazionale, attuazione regionale, regole del setting, riservatezza, relazione, collaborazione e limiti dell'attività attribuita. La deontologia, quindi, non è una frase finale di stile: è il criterio che impedisce di confondere autonomia con arbitrio, collaborazione con deresponsabilizzazione e supporto con sostituzione professionale.

Collaborazione multiprofessionale, confini, handover ed escalation

Autonomia non significa isolamento. La sicurezza delle cure, secondo la [legge 24/2017] (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24>), appartiene alle attività assistenziali e organizzative e coinvolge il personale delle strutture; la [legge 219/2017] (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-22;219>) collega consenso, relazione di cura, comunicazione e autodeterminazione. Per il concorso questo impone una distinzione: responsabilità della struttura, responsabilità dell'équipe e responsabilità del singolo profilo non sono intercambiabili.

Il passaggio di consegne, o handover, va presentato come continuità informativa dentro il setting: non è una formalità, ma il punto in cui ruolo, limite e tracciabilità diventano visibili. La risposta non deve descrivere moduli o sequenze aziendali non documentate; deve affermare che le informazioni rilevanti, i rischi riconosciuti, i limiti di competenza e le richieste di intervento devono restare comunicabili e ricostruibili secondo le regole del servizio.

Nel rapporto con l'OSS, collaborazione e attribuzione vanno tenute separate dalla delega generica. L'OSS contribuisce all'assistenza di base e alla continuità osservativa nel perimetro assegnato; il professionista sanitario conserva le proprie responsabilità di valutazione, pianificazione, decisione professionale e controllo quando la fonte lo richiede. Nel rapporto con il TPALL, invece, la collaborazione non deve compromettere terzietà e imparzialità del controllo: chi vigila non diventa consulente dell'ente controllato, e chi è controllato non determina il contenuto dell'accertamento.

L'escalation è il confine in movimento. Compare quando il caso supera il profilo, quando il rischio non è gestibile nel perimetro dato, quando serve un'altra competenza o quando il bando descrive un contesto non chiaro. La traccia corretta è: fonte del profilo, regola applicabile, contributo professionale, limite, collaborazione, handover, escalation e tracciabilità. Questa griglia non sostituisce protocolli clinici o ispettivi; serve a costruire una risposta prudente e verificabile.

Caso etico comparato, allenamento e controlli

CASO COMPARATIVO NON ESECUTIVO

Durante una giornata di attività in un servizio sociosanitario pubblico, una persona assistita e il familiare chiedono risposte rapide a figure diverse: all'OSS viene chiesto di “decidere da solo” come gestire un bisogno pratico; all’infermiere viene chiesto di non registrare una criticità organizzativa “per evitare problemi”; al fisioterapista viene chiesto di modificare un programma senza confronto con il percorso previsto; all’ostetrica viene chiesto un parere rassicurante su una situazione materno-neonatale non chiarita; al TPALL viene chiesto di considerare irrilevante una difformità osservata durante un controllo interno. La traccia non chiede di eseguire atti, tecniche o trattamenti. Chiede di riconoscere fonte, campo professionale, responsabilità, limite e verifica.

GRIGLIA PROFILO-REGOLA-AZIONE-LIMITE-VERIFICA

Profilo	Riferimento da ricordare	Regola	Azione da concorso
Infermiere	D.M. 739/1994; Codice FNOPI 2025	Il processo infermieristico richiede pianificazione, continuità, documentazione e collaborazione.	Riconoscere la criticità, comunicarla secondo il setting e non occultarla.
Ostetrica	D.M. 740/1994; Codice FNOPO	L'autonomia riguarda il percorso materno-neonatale di competenza, con riconoscimento del rischio.	Dare una risposta prudente: informare, orientare e attivare il percorso previsto.

Profilo	Riferimento da ricordare	Regola	Azione da concorso
Fisioterapista	D.M. 741/1994; legge 42/1999	Valutazione funzionale, programma riabilitativo e verifica appartengono al campo professionale.	Distinguere adattamento motivato, confronto con l'équipe e tracciabilità.
TPALL	D.M. 58/1997; Codice TPALL 2025	Vigilanza, imparzialità, verbalizzazione e rapporti con autorità/enti richiedono terzietà.	Inquadrare il fatto, mantenere indipendenza e non minimizzare pressioni improprie.
OSS	DPCM 25 marzo 2025; atti regionali applicabili	L'OSS è operatore di interesse sanitario, distinto dalle professioni ordinistiche.	Collaborare, segnalare e restare nell'attività attribuita dal contesto.

Profilo	Limite	Verifica
Infermiere	Non trasformare la risposta in procedura clinica o giudizio medico-legale.	Coerenza con profilo, codice, sicurezza delle cure e regole del servizio.
Ostetrica	Non rassicurare oltre i dati disponibili e non sostituire altre competenze.	Presenza del riferimento, consenso/comunicazione e indicazione del confine.
Fisioterapista	Nessuna sequenza tecnica o modifica non verificata del percorso.	Coerenza tra profilo, progetto, collaborazione e documentazione.
TPALL	Non inventare sanzioni, soglie, modelli di verbale o esiti.	Fonte dell'attribuzione, correttezza del ruolo, tracciabilità.
OSS	Le esperienze regionali non diventano regola nazionale unica.	Profilo nazionale, attuazione regionale, setting e supervisione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

“Spiegami perché autonomia professionale, responsabilità e collaborazione non sono concetti in contrasto nelle professioni sanitarie, e distingui il caso dell'OSS.”

Risposta modello.

L'autonomia non significa isolamento. Per le professioni sanitarie ordinistiche il campo proprio di attività e responsabilità si legge coordinando profilo professionale, ordinamento didattico e codice deontologico, nel rispetto delle altre competenze. L'infermiere, l'ostetrica, il fisioterapista e il TPALL hanno campi diversi, ma tutti devono agire con competenza, documentare o comunicare secondo il setting, collaborare con l'équipe e riconoscere il limite. La sicurezza delle cure rafforza questa lettura, perché coinvolge attività assistenziali e organizzative, senza confondere responsabilità della struttura, dell'équipe e del singolo professionista. L'OSS va distinto: non è professione sanitaria ordinistica; opera come operatore di interesse sanitario, in collaborazione e secondo profilo nazionale, attuazione regionale e organizzazione del servizio.

Un elenco di norme, da solo, non risponde al caso. Occorre individuare la figura, collegare fonte e campo professionale e spiegare il comportamento corretto in termini concorsuali: non nascondere una criticità, non sostituire altri profili, non promettere esiti e non trasformare un caso etico in una procedura tecnica. In ogni passaggio, la decisione deve restare tracciabile dentro il ruolo.

DOMANDA-TRAPPOLA

“Se una figura è autonoma, può decidere senza équipe e senza procedura?”

No. La risposta corretta è negativa. L'autonomia indica responsabilità professionale nel proprio campo, non libertà assoluta. Se il caso supera il profilo, richiede altra competenza, coinvolge consenso, rischio, vigilanza o attribuzioni del setting, la risposta corretta è verificare fonte e limite, comunicare, collaborare e attivare il percorso previsto.

La trappola consiste nel confondere “autonomo” con “non verificabile”. In sede orale conviene rispondere con una formula breve: autonomia nel profilo, collaborazione nel percorso, limite quando la fonte non basta. Questa formula evita sia l'esecutività cieca sia l'invenzione di poteri non documentati.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è usare una parola unica per tutti: “sanitario”, “assistenza”, “supporto”, “tecnica”, “controllo”. Così si perde il punto d'esame. L'infermiere non è solo esecutore, l'ostetrica non è un'infermiera del percorso nascita, il fisioterapista non è un tecnico della mobilitazione, il TPALL non è un consulente generico, l'OSS non è una professione ordinistica. Ogni risposta deve partire dalla fonte e chiudersi con il limite.

QUIZ

1. Quale coppia è corretta?

- A. OSS — albo professionale ordinistico.
- B. TPALL — prevenzione, vigilanza e controllo nei limiti delle attribuzioni.
- C. Fisioterapista — competenza generale su ogni bisogno assistenziale.
- D. Ostetrica — profilo privo di autonomia.

Soluzione ragionata: B. Il TPALL è collegato a prevenzione, verifica, controllo, vigilanza e, nei servizi competenti, funzioni ispettive entro attribuzioni definite. A è errata perché l'OSS non è professione ordinistica; C amplia impropriamente il fisioterapista; D cancella il campo autonomo ostetrico. La motivazione deve restare sul profilo, non su esempi inventati.

2. La deontologia:

- A. amplia automaticamente le competenze.
- B. sostituisce il profilo ministeriale.
- C. orienta condotta, responsabilità, relazione e limite.
- D. vale solo all'orale.

Soluzione ragionata: C. I codici integrano la lettura del campo professionale perché aiutano a qualificare relazione, responsabilità, documentazione, riservatezza, collaborazione e conflitti. Non autorizzano attività estranee al profilo e non sostituiscono norme, linee guida o procedure del servizio.

3. Nei bandi OSS, i programmi pratici:

- A. bastano a insegnare procedure complete.
- B. indicano output di prova e materie osservate.
- C. valgono come standard nazionale per tutte le Regioni.
- D. sostituiscono il DPCM 2025.

Soluzione ragionata: B. I bandi indicano come la prova può osservare ruolo, assistenza di base, relazione, sicurezza e attività simulate. Non sono fonti tecniche autosufficienti e non trasformano una prassi locale in disciplina nazionale. Il riferimento corrente per il profilo resta il DPCM 25 marzo 2025, coordinato con gli atti regionali applicabili e con il setting.

MINI-ESERCIZIO COMPARATIVO

Completa la frase con il profilo corretto e motiva: “Nel caso compare una richiesta di controllo imparziale, tracciabilità dell’attività e resistenza a una pressione a minimizzare la difformità.”

Soluzione ragionata.

Il profilo più coerente è il TPALL, perché la traccia richiama vigilanza, controllo, imparzialità e rapporti con autorità o enti. La risposta non deve indicare sanzioni o modelli di atto: deve spiegare che il candidato riconosce la fonte dell'attribuzione, mantiene terzietà, documenta secondo il contesto e segnala il limite della propria risposta. Se la stessa traccia riguardasse assistenza di base attribuita nel setting, il profilo sarebbe OSS; se riguardasse pianificazione assistenziale, infermiere; se riguardasse percorso materno-neonatale, ostetrica; se riguardasse valutazione funzionale e progetto riabilitativo, fisioterapista.

La motivazione va costruita per esclusione controllata. Non basta dire “c'è un controllo”: anche altri profili controllano l'esito del proprio lavoro. Qui contano difformità, pressione a minimizzare, imparzialità e tracciabilità verso l'ente o l'autorità competente. Sono segnali compatibili con il TPALL e non con una generica relazione di aiuto. Se il bando usa formule ampie, il candidato deve ancorare la risposta al contesto indicato: dipartimento di prevenzione, azienda sanitaria, ente ambientale o servizio con attribuzioni di vigilanza. La frase finale deve chiudere il perimetro: ruolo riconosciuto, fonte citata, nessuna procedura inventata, verifica professionale quando il dettaglio operativo non è nel bando.

CHECKLIST FINALE

- Ho citato la fonte del profilo prima dell'azione e ho evitato di partire dall'intuizione sul caso?
- Ho distinto professioni sanitarie ordinistiche, fondate su profilo, ordinamento, titolo e albo, dall'OSS come operatore di interesse sanitario?
- Ho evitato procedure, dosaggi, manovre, sequenze operative, soglie, sanzioni e modelli di atto che non posso giustificare con la disciplina applicabile?
- Ho separato responsabilità della struttura, dell'équipe e del singolo, senza attribuire a tutti lo stesso potere decisionale?
- Ho indicato collaborazione, comunicazione, documentazione o segnalazione solo come criteri generali compatibili con ruolo e setting?
- Ho evitato di trasformare Lombardia, Emilia-Romagna o Veneto in standard nazionale unico per l'OSS?
- Ho usato i bandi come indicatori di materie e output di prova, non come fonti tecniche autosufficienti?
- Ho controllato che “autonomia” non diventi arbitrio e che “collaborazione” non diventi deresponsabilizzazione?
- Ho distinto caso etico, prova teorico-pratica e attività reale, senza suggerire esecuzioni fuori contesto?
- Ho collegato sicurezza, consenso, riservatezza o deontologia solo nei termini sostenuti dalle fonti e senza conclusioni medico-legali?
- Ho previsto verifica su bando, setting, procedura aziendale e controllo professionale quando il dettaglio è mobile?

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- Legge 26 febbraio 1999, n. 42; legge 10 agosto 2000, n. 251; legge 1 febbraio 2006, n. 43; legge 11 gennaio 2018, n. 3, per campo professionale, autonomia, formazione e ordinamento.
- D.M. 14 settembre 1994, nn. 739, 740 e 741, per i profili di infermiere, ostetrica/o e fisioterapista.
- D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, per il profilo del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale sanitaria.
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219, su consenso informato, relazione di cura e disposizioni anticipate di trattamento.
- DPCM 25 marzo 2025, per il profilo nazionale dell'operatore sociosanitario, da coordinare con gli atti regionali e con l'organizzazione del servizio.
- Codici deontologici delle professioni considerate: FNOPI per le professioni infermieristiche, FNOPO per l'ostetrica/o, riferimenti FNOFI/AIFI per il fisioterapista e FNO TSRM e PSTRP per il TPALL, nelle versioni vigenti applicabili.

I riferimenti definiscono il perimetro generale, ma non sostituiscono il bando, le procedure aziendali, le linee guida vigenti o gli atti del servizio. In sede di prova, il candidato deve citare la fonte utile, spiegare la regola e fermarsi prima di attribuire poteri, responsabilità o procedure non ricavabili dal caso.

Assistenza infermieristica, tecniche assistenziali e supporto OSS

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Obiettivo del capitolo

Nelle prove per infermiere o OSS, il nome della tecnica è soltanto il punto di partenza. La commissione verifica se il candidato sa leggere i bisogni della persona, riconoscere i rischi, ordinare le priorità e distinguere le responsabilità. Conta anche la capacità di motivare che cosa osservare, comunicare, documentare e rivalutare.

Al termine del capitolo saprai:

- descrivere il processo assistenziale dalla raccolta dei dati alla valutazione degli esiti;
- trasformare un bisogno in un obiettivo osservabile e in un piano coerente;
- collegare sicurezza, prevenzione delle infezioni, terapia, cadute e integrità cutanea;
- inquadrare igiene, alimentazione, eliminazione, mobilità e relazione senza ridurle a gesti meccanici;
- distinguere la decisione professionale dell'infermiere dalle attività di supporto dell'OSS;
- risolvere un caso teorico-pratico indicando dati, rischi, priorità, azioni, limiti ed escalation.

Questo capitolo prepara il ragionamento richiesto nelle prove. Non sostituisce addestramento, valutazione della persona, prescrizioni, procedure aziendali, istruzioni del fabbricante o supervisione professionale. Quando mancano dati o il rischio supera il proprio ruolo, la risposta corretta non è improvvisare: è mettere in sicurezza, fermarsi, comunicare e verificare.

Mappa BANDO

Il filo logico è: persona → dati → bisogni → priorità → obiettivi → interventi → osservazione → valutazione.

Passaggio	Domanda da porsi	Risultato atteso
B — Bando	Il profilo è infermiere o OSS? Il setting è ospedaliero, territoriale, residenziale o sociale?	Delimitare ruolo, materie e tipo di prova
A — Aree	Il quesito riguarda pianificazione, sicurezza, bisogni di base, relazione o collaborazione?	Classificare il problema prima di rispondere

Passaggio	Domanda da porsi	Risultato atteso
N — Nuclei	Quali dati, rischi, priorità e limiti devo esplicitare?	Costruire la parte teorica
D — Diario	Ho saltato identità, privacy, rischio, osservazione, comunicazione o rivalutazione?	Correggere l'errore ricorrente
O — Output	Serve una definizione, un piano, una procedura ragionata o una risposta orale?	Adattare forma e profondità alla prova

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'assistenza parte dalla persona, non dalla tecnica. Il piano collega dati, bisogni, obiettivi, interventi e indicatori. La sicurezza attraversa ogni fase. L'infermiere governa il processo assistenziale di competenza; l'OSS collabora nelle attività attribuite e risponde della loro corretta esecuzione. Osservare, comunicare, documentare e rivalutare non sono passaggi accessori.

Dal bisogno al piano assistenziale

LA PERSONA PRIMA DELLA PRESTAZIONE

Assistere significa sostenere la persona rispetto a bisogni che possono essere fisici, psicologici, relazionali e sociali. Lo stesso bisogno assume forme diverse secondo età, condizioni cliniche, capacità residue, ambiente, cultura, preferenze, rete familiare e obiettivi di cura. Per questo non esiste una sequenza valida in modo identico per tutti.

Due scorciatoie portano fuori strada: vedere la persona come una somma di compiti (igiene, pasto, terapia, mobilitazione) e considerare ogni richiesta automaticamente appropriata. Una buona risposta parte da quattro domande:

1. che cosa sappiamo della persona e che cosa manca;
2. quale bisogno o problema emerge;
3. quale rischio richiede priorità;
4. quale professionista deve decidere, collaborare o essere informato.

La tutela della dignità è concreta. Significa presentarsi, verificare l'identità secondo le regole del servizio, spiegare ciò che si intende fare, ricercare partecipazione e consenso, proteggere la riservatezza, rispettare tempi e preferenze compatibili con la sicurezza. Significa anche valorizzare l'autonomia residua: aiutare non vuol dire sostituirsi automaticamente alla persona.

ACCERTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

L'accertamento è la raccolta organizzata delle informazioni necessarie a comprendere bisogni, problemi, risorse e rischi. I dati possono provenire dall'osservazione, dal colloquio, dalla documentazione, dalle consegne, dalla misurazione prevista, dalla persona assistita, dai caregiver e dagli altri componenti dell'équipe.

Per ragionare in prova conviene distinguere:

- dati soggettivi, riferiti dalla persona, come dolore, nausea, paura o difficoltà percepita;
- dati oggettivi, osservati o misurati, come alterazioni della cute, ridotta mobilità o quantità registrate;
- dati storici, relativi a condizioni, abitudini, allergie, precedenti eventi e livello abituale di autonomia;
- dati contestuali, relativi ad ambiente, ausili, caregiver, barriere e organizzazione;
- dati mancanti, senza i quali una decisione sarebbe prematura o rischiosa.

I dati servono a riconoscere un problema, stimare un rischio, definire una priorità, scegliere un intervento e verificarne l'esito. Accumularli senza stabilire questo collegamento rende la risposta dispersiva. In un caso concorsuale è utile scrivere una breve tabella con tre colonne: dato disponibile, significato possibile, dato ancora necessario.

L'osservazione dell'OSS è preziosa perché molte attività di supporto avvengono vicino alla persona e consentono di rilevare cambiamenti. L'interpretazione professionale e la pianificazione infermieristica, tuttavia, non si trasferiscono automaticamente con l'esecuzione dell'attività. L'OSS osserva, riferisce e registra secondo procedure e attribuzioni; l'infermiere integra i dati nel processo assistenziale e decide quanto compete al proprio profilo.

BISOGNI, PROBLEMI E PRIORITÀ

Un bisogno descrive ciò che serve alla persona per mantenere o recuperare benessere, sicurezza e autonomia. Un problema assistenziale esprime una condizione sulla quale l'assistenza può intervenire o che deve monitorare. Un rischio indica un evento non ancora verificato ma plausibile, da prevenire o intercettare precocemente.

La priorità non dipende dall'ordine in cui i problemi sono elencati. Dipende da gravità potenziale, urgenza, possibilità di prevenire danni, sofferenza, dipendenza, preferenze della persona e relazione con altri problemi. In termini concorsuali, il candidato deve motivarla. Scrivere «la priorità è la mobilitazione» è debole; scrivere «la priorità è prevenire una caduta perché la persona presenta nuova instabilità e tenta di alzarsi senza assistenza» collega dato, rischio e decisione.

Quando lo scenario presenta segni di deterioramento o una possibile emergenza, la normale pianificazione diventa insufficiente. Occorre attivare tempestivamente la comunicazione e il percorso previsto dal setting. Gli algoritmi di emergenza saranno trattati altrove; qui conta riconoscere che un cambiamento inatteso richiede escalation e non può essere normalizzato o gestito oltre competenza.

DIAGNOSI INFERMIERISTICA E DIAGNOSI MEDICA

La diagnosi medica identifica una malattia o condizione clinica. La diagnosi infermieristica interpreta la risposta della persona a problemi di salute o processi di vita, oppure il rischio che quella risposta si sviluppi; fonda la scelta degli interventi assistenziali e degli esiti dei quali l'infermiere risponde. Una non è la versione semplificata dell'altra.

In una persona con ictus, «ictus ischemico» identifica la condizione medica; la difficoltà a trasferirsi in sicurezza e il bisogno di aiuto nell'igiene sono problemi assistenziali da accertare e descrivere. Due persone con la stessa malattia possono avere autonomia, risorse e rischi molto diversi. La formulazione infermieristica deve collegare dati, problema o rischio, fattori pertinenti ed esito atteso. Un rischio è sostenuto dai fattori che lo rendono plausibile, non da segni inventati di un evento già avvenuto. Gli esempi usano un lessico didattico e non riproducono una classificazione diagnostica ufficiale.

Esempio: una persona è orientata, comprende le indicazioni e riesce a lavare viso e parte superiore del corpo, ma non raggiunge gli arti inferiori. Il piano conserva le attività autonome e organizza aiuto per quelle mancanti; l'obiettivo osservabile è completare l'igiene in sicurezza mantenendo la partecipazione. Limitarsi a scrivere «dipendente: fare l'igiene» perde informazioni utili e può ridurre inutilmente l'autonomia.

SCALE: MISURARE DOLORE, FUNZIONE E RISCHIO

Una scala rende ripetibile una rilevazione, se usata nella popolazione e nella versione per cui è appropriata. Prima di interpretarla bisogna sapere che cosa misura, come si raccoglie il dato e che cosa significa il punteggio.

Oggetto	Esempi e funzione	Limite da riconoscere
Dolore	Scale numeriche o verbali per l'intensità riferita; strumenti osservativi quando la comunicazione non è possibile	Un comportamento non coincide automaticamente con assenza o presenza di dolore
Autonomia	Scale delle attività quotidiane e indici funzionali, come Barthel	La somma non descrive da sola tutte le capacità, l'ambiente o l'aiuto necessario

Oggetto	Esempi e funzione	Limite da riconoscere
Rischio	Strumenti per caduta o lesione da pressione, come scale specifiche adottate nel setting	Stimano un rischio, non predicono con certezza un evento né sostituiscono l'osservazione

Si confrontano rilevazioni ottenute con lo stesso strumento e condizioni documentate. Un miglioramento del totale può nascondere un peggioramento in una singola attività importante. Per esempio, una persona che riferisce meno dolore ma compare confusa richiede valutazione del nuovo problema: il numero favorevole non chiude il caso. Nelle prove non si inventano soglie o equivalenze tra scale diverse.

OBIETTIVI, INTERVENTI E INDICATORI

Un obiettivo assistenziale descrive un risultato atteso riferito alla persona. Deve essere pertinente al problema, realistico, osservabile e collocato nel tempo previsto dal piano. Formule generiche come «migliorare il paziente» non permettono una verifica. È più utile indicare, per esempio, il mantenimento dell'integrità cutanea, l'assunzione del pasto con il livello di assistenza pianificato, l'assenza di cadute o la partecipazione della persona a una quota definita dell'attività.

L'intervento è ciò che viene pianificato per raggiungere l'obiettivo. Deve precisare almeno finalità, responsabile, condizioni, frequenza o momento, osservazioni richieste e modalità di comunicazione. Nei casi teorici non serve inventare dettagli clinici: serve mostrare coerenza.

La catena minima è:

Elemento	Domanda guida	Esempio non esecutivo
Dato	Che cosa osservo o apprendo?	Ridotta mobilità e cute arrossata in area sottoposta a pressione
Problema/rischio	Che cosa può accadere o peggiorare?	Rischio di lesione da pressione
Obiettivo	Quale esito voglio ottenere?	Mantenere l'integrità cutanea e ridurre l'esposizione ai fattori di rischio
Intervento	Che cosa viene pianificato?	Valutazione del rischio, piano di mobilità, cura della cute, supporto nutrizionale se indicato e uso appropriato delle superfici

Elemento	Domanda guida	Esempio non esecutivo
Indicatore	Come verifico l'esito?	Condizioni cutanee, aderenza al piano, tolleranza e nuovi segni riferiti

Gli interventi non sono una lista separata dalla persona. Devono essere compatibili con condizioni cliniche, preferenze, prescrizioni, risorse e setting. La pianificazione deve anche chiarire quali attività restano dell'infermiere, quali possono essere attribuite all'OSS e quali richiedono altri professionisti.

ATTUAZIONE, DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE

Attuare il piano significa eseguire o coordinare quanto previsto, mantenendo osservazione e capacità di adattamento. Se le condizioni cambiano, non si completa meccanicamente il compito: si rivaluta e si comunica. La corretta esecuzione comprende preparazione, sicurezza, rispetto della persona, uso appropriato dei materiali, osservazione durante l'attività, riordino e tracciabilità secondo le regole del servizio.

La documentazione assicura continuità, rende visibili dati e decisioni e consente la valutazione. Deve essere pertinente, tempestiva, comprensibile e coerente con responsabilità e strumenti adottati. Non va confusa con un racconto difensivo né con una copia automatica delle consegne. Nei quesiti, la formula «documentare» acquista valore solo se il candidato precisa che cosa: dato rilevante, attività svolta, risposta della persona, evento inatteso, comunicazione ed eventuale rivalutazione.

Valutare significa confrontare l'esito osservato con l'obiettivo. Le possibilità sono tre: obiettivo raggiunto, parzialmente raggiunto o non raggiunto. Da qui derivano conferma, modifica o interruzione del piano. La valutazione chiude un ciclo e ne apre un altro: nuovi dati generano nuove priorità.

ERRORE TIPICO

Presentare il piano come una lista di compiti. Un piano completo collega sempre dato → problema/rischio → obiettivo → intervento → indicatore → rivalutazione.

Sicurezza, infezioni e processo della terapia

LA SICUREZZA È UNA PROPRIETÀ DEL SISTEMA

La sicurezza delle cure comprende molto più dell'errore individuale: dipende da organizzazione, competenze, comunicazione, tecnologie, ambiente, procedure, segnalazione e apprendimento dagli eventi. La legge 24/2017 la colloca tra le componenti del diritto alla salute e richiama la prevenzione e gestione del rischio.

Nella risposta concorsuale la sicurezza deve risultare con chiarezza. Prima di un'attività occorre considerare almeno:

- identità della persona e corrispondenza con la prestazione;
- informazioni, consenso e partecipazione;
- condizioni attuali e cambiamenti rispetto alla situazione nota;
- prescrizioni, piano, attribuzione e procedura applicabile;
- igiene delle mani e precauzioni necessarie;
- ambiente, materiali, dispositivi e loro integrità;
- privacy, comfort e autonomia residua;
- criteri di interruzione, comunicazione ed escalation;
- documentazione e verifica finale.

Questi controlli formano una griglia, non una procedura universale. Servono a non concentrare tutta l'attenzione sul gesto. Nei quiz, molti distrattori descrivono un'azione tecnicamente plausibile ma priva di identificazione, valutazione o comunicazione.

INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

Le infezioni correlate all'assistenza, spesso indicate con la sigla ICA, possono insorgere in relazione a percorsi sanitari e sociosanitari e riguardano diversi setting. La prevenzione combina comportamenti individuali e misure organizzative: igiene delle mani, precauzioni appropriate, pulizia e gestione dell'ambiente, uso corretto dei dispositivi, sorveglianza, formazione, comunicazione e aderenza alle procedure.

La sorveglianza opera su un piano diverso dall'assistenza alla singola persona. Raccoglie, analizza, interpreta e restituisce dati in modo sistematico per riconoscere fenomeni, orientare interventi e monitorare risultati. All'esame occorre distinguere il livello assistenziale da quello epidemiologico:

- l'operatore applica le misure previste, osserva e segnala;
- il servizio organizza prevenzione, procedure, formazione e monitoraggio;
- i sistemi di sorveglianza aggregano dati e producono informazioni per il governo del rischio.

L'igiene delle mani è un principio trasversale, ma il candidato non deve trasformarla in una formula rituale. Va collegata al momento dell'assistenza, alle precauzioni, alla contaminazione possibile, ai dispositivi e alle indicazioni del contesto. I guanti non sostituiscono l'igiene delle mani e il loro uso non autorizza a passare senza controllo da un'attività all'altra.

Un segno sospetto di infezione o un cambiamento delle condizioni non deve essere diagnosticato dall'OSS. Deve essere osservato, comunicato con precisione e documentato secondo le regole del servizio. La qualità della segnalazione dipende da dati concreti: quando è comparso il cambiamento, che cosa è stato osservato, quali attività erano in corso e quale risposta ha avuto la persona.

IGIENE DELLE MANI E PRECAUZIONI

I cinque momenti OMS collegano l'igiene delle mani al rischio di trasmissione:

1. prima di toccare la persona assistita;
2. prima di una procedura pulita o asettica;
3. dopo il rischio di esposizione a liquidi biologici;
4. dopo aver toccato la persona;
5. dopo aver toccato ciò che la circonda nell'area assistenziale.

I guanti non sostituiscono l'igiene delle mani. Passare da un'attività contaminata a una pulita o da una persona a un'altra richiede di riconoscere una nuova indicazione, anche se si è rimasti nella stessa stanza. La scelta fra frizione alcolica e lavaggio con acqua e sapone segue condizioni delle mani, agente e procedura: non basta indossare guanti nuovi su mani contaminate.

Le precauzioni standard valgono per tutte le persone assistite, indipendentemente da diagnosi nota: igiene delle mani, uso dei dispositivi di protezione in base all'esposizione prevista, igiene respiratoria, sicurezza di aghi e taglienti, gestione di attrezzature, superfici e materiali. Le precauzioni basate sulla trasmissione si aggiungono quando quelle standard non bastano: contatto, droplet o via aerea richiedono misure coerenti con agente sospetto o accertato, esposizione e ambiente. Una mascherina chirurgica non è equivalente a un respiratore; la scelta della protezione non si deduce dalla sola parola «isolamento».

PREVENIRE LE INFEZIONI DA CATETERE URINARIO

Il primo presidio è evitare il dispositivo quando manca un'indicazione appropriata e rivalutarne la necessità per rimuoverlo appena possibile. Se indicato, l'inserzione richiede personale competente e tecnica asettica. Nel mantenimento contano circuito di drenaggio chiuso, deflusso libero e prevenzione della contaminazione; la sacca rimane sotto il livello della vescica e non a contatto con il pavimento. Igiene delle mani, manipolazioni necessarie e osservazione dei problemi fanno parte dello stesso percorso.

Questi principi spiegano il rischio; non costituiscono istruzioni per eseguire un cateterismo. L'OSS collabora alle attività attribuite e segnala anomalie, mentre valutazione dell'indicazione e decisioni professionali restano nei ruoli competenti. Non si disconnette il circuito per comodità né si stabiliscono sostituzioni a intervalli arbitrari.

Caso breve: durante il riordino si trova una sacca appoggiata a terra. Qual è il difetto da riconoscere? Soluzione: una condizione che favorisce contaminazione e richiede correzione secondo procedura e competenza, verifica del sistema e comunicazione dell'anomalia. Non è necessario attendere febbre o un esame positivo per intervenire sul rischio; non si conclude però che esista già un'infezione.

SICUREZZA DEL PROCESSO DELLA TERAPIA

La terapia farmacologica è un processo composto da più passaggi: prescrizione, approvvigionamento, conservazione, preparazione, somministrazione, monitoraggio, documentazione e comunicazione. Un errore può nascere in ciascuna fase o nel passaggio tra una fase e l'altra. Le raccomandazioni del Ministero della Salute richiamano, tra gli altri temi, prevenzione degli errori, gestione delle soluzioni concentrate di potassio, ricognizione e riconciliazione, abbreviazioni e simboli, manipolazione delle forme orali solide.

Per il candidato sono centrali alcuni principi:

1. la prescrizione deve essere disponibile e interpretabile secondo le regole adottate;
2. identità della persona, farmaco, dose, via, tempo e documentazione devono essere verificati nel processo previsto;
3. allergie, condizioni, interazioni informative e cambiamenti rilevanti devono essere considerati e comunicati;
4. abbreviazioni ambigue, trascrizioni improprie e comunicazioni incomplete aumentano il rischio;
5. la risposta della persona e gli eventi inattesi richiedono osservazione, comunicazione e gestione secondo procedura;
6. nessun operatore deve agire oltre competenza o sulla base di un ordine non chiarito.

Questi principi non autorizzano dosaggi, preparazioni o somministrazioni. Nella prova OSS, l'errore più grave è attribuire al supporto una decisione terapeutica. Il profilo nazionale del 2025 e le attuazioni regionali devono essere letti insieme al piano, alle attribuzioni e alle procedure del servizio. L'OSS può svolgere attività previste nel proprio perimetro e collaborare, ma non trasforma una consegna informale in autonomia prescrittiva o clinica.

La ricognizione raccoglie in modo accurato le informazioni sui medicinali assunti dalla persona; la riconciliazione confronta tali informazioni con le prescrizioni nel passaggio di cura, per individuare e risolvere discrepanze secondo responsabilità professionali e organizzative. In concorso le due parole non sono sinonimi e non vanno ridotte a un semplice elenco.

DOMANDA-TRAPPOLA

«Se la persona riferisce di assumere abitualmente un farmaco che non compare nella documentazione disponibile, l'operatore può somministrarlo per garantire continuità?»

No. La discrepanza deve essere rilevata e comunicata; occorre verificare prescrizione e processo di riconciliazione secondo responsabilità e procedura. L'abitudine riferita non sostituisce la decisione professionale.

CADUTE, AMBIENTE E INTEGRITÀ CUTANEA

La prevenzione delle cadute richiede una lettura multifattoriale. Condizioni della persona, terapie, precedenti cadute, mobilità, orientamento, calzature, illuminazione, ostacoli, ausili e bisogno di assistenza possono combinarsi. La risposta non è limitare indiscriminatamente il movimento: è valutare il rischio, predisporre misure proporzionate, informare, sorvegliare secondo piano e rivalutare dopo cambiamenti o eventi.

Anche la prevenzione delle lesioni da pressione è multidimensionale. La linea guida pubblicata nel Sistema Nazionale Linee Guida nel 2025 considera valutazione del rischio, riposizionamento e mobilizzazione, superfici di supporto, gestione dell'umidità e dell'incontinenza, nutrizione, classificazione, trattamento e coinvolgimento del caregiver. Nessuno di questi elementi è sufficiente isolatamente.

Tre livelli non vanno confusi:

- la linea guida nazionale offre raccomandazioni basate sulle conoscenze disponibili;
- il protocollo regionale o aziendale adatta responsabilità, strumenti e percorsi;
- il piano individuale considera rischio, condizioni, tolleranza, preferenze e setting.

Un arrossamento persistente, un dolore localizzato, un'alterazione della cute o una ridotta tolleranza alla posizione sono dati da osservare e comunicare. Non autorizzano l'OSS a classificare autonomamente una lesione o scegliere un trattamento. Anche per l'infermiere, valutazione e intervento devono rispettare competenza, linea guida, prescrizioni e procedura.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Terapia, ICA, cadute e lesioni da pressione non sono capitoli separati dalla pianificazione: sono rischi da integrare nel piano. La sicurezza richiede controlli prima, durante e dopo l'attività. Un dato inatteso va descritto, non interpretato oltre competenza. La procedura locale organizza l'azione, ma non sostituisce il giudizio professionale. La documentazione rende possibile continuità e rivalutazione.

Assistenza di base alla persona

IGIENE, COMFORT, DIGNITÀ E OSSERVAZIONE

L'igiene personale tutela pulizia, comfort, dignità, integrità cutanea e benessere. È anche un momento privilegiato di relazione e osservazione. Ridurla a una successione di gesti significa perdere informazioni sulla cute, sul dolore, sulla mobilità, sull'umore, sulla tolleranza allo sforzo e sul livello di autonomia.

Prima di pianificare l'assistenza igienica occorre considerare condizioni generali, capacità di collaborare, prescrizioni e limitazioni, preferenze, privacy, rischio di caduta, presenza di dispositivi e necessità di aiuto. La scelta tra cura autonoma, assistenza parziale e assistenza completa deriva da questa valutazione. Non dipende soltanto dall'etichetta diagnostica o dall'età.

Una risposta teorico-pratica ben costruita espone le fasi logiche, non inventa una tecnica universale:

1. verificare identità, piano, condizioni, consenso e grado di collaborazione;
2. predisporre ambiente, privacy, materiali e sicurezza;
3. sostenere la partecipazione della persona e osservare tolleranza e cute;
4. interrompere e comunicare in presenza di dolore, malessere, instabilità o altri dati inattesi;
5. assicurare comfort, riordino, documentazione e segnalazione finale.

I materiali formativi universitari sul bagno a letto e i programmi regionali OSS descrivono stazioni didattiche utili, ma dettagli come temperatura dell'acqua, direzione dei movimenti, massaggio, numero degli operatori e gestione dei dispositivi dipendono da persona, procedura e conoscenze aggiornate. All'esame è più sicuro motivare i principi e dichiarare l'adattamento necessario che recitare una sequenza rigida.

La cura del cavo orale, dell'area perineale, delle pieghe cutanee e degli indumenti richiede attenzione a comfort, contaminazione, integrità, presenza di dispositivi e preferenze. Ogni alterazione rilevante va descritta e comunicata. L'OSS non formula diagnosi; l'infermiere integra il dato nella valutazione e attiva quanto necessario nel proprio campo e nell'équipe.

ERRORE TIPICO

Dire «eseguo l'igiene e riferisco eventuali anomalie» senza precisare valutazione, privacy, autonomia residua, sicurezza, osservazioni e criteri di interruzione. La commissione valuta il ragionamento, non soltanto il nome della prestazione.

ALIMENTAZIONE, IDRATAZIONE E RISCHIO DI DISFAGIA

L'assistenza al pasto sostiene nutrizione, idratazione, piacere, relazione e autonomia. Comprende preparazione dell'ambiente, postura prevista, aiuto proporzionato, rispetto dei tempi, osservazione dell'assunzione e registrazione secondo piano. La fonte piemontese sulla ristorazione ospedaliera e assistenziale attribuisce all'OSS una funzione di assistenza minima al pasto e richiama postura, masticazione, deglutizione, osservazione e tutela dell'autonomia residua.

La disfagia è una difficoltà della deglutizione e può aumentare il rischio che alimenti o liquidi entrino nelle vie respiratorie. Il candidato non deve diagnosticare né improvvisare consistenze, posture o manovre. Deve riconoscere i dati che richiedono attenzione: tosse durante o dopo il pasto, voce modificata, difficoltà evidente, ristagno, affaticamento, rifiuto inatteso o altri segni previsti dalla formazione e dal piano.

Davanti a un segno sospetto, l'azione corretta è interrompere ciò che può aumentare il rischio, mantenere la persona in sicurezza, comunicare tempestivamente e seguire il percorso del servizio. La scelta della dieta, della consistenza e delle strategie specifiche appartiene alla valutazione multiprofessionale e alle indicazioni applicabili.

Nel caso concorsuale conviene distinguere:

- prima del pasto: identificazione, dieta/indicazioni disponibili, condizioni, postura e ambiente;
- durante: grado di assistenza, ritmo, tolleranza, autonomia, quantità e segni di difficoltà;
- dopo: comfort, quantità assunte, eventi, comunicazione e registrazione.

Registrare «ha mangiato poco» è meno utile di un dato coerente con gli strumenti del servizio e accompagnato dall'osservazione pertinente. Non vanno però inventate quantità se non misurate. Accuratezza significa riportare ciò che è stato realmente osservato.

ELIMINAZIONE E GESTIONE QUOTIDIANA DEI PRESIDI

L'eliminazione urinaria e intestinale è legata a comfort, dignità, idratazione, mobilità, alimentazione, farmaci, condizioni cliniche e abitudini. L'assistenza comprende accesso sicuro ai servizi o ai presidi, privacy, igiene, osservazione e registrazione secondo piano. Cambiamenti di frequenza, quantità, aspetto, dolore o continenza richiedono comunicazione quando pertinenti.

Nel tema del catetere vescicale è essenziale distinguere l'inserimento dalla gestione quotidiana. L'inserimento è un'attività riservata al personale qualificato secondo competenze, prescrizioni e procedure applicabili. L'OSS può collaborare nelle attività previste dal proprio profilo e dal setting, senza assumere decisioni cliniche autonome.

La prevenzione delle infezioni delle vie urinarie associate al catetere richiede indicazione appropriata, gestione del sistema, igiene, osservazione, riduzione delle manipolazioni non necessarie e rimozione secondo decisione competente. Dettagli su posizionamento del sacchetto, svuotamento o campionamento vanno esposti soltanto se sostenuti dalla procedura richiesta dalla prova. Restano sempre validi i principi: mantenere il sistema secondo indicazioni, evitare contaminazioni e trazioni, osservare persona e dispositivo, riferire alterazioni e documentare.

Se la domanda chiede «come gestire il catetere», una risposta forte precisa prima il livello richiesto: gestione assistenziale quotidiana, monitoraggio, raccolta di un campione o inserimento sono attività differenti. Confonderle significa oltrepassare il perimetro del quesito e, talvolta, quello del profilo.

RELAZIONE, AUTONOMIA RESIDUA E CAREGIVER

La relazione incide direttamente su sicurezza ed esiti. Informare, ascoltare, ottenere collaborazione, proteggere la dignità e comprendere ciò che la persona riesce o desidera fare cambiano il modo in cui l'assistenza può essere condotta. Una persona impaurita o non informata può opporsi, irrigidirsi, alzarsi senza aiuto o non riferire un sintomo.

La comunicazione deve essere comprensibile, rispettosa e proporzionata. L'operatore verifica che la persona abbia compreso ciò che è di sua competenza spiegare e non promette esiti né fornisce interpretazioni riservate ad altri professionisti. In presenza di barriere linguistiche, sensoriali o cognitive usa gli strumenti e i supporti previsti, senza affidare automaticamente informazioni delicate a un familiare.

Il caregiver può fornire informazioni e sostenere continuità e autonomia, ma non sostituisce sempre la volontà della persona. Ruolo, consenso, riservatezza e capacità decisionale vanno considerati nel caso concreto. Nell'assistenza quotidiana, coinvolgere correttamente significa chiarire obiettivi, attività possibili, segnali da comunicare e limiti.

Promuovere autonomia residua significa chiedere alla persona di partecipare per quanto possibile e sicuro. Può trattarsi di scegliere l'ordine delle attività, lavare una parte del corpo, impugnare una posata, mantenere una posizione o segnalare il bisogno. Il livello di aiuto va rivalutato: fare tutto al posto della persona può aumentare dipendenza e ridurre informazioni sulle capacità reali.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Igiene, pasto, eliminazione e relazione sono attività assistenziali complesse perché uniscono dignità, osservazione, rischio e autonomia. L'OSS opera nel perimetro attribuito e comunica i cambiamenti. L'infermiere integra i dati, pianifica e rivaluta. Un presidio non trasforma l'assistenza in automatismo. Ogni attività termina con comfort, comunicazione e tracciabilità.

Mobilità, cute e ausili

VALUTARE PERSONA, AMBIENTE E COLLABORAZIONE

La mobilità sostiene autonomia, funzione, relazione e prevenzione delle complicanze dell'immobilità. Ogni trasferimento o cambiamento di posizione espone però persona e operatori a rischi. Prima di scegliere livello di assistenza e ausilio, bisogna conoscere le condizioni della persona e dell'ambiente; chiedersi subito «quale presa uso?» anticipa la tecnica alla valutazione.

La valutazione considera almeno:

- capacità di comprendere e seguire indicazioni;
- forza, equilibrio, dolore, affaticamento e tolleranza;
- possibilità di caricare sugli arti e limitazioni note;
- dispositivi, medicazioni e linee presenti;
- peso e caratteristiche corporee rilevanti;
- storia di cadute e rischio cutaneo;
- spazio, pavimento, letto, sedia o carrozzina;
- disponibilità, integrità e compatibilità degli ausili;
- numero e formazione degli operatori previsti;
- piano assistenziale, prescrizioni e procedura del setting.

La collaborazione non è una qualità fissa. Una persona abitualmente collaborante può diventare confusa, dolorante o instabile; una persona dipendente può partecipare a singole fasi. Per questo la valutazione va ripetuta immediatamente prima e durante l'attività.

La movimentazione manuale riguarda anche la sicurezza del lavoratore. I riferimenti INAIL sulla valutazione del rischio e sul metodo MAPO aiutano a comprendere che organizzazione, ambiente, formazione, carico assistenziale e disponibilità di ausili sono fattori di sistema. L'abilità del singolo non neutralizza un rischio organizzativo.

PREVENIRE CADUTE E LESIONI DA PRESSIONE

Mobilità e integrità cutanea sono collegate. Una persona immobile può essere esposta a pressione, attrito, umidità e riduzione della partecipazione; una mobilitazione improvvisata può causare caduta, dolore o danno. Il piano deve quindi bilanciare protezione e mantenimento delle capacità.

Il riposizionamento non è una formula temporale uguale per tutti. Frequenza, posizioni, superfici, tolleranza e assistenza dipendono dalla valutazione individuale e dalle indicazioni applicabili. L'esame può chiedere i principi: valutare rischio e cute, pianificare, ridurre pressione e umidità, usare superfici appropriate, favorire nutrizione e mobilità, osservare e documentare. Non è corretto inventare intervalli universali.

Allo stesso modo, le sponde non sono una risposta automatica al rischio di caduta. Il loro uso deve rispettare valutazione, indicazioni, procedure e diritti della persona. Una barriera può avere effetti differenti secondo condizioni e comportamento; il candidato deve evitare equivalenze semplicistiche tra contenimento e sicurezza.

AUSILI, COMPATIBILITÀ E ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE

Gli ausili comprendono, tra gli altri, teli ad alto scorrimento, tavole o assi, cinture ergonomiche, dischi girevoli e sollevatori. Il nome dell'ausilio non definisce da solo la tecnica. La scelta dipende da attività, persona, ambiente, valutazione del rischio e addestramento.

I manuali del sollevatore mobile Birdie EVO e delle imbragature Universal Slings costituiscono un esempio utile. Richiamano lettura delle istruzioni, approvazione professionale, addestramento, valutazione individuale, integrità, fissaggio, carico del sistema, compatibilità tra sollevatore e imbragatura e manutenzione. Queste indicazioni valgono per i modelli e le revisioni cui si riferiscono, non per ogni sollevatore esistente.

In un quesito pratico, prima di usare un dispositivo occorre poter rispondere a domande essenziali:

- modello e accessori sono identificati?
- il dispositivo è destinato a quell'uso?
- persona e tipo di trasferimento sono stati valutati?
- taglia, configurazione e compatibilità dell'imbragatura sono confermate?
- integrità, carico e manutenzione sono verificati?
- gli operatori sono addestrati e il numero previsto è disponibile?
- ambiente e percorso sono idonei?
- sono noti criteri di interruzione e funzioni di emergenza?

Se una risposta manca, l'esperienza generica non colma il vuoto: si sospende l'uso e si verifica. Trasferimento e trasporto hanno finalità diverse; anche questa distinzione, richiamata dal manuale del fabbricante, può diventare un distrattore concorsuale.

QUANDO FERMARSI E CHIEDERE SUPPORTO

Fermarsi è una competenza di sicurezza. Dolore improvviso, perdita di collaborazione, malessere, instabilità, cedimento dell'ausilio, incompatibilità, spazio insufficiente o indicazioni contraddittorie impongono di interrompere e rivalutare. Continuare per «finire il compito» trasforma una difficoltà in rischio.

La comunicazione deve essere breve e informativa: identificare persona e situazione, descrivere il cambiamento, precisare l'attività in corso, indicare i rischi immediati e chiedere la valutazione necessaria. L'OSS non deve proporre diagnosi; l'infermiere non deve ignorare il dato perché l'attività era stata pianificata in precedenza.

DOMANDA DA COMMISSARIO

«Come imposta in sicurezza il trasferimento letto-carrozzina di una persona parzialmente collaborante?» Una risposta corretta parte da identità, condizioni, prescrizioni e capacità di collaborazione; valuta ambiente, letto, carrozzina, rischio di caduta e presenza di dispositivi; seleziona assistenza e ausilio secondo piano, procedura e addestramento; informa la persona e protegge la privacy; osserva tolleranza e interrompe in caso di cambiamento; conclude con comfort, comunicazione e documentazione. La sequenza tecnica concreta dipende dalla procedura e dagli ausili disponibili.

Infermiere e OSS: attribuzione, supervisione e comunicazione

DUE RUOLI, UN PERCORSO ASSISTENZIALE

Il D.M. 739/1994 definisce l'infermiere come professionista responsabile dell'assistenza generale infermieristica. Il DPCM 25 marzo 2025 definisce l'OSS come operatore di interesse sanitario che supporta la persona nei bisogni primari e favorisce benessere e autonomia nei contesti sanitario, sociosanitario e sociale. Le due figure lavorano spesso nello stesso percorso, ma non sono intercambiabili.

L'infermiere raccoglie e interpreta i bisogni assistenziali, pianifica, definisce priorità e risultati, assicura la corretta applicazione delle prescrizioni, valuta gli esiti e modifica il piano per quanto di competenza. L'OSS svolge attività coerenti con il profilo, la formazione, le attribuzioni e il setting, osserva la persona durante tali attività e comunica i dati rilevanti.

La collaborazione efficace non nasce da formule generiche come «l'OSS aiuta l'infermiere». Richiede un'assegnazione comprensibile: persona corretta, attività definita, obiettivo, condizioni da rispettare, osservazioni richieste, limiti, tempi e modalità di comunicazione. L'infermiere deve considerare complessità e prevedibilità della situazione; l'OSS deve riconoscere se le condizioni corrispondono a quelle previste.

ATTRIBUZIONE E RESPONSABILITÀ RESTANO DISTINTE

L'attribuzione organizza un'attività nel lavoro di équipe. Non trasferisce all'OSS la valutazione o la decisione professionale dell'infermiere. Allo stesso tempo, l'OSS risponde della corretta esecuzione di ciò che accetta e svolge nel proprio perimetro, dell'osservazione richiesta e della comunicazione dei cambiamenti.

La distinzione può essere sintetizzata così:

Passaggio	Infermiere	OSS
Valutazione assistenziale	raccoglie e interpreta i dati di competenza	osserva e riferisce dati nell'attività svolta
Pianificazione	definisce problemi, priorità, obiettivi e interventi infermieristici	comprende l'attività attribuita e collabora
Esecuzione	esegue gli interventi di competenza e coordina il piano	esegue correttamente le attività comprese nel perimetro
Cambiamento inatteso	rivaluta e attiva il percorso necessario	interrompe se occorre, mette in sicurezza e segnala
Documentazione	documenta valutazioni, decisioni, interventi ed esiti	registra attività e osservazioni secondo strumenti e responsabilità
Verifica	valuta gli esiti e aggiorna il piano	comunica risposta e dati utili alla valutazione

La tabella descrive il criterio generale, non un mansionario valido in ogni Regione e azienda. Il DPCM 2025 è attuato in contesti regionali e organizzativi differenti. Le deliberazioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto mostrano programmi, tirocini e laboratori diversi; la procedura concreta deve quindi essere verificata nel luogo di lavoro.

SUPERVISIONE ED ESCALATION

La supervisione assume forme diverse e non si riduce alla presenza fisica continua o al solo controllo finale. La sua intensità dipende da complessità, rischio, stabilità della persona, competenza dell'operatore, novità dell'attività e organizzazione. Può comprendere istruzioni, disponibilità, osservazione, verifica e feedback.

L'OSS deve chiedere chiarimento quando l'attribuzione è incompleta, incompatibile con il proprio profilo, diversa dalle condizioni effettive o non sostenuta da formazione e mezzi. L'infermiere deve rivalutare quando riceve un dato nuovo o quando l'attività non produce l'esito atteso. Dire «era stato già pianificato» non giustifica il proseguimento in una situazione cambiata.

Una comunicazione di escalation efficace contiene:

1. identificazione della persona e del luogo;
2. descrizione concreta della situazione;
3. cambiamento rispetto al dato precedente;
4. rischio immediato o attività sospesa;
5. richiesta di valutazione o indicazione.

CONTINUITÀ E DOCUMENTAZIONE

La continuità richiede che ciò che un operatore osserva non resti nella memoria individuale. Consegne, documentazione e comunicazioni devono rendere disponibili informazioni pertinenti a chi prosegue l'assistenza. La selezione è importante: troppe informazioni indistinte possono nascondere il dato critico.

L'OSS registra ciò che ha svolto e osservato secondo gli strumenti previsti; l'infermiere collega questi dati alla valutazione e al piano. In entrambi i casi, non si documenta ciò che non è stato osservato o eseguito. Correzioni, abbreviazioni e firme seguono le regole del sistema adottato.

ERRORE TIPICO

Confondere attribuzione e delega totale: «l'infermiere attribuisce, quindi l'OSS decide come procedere». La formulazione corretta è che l'attività attribuita resta dentro un piano e un perimetro; decisione professionale, corretta esecuzione, osservazione e supervisione conservano responsabilità distinte.

Caso guidato non esecutivo

SCENARIO

La signora Anna, 82 anni, è ricoverata dopo un periodo di ridotta mobilità. È vigile e orientata, ma riferisce stanchezza. Riesce a collaborare nei passaggi semplici e usa abitualmente una carrozzina. Il piano disponibile prevede assistenza nell'igiene e nel trasferimento, osservazione della cute e aiuto al pasto. Durante la mattina l'OSS nota un arrossamento nella regione sacrale, non descritto nella consegna precedente. Al pasto Anna tossisce dopo alcuni sorsi e appare più affaticata. Chiede inoltre di essere trasferita subito in carrozzina perché attende la figlia.

Il caso contiene tre rischi: alterazione cutanea, possibile difficoltà nella deglutizione e trasferimento in condizioni diverse da quelle attese. La richiesta della persona è importante, ma non elimina la necessità di rivalutare la sicurezza.

ANALISI DEI DATI E DELLE PRIORITÀ

I dati disponibili sono: età, ridotta mobilità, collaborazione parziale, uso abituale della carrozzina, arrossamento nuovo, tosse dopo i liquidi e maggiore affaticamento. Mancano almeno: caratteristiche complete dell'arrossamento, condizioni generali attuali, indicazioni sul rischio cutaneo, valutazione della deglutizione, ausilio e livello di assistenza previsti, eventuali limitazioni e risposta ai precedenti trasferimenti.

La priorità immediata è non proseguire automaticamente pasto e trasferimento. La tosse associata all'assunzione e il cambiamento della tolleranza richiedono interruzione dell'attività potenzialmente rischiosa, sicurezza e comunicazione all'infermiere. Anche l'arrossamento nuovo va segnalato perché può modificare valutazione e piano di prevenzione.

Il candidato non deve diagnosticare disfagia o lesione da pressione. Deve descrivere i dati e chiedere la valutazione competente. Non deve neppure negare in modo definitivo la richiesta di Anna: deve spiegarle che occorre verificare le condizioni per trasferirla in sicurezza e coinvolgerla nella nuova decisione.

PIANO ASSISTENZIALE ESSENZIALE

Dato	Problema/rischio	Obiettivo	Intervento ragionato
Arrossamento nuovo e mobilità ridotta	rischio di compromissione cutanea	proteggere l'integrità della cute	segnalare, favorire valutazione, applicare il piano aggiornato su mobilità, umidità, superficie e osservazione
Tosse dopo sorsi e affaticamento	rischio durante l'alimentazione	mantenere sicurezza e adeguata assistenza al pasto	interrompere, mettere in sicurezza, comunicare e attendere indicazioni; registrare quanto osservato
Richiesta di trasferimento con condizioni cambiate	rischio di caduta o scarsa tolleranza	effettuare il trasferimento solo con assistenza appropriata	rivalutare collaborazione, condizioni, ambiente e ausilio; spiegare la sospensione; procedere solo secondo piano aggiornato

Dato	Indicatore
Arrossamento nuovo e mobilità ridotta	evoluzione della cute e tolleranza
Tosse dopo sorsi e affaticamento	esito della valutazione e assunzione secondo nuovo piano
Richiesta di trasferimento con condizioni cambiate	trasferimento tollerato senza eventi, oppure scelta alternativa sicura

Il piano non contiene una diagnosi né una tecnica esecutiva. Rende invece espliciti dati, rischio, obiettivo, responsabilità e verifica.

RIPARTIZIONE DEI RUOLI

L'OSS interrompe le attività che non corrispondono più alle condizioni attese, garantisce la sicurezza immediata, informa Anna, comunica all'infermiere dati concreti e documenta secondo gli strumenti previsti. Non classifica l'arrossamento, non decide una nuova consistenza del pasto e non sceglie autonomamente una diversa tecnica di trasferimento.

L'infermiere rivaluta condizioni e bisogni, integra i dati nel processo assistenziale, decide gli interventi infermieristici, coinvolge altri professionisti quando necessario, aggiorna indicazioni e supervisione e verifica gli esiti. L'eventuale trasferimento sarà ripianificato sulla base di condizioni, ausili, procedura e operatori disponibili.

La comunicazione può essere formulata così: «Anna, stanza X, durante il pasto ha tossito dopo alcuni sorsi ed è apparsa più affaticata rispetto alla consegna. Ho interrotto il pasto e l'ho mantenuta in sicurezza. Durante l'igiene ho inoltre osservato un nuovo arrossamento sacrale. Chiede di essere trasferita in carrozzina: serve una rivalutazione prima di procedere». La formula identifica persona, cambiamento, azione prudente e richiesta.

CHE COSA VALUTA LA COMMISSIONE

La commissione non cerca soltanto la parola «segnalare». Valuta se il candidato:

- riconosce più problemi nello stesso scenario;
- ordina le priorità senza ignorare la volontà della persona;
- distingue osservazione da diagnosi;
- evita di continuare una procedura quando le condizioni cambiano;
- ripartisce correttamente decisione infermieristica e supporto OSS;
- collega comunicazione, documentazione e rivalutazione;
- non inventa posture, diete, trattamenti o manovre.

Allenamento da concorso

QUIZ 1 — PROCESSO ASSISTENZIALE

Quale sequenza rappresenta meglio il processo assistenziale?

- A. Attività, consegna, diagnosi, obiettivo, dimissione.
- B. Raccolta dati, problemi/bisogni, obiettivi, pianificazione, attuazione, valutazione.
- C. Prescrizione, esecuzione, registrazione, archiviazione.
- D. Bisogno, tecnica, delega, controllo finale.

Risposta corretta: B. Il processo parte dai dati e collega bisogni, obiettivi, interventi ed esiti. Le altre opzioni riducono l'assistenza a passaggi incompleti o impropri.

QUIZ 2 — OSS E CAMBIAMENTO INATTESO

Durante un'attività attribuita, l'OSS osserva un cambiamento che rende la situazione diversa da quella pianificata. Qual è la condotta più corretta?

- A. Completa l'attività perché è stata attribuita.
- B. Decide autonomamente un nuovo piano.
- C. Mette in sicurezza, interrompe se necessario, comunica dati concreti e attende la rivalutazione.
- D. Registra il cambiamento a fine turno senza disturbare l'équipe.

Risposta corretta: C. L'attribuzione non rende immodificabile il piano e non trasferisce la decisione professionale. Sicurezza e comunicazione vengono prima del completamento del compito.

QUIZ 3 — AUSILI

Quale affermazione è corretta riguardo a un sollevatore?

- A. Tutti i modelli utilizzano le stesse imbragature.
- B. L'esperienza dell'operatore sostituisce le istruzioni del fabbricante.
- C. Modello, compatibilità, integrità, valutazione della persona e addestramento devono essere verificati.
- D. Il sollevatore elimina la necessità di valutare ambiente e collaborazione.

Risposta corretta: C. Le istruzioni sono modello-specifiche e la sicurezza dipende dal sistema completo, dalla persona, dall'ambiente e dagli operatori.

QUESITO TEORICO-PRATICO

Traccia: «Descriva come pianificare l'assistenza al pasto di una persona non autosufficiente e quali elementi richiedono segnalazione».

Una risposta completa può seguire questa scaletta:

1. verificare identità, piano alimentare, indicazioni, condizioni e grado di autonomia;
2. predisporre ambiente, privacy, postura prevista e materiali;
3. informare e favorire partecipazione, rispettando ritmo e preferenze compatibili;
4. osservare masticazione, deglutizione, tolleranza e quantità assunte;
5. interrompere e segnalare tosse, difficoltà, alterazioni della voce, affaticamento o altri cambiamenti;
6. assicurare comfort, registrare assunzione ed eventi e comunicare secondo responsabilità;
7. precisare che consistenze, strategie specifiche e decisioni cliniche derivano dalla valutazione competente.

La risposta è forte perché spiega finalità, sicurezza e osservazione; non perché elenca una manovra.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: «Qual è la differenza tra attività attribuita all'OSS e responsabilità infermieristica?»

Risposta modello: «L'infermiere è responsabile del processo assistenziale di competenza: valuta i bisogni, definisce priorità e obiettivi, pianifica, verifica gli esiti e aggiorna il piano. L'OSS svolge attività coerenti con profilo, formazione, attribuzione e setting, risponde della corretta esecuzione, osserva e comunica. L'attribuzione non trasferisce la decisione professionale e deve indicare attività, condizioni, limiti e dati da riferire. Se la situazione cambia, l'OSS mette in sicurezza e segnala; l'infermiere rivaluta».

Possibile follow-up: «La disciplina è identica in tutte le Regioni?» Risposta: «Il profilo nazionale è definito dal DPCM 25 marzo 2025, ma formazione e organizzazione sono attuate a livello regionale e aziendale. Occorre quindi distinguere il nucleo nazionale dalle procedure e attribuzioni del setting concreto».

MINI-ESERCIZIO

Completa questa griglia per uno scenario a tua scelta: persona con ridotta mobilità, assistenza igienica o bisogno di aiuto al pasto.

Passaggio	La tua risposta
Tre dati disponibili	
Due dati mancanti	
Problema o rischio prioritario	
Obiettivo osservabile	
Intervento non esecutivo	
Che cosa compete all'infermiere	
Che cosa può essere attribuito all'OSS	
Criterio di interruzione/escalation	

Passaggio	La tua risposta
Indicatore per la rivalutazione	

Controlla poi se hai usato almeno una volta ciascuno dei verbi: valutare, verificare, proteggere, osservare, comunicare, documentare, rivalutare.

ERRORI E TRAPPOLE DA EVITARE

- partire dalla tecnica prima di aver valutato persona, rischio e contesto;
- confondere osservazione con diagnosi o segnalazione con decisione clinica;
- considerare l'attribuzione all'OSS come trasferimento del processo infermieristico;
- proseguire un'attività nonostante un cambiamento inatteso;
- usare una procedura regionale, aziendale o modello-specifica come regola universale;
- documentare formule vaghe, senza dato osservato, risposta della persona ed esito;
- presentare il rispetto della volontà della persona come alternativo alla sicurezza, anziché integrare informazione, partecipazione e rivalutazione.

Checklist finale

Prima di consegnare una risposta, verifica:

- ho identificato profilo, persona e setting;
- ho distinto dati disponibili e dati mancanti;
- ho formulato bisogno, problema o rischio senza inventare diagnosi;
- ho motivato la priorità;
- ho indicato un obiettivo osservabile;
- ho collegato interventi e indicatori;
- ho reso espliciti identità, privacy, sicurezza e autonomia residua;
- ho distinto decisione infermieristica e attività OSS;
- ho previsto osservazione, comunicazione, documentazione e rivalutazione;
- ho evitato dosaggi, manovre e procedure universali non richieste;
- ho indicato quando fermarsi e chiedere supporto;
- ho concluso con l'esito atteso, non con il solo completamento del compito.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.M. 14 settembre 1994, n. 739, profilo professionale dell'infermiere.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, sicurezza delle cure e responsabilità professionale sanitaria.
- DPCM 25 marzo 2025, revisione del profilo dell'operatore socio-sanitario.
- Codice deontologico delle professioni infermieristiche FNOPI, edizione vigente nel 2025.
- Ministero della Salute, Raccomandazione n. 7 per la prevenzione degli errori in terapia farmacologica.
- Ministero della Salute, Raccomandazione n. 13 per la prevenzione e gestione della caduta del paziente.
- Ministero della Salute, Raccomandazione n. 17 sulla riconciliazione della terapia farmacologica.
- Ministero della Salute, Raccomandazione n. 18 su abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli in terapia.
- Sistema Nazionale Linee Guida, Prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione, pubblicata nel 2025.
- Regione del Veneto, DGR n. 883/2025 e guida 2026 per le attività seminariali e laboratoriali dei corsi OSS.
- Indicazioni e procedure regionali o aziendali applicabili al setting, da verificare nella loro versione vigente.

Questi riferimenti forniscono il quadro di studio. Nella pratica e nelle prove che richiedono una procedura specifica, il candidato deve sempre coordinare profilo, piano assistenziale, indicazioni cliniche, procedura dell'ente, istruzioni del dispositivo e condizioni effettive della persona.

Valutazione clinica, triage, urgenza ed emergenza

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Obiettivo del capitolo

Nell'emergenza il tempo conta, ma la rapidità senza metodo produce errori. La commissione verifica se il candidato sa riconoscere un cambiamento, raccogliere i dati essenziali, assegnare una priorità, allertare il team e rivalutare. Non chiede soltanto il nome di uno score o di un algoritmo.

Al termine saprai:

- impostare una valutazione iniziale orientata alla sicurezza e alle funzioni vitali;
- distinguere urgenza, emergenza e rischio evolutivo;
- riconoscere il deterioramento e spiegare la funzione di NEWS2 senza usarlo come diagnosi;
- descrivere finalità, fasi e responsabilità del triage;
- collegare allerta, leadership, comunicazione, documentazione e debriefing;
- distinguere il quadro del supporto vitale di base, avanzato e neonatale;
- riconoscere gli allarmi ostetrici e attivare la risposta senza trasformare il testo in un protocollo esecutivo.

Il capitolo prepara alle prove teoriche e ai casi ragionati. Non sostituisce corsi certificati, simulazione, addestramento, protocolli della struttura o attribuzioni professionali. Soglie, codici, farmaci, dosi, energie, manovre e sequenze devono sempre essere verificati sulla versione e sul setting applicabili.

Mappa BANDO

La sequenza di ragionamento è: sicurezza → riconoscimento → priorità → allerta → supporto → rivalutazione.

Passaggio	Domanda	Output atteso
B — Bando	Quale profilo, setting e forma di prova sono indicati?	Delimitare competenze e profondità
A — Aree	Il caso riguarda valutazione, deterioramento, triage, rianimazione o allarme ostetrico?	Identificare l'area clinica

Passaggio	Domanda	Output atteso
N — Nuclei	Quali dati, rischi, priorità, ruoli e limiti devo esporre?	Costruire la risposta
D — Diario	Ho ignorato un cambiamento, ritardato l'allerta o trasformato uno score in diagnosi?	Correggere l'errore
O — Output	Devo definire, confrontare, prioritzare o risolvere un caso?	Scegliere forma e sequenza

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La valutazione iniziale cerca le minacce immediate e i dati che cambiano la priorità. Il triage ordina l'accesso alle cure e richiede rivalutazione. Uno score sostiene il giudizio, non lo sostituisce. L'emergenza attiva una risposta coordinata, non una prestazione isolata. Riconoscere i propri limiti e allertare in tempo è parte della competenza.

9.1 Valutazione iniziale, priorità e rivalutazione

SICUREZZA E IMPRESSIONE GENERALE

La valutazione comincia prima del contatto. Occorre verificare che l'ambiente non esponga persona, operatori o presenti a un pericolo ulteriore e attivare le risorse previste. In una struttura sanitaria questo significa anche considerare isolamento, dispositivi, spazi, attrezzature e necessità di supporto.

L'impressione generale risponde a una domanda semplice: la persona appare stabile o criticamente compromessa? Stato di coscienza, respirazione, colorito, postura, capacità di parlare, comportamento e segni di sofferenza offrono dati immediati. Non producono da soli una diagnosi, ma orientano priorità e richiesta di aiuto.

Identità e contesto restano essenziali anche quando il tempo è breve. Se l'identità non è nota, si applica il percorso previsto dal servizio. Due errori opposti compromettono la sicurezza: ritardare una risposta salvavita per completare ogni formalità oppure ignorare identificazione, allergie, eventi precedenti e informazioni già disponibili.

FUNZIONI VITALI E INFORMAZIONI ESSENZIALI

La valutazione iniziale segue un ordine che consente di individuare e trattare le minacce più immediate secondo formazione e protocollo. Nel testo concorsuale è sufficiente chiarire le aree: pervietà delle vie aeree, respirazione, circolo, stato neurologico ed esposizione/contesto. L'ordine concreto e gli interventi dipendono dall'algoritmo applicabile.

Per ogni area si raccolgono dati osservabili e misurabili:

- capacità di parlare, rumori o segni di ostruzione;
- frequenza e qualità della respirazione, saturazione quando prevista, lavoro respiratorio;
- polso, pressione, perfusione, cute e segni di sanguinamento;
- stato di coscienza, orientamento e cambiamenti neurologici;
- temperatura, lesioni, dolore, dispositivi e altri elementi pertinenti.

La raccolta va accompagnata da informazioni essenziali: esordio e andamento, sintomo principale, allergie, farmaci rilevanti, patologie, eventi recenti e dato basale. In emergenza l'anamnesi è mirata; i dettagli non urgenti possono seguire dopo la stabilizzazione.

URGENZA, EMERGENZA E RISCHIO EVOLUTIVO

L'emergenza comporta una minaccia immediata alle funzioni vitali e richiede risposta senza ritardo. L'urgenza richiede un intervento tempestivo perché il ritardo può produrre peggioramento o danno, pur senza una compromissione vitale già manifesta. Il rischio evolutivo descrive la possibilità che una situazione apparentemente stabile peggiori.

Queste categorie aiutano il ragionamento, ma non sostituiscono il sistema di triage adottato. Un sintomo modesto può avere alto rischio in una persona fragile; un parametro isolato va letto insieme a tendenza, contesto e condizioni precedenti. La priorità non coincide con l'ordine di arrivo né con l'intensità dichiarata di un solo sintomo.

Per motivare una priorità in prova usa quattro passaggi:

1. indica il dato più preoccupante;
2. spiega quale funzione o rischio coinvolge;
3. dichiara l'allerta o la risposta necessaria;
4. prevedi rivalutazione e possibile aumento della priorità.

RIVALUTAZIONE

La valutazione iniziale è una fotografia; la situazione clinica è un processo. La rivalutazione cerca cambiamenti dopo il tempo trascorso, un intervento, un trasferimento o la comparsa di nuovi dati. Deve essere più frequente quando il rischio è maggiore e segue i tempi previsti dal protocollo.

Rivalutare significa ripetere gli elementi pertinenti, confrontarli con il dato precedente e verificare la risposta. Un parametro stabile non esclude il peggioramento se coscienza, respiro, dolore o comportamento cambiano. Nel triage, la rivalutazione impedisce che l'assegnazione iniziale diventi definitiva nonostante l'evoluzione.

La rivalutazione deve rispondere a tre domande: la persona è migliorata, è rimasta stabile o è peggiorata? L'intervento ha prodotto l'effetto atteso? La priorità e il livello di assistenza sono ancora adeguati? Se la risposta è incerta, non si presume la stabilità: si ripetono i controlli pertinenti e si chiede la valutazione necessaria.

Nel passaggio tra operatori, riportare soltanto l'ultimo valore è insufficiente. La tendenza rende l'informazione clinicamente utile: «la frequenza respiratoria è aumentata rispetto a un'ora fa» comunica più di un numero isolato. Anche il momento della rilevazione, l'eventuale supporto in corso e la risposta della persona devono essere chiari.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA E DATI MANCANTI

Dopo aver escluso o affrontato le minacce immediate, la valutazione può approfondire sintomi, storia, dolore, esame mirato e contesto. L'ordine resta governato dalla priorità: una domanda utile non deve ritardare un'allerta necessaria.

I dati mancanti vanno dichiarati. In un caso scritto, il candidato può specificare: «verificherei terapia in corso, allergie, esordio, basale e precedenti eventi, senza ritardare l'attivazione». Questa formula mostra metodo e prudenza. Inventare un dato per completare lo scenario rende invece fragile tutta la soluzione.

Particolare attenzione meritano persone anziane, fragili, con disabilità, gravidanza, puerperio o difficoltà comunicative. La presentazione può essere meno tipica e il dato basale diventa ancora più importante. La fragilità non assegna automaticamente la massima priorità, ma modifica il rischio e la soglia organizzativa di attenzione secondo protocollo.

ERRORE TIPICO

Elencare parametri senza spiegare che cosa cambia la priorità. La commissione cerca il collegamento dato → rischio → allerta → rivalutazione.

9.2 Deterioramento clinico, NEWS2 e sepsi

RICONOSCERE IL PEGGIORAMENTO

Il deterioramento clinico è un peggioramento delle condizioni che può precedere un evento critico. Può emergere da parametri vitali alterati, cambiamento dello stato mentale, aumento del lavoro respiratorio, riduzione della perfusione, dolore inatteso, scarsa diuresi, nuova debolezza o preoccupazione della persona, del caregiver o dell'operatore.

Il confronto con il basale è decisivo. Lo stesso valore può avere significati diversi secondo la persona; la tendenza può essere più informativa del dato singolo. Anche l'impressione clinica mantiene valore: se la persona appare peggiore, una cifra rassicurante non giustifica l'attesa.

Il riconoscimento deve produrre un'azione proporzionata: ripetere e verificare i dati, mettere in sicurezza, allertare secondo percorso, preparare informazioni utili e continuare la sorveglianza. L'operatore non deve attendere di avere una diagnosi completa prima di comunicare un peggioramento.

NEWS2: FUNZIONE E LIMITI

NEWS2 è un sistema di allerta precoce che combina parametri fisiologici per sostenere il riconoscimento e il monitoraggio della gravità nella patologia acuta. Il documento della Regione Emilia-Romagna del 2024 lo collega anche a un percorso per la sospetta sepsi.

Il perimetro ordinario è quello dei pazienti adulti. Secondo il Royal College of Physicians, NEWS2 non va applicato come score standard sotto i 16 anni o in gravidanza: occorrono strumenti pediatrici od ostetrici appropriati al contesto. La presenza di argomenti ostetrici in questo capitolo non estende a quelle pazienti la tabella NEWS2.

Lo score ha tre funzioni didattiche:

- rende sistematica la raccolta di parametri;
- segnala combinazioni e tendenze che richiedono attenzione;
- collega il risultato a frequenza di monitoraggio ed escalation secondo protocollo.

NEWS2 è uno strumento di supporto, non una diagnosi. Il giudizio clinico mantiene il proprio ruolo e un dato preoccupante conserva valore anche se non modifica il punteggio. Popolazione, eccezioni, modalità di calcolo e soglie devono essere verificate sulla versione adottata. La tabella seguente riporta i valori del documento regionale 2024, con ambito e limiti dichiarati.

NEWS2: CALCOLO, SCALE E LIMITI

Fonte e versione: Regione Emilia-Romagna, NEWS2. Score per identificare precocemente la gravità dei pazienti con patologia acuta, settembre 2024; lo strumento riprende NEWS2 del Royal College of Physicians, versione 2017. Ambito: valutazione di pazienti adulti con patologia acuta nel percorso organizzativo che adotta NEWS2. Non è una diagnosi, non sostituisce il giudizio clinico e non definisce da solo le attribuzioni professionali. Regola di calcolo: si assegna a ciascun parametro il punteggio indicato, si sommano i punteggi e si aggiungono 2 punti se è in corso ossigenoterapia.

Parametro	Intervallo e punteggio NEWS2
Frequenza respiratoria/min	≤8 = 3; 9–11 = 1; 12–20 = 0; 21–24 = 2; ≥25 = 3
Frequenza cardiaca/min	≤40 = 3; 41–50 = 1; 51–90 = 0; 91–110 = 1; 111–130 = 2; ≥131 = 3

Parametro	Intervallo e punteggio NEWS2
Temperatura corporea	≤35,0 °C = 3; 35,1–36,0 = 1; 36,1–38,0 = 0; 38,1–39,0 = 1; ≥39,1 = 2
Pressione sistolica	≤90 mmHg = 3; 91–100 = 2; 101–110 = 1; 111–219 = 0; ≥220 = 3
Stato di coscienza	cosciente = 0; confusione/disorientamento/agitazione di nuova insorgenza oppure risposta V, P o U della scala AVPU = 3
Saturazione, scala 1	≤91% = 3; 92–93 = 2; 94–95 = 1; ≥96 = 0
Saturazione, scala 2: solo nei casi precisati sotto	≤83% = 3; 84–85 = 2; 86–87 = 1; 88–92 = 0; in aria ambiente ≥93 = 0; con O ₂ 93–94 = 1, 95–96 = 2, ≥97 = 3
Ossigenoterapia	aggiungere 2 punti

Scelta della scala: la scala 2 richiede insufficienza respiratoria ipercapnica confermata da emogasanalisi corrente o di un precedente ricovero e decisione clinica documentata del target SpO₂ 88–92%. La sola diagnosi di BPCO non basta. Negli altri casi si applica la scala 1, secondo RCP NEWS2, §5.

Soglia nel documento regionale: un punteggio globale ≥5 indica un elevato livello di allarme che richiede intervento immediato; con infezione nota o sospetta, o alto rischio di infezione, impone di considerare sempre la sepsi. La stessa fonte precisa che la soglia può essere adattata al singolo paziente sulla base della valutazione clinica.

COMUNICAZIONE STRUTTURATA ED ESCALATION

L'escalation trasferisce l'informazione alla persona o al team in grado di valutare e intervenire. Una comunicazione utile comprende identificazione, situazione attuale, contesto rilevante, dati osservati, cambiamento rispetto al basale, azioni già svolte e richiesta chiara.

Dire «il paziente non mi piace» può esprimere un'intuizione valida solo se viene tradotta in elementi concreti: nuovo stato confusionale, respiro più faticoso, pressione in calo, ridotta risposta o peggioramento rapido. Anche leggere soltanto il punteggio, senza descrivere i parametri, può nascondere il problema.

La comunicazione non chiude il compito. Chi segnala resta responsabile delle misure previste nel proprio ruolo, della sorveglianza e di una nuova escalation se la risposta tarda o la persona peggiora.

SOSPETTA INFEZIONE E PERCORSO SEPSI

La sepsi è una condizione tempo-dipendente associata a infezione e disfunzione d'organo. In un manuale concorsuale il punto centrale è riconoscere la possibile combinazione di infezione, peggioramento e alterazione delle funzioni, non formulare autonomamente la diagnosi o il trattamento.

Febbre o ipotermia, alterazione dello stato mentale, difficoltà respiratoria, segni di perfusione ridotta e altri cambiamenti possono richiedere valutazione urgente nel contesto appropriato. Le definizioni, i criteri, gli esami e la terapia seguono linee guida e procedure correnti.

Il percorso ragionato è: sospettare sulla base dei dati, misurare e verificare quanto previsto, allertare, attivare il percorso sepsi del setting, supportare secondo competenza, documentare tempi e risposta, rivalutare. NEWS2 può contribuire all'allerta, ma non decide da solo presenza o assenza di sepsi.

DOMANDA-TRAPPOLA

«Il NEWS2 è basso: si può escludere il deterioramento?» No. Il punteggio va interpretato con quadro clinico, tendenza, basale e fattori non rappresentati. Un cambiamento preoccupante richiede valutazione ed escalation anche quando lo score non appare elevato.

9.3 Triage e gestione dinamica della priorità

FINALITÀ E RESPONSABILITÀ

Il triage è un processo di valutazione che assegna una priorità di accesso alle cure in base a condizioni, rischio ed evoluzione possibile. La priorità clinica prevale sull'anzianità di arrivo e precede la diagnosi completa. Le linee nazionali sul triage intraospedaliero del 2019 ne richiamano valutazione iniziale, fasi, rivalutazione e responsabilità organizzative.

La priorità deve essere riproducibile e motivata. Richiede personale formato, protocolli, documentazione, ambienti e percorsi. Il professionista integra sintomo principale, dati vitali, dolore, fattori di rischio, meccanismo dell'evento, fragilità e osservazione generale.

ASSEGNAZIONE E RIVALUTAZIONE

TRIAGE: CODICI E TEMPI DI ACCESSO

Fonte e versione: Ministero della Salute, Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, 2019, tabelle 1–2. Quadro verificato al 3 ottobre 2026. Ambito: triage intraospedaliero a cinque priorità. I tempi si riferiscono all'accesso alle aree di trattamento, non alla conclusione della visita o alla dimissione.

Codice e priorità	Criterio essenziale	Accesso entro
1 — Emergenza	Una o più funzioni vitali interrotte o compromesse	Immediato
2 — Urgenza	Rischio di compromissione vitale, rischio evolutivo o dolore severo	15 minuti
3 — Urgenza differibile	Stabilità senza rischio evolutivo, ma sofferenza e ricaduta generale; prestazioni solitamente complesse	60 minuti
4 — Urgenza minore	Stabilità senza rischio evolutivo; prestazioni solitamente semplici e monospecialistiche	120 minuti
5 — Non urgenza	Problema non urgente o di minima rilevanza clinica	240 minuti

Limite: il peggioramento richiede rivalutazione e adeguamento della priorità senza attendere la scadenza. Il codice 2 richiede osservazione con monitoraggio costante; per 3–5 la rivalutazione segue giudizio infermieristico, richiesta della persona e decorso del tempo massimo previsto. Il codice 1 accede direttamente al trattamento. Le associazioni cromatiche vanno lette nell'implementazione adottata; il numero rende esplicita la priorità nazionale.

Verifica: un assistito classificato 4 diventa improvvisamente dispnoico mentre attende. Si devono attendere i 120 minuti? Soluzione: no. Il tempo indicato non protegge la classificazione iniziale da revisione; il nuovo dato impone valutazione immediata e possibile aumento della priorità.

L'assegnazione iniziale fotografa il rischio nel momento della valutazione. Il tempo di attesa, nuovi sintomi o un cambiamento dei parametri possono modificare la priorità. La persona deve sapere come segnalare un peggioramento e l'organizzazione deve garantire la rivalutazione prevista.

Sovrastimare in modo sistematico può saturare i percorsi più intensivi; sottostimare può ritardare cure necessarie. La priorità va quindi motivata attraverso i dati, senza formule automatiche. Codici e tempi variano con il modello adottato e vanno verificati nel protocollo richiesto dal bando o dal servizio.

Elemento	Domanda utile
Presentazione	Qual è il problema principale e quando è iniziato?
Stabilità	Vi sono minacce immediate o peggioramento rapido?
Rischio	Quali fragilità, eventi o condizioni aumentano la probabilità di danno?
Percorso	Quale area e quale team devono essere attivati?
Attesa	Quali dati richiedono monitoraggio e quando rivalutare?

IL PROCESSO DI TRIAGE

Il processo può essere letto in cinque passaggi logici. L'accoglienza identifica persona e motivo dell'accesso. La valutazione raccoglie dati mirati e riconosce minacce o fattori di rischio. L'assegnazione traduce tali dati in priorità secondo il sistema vigente. L'invio colloca la persona nel percorso appropriato. La rivalutazione controlla che attesa ed evoluzione non abbiano modificato il rischio.

Ogni passaggio lascia una traccia. La documentazione deve permettere di comprendere quali dati hanno sostenuto la priorità, quali informazioni sono state date e quali cambiamenti hanno determinato una nuova valutazione. Una motivazione generica come «condizioni discrete» non consente questo controllo.

Il triage organizza risorse limitate in base al bisogno e al rischio; la visita completa viene dopo e i tempi dipendono dal contesto. Priorità clinica e accettazione amministrativa restano piani distinti: una difficoltà documentale non può ritardare la risposta a una minaccia immediata, mentre identificazione e registrazione devono essere recuperate con il percorso previsto.

SOVRASTIMA, SOTTOSTIMA E SICUREZZA

La sottostima assegna una priorità inferiore a quella richiesta dal rischio e può produrre ritardo. La sovrastima assegna una priorità superiore e, se sistematica, sottrae risorse ai casi più critici. La sicurezza richiede formazione, audit, confronto tra esito e assegnazione, aggiornamento dei protocolli e possibilità di rivalutazione.

In un quiz, diffidare delle risposte assolute: «un parametro normale esclude l'urgenza», «il dolore più intenso ha sempre precedenza» o «il codice non cambia dopo l'assegnazione». La priorità nasce dall'insieme e resta dinamica.

FRAGILITÀ, DOLORE E PRESENTAZIONI NON TIPICHE

Età, gravidanza, disabilità, comorbidità, terapia in corso e difficoltà comunicative possono modificare rischio e presentazione. Una persona anziana può mostrare confusione o perdita funzionale prima di un sintomo classico; una persona con disabilità può avere un basale diverso da quello presunto dall'operatore. Il triage deve cercare il confronto con il funzionamento abituale senza trasformare la fragilità in un'etichetta automatica.

Il dolore è un dato rilevante e richiede valutazione, ma la sua intensità non è l'unico criterio di priorità. Sede, esordio, andamento, sintomi associati, rischio e condizioni generali modificano il significato. Allo stesso tempo, l'incapacità di esprimere il dolore non equivale alla sua assenza: osservazione, scale appropriate e informazioni di chi conosce la persona possono contribuire.

Barriere linguistiche, sensoriali o cognitive richiedono strumenti adeguati e comunicazione accessibile. Un familiare può offrire informazioni utili, ma la relazione con la persona e la riservatezza non vengono automaticamente trasferite al caregiver. L'organizzazione deve prevedere come raccogliere dati senza produrre ritardi pericolosi.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il triage è valutazione di priorità, non diagnosi definitiva. Integra sintomo, parametri, rischio, fragilità e possibile evoluzione. L'ordine di arrivo non governa l'accesso clinico. La rivalutazione può modificare la priorità. Codici, tempi e percorsi appartengono al sistema vigente della struttura.

9.4 Team dell'emergenza, comunicazione e sicurezza

ATTIVAZIONE, RUOLI E LEADERSHIP

L'emergenza richiede una risposta di squadra. L'allerta deve identificare luogo, tipo di evento, condizioni note e risorse necessarie. Nel team, leadership e ruoli chiari riducono sovrapposizioni e omissioni. Chi coordina mantiene una visione complessiva; gli altri dichiarano ciò che eseguono e riferiscono l'esito.

Le competenze cambiano tra infermiere, ostetrica, fisioterapista, medico e altri operatori. Un fisioterapista che osserva deterioramento durante un trattamento interrompe, mette in sicurezza e attiva il percorso previsto; non prosegue l'esercizio né assume funzioni non attribuite. L'ostetrica applica il proprio campo nel percorso nascita e chiama precocemente il team quando la situazione supera la fisiologia o richiede risposta multiprofessionale.

DETERIORAMENTO DURANTE UNA PRESTAZIONE RIABILITATIVA

La valutazione funzionale non elimina il rischio clinico. Durante esercizio, mobilitazione o trattamento possono comparire dispnea, dolore toracico, alterazione della coscienza, deficit neurologico improvviso, instabilità o sintomi diversi dal quadro atteso. Il fisioterapista deve conoscere il basale, le limitazioni, i criteri di interruzione e il percorso di allerta del setting.

Riconoscimento e sicurezza guidano la risposta: interrompere l'attività, proteggere la persona, richiedere aiuto, comunicare esordio e dati osservati, collaborare secondo competenza e documentare. Completare la seduta o attribuire automaticamente il sintomo allo sforzo esporrebbe la persona a un rischio. La ripresa richiede una nuova valutazione e le indicazioni professionali pertinenti.

COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE E HANDOVER

In emergenza la comunicazione deve essere chiusa: chi riceve ripete l'informazione critica o conferma l'azione, e chi l'ha data verifica la corretta comprensione. Farmaci, dispositivi e passaggi ad alto rischio richiedono i controlli previsti dal protocollo.

La documentazione registra tempi, dati, allerta, interventi, risposta e trasferimento. Non deve ostacolare l'assistenza immediata, ma va completata con accuratezza. L'handover finale collega evento, stato attuale, rischi residui e piano successivo.

Il debriefing ricostruisce ciò che è accaduto per apprendere e migliorare. Non è una ricerca sommaria del colpevole: analizza comunicazione, risorse, ambiente, decisioni e fattori di sistema.

FATTORI UMANI ED ERRORI COGNITIVI

Sotto pressione, attenzione e memoria di lavoro si riducono. Il team può fissarsi sulla prima ipotesi, trascurare un dato discordante o continuare un piano nonostante il cambiamento. Checklist, verbalizzazione dei dati, rivalutazione e possibilità di esprimere un dubbio servono anche a contrastare questi errori.

Tre distorsioni sono utili per l'esame:

- ancoraggio: restare legati alla prima interpretazione;
- chiusura prematura: smettere di cercare alternative troppo presto;
- normalizzazione: considerare abituale un segno anomalo perché ricorre spesso.

Il correttivo consiste nel tornare ai dati, verificare la risposta, ascoltare il dubbio del team e cercare l'informazione che contraddice l'ipotesi corrente. Moltiplicare gli esami senza criterio non risolve l'errore. Una leadership efficace permette a ogni componente di segnalare un rischio senza attendere il proprio turno gerarchico.

INFORMAZIONE, CONSENSO E DIGNITÀ

L'urgenza non annulla la persona. Quando le condizioni lo consentono, l'operatore spiega in modo breve ciò che sta accadendo, che cosa sta per fare nel proprio ruolo e perché è necessario coinvolgere altri professionisti. La legge 219/2017 colloca informazione, consenso e comunicazione nella relazione di cura; l'applicazione al caso concreto dipende da capacità, condizioni, rappresentanza e quadro organizzativo.

Se la persona non può comunicare o decidere, il team applica le regole previste senza inventare una volontà. La presenza di un familiare non autorizza automaticamente la diffusione di ogni informazione. Anche durante un evento critico restano importanti privacy possibile, rispetto del corpo, linguaggio professionale e comunicazione successiva con la persona o chi ne ha titolo.

Nei casi concorsuali, evitare conclusioni medico-legali assolute. È più corretto dichiarare: «garantisco le misure urgenti previste dal mio ruolo, attivo il team e applico la disciplina del consenso e della rappresentanza secondo condizioni e procedura, documentando il percorso».

PREPARAZIONE ORGANIZZATIVA

La preparazione precede l'evento. Controlli delle attrezzature, disponibilità dei dispositivi, farmaci gestiti secondo procedura, numeri di chiamata, percorsi di accesso e formazione del personale riducono ritardi evitabili. La sola presenza di un carrello o di un defibrillatore non dimostra la prontezza del servizio: contano integrità, collocazione, manutenzione e conoscenza del loro impiego.

Briefing e simulazioni fanno emergere problemi che una lezione teorica non mostra: rumore, spazi, ruoli sovrapposti, comunicazioni incomplete e difficoltà di trasferimento. In un quesito organizzativo, il candidato deve collegare competenza individuale e affidabilità del sistema.

La sicurezza continua dopo l'evento. Ripristino dei materiali, segnalazione di anomalie, documentazione e sostegno al team preparano la risposta successiva. L'audit distingue ciò che dipende dalla condotta individuale da ciò che richiede un cambiamento organizzativo.

Un quesito può chiedere che cosa controllare senza richiedere l'uso dell'attrezzatura. Vanno considerati disponibilità, integrità, scadenze quando pertinenti, alimentazione, accessori, collocazione e avvenuta manutenzione. Per farmaci e dispositivi, preparazione e verifica seguono le responsabilità del profilo e le raccomandazioni di sicurezza; conoscere il nome non autorizza l'impiego.

9.5 Arresto cardiaco nell'adulto: quadro BLS e ALS

RICONOSCIMENTO E ALLERTA

La linea guida ISS-SNIG sulla gestione dell'arresto cardiaco, area BLS, aggiornata a giugno 2026, fornisce il riferimento nazionale corrente del corpus. Il riconoscimento rapido e l'allerta dei servizi di emergenza avviano la risposta. Sicurezza, valutazione prevista, chiamata di aiuto e disponibilità del defibrillatore appartengono all'organizzazione della catena.

Il BLS riguarda il supporto di base. L'ALS aggiunge competenze, valutazioni e interventi avanzati, incluse gestione dei ritmi, defibrillazione manuale, vie aeree, accessi, farmaci, cause reversibili e cure post-rianimazione. Le linee ERC 2025, tradotte e adattate da IRC, sostengono questo quadro ma non definiscono da sole le attribuzioni professionali italiane o il protocollo locale.

La combinazione da riconoscere è mancata risposta e respirazione assente o anormale. Il gasping, cioè respiri agonici irregolari, non è respirazione normale e non rassicura. Si attiva subito il sistema di emergenza; la valutazione non deve trasformarsi in un'attesa della certezza diagnostica. Il supporto di base comprende compressioni toraciche, ventilazioni secondo formazione e contesto e uso precoce del DAE seguendo le istruzioni. Durante analisi ed eventuale scarica occorre impedire il contatto con la persona.

L'ALS distingue due gruppi: fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso, defibrillabili; asistolia e attività elettrica senza polso, non defibrillabili. «Non defibrillabile» non significa non trattabile: proseguono rianimazione, trattamento avanzato e ricerca della causa. Le cause reversibili includono ipossia, ipovolemia, alterazioni metaboliche ed elettrolitiche, ipotermia, trombosi coronarica o polmonare, tamponamento cardiaco, pneumotorace iperteso e tossici. Il team le ricerca sulla base del contesto, senza ritardare il supporto.

Caso. Un adulto crolla, non risponde e presenta pochi respiri irregolari. Il gasping non permette di concludere che respiri normalmente: la risposta corretta riconosce il sospetto arresto, attiva aiuto e DAE e avvia il supporto previsto. Se il DAE non consiglia la scarica, non si conclude che l'emergenza sia cessata: si seguono le istruzioni e si continua la risposta.

DAL SUPPORTO DI BASE ALLA RISPOSTA AVANZATA

I livelli hanno funzioni e confini differenti:

- il riconoscimento e l'allerta attivano il sistema;
- il supporto di base mantiene la risposta iniziale secondo formazione;
- il team avanzato integra monitoraggio, decisioni e trattamenti;
- le cure post-evento proseguono valutazione, stabilizzazione e trasferimento.

Il manuale non riporta frequenze, energie, farmaci o dosi. Questi dettagli devono essere appresi nei corsi e nelle linee vigenti, provati in simulazione e applicati secondo competenza. In prova, una risposta forte chiarisce priorità, team, sicurezza, continuità e limiti.

Livello	Funzione	Confine da ricordare
Riconoscimento e allerta	identifica l'evento e attiva la catena	non richiede attendere una diagnosi completa
BLS	sostiene la risposta iniziale e la defibrillazione prevista	non coincide con il supporto avanzato
ALS	integra ritmo, vie aeree, farmaci, cause reversibili e decisioni avanzate	richiede competenze, team e protocollo
Post-rianimazione	prosegue stabilizzazione, monitoraggio e trasferimento	l'evento non termina con il ritorno della circolazione

Le cause reversibili appartengono al ragionamento avanzato perché ricordano che l'arresto può derivare da condizioni trattabili. Nel capitolo non vengono trasformate in una checklist terapeutica: servono a comprendere la funzione dell'ALS e la necessità di un team capace di integrare dati e interventi.

La defibrillazione aiuta a comprendere un'altra distinzione essenziale. La disponibilità di un defibrillatore e l'attivazione precoce della catena non rendono equivalenti defibrillazione automatizzata e gestione manuale avanzata. Dispositivo, analisi del ritmo, decisione, sicurezza e competenze cambiano secondo livello di risposta e setting. In un orale è quindi più corretto spiegare la funzione del passaggio che recitare energie o sequenze non richieste.

Il lavoro di squadra non è accessorio all'algoritmo. Chi coordina mantiene la visione d'insieme; gli altri componenti eseguono compiti definiti, confermano i messaggi critici e segnalano problemi. Il cambio di operatore, la preparazione dei materiali e la registrazione dei tempi devono ridurre interruzioni e ambiguità. Una risposta tecnicamente ricca ma priva di ruoli, comunicazione e controllo reciproco resta incompleta sul piano della sicurezza.

Nel caso intraospedaliero, il candidato deve collegare il prima, il durante e il dopo. Prima: riconoscimento del deterioramento e chiamata appropriata. Durante: supporto coerente con formazione e protocollo, integrazione del team e rivalutazione continua. Dopo: cure post-rianimazione, ricerca delle cause, monitoraggio, trasferimento e documentazione. Questa continuità evita di presentare l'arresto come un evento isolato dal percorso assistenziale.

ARRESTO EVITABILE E DETERIORAMENTO

La gestione dell'arresto comincia dalla prevenzione. Riconoscimento del deterioramento, monitoraggio, comunicazione e rapid response possono evitare alcuni eventi. NEWS2, giudizio clinico e preoccupazione dell'operatore concorrono all'allerta; nessuno è sufficiente da solo.

Anche dopo la risposta iniziale restano rischi. La persona necessita di continuità, monitoraggio, ricerca della causa, comunicazione con il servizio ricevente e documentazione. Il candidato che chiude il caso con «il paziente riprende» omette una parte decisiva: la gestione post-evento e il trasferimento sicuro.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

BLS e ALS non sono sinonimi. Il primo organizza il supporto di base; il secondo richiede risposta avanzata e competenze specifiche. Le linee guida sono versionate. Il protocollo del setting coordina ruoli e risorse. Il testo prepara al ragionamento, mentre l'esecuzione richiede addestramento certificato.

9.6 Neonato e supporto vitale

PREPARAZIONE E VALUTAZIONE INIZIALE

Il supporto vitale neonatale ha caratteristiche proprie e non è una versione ridotta dell'algoritmo adulto. Le linee ERC 2025, pubblicate in italiano da IRC nel 2026, trattano preparazione del team, controllo termico, valutazione iniziale, vie aeree, ventilazione, compressioni, farmaci, trasferimento e comunicazione con i genitori.

La preparazione anticipa l'evento: fattori di rischio, briefing, ruoli, ambiente, attrezzature e possibilità di trasferimento devono essere considerati. Dopo la nascita, valutazione e risposta seguono l'algoritmo corrente e la formazione del team.

Nel supporto neonatale, controllo termico, valutazione della respirazione e del tono, attivazione dell'aiuto e comunicazione fanno parte della sicurezza. Soglie e sequenze dipendono dalla versione applicabile e dalle competenze presenti.

La nascita comporta una transizione fisiologica; la maggior parte dei neonati non richiede rianimazione avanzata, mentre alcuni necessitano di supporto tempestivo. Per questo la preparazione deve precedere la nascita quando sono presenti fattori di rischio e restare disponibile anche quando l'evento era considerato fisiologico.

Valutazione e intervento procedono insieme nel protocollo: la risposta del neonato determina il passaggio successivo e impone rivalutazione. Questa logica è comune all'emergenza, ma strumenti e criteri sono specifici del neonato. Applicare categorie dell'adulto senza adattamento è un errore concettuale.

La differenza fisiologica centrale è l'avvio della respirazione dopo la nascita: l'aerazione dei polmoni e una ventilazione efficace sostengono il passaggio alla circolazione extrauterina. La compromissione neonatale è spesso legata a questa transizione; perciò la ventilazione ha un ruolo decisivo e non va sostituita da una trasposizione del ragionamento sui ritmi dell'adulto. Il team valuta respirazione, frequenza cardiaca e tono e controlla se il supporto produce una risposta. Il punteggio di Apgar descrive le condizioni a tempi definiti, ma non è un requisito da attendere prima di assistere un neonato compromesso.

Caso. Dopo la nascita il neonato è ipotonico e non respira efficacemente. Il candidato collega il dato a una transizione respiratoria inadeguata, richiede il team preparato, protegge dal raffreddamento e descrive la priorità del supporto ventilatorio e della rivalutazione secondo algoritmo neonatale. Aspettare il successivo punteggio di Apgar o applicare automaticamente l'algoritmo adulto sono errori di ragionamento.

TEAM, TRASFERIMENTO E FAMIGLIA

Un neonato che richiede supporto coinvolge professionisti e setting differenti. Preparazione al trasferimento, continuità e documentazione sono parte della risposta. I genitori devono ricevere informazioni appropriate e sostegno compatibile con l'emergenza; la comunicazione non viene rimandata indefinitamente perché l'evento è tecnico.

Nel team devono essere chiari chi coordina, chi valuta, chi prepara materiali, chi registra e chi comunica. I ruoli dipendono da profili e organizzazione. Il trasferimento verso un livello di cura diverso richiede stabilizzazione secondo protocollo, contatto con il servizio ricevente e handover completo.

La specificità neonatale emerge anche dalla preparazione dell'ambiente. Controllo termico, attrezzature adatte alle dimensioni del neonato, disponibilità delle competenze necessarie e previsione del trasporto non sono dettagli accessori: riducono ritardi e rendono la risposta coerente. Nella prova scritta il candidato deve quindi iniziare dal briefing e dalla verifica delle risorse, non dalla descrizione isolata di una manovra.

La valutazione iniziale non è un atto unico. Respirazione, tono, frequenza cardiaca e risposta al supporto orientano rivalutazioni successive secondo l'algoritmo vigente. Il dato va collocato nel tempo e collegato alla decisione: osservare senza dichiarare che cosa cambia produce una risposta incompleta; applicare soglie ricordate senza indicare versione, formazione e setting produce una risposta pericolosamente assoluta.

Anche il passaggio alla fase post-evento è parte della competenza. Occorre assicurare continuità del monitoraggio, protezione termica, documentazione dei tempi e degli interventi, comunicazione con il servizio ricevente e informazione ai genitori compatibile con le condizioni. Se è necessario un trasferimento, l'handover deve distinguere dati alla nascita, evoluzione, supporti applicati, risposta osservata e rischi ancora presenti.

Per l'esame, la differenza tra conoscenza ed esecuzione va dichiarata con precisione. Il candidato può descrivere finalità della preparazione, criteri generali di valutazione, necessità della ventilazione efficace, lavoro di équipe, rivalutazione e trasferimento. Non deve però trasformare il capitolo in una sequenza operativa autonoma: frequenze, rapporti, farmaci e indicazioni dipendono dalle linee ERC/IRC vigenti, dal corso specifico e dall'organizzazione. Questo limite non impoverisce la risposta; dimostra consapevolezza professionale.

Una buona risposta collega infine madre, neonato e rete dei servizi senza confondere i rispettivi percorsi. Le informazioni ostetriche rilevanti accompagnano l'handover neonatale; le condizioni del neonato non fanno perdere di vista la sorveglianza materna. Coordinare questi due piani è una responsabilità organizzativa del team, non un compito isolato affidato alla memoria del singolo operatore.

ERRORE TIPICO

Trattare il supporto vitale neonatale come il BLS adulto "in piccolo". Popolazione, transizione fisiologica, criteri, attrezzature, sequenze e competenze sono specifici; ciò che resta comune è il metodo organizzativo: preparare, riconoscere, allertare, sostenere, rivalutare e trasferire in sicurezza.

9.7 Allarmi ostetrici e risposta multidisciplinare

EMORRAGIA POST PARTUM

L'emorragia post partum è un'emergenza tempo-dipendente che richiede riconoscimento, allerta e gestione multidisciplinare. La linea guida ISS-SNLG pubblicata nel 2016 e aggiornata nel documento a ottobre 2020 tratta prevenzione, riconoscimento, trattamento, rianimazione, monitoraggio e rischio clinico.

Nella prova occorre riconoscere il cambiamento, attivare il team, sostenere la valutazione e preparare risorse secondo ruolo. Quantificazione, farmaci, dosi, procedure e sequenze seguono la linea e il protocollo vigenti e non sono riportati qui.

ECLAMPSIA, SEPSI E TROMBOEMBOLISMO

L'eclampsia è la comparsa di crisi convulsive nel contesto della malattia ipertensiva ostetrica, non spiegate da altre cause. Può manifestarsi in gravidanza, durante il parto o nel puerperio. Cefalea intensa, disturbi visivi ed epigastralgia sono segnali di allarme; non sono però necessari perché si verifichi una crisi e non sostituiscono la diagnosi differenziale neurologica e metabolica.

La sepsi materna comporta una disfunzione d'organo dovuta a infezione nel corso della gravidanza, del parto, dopo un aborto o nel puerperio. Febbre e infezione non sono sinonimi di sepsi; viceversa, l'assenza di febbre non la esclude. Alterazioni dello stato mentale, dispnea, compromissione circolatoria o riduzione della diuresi nel contesto infettivo richiedono attenzione immediata. Il tromboembolismo venoso comprende trombosi venosa profonda ed embolia polmonare: dolore e gonfiore monolaterale di un arto o dispnea improvvisa con dolore toracico orientano il sospetto, senza confermarlo da soli.

ItOSS documenta tre aree di rischio materno: eclampsia, sepsi e tromboembolismo venoso in gravidanza e puerperio. Sono condizioni differenti per fattori, presentazione e percorso, ma condividono alcuni principi: sorveglianza, riconoscimento dei segni di allarme, rapidità dell'escalation, lavoro di équipe e continuità anche dopo il parto.

Una convulsione in gravidanza o puerperio, un peggioramento associato a possibile infezione o segni compatibili con un evento tromboembolico richiedono attivazione urgente del percorso. Il candidato non deve proporre diagnosi, farmaci o dosi senza la traccia e la fonte applicabili.

Area di allarme	Nucleo concorsuale	Errore da evitare
Eclampsia	riconoscimento della convulsione nel contesto ostetrico, sicurezza e team	ridurla a una convulsione generica
Sepsi materna	possibile infezione, disfunzione, rapidità e sorveglianza materno-fetale	affidarsi a un solo parametro o score
Tromboembolismo	rischio in gravidanza/puerperio e percorso urgente	proporre autonomamente diagnosi o terapia
Emorragia post partum	perdita ematica, condizioni della donna, allerta e risposta multidisciplinare	attendere una stima perfetta prima di chiamare aiuto

Il puerperio non è una fase priva di rischio. Segni di allarme possono comparire dopo la dimissione e richiedono educazione, accesso ai servizi e continuità. Questa osservazione collega emergenza e presa in carico senza anticipare il capitolo dedicato al territorio.

DISTOCIA DI SPALLA E PROLASSO DI FUNICOLO

Nella distocia di spalla, dopo la nascita della testa una spalla rimane bloccata e occorrono manovre ostetriche aggiuntive per completare il parto. La difficoltà non va affrontata aumentando indiscriminatamente la trazione: richiede riconoscimento e intervento coordinato di personale addestrato. I rischi comprendono danno neonatale e materno.

Nel prolasso di funicolo, a membrane rotte, il cordone scende attraverso la cervice accanto o oltre la parte fetale presentata. La compressione può compromettere il flusso ematico fetale; alterazioni improvvise della frequenza cardiaca fetale dopo la rottura delle membrane rendono urgente la valutazione. La presentazione del cordone e il prolasso non sono termini intercambiabili.

Distocia di spalla e prolasso di funicolo sono emergenze ostetriche che richiedono allerta, coordinamento, ruoli chiari, comunicazione e documentazione. Le fonti disponibili comprendono una pratica regionale toscana, procedure aziendali storicizzate, un piano formativo 2026 e linee RCOG.

La loro natura mostra perché una procedura locale non diventa regola universale. Le manovre si apprendono con linee correnti, protocollo e simulazione. Nel capitolo interessano riconoscimento dell'emergenza, attivazione del team, sicurezza e tracciabilità.

In entrambi i casi, il candidato deve distinguere il riconoscimento dall'esecuzione delle manovre. Può spiegare che servono chiamata immediata, coordinamento, assegnazione dei ruoli, preparazione delle risorse, comunicazione e registrazione. Non deve colmare l'assenza del protocollo con una sequenza ricordata da una fonte locale o datata.

Il confronto fra le emergenze aiuta a costruire una risposta ordinata. Nell'emorragia il cambiamento emodinamico e la perdita ematica richiedono riconoscimento e risposta multidisciplinare; nell'eclampsia la convulsione nel contesto ostetrico impone sicurezza e attivazione immediata; nella sepsi materna occorre leggere possibile infezione, disfunzione ed evoluzione; nel tromboembolismo assumono rilievo il rischio di gravidanza e puerperio e il percorso urgente. Distocia e prolasso aggiungono la necessità di coordinamento ostetrico-neonatale e simulazione specifica.

La documentazione dell'evento sostiene continuità e audit. Deve rendere ricostruibili orario del cambiamento, dati osservati, allerta, persone coinvolte, azioni svolte nel proprio ruolo, risposta e trasferimento. Formule generiche come «emergenza gestita» non mostrano il processo; al contrario, una cronologia essenziale consente di verificare tempestività e comunicazione senza trasformare la nota in un giudizio colpevolizzante.

Anche la comunicazione con donna e familiari va collocata nel percorso. Durante la criticità deve essere compatibile con sicurezza e tempo disponibile; dopo l'evento richiede informazioni coerenti, rispetto della dignità e raccordo con chi ha titolo a riceverle. Il professionista evita rassicurazioni assolute, non anticipa conclusioni diagnostiche e segnala al team i bisogni comunicativi rimasti aperti.

In una prova pratica simulata, la risposta più solida esplicita il limite: riconosco l'allarme, chiamo il team, preparo e opero secondo ruolo e protocollo, comunico e documento; le manovre specifiche sono eseguite soltanto con formazione, simulatore e procedura vigente. Questa formula integra prudenza, capacità organizzativa e responsabilità.

ERRORE TIPICO

Recitare una manovra ostetrica senza specificare versione, competenza e protocollo. Nella prova teorica la prima risposta è riconoscere la criticità, chiamare il team e descrivere il proprio ruolo.

▣ Verifica 05.A · Casi ragionati e quiz

CASO RAGIONATO 1 — DETERIORAMENTO DELL'ADULTO

Un uomo di 68 anni, ricoverato per infezione, appare più sonnolento rispetto al turno precedente. Respira più rapidamente, risponde lentamente e presenta parametri diversi dal basale. Il punteggio NEWS2 calcolato secondo il sistema del reparto richiede attenzione, ma un valore non è disponibile.

Il cambiamento viene prima del calcolo incompleto. Occorre verificare i dati, mettere la persona in sicurezza, allertare secondo il percorso, comunicare basale e tendenza e continuare la sorveglianza. La possibile infezione e il peggioramento impongono di considerare il percorso sepsi del setting.

Passaggio	Applicazione
Riconoscimento	nuova sonnolenza, respiro modificato e parametri diversi dal basale
Priorità	rischio di deterioramento e possibile disfunzione associata a infezione
Allerta	comunicazione strutturata con richiesta di valutazione
Supporto	misure previste dal ruolo e dal protocollo
Rivalutazione	confronto ravvicinato dei dati e nuova escalation se peggiora

L'errore sarebbe attendere il parametro mancante o un punteggio definitivo prima di segnalare.

CASO RAGIONATO 2 — ALLARME OSTETRICO

Una donna nel puerperio riferisce malessere improvviso e presenta un cambiamento delle condizioni. L'ostetrica riconosce che la situazione esce dal percorso fisiologico.

Nella risposta concorsuale vanno indicati valutazione rapida, allerta del team, sicurezza, raccolta dei dati essenziali, preparazione delle risorse previste, comunicazione e documentazione. Scegliere una diagnosi tra emorragia, sepsi o tromboembolismo sulla base di informazioni insufficienti, oppure proporre farmaci e dosi, sarebbe improprio. La priorità è attivare il percorso competente e rivalutare.

CASO RAGIONATO 3 — DETERIORAMENTO DURANTE RIABILITAZIONE

Durante un trattamento, una persona manifesta improvvisa difficoltà respiratoria e ridotta capacità di rispondere. Il fisioterapista interrompe l'attività, garantisce la sicurezza, chiama aiuto e comunica l'esordio, l'attività in corso e i dati osservati. Proseguire per verificare se «passa con l'esercizio» sarebbe inappropriato.

Il caso mostra che riconoscimento ed escalation appartengono a tutti i professionisti, mentre la risposta successiva segue competenze e organizzazione.

ALLENAMENTO DA CONCORSO

QUIZ 1

Quale affermazione descrive correttamente NEWS2?

- A. Formula una diagnosi di sepsi.
- B. Sostituisce la valutazione clinica.
- C. Supporta riconoscimento, monitoraggio ed escalation secondo protocollo.
- D. Può essere ignorato se la persona non riferisce dolore.

Risposta corretta: C. Lo score organizza dati fisiologici, ma va interpretato con quadro, basale e tendenza.

Distrattore chiave: A è errata perché NEWS2 sostiene il riconoscimento del deterioramento e l'escalation, ma non formula una diagnosi di sepsi.

QUIZ 2

Nel triage, la priorità iniziale:

- A. resta invariata fino alla visita;
- B. coincide sempre con l'ordine di arrivo;
- C. deve essere rivalutata se condizioni o attesa cambiano;
- D. equivale alla diagnosi definitiva.

Risposta corretta: C. Il triage è dinamico e la rivalutazione intercetta l'evoluzione.

Distrattore chiave: B è errata perché la priorità dipende da condizioni, rischio ed evoluzione, non dall'ordine di arrivo.

QUIZ 3

Qual è la distinzione più corretta?

- A. BLS e ALS sono due nomi dello stesso livello.
- B. NLS applica senza modifiche l'algoritmo adulto.
- C. BLS, ALS e NLS hanno finalità, competenze e algoritmi distinti.
- D. La lettura del manuale sostituisce l'addestramento.

Risposta corretta: C. I tre ambiti non sono intercambiabili e richiedono formazione e protocolli specifici.

Distrattore chiave: B è errata perché il supporto vitale neonatale possiede criteri, attrezzature e algoritmo propri.

QUIZ 4

Quale comunicazione rende più sicura un'escalation per deterioramento?

- A. «Il paziente non mi convince», senza altri dati.
- B. Il solo punteggio NEWS2, senza parametri né tendenza.
- C. Situazione, contesto, dati osservati, variazione dal basale, azioni svolte e richiesta chiara.
- D. Una diagnosi definitiva formulata prima di chiamare il team.

Risposta corretta: C. La comunicazione strutturata rende visibili rischio, andamento e bisogno operativo, consentendo al destinatario di rispondere in modo proporzionato.

Distrattore chiave: A può esprimere una preoccupazione legittima, ma deve essere tradotta in dati concreti e in una richiesta esplicita.

QUIZ 5

Quale affermazione distingue correttamente BLS e ALS?

- A. L'ALS è soltanto un BLS più lungo.
- B. Il BLS organizza il supporto di base; l'ALS integra competenze e interventi avanzati, cause reversibili e cure post-rianimazione.
- C. Il ritorno della circolazione conclude sempre la gestione.
- D. Conoscere l'algoritmo autorizza qualsiasi professionista a eseguirne ogni parte.

Risposta corretta: B. I due livelli hanno finalità e requisiti diversi; l'ALS richiede team, competenze, protocollo e continuità post-evento.

Distrattore chiave: C è errata perché monitoraggio, ricerca della causa, stabilizzazione e trasferimento continuano dopo il ritorno della circolazione.

QUIZ 6

Nel supporto vitale neonatale, quale impostazione è corretta?

- A. Applicare senza adattamenti l'algoritmo dell'adulto.
- B. Attendere l'evento prima di verificare ambiente e attrezzature.
- C. Preparare team e ambiente, applicare l'algoritmo neonatale vigente, rivalutare la risposta e organizzare continuità e trasferimento.
- D. Rinviare sempre la comunicazione con i genitori alla dimissione.

Risposta corretta: C. Preparazione, specificità neonatale, rivalutazione e continuità sono parti della stessa risposta sicura.

Distrattore chiave: A è errata perché il neonato non è un adulto di dimensioni ridotte e richiede criteri e strumenti specifici.

QUIZ 7

Di fronte a un allarme ostetrico con informazioni ancora incomplete, la risposta concorsuale più solida è:

- A. scegliere subito una diagnosi e indicare farmaci e dosi;
- B. attendere una stima perfetta prima di attivare il team;
- C. riconoscere la criticità, allertare il team, raccogliere i dati essenziali, operare nel proprio ruolo, documentare e rivalutare;
- D. applicare come universale una procedura locale storicizzata.

Risposta corretta: C. Le emergenze ostetriche richiedono risposta multidisciplinare tempestiva, mentre diagnosi, trattamenti e manovre dipendono da dati, competenze e protocollo vigente.

Distrattore chiave: D è errata perché una procedura locale o datata può documentare l'organizzazione di un setting, ma non diventa una regola nazionale.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: «Come riconosce e gestisce il deterioramento clinico?»

Risposta modello: «Confronto le condizioni attuali con il basale, raccolgo e verifico i dati vitali e osservo coscienza, respirazione e perfusione. Uso lo score previsto come supporto, senza sostituirlo al giudizio clinico. Se emerge un cambiamento, metto in sicurezza, attivo l'escalation, comunico situazione, contesto, dati e richiesta, applico le misure del mio ruolo e rivaluto. Se vi è possibile infezione, considero il percorso sepsi del setting. Documento tempi, risposta e passaggio di consegne».

Follow-up: «Un punteggio non elevato esclude il rischio?» Risposta: «No. Tendenza, basale, impressione clinica e dati non inclusi possono richiedere escalation indipendentemente dal punteggio».

ERRORI E TRAPPOLE DA EVITARE

- assegnare la priorità dal solo sintomo o dall'ordine di arrivo;
- aspettare una diagnosi completa prima di allertare;
- usare NEWS2 come automatismo diagnostico;
- confondere BLS, ALS e NLS;
- riportare soglie, dosi o manovre senza versione e setting;
- proseguire un trattamento nonostante il peggioramento;
- dimenticare rivalutazione, documentazione o handover.

MINI-ESERCIZIO

Per uno scenario di deterioramento compila:

Campo	Risposta
Dato basale	
Cambiamento osservato	
Dato da verificare	
Rischio prioritario	
Team/percorso da attivare	
Comunicazione essenziale	
Azione nel proprio ruolo	
Criterio di nuova escalation	
Dato da documentare	

Checklist finale

- ho verificato sicurezza e impressione generale;
- ho distinto dato, interpretazione e diagnosi;
- ho confrontato le condizioni con il basale;
- ho motivato urgenza, emergenza o rischio evolutivo;
- ho usato lo score soltanto come supporto;
- ho indicato allerta, team e richiesta;
- ho previsto rivalutazione;
- ho distinto BLS, ALS e NLS;
- ho evitato algoritmi, soglie, farmaci, dosi e manovre non richiesti;
- ho considerato profilo, protocollo, addestramento e setting;
- ho previsto comunicazione, documentazione e handover;
- ho esplicitato quando fermarsi e chiedere supporto.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- legge 8 marzo 2017, n. 24, sicurezza delle cure e gestione del rischio;
- Ministero della Salute, linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero, 2019;
- Regione Emilia-Romagna, documento NEWS2 per il riconoscimento precoce della gravità, 2024;
- ISS-SNLG, linea guida sulla gestione dell'arresto cardiaco extra- e intraospedaliero, area BLS, aggiornamento giugno 2026;
- European Resuscitation Council, linee guida 2025 sull'ALS adulto, traduzione e adattamento Italian Resuscitation Council;
- European Resuscitation Council, linee guida 2025 sul supporto vitale neonatale, edizione italiana IRC 2026;
- ISS-ItOSS, documenti su emorragia post partum, eclampsia, sepsi materna e tromboembolismo;
- Ministero della Salute, Raccomandazione n. 6 sulla prevenzione della morte materna correlata a travaglio e parto;
- protocolli e procedure della struttura nella versione vigente.

I riferimenti indicano il quadro di studio. L'applicazione pratica richiede sempre la versione corrente, il protocollo locale, le attribuzioni professionali, l'attrezzatura disponibile e l'addestramento previsto.

Prevenzione, continuità assistenziale e presa in carico

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Obiettivo del capitolo

La qualità dell'assistenza dipende dal raccordo tra le prestazioni. La persona può attraversare ospedale, domicilio, ambulatorio, riabilitazione e servizi sociali; se informazioni, responsabilità e obiettivi non si incontrano, anche interventi corretti perdono efficacia. Prevenzione, presa in carico e continuità servono a governare questo percorso nel tempo.

Nelle prove concorsuali il tema compare in domande teoriche, casi di dimissione, scenari sulla fragilità e quesiti relativi all'organizzazione territoriale. La commissione valuta se il candidato sa distinguere i concetti, riconoscere i bisogni, individuare i nodi della rete e costruire un passaggio sicuro senza inventare procedure locali.

Al termine saprai:

- distinguere promozione della salute e prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
- spiegare il ruolo dell'educazione, della partecipazione e del consenso;
- riconoscere cronicità, multimorbilità e fragilità come condizioni diverse;
- definire presa in carico, piano individuale e percorso diagnostico terapeutico assistenziale;
- descrivere le funzioni essenziali dei nodi territoriali, compresa la Centrale operativa territoriale;
- distinguere continuità informativa, gestionale e relazionale;
- impostare una transizione assistenziale con obiettivi, informazioni, responsabilità, follow-up ed esiti;
- applicare il quadro ai diversi profili sanitari senza oltrepassarne le competenze.

Il capitolo presenta principi nazionali e un esempio regionale per mostrare come cambia l'organizzazione. Criteri di accesso, tempi, moduli, piattaforme, responsabilità operative e composizione delle équipes devono essere verificati negli atti regionali e aziendali applicabili.

Mappa BANDO

La sequenza di ragionamento è: bisogno → rischio → obiettivo → rete → piano → transizione → follow-up → esito.

Passaggio	Domanda guida	Output atteso
Bisogno	Quali problemi, capacità e preferenze presenta la persona?	quadro multidimensionale essenziale
Rischio	Quali eventi o interruzioni vanno prevenuti?	priorità motivate
Obiettivo	Quale risultato condiviso si vuole raggiungere?	obiettivi osservabili e realistici
Rete	Quali professionisti, servizi e risorse sono pertinenti?	mappa dei nodi e delle competenze
Piano	Come si coordinano interventi, tempi e responsabilità?	piano individuale o percorso applicabile
Transizione	Che cosa deve passare da un setting all'altro?	handover e documentazione essenziale
Follow-up	Chi verifica, quando e con quali segnali di allerta?	contatti, controlli e rivalutazione
Esito	Come si comprende se il percorso funziona?	indicatori clinici, funzionali e riferiti dalla persona

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Prevenire significa ridurre probabilità, impatto o conseguenze di un problema di salute. 2. Prendere in carico significa assumere responsabilità coordinate nel tempo, non prenotare una singola prestazione. 3. Il piano riguarda la persona; il PDTA organizza un percorso per una popolazione o condizione definita. 4. La continuità richiede informazioni, gestione coerente e riferimenti riconoscibili. 5. Il modello nazionale orienta; regione e azienda definiscono l'applicazione concreta.

Prevenzione e promozione della salute

PROMUOVERE SALUTE, PREVENIRE DANNO

La promozione della salute rafforza capacità, condizioni e risorse che consentono alle persone e alle comunità di esercitare maggiore controllo sulla propria salute. Non riguarda soltanto il comportamento individuale: ambiente, istruzione, reddito, lavoro, accessibilità dei servizi, relazioni e condizioni abitative influenzano le opportunità concrete di adottare scelte favorevoli.

La prevenzione interviene invece su rischi, malattie, complicanze e disabilità. Le due prospettive sono collegate. Un programma di attività fisica accessibile può promuovere benessere e partecipazione; un intervento rivolto a una popolazione a rischio può perseguire anche un obiettivo preventivo specifico.

Nel Servizio sanitario nazionale la prevenzione è insieme clinica, assistenziale, organizzativa e di popolazione. Il Piano nazionale della prevenzione 2026-2031 costituisce il quadro programmatico nazionale vigente alla data di aggiornamento del capitolo; le azioni concrete sono declinate nei piani regionali e nei programmi locali. Occorre quindi distinguere il livello dell'atto: un obiettivo nazionale non descrive automaticamente il percorso operativo della propria azienda.

PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA

Livello	Finalità	Esempio concettuale	Errore da evitare
Primaria	ridurre l'insorgenza di un problema agendo prima che si manifesti	educazione, vaccinazioni secondo programma, riduzione di esposizioni e promozione di stili di vita	confonderla con la diagnosi precoce
Secondaria	identificare precocemente una condizione o un rischio in una popolazione appropriata	programmi organizzati di screening o individuazione tempestiva	considerare ogni test uno screening
Terziaria	limitare complicanze, recidive, perdita funzionale e impatto di una condizione già presente	controllo della cronicità, riabilitazione, prevenzione delle complicanze	ridurla alla sola terapia

La classificazione descrive la finalità prevalente, non il luogo in cui si svolge l'intervento. Il territorio può ospitare attività di tutti e tre i livelli; anche l'ospedale può contribuire alla prevenzione, per esempio preparando una dimissione sicura o riducendo il rischio di infezioni correlate all'assistenza.

Uno stesso intervento può assumere significati diversi a seconda della popolazione e dell'obiettivo. L'esercizio può promuovere salute nella popolazione generale, contribuire alla gestione del rischio in gruppi selezionati o sostenere la funzione in una persona con malattia cronica. In prova la classificazione va motivata attraverso finalità e destinatari, non ricavata da una parola isolata.

PREVENZIONE INDIVIDUALE E DI COMUNITÀ

La prevenzione individuale parte dai bisogni della persona e considera anamnesi, rischio, capacità, preferenze e contesto. Quella di comunità osserva distribuzione dei problemi, determinanti, gruppi vulnerabili, accesso ai servizi e impatto degli interventi. I due piani si alimentano: i dati di popolazione orientano la programmazione, mentre l'esperienza dei servizi segnala ostacoli e bisogni emergenti.

Il professionista sanitario non trasforma ogni incontro in una lezione standard. Seleziona il messaggio pertinente, verifica che sia comprensibile e collega la raccomandazione a un percorso realmente accessibile. L'efficacia dipende anche dalla possibilità concreta di agire: indicare un servizio inesistente, un canale non aggiornato o un controllo non previsto può aumentare la frammentazione.

INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

Le infezioni correlate all'assistenza, o ICA, mostrano bene il carattere sistemico della prevenzione. Il rischio non dipende da un solo comportamento, ma dall'insieme di organizzazione, pratiche, dispositivi, ambiente, formazione, sorveglianza, comunicazione e partecipazione della persona. La prevenzione coinvolge tutto il personale secondo ruolo e competenza.

La sorveglianza raccoglie, analizza e restituisce informazioni utili a riconoscere fenomeni e valutare interventi. Non coincide con una tecnica assistenziale né sostituisce le precauzioni e le procedure applicabili. Durante una transizione, il rischio infettivo richiede che informazioni pertinenti, dispositivi presenti, controlli previsti e segnali di allerta siano comunicati al servizio successivo e alla persona, senza diffondere dati eccedenti.

ERRORE TIPICO

Descrivere la prevenzione come una campagna informativa isolata. Un intervento completo specifica destinatari, bisogno, obiettivo, canale, responsabilità, accessibilità, verifica della comprensione, indicatori ed eventuale follow-up.

Educazione, partecipazione e consenso

INFORMARE NON EQUIVALE A EDUCARE

Informare significa mettere a disposizione dati e spiegazioni pertinenti. Educare richiede un processo più ampio: identificare ciò che la persona deve comprendere o saper gestire, concordare obiettivi, adattare linguaggio e strumenti, verificare l'apprendimento e riesaminare il risultato nel tempo.

Un foglio consegnato alla dimissione può essere utile, ma non dimostra che la persona abbia compreso. La verifica può chiedere di riformulare con parole proprie i passaggi essenziali: che cosa osservare, quale comportamento seguire, chi contattare e quando chiedere aiuto. Non è un esame alla persona; controlla la qualità della comunicazione del professionista.

Azione	Domanda professionale
Informare	Quali dati sono necessari per una scelta consapevole?
Educare	Quale capacità o conoscenza deve essere acquisita?
Concordare	L'obiettivo è rilevante e realistico per questa persona?
Verificare	La persona sa spiegare il piano e riconoscere i segnali importanti?
Rivalutare	Il piano funziona nel contesto reale o deve essere adattato?

ALFABETIZZAZIONE SANITARIA E ACCESSIBILITÀ

L'alfabetizzazione sanitaria comprende la capacità di trovare, comprendere, valutare e usare informazioni per decisioni di salute. Non è una caratteristica fissa né una colpa individuale: complessità del sistema, linguaggio, stress, disabilità, competenze digitali e differenze linguistiche possono rendere difficile anche un messaggio formalmente corretto.

Una comunicazione accessibile usa termini comprensibili, ordine logico, quantità sostenibile di informazioni e canali adeguati. Materiali scritti, interpreti, strumenti visivi o supporti digitali vanno scelti secondo bisogno e disponibilità. Semplificare non significa omettere rischi o alternative rilevanti; significa renderli utilizzabili.

OBIETTIVI CONDIVISI, ADESIONE E AUTOGESTIONE

L'adesione non è obbedienza passiva. Indica quanto il comportamento concordato sia compatibile con il piano condiviso e con le condizioni reali della persona. Prima di etichettare una “mancata adesione” occorre cercare ostacoli: effetti indesiderati, costi, difficoltà di accesso, orari, carico assistenziale, incomprensione, priorità familiari, ridotta capacità funzionale o convinzioni non esplorate.

L'autogestione comprende le capacità con cui una persona affronta aspetti quotidiani della propria condizione, osserva cambiamenti, usa risorse e richiede aiuto. Non trasferisce sulla persona responsabilità che spettano ai servizi. Un buon programma stabilisce ciò che può essere gestito autonomamente, ciò che richiede supporto e ciò che impone contatto o escalation.

CONSENSO, PREFERENZE E CAREGIVER

La legge 219/2017 colloca informazione, consenso e comunicazione nella relazione di cura. La persona partecipa alle decisioni, può rifiutare o revocare un trattamento nei termini previsti e deve ricevere informazioni comprensibili. Il singolo professionista contribuisce secondo competenza; non tutti i componenti dell'équipe hanno gli stessi compiti decisionali o informativi.

Il caregiver può offrire sostegno, osservazioni e continuità, ma non sostituisce automaticamente la volontà della persona. Il coinvolgimento dipende da consenso, capacità, rappresentanza applicabile e necessità assistenziali. Anche quando il caregiver è centrale, vanno rispettate riservatezza e dignità.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il familiare gestisce ogni appuntamento, può ricevere qualsiasi informazione sanitaria? No. Il ruolo pratico del familiare non crea un accesso indiscriminato. Occorre verificare volontà della persona, legittimazione, necessità e regole applicabili, condividendo solo le informazioni pertinenti.

Cronicità, multimorbidità e fragilità

TRE CONCETTI DA NON CONFONDERE

La cronicità riguarda condizioni che persistono nel tempo e richiedono monitoraggio, adattamento e spesso interventi continuativi. Non significa necessariamente disabilità grave: una persona può avere una condizione cronica ben controllata e conservare elevata autonomia.

La multimorbidità è la presenza contemporanea di più condizioni nella stessa persona. La somma di percorsi separati non risolve il problema: raccomandazioni, appuntamenti, farmaci, obiettivi e oneri possono interferire tra loro. La presa in carico deve ricomporli in un piano sostenibile.

La fragilità descrive una ridotta riserva e una maggiore vulnerabilità agli eventi stressanti. Non coincide automaticamente con età avanzata, disabilità o numero di diagnosi. Può emergere da fattori clinici, funzionali, cognitivi, psicologici, sociali e ambientali.

Concetto	Domanda centrale	Conseguenza organizzativa
Cronicità	Che cosa va seguito nel tempo?	monitoraggio e continuità
Multimorbilità	Come interagiscono più problemi e trattamenti?	priorità e coordinamento
Fragilità	Quanto è vulnerabile la persona a un cambiamento?	valutazione multidimensionale e prevenzione delle transizioni fallite

STRATIFICAZIONE E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

La stratificazione raggruppa persone o popolazioni secondo complessità, rischio o bisogno per orientare risorse e modelli di assistenza. È uno strumento programmatico e organizzativo; non sostituisce la valutazione individuale e non produce da solo un piano clinico.

La valutazione multidimensionale considera più domini: condizioni di salute, funzione, cognizione, stato emotivo, autonomia, ambiente, rete familiare, risorse sociali e obiettivi personali. Professioni e servizi contribuiscono secondo competenza. Il valore della valutazione sta nel collegare i dati a decisioni e responsabilità, non nel compilare una somma di scale.

PERSONALIZZAZIONE E RISULTATI

Personalizzare significa scegliere priorità, intensità e supporti coerenti con bisogni e preferenze. Due persone con la stessa diagnosi possono avere obiettivi diversi: mantenere autonomia, ridurre il carico del caregiver, recuperare una funzione, evitare una nuova ospedalizzazione o tornare a un'attività significativa.

Gli esiti non sono soltanto clinici. Possono riguardare funzione, partecipazione, qualità di vita, esperienza della persona, sicurezza, uso appropriato dei servizi e raggiungimento degli obiettivi concordati. Un indicatore va interpretato: misurare un contatto effettuato non dimostra, da solo, che la continuità sia stata efficace.

Presa in carico, piano individuale e PDTA

CHE COSA SIGNIFICA PRENDERE IN CARICO

La presa in carico è un'assunzione coordinata di responsabilità rispetto a bisogni che si sviluppano nel tempo. Comprende valutazione, obiettivi, pianificazione, raccordo tra soggetti, attuazione, monitoraggio e rivalutazione. Non richiede che un unico professionista svolga tutto; richiede che ruoli e passaggi siano riconoscibili e che nessun bisogno rilevante resti affidato al caso.

Una prenotazione o una prestazione possono far parte della presa in carico, ma non la esauriscono. Lo stesso vale per l'invio a un altro servizio: un rinvio senza informazioni, verifica di accesso e responsabilità del passaggio può creare una frattura. Nei casi concorsuali, formule come “si invia al territorio” sono incomplete finché non spiegano quale bisogno motiva il passaggio, quale nodo viene attivato, quali informazioni sono trasmesse e chi verifica l'esito.

La presa in carico non elimina l'autonomia della persona. Obiettivi e interventi devono essere discussi, compresi e adattati alle preferenze e alle condizioni concrete. Quando esistono rischi o limiti, vanno comunicati e documentati secondo le responsabilità professionali.

IL PIANO INDIVIDUALE

Le denominazioni variano tra servizi e territori. In termini didattici, un piano individuale traduce la valutazione della singola persona in obiettivi, interventi, responsabilità, tempi e criteri di verifica. Può assumere forme diverse, tra cui piano assistenziale individualizzato, progetto riabilitativo individuale o altri strumenti previsti dal setting.

Un piano utile contiene almeno:

1. bisogni, capacità, rischi e preferenze rilevanti;
2. priorità motivate;
3. obiettivi osservabili e concordati;
4. interventi o azioni pertinenti;
5. professionisti, servizi e altri soggetti coinvolti;
6. responsabilità e punti di contatto;
7. tempi, scadenze e condizioni di rivalutazione;
8. indicatori o criteri con cui giudicare il risultato;
9. modalità di comunicazione con persona e caregiver;
10. segnali che richiedono modifica del piano o escalation.

L'elenco non è un modulo universale. La documentazione reale segue regole, piattaforme e responsabilità dell'organizzazione. Il principio stabile è la coerenza: ogni bisogno prioritario deve condurre a un obiettivo e ogni obiettivo a un'azione verificabile.

IL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE

Nel percorso riabilitativo il progetto individuale collega valutazione funzionale, obiettivi, setting, interventi, professionisti e risultati. Il modello è bio-psico-sociale: non considera soltanto la menomazione, ma anche attività, partecipazione, ambiente e ciò che è significativo per la persona.

Il progetto definisce dove si vuole arrivare, quali risorse servono, come si misura il cambiamento e come avviene il passaggio tra setting. Una semplice lista di esercizi non assolve questa funzione. Programma e strumenti concreti richiedono valutazione professionale, evidenze applicabili e protocolli del servizio.

IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE

Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, indicato con l'acronimo PDTA, organizza per una popolazione o condizione definita una sequenza coerente di attività cliniche, assistenziali e organizzative. Collega evidenze, ruoli, snodi, tempi, documenti e indicatori nel contesto in cui viene applicato.

Il PDTA non è:

- una linea guida, perché una linea guida formula raccomandazioni basate sulle evidenze;
- il piano della singola persona, perché descrive un percorso per una popolazione definita;
- un semplice protocollo tecnico, perché comprende più fasi e più soggetti;
- un elenco rigido di prestazioni, perché deve prevedere accesso, valutazione, transizioni, eccezioni e monitoraggio;
- una regola nazionale identica in ogni azienda, perché organizzazione e risorse cambiano.

Il PDTA traduce raccomandazioni e programmazione nel contesto organizzativo, mentre il piano individuale adatta obiettivi e interventi alla persona. Il rapporto può essere rappresentato così: il percorso offre una cornice; la valutazione individua ciò che è pertinente; il piano personalizza; il monitoraggio verifica risultati e scostamenti.

Strumento	Oggetto	Domanda guida	Limite
Singola prestazione	attività circoscritta	Che cosa viene erogato ora?	non governa l'intero percorso
Piano individuale	persona concreta	Quali obiettivi e azioni sono appropriati per lei?	dipende dalla valutazione e dal setting

Strumento	Oggetto	Domanda guida	Limite
Progetto riabilitativo	funzione, attività e partecipazione della persona	Quale percorso riabilitativo conduce agli esiti concordati?	non è un catalogo di esercizi
PDTA	popolazione o condizione definita	Come si organizza un percorso coerente nel sistema?	richiede adattamento locale e revisione

INDICATORI E REVISIONE DEL PERCORSO

Un percorso deve poter essere valutato. Gli indicatori possono riguardare struttura, processo ed esito. La disponibilità di un servizio è un elemento strutturale; il completamento di un passaggio è un indicatore di processo; un cambiamento clinico, funzionale o riferito dalla persona riguarda l'esito.

Nessun indicatore, isolato, racconta tutto. Un alto numero di contatti può indicare buona accessibilità oppure frammentazione; una riduzione dei ricoveri può essere positiva soltanto se non corrisponde a ostacoli nell'accesso. La lettura deve considerare obiettivo, popolazione, qualità del dato, periodo e possibili conseguenze inattese.

DA SAPERE IN 5 RIGHE: PAI E PDTA

1. Il piano individuale parte dai bisogni di una persona concreta. 2. Il progetto riabilitativo collega funzione, partecipazione, interventi e risultati. 3. Il PDTA organizza un percorso per una popolazione o condizione definita. 4. Linea guida, PDTA e procedura aziendale hanno funzioni diverse. 5. Piano e percorso devono essere monitorati e modificati quando bisogni o risultati cambiano.

La rete territoriale e i suoi nodi

DAL LUOGO ALLA FUNZIONE

Il territorio è una rete di servizi sanitari, sociosanitari e sociali che opera in prossimità, al domicilio, in strutture intermedie e in collegamento con l'ospedale. Non coincide, quindi, con tutto ciò che si trova fuori dall'ospedale. La rete si comprende attraverso le funzioni dei suoi nodi: accesso, valutazione, coordinamento, erogazione, monitoraggio o risposta a un bisogno specifico.

Il manuale AGENAS sulla presa in carico della cronicità propone un quadro nazionale che comprende stratificazione, piani e percorsi, Case di Comunità, infermieristica di famiglia o comunità, Centrali operative territoriali, 116117, telemedicina e cure intermedie. Il disegno concreto dipende dalla programmazione regionale e dall'attuazione aziendale.

CASA DELLA COMUNITÀ

Il riferimento nazionale è il D.M. 77/2022. I suoi standard di programmazione comprendono una Casa della Comunità hub ogni 40.000–50.000 abitanti, una COT ogni 100.000 o a valenza distrettuale quando il bacino è maggiore e un Ospedale di Comunità con 20 posti letto ogni 100.000. Per l'infermiere di famiglia o comunità lo standard è uno ogni 3.000 abitanti, calcolato complessivamente nei diversi setting territoriali. Questi numeri indicano il modello da programmare: non provano che tutte le strutture siano già operative in una determinata regione.

L'infermiere di famiglia o comunità integra assistenza, prevenzione e gestione proattiva dei bisogni con gli altri professionisti. L'Ospedale di Comunità offre assistenza intermedia: favorisce dimissioni protette e previene ricoveri impropri, senza assumere la funzione dell'ospedale per acuti. Per il raccordo fra SSN, aziende, distretto e atti di programmazione, riprendi il capitolo «SSN, aziende sanitarie, atti e flussi informativi» di M-SA01.

ACCESSO ALLA CASA DELLA COMUNITÀ

La Casa della Comunità è un nodo territoriale orientato alla prossimità e all'integrazione di attività e professionisti. Può favorire accesso, valutazione, gestione della cronicità, prevenzione e raccordo con altri servizi. Non va descritta come uno sportello identico in tutta Italia né come luogo che contiene necessariamente ogni funzione sanitaria o sociale.

In una risposta concorsuale è più sicuro indicarne la funzione di nodo integrato e poi precisare che servizi, orari, équipe e modalità di accesso derivano dalla configurazione regionale e aziendale.

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

La Centrale operativa territoriale, o COT, sostiene il coordinamento delle transizioni e il raccordo tra professionisti, servizi e setting. Può facilitare tracciamento, comunicazione e attivazione dei nodi appropriati. Non “cura” direttamente ogni persona, non sostituisce la valutazione clinica e non coincide con un servizio di emergenza.

Nel modello toscano del 2023 la COT è descritta come interfaccia tra territorio e ospedale e tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali. È un esempio regionale utile per capire la funzione, non una procedura universale. In prova va qualificato come tale e confrontato con il modello richiesto dal bando.

PUNTO UNICO DI ACCESSO E 116117

Il Punto unico di accesso, spesso indicato come PUA, orienta l'accesso e può sostenere l'integrazione della valutazione quando il bisogno coinvolge più componenti. Non coincide automaticamente con la COT: il primo è centrato sull'accesso e sull'orientamento; la seconda sul coordinamento operativo e sulle transizioni, secondo l'organizzazione applicabile.

Il numero 116117 è collegato all'accesso a cure mediche non urgenti e ad altri servizi territoriali secondo l'attuazione prevista. Non sostituisce i numeri di emergenza e non va presentato con funzioni identiche in ogni territorio senza verifica.

DOMICILIO, CURE INTERMEDIE E TELEMEDICINA

Il domicilio può essere un setting di cura quando bisogni, sicurezza, risorse, abitazione e supporti lo consentono. Non è sempre la soluzione più appropriata e non deve tradursi in trasferimento del carico sui familiari. La decisione richiede valutazione e responsabilità definite.

Le cure intermedie sostengono persone che non necessitano dell'intensità ospedaliera ma non possono ancora essere gestite in sicurezza con il livello ordinario di assistenza disponibile. Funzioni, criteri e denominazioni cambiano nei sistemi regionali.

La telemedicina è una modalità di erogazione e comunicazione che può integrare monitoraggio, consulto e continuità. Non è un servizio unico né sostituisce automaticamente il contatto in presenza. Occorrono appropriatezza, consenso e informazione, competenze digitali, protezione dei dati, affidabilità tecnologica e un percorso per gestire problemi o segnali di allerta.

Nodo o modalità	Funzione prevalente	Non va confuso con
Casa della Comunità	prossimità e integrazione di attività territoriali	un ospedale ridotto o un modello identico ovunque
COT	coordinamento e transizioni	servizio che eroga ogni cura o centrale di emergenza
PUA	accesso, orientamento e integrazione della domanda	semplice centralino o COT
116117	accesso non urgente secondo attuazione territoriale	numero di emergenza
Cure intermedie	passaggio assistenziale a intensità appropriata	permanenza senza obiettivi e rivalutazione
Telemedicina	modalità digitale integrata nel percorso	sostituzione automatica di ogni visita

ERRORE TIPICO

Elencare sigle senza descrivere funzioni e raccordi. In una prova, ogni nodo va collegato a bisogno, accesso, responsabilità, informazione trasmessa e risultato atteso.

Continuità e transizioni assistenziali

TRE DIMENSIONI DELLA CONTINUITÀ

La continuità assistenziale è la coerenza dell'esperienza di cura nel tempo e tra soggetti diversi. Non richiede che la stessa persona eroghi ogni intervento, ma che il percorso sia comprensibile, coordinato e capace di conservare le informazioni necessarie.

Dimensione	Significato	Segnale di interruzione
Informativa	dati essenziali disponibili, aggiornati e comprensibili a chi deve usarli	documenti mancanti, informazioni discordanti, persona costretta a ricostruire tutto
Gestionale	interventi, tempi e responsabilità coerenti tra servizi	duplicazioni, vuoti, indicazioni incompatibili, nessun referente del passaggio
Relazionale	presenza di riferimenti riconoscibili e fiducia nel percorso	persona disorientata, contatti anonimi, ripetuti cambi senza spiegazione

Le tre dimensioni si influenzano. Un documento completo non garantisce continuità se nessuno attiva il servizio successivo; un referente disponibile non può coordinare senza informazioni affidabili; una sequenza formalmente corretta può fallire se la persona non comprende che cosa accadrà.

PREPARARE DIMISSIONE E TRASFERIMENTO

La dimissione è una transizione, non l'ultimo atto amministrativo del ricovero. La preparazione dovrebbe iniziare quando emergono bisogni successivi: capacità di gestione, supporto familiare, mobilità, terapia, dispositivi, condizioni abitative, accesso ai servizi, controlli e segnali di allerta.

Una preparazione ordinata segue sei domande:

1. qual è la situazione attuale e che cosa è cambiato;
2. quali bisogni restano attivi dopo il passaggio;
3. che cosa può gestire la persona e quale supporto serve;
4. quale servizio o professionista deve intervenire;
5. quali informazioni, documenti e risorse devono accompagnare il passaggio;
6. chi verifica che il contatto o il follow-up siano avvenuti.

Dimettere in sicurezza non significa trattenere chiunque finché ogni problema sociale sia risolto. Significa riconoscere i rischi, attivare i percorsi disponibili, chiarire i limiti e documentare decisioni e comunicazioni.

HANDOVER E DOCUMENTAZIONE

L'handover è il trasferimento strutturato di informazioni e responsabilità tra professionisti o servizi. Deve essere selettivo: troppe informazioni non ordinate possono nascondere quelle decisive. Dati identificativi, situazione attuale, bisogni, rischi, interventi in corso, risultati, controlli e azioni richieste devono essere pertinenti al destinatario e al passaggio.

La comunicazione verbale può essere necessaria nei casi complessi, ma non sostituisce la documentazione prevista. Allo stesso modo, inviare un documento non dimostra che il destinatario lo abbia ricevuto, compreso o preso in carico. I sistemi organizzativi devono prevedere conferma, tracciamento o altra modalità coerente con il rischio e con la procedura.

Riservatezza e minimizzazione restano valide durante la continuità. Si condividono le informazioni necessarie con soggetti legittimati e tramite canali appropriati. Proteggere i dati non significa interrompere la comunicazione clinico-assistenziale necessaria; significa governarla correttamente.

RICOGNIZIONE E RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA

Le transizioni aumentano il rischio di discrepanze nella terapia. La ricognizione raccoglie in modo accurato le informazioni sui medicinali e altri prodotti assunti. La riconciliazione confronta queste informazioni con quanto prescritto nel nuovo passaggio, identifica differenze e sostiene una decisione documentata da parte dei soggetti competenti.

I due processi non coincidono con la semplice copia di un elenco. Richiedono fonti informative, chiarimento delle discrepanze, comunicazione alla persona e trasferimento delle indicazioni pertinenti. Ruoli, moduli e sequenze seguono la raccomandazione ministeriale e la procedura aziendale corrente; il capitolo non assegna a un profilo decisioni che non gli competono.

FOLLOW-UP, ADERENZA E RIVALUTAZIONE

Il follow-up verifica andamento, comprensione, accesso ai servizi, comparsa di problemi e necessità di modificare il piano. Un appuntamento programmato è soltanto una parte: occorre sapere chi lo effettua, con quale obiettivo, quali dati servono e che cosa accade se la persona non si presenta o peggiora.

La mancata presentazione non va interpretata subito come disinteresse. Può segnalare difficoltà organizzative, economiche, cognitive, linguistiche, digitali o familiari. Individuare l'ostacolo consente una risposta più appropriata e riduce disuguaglianze.

La rivalutazione confronta situazione attuale, obiettivi e risultati. Se i bisogni cambiano, cambiano anche intensità, setting, interventi o priorità. Un piano che non può essere modificato non è personalizzato: è un adempimento statico.

FRAMMENTAZIONE E SICUREZZA

La frammentazione compare quando ogni soggetto svolge la propria parte senza una visione condivisa. I segnali tipici sono ripetizione di esami o valutazioni, indicazioni discordanti, farmaci non chiariti, caregiver sovraccarico, appuntamenti incompatibili, assenza di un contatto e accessi urgenti evitabili.

Le contromisure non consistono nel creare un unico responsabile di tutto. Servono obiettivi comuni, ruoli espliciti, informazioni accessibili, punti di contatto, gestione delle eccezioni e verifica dell'esito. La responsabilità resta distribuita secondo competenze, ma il percorso deve apparire unitario alla persona.

DA SAPERE IN 5 RIGHE: TRANSIZIONE SICURA

1. La dimissione si prepara prima del passaggio. 2. Handover significa trasferire informazioni e responsabilità pertinenti. 3. La riconciliazione affronta le discrepanze di terapia nelle transizioni. 4. Persona e caregiver devono conoscere piano, contatti e segnali di allerta. 5. Il follow-up verifica accesso, andamento ed eventuale necessità di modifica.

Applicazione ai profili professionali

INFERMIERE

Il profilo infermieristico comprende assistenza preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, identificazione dei bisogni, pianificazione, gestione e valutazione, educazione e collaborazione. Nella continuità l'infermiere contribuisce a valutare bisogni assistenziali, preparare la persona, documentare, comunicare con la rete e verificare gli esiti secondo organizzazione e responsabilità.

In un caso concorsuale, una risposta forte non si limita a “educare il paziente”. Specifica bisogno educativo, capacità, obiettivo, contenuto, modalità, verifica della comprensione, coinvolgimento del caregiver e follow-up. Terapia e riconciliazione vanno trattate secondo responsabilità professionali e procedura.

OSTETRICA/O

L'ostetrica/o opera nella continuità del percorso nascita, dalla gravidanza al puerperio e all'assistenza al neonato nelle aree di competenza. Informazione, educazione, sostegno, prevenzione, riconoscimento del rischio e raccordo con i servizi sono centrali.

La linea guida ISS-SNLG sulla gravidanza fisiologica sostiene organizzazione dell'assistenza e comunicazione; la linea guida OMS sul postnatale considera valutazione, contatti, dimissione, allattamento, salute mentale e accesso. In prova bisogna distinguere fisiologia, segni che richiedono valutazione e percorso locale, senza inventare frequenze, controlli o criteri clinici.

FISIOTERAPISTA

Il fisioterapista integra valutazione funzionale, programma o progetto riabilitativo, interventi, verifica e collaborazione. La continuità riguarda passaggi tra fase acuta, riabilitazione, territorio e domicilio, mantenendo obiettivi funzionali, informazioni sugli ausili, capacità della persona e indicatori di risultato.

La risposta deve mostrare valutazione bio-psico-sociale, obiettivi significativi, scelta del setting, coordinamento, educazione all'autogestione e rivalutazione. La sola tecnica non rappresenta il percorso riabilitativo. Scale, esercizi e protocolli specifici richiedono una fonte applicabile e una verifica professionale.

TPALL

Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro agisce su rischi collettivi, ambienti, sicurezza, igiene e vigilanza secondo attribuzioni. Nel capitolo il raccordo riguarda la funzione preventiva e la capacità di collegare osservazioni, fattori di rischio, servizi competenti, comunicazione e monitoraggio.

Non va trasformato in gestore del piano clinico individuale. I procedimenti ispettivi, il campionamento, gli atti e le sanzioni appartengono al verticale dedicato. Qui interessa la distinzione tra prevenzione sulla persona, prevenzione nella comunità e controllo dei determinanti ambientali o lavorativi.

OPERATORE SOCIOSANITARIO

L'operatore sociosanitario può contribuire alla continuità attraverso attività attribuite, osservazione, assistenza quotidiana e comunicazione tempestiva dei cambiamenti. Può rinforzare indicazioni già definite dall'équipe nei limiti del proprio ruolo, ma non formula autonomamente piani clinico-assistenziali né modifica prescrizioni.

Durante un passaggio, le osservazioni su autonomia, alimentazione, eliminazione, mobilità, comportamento e capacità di gestione possono essere rilevanti. Devono essere comunicate con dati concreti, evitando diagnosi o interpretazioni fuori competenza.

Caso guidato: dimissione di una persona fragile

SCENARIO

La signora Elena, 78 anni, vive sola. È ricoverata dopo un episodio acuto ora stabilizzato. Presenta due condizioni croniche, riduzione della mobilità rispetto al periodo precedente e difficoltà nel ricordare alcune indicazioni. La figlia abita in un altro comune e può essere presente solo in determinati giorni. Prima della dimissione risultano previsti un controllo, una rivalutazione della terapia e la prosecuzione del percorso riabilitativo. Elena desidera rientrare a casa, ma non sa chi contattare se incontra difficoltà.

La traccia chiede di impostare la continuità assistenziale senza scegliere una terapia né inventare l'organizzazione territoriale.

1. BISOGNI E CAPACITÀ

L'analisi parte dai dati disponibili e da quelli mancanti. Occorre chiarire autonomia nelle attività quotidiane, mobilità, cognizione, comprensione del piano, condizioni dell'abitazione, rete di supporto, terapia effettivamente assunta, servizi già attivi e preferenze. La volontà di rientrare a casa è un elemento del progetto, non la conclusione automatica della valutazione.

2. RISCHI PRIORITARI

I rischi derivano dall'interazione tra condizioni: discrepanze di terapia, caduta, mancato accesso al controllo, interruzione della riabilitazione, incomprensione dei segnali di allerta e sovraccarico della figlia. Non si attribuisce una diagnosi nuova; si identificano i punti che possono compromettere la transizione.

3. OBIETTIVI

Gli obiettivi iniziali sono comprensibili e verificabili: rientro nel setting appropriato, terapia chiarita dai professionisti competenti, primo contatto territoriale definito, continuità riabilitativa organizzata, conoscenza di contatti e segnali di allerta, coinvolgimento sostenibile della figlia con consenso di Elena.

4. RETE E PIANO

Il team individua i nodi previsti dall'organizzazione: professionista referente del passaggio, servizio territoriale, eventuale COT o PUA, riabilitazione, medico e altri soggetti pertinenti. Non basta scrivere “attivare la COT”: bisogna motivare la funzione richiesta, verificare criteri e canale e chiarire chi invia la segnalazione.

Il piano specifica azioni, responsabilità, tempi, informazioni da trasmettere e modalità di verifica. Per la terapia si eseguono ricognizione e riconciliazione secondo procedura. Per la mobilità si trasferiscono valutazione, obiettivi e indicazioni pertinenti al servizio riabilitativo. Per la figlia si concordano compiti realistici, senza trasformarla nell'unica garanzia del percorso.

5. EDUCAZIONE E CONSENSO

Elena riceve informazioni ordinate: che cosa è cambiato, che cosa deve fare, quali appuntamenti sono previsti, chi contattare e quali segnali richiedono aiuto. La comprensione viene verificata chiedendole di riformulare il piano. Il coinvolgimento della figlia avviene con il consenso e nel rispetto della riservatezza.

6. TRANSIZIONE E FOLLOW-UP

L'handover trasferisce al servizio successivo situazione, bisogni, rischi, obiettivi, terapia riconciliata, stato funzionale, appuntamenti e azioni richieste. La dimissione documenta ciò che è stato attivato e ciò che resta da verificare. Il follow-up controlla accesso, comprensione, andamento e necessità di adattare il piano.

SOLUZIONE SINTETICA DA PROVA

NOTA

Imposterei il caso come transizione multidimensionale. Valuterei autonomia, cognizione, mobilità, terapia, abitazione, rete e preferenze; identificarei i rischi di interruzione; concorderei obiettivi realistici; attiverei i nodi territoriali previsti, motivandone la funzione; assicurerei riconciliazione, handover, educazione e documentazione; definirei referente, contatti, follow-up e criteri di rivalutazione. Il modello concreto dipende dall'organizzazione regionale e aziendale.

PERCHÉ LA RISPOSTA È FORTE

La soluzione non promette un servizio non verificato, non delega tutto alla famiglia e non trasforma la COT in erogatore universale. Collega dati, rischi, obiettivi, rete, responsabilità, informazione ed esito.

Micro-scenari per profilo

CONTINUITÀ NEL PUERPERIO

Una donna viene dimessa con il neonato dopo un decorso fisiologico. Una risposta completa considera informazioni comprensibili, sostegno, alimentazione del neonato, benessere materno, rete, contatti postnatali e riconoscimento dei segnali di allarme. Non definisce controlli universali né tratta una difficoltà come diagnosi senza valutazione. L'ostetrica/o contribuisce secondo competenza e collega la donna ai servizi previsti dal territorio.

PASSAGGIO RIABILITATIVO

Una persona conclude una fase riabilitativa intensiva e prosegue al domicilio. Il passaggio deve conservare stato funzionale, obiettivi raggiunti e residui, ausili, rischi, capacità di autogestione, programma applicabile, criteri di verifica e contatti. Copiare soltanto il nome della diagnosi non sostiene la continuità; trasmettere una lista di esercizi senza valutazione e responsabilità espone a errore.

RISCHIO INFETTIVO NELLA TRANSIZIONE

Una persona con un dispositivo prosegue l'assistenza in un altro setting. La continuità richiede informazioni pertinenti sul dispositivo, osservazioni, controlli previsti, responsabilità, precauzioni e segnali che impongono contatto. Le modalità tecniche seguono la procedura corrente. Il caso verifica se il candidato collega prevenzione delle ICA, documentazione, educazione e handover.

Errori e trappole da evitare

1. Confondere prevenzione secondaria con ogni esame. Lo screening riguarda una popolazione e un programma definiti; un accertamento diagnostico risponde a un quesito clinico individuale.
2. Usare “presa in carico” come sinonimo di prenotazione. Il concetto comprende responsabilità, coordinamento, tempo e verifica.
3. Presentare il PDTA come linea guida. La linea guida formula raccomandazioni; il PDTA le contestualizza in un percorso organizzato.
4. Confondere COT, PUA e Casa della Comunità. Sono nodi con funzioni diverse e configurazione territoriale.
5. Scrivere “dimissione protetta” senza descrivere protezioni reali. Servono bisogni, rete, informazioni, responsabilità, contatti e follow-up.
6. Delegare la continuità al caregiver. Il caregiver è una risorsa, non il sostituto automatico dei servizi.
7. Considerare la non adesione una colpa. Vanno esplorati comprensione, accesso, fattibilità e preferenze.
8. Trasferire tutti i dati disponibili. La continuità richiede informazioni pertinenti, corrette e condivise tramite canali legittimi.
9. Generalizzare un modello regionale. Un esempio toscano dimostra una possibile applicazione, non l'assetto di ogni regione.
10. Dimenticare la rivalutazione. Bisogni e condizioni cambiano; piano e setting devono poter essere adattati.

Quiz ragionati

QUIZ 1

Quale affermazione descrive meglio la prevenzione secondaria?

- A. Riduce soltanto le complicità di una malattia già diagnosticata.
- B. Identifica precocemente una condizione o un rischio in una popolazione appropriata.
- C. Coincide con qualsiasi esame richiesto a una persona sintomatica.
- D. Riguarda esclusivamente campagne svolte fuori dall'ospedale.

Soluzione: B. La prevenzione secondaria mira all'individuazione precoce secondo popolazione, obiettivo e programma. A descrive soprattutto la prevenzione terziaria; C confonde screening e diagnosi; D attribuisce il livello al luogo invece che alla finalità.

QUIZ 2

Qual è la distinzione più corretta tra piano individuale e PDTA?

- A. Il piano individuale riguarda una persona; il PDTA organizza il percorso di una popolazione o condizione definita.
- B. Il PDTA è sempre nazionale, mentre il piano individuale è sempre regionale.
- C. Il piano individuale contiene solo dati clinici; il PDTA contiene solo dati amministrativi.
- D. Sono due nomi equivalenti per una singola prestazione.

Soluzione: A. Piano e PDTA operano su livelli diversi ma collegati. Il PDTA è contestualizzato nell'organizzazione; entrambi possono integrare componenti cliniche, assistenziali e organizzative.

QUIZ 3

In un caso di dimissione complessa, quale azione dimostra continuità?

- A. Consegnare molti documenti senza verificare comprensione o destinatario.
- B. Scrivere genericamente “inviare al territorio”.
- C. Definire bisogni, nodo competente, informazioni, responsabilità, contatto, follow-up ed esito atteso.
- D. Affidare al familiare ogni coordinamento perché conosce la persona.

Soluzione: C. La continuità collega valutazione, rete, passaggio e verifica. Le altre opzioni producono sovraccarico informativo, rinvio generico o delega impropria.

QUIZ 4

Quale affermazione sulla COT è corretta?

- A. È sempre il luogo fisico in cui vengono erogate tutte le cure territoriali.
- B. Sostiene coordinamento e transizioni secondo il modello organizzativo applicabile.
- C. Sostituisce il numero di emergenza.
- D. Decide autonomamente ogni piano clinico.

Soluzione: B. La funzione centrale è il raccordo operativo. Erogazione diretta, configurazione, canali e responsabilità dipendono dal modello territoriale; la COT non sostituisce emergenza o valutazione professionale.

Domanda da commissario

Domanda: Come si garantisce la continuità assistenziale nella dimissione di una persona fragile?

Risposta efficace: si avvia una valutazione multidimensionale e si chiariscono capacità, rischi, preferenze e rete. Si definiscono obiettivi condivisi, si individuano servizi e responsabilità, si preparano handover e documentazione, si affrontano le discrepanze di terapia secondo procedura e si educano persona e caregiver. Il passaggio deve indicare contatti, segnali di allerta, follow-up e criteri di rivalutazione. Nodi e modalità concrete dipendono dall'organizzazione regionale e aziendale.

Follow-up: Qual è il ruolo della COT?

Risposta: sostenere raccordo, coordinamento e tracciamento delle transizioni secondo il modello applicabile; non sostituire la valutazione clinica né erogare necessariamente ogni prestazione.

Mini-esercizio

Leggi lo scenario: una persona con più condizioni croniche lascia l'ospedale, vive con un coniuge anziano, usa un ausilio e deve proseguire controlli e riabilitazione. Costruisci una scheda in sei colonne.

Bisogni e capacità	Rischi	Obiettivi	Nodi e responsabilità
che cosa sai e che cosa manca?	che cosa può interrompere il percorso?	quale risultato è prioritario?	chi coordina, eroga e verifica?

Bisogni e capacità	Informazioni da trasferire	Follow-up ed esiti
che cosa sai e che cosa manca?	quali dati sono pertinenti?	quando e come si rivaluta?

Regole dell'esercizio:

- non scegliere farmaci o terapie;
- non inventare servizi presenti nel territorio;
- distinguere ciò che è certo da ciò che va verificato;
- includere la volontà della persona e il ruolo sostenibile del caregiver;
- chiudere con un indicatore di processo e uno di esito.

Checklist finale

Prima di chiudere una risposta su prevenzione e presa in carico, verifica:

- ☐ ho distinto promozione della salute e livelli di prevenzione;
- ☐ ho identificato bisogni, capacità, preferenze e rischi;
- ☐ ho distinto cronicità, multimorbilità e fragilità;
- ☐ ho formulato obiettivi condivisi e verificabili;

- ☐ ho distinto prestazione, piano individuale, progetto riabilitativo e PDTA;
- ☐ ho attribuito a COT, PUA, Casa della Comunità, 116117 e telemedicina funzioni corrette;
- ☐ ho separato quadro nazionale, modello regionale e procedura aziendale;
- ☐ ho considerato continuità informativa, gestionale e relazionale;
- ☐ ho previsto handover, documentazione e protezione dei dati;
- ☐ ho collegato ricognizione e riconciliazione alla procedura competente;
- ☐ ho verificato comprensione, consenso e ruolo del caregiver;
- ☐ ho indicato contatti, segnali di allerta, follow-up e rivalutazione;
- ☐ ho rispettato competenze e confini dei profili;
- ☐ ho previsto indicatori di processo ed esito;
- ☐ ho evitato di presentare un modello locale come regola universale.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.M. 14 settembre 1994, nn. 739, 740 e 741, sui profili di infermiere, ostetrica/o e fisioterapista; D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, sul profilo TPALL.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, sicurezza delle cure e responsabilità professionale.
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219, consenso informato e relazione di cura.
- Ministero della Salute, Piano nazionale della prevenzione 2026-2031.
- Ministero della Salute, raccomandazione sulla riconciliazione della terapia farmacologica e documenti sulla sicurezza delle cure.
- AGENAS e Ministero della Salute, Logiche e strumenti gestionali e digitali per la presa in carico della cronicità, edizione acquisita 2022.
- Regione Toscana, documenti 2023 su accesso ai servizi, continuità ospedale-territorio e PDTA della persona fragile, usati come esempio regionale.
- ISS-SNLG, linea guida sulla gravidanza fisiologica, parti pubblicate dal 2023 al 2026.
- Organizzazione mondiale della sanità, linea guida 2022 sull'assistenza postnatale di donna e neonato.
- Ministero della Salute, ISS e Organizzazione mondiale della sanità, documenti sulla riabilitazione e sulla continuità fra setting.

Le fonti definiscono il quadro di studio. Prima di applicare criteri, ruoli, moduli o flussi a un caso reale o a un bando specifico, occorre controllare versione vigente, normativa regionale, atti aziendali e competenze del profilo.

Evidenze scientifiche, PICO, GRADE e applicabilità

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Obiettivo del capitolo

Trovare un articolo che confermi un'idea non risolve un dubbio professionale. Servono una domanda chiara, una ricerca proporzionata, una valutazione critica e un giudizio sul contesto. Lo stesso risultato può essere affidabile ma poco pertinente, promettente ma incerto, oppure valido in una popolazione diversa da quella della traccia.

Nei concorsi questo nucleo compare in quesiti sull'evidence based practice, sulle linee guida, sui disegni di studio, sui bias e sul metodo GRADE. Può inoltre entrare in un caso: la commissione presenta una raccomandazione o uno studio e chiede se sia applicabile a una persona, a un servizio o a un'organizzazione.

Al termine saprai:

- trasformare un problema professionale in un quesito PICO o PICOT;
- associare la domanda al disegno di studio più pertinente;
- impostare una ricerca essenziale e tracciabile;
- distinguere selezione della fonte e appraisal critico;
- riconoscere rischio di bias, confondimento, incoerenza, indirettezza e imprecisione;
- spiegare che cosa esprime la certezza delle prove secondo GRADE;
- distinguere certezza delle prove e forza della raccomandazione;
- leggere le principali dimensioni di un framework Evidence to Decision;
- motivare applicabilità, trasferibilità e aggiornamento di una raccomandazione;
- costruire una risposta concorsuale prudente, specifica e verificabile.

Il capitolo insegna il metodo. Non sostituisce una revisione sistematica, un panel di linea guida, la competenza professionale o la valutazione del caso concreto.

Mappa BANDO

La catena operativa è: problema → quesito → ricerca → selezione → appraisal → sintesi → raccomandazione → applicazione → verifica.

Passaggio	Domanda guida	Output atteso
Problema	Quale incertezza ostacola la decisione?	problema circoscritto
Quesito	Chi, quale intervento o esposizione, quale confronto, quale esito?	PICO/PICOT

Passaggio	Domanda guida	Output atteso
Ricerca	Dove e con quali termini cercare?	strategia minima documentata
Selezione	Quali fonti rispondono davvero al quesito?	criteri di inclusione pertinenti
Appraisal	Quanto sono credibili risultati e metodo?	giudizio su validità e limiti
Sintesi	Qual è il quadro complessivo delle prove?	effetto, precisione e certezza
Raccomandazione	Che cosa propone il panel e con quale forza?	direzione, forza e motivazione
Applicazione	La raccomandazione vale per popolazione e setting della traccia?	decisione motivata e cautele
Verifica	Versione e contesto sono ancora attuali?	controllo di stato e aggiornamento

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Il quesito ben formulato determina che cosa cercare e quali studi considerare. 2. Il disegno di studio non garantisce da solo qualità o pertinenza. 3. L'appraisal valuta validità, risultati e applicabilità. 4. GRADE separa certezza delle prove e forza della raccomandazione. 5. Una raccomandazione va letta con popolazione, setting, versione, valori e risorse.

Evidence based practice: che cosa significa

L'evidence based practice integra le migliori prove disponibili con competenza professionale, valori e preferenze della persona e caratteristiche del contesto. Nessuno dei quattro elementi, isolato, basta.

Le prove senza giudizio non si applicano da sole. L'esperienza senza confronto con le prove può perpetuare pratiche inefficaci. Le preferenze senza informazione non producono una scelta pienamente consapevole. Il contesto non può essere una scusa per ignorare risultati solidi, ma può modificare fattibilità, equità e modalità di attuazione.

La legge 24/2017 richiama, per gli esercenti le professioni sanitarie, le linee guida pubblicate nel Sistema Nazionale Linee Guida e, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, tenendo conto delle specificità del caso concreto. Questo quadro non trasforma la linea guida in un comando automatico. Occorre distinguere almeno cinque oggetti:

Oggetto	Funzione
Studio primario	produce dati originali su un quesito definito
Revisione sistematica	identifica, valuta e sintetizza studi con metodo esplicito
Linea guida	formula raccomandazioni attraverso un processo metodologico e multiprofessionale
Protocollo o procedura	organizza attività e responsabilità in uno specifico contesto
Decisione professionale	applica prove e raccomandazioni alla persona o situazione concreta

Una linea guida può contenere più raccomandazioni; una raccomandazione riguarda uno specifico quesito. Il protocollo locale traduce il quadro nel servizio, ma non modifica silenziosamente popolazione, benefici e rischi. La decisione finale deve restare documentabile e coerente con competenze e preferenze.

Formulare il quesito

DAL DUBBIO ALLA DOMANDA RICERCABILE

Un problema generico produce una ricerca dispersiva. “Qual è il trattamento migliore?” non chiarisce per chi, rispetto a che cosa, per quale risultato e in quale tempo. Bisogna anzitutto delimitare l'incertezza.

Prima di usare un acronimo, occorre chiedersi:

- qual è la decisione o conoscenza necessaria;
- chi è interessato;
- quale intervento, esposizione o fenomeno si vuole valutare;
- con che cosa si confronta;
- quale esito conta davvero;
- quale setting e orizzonte temporale modificano la domanda.

PICO E PICOT

PICO organizza quattro componenti:

- P — Population/Problem: popolazione o problema;
- I — Intervention: intervento o fattore di interesse;
- C — Comparison: confronto;
- O — Outcome: esito.

Quando il tempo è decisivo si aggiunge T — Time, formando PICOT. Il setting può essere specificato nella popolazione o come elemento aggiuntivo. In domande sull'esposizione, la I può essere letta come esposizione; nelle domande qualitative servono strutture diverse, perché l'obiettivo non è sempre confrontare interventi.

Esempio:

NOTA

Negli adulti con lombalgia primaria cronica seguiti in un servizio territoriale (P), un programma multiprofessionale di educazione ed esercizio (I), rispetto alla presa in carico ordinaria (C), migliora la capacità funzionale riferita dalla persona (O) a dodici settimane (T)?

Il quesito non prescrive l'intervento. Definisce ciò che si vuole cercare e misurare.

SCEGLIERE GLI OUTCOME

Un outcome è l'esito usato per valutare conseguenze positive o negative. Deve essere pertinente alla persona e alla decisione, definito in modo misurabile e osservato in un tempo coerente.

Gli outcome possono riguardare mortalità, eventi clinici, sintomi, funzione, partecipazione, qualità di vita, effetti indesiderati, esperienza, uso dei servizi o risorse. Gli outcome surrogati misurano un indicatore intermedio: possono essere utili, ma non equivalgono automaticamente a un beneficio percepibile dalla persona.

Un errore frequente è scegliere soltanto ciò che è facile misurare. Un cambiamento statisticamente rilevabile in un indicatore secondario può essere meno importante di un effetto sulla funzione o sugli eventi avversi.

QUESITI DIVERSI

Tipo di quesito	Esempio di oggetto	Disegni spesso pertinenti
Intervento	efficacia e sicurezza di un programma	studi randomizzati; revisioni sistematiche
Diagnosi	accuratezza di un test rispetto a un riferimento	studi di accuratezza diagnostica
Prognosi	probabilità di un esito nel tempo	coorti longitudinali
Eziologia/rischio	associazione tra esposizione ed esito	coorti, caso-controllo, altri osservazionali

Tipo di quesito	Esempio di oggetto	Disegni spesso pertinenti
Frequenza	distribuzione o prevalenza di un fenomeno	studi trasversali o sistemi di sorveglianza
Esperienza	vissuti, ostacoli e preferenze	studi qualitativi

La tabella non è una gerarchia rigida. Indica l'allineamento tra domanda e disegno.

ERRORI DI FORMULAZIONE

Un quesito debole presenta uno o più problemi:

- popolazione troppo ampia o indefinita;
- intervento non descrivibile;
- confronto assente quando necessario;
- outcome vago, come “stare meglio” senza misura;
- tempo incompatibile con l'esito;
- molte domande diverse fuse insieme;
- conclusione già incorporata, per esempio “intervento efficace”;
- passaggio diretto dal quesito alla prescrizione.

ERRORE TIPICO

Inserire nel PICO il risultato desiderato. “Programma efficace” non è un intervento neutro: anticipa la conclusione. Il quesito deve permettere anche una risposta negativa o incerta.

Disegni e gerarchia delle prove

STUDI OSSERVAZIONALI

Negli studi osservazionali il ricercatore osserva esposizioni e risultati senza assegnare sperimentalmente l'intervento.

Lo studio trasversale descrive una popolazione in un momento o periodo definito. È utile per prevalenza e associazioni, ma spesso non chiarisce la sequenza temporale tra esposizione ed esito.

Lo studio di coorte segue gruppi definiti dall'esposizione o da altre caratteristiche e confronta l'insorgenza degli esiti. Può sostenere domande di prognosi e rischio; richiede attenzione a perdite, misurazione dell'esposizione e confondimento.

Lo studio caso-controllo parte da persone con e senza un esito e ricostruisce esposizioni precedenti. È efficiente per eventi rari, ma è sensibile alla selezione dei controlli e alla qualità delle informazioni retrospettive.

Gli studi osservazionali non sono “prove inutili”. Per danni, prognosi, esposizioni ambientali o effetti a lungo termine possono essere i disegni più appropriati o gli unici eticamente possibili.

STUDI SPERIMENTALI

Nello studio controllato randomizzato i partecipanti vengono assegnati casualmente ai gruppi. La randomizzazione mira a rendere comparabili i gruppi rispetto a fattori noti e ignoti; non garantisce però esecuzione corretta, assenza di perdite, misurazione imparziale o reporting completo.

Mascheramento, aderenza all'intervento, gestione dei dati mancanti, analisi e selezione degli outcome influenzano l'affidabilità. Un RCT piccolo, interrotto precocemente o con molte perdite può produrre una stima molto incerta.

REVISIONI SISTEMATICHE E META-ANALISI

La revisione sistematica usa un metodo esplicito per definire il quesito, cercare gli studi, selezionarli, valutarli e sintetizzarli. La meta-analisi è una tecnica statistica che combina quantitativamente risultati sufficientemente confrontabili. Non tutte le revisioni includono una meta-analisi e non ogni combinazione numerica è appropriata.

Una revisione eredita i limiti degli studi inclusi e può aggiungerne altri: ricerca incompleta, selezione non trasparente, valutazione debole del rischio di bias o sintesi di studi troppo diversi. Il simbolo di una meta-analisi non sostituisce la lettura del metodo.

LINEE GUIDA

Una linea guida di pratica clinica non è una revisione sistematica con una conclusione aggiunta. Collega quesiti, sintesi delle prove, valori, benefici e danni, risorse, equità, accettabilità e fattibilità, attraverso un panel e un metodo dichiarato. Gestione dei conflitti di interesse, consultazione, revisione esterna e aggiornamento fanno parte della qualità del processo.

Il Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità pubblica linee guida e informazioni sul loro stato. Titolo, ente, versione e data vanno controllati sulla pagina canonica: una copia PDF isolata può non rappresentare l'ultima versione.

DISEGNO, QUALITÀ E PERTINENZA

La cosiddetta gerarchia delle prove è utile soltanto se non diventa automatismo. Un disegno collocato in alto può rispondere male a un quesito diverso, essere eseguito con errori o produrre risultati imprecisi. Un disegno osservazionale ben condotto può essere decisivo per una domanda di rischio o di prognosi.

Il controllo procede in questo ordine:

1. chiarire la domanda;
2. identificare il disegno appropriato;
3. valutare come lo studio è stato condotto;
4. interpretare risultato e precisione;
5. giudicare la pertinenza alla decisione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Uno studio randomizzato fornisce sempre prove di certezza alta? No. Il disegno può determinare un livello iniziale favorevole nel framework GRADE, ma rischio di bias, incoerenza, indirettezza, imprecisione e bias di pubblicazione possono ridurre la certezza finale.

Ricerca e selezionare le fonti

DAL PICO AI TERMINI DI RICERCA

La ricerca traduce il quesito in concetti. Non tutte le componenti PICO devono diventare parole obbligatorie: inserire confronto, outcome e tempo in ogni ricerca può escludere studi pertinenti che li descrivono con termini diversi.

Una strategia essenziale parte di solito da popolazione e intervento o esposizione. Per ogni concetto si raccolgono sinonimi, acronimi, varianti linguistiche e, quando disponibili, termini controllati della banca dati.

Esempio semplificato:

- popolazione: lombalgia cronica, chronic low back pain;
- intervento: esercizio, exercise therapy, programma multiprofessionale;
- eventuale filtro metodologico: revisione sistematica o studio randomizzato, se coerente con la fase di ricerca.

Gli operatori booleani organizzano i termini:

- OR amplia includendo sinonimi dello stesso concetto;
- AND restringe richiedendo la presenza di concetti diversi;
- NOT esclude, ma va usato con cautela perché può eliminare record pertinenti.

Virgolette, troncamenti e campi di ricerca dipendono dalla piattaforma. Una strategia corretta in una banca dati non si trasferisce automaticamente in un'altra senza adattamento.

DOVE CERCARE

La fonte dipende dallo scopo:

Esigenza	Punto di partenza ragionevole
Linea guida italiana pubblicata	catalogo SNLG e pagina dell'ente produttore
Sintesi delle prove	banche di revisioni sistematiche e database bibliografici
Studio primario	database bibliografici pertinenti alla disciplina
Atto o raccomandazione istituzionale	sito canonico dell'autorità competente
Procedura applicabile	sistema documentale dell'ente o servizio proprietario

Un motore di ricerca generale può aiutare a localizzare un documento, ma non dimostra qualità, completezza o vigenza. Un aggregatore può indicare l'esistenza di una linea guida; la verifica deve tornare alla pagina istituzionale e al documento identificato.

RICERCA SENSIBILE E RICERCA SPECIFICA

Una ricerca sensibile mira a non perdere studi pertinenti e accetta più risultati irrilevanti. Una ricerca specifica riduce il rumore, con il rischio di escludere materiale utile. La scelta dipende da scopo, tempo, risorse e conseguenze dell'errore.

Per una revisione sistematica serve una strategia ampia, documentata e spesso validata da competenze bibliografiche. Per una risposta concorsuale è sufficiente mostrare il metodo: quesito, concetti, sinonimi, fonti, criteri, periodo e verifica della versione.

SELEZIONE E TRACCIABILITÀ

I criteri di inclusione ed esclusione vanno definiti prima di conoscere i risultati, per ridurre decisioni opportunistiche. Possono riguardare popolazione, intervento, confronto, outcome, disegno, setting, lingua, periodo e tipo di pubblicazione.

La tracciabilità minima comprende:

- quesito e data della ricerca;
- fonti consultate;
- strategia o termini principali;
- filtri applicati;
- criteri di selezione;
- titolo, ente o autori, data e versione dei documenti usati;
- ragioni delle esclusioni più rilevanti.

Registrare il percorso permette aggiornamento e controllo. Non significa accumulare riferimenti: una selezione breve ma pertinente è più utile di una bibliografia lunga e indifferenziata.

ERRORE TIPICO

Fermarsi al primo risultato o cercare soltanto il titolo dell'intervento desiderato. La ricerca deve poter trovare anche risultati nulli, effetti indesiderati e alternative.

Appraisal: validità, risultati e pertinenza

LE TRE DOMANDE FONDAMENTALI

La lettura critica può essere organizzata in tre blocchi:

1. validità: il metodo riduce abbastanza il rischio di errore sistematico?
2. risultati: qual è la direzione e l'entità dell'effetto, con quale precisione?
3. applicabilità: popolazione, intervento, confronto, esiti e setting sono pertinenti?

Saltare il primo blocco conduce a interpretare numeri non affidabili. Fermarsi alla validità impedisce di capire la rilevanza dell'effetto. Ignorare l'applicabilità trasforma uno studio corretto in una risposta fuori contesto.

RISCHIO DI BIAS

Il bias è un errore sistematico che può spostare il risultato rispetto alla realtà. Non è sinonimo di imprecisione e non scompare perché il campione è grande.

Area	Problema tipico	Domanda di controllo
Selezione	gruppi non comparabili o inclusione distorta	come sono stati reclutati e assegnati i partecipanti?
Esecuzione	differenze di assistenza oltre all'intervento studiato	gruppi e operatori hanno ricevuto trattamenti aggiuntivi diversi?
Misurazione	outcome valutato in modo diverso o influenzato dalla conoscenza del gruppo	strumenti e valutatori erano adeguati?
Dati mancanti	perdite diverse o numerose	chi manca al follow-up e perché?
Reporting	pubblicazione selettiva di outcome o analisi	protocollo e risultati dichiarati coincidono?

Le denominazioni e gli strumenti specifici cambiano per disegno. Il principio resta: collegare ogni giudizio a un meccanismo con cui il risultato potrebbe essere alterato.

CONFONDIMENTO

Il confondimento si verifica quando un fattore è associato sia all'esposizione sia all'esito e altera l'associazione osservata. Per esempio, se due gruppi differiscono molto per gravità iniziale, la differenza finale può dipendere in parte dalla gravità e non dall'esposizione studiata.

Restrizione, appaiamento, stratificazione e modelli statistici possono controllare fattori misurati, ma non garantiscono l'eliminazione del confondimento residuo o non misurato. La randomizzazione ben eseguita mira a distribuire i confondenti, ma resta necessario verificare esecuzione e analisi.

EFFETTO E PRECISIONE

Una stima di effetto indica direzione e dimensione della differenza o associazione. Può essere espressa in termini relativi o assoluti. Il relativo aiuta a confrontare proporzioni; l'assoluto mostra quante persone o eventi sono coinvolti nel contesto di rischio iniziale.

L'intervallo di confidenza rappresenta l'incertezza statistica attorno alla stima secondo il modello adottato. Un intervallo ampio può essere compatibile con beneficio rilevante, effetto piccolo o assenza di differenza. Limitarsi alla significatività statistica nasconde questa informazione.

Il valore p non misura la rilevanza clinica o professionale. Un effetto può essere statisticamente compatibile con una differenza ma troppo piccolo per modificare la decisione; al contrario, un effetto potenzialmente importante può restare incerto per campione ridotto.

OUTCOME SURROGATI E COMPOSITI

Un outcome surrogato sostituisce un esito direttamente importante con un indicatore intermedio. La sua utilità dipende dalla solidità del rapporto con l'esito che interessa alla persona.

Un outcome composito unisce eventi diversi. Può aumentare il numero di eventi, ma va scomposto: il risultato complessivo può essere guidato dalla componente più frequente e meno importante. La denominazione del composito non deve nascondere differenze tra le componenti.

APPLICABILITÀ DELLO STUDIO

La validità interna chiede se il risultato è credibile nello studio. L'applicabilità chiede se quel risultato può informare la decisione della traccia. Occorre confrontare:

- caratteristiche e rischio iniziale della popolazione;
- definizione e intensità dell'intervento;
- confronto effettivamente disponibile;
- outcome e tempi;

- competenze e risorse;
- accettabilità e preferenze;
- organizzazione del setting.

Differenze non determinano automaticamente esclusione. Devono essere abbastanza importanti da modificare beneficio, danno, fattibilità o decisione.

SCHEMA DI LETTURA CRITICA

Blocco	Domande
Quesito	popolazione, intervento/esposizione, confronto e outcome sono chiari?
Disegno	è appropriato alla domanda?
Selezione	chi è entrato nello studio e chi è rimasto fuori?
Conduzione	gruppi, misure, follow-up e analisi sono adeguati?
Risultato	direzione, entità e precisione sono comprensibili?
Esiti	sono importanti per la persona? benefici e danni sono entrambi considerati?
Pertinenza	popolazione e setting corrispondono alla traccia?
Decisione	quale conclusione è sostenuta e quali cautele restano?

La scheda non produce un voto automatico. Organizza un giudizio trasparente.

GRADE e certezza delle prove

CHE COSA ESPRIME LA CERTEZZA

GRADE valuta quanto si può essere fiduciosi che la stima dell'effetto sia adeguata a sostenere una raccomandazione o decisione. La certezza viene giudicata per ciascun outcome importante, non attribuita una volta per tutte a un articolo o a un intervento.

Le categorie sono:

- alta: elevata fiducia che l'effetto reale sia vicino alla stima;
- moderata: l'effetto reale è probabilmente vicino, ma potrebbe essere sostanzialmente diverso;
- bassa: fiducia limitata; l'effetto reale può essere sostanzialmente diverso;
- molto bassa: fiducia molto limitata; la stima è altamente incerta.

Queste categorie non misurano l'importanza dell'outcome e non dicono da sole che cosa fare. Un outcome molto importante può avere prove di bassa certezza; un outcome secondario può avere prove di alta certezza.

PUNTO DI PARTENZA E GIUDIZIO FINALE

Nell'impostazione standard GRADE, gli studi randomizzati partono da una certezza iniziale più alta e gli studi osservazionali da una più bassa. Il livello finale dipende però dai domini. Non si sommano penalità in modo meccanico: il gruppo deve spiegare perché un problema è abbastanza serio da ridurre la fiducia e di quanto.

Anche il disegno va letto rispetto al quesito. Per alcuni effetti indesiderati rari o a lungo termine, gli studi osservazionali possono offrire informazioni essenziali che gli RCT non forniscono.

DOMINI CHE POSSONO RIDURRE LA CERTEZZA

Dominio	Significato	Segnale tipico
Rischio di bias	limiti nella conduzione degli studi	perdite, misure non affidabili, reporting selettivo
Incoerenza	risultati diversi tra studi senza spiegazione sufficiente	effetti in direzioni o dimensioni molto variabili
Indirettezza	prove non pienamente corrispondenti al quesito	popolazione, intervento, confronto o outcome diversi
Imprecisione	stima compatibile con decisioni differenti	intervallo ampio o pochi eventi
Bias di pubblicazione	risultati disponibili non rappresentativi di tutti gli studi condotti	piccoli studi positivi, assenza di risultati negativi attesi

Numeri diversi non dimostrano da soli incoerenza: bisogna considerare sovrapposizione degli intervalli, direzione, entità e possibili differenze cliniche o metodologiche. Anche l'indirettezza richiede un giudizio. Una differenza di età o setting conta quando può modificare l'effetto o la decisione.

POSSIBILI AUMENTI DELLA CERTEZZA

Per prove osservazionali, GRADE può considerare un aumento in circostanze specifiche, come un effetto molto grande, un gradiente dose-risposta o confondimenti plausibili che ridurrebbero l'effetto osservato. Non sono premi automatici: richiedono dati convincenti e assenza di problemi che rendano fragile l'interpretazione.

ESEMPIO SINTETICO

Quattro studi randomizzati valutano lo stesso confronto. Due presentano perdite rilevanti al follow-up; le stime variano molto; l'intervallo complessivo comprende beneficio modesto e assenza di effetto. Popolazione e outcome sono direttamente pertinenti.

La lettura corretta è:

- perdite rilevanti: possibile rischio di bias;
- variabilità non spiegata: possibile incoerenza;
- intervallo compatibile con conclusioni diverse: imprecisione;
- popolazione e outcome pertinenti: nessuna indirettezza evidente sulla base dei dati forniti.

Non è possibile assegnare un livello definitivo senza dettagli, soglie e giudizi completi. Il valore dell'esercizio consiste nell'associare ogni problema al dominio corretto e motivare l'incertezza.

ERRORE TIPICO

Sottrarre un livello per ogni criticità nominata. I domini possono sovrapporsi o non essere abbastanza seri; il giudizio deve essere motivato per outcome.

Dalle prove alla raccomandazione

CERTEZZA E FORZA NON SONO SINONIMI

La certezza riguarda la fiducia nella stima degli effetti. La raccomandazione esprime una direzione — a favore o contro un'opzione — e una forza, spesso formulata come forte o condizionata secondo il metodo adottato.

Una certezza alta non produce automaticamente una raccomandazione forte: benefici e danni possono essere bilanciati, preferenze variabili o risorse molto diverse. Una certezza bassa non impedisce in assoluto una raccomandazione, soprattutto quando il rischio di non agire è rilevante o quando altre dimensioni orientano una scelta prudente; richiede però trasparenza sull'incertezza.

Una raccomandazione forte suggerisce che, nelle condizioni specificate, la maggior parte delle persone dovrebbe ricevere l'opzione raccomandata e che sistemi e professionisti possono orientarsi in modo relativamente uniforme, salvo eccezioni motivate. Una raccomandazione condizionata segnala che scelte diverse possono essere appropriate in base a valori, preferenze, rischio, risorse o contesto.

Le parole esatte vanno lette nella linea guida: “si raccomanda”, “si suggerisce”, “considerare” e altre formule dipendono dal sistema adottato e non possono essere interpretate fuori dal documento.

EVIDENCE TO DECISION

Un framework Evidence to Decision, o EtD, rende esplicito il passaggio dalle prove alla raccomandazione. Le dimensioni possono includere:

- priorità del problema;
- benefici attesi;
- effetti indesiderati;
- certezza delle prove;
- valori e preferenze;
- equilibrio tra conseguenze favorevoli e sfavorevoli;
- risorse e costo-opportunità;
- equità;
- accettabilità;
- fattibilità.

Il panel non dovrebbe limitarsi a votare un'opinione. Registra prove, giudizi, divergenze e motivazione. La trasparenza consente al lettore di capire perché la stessa certezza può condurre a raccomandazioni diverse in contesti differenti.

VALORI, PREFERENZE ED EQUITÀ

Valori e preferenze riguardano l'importanza attribuita agli esiti e la disponibilità ad accettare benefici, rischi e oneri. Variabilità elevata favorisce spesso una raccomandazione condizionata e una decisione condivisa più attenta.

L'equità chiede se un'opzione riduce o aumenta differenze ingiuste. Un intervento efficace ma accessibile soltanto a chi possiede tecnologie, trasporto o competenze digitali può ampliare disuguaglianze. L'analisi non si esaurisce nel costo medio.

SCOSTAMENTO MOTIVATO

Applicare una linea guida richiede più della ripetizione di una frase. Occorre verificare che popolazione, condizioni e setting corrispondano. Lo scostamento può essere appropriato quando il caso presenta caratteristiche non rappresentate, controindicazioni, preferenze informate o vincoli rilevanti. Deve però essere motivato e documentato secondo responsabilità e organizzazione.

La linea guida sostiene il giudizio, non lo sostituisce. Allo stesso tempo, “il caso è diverso” non è una motivazione sufficiente: bisogna specificare quale differenza modifica il bilancio o l'applicabilità.

DA SAPERE IN 5 RIGHE: CERTEZZA E RACCOMANDAZIONE

1. La certezza riguarda la fiducia nelle stime per outcome. 2. La forza riguarda quanto uniformemente seguire una direzione proposta. 3. Benefici, danni, preferenze, risorse ed equità concorrono alla raccomandazione. 4. Una raccomandazione condizionata richiede particolare attenzione al caso. 5. Ogni applicazione deve rispettare popolazione, versione e setting.

Applicabilità e versionamento

APPLICABILITÀ E TRASFERIBILITÀ

L'applicabilità valuta se una prova o raccomandazione può essere usata nella situazione concreta. La trasferibilità considera quanto risultati ottenuti in un contesto siano plausibilmente estendibili a un altro. I termini possono essere usati con sfumature diverse, ma entrambi impongono un confronto esplicito.

Una griglia pratica considera:

Dimensione	Domanda
Popolazione	rischio, età, condizioni e bisogni sono comparabili?
Intervento	contenuto, intensità e competenze corrispondono?
Confronto	l'alternativa dello studio esiste nel servizio?
Outcome	sono importanti e misurabili nel setting?
Risorse	personale, tempo, tecnologie e costi sono sostenibili?
Equità	chi potrebbe essere escluso o svantaggiato?
Accettabilità	persone e professionisti considerano praticabile l'opzione?
Fattibilità	organizzazione e vincoli consentono l'attuazione?

La presenza di una differenza non chiude l'analisi. Occorre spiegare se e come può cambiare effetto, rischio o implementazione.

LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E AZIENDALE

Un manuale nazionale può descrivere principi e modelli. Una regione può definire reti, percorsi e assetti. L'azienda traduce tali indicazioni in procedure, responsabilità, piattaforme e moduli. Questi livelli sono collegati ma non intercambiabili.

Se un modello toscano descrive accesso e COT, un candidato di un'altra regione può usarlo come esempio di funzione organizzativa, non come flusso vigente. Dovrà verificare almeno:

- procedura corrente;
- criteri di accesso;
- ruoli e responsabilità;
- contatti e servizi disponibili;
- piattaforma e modulistica;
- tempi e flusso informativo;
- indicatori e gestione delle eccezioni.

VERSIONE E STATO EDITORIALE

Una raccomandazione non è separabile dalla sua versione. Titolo simile, PDF disponibile online e data di download non dimostrano che il documento sia vigente. Vanno registrati:

- titolo completo;
- ente produttore;
- versione o data;
- popolazione e ambito;
- pagina canonica e URL del documento;
- stato: pubblicato, aggiornato, ritirato, in revisione o in progress;
- data dell'ultimo controllo.

La linea guida ISS-SNLG sulla gravidanza fisiologica offre un esempio: le parti sono state aggiornate in anni diversi tra 2023 e 2026. Citare genericamente una vecchia edizione senza identificare la parte pertinente può attribuire attualità a contenuti superati.

Il materiale riabilitativo mostra un'altra difficoltà: piano nazionale, linea guida SNLG, documenti OMS e valutazioni HTA hanno scopi, popolazioni e date differenti. Non formano automaticamente una linea guida unica.

DIVERGENZE TRA PAGINA E DOCUMENTO

Se la pagina istituzionale segnala una versione più recente del PDF archiviato, non si sostituisce silenziosamente la fonte. Si confrontano titolo, data, versione e contenuto; si conserva traccia del documento effettivamente usato; si aggiorna il claim solo dopo verifica. Se la divergenza riguarda una regola operativa e non può essere risolta, il claim va sospeso o qualificato.

Una procedura locale priva di data certa richiede verifica presso l'ente proprietario. La sola presenza in una cartella o su una intranet non ne dimostra la vigenza.

ERRORE TIPICO

Considerare “online” sinonimo di “vigente e applicabile”. La verifica riguarda autorità, versione, stato, popolazione e contesto.

Casi ed esercizi guidati

CASO 1 — FORMULARE IL PICO

Un servizio territoriale vuole valutare se, negli adulti con lombalgia primaria cronica, un programma multiprofessionale di educazione ed esercizio, rispetto alla presa in carico ordinaria, migliori la capacità funzionale riferita dalla persona a dodici settimane.

Elemento	Formulazione
P	adulti con lombalgia primaria cronica nel servizio territoriale
I	programma multiprofessionale di educazione ed esercizio
C	presa in carico ordinaria
O	capacità funzionale riferita dalla persona
T	dodici settimane

Prima della ricerca restano da precisare almeno criteri di inclusione, contenuto e intensità del programma, misura dell'outcome, cointerventi e caratteristiche del confronto.

Risposta sintetica da prova: formulerei un PICOT identificando popolazione, programma, confronto, outcome funzionale e tempo. Tradurrei popolazione e intervento in sinonimi e termini controllati, cercherei revisioni e studi pertinenti, quindi valuterei rischio di bias, entità, precisione e applicabilità al servizio. Il quesito non autorizza una prescrizione sul singolo caso.

CASO 2 — VALUTARE LA CERTEZZA

Dataset didattico sintetico: quattro studi randomizzati valutano lo stesso confronto. Due hanno perdite rilevanti al follow-up; le stime sono molto variabili; l'intervallo complessivo comprende beneficio modesto e assenza di effetto. Popolazione e outcome corrispondono al quesito.

Dato	Dominio da esaminare	Motivo
Perdite rilevanti	rischio di bias	i dati mancanti possono alterare la stima
Stime variabili	incoerenza	gli studi non restituiscono un quadro uniforme
Intervallo ampio	imprecisione	sono compatibili conclusioni diverse
Popolazione pertinente	indirettezza	sulla base dei dati non emerge una differenza rilevante

La conclusione prudente non assegna un livello definitivo. Mancano informazioni su ampiezza, soglie, analisi, cause dell'eterogeneità e altri domini.

CASO 3 — CERTEZZA E EVIDENCE TO DECISION

Dataset didattico sintetico: per l'opzione A la certezza sull'effetto principale è moderata, ma fattibilità, accettabilità e risorse variano tra servizi. Per l'opzione B la certezza è bassa; il panel considera un possibile beneficio in un sottogruppo e sottolinea la decisione condivisa.

La lettura corretta distingue:

- fiducia nelle stime;
- bilancio tra benefici e danni;
- variabilità di valori e preferenze;
- risorse, equità, accettabilità e fattibilità;
- caratteristiche del sottogruppo;
- forza e direzione della raccomandazione effettivamente formulata.

Non è possibile scrivere “A è raccomandata” o “B è vietata” senza il giudizio completo del panel. Il dataset serve a mostrare perché certezza e forza non sono sinonimi.

CASO 4 — APPLICABILITÀ ORGANIZZATIVA

Un gruppo dispone di un manuale nazionale sulla presa in carico, di un modello regionale toscano su accesso e COT, di un documento sulla continuità ospedale-territorio e di un PDTA regionale della persona fragile. Deve costruire un caso per un'azienda non ancora scelta.

Il quadro generale utilizzabile comprende presa in carico, integrazione, transizioni e funzioni dei nodi. Restano da verificare procedura, criteri, ruoli, contatti, piattaforma, modulistica, tempi, servizi disponibili e flussi dell'azienda.

Una nota di applicabilità corretta potrebbe essere:

NOTA

Il caso usa principi nazionali e un modello regionale come esempio organizzativo. Prima dell'impiego in uno specifico servizio vanno verificati atti regionali vigenti, procedura aziendale, responsabilità, criteri di accesso, risorse, piattaforme, modulistica e indicatori; è inoltre necessaria una revisione multiprofessionale.

CASO 5 — VERSIONE E TRACCIABILITÀ

Un capitolo cita il Manuale metodologico ISS-SNLG versione 2.0 del 2024, una linea guida con pagina istituzionale, un PDF archiviato e una procedura locale priva di data.

L'ordine dei controlli è:

1. aprire la pagina canonica e verificare stato e data;
2. confrontare pagina, PDF e citazione;
3. registrare titolo, ente, versione, URL e data di controllo;
4. verificare separatamente la procedura con l'ente proprietario;
5. descrivere eventuali divergenze;
6. sospendere il claim operativo se la divergenza non è risolta.

Quiz ragionati**QUIZ 1**

Quale componente PICO descrive l'esito rilevante?

- A. Population.
- B. Intervention.
- C. Comparison.
- D. Outcome.

Soluzione: D. L'outcome è ciò che viene misurato per valutare conseguenze dell'intervento o esposizione.

QUIZ 2

Quale affermazione sulla gerarchia delle prove è più corretta?

- A. Un RCT risponde meglio a ogni tipo di domanda.
- B. Il disegno appropriato dipende dal quesito e deve essere valutato per qualità.
- C. Gli studi osservazionali non possono informare decisioni.
- D. Una meta-analisi elimina i limiti degli studi inclusi.

Soluzione: B. Domanda, disegno, conduzione e pertinenza vanno letti insieme. Le altre risposte trasformano categorie metodologiche in automatismi.

QUIZ 3

In GRADE, quale dominio riguarda un intervallo compatibile sia con beneficio rilevante sia con assenza di effetto?

- A. Indirettezza.
- B. Imprecisione.
- C. Accettabilità.
- D. Confondimento.

Soluzione: B. L'intervallo non consente una conclusione sufficientemente stabile. Accettabilità appartiene al passaggio verso la raccomandazione, non al dominio di certezza descritto.

QUIZ 4

Perché certezza moderata non implica sempre una raccomandazione forte?

- A. Perché GRADE non considera gli effetti.
- B. Perché la forza dipende anche da benefici/danni, valori, risorse, equità, accettabilità e fattibilità.
- C. Perché soltanto gli studi osservazionali producono raccomandazioni.
- D. Perché una raccomandazione forte richiede certezza assoluta.

Soluzione: B. La raccomandazione deriva da un giudizio più ampio della sola certezza delle stime.

QUIZ 5

Un PDF è presente sul sito di un ente. Qual è il primo giudizio corretto?

- A. È certamente vigente.
- B. È automaticamente applicabile in ogni azienda.
- C. Occorre verificarne pagina canonica, versione, stato e ambito.
- D. È preferibile a ogni linea guida più recente.

Soluzione: C. Disponibilità online e vigenza non coincidono.

Domanda da commissario

Domanda: Quali passaggi segue per applicare una raccomandazione a un caso professionale?

Risposta efficace: identifico quesito, popolazione, intervento, confronto e outcome; verifico ente, versione e forza della raccomandazione; considero la certezza delle prove e il bilancio tra benefici e danni; confronto popolazione e setting con il caso; valuto preferenze, risorse, equità, accettabilità e fattibilità; infine motivo applicazione o scostamento e documento le incertezze. La raccomandazione sostiene, ma non sostituisce, il giudizio professionale.

Follow-up: Qual è la differenza tra certezza e forza?

Risposta: la certezza esprime fiducia nelle stime per gli outcome; la forza indica quanto uniformemente il panel propone una direzione, considerando anche altre dimensioni decisionali.

Mini-esercizio

Scegli un dubbio professionale non esecutivo e compila la scheda.

Campo	Risposta
Problema	quale incertezza vuoi ridurre?
PICO/PICOT	P, I/E, C, O, T
Disegno	quale disegno risponde meglio e perché?
Ricerca	due concetti, sinonimi, fonte e data
Appraisal	un rischio di bias, risultato e precisione
GRADE	quali domini richiedono attenzione?
Raccomandazione	direzione, forza e motivazione disponibile
Applicabilità	popolazione, setting, preferenze, risorse ed equità
Versione	ente, titolo, data, stato e controllo
Conclusione	che cosa puoi affermare e quale limite resta?

Regola: ogni conclusione deve citare il dato che la sostiene e dichiarare ciò che manca.

Checklist finale

- ☐ ho trasformato il problema in un quesito circoscritto;
- ☐ PICO/PICOT contiene popolazione, intervento o esposizione, confronto, outcome e tempo quando pertinente;
- ☐ ho scelto il disegno in base alla domanda;
- ☐ ho distinto studio primario, revisione, linea guida e procedura;

- ☐ la ricerca usa termini, fonti, filtri e data tracciabili;
- ☐ ho valutato validità, risultati e applicabilità;
- ☐ ho distinto bias, confondimento e imprecisione;
- ☐ ho interpretato entità e intervallo, non solo significatività;
- ☐ la certezza GRADE è riferita a un outcome;
- ☐ ho distinto certezza, direzione e forza della raccomandazione;
- ☐ ho considerato benefici, danni, valori, risorse, equità, accettabilità e fattibilità;
- ☐ ho confrontato popolazione e setting della fonte con la traccia;
- ☐ ho verificato titolo, ente, versione, stato e data;
- ☐ ho motivato applicazione o scostamento;
- ☐ ho evitato prescrizioni o conclusioni oltre i dati.

Riferimenti normativi e metodologici essenziali

- Istituto Superiore di Sanità, Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica, versione 2.0, dicembre 2024.
- Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 5, linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali.
- Istituto Superiore di Sanità, materiali metodologici su epidemiologia di base, disegni, bias e confondimento.
- ISS-SNLG, linea guida sulla gravidanza fisiologica, parti aggiornate tra 2023 e 2026, esempio di versionamento e applicazione GRADE.
- Ministero della Salute, ISS e Organizzazione mondiale della sanità, documenti riabilitativi usati come esempi di popolazione, setting e applicabilità.

Il controllo metodologico non termina con la pubblicazione del documento. Prima di usare una raccomandazione occorre verificarne stato, popolazione, forza, versione e compatibilità con il contesto professionale e organizzativo.

Igiene pubblica, epidemiologia, sorveglianza e screening

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Obiettivo del capitolo

Un dato sanitario non parla da solo. Diventa utile quando sappiamo a chi si riferisce, come è stato ottenuto, quale denominatore usa e quale decisione può sostenere. Dire che «i casi sono aumentati» o che «la copertura è bassa» non basta: occorre definire popolazione, evento, periodo, fonte, misura e limiti.

Nei concorsi questo nucleo compare in quiz su incidenza, prevalenza, sensibilità e specificità; in calcoli su percentuali e rischi; in domande su screening, sorveglianza e notifica; nelle prove pratiche che chiedono di impostare la risposta a un segnale epidemiologico. La commissione valuta sia l'esattezza del calcolo sia la prudenza dell'interpretazione.

Al termine saprai:

- distinguere rapporto, proporzione e tasso;
- scegliere numeratore e denominatore di prevalenza, incidenza, mortalità, letalità e tasso d'attacco;
- interpretare differenze assolute, rapporti e rischio relativo;
- distinguere associazione e causalità;
- spiegare sensibilità, specificità e valori predittivi;
- riconoscere lo screening come programma e non come singolo test;
- leggere un indicatore PASSI senza trasformare una stima in un conteggio;
- distinguere sorveglianza, notifica, indagine epidemiologica e monitoraggio;
- formulare una definizione operativa di caso;
- descrivere la risposta dal segnale al rapporto finale;
- collegare sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza e prevenzione di sistema.

Il capitolo insegna un metodo di sanità pubblica. Non sostituisce definizioni di caso vigenti, protocolli regionali o aziendali, competenze professionali e decisioni sul singolo evento.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda del candidato	Output atteso
B — Bando	Quale misura, sistema o procedura è richiesta?	Perimetro del quesito
A — Aree	Si parla di frequenza, associazione, screening, sorveglianza, notifica o ICA?	Classificazione corretta
N — Nuclei	Quali sono popolazione, evento, tempo, fonte, numeratore e denominatore?	Dati essenziali
D — Diario	Quali ipotesi, limiti e aggiornamenti vanno registrati?	Traccia verificabile
O — Output	Serve un calcolo, una risposta orale, una definizione di caso o un piano d'indagine?	Risposta nel formato di prova

La sequenza utile è: popolazione → evento → misura → interpretazione → azione → verifica. Saltare un passaggio genera percentuali prive di denominatore, confronti non omogenei, causalità dedotta da un'associazione e procedure locali presentate come universali.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'epidemiologia studia distribuzione e determinanti degli eventi di salute in popolazioni definite e usa i risultati per orientare prevenzione e decisioni. Ogni misura richiede numeratore, denominatore, periodo e fonte. Lo screening è un programma rivolto a persone eleggibili, non un test diagnostico isolato. La sorveglianza raccoglie, analizza, interpreta e restituisce dati in modo sistematico. Un segnale avvia una verifica: non dimostra ancora causa, responsabilità o focolaio.

Fondamenti e linguaggio dell'epidemiologia

POPOLAZIONE, EVENTO, TEMPO E FONTE

Il numero, da solo, non è ancora un'informazione epidemiologica. Prima di calcolare bisogna chiedere chi può entrare nel denominatore, che cosa conta come evento, quale periodo si osserva, quale fonte produce il dato e quali esclusioni esistono.

La popolazione a rischio comprende i soggetti che potrebbero sperimentare l'evento. Inserire nel denominatore persone che non possono averlo altera la misura. La popolazione in studio è quella effettivamente osservata e può differire dalla popolazione bersaglio alla quale si vorrebbero estendere i risultati.

RAPPORTO, PROPORZIONE E TASSO

Un rapporto confronta due quantità; il numeratore non deve essere incluso nel denominatore. Una proporzione esprime una parte del tutto e varia, di regola, tra 0 e 1 oppure tra 0% e 100%. Un tasso incorpora il tempo e descrive la velocità con cui si verificano eventi. Alcuni indicatori sono chiamati «tassi» pur essendo proporzioni: in prova conviene riconoscere la formula e spiegare il denominatore.

Se 24 persone su 96 intervistate soddisfano una definizione operativa, la proporzione è $24 / 96 = 25,0\%$. Bisogna specificare che riguarda gli intervistati, la definizione adottata e il periodo dell'indagine.

PREVALENZA E INCIDENZA

La prevalenza misura la quota di popolazione che presenta una condizione in un momento o periodo:

Prevalenza = casi presenti / popolazione osservata.

Comprende casi già esistenti e dipende sia dall'insorgenza sia dalla durata. È utile per stimare carico assistenziale e bisogno di servizi, ma non misura direttamente il rischio di diventare caso.

L'incidenza cumulativa misura la proporzione di nuovi casi in una popolazione inizialmente a rischio:

Incidenza cumulativa = nuovi casi nel periodo / persone a rischio all'inizio.

Il tasso di incidenza usa il tempo-persona: nuovi casi / somma del tempo-persona a rischio. È utile quando le persone sono osservate per durate diverse. Le due misure non sono intercambiabili.

MORTALITÀ, LETALITÀ E TASSO D'ATTACCO

La mortalità mette in relazione i decessi con la popolazione di riferimento; la letalità considera i decessi tra le persone che presentano la condizione. La prima descrive l'impatto sulla popolazione, la seconda la gravità tra i casi.

Il tasso d'attacco è una proporzione d'incidenza usata in eventi circoscritti:

Tasso d'attacco = nuovi casi tra gli esposti / persone esposte a rischio.

Il nome non deve far dimenticare che il denominatore è un gruppo definito, non il tempo-persona.

DENOMINATORI, DATI MANCANTI E STANDARDIZZAZIONE

«516 test eseguiti» è un conteggio; «516 su 1.200 rispondenti validi» è il 43,0%. Se 50 persone hanno risposto «non so» o rifiutato, occorre dichiarare perché siano escluse e quanto possa incidere la non risposta.

Confrontare popolazioni richiede definizioni, periodi e fonti omogenei. Differenze nella struttura per età possono produrre valori grezzi diversi. La standardizzazione migliora il confronto rispetto a una struttura di riferimento, ma deve essere descritta: non si ricostruisce un dato standardizzato con una divisione se mancano pesi e strati.

Misure di associazione e interpretazione

DIFFERENZA ASSOLUTA E RAPPORTO

La differenza tra 70,4% e 50,6% è 19,8 punti percentuali. Non è corretto dire «inferiore del 19,8%». Una variazione relativa richiede invece di dividere lo scarto per il valore di riferimento. Differenza assoluta e confronto relativo rispondono a domande diverse.

RISCHIO RELATIVO

Il rischio relativo (RR) confronta il rischio negli esposti con quello nei non esposti:

$RR = \text{rischio negli esposti} / \text{rischio nei non esposti}$.

- $RR = 1$: nessuna associazione osservata;
- $RR > 1$: evento più frequente negli esposti;
- $RR < 1$: evento meno frequente negli esposti.

In una coorte ricostruita, 22 malati su 44 esposti danno un tasso del 50,0%; 2 su 52 non esposti danno il 3,85%. $RR = 0,50 / 0,03846 = 13,0$. L'evento è tredici volte più frequente tra gli esposti nel dataset, ma ciò non prova da solo la causa.

ASSOCIAZIONE NON SIGNIFICA CAUSALITÀ

Un'associazione può dipendere da un rapporto causale, confondimento, selezione, errore di informazione o ricordo, misclassificazione, casualità o esposizioni correlate. La causalità richiede coerenza tra tempo, plausibilità, qualità dei dati, evidenze epidemiologiche, microbiologiche e ambientali e spiegazioni alternative.

Una stima puntuale va letta con la sua precisione. Un intervallo di confidenza ampio indica maggiore incertezza. La non sovrapposizione tra intervalli è un'indicazione descrittiva, ma non sostituisce necessariamente un test formale coerente con disegno e pesi.

ERRORE TIPICO

«Il Nord ha una copertura doppia del Sud, quindi l'organizzazione del Nord è certamente più efficace.» Il rapporto descrive un divario geografico. Non identifica da solo le cause e non misura l'efficacia senza un disegno adeguato.

Screening: dal test al programma

SCREENING, DIAGNOSI E PREVENZIONE

Lo screening offre sistematicamente un test a una popolazione asintomatica definita per individuare persone che potrebbero beneficiare di approfondimento. Non formula da solo una diagnosi. Un programma comprende popolazione eleggibile, invito, informazione, test, comunicazione, approfondimento, presa in carico, qualità, valutazione ed equità.

Un esame eseguito su una persona con segni o sintomi appartiene a un percorso diagnostico, non allo screening della popolazione asintomatica.

I TRE PROGRAMMI ONCOLOGICI

Il quadro ordinario di riferimento, verificato sulle informazioni ISS al 3 ottobre 2026, permette di collegare organo, popolazione e test. Riguarda persone asintomatiche eleggibili; sintomi, rischio individuale elevato e precedenti clinici possono richiedere percorsi diversi.

Programma	Popolazione ordinaria di riferimento	Test e intervallo ordinario
Mammella	Donne 50–69 anni	Mammografia ogni due anni
Cervice uterina	Donne 25–64 anni	Pap test ogni tre anni nella fascia 25–29; HPV primario ogni cinque anni nella fascia 30–64
Colon-retto	Donne e uomini 50–69 anni	Ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni

Alcune Regioni estendono l'invito mammografico alle fasce 45–49 e 70–74 e quello coloretale fino a 74 anni. I percorsi cervicali possono essere adattati alla storia vaccinale e al programma attuato: il test e la data del nuovo invito si leggono nelle istruzioni del programma. Il quadro di riferimento non autorizza a sostituire un invito concreto con un calendario universale.

Un risultato positivo apre un approfondimento: non è già diagnosi di tumore. L'intervallo previsto dopo un test negativo non vale automaticamente dopo un esito positivo. Esempio: sommare persone invitate, aderenti e positive produce un totale senza significato, perché sono fasi e denominatori differenti dello stesso percorso.

SENSIBILITÀ, SPECIFICITÀ E VALORI PREDITTIVI

	Condizione presente	Condizione assente
Test positivo	veri positivi (VP)	falsi positivi (FP)
Test negativo	falsi negativi (FN)	veri negativi (VN)

Sensibilità = $VP / (VP + FN)$ indica la quota di positivi tra chi presenta la condizione.

Specificità = $VN / (VN + FP)$ indica la quota di negativi tra chi non presenta la condizione.

VPP = $VP / (VP + FP)$ indica quanti, tra i positivi, presentano la condizione.

VPN = $VN / (VN + FN)$ indica quanti, tra i negativi, non la presentano.

I valori predittivi dipendono anche dalla frequenza della condizione nella popolazione. In una popolazione a bassa prevalenza, anche un buon test può produrre una quota non trascurabile di falsi positivi.

COPERTURA ORGANIZZATA, SPONTANEA E TOTALE

La copertura organizzata riguarda l'esame nel programma; quella spontanea l'esame preventivo fuori dal programma; la totale combina le componenti secondo la definizione dell'indicatore.

Per lo screening coloretale, una tabella ISS 2025 riporta 47,4% totale, 39,3% organizzato e 7,7% spontaneo. Su 1.000 persone la trasformazione didattica produce 474, 393 e 77 frequenze attese. La somma $393 + 77$ è 470: le componenti pubblicate non sommano al totale, con uno scarto di 0,4 punti percentuali. La causa non è determinabile dal solo prospetto; occorrono denominatori, dati mancanti e regole di classificazione. Non basta invocare arrotondamento o pesatura: con tre valori arrotondati al decimo, lo scarto massimo attribuibile al solo arrotondamento è 0,15 punti. Si conservano i dati ufficiali e si dichiara il limite del confronto.

BENEFICI, DANNI ED EQUITÀ

La valutazione considera partecipazione, qualità, tempi, approfondimenti, falsi positivi e negativi, sovradiagnosi, possibili trattamenti non necessari, carico organizzativo ed equità. Una copertura elevata non dimostra da sola riduzione della mortalità; una copertura bassa non spiega da sola il motivo.

Sorveglianza e caso PASSI

FUNZIONI DELLA SORVEGLIANZA

La sorveglianza di sanità pubblica è la raccolta sistematica e continuativa di dati, seguita da analisi, interpretazione e diffusione a chi deve agire. Serve a descrivere problemi, riconoscere tendenze, orientare programmi e valutarne l'andamento.

Non coincide con una singola indagine occasionale, un registro usato senza analisi e restituzione, la vigilanza ispettiva, il monitoraggio di una sola persona o una procedura assistenziale.

Il ciclo è: obiettivo → definizioni → raccolta → controllo qualità → analisi → interpretazione → restituzione → azione → valutazione.

PASSI: POPOLAZIONE, CAMPIONE E PESI

PASSI è una sorveglianza nazionale di popolazione basata su interviste. Il protocollo definisce obiettivi, popolazione in studio, campionamento, raccolta, variabili, indicatori, piano di analisi, diffusione, etica e riservatezza.

I risultati PASSI sono stime campionarie pesate, non conteggi amministrativi degli inviti o degli esami. Ogni indicatore deve specificare popolazione eleggibile, numeratore, denominatore valido, esclusioni, periodo, fonte, eventuale pesatura e intervallo di confidenza.

In uno scenario didattico vi sono 1.250 intervistati eleggibili; 50 rifiutano o rispondono «non so»; 516 dichiarano il test nel periodo definito.

Denominatore valido = $1.250 - 50 = 1.200$.

Indicatore grezzo = $516 / 1.200 \times 100 = 43,0\%$.

Il 43,0% è il risultato grezzo dello scenario, non una stima PASSI reale. In un'analisi effettiva occorrono disegno campionario, pesi e procedure del protocollo.

Notifica, definizioni di caso e PREMAL

FLUSSO ESSENZIALE DELLA SEGNALAZIONE

Il D.M. 7 marzo 2022 disciplina organizzazione e funzionamento del sistema PREMAL. Il medico che, nell'esercizio delle proprie funzioni, viene a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo effettua la segnalazione alla struttura competente dell'Azienda sanitaria.

La struttura aziendale, secondo il quadro applicabile:

1. alimenta PREMAL;
2. svolge l'indagine epidemiologica;
3. adotta i provvedimenti di sanità pubblica di competenza;
4. completa i dati inizialmente mancanti;
5. valida e trasmette la segnalazione al livello regionale o provinciale autonomo competente.

L'art. 5 del D.M. 7 marzo 2022 stabilisce tempi nazionali, distinti dai contatti e dalla modulistica aziendale:

Tipo di segnalazione	Medico → Azienda sanitaria	Azienda sanitaria → PREMAL
Malattia che genera allerta secondo la disciplina applicabile	Caso sospetto entro 12 ore	Alimentazione entro 24 ore
Altre malattie infettive soggette a segnalazione	Caso sospetto entro 48 ore	Alimentazione entro sette giorni

L'azienda completa i dati, svolge l'indagine e adotta le misure di competenza; la struttura regionale o della Provincia autonoma valuta, integra e valida la notifica, che arriva alla direzione ministeriale competente. Anche il livello nazionale valuta e valida per le proprie funzioni. Se l'azienda ricevente differisce da quella di residenza, le due strutture si raccordano secondo l'art. 4. La disponibilità di tutti i risultati di laboratorio non è un requisito per attendere oltre il termine quando è prevista la segnalazione del sospetto.

Verifica: il medico sospetta una malattia che genera allerta, ma il laboratorio non ha ancora concluso l'esame. Può aspettare una settimana? Soluzione: no. Il termine del medico è di 12 ore per il caso sospetto; i dati potranno essere completati nel flusso previsto. L'elenco corrente delle malattie e le istruzioni per lo specifico evento determinano quale disciplina applicare.

STATI DEL SISTEMA E CLASSI EPIDEMIOLOGICHE

Nel flusso PREMAL, potenziale indica un caso ancora privo di dati sufficienti e conclamato un caso che soddisfa la definizione applicabile. Questi stati non coincidono con le categorie possibile, probabile e confermato previste dalle definizioni di sorveglianza delle specifiche malattie.

La definizione ufficiale può combinare criteri clinici, di laboratorio ed epidemiologici. Va controllata nella versione vigente per la malattia considerata. Non si trasferisce una classificazione da una patologia a un'altra.

DEFINIZIONE OPERATIVA DI CASO NELL'INDAGINE DI FOCOLAIO

Il focolaio riguarda un'aggregazione di casi con legami temporali, spaziali o epidemiologici da valutare rispetto alla situazione attesa. La definizione di caso stabilisce invece quali persone includere nell'indagine: non sono la stessa cosa.

Durante un'indagine serve una definizione di lavoro applicabile in modo uniforme. Deve indicare almeno persona o popolazione, luogo o esposizione, tempo e criterio clinico; può aggiungere laboratorio e legame epidemiologico se disponibili.

Esempio: «Persona presente al pranzo della mensa aziendale del 15 ottobre che abbia sviluppato diarrea, definita come almeno tre scariche liquide in 24 ore, entro le 72 ore successive al pasto».

La definizione serve a cercare e classificare i casi. Non identifica l'agente, non prova la causa e non sostituisce la definizione ufficiale. Può essere aggiornata documentando il motivo.

LINE LIST E RISERVATEZZA

La line list è l'elenco strutturato dei casi. Può includere identificativo pseudonimizzato, età o classe, ruolo, esposizioni, data e ora di esordio, sintomi, assistenza, esami e classificazione. Si applicano minimizzazione, accessi autorizzati, canali protetti e regole di conservazione.

Risposta a un segnale epidemiologico

VERIFICARE IL SEGNALE

Un segnale è un'informazione che richiede valutazione. La prima domanda non è «qual è la causa?», ma «esiste un incremento coerente di eventi collegati nel tempo, nel luogo o nella popolazione?».

Occorre controllare duplicati, definizione provvisoria, date di esordio, baseline e stagionalità, cambiamenti diagnostici o di segnalazione, fonte, qualità dei dati, gravità e necessità di azioni tempestive.

ATTIVARE COORDINAMENTO E RICERCA DEI CASI

La composizione del gruppo dipende dall'evento e dall'organizzazione: sanità pubblica, assistenza, laboratorio, prevenzione e altri soggetti pertinenti. La partecipazione al team non attribuisce automaticamente poteri, atti o firme.

Si costruisce la line list, si ricercano attivamente i casi e si applica la definizione in modo uniforme anche a chi non ha richiesto assistenza, se rientra nella popolazione studiata.

DESCRIVERE TEMPO, LUOGO E PERSONA

La descrizione comprende curva epidemica, distribuzione geografica o per setting, caratteristiche delle persone, esposizioni, denominatori, tassi d'attacco, dati mancanti e non risposta. Un andamento compatibile con una fonte comune genera un'ipotesi, non dimostra l'origine.

GENERARE E TESTARE IPOTESI

In un pranzo didattico, 96 persone su 112 contattabili completano l'intervista: $96 / 112 = 85,7\%$. Ventiquattro soddisfano la definizione: $24 / 96 = 25,0\%$.

Per la pietanza A il RR è 13,0. Per la pietanza B, con 17 casi su 68 esposti e 7 su 28 non esposti, i due tassi sono entrambi 25,0% e $RR = 1,0$. A è l'ipotesi prioritaria; B non discrimina i casi nel dataset. Prima di concludere si valutano precisione, non risposta, ricordo, esposizioni correlate, contaminazione crociata, plausibilità temporale e risultati di laboratorio e ambiente.

INTEGRARE EPIDEMIOLOGIA, LABORATORIO E AMBIENTE

Le tre componenti sono complementari, non intercambiabili. L'ipotesi orienta campioni e accertamenti; il laboratorio interpreta metodi e tempi; l'indagine ambientale ricostruisce processi e tracciabilità.

Un risultato negativo può essere poco informativo se campione, tempo o metodo sono inadeguati. Un risultato positivo richiede collegamento con persone, evento e catena di esposizione.

ADOTTARE MISURE PROPORZIONATE

Non occorre sempre attendere la prova eziologica definitiva quando esiste un rischio controllabile. Le misure devono essere proporzionate, motivate, adottate da chi ne ha competenza e registrate con data, responsabile, destinatari e criterio di revisione. Occorre separare tutela tempestiva e attribuzione prematura di causalità o responsabilità.

COMUNICARE E CHIUDERE

La comunicazione si articola in tre prodotti: un aggiornamento operativo per il gruppo e le autorità; un messaggio chiaro per i soggetti interessati; un rapporto finale con obiettivo, metodi, definizione di caso, risultati, laboratorio, ambiente, limiti, azioni e raccomandazioni.

La chiusura verifica andamento dei casi, risultati pendenti, efficacia delle misure e apprendimenti. Il rapporto separa fatti, calcoli, interpretazioni, ipotesi e decisioni.

Infezioni correlate all'assistenza e indicatori

CHE COSA SONO LE ICA

Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono infezioni acquisite in relazione all'assistenza ricevuta in diversi setting. Non vanno ridotte a «infezioni ospedaliere»: possono riguardare strutture residenziali, territorio e altre forme di assistenza.

La loro insorgenza è multifattoriale. La prevenzione richiede organizzazione, competenze, pratiche appropriate, ambiente, dispositivi, uso prudente degli antimicrobici, sorveglianza e miglioramento continuo. Un singolo caso non prova automaticamente una colpa; un aggregato non va ignorato.

INDICATORI DI STRUTTURA, PROCESSO ED ESITO

- Struttura: risorse, dotazioni, organizzazione e disponibilità di sistemi.
- Processo: aderenza a pratiche definite, tempestività e completezza delle attività.
- Esito: eventi osservati, infezioni, complicanze o altri risultati.

Un indicatore è utile se definizione, popolazione, fonte, periodicità e responsabilità sono chiare. Un esito va interpretato considerando rischio dei pazienti, esposizioni, qualità della rilevazione e cambiamenti diagnostici.

SORVEGLIANZA E FEEDBACK

La sorveglianza ICA identifica tendenze e segnali, sostiene interventi e ne monitora gli effetti. Il feedback deve raggiungere chi può migliorare il sistema. Raccogliere dati senza restituirli o agire ne riduce il valore.

I ruoli sono multiprofessionali e dipendono dall'organizzazione. In prova occorre riconoscere le responsabilità del proprio profilo, la collaborazione necessaria e le procedure vigenti, senza attribuire a tutti le stesse competenze.

Caso guidato

TRACCIA

Un servizio riceve segnalazioni di disturbi gastrointestinali dopo un evento con 120 presenti. Sono contattabili 112 persone e 96 rispondono. Ventiquattro soddisfano la definizione operativa. Per la pietanza A risultano 22 malati e 22 non malati tra 44 esposti; 2 malati e 50 non malati tra 52 non esposti.

RISPOSTA MODELLO

1. Verifico il segnale: controllo duplicati, esordio, comune esposizione, gravità, baseline e variazioni diagnostiche.
2. Attivo il flusso competente: segnale e coordino secondo quadro e organizzazione vigenti, senza inventare ruoli o atti.
3. Definisco i casi: persona, pranzo, finestra temporale e criterio clinico espliciti.
4. Costruisco la line list: dati minimi, esposizioni, sintomi, esami e classificazione, con protezione dei dati.
5. Calcolo: risposta 85,7%; attacco complessivo 25,0%; attacco esposti A 50,0%; non esposti A 3,85%; RR 13,0.
6. Interpreto: forte associazione nel dataset, non causalità dimostrata.
7. Integro: epidemiologia, laboratorio e ambiente; valuto bias e plausibilità.
8. Propongo misure: proporzionate, motivate e adottate dai soggetti competenti.
9. Comunico: distinguo fatti, ipotesi e incertezze.
10. Chiudo: aggiornerò dati, verifico andamento e documento apprendimenti.

Domande e verifica

DOMANDA DA COMMISSARIO

«Spieghi la differenza tra prevalenza e incidenza e indichi quando userebbe ciascuna misura.»

Risposta efficace: la prevalenza descrive i casi presenti in una popolazione e informa sul carico assistenziale; l'incidenza riguarda i nuovi casi in una popolazione a rischio e informa sulla comparsa dell'evento. Vanno indicati popolazione, periodo e denominatore. La prevalenza dipende anche dalla durata, quindi non sostituisce il rischio d'insorgenza.

DOMANDA-TRAPPOLA

«Un test con sensibilità del 95% garantisce che il 95% dei positivi sia malato?»

No. Il 95% riguarda la quota di positivi tra chi presenta la condizione. La probabilità che un positivo sia realmente caso è il valore predittivo positivo e dipende anche dalla frequenza della condizione e dalla specificità.

MINI-ESERCIZIO

Copertura cervicale totale: 77,7%; organizzata: 46,8%; spontanea: 30,7%.

1. Somma delle componenti: $46,8 + 30,7 = 77,5\%$.
2. Scarto dal totale: $77,7 - 77,5 = 0,2$ punti percentuali.
3. Interpretazione: lo scarto di 0,2 punti supera quanto spiegabile dal solo arrotondamento di tre valori al decimo. La tabella non ne dimostra la causa; si mantengono i dati pubblicati e si richiedono denominatori e regole di classificazione prima di interpretare le componenti come partizione esatta del totale.

Quiz ragionati

QUIZ 1

Quale misura descrive i nuovi casi in una popolazione inizialmente a rischio durante un periodo?

- A. Prevalenza puntuale.
- B. Incidenza cumulativa.
- C. Letalità.
- D. Valore predittivo positivo.

Soluzione: B. La prevalenza comprende casi presenti; la letalità considera decessi tra casi; il VPP riguarda i positivi al test.

QUIZ 2

Una differenza tra 62% e 30% equivale a:

- A. 32 punti percentuali.
- B. 32% in ogni formulazione.
- C. un rischio relativo di 32.
- D. una prova di causalità.

Soluzione: A. La differenza assoluta tra percentuali si esprime in punti percentuali.

QUIZ 3

Quale affermazione sui valori predittivi è corretta?

- A. Sono indipendenti dalla frequenza della condizione.
- B. Coincidono sempre con sensibilità e specificità.
- C. Dipendono anche dalla frequenza della condizione nella popolazione.
- D. Il VPP considera tutti i malati.

Soluzione: C. Il VPP considera i positivi e varia con frequenza della condizione e prestazioni del test.

QUIZ 4

Le percentuali PASSI rappresentano:

- A. sempre conteggi amministrativi degli esami.
- B. stime campionarie ottenute secondo protocollo e pesatura.
- C. diagnosi individuali.
- D. misure prive di denominatore.

Soluzione: B. Fonte, popolazione, definizione, pesi e intervalli sono essenziali per interpretarle.

QUIZ 5

Una definizione operativa di caso in un focolaio:

- A. prova automaticamente la causa.
- B. sostituisce ogni definizione ufficiale.
- C. serve a ricercare e classificare coerentemente i casi nell'indagine.
- D. deve contenere sempre un agente già confermato.

Soluzione: C. È uno strumento di lavoro aggiornabile; non prova causalità e non sostituisce la definizione ufficiale.

Checklist finale

Prima di consegnare una risposta verifica di avere:

- ☐ definito popolazione, evento, periodo e fonte;
- ☐ indicato numeratore e denominatore;
- ☐ distinto rapporto, proporzione e tasso;
- ☐ separato prevalenza e incidenza;
- ☐ separato mortalità e letalità;
- ☐ espresso le differenze tra percentuali in punti percentuali;
- ☐ interpretato RR senza trasformarlo automaticamente in causa;
- ☐ distinto sensibilità, specificità, VPP e VPN;
- ☐ trattato lo screening come programma;
- ☐ distinto stime campionarie e conteggi amministrativi;
- ☐ dichiarato dati mancanti, pesi e intervalli quando pertinenti;
- ☐ distinto sorveglianza, notifica e indagine;
- ☐ separato definizione ufficiale e operativa;
- ☐ descritto PREMAL senza confondere stati e classi di caso;
- ☐ protetto i dati della line list;
- ☐ separato evidenze epidemiologiche, di laboratorio e ambientali;
- ☐ motivato misure e competenze senza inventare procedure locali;
- ☐ distinto fatti, calcoli, ipotesi e decisioni;
- ☐ collegato gli indicatori ICA all'azione e al feedback;
- ☐ concluso con limiti e dati necessari per rivalutare.

Riferimenti essenziali

- Istituto Superiore di Sanità, materiali metodologici su epidemiologia di base, misure, bias e screening.
- Istituto Superiore di Sanità, Protocollo di studio PASSI, versione 8 febbraio 2023.
- EpiCentro-ISS, risultati PASSI e documentazione sui programmi di screening oncologico, dati 2021-2025.
- Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive PREMAL.
- Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità ed ECDC, materiali su definizioni di caso e indagini di focolaio.
- Ministero della Salute ed EpiCentro-ISS, sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza e prevenzione.

Prima dell'uso operativo occorre verificare versioni correnti, definizioni della specifica malattia, indicatori, protocolli e organizzazione territoriale applicabile.

Controlli TPALL, verbalizzazione, campionamento e sanzioni

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Obiettivo del capitolo

Un controllo non si riduce a una successione di moduli. Competenza, obiettivo, evidenze, atti e conseguenze devono restare coerenti. Una fotografia priva di contesto, un campione non rappresentativo o un verbale che mescola fatti e giudizi può compromettere la ricostruzione dell'attività.

Nei concorsi per tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL) questo nucleo compare in quesiti teorici, prove pratiche e colloqui: preparare un sopralluogo, descrivere un campionamento, redigere un verbale, classificare una non conformità o distinguere i percorsi conseguenti a un illecito.

Al termine saprai:

- collocare le attività di vigilanza nel profilo professionale;
- verificare competenza, mandato, oggetto e norma prima del controllo;
- descrivere le fasi del sopralluogo;
- distinguere osservazione, dichiarazione, documento, misura, fotografia e campione;
- impostare un piano di campionamento non esecutivo;
- riconoscere perché matrici, metodi e regimi non sono intercambiabili;
- distinguere verbale, rapporto di prova, rapporto ispettivo e provvedimento;
- collegare requisito, evidenza, non conformità e azione;
- separare illecito amministrativo, contravvenzione, prescrizione e notizia di reato;
- costruire una risposta prudente, tracciabile e verificabile.

Il capitolo non sostituisce norme settoriali, autorizzazioni, procedure dell'ente, metodi tecnici vigenti o attribuzioni individuali. Il caso concreto deve sempre identificare autorità competente, disciplina, metodo e territorio.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda guida	Output
B — Bando	Quale settore e quale tipo di prova sono richiesti?	Perimetro del controllo
A — Aree	Sicurezza, ambiente, alimenti, AIA, rifiuti o altra matrice?	Disciplina pertinente

Passaggio	Domanda guida	Output
N — Nuclei	Competenza, requisito, evidenza, metodo, atto e conseguenza sono distinti?	Schema tecnico-giuridico
D — Diario	Che cosa va registrato, da chi e in quale momento?	Tracciabilità
O — Output	Piano, verbale, rapporto, classificazione o risposta orale?	Elaborato richiesto

La catena da ricordare è:

mandato → piano → sopralluogo → evidenze → eventuale campione → verbale → esito → follow-up.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il controllo parte dalla competenza e dalla norma applicabile. Il verbale descrive attività e fatti, senza sostituire ogni valutazione successiva. Il campionamento richiede obiettivo, matrice, metodo, rappresentatività e catena di custodia. Una non conformità non coincide automaticamente con una sanzione. Illecito amministrativo, contravvenzione e notizia di reato seguono presupposti e percorsi distinti.

Fondamenti professionali e giuridici

PROFILO TPALL

Il D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, colloca il TPALL nelle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, alimenti e bevande, sanità pubblica e veterinaria. Il profilo comprende attività istruttorie, campionamenti, accertamenti, contestazione delle irregolarità e vigilanza sulle strutture.

Nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza il tecnico assume, nei limiti delle attribuzioni, funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. La formula «nei limiti delle attribuzioni» è decisiva: qualifica, territorio, materia, organizzazione e incarico concreto non si presumono dal solo titolo professionale.

COMPETENZA PRIMA DEL POTERE

Prima di descrivere un accesso o un atto, la risposta deve identificare:

- ente e servizio competente;
- fonte dell'attribuzione;
- territorio;
- materia e impianto normativo;

- oggetto del controllo;
- mandato o programma;
- qualifica degli operatori;
- eventuali autorità da coinvolgere.

Non esiste un generico «potere del controllore» valido per ogni settore. Un controllo ufficiale alimentare, un'ispezione AIA, un accertamento sulla sicurezza del lavoro e un'attività su rifiuti possono coinvolgere autorità, fonti, atti e garanzie differenti.

QUATTRO PIANI DA NON CONFONDERE

Piano	Domanda
Tecnico	Che cosa è stato osservato, misurato o analizzato?
Amministrativo	Quale requisito, autorizzazione o provvedimento rileva?
Sanzionatorio	Quale illecito è astrattamente configurabile e chi procede?
Penale	Esistono fatti da riferire all'autorità giudiziaria secondo competenza?

La stessa evidenza può alimentare più valutazioni, ma non le rende automatiche. Il tecnico documenta ciò che rientra nelle proprie attribuzioni e attiva il percorso previsto, senza anticipare decisioni dell'autorità competente.

Anatomia del controllo

PREPARAZIONE

La preparazione traduce l'obiettivo in un piano verificabile. Occorre definire:

- finalità e campo del controllo;
- norme, autorizzazioni e prescrizioni applicabili;
- precedenti, scadenze e dati disponibili;
- composizione del gruppo e responsabilità;
- rischi per gli operatori;
- documenti, strumenti e dispositivi necessari;
- necessità e finalità di eventuali campioni;
- modalità di registrazione e comunicazione.

Un elenco standard può aiutare, ma non sostituisce l'analisi del caso. Preparare un controllo su emissioni convogliate richiede, tra l'altro, informazioni sul punto di misura e sulla sicurezza di accesso; un controllo alimentare richiede il quadro dei controlli ufficiali e la procedura applicabile; un controllo AIA richiede l'autorizzazione e il piano di monitoraggio.

ACCESSO E APERTURA

All'avvio si identificano operatori, soggetti presenti, ruolo del referente, oggetto e base dell'attività nei limiti consentiti. Si registrano data, ora, luogo e circostanze. Le modalità di informazione, assistenza, contraddittorio e accesso dipendono dalla disciplina applicabile.

La sicurezza viene valutata prima e durante l'attività. Rischi di caduta, spazi, traffico, sostanze, atmosfere, agenti biologici, impianti ed emergenze richiedono misure coerenti. L'urgenza non autorizza l'improvvisazione tecnica.

OSSERVAZIONE E RACCOLTA DELLE EVIDENZE

L'osservazione deve essere precisa e ripetibile. È utile distinguere:

- fatto osservato: ciò che l'operatore vede direttamente;
- dichiarazione: ciò che riferisce una persona identificata;
- documento: contenuto di un atto o registro acquisito;
- misura: risultato prodotto da uno strumento secondo un metodo;
- fotografia: rappresentazione associata a luogo, data, autore e contesto;
- campione: porzione prelevata secondo un piano e destinata a esame o prova.

Scrivere «impianto non a norma» è una conclusione. Scrivere che un determinato dispositivo risultava assente nel punto osservato, indicare requisito e documentazione esaminata rende l'evidenza controllabile.

DICHIARAZIONI E DOCUMENTI

Le dichiarazioni non vanno trasformate in osservazioni dirette. Devono essere attribuite e riportate in modo fedele. Per i documenti si registrano titolo, data, versione, estremi, provenienza e modalità di acquisizione. Una copia deve poter essere collegata al documento esaminato.

CHIUSURA E FOLLOW-UP

Prima di lasciare il sito si verifica la completezza delle registrazioni, si riepilogano le attività nei limiti consentiti, si raccolgono eventuali dichiarazioni e si gestiscono sottoscrizione, consegna o riserve secondo la procedura applicabile.

Il controllo prosegue con valutazione degli esiti, richieste integrative, risultati di laboratorio, classificazione delle non conformità, comunicazioni e verifica delle azioni. Il sopralluogo non coincide sempre con la chiusura del procedimento di controllo.

ERRORE TIPICO

Iniziare dalla sanzione. La sequenza corretta parte da competenza, requisito ed evidenza. Soltanto dopo si individua il percorso previsto dalla disciplina applicabile.

Evidenze e tracciabilità

FATTO, REQUISITO E INFERENZA

Per ricostruire il controllo occorre separare tre livelli:

1. requisito: ciò che norma, autorizzazione, prescrizione o piano richiede;
2. evidenza: ciò che è stato osservato, dichiarato, misurato o documentato;
3. valutazione: il confronto motivato tra requisito ed evidenza.

La separazione riduce formule vaghe e permette a un altro soggetto di ripercorrere il ragionamento. Se manca la fonte del requisito, la non conformità non è verificabile; se manca l'evidenza, la valutazione resta assertiva.

INTEGRITÀ E CATENA DOCUMENTALE

Ogni elemento deve conservare identità e collegamento con il controllo. Numerazione, data, autore, luogo, dispositivo, versione e allegati aiutano a dimostrare origine e integrità. Le modifiche devono restare riconoscibili secondo le regole applicabili.

La tracciabilità non serve solo in giudizio: sostiene qualità, confronto tecnico, riesame, audit e continuità tra sopralluogo, laboratorio e autorità.

Campionamento: dal quesito al laboratorio

IL CAMPIONAMENTO È UNA DECISIONE

Campionare significa selezionare una porzione o un insieme di unità per ottenere informazioni su un lotto, un flusso, un ambiente o un processo. La domanda preliminare è: quale decisione dovrà sostenere il risultato?

Prima del prelievo si definiscono:

- obiettivo;
- popolazione, lotto, flusso o area di riferimento;
- matrice e analita;
- distribuzione attesa e variabilità;
- punti, numero e tempi;
- tipo di campione;
- metodo di campionamento e analisi;
- criteri di accettazione;
- controllo qualità;
- laboratorio, trasporto e tempi;
- uso amministrativo o probatorio previsto.

Un campione tecnicamente analizzabile può essere inadeguato alla domanda se non rappresenta l'oggetto del controllo.

RAPPRESENTATIVITÀ

La rappresentatività indica quanto il campione consenta di riferire il risultato all'insieme definito. Dipende da eterogeneità, distribuzione, localizzazione, tempo, modalità di prelievo e obiettivo.

Una matrice omogenea non si tratta come un rifiuto eterogeneo; un'emissione variabile nel tempo non si descrive automaticamente con una misura istantanea; uno screening dei gas del suolo non equivale a una stima quantitativa valida per ogni decisione.

Gli errori principali derivano da selezione non coerente, contaminazione, perdita di analita, scambio di campioni, contenitore inadeguato, conservazione errata, ritardo, strumento non controllato o registrazioni incomplete.

PIANO DI CAMPIONAMENTO

Il piano collega obiettivo e operazioni. In forma concorsuale deve indicare almeno:

Campo	Contenuto
Oggetto	lotto, impianto, punto, area o popolazione
Finalità	conformità, caratterizzazione, monitoraggio, verifica o screening

Campo	Contenuto
Matrice/analita	che cosa si preleva e che cosa si ricerca
Strategia	punti, tempi, numero, criterio di selezione
Metodo	riferimento vigente e versione
Qualità	bianchi, duplicati, tarature o altri controlli pertinenti
Gestione	contenitore, identificazione, sigillo, conservazione e trasporto
Laboratorio	destinazione, prova richiesta e tempi
Registrazioni	operatori, condizioni, anomalie e catena di custodia

Il livello di dettaglio esecutivo dipende dalla fonte tecnica applicabile. In prova non si inventano volume, aliquote, temperatura, conservante o durata se la traccia non fornisce metodo e matrice.

IDENTIFICAZIONE E CATENA DI CUSTODIA

L'identificativo collega campione, verbale, contenitore, richiesta e rapporto di prova. La catena di custodia documenta chi ha avuto il campione, quando, in quali condizioni e per quale passaggio. Sigilli, firme, registrazioni di consegna e condizioni di trasporto dipendono dal regime applicabile.

La catena non corregge un campione non rappresentativo, ma protegge identità e integrità dal prelievo al laboratorio.

QA/QC E RAPPORTO DI PROVA

Il controllo qualità può includere tarature, verifiche, bianchi, duplicati, materiali di riferimento, criteri di accettazione e registrazioni. Non tutti gli strumenti si applicano a ogni metodo.

Il rapporto di prova espone risultati, metodo, unità, eventuale incertezza e informazioni del laboratorio. Non coincide con il verbale di sopralluogo né decide da solo la conseguenza amministrativa o penale. Il risultato va confrontato con requisito, autorizzazione, condizioni e qualità del campione.

Matrici e regimi distinti

ACQUE INTERNE

Il campionamento delle acque richiede programma, punti, attrezzature, contenitori, prevenzione delle contaminazioni, misure in campo, conservazione, trasporto e registrazioni. Parametro, corpo idrico, finalità e variabilità orientano la strategia. Un campione destinato a parametri chimici non autorizza generalizzazioni su microbiologia o altri obiettivi.

ARIA AMBIENTE ED EMISSIONI CONVOGLIATE

La rete di qualità dell'aria misura l'ambiente secondo programmi e QA/QC. Le emissioni convogliate riguardano invece un flusso emesso attraverso un punto definito. Cambiano sicurezza di accesso, rappresentatività, condizioni di esercizio, durata, strumentazione e metodo.

Per le emissioni, autorizzazione, BAT conclusions, livelli BAT-AEL, piano di monitoraggio e controllo, limite, metodo e risultato hanno funzioni diverse. Un BAT-AEL non è automaticamente il valore da confrontare senza leggere l'atto applicabile.

Le linee SNPA sulla sicurezza richiamano preparazione, coordinamento con il gestore, accessibilità del punto e rischi specifici. Nessun repertorio pubblico di metodi sostituisce il testo vigente della norma tecnica.

SUOLO, GAS INTERSTIZIALI, TERRE E ROCCE

Caratterizzazione del sito, gas del suolo, terre e rocce da scavo e materiali di riporto rispondono a regimi differenti. Modello concettuale, sorgenti, vie di migrazione, recettori e obiettivo guidano punti e metodi.

Il campionamento passivo dei gas interstiziali può sostenere screening e monitoraggio in condizioni definite. Metodo passivo e attivo, durata di esposizione, calibrazione e incertezza non sono intercambiabili. Il Quaderno ISPRA 30/2024 offre un caso recente, ma non sostituisce il piano sito-specifico.

RIFIUTI

Per i rifiuti occorre distinguere origine, processo, stato fisico, eterogeneità, codice e valutazione delle caratteristiche di pericolo. Il campionamento deve sostenere una classificazione documentata. Un prelievo occasionale da un punto comodo può non rappresentare il lotto.

Le linee SNPA aiutano a strutturare il giudizio, ma i metodi tecnici richiamati devono essere verificati nella versione applicabile.

ALIMENTI E CONTROLLI UFFICIALI

Il regolamento (UE) 2017/625 struttura i controlli ufficiali secondo rischio, frequenza appropriata, metodi e tecniche, campionamento, analisi, trasparenza e misure in caso di non conformità. Il D.Lgs. 27/2021 coordina il sistema nazionale.

Programmazione e sospetto, autorità, laboratorio, aliquote, sigillatura, diritti dell'operatore e azioni seguono disciplina e procedure applicabili. Un piano regionale, come quello lombardo 2024-2027, documenta un'organizzazione territoriale: non diventa una procedura nazionale.

AIA E AUA

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riguarda installazioni e condizioni integrate di esercizio e controllo. Il ciclo ispettivo può comprendere programmazione, pianificazione, ispezione, verbale, campionamento, analisi, gestione degli esiti, non conformità e rapporto di ispezione ambientale.

L'autorizzazione unica ambientale (AUA), regolata dal D.P.R. 59/2013, riunisce i titoli ambientali indicati dal regolamento per le imprese e gli impianti nel suo ambito, non soggetti ad AIA. La domanda passa dal SUAP; l'autorità competente adotta il provvedimento secondo il riparto applicabile. Non sostituisce qualsiasi autorizzazione né trasforma un impianto AIA in impianto AUA. L'AIA, disciplinata dalla parte II del D.Lgs. 152/2006, considera in modo integrato gli impatti dell'installazione e le migliori tecniche disponibili (BAT).

I BAT-AEL sono livelli di emissione associati alle BAT nelle condizioni indicate: non vanno scambiati con un limite numerico universale per qualunque impianto. AIA e AUA non sono sinonimi. Nel caso concreto si leggono autorizzazione, allegati, prescrizioni, piano di monitoraggio, modifiche e competenza.

ATTENZIONE

Matrice, metodo e regime devono procedere insieme. Una sequenza valida per le acque non si trasferisce automaticamente ad alimenti, emissioni o rifiuti.

Sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare

Nel luogo di lavoro il DVR rende documentata la valutazione dei rischi. Il datore di lavoro non può delegare tale valutazione e la conseguente elaborazione del documento, né la designazione del RSPP. RSPP e medico competente, nei casi previsti, collaborano; il RLS è consultato, non sostituisce il datore nella valutazione. Dirigenti e preposti hanno obblighi propri legati alle rispettive funzioni. In un sopralluogo non basta trovare un fascicolo intitolato DVR: si confrontano mansioni, rischi reali, misure, formazione, sorveglianza sanitaria e aggiornamento.

Nel settore alimentare l'operatore è responsabile delle procedure basate sui principi HACCP: analisi dei pericoli, punti critici, limiti, monitoraggio, azioni correttive, verifica e registrazioni proporzionate. Il controllo ufficiale verifica il sistema e le evidenze, non redige al posto dell'operatore il suo autocontrollo. La rintracciabilità permette di risalire ai fornitori e individuare i destinatari professionali; il ritiro rimuove dalla filiera un prodotto non sicuro, mentre il richiamo raggiunge anche il consumatore quando necessario. Il semplice ritrovamento di una scheda incompleta non dimostra automaticamente un alimento pericoloso, ma impone di valutarne rilevanza e conseguenze.

CONTROPERIZIA E CONTROVERSIA

Per i controlli ufficiali nel campo del D.Lgs. 27/2021, la controperizia dell'art. 7 consente all'operatore, a proprie spese, un esame documentale da parte di un esperto qualificato; la richiesta va presentata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole. Può comprendere l'analisi dell'aliquota disponibile presso un laboratorio accreditato di fiducia. Se dopo la controperizia permane il dissenso, l'art. 8 prevede la controversia documentale davanti all'ISS, da attivare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole; l'eventuale fase analitica ha istanza e termine distinti, decorrenti dalla valutazione documentale ISS.

Non sono sinonimi di una generica «seconda analisi». Aliquote, riproducibilità, deperibilità e motivazione delle eventuali limitazioni vanno considerate fin dal campionamento. La L. 71/2021 ha rimosso le disposizioni che escludevano le garanzie dell'art. 223 D.Lgs. 271/1989: non si deve quindi affermare che controperizia e controversia cancellino ogni garanzia processuale. Le misure urgenti per contenere il rischio sanitario restano possibili.

Verbale, rapporto e non conformità

FUNZIONE DEL VERBALE

Il verbale rende tracciabili soggetti, luogo, tempo, attività, evidenze, documenti, dichiarazioni, campioni e allegati. Deve consentire di comprendere che cosa sia avvenuto senza colmare i vuoti con formule generiche.

In base alla disciplina e al tipo di atto, possono rilevare:

- autorità, servizio e operatori;
- data, ora e luogo;
- soggetti presenti e qualità dichiarata;
- oggetto e base dell'attività;
- ambienti, impianti o lotti esaminati;
- operazioni compiute;
- documenti acquisiti;
- evidenze e misure;
- campioni, identificativi e destinazione;
- dichiarazioni e osservazioni;
- allegati;
- lettura, sottoscrizione, rifiuto o riserve;

- consegna o notifica secondo il regime applicabile.

L'assenza di firma di una parte, quando prevista la possibilità di rifiuto, non si risolve forzando la sottoscrizione: si documenta quanto avvenuto secondo la procedura applicabile.

ESTRATTO DI VERBALE COMPILATO: ESEMPIO DIDATTICO

Verbale n. 12/2026 — dati interamente fittizi. Il 3 ottobre 2026, dalle 9:15 alle 10:10, presso il laboratorio alimentare Alfa, gli operatori del servizio competente Rossi e Bianchi, alla presenza della responsabile Verdi, verificano registrazioni di autocontrollo e rintracciabilità del lotto L0310.

Fatti osservati. Il registro delle temperature del frigorifero F2 non presenta annotazioni per il turno precedente. La procedura aziendale HACCP, revisione 3, prevede una rilevazione a ogni turno. Sono acquisiti copia della pagina del registro (allegato A), procedura pertinente (B) e documento di ingresso del lotto (C). Non sono state eseguite analisi né accertate temperature retrospettive.

Dichiarazione attribuita. La responsabile riferisce che «il controllo è stato fatto, ma non registrato». La dichiarazione è distinta dal fatto verificabile: l'assenza della registrazione. Non dimostra quale fosse la temperatura del prodotto.

Valutazione e seguito. È rilevato uno scostamento documentale dalla procedura; il servizio valuta rischio, altri dati disponibili e disciplina applicabile prima di qualificare l'illecito o disporre misure. Sono richiesti i registri digitali eventualmente disponibili e il collegamento del lotto ai destinatari. Il verbale è letto, sottoscritto e consegnato secondo le modalità del servizio. Questo estratto non contiene una sanzione presunta né un esito analitico inventato.

VERBALE, RAPPORTO DI PROVA E RAPPORTO ISPETTIVO

Documento	Funzione principale
Verbale	documentare operazioni e fatti del controllo
Rapporto di prova	esporre risultati analitici e metodo del laboratorio
Rapporto ispettivo	integrare attività, evidenze, valutazione ed esiti dell'ispezione
Provvedimento	esprimere la decisione dell'autorità competente

I documenti possono collegarsi, ma non si sostituiscono. Un rapporto di prova non racconta l'intero sopralluogo; un verbale non assume automaticamente valore di provvedimento.

NON CONFORMITÀ

Una non conformità è uno scostamento rispetto a un requisito applicabile. La formulazione deve indicare requisito, evidenza e campo. La classificazione e l'azione dipendono dal sistema di controllo e dalla disciplina settoriale.

Schema utile:

requisito → evidenza → valutazione → classificazione → azione → verifica.

Non ogni osservazione è una non conformità; non ogni non conformità è un reato; non ogni irregolarità produce la stessa misura. Gravità, rischio, intenzionalità, recidiva, competenza e norme applicabili non si possono dedurre da un'etichetta generica.

Illeciti e percorsi conseguenti

ILLECITO AMMINISTRATIVO

La legge 24 novembre 1981, n. 689, contiene principi generali delle sanzioni amministrative e disciplina, tra l'altro, accertamento, contestazione o notificazione e ordinanza-ingiunzione. La risposta concorsuale deve distinguere l'organo che accerta dal soggetto competente per le fasi successive.

Lo schema generale della L. 689/1981, salvo regole speciali, è il seguente.

Fase	Regola generale	Punto da controllare
Contestazione/notifica, art. 14	contestazione immediata ove possibile; altrimenti notifica entro 90 giorni ai residenti in Italia, 360 all'estero, dall'accertamento	accertamento e commissione del fatto non coincidono necessariamente
Pagamento ridotto, art. 16	entro 60 giorni dalla contestazione o notifica; un terzo del massimo oppure, se previsto e più favorevole, doppio del minimo, oltre alle spese	ammissibilità e deroghe settoriali

Fase	Regola generale	Punto da controllare
Difese, art. 18	entro 30 giorni dalla contestazione/notifica, scritti, documenti e richiesta di audizione	autorità destinataria competente
Rapporto, art. 17	se non è effettuato il pagamento ridotto, trasmissione del rapporto con prova della contestazione/notifica	distinto dalla notizia di reato
Decisione, art. 18	esame degli atti e delle difese, audizione se richiesta; ordinanza-ingiunzione motivata o archiviazione	distinto dal verbale di accertamento

Esempio aritmetico. Una fattispecie didattica ammette il pagamento ridotto e prevede da 300 a 1.200 euro: un terzo del massimo è 400, il doppio del minimo è 600. La misura più favorevole è 400 euro, oltre alle spese. Il calcolo non dimostra da solo che l'art. 16 sia applicabile al caso: occorre prima verificare la disciplina speciale.

CONTRAVVENZIONE E PRESCRIZIONE

Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, disciplina una specifica procedura estintiva per contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. La sequenza comprende, nei casi e nei limiti previsti, prescrizione, termine per la regolarizzazione, verifica dell'adempimento e passaggi successivi.

Non è una sanatoria generale e non si applica automaticamente a ogni illecito ambientale, alimentare o amministrativo. La prescrizione deve essere collegata alla fattispecie, all'organo competente e agli adempimenti previsti.

DALLA PRESCRIZIONE ALL'ESTINZIONE: CONFRONTO DEI REGIMI

Nel D.Lgs. 758/1994 l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione per eliminare la contravvenzione e fissa il tempo tecnicamente necessario. Resta l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero. Entro 60 giorni dalla scadenza verifica l'adempimento: se positivo, ammette al pagamento, entro 30 giorni, di un quarto del massimo dell'ammenda. Adempimento e pagamento nei termini fondano l'estinzione; il pagamento isolato non sana l'omessa regolarizzazione. Il procedimento penale segue la disciplina di sospensione e le comunicazioni previste dagli artt. 21–24; l'organo di vigilanza non emette una sentenza di assoluzione.

La parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006 riguarda invece determinate contravvenzioni ambientali, in assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse protette. Non è applicabile ai delitti ambientali e non basta che il responsabile dichiari di avere riparato. La prescrizione richiede asseverazione tecnica dell'ente specializzato; seguono verifica entro 60 giorni dalla scadenza e, in caso di adempimento, ammissione al pagamento entro 30 giorni di un quarto del massimo dell'ammenda, con gli ulteriori oneri previsti per prescrizione e asseverazione. Il D.M. 8 ottobre 2025, pubblicato il 16 febbraio 2026, disciplina questi oneri e i versamenti.

Elemento	Sicurezza del lavoro	Ambiente
Fonte	D.Lgs. 758/1994 e raccordo art. 301 D.Lgs. 81/2008	D.Lgs. 152/2006, parte VI-bis
Primo controllo	contravvenzione compresa nell'ambito applicabile	natura contravvenzionale, pena e condizioni dell'art. 318-bis
Prescrizione	organo di vigilanza, termine tecnicamente necessario	prescrizione con asseverazione tecnica
Esito favorevole ordinario	adempimento e pagamento nei termini	adempimento e pagamento nei termini, inclusi oneri applicabili
Errore	considerarla una multa amministrativa ordinaria	estenderla a qualsiasi danno ambientale o delitto

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E NOTIZIA DI REATO

Quando emergono fatti penalmente rilevanti, gli operatori che esercitano funzioni di polizia giudiziaria agiscono nei limiti della qualifica, delle attribuzioni e del codice di procedura penale. La notizia di reato, gli atti urgenti e i rapporti con l'autorità giudiziaria richiedono precisione e tempestività secondo le norme applicabili.

In sede d'esame non bisogna attribuirsi poteri che la traccia non indica. La risposta verifica qualifica, competenza, fattispecie e procedura, quindi descrive il percorso coerente.

PERCORSI NON SOVRAPPONIBILI

La stessa attività può rilevare irregolarità di natura diversa. Tuttavia:

- la non conformità è un giudizio rispetto a un requisito;
- l'illecito amministrativo richiede una fattispecie sanzionata amministrativamente;
- la contravvenzione è un reato;
- la prescrizione opera soltanto nel suo ambito;

- il provvedimento amministrativo risponde a presupposti e competenze proprie.

Non si sommano etichette per dare maggiore severità alla risposta. Si qualificano fatti e percorsi con prudenza.

Caso guidato: controllo AIA non esecutivo

TRACCIA

Durante un controllo programmato su un'installazione soggetta ad AIA, il gruppo deve verificare una prescrizione relativa a un'emissione convogliata. La documentazione indica un punto di misura e controlli periodici. Sul posto emergono difficoltà di accesso in sicurezza e una discrepanza tra il codice del punto riportato nel registro e quello presente sulla planimetria.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Perimetro: identificare autorità, AIA vigente, prescrizione, piano di monitoraggio, punto e parametro.
2. Sicurezza: non accedere al punto finché condizioni e coordinamento non siano adeguati; documentare l'impedimento.
3. Evidenze: acquisire registro, planimetria, identificativi, fotografie contestualizzate e dichiarazioni attribuite.
4. Discrepanza: descrivere i due codici senza concludere subito che il monitoraggio sia invalido.
5. Campionamento: verificare finalità, condizioni di esercizio, punto, metodo, durata, strumentazione e laboratorio. Se i presupposti mancano, motivare il rinvio o l'azione prevista.
6. Verbale: registrare attività svolte, limite incontrato, documenti e dichiarazioni.
7. Valutazione: confrontare requisito ed evidenza dopo aver chiarito l'identità del punto.
8. Esito: classificazione e azione spettano secondo AIA, disciplina e competenza; programmare follow-up.

La risposta è corretta perché non trasforma una discrepanza documentale in superamento del limite e non esegue un prelievo insicuro o metodologicamente inadeguato.

Domande e verifica

DOMANDA DA COMMISSARIO

«Quali elementi deve contenere un piano di campionamento?»

Risposta efficace: obiettivo e decisione da sostenere; oggetto e matrice; analita; strategia spaziale e temporale; metodo e versione; rappresentatività; controlli qualità; contenitori, identificazione, conservazione e trasporto; laboratorio; registrazioni e catena di custodia. Il dettaglio dipende dalla disciplina e dal metodo del caso.

DOMANDA-TRAPPOLA

«Ogni non conformità accertata dal TPALL determina una prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994?»

No. La procedura ha un ambito specifico riferito a determinate contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Occorre prima qualificare fatto, norma, competenza e percorso.

MINI-ESERCIZIO

Classifica le seguenti frasi:

1. «Il contenitore recava l'identificativo C-17»: fatto osservato.
2. «Il responsabile dichiara che il prelievo precedente è avvenuto lunedì»: dichiarazione attribuita.
3. «Il campione non è rappresentativo»: valutazione da motivare con piano, matrice e metodo.
4. «Il rapporto di prova riporta 12 mg/L»: contenuto documentale, da leggere con metodo, unità e requisito.

Quiz ragionati

QUIZ 1

Qual è il primo controllo logico prima di descrivere un potere ispettivo?

- A. L'importo della sanzione.
- B. Competenza, fonte, territorio e attribuzione.
- C. Il colore del modulo.
- D. Il laboratorio più vicino.

Soluzione: B. I poteri non derivano in modo uniforme dal solo titolo professionale.

QUIZ 2

Quale elemento collega il campione ai passaggi di consegna e laboratorio?

- A. La prevalenza.
- B. La catena di custodia.
- C. La BAT conclusion.
- D. L'ordinanza-ingiunzione.

Soluzione: B. Documenta identità, soggetti, tempi e condizioni dei trasferimenti.

QUIZ 3

Il rapporto di prova:

- A. sostituisce sempre il verbale.
- B. decide automaticamente la sanzione.
- C. espone risultati e metodo del laboratorio.
- D. attribuisce la qualifica di PG.

Soluzione: C. Deve essere integrato con campionamento, requisito e procedimento di controllo.

QUIZ 4

Per un'emissione convogliata, quale affermazione è corretta?

- A. Qualunque metodo dell'elenco ARPA è intercambiabile.
- B. Punto, condizioni, autorizzazione e metodo applicabile devono essere verificati.
- C. La rete di aria ambiente è la stessa cosa.
- D. Il BAT-AEL coincide sempre con il limite autorizzativo.

Soluzione: B. Gli altri enunciati confondono fonti e oggetti diversi.

QUIZ 5

Una non conformità:

- A. coincide sempre con un reato.
- B. è uno scostamento da un requisito applicabile.
- C. produce sempre prescrizione.
- D. può essere formulata senza evidenza.

Soluzione: B. Classificazione e conseguenze richiedono disciplina, evidenza e competenza.

Checklist finale

- ☐ Ho identificato ente, servizio, territorio e qualifica?
- ☐ Ho indicato norma, autorizzazione o requisito?
- ☐ Ho definito oggetto e finalità del controllo?
- ☐ Ho valutato sicurezza e coordinamento?
- ☐ Ho separato fatti, dichiarazioni, documenti, misure e valutazioni?
- ☐ Ho reso tracciabili fotografie e allegati?
- ☐ Il campionamento risponde a una domanda esplicita?
- ☐ Ho indicato matrice, metodo e rappresentatività?

- ☐ Ho considerato identificazione, conservazione, trasporto e catena di custodia?
- ☐ Ho distinto verbale, rapporto di prova, rapporto ispettivo e provvedimento?
- ☐ Ho collegato requisito, evidenza e non conformità?
- ☐ Ho evitato di anticipare una sanzione?
- ☐ Ho distinto illecito amministrativo e contravvenzione?
- ☐ Ho limitato prescrizione e funzioni di PG al loro ambito?
- ☐ Ho indicato limiti, dati mancanti e follow-up?

Riferimenti essenziali

- D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, profilo professionale del TPALL.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, salute e sicurezza sul lavoro.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, normativa ambientale.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, sanzioni amministrative.
- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
- Regolamento (UE) 2017/625 e D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, controlli ufficiali.
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, autorizzazione unica ambientale.
- Linee guida SNPA e manuali ISPRA su AIA, campionamento, aria, emissioni, BAT-AEL, terre e rocce, rifiuti e siti contaminati.

Prima dell'uso operativo vanno verificate vigenza, autorizzazione, metodo, attribuzioni, modulistica e procedura territoriale applicabili.

Prova pratica e casi professionali

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Obiettivo del capitolo

Nella prova pratica, ricordare una definizione è solo il punto di partenza. La commissione osserva come il candidato legge la situazione, stabilisce le priorità, agisce entro le proprie competenze e motiva le scelte. Contano anche la comunicazione, la documentazione e la verifica dell'esito.

La prova può chiedere un'esecuzione reale o simulata, la descrizione di una procedura, la soluzione di un caso, la predisposizione di un piano assistenziale o riabilitativo, la compilazione di un atto tecnico oppure una risposta orale strutturata. Il formato cambia; il ragionamento di fondo resta riconoscibile.

Al termine saprai:

- decodificare verbo, profilo, contesto, vincoli e prodotto richiesto;
- trasformare una traccia in una sequenza professionale ordinata;
- distinguere dati disponibili, informazioni mancanti, rischi e priorità;
- esplicitare competenze, limiti, collaborazione ed escalation;
- integrare sicurezza, comunicazione, documentazione e rivalutazione;
- impostare casi per infermiere, OSS, ostetrica, fisioterapista e TPALL;
- verificare la risposta prima della consegna.

Il capitolo insegna un metodo di soluzione. Non sostituisce procedure aziendali, protocolli clinici, istruzioni dei dispositivi, metodi tecnici, attribuzioni professionali o indicazioni della postazione d'esame.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
B — Bando	Quali profilo, prova, materie e criteri risultano dagli atti del concorso?	Perimetro della preparazione
A — Aree	La traccia riguarda assistenza, emergenza, prevenzione, riabilitazione, ostetricia o controllo?	Area professionale corretta

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
N — Nuclei	Quali conoscenze e decisioni sono indispensabili?	Priorità e sequenza
D — Diario	Che cosa deve essere osservato, comunicato, registrato e rivalutato?	Tracciabilità dell'azione
O — Output	È richiesto un piano, una procedura, un caso, un verbale o una risposta orale?	Elaborato coerente con la consegna

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Una buona risposta parte dal verbo della traccia e dal profilo messo a concorso. Separa fatti, dati mancanti e rischi; ordina le azioni per priorità e sicurezza; dichiara competenze e limiti. Motiva ciò che propone, indica comunicazioni e registrazioni necessarie, quindi rivaluta l'esito. Non inventa parametri, dosi, manovre, moduli o poteri non forniti dal caso.

Fondamenti della prova pratica

CHE COSA VIENE REALMENTE VALUTATO

La prova pratica verifica la capacità di applicare conoscenze a una situazione. Anche quando la consegna usa la parola «descrive», la risposta non dovrebbe essere una lista imparata a memoria. Deve mostrare il collegamento tra problema, decisione, azione e controllo dell'esito.

Le dimensioni più ricorrenti sono:

- analisi: comprendere la richiesta e selezionare i dati pertinenti;
- priorità: distinguere ciò che viene prima da ciò che può attendere;
- sicurezza: proteggere persona, operatore, ambiente e validità dell'attività;
- appropriatezza: proporre azioni coerenti con bisogno, evidenze e contesto;
- competenza: rispettare profilo, responsabilità e organizzazione;
- motivazione: spiegare perché una scelta è necessaria;
- comunicazione: identificare destinatario, contenuto e urgenza;
- documentazione: rendere ricostruibili dati, attività ed esiti;
- rivalutazione: verificare la risposta e stabilire quando fermarsi o attivare aiuto.

Il peso di ciascuna dimensione dipende dai criteri stabiliti dalla commissione. La griglia serve per prepararsi e impedisce di ridurre la prova alla sola esecuzione materiale.

IL VERBO GOVERNA LA RISPOSTA

«Elencare», «descrivere», «predisporre», «valutare», «eseguire», «motivare» e «redigere» non sono sinonimi.

- Elencare richiede elementi essenziali, ordinati e pertinenti.
- Descrivere richiede una sequenza comprensibile e completa.
- Predisporre richiede un piano pronto all'uso, con condizioni e controlli.
- Valutare richiede criteri, dati, confronto e giudizio motivato.
- Eseguire richiede comportamento sicuro, corretto e osservabile.
- Motivare richiede di collegare decisione, ragione e conseguenza.
- Redigere richiede forma documentale, fatti, riferimenti e tracciabilità.

Prima di rispondere, il candidato deve quindi sottolineare il verbo, identificare il destinatario dell'azione e nominare l'output finale. Una risposta clinicamente plausibile ma consegnata nel formato sbagliato può risultare incompleta.

DATI CERTI, DATI MANCANTI E IPOTESI

Un caso concorsuale offre spesso informazioni selezionate. Il candidato deve separare:

1. ciò che la traccia afferma;
2. ciò che può essere ragionevolmente ricavato;
3. ciò che occorre ancora accertare;
4. ciò che non può essere presunto.

I dati mancanti non autorizzano a bloccare ogni risposta. Si dichiarano e si spiega come recuperarli. Se la mancanza incide sulla sicurezza, l'azione viene sospesa o adattata e si attiva il professionista o il livello competente. È scorretto, invece, riempire i vuoti con valori, diagnosi, dispositivi o procedure inventati.

Il metodo LEAD-S

LEAD-S è un promemoria didattico costruito per organizzare la risposta: non è una scala clinica, una linea guida o un protocollo operativo. Le cinque lettere ricordano di Leggere, Estrarre, Agire, Documentare e Sorvegliare.

L — LEGGI LA CONSEGNA

Individua cinque elementi:

- il verbo che definisce l'operazione richiesta;
- il profilo professionale del candidato;
- il contesto, reale o simulato;
- il prodotto da consegnare;
- i vincoli: tempo, materiali, informazioni e regole della postazione.

La prima frase della risposta deve far capire che hai compreso il compito. Per esempio: «Imposto la gestione del caso individuando priorità assistenziali, azioni di competenza, comunicazioni, documentazione e criteri di rivalutazione».

E — ESTRAI DATI, RISCHI E PRIORITÀ

Raccogli i dati forniti e ordinali. Nelle situazioni rivolte alla persona considera condizioni, bisogni, cambiamenti, vulnerabilità, autonomia, ambiente e informazioni mancanti. Nei controlli tecnici considera mandato, requisito, oggetto, evidenze, sicurezza dell'accesso e metodo applicabile.

Formula poi una priorità. Non serve assegnare etichette diagnostiche non richieste: basta dichiarare quale problema deve essere affrontato per primo e perché. Se emergono segnali di possibile deterioramento o pericolo, la priorità diventa proteggere, interrompere l'attività non sicura e attivare tempestivamente il livello competente.

A — AGISCI IN SEQUENZA

La sequenza generale è:

preparazione → verifica iniziale → azione prioritaria → attività successive → rivalutazione → chiusura.

Ogni passaggio deve restare nel perimetro professionale. Quando una decisione spetta ad altri, il candidato non la simula: raccoglie e comunica i dati pertinenti, collabora all'intervento e documenta quanto svolto. Nei compiti delegati o attribuiti occorre verificare chiarezza della consegna, condizioni della persona, capacità di eseguire in sicurezza e necessità di riferire variazioni.

D — DOCUMENTA E COMUNICA

Una prova professionale non termina con il gesto. La risposta deve indicare:

- quali dati e attività registrare;
- a chi comunicare gli elementi rilevanti;
- con quale urgenza;
- quali esiti, anomalie o rifiuti rendere tracciabili;
- quali consegne assicurano continuità.

Quando il caso coinvolge la persona, si rispettano identificazione, dignità, riservatezza, informazione e consenso secondo il contesto. Nei controlli tecnici si distinguono fatti osservati, dichiarazioni, documenti, misure e valutazioni.

S — SORVEGLIA L'ESITO

La chiusura risponde a tre domande:

1. Che cosa controllo dopo l'intervento?
2. Quale risultato mi aspetto?
3. Quale cambiamento impone arresto, nuova valutazione o escalation?

Senza rivalutazione la risposta resta incompleta. Anche un'attività eseguita correttamente può non produrre l'esito previsto o può far emergere un nuovo rischio.

Sicurezza, competenze e limiti

LA SICUREZZA PRECEDE LA PRESTAZIONE

Prima di agire, verifica persona, ambiente, attrezzature e condizioni dell'operatore. In una stazione simulata segui le istruzioni ricevute e tratta i materiali come indicato. In un caso scritto dichiara le verifiche essenziali senza inventare dettagli esecutivi.

Sono segnali di una risposta pericolosa:

- procedere senza identificare correttamente persona, sito, campione o dispositivo;
- ignorare un cambiamento improvviso o un accesso non sicuro;
- usare un'attrezzatura senza verificarne idoneità, integrità e istruzioni;
- applicare una procedura locale come se fosse universale;
- oltrepassare competenze o attribuzioni;
- omettere la richiesta di aiuto quando il rischio supera le risorse disponibili;
- concludere senza controllo dell'esito.

La frase «chiamo il medico» o «avviso il responsabile» non basta da sola. Devi precisare quali dati comunichi, perché il contatto è urgente e che cosa fai, nel frattempo, entro la tua competenza.

AUTONOMIA E COLLABORAZIONE

Il professionista è responsabile delle attività che compie e delle decisioni comprese nel proprio profilo. L'autonomia si esercita valutando il caso, scegliendo le azioni pertinenti e riconoscendo quando occorrono integrazione o intervento altrui. Collaborare non significa trasferire indistintamente la responsabilità.

Per l'OSS assumono particolare rilievo l'organizzazione del servizio, le attività attribuite, le condizioni della persona, le indicazioni ricevute e l'obbligo di riferire cambiamenti. Per le professioni sanitarie regolamentate occorre collegare profilo, formazione, codice deontologico, evidenze e organizzazione. Per il TPALL vanno inoltre verificati ente, materia, territorio, mandato e funzioni concretamente attribuite.

ERRORI CRITICI DA INTERCETTARE

Una commissione può considerare particolarmente grave una condotta che espone a pericolo, viola un limite professionale o rende inattendibile l'atto. Non esiste una lista unica valida per ogni concorso, ma il candidato deve sorvegliare almeno questi errori:

1. mancato riconoscimento del rischio prioritario;
2. azione oltre competenza o senza presupposti;
3. assenza di escalation quando necessaria;
4. uso improprio di dispositivo, metodo o procedura;

5. omissione di identificazione, comunicazione o documentazione essenziale;
6. mancata rivalutazione;
7. trasformazione di un'ipotesi in fatto certo.

ERRORE TIPICO

Recitare la procedura ideale senza adattarla alla traccia. La commissione non cerca soltanto la sequenza: vuole vedere quali dati l'hanno determinata, quali limiti la condizionano e come controlleresti l'esito.

Laboratorio 1 — Infermiere: peggioramento della persona assistita

TRACCIA

Durante l'assistenza a una persona fragile ricoverata, l'infermiere rileva un cambiamento rispetto alla situazione precedente: la persona appare più debole, riferisce un nuovo malessere e collabora meno. La traccia non fornisce diagnosi né parametri completi. Predisponi la gestione iniziale del caso.

SOLUZIONE GUIDATA CON LEAD-S

Leggi. È richiesta una gestione iniziale, non una diagnosi. Il prodotto deve contenere valutazione, priorità, azioni infermieristiche, comunicazione e rivalutazione.

Estrai. Il dato centrale è il cambiamento rispetto al basale. Verifico immediatamente condizioni generali, sicurezza, responsabilità, sintomi riferiti e parametri pertinenti secondo contesto e procedura. Recupero informazioni su decorso, terapie, rischi e precedenti osservazioni senza ritardare l'attivazione se la situazione appare urgente.

Agisci. Rimango con la persona se vi è rischio, assicuro le prime misure di sicurezza di competenza, interrompo attività non prioritarie e attivo il percorso previsto per il deterioramento. Preparo informazioni e risorse utili alla valutazione successiva. Non assegno una diagnosi sulla base dei pochi dati e non invento trattamenti.

Documenta. Comunico in modo strutturato identità, situazione, cambiamento, dati raccolti, azioni compiute e risposta. Registro tempi, rilevazioni, comunicazioni, indicazioni ricevute e interventi attuati.

Sorveglia. Rivaluto con frequenza coerente con rischio e indicazioni, confronto con il basale e segnalo tempestivamente ogni ulteriore variazione. La chiusura del caso comprende la presa in carico da parte del livello attivato e la continuità delle consegne.

CRITERI DI CORRETTEZZA

Non confonde valutazione infermieristica e diagnosi medica; non aspetta dati completi davanti a un possibile peggioramento; rende visibili sicurezza, escalation, comunicazione e rivalutazione. Se il bando richiede una tecnica specifica, la preparazione deve essere integrata con la procedura e i criteri applicabili a quella tecnica.

Laboratorio 2 — OSS: trasferimento letto-carrozzina

TRACCIA

All'OSS viene chiesto di collaborare al trasferimento di una persona dal letto alla carrozzina. La persona è meno collaborante del solito e il sollevatore disponibile presenta un'imbracatura di cui non è certa la compatibilità. Descrivi come procedi.

SOLUZIONE GUIDATA CON LEAD-S

Leggi. La consegna riguarda collaborazione al trasferimento, sicurezza della persona e uso di un ausilio. Non richiede di inventare una manovra.

Estrai. Verifico identità, consegna, livello abituale di collaborazione, cambiamento osservato, ambiente, freni e ingombri, disponibilità di personale e condizioni dichiarate dell'ausilio. La compatibilità incerta dell'imbracatura è un limite decisivo.

Agisci. Non improvviso l'abbinamento tra sollevatore e imbracatura. Metto la persona in sicurezza, interrompo il trasferimento e riferisco al professionista di riferimento il cambiamento e il problema tecnico. L'attività riprende soltanto quando indicazioni, personale e dispositivo risultano adeguati, seguendo procedura organizzativa e manuale del fabbricante.

Documenta. Comunico dati concreti: minore collaborazione rispetto al solito, ausilio disponibile, elemento non verificato e attività sospesa. Registro o segnalo l'anomalia secondo l'organizzazione del servizio.

Sorveglia. Durante e dopo il trasferimento osservo tolleranza, postura, comfort, cute, sicurezza e ogni variazione da riferire. Ripristino ambiente, ausili e sistemi di chiamata secondo bisogno.

IL PUNTO DECISIVO

La sicurezza non viene sacrificata per completare il compito. Il candidato riconosce sia il cambiamento della persona sia il limite tecnico e agisce nel sistema di attribuzione e supervisione, evitando dettagli operativi non verificabili.

Laboratorio 3 — Ostetrica: segnale di allarme nel puerperio

TRACCIA

Durante l'assistenza in puerperio una donna riferisce un malessere nuovo e presenta un cambiamento che può indicare una complicanza. I dati sono incompleti. Illustra la risposta professionale iniziale.

SOLUZIONE GUIDATA CON LEAD-S

Leggi. È richiesto il riconoscimento e la gestione iniziale di un segnale d'allarme, non la ricostruzione di una singola emergenza né l'indicazione di dosi terapeutiche.

Estrai. Considero tempo dal parto, sintomi, perdite, dolore, condizioni generali, parametri pertinenti, fattori di rischio e andamento precedente. Valuto madre e, quando rilevante, neonato come persone distinte, senza perdere la priorità materna davanti a un possibile deterioramento.

Agisci. Non lascio sola la donna se la situazione è potenzialmente urgente, attivo il percorso locale e richiedo supporto appropriato. Avvio le misure previste di competenza, preparo materiali e informazioni, coordino i ruoli e preservo dignità e comunicazione con la donna. Procedure e manovre specifiche dipendono dal quadro riconosciuto e dal protocollo vigente.

Documenta. Comunico situazione, dati, evoluzione, fattori rilevanti, azioni ed esito. Registro tempi di comparsa, osservazioni, chiamate, indicazioni, interventi e rivalutazioni.

Sorveglia. Controllo la risposta, individuo criteri di ulteriore escalation e assicuro continuità nella presa in carico. Dopo l'evento, la verifica organizzativa o il debriefing non sostituisce la documentazione clinico-assistenziale.

CRITERI DI CORRETTEZZA

Mantiene alta l'attenzione sui segnali di allarme senza trasformare informazioni incomplete in diagnosi. In sede pratica, sequenze e manovre ostetriche devono essere eseguite soltanto secondo scenario, addestramento, protocollo e istruzioni della commissione.

Laboratorio 4 — Fisioterapista: variazione durante il trattamento

TRACCIA

Una persona, recentemente dimessa dopo un ricovero, segue un programma riabilitativo per recuperare autonomia. Durante la seduta riferisce un sintomo nuovo e mostra una prestazione diversa dal basale. Imposta la gestione del caso.

SOLUZIONE GUIDATA CON LEAD-S

Leggi. La traccia chiede di gestire una variazione durante il trattamento. Non chiede di proseguire a ogni costo né di formulare una diagnosi medica.

Estrai. Confronto il dato con valutazione iniziale, obiettivi, andamento, comorbidità, precauzioni e informazioni disponibili. Chiarisco caratteristiche del sintomo, attività che lo ha preceduto, condizioni osservabili e parametri pertinenti. Identifico eventuali segnali incompatibili con la prosecuzione sicura.

Agisci. Suspendo o modifico l'attività quando la sicurezza lo richiede, proteggerò la persona e attiverò il livello appropriato. Se non emergono segnali di allarme, rivaluto comunque indicazione, carico e tolleranza prima di decidere la prosecuzione. Non attribuisco il sintomo automaticamente a decondizionamento o scarsa motivazione.

Documenta. Registro attività, sintomo, momento di comparsa, dati raccolti, decisione, comunicazioni e risposta. Condivido gli elementi utili con l'équipe per mantenere coerenti obiettivi e programma.

Sorveglianza. Verifico l'evoluzione immediata e i criteri per ripresa, modifica o rivalutazione interdisciplinare. Gli esiti funzionali devono essere confrontabili nel tempo con misure appropriate al caso, senza usare una scala soltanto perché nota.

IL PUNTO DECISIVO

Integra ragionamento riabilitativo, sicurezza e continuità. Il piano resta centrato su funzione, partecipazione e obiettivi della persona, ma riconosce che un cambiamento può imporre una pausa e una valutazione ulteriore.

Laboratorio 5 — TPALL: controllo e campionamento

TRACCIA

Durante un controllo programmato su un'installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, occorre verificare una prescrizione relativa a un'emissione. Il codice del punto di misura non coincide nei documenti esaminati e l'accesso alla postazione presenta una condizione di sicurezza non chiarita. Predisponi la prosecuzione dell'attività.

SOLUZIONE GUIDATA CON LEAD-S

Leggi. Il prodotto è un piano di prosecuzione del controllo, non una sanzione e non un risultato analitico.

Estrai. Verifico ente, competenza, autorizzazione vigente, prescrizione, piano di monitoraggio, identificazione del punto, condizioni di esercizio, metodo previsto e mandato del gruppo. I codici discordanti sono il fatto osservato; la loro rilevanza deve ancora essere valutata.

Agisci. Non accedo né campiono finché la postazione non è sicura e il punto non è identificato con sufficiente certezza. Documento l'impedimento, acquisisco planimetria, registro, autorizzazione e dichiarazioni attribuite; chiarisco la discrepanza con il soggetto controllato e con gli atti. Il campionamento viene pianificato soltanto con obiettivo, matrice, metodo, rappresentatività, controlli di qualità, laboratorio e catena di custodia definiti.

Documenta. Nel verbale distinguo attività compiute, evidenze, documenti, dichiarazioni, limiti e operazioni rinviate. Non scrivo che il limite è superato o che esiste una violazione se non dispongo dei relativi presupposti.

Sorveglianza. Definisco integrazioni, responsabilità, tempi e follow-up secondo procedura e competenza. Risultati e non conformità saranno valutati rispetto al requisito applicabile; le conseguenze amministrative o penali non sono automatiche.

CRITERI DI CORRETTEZZA

Mantiene uniti sicurezza, validità tecnica e correttezza giuridica. Evita due errori frequenti: effettuare un prelievo in condizioni inadeguate e trasformare una discrepanza documentale in illecito già accertato.

Cinque casi completi: dall'obiettivo alla verifica

I dati seguenti sono simulati. Ciascun caso richiede una decisione professionale motivata e un esito controllabile; non basta scrivere «avviso il referente».

INFERMIERE: RECUPERARE AUTONOMIA NELL'IGIENE

Traccia. Una persona clinicamente stabile dopo un ictus comprende le istruzioni, muove l'arto superiore destro e richiede aiuto per igiene e vestizione. Il piano segnala deficit motorio a sinistra, rischio di caduta e necessità di assistenza nei trasferimenti. Riferisce imbarazzo quando viene aiutata. Imposta l'assistenza mattutina.

Soluzione. Distinguo la diagnosi medica dal bisogno infermieristico: deficit nella cura di sé, con risorse residue e rischio di perdita di autonomia. Concordo un obiettivo osservabile: eseguire personalmente le parti dell'igiene raggiungibili in sicurezza e scegliere l'abbigliamento. Preparo ambiente, privacy e materiali accessibili; verifico dolore e tolleranza, assisto nelle attività non sicure, proteggero la cute e coinvolgo l'OSS con indicazioni coerenti con piano e competenze. Evito di sostituirmi in tutto alla persona soltanto per finire prima. Registro attività svolte autonomamente, aiuto necessario, integrità cutanea e risposta emotiva. Alla rivalutazione confronto questi dati con il giorno precedente e adeguo il piano con l'équipe.

OSS: UNA SEQUENZA SICURA DI ASSISTENZA QUOTIDIANA

Traccia. Il piano assistenziale prevede igiene al lavabo con una persona vigile, collaborante, che può stare seduta e necessita di aiuto nei trasferimenti. Gli ausili prescritti sono disponibili e verificati. Descrivi l'intervento e la consegna.

Soluzione. Confermo identità, consegna e collaborazione; spiego l'attività e tutelo riservatezza. Preparo materiali, ambiente e ausili, eseguo igiene delle mani e uso i dispositivi necessari al rischio. Collaboro al trasferimento con personale e tecnica previsti, senza improvvisare sollevamenti. Lascio svolgere alla persona ciò che riesce a fare, aiuto nelle parti indicate e osservo cute, dolore e affaticamento. Al termine assicuro comfort, abbigliamento, campanello e sistemazione dell'ambiente. Riferisco, per esempio, «igiene del viso eseguita autonomamente; comparso arrossamento persistente al tallone sinistro, segnalato all'infermiere», senza diagnosticare una lesione. L'esito si valuta su partecipazione, comfort e assenza di eventi avversi, non sul solo completamento del compito.

OSTETRICA: DIMISSIONE DOPO PUERPERIO FISIOLOGICO

Traccia. Donna al secondo giorno dopo parto vaginale non complicato, condizioni stabili, neonato seguito nel percorso ordinario. Chiede quali cambiamenti osservare a domicilio e come organizzare il sostegno.

Soluzione. Rivaluto benessere, dolore, perdite, eliminazione, riposo, vissuto emotivo e avvio dell'allattamento secondo il percorso. Concordo un piano di continuità con recapiti e contatti previsti. Spiego che sanguinamento improvviso abbondante, dispnea, dolore toracico, convulsioni o rapido peggioramento richiedono soccorso urgente; febbre associata a malessere, dolore crescente, cefalea intensa o disturbi visivi richiedono tempestiva valutazione. Non presento una perdita normale come garanzia che non possano comparire complicanze. Verifico la comprensione chiedendo alla donna di descrivere come agirebbe in due scenari e chi può aiutarla. Documento bisogni, informazioni condivise, contatto successivo e criticità ancora aperte. Il neonato conserva il proprio percorso di valutazione e sorveglianza.

FISIOTERAPISTA: OBIETTIVO FUNZIONALE E MISURA DELL'ESITO

Traccia. Persona stabile in riabilitazione dopo ricovero, con indicazioni mediche disponibili e nessun nuovo allarme. Cammina per 20 metri con ausilio e supervisione; desidera raggiungere il bagno, distante 12 metri, in sicurezza. Definisci un piano breve.

Soluzione. Valuto trasferimenti, equilibrio, forza, tolleranza e barriere ambientali; verifico ausilio, precauzioni e bisogni della persona. L'obiettivo condiviso è completare il percorso letto-bagno nelle condizioni concordate, riducendo l'aiuto quando possibile. Programmo attività graduate e pertinenti: passaggi posturali, cammino sul percorso reale o simulato e gestione dell'ausilio, con dose individualizzata e criteri di interruzione. Non deduco l'autonomia dal solo fatto che 20 sia maggiore di 12: svolte, alzata, soglie e affaticamento possono cambiare il compito. Registro distanza, tipo di aiuto, pause, sintomi e qualità del movimento. Rivaluto con la stessa modalità e raccordo il risultato con équipe e caregiver.

TPALL: DALLA VERIFICA DOCUMENTALE ALLA CONCLUSIONE MOTIVATA

Traccia. Nel controllo AIA il punto E2 è stato identificato senza ambiguità, l'accesso è sicuro e la prescrizione richiede una misura annuale. Il gestore produce il rapporto relativo all'anno precedente e nessuna evidenza dell'anno corrente, il cui termine è già scaduto. Non sono disponibili misure per affermare un superamento emissivo.

Soluzione. Acquisisco autorizzazione, prescrizione, termine e documenti prodotti; verifico eventuali modifiche o proroghe. Distinguo mancata dimostrazione dell'autocontrollo da superamento del limite: solo la prima è sostenuta dai dati. Registro richieste, risposte e allegati e completo gli accertamenti necessari. L'autorità competente qualifica la violazione della prescrizione alla luce della norma applicabile e dispone il seguito; un eventuale campionamento ufficiale risponde a un quesito distinto. La verifica finale accerta l'esecuzione degli adempimenti richiesti e l'esito del procedimento, senza trasformare una nuova misura conforme nella prova che l'obbligo passato fosse stato rispettato.

Costruire una risposta orale efficace

Quando la commissione presenta un caso a voce, puoi organizzare l'esposizione in sei passaggi:

1. inquadramento: definisci problema, profilo e prodotto richiesto;
2. dati: richiama quelli disponibili e quelli da acquisire;
3. priorità: dichiara il primo obiettivo e la sua ragione;
4. azioni: esponi una sequenza, distinguendo competenze e collaborazione;
5. tracciabilità: indica comunicazioni e documentazione;
6. chiusura: descrivi rivalutazione, criteri di arresto o escalation e continuità.

Non è una formula da recitare. Serve a evitare salti logici. Se la commissione interrompe, rispondi al nuovo quesito e poi riprendi dal punto necessario, senza ricominciare ogni volta dall'inizio.

Il linguaggio deve essere preciso ma comprensibile. Sono preferibili frasi come «verifico», «confronto», «comunico» e «rivaluto» rispetto a formule impersonali. Quando il dato manca, dichiaralo: «La traccia non indica il tipo di dispositivo; prima dell'uso verifico compatibilità e istruzioni». Questa prudenza dimostra controllo del caso, non insicurezza.

Autoverifica della prova

La seguente rubrica è uno strumento didattico, non una griglia ufficiale. Per ogni voce indica presente, parziale o assente.

Area	Domanda di controllo
Consegna	Ho risposto al verbo e prodotto l'output richiesto?
Dati	Ho distinto informazioni certe, mancanti e ipotesi?
Priorità	È chiaro che cosa viene prima e perché?
Sicurezza	Ho riconosciuto rischi, condizioni di arresto e protezioni?
Competenza	Ho rispettato profilo, attribuzioni e collaborazione?
Sequenza	Le azioni sono ordinate e realizzabili?

Area	Domanda di controllo
Motivazione	Ogni scelta decisiva ha una ragione esplicita?
Comunicazione	Ho indicato destinatario, contenuto e urgenza?
Documentazione	Dati, attività ed esiti sono tracciabili?
Rivalutazione	Ho definito risultato atteso, controllo ed escalation?

Se una voce decisiva è assente, correggi la risposta. Non compensare una lacuna di sicurezza con maggiori dettagli tecnici.

Domande e verifica

DOMANDA DA COMMISSARIO

«Come affronta una prova pratica quando la traccia non contiene tutti i dati necessari?»

Risposta efficace: distinguo ciò che è noto da ciò che devo accertare; individuo quali mancanze incidono sulla sicurezza o sulla decisione; raccolgo i dati disponibili con gli strumenti pertinenti; procedo nelle attività sicure e di competenza; sospendo o attivo aiuto quando mancano presupposti essenziali; documento ipotesi, limiti e rivalutazione. Non invento informazioni per chiudere artificialmente il caso.

DOMANDA-TRAPPOLA

«Per ottenere un buon punteggio conviene descrivere sempre la procedura più completa possibile?»

No. La procedura deve essere pertinente alla consegna, al profilo, ai dati e alle condizioni. Aggiungere manovre, poteri o dettagli non richiesti può introdurre errori e nascondere la priorità.

MINI-ESERCIZIO

Leggi la consegna: «Predisporre la risposta iniziale a un evento imprevisto durante un'attività professionale».

Completa in cinque frasi:

1. Leggo: il verbo richiesto è ____ e l'output è ____.
2. Estraggo: il dato prioritario è ____; manca ____.
3. Agisco: per prima cosa ____ perché ____.
4. Documento: comunico e registro ____.
5. Sorveglio: rivaluto ____; attivo aiuto se ____.

Verifica poi se hai nominato sicurezza, competenza e limite. Se hai scritto soltanto una tecnica, il caso non è ancora completo.

Quiz ragionati

QUIZ 1

Quale elemento definisce per primo la forma della risposta?

- A. La procedura più lunga studiata.
- B. Il verbo della consegna e l'output richiesto.
- C. Il numero di candidati.
- D. Il titolo del manuale.

Soluzione: B. Il contenuto deve essere organizzato in funzione dell'azione e del prodotto richiesti.

QUIZ 2

Se manca un dato decisivo per usare in sicurezza un dispositivo, il candidato deve:

- A. scegliere il valore più probabile;
- B. procedere e riferire dopo;
- C. sospendere l'uso, verificare il dato e attivare il riferimento competente;
- D. omettere il problema dalla risposta.

Soluzione: C. La mancanza va gestita, non colmata con un'ipotesi.

QUIZ 3

Quale affermazione descrive meglio l'autonomia professionale?

- A. Agire senza comunicare con nessuno.
- B. Decidere e agire nel proprio perimetro, riconoscendo quando integrare altre competenze.
- C. Eseguire sempre l'indicazione ricevuta.
- D. Evitare ogni responsabilità personale.

Soluzione: B. Autonomia, responsabilità e collaborazione devono rimanere coerenti.

QUIZ 4

In un caso TPALL, una discordanza tra due codici del punto di misura dimostra da sola:

- A. il superamento del limite;
- B. un reato ambientale;
- C. la necessità di chiarire identità, requisito ed evidenze;
- D. l'inutilità del verbale.

Soluzione: C. La discordanza è un'evidenza da verificare, non una conclusione sanzionatoria automatica.

QUIZ 5

Quale passaggio chiude correttamente un caso professionale?

- A. Ripetere la definizione iniziale.
- B. Aggiungere una tecnica non richiesta.
- C. Indicare esito da controllare, rivalutazione e criteri di escalation.
- D. Dichiarare che non servono ulteriori dati.

Soluzione: C. La prestazione deve essere verificata e collegata alla continuità.

Checklist finale

- ☐ Ho identificato verbo, profilo, contesto e output?
- ☐ Ho separato dati certi, dati mancanti e ipotesi?
- ☐ Ho dichiarato priorità e motivazione?
- ☐ Ho verificato persona, ambiente, strumenti o oggetto del controllo?
- ☐ Ho rispettato competenze, attribuzioni e procedure applicabili?
- ☐ Ho indicato quando sospendere e quando attivare aiuto?
- ☐ Ho ordinato preparazione, azione, rivalutazione e chiusura?
- ☐ Ho evitato dosi, parametri, manovre o poteri non forniti?
- ☐ Ho previsto comunicazione strutturata e documentazione?
- ☐ Ho indicato risultato atteso e criteri di ulteriore escalation?
- ☐ La risposta è leggibile e aderente alla domanda?

Riferimenti essenziali

- D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
- D.M. 14 settembre 1994, n. 739; D.M. 14 settembre 1994, n. 740; D.M. 14 settembre 1994, n. 741; D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, profili rispettivamente di infermiere, ostetrica, fisioterapista e TPALL.
- Legge 26 febbraio 1999, n. 42; legge 10 agosto 2000, n. 251; legge 1° febbraio 2006, n. 43, inquadramento delle professioni sanitarie.
- D.P.C.M. 25 marzo 2025, revisione del profilo dell'operatore socio-sanitario, da coordinare con la disciplina attuativa e organizzativa applicabile.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, sicurezza delle cure e responsabilità professionale.
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219, consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
- Linee di indirizzo e raccomandazioni del Ministero della salute sulla sicurezza dell'assistenza e sul triage.
- Linee guida e documenti ISS, SNLG, ItOSS, OMS e IRC pertinenti ad assistenza, puerperio, emergenze e riabilitazione.

- Normativa ambientale, autorizzazioni e linee tecniche SNPA, ISPRA e ARPA applicabili ai controlli TPALL.

Per l'esecuzione reale occorre sempre verificare il testo vigente, la procedura dell'ente, il protocollo locale, il metodo tecnico, il manuale del dispositivo e le attribuzioni professionali applicabili al caso.

M-SA03

Dirigenza medica e sanitaria

Sezione interna del volume VOL-07 — Sanità amministrativa e professioni sanitarie.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	15 Profili, requisiti e prove della dirigenza sanitaria; 16 Programmazione sanitaria e organizzazione dei servizi
Sviluppo	17 Linee guida, appropriatezza e decisioni cliniche; 18 Governo clinico, HTA, qualità, accreditamento e rischio
Allenamento	19 Epidemiologia e sanità pubblica per la dirigenza; 20 Dirigenza medica: discipline e casi
Strumenti	21 Dirigenza sanitaria non medica: discipline e casi

Profili, requisiti e prove della dirigenza sanitaria

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

La dicitura "dirigenza sanitaria" non identifica una preparazione unica. Un concorso per dirigente medico in una disciplina clinica, uno per dirigente medico nell'area dell'igiene e uno per dirigente farmacista appartengono allo stesso ampio contesto del Servizio sanitario nazionale (SSN), ma non richiedono gli stessi titoli né verificano lo stesso sapere professionale.

Il primo compito del candidato è dunque classificare bene la procedura. Prima di scegliere il manuale specialistico deve capire quale profilo è messo a concorso, quale disciplina è indicata, quali requisiti sono richiesti e quale prodotto sarà valutato nelle prove. Un errore in questa fase può rendere inutile molto studio: si può preparare bene una materia e scoprire di non possedere un requisito, oppure allenarsi su un tema quando la prova richiede un caso o l'illustrazione di una tecnica.

La disciplina di riferimento per i concorsi della dirigenza del SSN è il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. Il regolamento tratta requisiti specifici, titoli, commissioni e prove distinguendo i profili. Il bando traduce quella cornice nella procedura concreta. I due livelli vanno letti insieme: il regolamento non sostituisce il bando e il bando non autorizza ad applicare per analogia la disciplina prevista per un'altra professione.

Le famiglie della dirigenza sanitaria

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine saprai:

- distinguere le principali famiglie concorsuali comprese nella dirigenza medica e sanitaria;
- leggere i requisiti nella sequenza corretta, senza confondere ammissione e valutazione dei titoli;
- riconoscere quali dati sono relativamente stabili e quali cambiano da una procedura all'altra;
- distinguere concorso ordinario e avviso temporaneo;
- collegare prova scritta, pratica e orale all'output richiesto;
- compilare un Bando Decoder specifico per M-SA03;
- gestire un requisito dubbio senza colmarlo con un'interpretazione personale.

Il capitolo insegna il quadro comune. Non sostituisce la preparazione clinica, biologica, farmaceutica, psicologica o di altra disciplina, che richiede fonti e allenamenti propri.

LA DISTINZIONE CHE VIENE PRIMA DI TUTTO

Il D.P.R. 483/1997 disciplina in modo differenziato medici, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti. Già questo elenco mostra perché "dirigente sanitario" non basta per identificare requisiti e prove. Occorre leggere la denominazione completa.

Nel lavoro di orientamento sono utili tre famiglie.

Famiglia	Identità della preparazione	Output che può ricorrere
Dirigenza medica per disciplina	conoscenza clinica verticale, ragionamento sul caso, appropriatezza, sicurezza e compiti della funzione	relazione su un caso, trattazione di un argomento, quesiti sintetici, illustrazione di tecniche, colloquio
Igiene, epidemiologia, organizzazione e territorio	lettura di bisogni e dati di popolazione, prevenzione, programmazione, reti e organizzazione dei servizi	tema o quesiti, piano di sanità pubblica, lettura epidemiologica, progetto organizzativo, colloquio
Dirigenza sanitaria non medica	sapere professionale proprio del profilo e della disciplina: per esempio laboratorio, farmacia ospedaliera o psicologia	trattazione specialistica, prova applicativa differenziata, illustrazione di metodi o tecniche, colloquio

La seconda famiglia non è separata dalla dirigenza medica sul piano professionale: serve qui come distinzione didattica, perché sposta l'oggetto della prova dal singolo caso clinico alla popolazione, ai servizi e all'organizzazione. Anche al suo interno il bando resta decisivo.

La terza famiglia è la più esposta alle generalizzazioni. Biologo, farmacista e psicologo non sono varianti di una stessa prova pratica. Cambiano titolo di base, iscrizione professionale, specializzazione, attività e contenuti tecnici. Lo stesso vale per gli altri profili disciplinati dalla normativa. La parte comune riguarda il metodo di lettura del concorso, non il sapere tecnico.

MAPPA BANDO

Il Metodo BANDO aiuta a trasformare la classificazione in un piano.

Fase	Domanda per M-SA03	Risultato
B — Bando	Quali sono profilo, disciplina, tipo di procedura, requisiti e prove?	scheda di ammissibilità
A — Aree	Quale nucleo è comune e quale appartiene alla disciplina?	mappa delle materie

Fase	Domanda per M-SA03	Risultato
N — Nuclei	Quali concetti e output possono decidere la prova?	priorità di studio
D — Diario	Quali requisiti, equivalenze, date o comunicazioni devo ricontrollare?	elenco di dubbi con fonte e scadenza
O — Output	Devo produrre una relazione, risolvere un caso, illustrare una tecnica o sostenere un colloquio?	allenamento coerente con la prova

La mappa evita due estremi: preparare soltanto la disciplina e ignorare la procedura, oppure studiare il regolamento concorsuale senza allenare il sapere professionale che la commissione deve valutare.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La dirigenza sanitaria comprende profili diversi. Il nome completo del profilo viene prima dell'elenco delle materie. Il D.P.R. 483/1997 distingue requisiti e prove per professione. Il bando definisce la procedura concreta. La preparazione è corretta solo quando profilo, disciplina, prova e output sono allineati.

Punteggi ordinari: distinguere dirigenza e comparto

Per i profili centrali di questo modulo, il D.P.R. 483/1997 stabilisce il seguente quadro dei concorsi ordinari per titoli ed esami.

Profilo	Articolo sul punteggio	Titoli	Scritta
Medico	27	20	30
Farmacista	35	20	30
Biologo	43	20	30
Psicologo	55	20	30

Profilo	Pratica	Orale
Medico	30	20
Farmacista	30	20
Biologo	30	20
Psicologo	30	20

Nei quattro casi i 20 punti dei titoli si dividono in 10 per carriera, 3 per titoli accademici e di studio, 3 per pubblicazioni e titoli scientifici, 4 per curriculum formativo e professionale. L'art. 14 richiede almeno 21/30 nella scritta e nella pratica e 14/20 nell'orale. I titoli non compensano una prova insufficiente: 20 punti nei titoli non rendono idonea una pratica da 20/30.

Il contenuto delle prove e la valutazione dei singoli titoli restano specifici del profilo. Questo schema non va trasferito automaticamente agli incarichi di struttura complessa, a procedure speciali o ad altri ordinamenti. Nel bando si controllano fonte applicata, eventuali deroghe e modalità concrete; una difformità merita verifica, non una correzione personale del bando.

Requisiti: la sequenza corretta di controllo

CINQUE PASSAGGI, NELLO STESSO ORDINE

Il controllo dei requisiti deve essere documentale. Non basta che il proprio percorso "sembri compatibile". Occorre confrontare ciò che il bando richiede con ciò che risulta dai titoli e dalle attestazioni possedute.

La sequenza più sicura è questa:

1. identificare la denominazione esatta del profilo;
2. individuare la disciplina messa a concorso;
3. trascrivere separatamente ogni requisito specifico;
4. associare a ciascun requisito il documento che dovrebbe dimostrarlo;
5. segnare come dubbio ogni corrispondenza non letterale.

Nei concorsi disciplinari ricorrono titolo di studio abilitante, abilitazione, iscrizione all'ordine e specializzazione nella disciplina o in una disciplina ammessa dalla normativa e dal bando. Questa è una struttura di lettura, non una formula da copiare in ogni domanda. Per i profili non medici cambiano il titolo di base, l'ordine professionale e la specializzazione pertinente.

PROFILO E DISCIPLINA NON SONO SINONIMI

Il profilo indica la figura professionale. La disciplina circoscrive il settore per il quale si concorre. Due bandi possono cercare lo stesso profilo ma discipline diverse; di conseguenza possono cambiare specializzazione richiesta, programma e contenuto delle prove.

Per il candidato, la conseguenza è pratica: non si controlla soltanto se il titolo appartiene alla stessa area generale. Si verifica se corrisponde alla formulazione del bando e alle regole applicabili alla disciplina. Se compare un'alternativa, come una disciplina equipollente o affine, non la si presume sulla base della somiglianza del nome. Occorre individuare l'atto ufficiale richiamato e verificare la corrispondenza.

Lo stesso metodo vale quando il bando disciplina l'ammissione di medici in formazione specialistica o prevede condizioni particolari. La possibilità osservata in una procedura non diventa automaticamente una regola per la successiva.

REQUISITO DI AMMISSIONE E TITOLO VALUTABILE

Un requisito di ammissione è una condizione necessaria per partecipare. Se manca, la qualità complessiva del curriculum non compensa l'assenza. Un titolo valutabile, invece, può concorrere al punteggio attribuito ai titoli secondo le regole della procedura.

La distinzione incide sulla lettura:

- i requisiti vanno verificati prima di investire nello studio;
- i titoli valutabili vanno censiti e documentati secondo il bando;
- le materie d'esame vanno trasformate in un piano di preparazione;
- i tre elenchi non devono essere fusi in un'unica lista.

Anche quando lo stesso documento ha rilievo in più punti, il candidato deve capire quale funzione svolge: consente l'accesso, viene valutato oppure prova un dato dichiarato.

IL DUBBIO VA TRASFORMATO IN UN'AZIONE

Un titolo con denominazione diversa, una specializzazione non citata letteralmente o un'iscrizione con decorrenza particolare non si risolvono affidandosi a forum, riassunti o analogie. Il candidato deve:

1. copiare la clausola esatta;
2. annotare la fonte ufficiale richiamata;
3. confrontare denominazione e data del proprio titolo;
4. controllare gli eventuali chiarimenti ufficiali della procedura;
5. usare il canale indicato dall'ente per una richiesta formale, se il dubbio resta.

La risposta dell'ente, quando prevista, non va sostituita da una rassicurazione informale. Il costo di un controllo in più è basso; il costo di una domanda fondata su un requisito soltanto supposto può essere alto.

Commissione e prove: che cosa deve produrre il candidato

LA COMMISSIONE VALUTA UN PROFILO PRECISO

La commissione non valuta una generica cultura sanitaria. Opera nella procedura prevista per un determinato profilo e una determinata disciplina. Il D.P.R. 483/1997 regola anche le commissioni con distinzioni coerenti con i profili; il bando e gli atti della procedura permettono di conoscere la disciplina applicata e le modalità concrete.

Per prepararsi non serve anticipare chi porrà la singola domanda. Serve comprendere che la valutazione riguarda due dimensioni:

- padronanza del sapere professionale richiesto;
- capacità di trasformarlo nella forma prevista dalla prova.

Una risposta clinicamente o tecnicamente corretta può essere debole se non rispetta la traccia. Una risposta ben ordinata resta insufficiente se elude la disciplina.

CONCORSO ORDINARIO E AVVISO TEMPORANEO

Nei quindici bandi ufficiali esaminati per questa famiglia, la struttura dominante dei concorsi ordinari è la valutazione dei titoli seguita da prova scritta, prova pratica e prova orale. Nel gruppo dedicato a igiene, organizzazione e territorio sono stati osservati anche avvisi temporanei basati su titoli e colloquio.

La differenza non è terminologica. Cambia il percorso selettivo e, quindi, cambia il piano di allenamento.

Procedura	Segnale da cercare	Conseguenza sullo studio
Concorso ordinario	titoli e sequenza di prove indicata dal bando	preparazione distinta per scritto, pratica e orale
Avviso temporaneo	durata o incarico legato all'avviso; selezione su titoli e colloquio quando previsto	maggior concentrazione sul curriculum documentato e sul colloquio, senza inventare prove assenti

Il candidato deve leggere la sezione dedicata alla procedura, non dedurre la struttura dal solo nome del posto.

PROVA SCRITTA

Nei bandi della dirigenza medica, la prova scritta può assumere la forma di una relazione su un caso simulato, della trattazione di un argomento della disciplina o di quesiti sintetici. Per i profili non medici i contenuti cambiano con la professione. In igiene e organizzazione possono assumere rilievo un problema di sanità pubblica, un progetto o una questione organizzativa.

Tre allenamenti non sono intercambiabili:

- la relazione richiede selezione dei dati, ordine del ragionamento e conclusione motivata;
- il quesito sintetico richiede definizione, elementi, distinzione e conseguenza senza dispersione;
- il progetto richiede coerenza tra problema, obiettivo, azione, responsabilità e verifica.

Il bando può specificare forma e programma. Se non lo fa in modo dettagliato, il candidato non deve inventare un formato certo: prepara una struttura flessibile e controlla gli avvisi successivi.

PROVA PRATICA

La prova pratica verifica l'applicazione della disciplina. Nei bandi medici può riguardare tecniche e manualità e richiedere un'illustrazione schematica per iscritto. Nei profili sanitari non medici il contenuto applicativo è differenziato: laboratorio, farmacia e psicologia, per esempio, non possono essere ricondotti a un'unica prova.

"Pratica" non significa necessariamente esecuzione materiale davanti alla commissione. Può significare descrivere una procedura, interpretare dati, motivare una sequenza operativa o illustrare una tecnica nel formato stabilito. Il candidato deve ricavare dal bando:

- oggetto della prova;
- modalità di svolgimento;
- eventuale forma scritta dell'illustrazione;
- criteri o indicazioni comunicati;
- strumenti consentiti, se specificati.

L'allenamento efficace rende visibili presupposti, passaggi, controlli, limiti e sicurezza. Non aggiunge dettagli esecutivi che la traccia non consente di sostenere.

PROVA ORALE

L'orale può verificare la disciplina e i compiti connessi alla funzione. L'art. 37 del D.Lgs. 165/2001 richiede l'accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche diffuse e della lingua inglese; altre lingue possono essere previste in relazione al profilo. L'obbligo generale va coordinato con la disciplina concorsuale sanitaria: il bando specifica modalità, livello e collocazione della verifica, non rende l'inglese una materia meramente facoltativa.

Una risposta dirigenziale ordinata può seguire questa sequenza:

1. definire l'oggetto della domanda;
2. collocarlo nel profilo e nel contesto organizzativo;
3. esporre elementi e distinzioni;
4. mostrare la conseguenza professionale;
5. indicare il limite o il dato che richiede verifica.

Questa struttura non sostituisce la conoscenza disciplinare. Serve a renderla valutabile, soprattutto quando la domanda collega contenuto tecnico, sicurezza, appropriatezza e organizzazione.

DALLA PROVA ALL'ALLENAMENTO

Traccia	Output da allenare	Controllo finale
Caso clinico simulato	relazione con dati, ipotesi, priorità, decisione e limiti	la risposta resta pertinente e non inventa dati mancanti
Argomento della disciplina	trattazione breve con definizione, quadro, elementi e applicazione	ogni paragrafo risponde alla domanda
Tecnica o manualità	illustrazione ordinata di presupposti, passaggi, controlli e sicurezza	il livello di dettaglio è coerente con profilo e setting
Problema di sanità pubblica	schema bisogno-obiettivo-azione-indicatore-verifica	popolazione e denominatore sono chiari
Quesito orale	risposta progressiva con esempio e limite	niente elenco mnemonico privo di nesso

La tabella è una guida di allenamento. Il testo del bando e gli avvisi della procedura stabiliscono l'output effettivo.

Dati stabili e dati mobili

GLI ANCORAGGI PROFESSIONALI

Alcuni elementi sono relativamente stabili perché derivano dall'identità professionale e dalla disciplina concorsuale:

- denominazione del profilo;
- relazione tra profilo e disciplina;
- necessità dei titoli professionali richiesti per quel percorso;
- distinzione tra requisito di accesso, titolo valutabile e materia d'esame;

- differenziazione delle prove tra i profili;
- separazione tra disciplina concorsuale e rapporto di lavoro.

"Relativamente stabile" non significa che il candidato possa smettere di verificare. Significa che l'elemento nasce da una fonte sovraordinata rispetto al singolo calendario o al numero dei posti.

Il CCNL Area Sanità regola il rapporto di lavoro della dirigenza interessata. Il contratto 2022-2024 è stato sottoscritto definitivamente il 27 febbraio 2026. Non va però usato come sostituto del D.P.R. 483/1997 o del bando per ricostruire i requisiti concorsuali. Accesso, selezione e disciplina del rapporto sono piani collegati, ma distinti.

LE VARIABILI DEL SINGOLO BANDO

Molti dati cambiano e devono essere ricontrollati ogni volta:

Dato mobile	Perché non si può trasferire da un altro bando
numero dei posti, riserve e preferenze	dipendono dalla singola procedura
disciplina e specializzazioni ammesse	la formulazione può cambiare per profilo e atto richiamato
ammissione di candidati in formazione specialistica	non è identica in tutte le procedure
anzianità o ulteriori condizioni	possono essere previste o escluse dalla disciplina applicabile
rapporto esclusivo	va letto nella clausola concreta
sedi, durata e progetto	dipendono dall'ente e dalla natura dell'incarico
forma dettagliata delle prove	cambia per profilo, disciplina e procedura
informatica e inglese	obbligo generale ex art. 37; verificare modalità e livello
punteggi, soglie, calendario e convocazioni	appartengono alla procedura specifica
domanda, allegati e comunicazioni	seguono le istruzioni ufficiali dell'ente

LA REGOLA OPERATIVA

Ogni dato del Decoder deve avere un'etichetta:

- S — strutturale: deriva dall'identità del profilo o dalla disciplina applicabile;
- M — mobile: è valido per il singolo bando o avviso;
- V — da verificare: la formulazione non consente ancora una conclusione sicura.

L'etichetta V non è una lacuna. È un promemoria operativo. Diventa problematica soltanto se resta senza fonte, responsabile del controllo e data entro cui chiarirla.

ATTENZIONE

Equipollenze, affinità, ammissione di candidati in formazione specialistica, anzianità e rapporto esclusivo non si trasferiscono per analogia. Copia la clausola del tuo bando, individua l'atto richiamato e verifica il tuo caso documentale prima di fare affidamento sul requisito.

Bando Decoder per M-SA03

Il Decoder per la dirigenza sanitaria deve rispondere a due domande: "posso partecipare?" e "che cosa devo produrre per essere valutato?". La versione seguente è completa per l'avvio dello studio. Il template generale del Metodo BANDO può essere usato in seguito per calendario, confronto tra procedure e pianificazione più ampia.

PAGINA 1: ACCESSO E IDENTITÀ PROFESSIONALE

Campo	Compilazione
Ente e fonte ufficiale	
Natura della procedura	concorso ordinario / avviso temporaneo / altra forma indicata
Denominazione completa del profilo	
Disciplina	
Titolo di base richiesto	
Abilitazione richiesta	
Iscrizione professionale richiesta	
Specializzazione richiesta	

Campo	Compilazione
Discipline equipollenti o affini richiamate	
Altre condizioni di ammissione	
Documento con cui provo ogni requisito	
Dubbi e fonte da consultare	

La colonna non va compilata a memoria. Accanto a ogni requisito è utile riportare articolo o paragrafo del bando. Se una condizione deriva da un atto richiamato, si annotano anche titolo e data dell'atto.

PAGINA 2: PROVE, OUTPUT E CONTROLLO

Campo	Compilazione
Valutazione dei titoli	titoli richiesti, titoli valutabili, documentazione
Prova scritta	forma, materie, output
Prova pratica	forma, disciplina, modalità di illustrazione
Prova orale	materie, compiti della funzione, altri accertamenti
Comunicazioni successive	canale ufficiale e frequenza di controllo
Primo output da allenare	
Prima simulazione	
Punto ad alto rischio	
Decisione	procedo / procedo dopo verifica / non procedo

COME TRASFORMARE I CAMPI IN STUDIO

Il Decoder non è una trascrizione del bando. Ogni riga deve produrre un'azione.

- Se la prova scritta è una relazione, il primo allenamento è una scaletta completa, non una batteria casuale di quiz.
- Se la pratica richiede illustrazione scritta, serve una griglia per ordinare presupposti, passaggi e controlli.
- Se la selezione è su titoli e colloquio, non si aggiungono prove assenti per abitudine.
- Se un requisito è dubbio, si sospende la decisione di ammissibilità e si apre una verifica.
- Se il programma è ampio, si separano nucleo trasversale e disciplina, poi si assegnano output diversi.

La decisione finale deve essere scritta. "Procedo dopo verifica" è più utile di un sì incerto, perché indica che lo studio può iniziare soltanto entro un limite di rischio definito.

Esempio guidato: leggere una procedura senza inventare

IL TESTO DIDATTICO

Un'azienda sanitaria pubblica un concorso ordinario per un dirigente sanitario in un profilo non medico e in una disciplina specifica. Il bando elenca titolo, abilitazione, iscrizione all'ordine e specializzazione secondo la formulazione applicabile al profilo. Prevede valutazione dei titoli, prova scritta, prova pratica e prova orale. La prova pratica richiede l'illustrazione di un metodo pertinente alla disciplina.

Una candidata possiede il titolo di base e l'iscrizione professionale. La denominazione della sua specializzazione, però, non coincide con quella scritta nel bando. Ha trovato online un concorso precedente nel quale un titolo dal nome simile era stato ammesso.

Il caso è composito e serve a mostrare il metodo. Non riproduce un bando reale e non consente di decidere l'ammissibilità della candidata.

COMPILAZIONE RAGIONATA

Il primo errore sarebbe partire dalla somiglianza tra i due titoli. La candidata deve invece separare fatti e inferenze.

Elemento	Stato	Azione
profilo e disciplina	presenti nel bando	trascrivere senza abbreviazioni
titolo di base	corrispondenza documentabile	associare il documento

Elemento	Stato	Azione
iscrizione professionale	corrispondenza documentabile	verificare decorrenza e dichiarazione richiesta
specializzazione	denominazione non coincidente	classificare V — da verificare
bando precedente trovato online	procedura diversa	non usarlo come prova di ammissibilità
prove	scritta, pratica e orale	aprire tre linee di allenamento

Per il requisito dubbio, la candidata copia la clausola, individua gli atti ufficiali sulle discipline ammesse richiamati dalla procedura, confronta il proprio titolo e controlla eventuali chiarimenti dell'ente. Se il canale ufficiale lo consente, formula una richiesta precisa. Fino a quel momento l'esito resta "procedo dopo verifica".

PIANO DI OUTPUT

La preparazione parte comunque dalla forma delle prove, senza fingere che il requisito sia già risolto:

1. per lo scritto, prepara una risposta sintetica su un nucleo della disciplina;
2. per la pratica, costruisce una griglia di illustrazione del metodo con presupposti, sequenza, controlli e limiti;
3. per l'orale, prepara una spiegazione di due minuti che collega disciplina, funzione e sicurezza;
4. nel Diario segna il requisito dubbio, la fonte da controllare e la data limite.

La soluzione non è "studiare tutto in attesa". È mantenere separati due flussi: verifica dell'ammissibilità e allenamento dell'output. Se il requisito viene confermato, il lavoro prosegue. Se non viene confermato, la candidata interrompe la preparazione per quella procedura senza confondere il risultato con il proprio valore professionale.

Verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: Qual è la differenza tra requisito di ammissione, titolo valutabile e materia d'esame?

Risposta modello: il requisito di ammissione è una condizione necessaria per partecipare e deve essere posseduto e documentato secondo il bando. Il titolo valutabile incide sul punteggio attribuito ai titoli, se la procedura lo prevede. La materia d'esame è il contenuto sul quale il candidato deve dimostrare conoscenza o capacità applicativa. I tre piani possono avere collegamenti, ma vanno letti separatamente perché producono conseguenze diverse.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: Poiché il D.P.R. 483/1997 disciplina i concorsi della dirigenza del SSN, tutti i profili sostengono la stessa prova pratica?

Risposta: no. Il regolamento distingue i profili e i contenuti delle prove. Anche i bandi esaminati mostrano output diversi tra discipline mediche, igiene e organizzazione, biologia, farmacia e psicologia. La forma concreta si ricava dal bando; non si trasferisce la prova di un profilo a un altro.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è leggere prima l'elenco delle materie e soltanto dopo i requisiti e le prove. L'ordine corretto è l'opposto: profilo, disciplina, ammissibilità, natura della procedura, prove, output e infine piano delle materie. Così lo studio nasce dal concorso reale.

MINI-ESERCIZIO

Classifica ogni elemento con S (strutturale), M (mobile) o V (da verificare nel caso concreto).

Elemento	Tua risposta
Identità del profilo professionale	
Numero dei posti	

Elemento	Tua risposta
Denominazione della disciplina del bando	
Ammissione di candidati in formazione specialistica	
Iscrizione all'ordine richiesta per il profilo	
Corrispondenza tra una specializzazione dal nome diverso e quella ammessa	
Calendario della prova orale	
Distinzione tra prova scritta e pratica	
Modalità e livello della verifica di inglese	
Sede dell'incarico	

Soluzione ragionata: l'identità del profilo, l'iscrizione professionale pertinente e la distinzione tra le forme di prova sono ancoraggi S, pur dovendo essere letti nella fonte applicabile. Numero dei posti, disciplina scelta dall'ente, ammissione di candidati in formazione, calendario, modalità/livello della verifica di inglese e sede sono dati M; l'obbligo generale di accertamento dell'inglese e dell'informatica è un ancoraggio normativo S. La corrispondenza tra specializzazioni con denominazioni diverse è V finché non viene verificata sugli atti ufficiali richiamati.

CHECKLIST FINALE

Prima di chiudere il Decoder, controlla:

- ho scritto profilo e disciplina per esteso;
- ho distinto concorso ordinario e avviso temporaneo;
- ogni requisito ha un documento associato;
- ho separato requisiti, titoli valutabili e materie;
- non ho dedotto equipollenze o affinità dal solo nome;
- ho ricavato dal bando tutte le prove previste;
- a ogni prova corrisponde un output di allenamento;
- dati mobili e dubbi hanno una fonte e una scadenza di controllo;

- controllo soltanto i canali ufficiali indicati dalla procedura;
- il mio piano specialistico appartiene davvero al profilo richiesto.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per la disciplina concorsuale della dirigenza del SSN, da applicare secondo profilo e disciplina.
- Bando, allegati, avvisi e atti della singola procedura, che definiscono requisiti, prove, calendario e comunicazioni concrete.
- Atti ufficiali richiamati dal bando per discipline equipollenti o affini e per le altre condizioni di accesso.
- CCNL Area Sanità 2022-2024 per il rapporto di lavoro, tenuto distinto dalla disciplina dell'ammissione al concorso.
- Fonti professionali e tecnico-scientifiche proprie della disciplina per la preparazione dei contenuti specialistici.

Programmazione sanitaria e organizzazione dei servizi

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Programmare in sanità non significa scrivere un elenco di buone intenzioni. Significa partire da un bisogno osservabile, scegliere una priorità, assegnare responsabilità e risorse, misurare l'esito e correggere la rotta. In una prova concorsuale il candidato deve mostrare questa catena, senza confondere un obiettivo con un'attività o un indicatore con un risultato.

Dai LEA al cruscotto di servizio

Per il quadro di SSN, aziende, distretto e flussi riprendi «SSN, aziende sanitarie, atti e flussi informativi» di M-SA01. Qui il passaggio ulteriore è usare le informazioni per decidere. Il NSIS organizza flussi informativi sanitari; il Nuovo Sistema di Garanzia, introdotto dal D.M. 12 marzo 2019 e operativo dal 2020, monitora i LEA. Il sottoinsieme CORE consente la valutazione delle macro-aree prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera. Nel metodo NSG la sufficienza richiede almeno 60 punti in ciascuna area: un risultato alto nell'ospedaliera non compensa una prevenzione insufficiente.

Il cruscotto seguente è un esempio didattico originale, non una riproduzione degli indicatori o dei target ufficiali NSG. Periodo, popolazione ed esclusioni devono essere fissati prima del calcolo.

Indicatore di servizio	Numeratore / denominatore	Dato simulato	Target didattico
Completezza delle consegne	dimissioni eleggibili con campi obbligatori completi / tutte le dimissioni eleggibili nel mese	180/200 = 90%	almeno 95%
Presa in carico entro il tempo concordato	persone eleggibili prese in carico entro il termine del percorso / persone eleggibili inviate con documentazione completa	72/80 = 90%	almeno 90%

Indicatore di servizio	Numeratore / denominatore	Dato simulato	Target didattico
Riammissioni non programmate	persone dimesse vive con riammissione non programmata entro 30 giorni / persone dimesse vive con follow-up osservabile per 30 giorni	8/160 = 5%	non oltre 5%

Il primo indicatore suggerisce di verificare dove manchino le informazioni. Il secondo richiede di controllare anche quanti invii restino esclusi per documentazione incompleta: un buon valore può nascondere una barriera d'accesso. Il terzo non dimostra da solo la qualità delle dimissioni: gravità, casistica e completezza del follow-up influenzano il risultato. Il dirigente associa quindi al numero una fonte, un responsabile, una periodicità e un'azione verificabile, evitando di premiare un miglioramento ottenuto restringendo artificiosamente il denominatore.

Il ciclo di programmazione

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine saprai ricostruire il ciclo di programmazione sanitaria, distinguere i livelli nazionale, regionale e aziendale, collegare bisogni, obiettivi, risorse e indicatori e trasformare un problema organizzativo in un programma verificabile.

La programmazione rende coerenti popolazione, servizi e risorse. Non sostituisce il giudizio professionale sul singolo caso: crea le condizioni organizzative perché la presa in carico sia accessibile, appropriata e valutabile.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda utile	Output di studio
Bando	Il programma richiede organizzazione, LEA, reti, territorio o indicatori?	parole-chiave della traccia
Aree	Il problema riguarda bisogno, accesso, processo o esito?	mappa del problema

Passaggio	Domanda utile	Output di studio
Nuclei	Quali sono popolazione, obiettivo, azione, risorse e misura?	schema di risposta
Diario	Quale dato o regola dipende dal territorio?	punto da verificare
Output	Devo proporre un piano, leggere un indicatore o discutere una rete?	risposta o progetto breve

Il ciclo essenziale è: conoscere il contesto, individuare il bisogno, definire una priorità, progettare gli interventi, attuarli, misurare e rivalutare. Un buon programma rende esplicito il legame tra ogni passaggio; non parte dalla soluzione preferita da chi lo scrive.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Un bisogno non è ancora un obiettivo. Un obiettivo non è un'attività. Un'attività non dimostra da sola un risultato. La programmazione collega bisogno, popolazione, azioni, risorse, responsabilità, indicatore e valutazione. Se manca uno di questi elementi, il piano è difficile da governare.

Quadro teorico della programmazione sanitaria

La programmazione sanitaria è un processo decisionale continuo: usa informazioni disponibili per orientare servizi e risorse verso bisogni prioritari, verifica gli effetti delle azioni e modifica ciò che non funziona. Il suo valore sta nel rendere esplicito il nesso tra decisione, responsabilità e risultato, non nel produrre documenti separati dall'attività dei servizi.

Dal bisogno al problema prioritario

Un bisogno sanitario può emergere da dati di salute, uso dei servizi, attese, disuguaglianze di accesso, segnalazioni degli operatori o confronto con standard applicabili. Il dato è il punto di partenza; l'interpretazione richiede di chiedersi per chi esiste il problema, con quale intensità, in quale percorso e con quali conseguenze.

Non ogni bisogno diventa una priorità nello stesso momento. La scelta considera rilevanza, gravità, ampiezza della popolazione coinvolta, fattibilità e risorse disponibili. Questa selezione non autorizza a ignorare i problemi esclusi: serve a rendere una decisione sostenibile e controllabile.

DAL DATO ALLA DECISIONE

Domanda	Esempio di risposta utile
Qual è il bisogno?	difficoltà di accesso a un percorso territoriale
Chi riguarda?	popolazione definita e area di riferimento
Quale ostacolo lo produce?	passaggi frammentati, informazione insufficiente o capacità non adeguata
Quale cambiamento si cerca?	accesso più tempestivo e continuità del percorso
Come lo si controllerà?	indicatore con fonte, periodo e responsabile

La definizione del problema deve restare prudente. Un indicatore sfavorevole può segnalare un approfondimento necessario, ma da solo non dimostra una causa. Nella risposta concorsuale conviene distinguere fatti osservati, ipotesi di lavoro e decisioni da verificare.

Livelli nazionale, regionale e aziendale

Il Servizio sanitario nazionale (SSN) opera attraverso livelli collegati. Il livello nazionale definisce il quadro generale, compresi i Livelli essenziali di assistenza (LEA), e orienta monitoraggio e garanzia dell'assistenza. Le Regioni organizzano e programmano il proprio servizio sanitario nel rispetto del quadro nazionale. Le aziende sanitarie e ospedaliere traducono gli indirizzi in servizi, percorsi, responsabilità e uso concreto delle risorse.

I livelli non sono copie dello stesso piano. Il livello nazionale stabilisce indirizzi e garanzie comuni; quello regionale adatta l'organizzazione al territorio; quello aziendale trasforma gli obiettivi in processi e risultati verificabili. Una rete territoriale, per esempio, non va descritta come un organigramma astratto: occorre indicare destinatari, accessi, passaggi, professionisti coinvolti e verifica.

CHE COSA NON VA GENERALIZZATO

Piani regionali, atti aziendali, denominazioni delle strutture, tempi e target numerici dipendono dal contesto. In una prova si può descrivere il metodo, ma non attribuire a tutte le aziende una procedura locale. Se la traccia indica Regione o ente, il candidato deve usare il documento richiamato e dichiarare ciò che richiede verifica.

Obiettivi e risorse

Un obiettivo efficace descrive il cambiamento atteso per una popolazione o un percorso. "Migliorare il servizio" è un'intenzione; "ridurre i passaggi non necessari nel percorso definito, monitorando accesso e continuità" è una direzione verificabile. L'obiettivo va accompagnato da azioni, responsabili, tempi, risorse e condizioni di sicurezza.

Le risorse non sono soltanto economiche. Comprendono persone, competenze, tempo, spazi, tecnologie, dati, accordi tra servizi e capacità di coordinamento. Progettare senza indicarle trasforma il programma in una dichiarazione. Ridurre tutto al budget, però, fa perdere il rapporto tra organizzazione e qualità.

Elemento	Domanda di controllo
Obiettivo	quale cambiamento atteso e per chi?
Azione	quale passaggio concreto lo rende possibile?
Responsabile	chi coordina e chi contribuisce?
Risorsa	cosa serve perché l'azione sia realistica?
Rischio	quale ostacolo può compromettere il percorso?
Verifica	quale evidenza mostrerà avanzamento o criticità?

Indicatori e valutazione

L'indicatore è una misura definita usata per osservare un fenomeno o un cambiamento. Non sostituisce il giudizio professionale e non va scelto perché è facile da contare. Deve essere pertinente all'obiettivo e interpretabile nel contesto.

È utile distinguere tre domande: le risorse previste sono disponibili? Le attività e i passaggi si svolgono come progettato? Il percorso produce il cambiamento atteso? Da qui derivano indicatori di struttura, processo ed esito. Un indicatore richiede almeno definizione, numeratore quando pertinente, denominatore o popolazione di riferimento, fonte, periodo, responsabile e limite interpretativo.

Un valore cambia significato se cambia la popolazione osservata, il periodo o la qualità della registrazione. Per questo la valutazione confronta dati omogenei, ascolta gli operatori e verifica gli effetti indesiderati. L'obiettivo della misurazione è apprendere e migliorare, non trovare un colpevole.

Caso di programma: continuità di un percorso territoriale

Un'azienda rileva segnalazioni di cittadini e operatori su passaggi poco chiari tra servizi territoriali. I dati disponibili suggeriscono che una parte degli utenti rinuncia o arriva tardi al servizio appropriato. Il dato non basta per attribuire la causa, ma giustifica l'analisi del percorso.

Il gruppo di lavoro definisce la popolazione interessata, mappa i punti di accesso e raccoglie informazioni su tempi, rinvii e comunicazioni. Sceglie un obiettivo: rendere il percorso più comprensibile e continuo per la popolazione definita. Prevede una procedura di orientamento, un referente di percorso, momenti di confronto tra servizi e una verifica periodica.

Blocco	Decisione motivata
Bisogno	accesso e continuità da approfondire
Obiettivo	ridurre frammentazioni evitabili nel percorso definito
Risorse	referenti, tempo di coordinamento, informazioni aggiornate e dati utilizzabili
Indicatori	accessi completati, rinvii, tempi osservati e riscontri degli utenti
Limite	risultati e target dipendono dal contesto locale

La risposta non promette un effetto prima di misurarlo. Mostra invece come collegare bisogno, azione e verifica. In un orale, questa sequenza vale più di un elenco di sigle.

Verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: Come impostaresti un programma sanitario partendo da un bisogno territoriale?

Risposta modello: definirei popolazione e problema usando dati e informazioni pertinenti; distinguerei il bisogno osservato dalle cause da verificare; sceglierei una priorità motivata; formulerei un obiettivo, azioni, responsabilità e risorse; indicherei indicatori di struttura, processo ed esito con fonte e periodo; prevederei una rivalutazione per correggere il programma.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: Se un'attività è stata realizzata, il programma ha raggiunto il risultato?

Risposta: no. L'attività documenta che un'azione è stata svolta; il risultato richiede una misura coerente con il cambiamento atteso e un'interpretazione nel contesto.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è partire dalla soluzione, per esempio aprire un servizio o acquistare uno strumento, senza definire bisogno, popolazione, responsabilità e indicatore. Il progetto diventa così difficile da valutare e da correggere.

MINI-ESERCIZIO

Completa la sequenza: per un problema di accesso a un percorso, scrivi una popolazione, un obiettivo, un'azione, una risorsa, un indicatore di processo e un limite da verificare. Poi controlla che ogni riga risponda alla precedente: il dato giustifica il bisogno, il bisogno giustifica l'obiettivo e l'indicatore misura davvero ciò che l'obiettivo promette.

CHECKLIST FINALE

- ho distinto bisogno, priorità, obiettivo, azione e risultato;
- ho indicato popolazione e livello organizzativo;
- ho collegato risorse e responsabilità alle azioni;
- ho scelto indicatori pertinenti e interpretabili;
- non ho trasformato un dato locale in una regola nazionale;
- ho previsto verifica e correzione del programma.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per organizzazione, aziende sanitarie, distretto e programmazione.
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017, sui Livelli essenziali di assistenza (LEA).
- D.M. 2 aprile 2015, n. 70, sugli standard dell'assistenza ospedaliera, e D.M. 23 maggio 2022, n. 77, sui modelli e standard dell'assistenza territoriale.
- Atti regionali e aziendali richiamati dalla traccia, da usare solo per il territorio e la procedura cui si riferiscono.

Linee guida, appropriatezza e decisioni cliniche

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Una linea guida non sostituisce la decisione professionale. Aiuta a renderla più trasparente: chiarisce il quesito, esamina le prove, formula raccomandazioni e dichiara il contesto nel quale possono essere applicate.

Ciclo di vita della linea guida

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine saprai distinguere evidenza, raccomandazione, appropriatezza e procedura locale; leggere forza e limiti di una linea guida; motivare una decisione senza trasformare una raccomandazione in un comando automatico.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda	Output
Bando	La traccia chiede evidenze, appropriatezza o decisione?	quesito preciso
Aree	Riguarda popolazione, intervento, setting o risorse?	confini del caso
Nuclei	Quali prove e quale raccomandazione?	scaletta motivata
Diario	Versione e contesto sono verificati?	limite esplicito
Output	Devo argomentare una scelta?	risposta ordinata

Il percorso metodologico parte dal quesito, ricerca e valuta le prove, considera benefici e possibili effetti indesiderati, quindi formula e aggiorna la raccomandazione. Il Sistema Nazionale Linee Guida rende pubbliche linee guida e documenti collegati; per una decisione conta sempre anche versione, popolazione e setting.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Evidenza e raccomandazione non sono sinonimi. La qualità delle prove non coincide con la forza della raccomandazione. Una linea guida non è un protocollo locale. L'appropriatezza unisce efficacia, persona, setting, risorse e fattibilità. La decisione deve dichiarare ciò che resta da verificare.

Forza della raccomandazione e qualità delle prove

Il metodo GRADE distingue la certezza delle prove dalla forza di una raccomandazione. Una raccomandazione forte indica che il bilancio complessivo sostiene con maggiore nettezza una scelta; una raccomandazione condizionata richiede più attenzione alle circostanze e alle preferenze. In entrambi i casi il lettore deve chiedersi a quale popolazione si riferisca e quali esiti siano stati considerati.

La forza non deriva da un solo studio né dal prestigio dell'autore. Il giudizio considera benefici, effetti indesiderati, valori e preferenze, equità, accettabilità, fattibilità e risorse. Il manuale concorsuale insegna ad argomentare il rapporto fra prove e decisione. Nel caso reale la scelta clinica resta responsabilità del professionista abilitato, che esercita la propria autonomia entro competenze, evidenze, condizioni della persona e obblighi professionali.

Dimensioni dell'appropriatezza

Una scelta può essere supportata da prove e risultare comunque non appropriata per una persona o un servizio se non è trasferibile al setting, ignora un vincolo rilevante o non è realizzabile in sicurezza. L'appropriatezza clinica riguarda il rapporto fra bisogno e intervento; quella organizzativa riguarda anche percorso, tempi, competenze, coordinamento e risorse.

Dimensione	Controllo
Quesito	popolazione e problema coincidono con il caso?
Evidenze	versione e raccomandazione sono pertinenti?
Persona	valori, preferenze e condizioni rilevanti sono considerati?
Setting	competenze, rete e sicurezza rendono possibile la scelta?
Verifica	quale esito o limite deve essere monitorato?

Adattamento locale senza deformare la raccomandazione

Adattare non significa riscrivere una linea guida per comodità. Significa verificare se popolazione, risorse e organizzazione permettono di applicarla e documentare lo scostamento quando è necessario. Una procedura aziendale organizza responsabilità e passaggi nel proprio setting; non può essere presentata come regola nazionale.

L'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 collega la pratica alle raccomandazioni previste dal sistema delle linee guida, tenendo conto delle specificità del caso concreto. Nella prova concorsuale è corretto distinguere norma, linea guida, raccomandazione, buona pratica e protocollo.

Caso decisionale: una scelta tracciabile

Un gruppo valuta un percorso per una popolazione definita. Esiste una linea guida pertinente, ma il servizio deve verificare competenze disponibili, continuità con gli altri nodi della rete e modalità di informazione. Il gruppo non conclude che la raccomandazione sia inapplicabile: raccoglie i dati necessari, identifica il limite organizzativo e definisce una verifica successiva.

La risposta corretta separa: fatto disponibile, raccomandazione, condizione del setting e decisione motivata. Non inventa un esito clinico né usa una raccomandazione come formula valida per ogni persona.

Risposta orale

Una risposta ordinata può: definire il quesito; indicare fonte e versione; distinguere certezza delle prove e forza della raccomandazione; valutare persona e setting; dichiarare decisione, limite e verifica. Questo mostra ragionamento, non memorizzazione di sigle.

Verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: Perché una raccomandazione forte non elimina il giudizio sul caso?

Risposta modello: perché la forza esprime il bilancio delle prove nel quesito considerato, ma la decisione richiede di verificare popolazione, condizioni della persona, setting, fattibilità e limiti applicativi.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: Un protocollo aziendale e una linea guida nazionale hanno lo stesso ruolo?

Risposta: no. La linea guida formula raccomandazioni su evidenze e contesto; il protocollo locale organizza l'applicazione in un servizio determinato.

ERRORE TIPICO

Citare una linea guida senza controllare versione, popolazione o forza della raccomandazione. Il riferimento diventa ornamentale e non sostiene la decisione.

MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

Per una traccia, compila: quesito, linea guida e versione, raccomandazione, benefici e limiti, condizione del setting, decisione e verifica. Controlla di non aver confuso evidenza con ordine automatico o procedura locale con regola nazionale.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

- Istituto Superiore di Sanità, Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica, versione 2.0, dicembre 2024.
- Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità, catalogo delle linee guida pubblicate.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 5, nel testo vigente.

Governo clinico, HTA, qualità, accreditamento e rischio

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Qualità, sicurezza, accreditamento, audit e valutazione delle tecnologie non sono attività isolate. Nel governo clinico concorrono a una stessa domanda: come rende un'organizzazione sanitaria le proprie decisioni assistenziali fondate, trasparenti, verificabili e migliorabili? In una prova concorsuale occorre saper collegare questi strumenti senza confonderne funzione, livello decisionale e valore giuridico.

Riconoscere gli eventi e scegliere lo strumento di analisi

Un evento avverso produce un danno correlato all'assistenza; non ogni evento avverso deriva da errore. Un near miss è un incidente che non determina danno, perché intercettato o per circostanze favorevoli. Un evento sentinella è particolarmente grave, potenzialmente evitabile e indicativo di un possibile problema di sistema: richiede analisi e azioni appropriate anche se osservato una sola volta. La lista e il protocollo ministeriale guidano la segnalazione attraverso SIMES, il sistema informativo nazionale per il monitoraggio degli errori in sanità. L'incident reporting interno e il flusso SIMES hanno funzioni collegate, ma non sono intercambiabili.

Strumento	Quando parte	Domanda e risultato
RCA, analisi delle cause	dopo un evento o criticità selezionata	quali fattori hanno consentito l'accaduto e quali barriere vanno rafforzate?
FMEA, analisi dei modi di guasto	prima dell'evento, su un processo	dove può fallire il processo, con quali effetti e quali controlli preventivi?

Applicazione. In una somministrazione è stato selezionato il paziente sbagliato e il doppio controllo ha intercettato l'errore: è un near miss, non un danno da presumere. La RCA ricostruisce sequenza, identificatori, interfaccia, interruzioni e comunicazioni, senza fermarsi a «disattenzione». Prima di introdurre un nuovo sistema, la FMEA scompone prescrizione, selezione, preparazione e somministrazione; per ciascuna fase identifica possibili errori, effetti e capacità di intercettazione. Si può scegliere di rendere visibili due identificatori e impedire selezioni ambigue, quindi verificare errori e tempi.

Un punteggio di priorità locale aiuta il confronto, ma non dimostra una probabilità clinica universale. Per il caso tecnologico e il collegamento fra evento, dispositivo e azione correttiva, riprendi «Tecnologie, dispositivi, apparecchiature e rischio» di M-SA04.

Architettura del governo clinico

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine saprai descrivere il governo clinico come sistema, costruire un audit, distinguere qualità e accreditamento, impostare un mini-HTA, analizzare il rischio senza attribuzioni premature di colpa e proporre un ciclo di miglioramento misurabile.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Output atteso
Bando	La traccia chiede qualità, rischio, HTA o accreditamento?	perimetro corretto
Aree	Quali dimensioni cliniche, organizzative e normative sono coinvolte?	mappa del sistema
Nuclei	Quali standard, dati, attori e strumenti servono?	argomentazione completa
Diario	Quali fonti e requisiti devono essere aggiornati?	limite e cut-off
Output	Serve un caso, un audit o una valutazione?	risposta verificabile

Il governo clinico è la cornice nella quale professionisti e organizzazione assumono responsabilità per qualità e sicurezza. Non coincide con il solo controllo amministrativo e non è affidato a un singolo ufficio. Integra evidenze, competenze, audit, formazione, gestione del rischio, partecipazione, dati e miglioramento dei processi.

La governance diventa concreta quando sono definiti almeno cinque elementi: obiettivo, responsabilità, standard o criterio, dato osservabile e ciclo di verifica. Se manca uno di essi, il programma rischia di restare una dichiarazione di principio.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il governo clinico coordina strumenti diversi. La qualità descrive e migliora processi ed esiti; l'accreditamento verifica requisiti per operare nel sistema; l'audit confronta pratica e criterio; l'HTA informa decisioni sulle tecnologie; la gestione del rischio apprende da eventi, quasi eventi e condizioni pericolose.

EVIDENZE, PDTA, ÉQUIPE E FORMAZIONE

L'Evidence-Based Practice (EBP) porta nel governo clinico un metodo: formulare il quesito, cercare e valutare le prove, distinguere la certezza delle evidenze dalla forza delle raccomandazioni e verificarne l'applicabilità. Le evidenze non decidono da sole; vanno integrate con competenza professionale, caratteristiche della persona, setting, risorse e preferenze. Il manuale metodologico ISS-SNLG versione 2.0 del dicembre 2024 offre il riferimento ufficiale per il passaggio dalle evidenze alle raccomandazioni.

Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) traduce per una popolazione definita il raccordo fra raccomandazioni e organizzazione. Specifica accesso, passaggi, responsabilità, snodi tra servizi, continuità e indicatori. Non è una linea guida e non sostituisce il giudizio sul singolo caso: rende esplicito come il sistema locale prende in carico il bisogno secondo le fonti applicabili.

La multiprofessionalità richiede ruoli leggibili, obiettivi condivisi, comunicazione e sedi decisionali definite. Non significa che tutte le professioni abbiano le stesse competenze. La formazione, infine, deve rispondere a un divario osservato e va verificata nella pratica: numero di partecipanti e ore erogate misurano l'attività, non dimostrano da soli il miglioramento. In un progetto completo, audit, confronto in équipe e formazione mirata possono concorrere alla stessa azione correttiva.

Qualità: dimensioni, indicatori e miglioramento

La qualità sanitaria non si esaurisce nella conformità formale. Deve essere definita rispetto al problema, alla popolazione e allo standard scelto: solo così può essere tradotta in criteri e indicatori. Le dimensioni da valutare non costituiscono un elenco universale; dipendono dalla fonte applicabile e possono riguardare, per esempio, sicurezza, appropriatezza, continuità o accesso.

Un indicatore richiede numeratore, denominatore quando pertinente, fonte, periodo, popolazione e significato. Il valore osservato non dimostra da solo la causa di un problema. Può segnalare uno scostamento, ma l'interpretazione deve considerare completezza dei dati, composizione della popolazione, setting e possibili fattori confondenti.

Piano di osservazione	Esempio di domanda	Limite da dichiarare
condizioni	le risorse e le competenze richieste dal criterio sono disponibili?	presenza non equivale a uso corretto
attività	il passaggio previsto è stato eseguito e documentato?	adempimento non prova il risultato

Piano di osservazione	Esempio di domanda	Limite da dichiarare
risultato	il cambiamento atteso è osservabile con la misura scelta?	associazione non equivale a causalità
effetti collaterali	l'intervento ha creato ritardi, esclusioni o duplicazioni?	il miglioramento va letto nell'intero percorso

Accreditamento e requisiti

L'autorizzazione e l'accREDITAMENTO istituzionale non sono sinonimi. In termini generali, l'autorizzazione riguarda i requisiti per l'esercizio dell'attività sanitaria; l'accREDITAMENTO istituzionale verifica requisiti ulteriori per i soggetti che intendono operare per conto del Servizio sanitario nazionale. L'accREDITAMENTO è necessario, ma non equivale da solo all'erogazione di prestazioni a carico del SSN: il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 disciplina separatamente accREDITAMENTO (articolo 8-quater) e accordi contrattuali (articolo 8-quinquies). Procedure, manuali, periodicità e organismi di verifica dipendono anche dalla disciplina regionale vigente.

Per il candidato è essenziale distinguere tre livelli:

- il requisito, che formula ciò che deve essere assicurato;
- l'evidenza, che dimostra come il requisito è attuato;
- la verifica, che valuta presenza, applicazione e mantenimento nel tempo.

Un documento non basta se la pratica non è coerente; una buona pratica locale non sostituisce un requisito obbligatorio. Nella risposta vanno citati il sistema regionale e il manuale applicabile solo dopo averli identificati nella traccia o nel bando.

Audit clinico

L'audit clinico è un ciclo di miglioramento, non una ricerca del colpevole. Parte da un tema rilevante, definisce criterio e standard, raccoglie dati sulla pratica, misura lo scostamento, analizza le cause, attua azioni e ripete la misurazione.

La sequenza essenziale è:

1. scegliere il problema e la popolazione;
2. individuare criteri fondati su fonti pertinenti;
3. fissare lo standard applicabile, distinguendolo da un target didattico;
4. definire dati, periodo e responsabilità;
5. confrontare pratica e criterio;
6. progettare azioni sulle cause modificabili;
7. eseguire il re-audit.

Un audit senza re-audit descrive ma non dimostra il miglioramento. Un audit privo di criterio esplicito produce opinioni, non un confronto verificabile.

Health Technology Assessment

L'Health Technology Assessment (HTA) valuta una tecnologia nel percorso in cui dovrebbe essere usata. Per tecnologia si possono intendere dispositivi, farmaci, procedure, sistemi organizzativi o soluzioni digitali, secondo il perimetro del metodo applicabile. L'HTA sostiene decisioni; non coincide con l'acquisto e non si riduce al prezzo.

Nel processo HTA, assessment e appraisal non coincidono. L'assessment formula il quesito e raccoglie, valuta e sintetizza le evidenze sui domini pertinenti, rendendo visibili qualità dei dati e incertezza. L'appraisal è il successivo giudizio contestuale e deliberativo: interpreta quel quadro rispetto a priorità, valori, equità, fattibilità e livello decisionale, con il coinvolgimento previsto degli stakeholder. Dall'appraisal può derivare una raccomandazione a supporto della decisione; non una conseguenza automatica dei soli dati.

Un mini-HTA concorsuale può seguire questa griglia:

Domínio	Domanda
problema e comparatore	quale bisogno affronta e rispetto a quale alternativa?
efficacia e sicurezza	quali benefici e rischi sono documentati?
economia	quali costi e conseguenze economiche sono pertinenti?
organizzazione	quali competenze, volumi, spazi e flussi richiede?
etica, equità e società	chi può beneficiare o restare escluso?
incertezza	quali dati mancano e come saranno monitorati?

La decisione può variare tra livello nazionale, regionale e aziendale. Una valutazione locale non deve pretendere di sostituire processi nazionali o regionali; deve dichiarare mandato, comparatore, fonti e condizioni di utilizzo. Al cut-off del 31 luglio 2026, AGENAS identifica come operativo il PNHTA-DM 2026–2028 per i dispositivi medici. Il riferimento non si estende automaticamente a ogni tecnologia o valutazione locale; programma, documenti metodologici e atti applicabili vanno ricontrollati alla data del bando.

Gestione del rischio clinico

La legge 8 marzo 2017, n. 24 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e coinvolge nelle attività di prevenzione del rischio tutto il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Questa cornice non autorizza conclusioni automatiche sulla responsabilità del singolo.

Nel lessico ministeriale, l'evento avverso è un evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno non intenzionale e indesiderabile. Nell'analisi organizzativa è utile distinguere:

- evento avverso, secondo la definizione ministeriale appena richiamata;
- near miss o quasi evento, quando la sequenza avrebbe potuto produrre danno ma viene intercettata o non lo determina;
- condizione pericolosa, quando esistono fattori capaci di favorire un evento.

Le definizioni operative di near miss e condizione pericolosa devono essere lette nel sistema di segnalazione adottato e negli indirizzi vigenti. Segnalare serve ad apprendere; l'analisi ricostruisce fatti, condizioni e barriere. Non attribuisce colpa o nesso causale senza l'istruttoria competente.

Dall'incidente all'apprendimento

Una risposta matura evita la spiegazione unica «errore dell'operatore». Considera fattori relativi a compito, comunicazione, équipe, ambiente, tecnologie, organizzazione e condizioni della persona. Strumenti come analisi delle cause, audit o revisione dell'evento vanno scelti secondo gravità, regole aziendali e finalità.

Le azioni di sistema modificano le condizioni che favoriscono il rischio: semplificano un passaggio, introducono una barriera, rendono visibile un'informazione critica o riducono una dipendenza dalla memoria. Formazione e richiamo procedurale possono essere necessari, ma da soli non risolvono ogni causa organizzativa. Ogni azione deve avere responsabile, scadenza e indicatore.

Caso di miglioramento integrato

Un'unità rileva una variabilità nella documentazione di un passaggio critico. Il gruppo non conclude che vi sia automaticamente danno o negligenza. Definisce popolazione e periodo, verifica il requisito e la fonte applicabile, misura la completezza del processo e ascolta gli operatori per individuare ostacoli.

L'audit mostra che il campo è presente ma collocato in punti diversi del sistema informativo. L'azione scelta è una registrazione univoca con responsabilità e controllo di completezza. Prima dell'adozione, il gruppo valuta impatto sul flusso e sugli utenti; dopo un periodo definito esegue il re-audit e controlla un indicatore di equilibrio, per esempio ritardi o duplicazioni. Se la soluzione richiede una nuova tecnologia, il confronto include anche sicurezza, organizzazione, costi, interoperabilità ed equità.

Il caso integra governo clinico, qualità, audit, rischio e HTA senza confonderli: l'audit misura la pratica, l'analisi del rischio cerca fattori e barriere, l'HTA supporta l'eventuale scelta tecnologica, il sistema qualità rende stabile la modifica.

Verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: Come imposteresti un progetto di governo clinico su un problema di qualità?

Risposta modello: definirei bisogno, popolazione e responsabilità; individuerei criterio e standard applicabili; misurerei la pratica con dati dichiarati; analizzerei le cause con i professionisti; sceglierei azioni proporzionate; assegnerei responsabilità e tempi; eseguirei re-audit e monitorerei anche effetti indesiderati.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: Se un indicatore peggiora, è dimostrata la responsabilità degli operatori?

Risposta: no. L'indicatore segnala un fenomeno da interpretare; non prova da solo causalità, colpa o responsabilità. Occorre verificare qualità del dato, contesto, fattori di sistema e competenze istruttorie.

ERRORE TIPICO

Elencare sigle senza mostrare il collegamento operativo. Una risposta efficace parte dal problema, assegna a ogni strumento la sua funzione e chiude con verifica e limite.

MINI-ESERCIZIO

Scegli uno scostamento organizzativo e compila sette righe: criterio, standard applicabile, dato, causa ipotizzata da verificare, azione, responsabile, indicatore di re-audit. Aggiungi una riga su ciò che il dato non consente di concludere.

CHECKLIST FINALE

- ho distinto governo clinico, audit, HTA e accreditamento;
- ho collegato qualità a criteri e indicatori interpretabili;
- ho previsto re-audit e indicatore di equilibrio;
- ho analizzato il rischio senza attribuzioni premature;
- ho dichiarato livello decisionale, fonte, versione e limiti;
- ho rinviato requisiti regionali e procedure aziendali alla fonte applicabile.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

- Legge 8 marzo 2017, n. 24, nel testo vigente, per sicurezza delle cure e gestione del rischio.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies nel testo vigente, per autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali.
- Istituto Superiore di Sanità, Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica, versione 2.0, dicembre 2024, per evidenze e raccomandazioni.
- AGENAS e Ministero della Salute, Logiche e strumenti gestionali e digitali per la presa in carico della cronicità, edizione del 31 dicembre 2021 integrata ad aprile 2022, per organizzazione, PDTA e integrazione dei servizi.
- AGENAS, PNHTA-DM 2026–2028: sbloccate le risorse del Fondo, al via la fase operativa, pagina pubblicata il 12 gennaio 2026 e modificata il 27 aprile 2026.
- AGENAS, materiali istituzionali su qualità e accreditamento, da coordinare con il manuale e la disciplina della Regione interessata.
- Ministero della Salute, Monitoraggio errori in sanità, pagina aggiornata il 26 settembre 2024, e Monitoraggio eventi sentinella, pagina aggiornata l'11 agosto 2025 con Protocollo luglio 2024.

Limite e cut-off (31 luglio 2026): programmi HTA, manuali di accreditamento, requisiti regionali, procedure aziendali e standard operativi devono essere verificati di nuovo nella versione vigente richiamata dal bando. Il capitolo fornisce metodo concorsuale e non autorizza protocolli clinici o giudizi medico-legali.

Epidemiologia e sanità pubblica per la dirigenza

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

L'epidemiologia trasforma gli eventi osservati in una popolazione definita in informazioni utili per decidere. Per il dirigente, il punto non è produrre una percentuale isolata, ma formulare il quesito, scegliere una misura coerente, riconoscere l'incertezza e collegare il risultato a un'azione proporzionata e verificabile.

Misure di frequenza e associazione

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine saprai distinguere le principali misure epidemiologiche, riconoscere disegni di studio e distorsioni, interpretare sorveglianza e screening, leggere le differenze tra gruppi e costruire indicatori utili alla gestione. Saprai inoltre impostare la risposta a un segnale epidemiologico senza confondere associazione, causalità e competenze operative.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Output atteso
Bando	La traccia chiede un calcolo, una lettura critica o un intervento?	tipo di prova
Aree	Quali popolazioni, esiti, esposizioni e servizi sono coinvolti?	perimetro
Nuclei	Quali misure, disegni, bias e fonti informative servono?	struttura della risposta
Diario	Quali definizioni, periodi e sistemi sono soggetti ad aggiornamento?	cut-off
Output	Serve una formula, un rapporto, un caso o un colloquio?	risposta verificabile

PRINCIPI DI BASE

Ogni misura richiede cinque elementi: evento, popolazione, luogo, periodo e fonte. Prima di calcolare, occorre verificare che il numeratore appartenga al denominatore e che la popolazione sia realmente esposta alla possibilità di diventare caso.

La prevalenza esprime la quota di persone che presenta una condizione in un momento o durante un periodo:

NOTA

prevalenza = casi esistenti / popolazione osservata

È utile per descrivere il carico assistenziale. Dipende sia dalla comparsa di nuovi casi sia dalla durata della condizione: può aumentare perché cresce l'incidenza, ma anche perché le persone vivono più a lungo con la malattia. Non misura direttamente il rischio di ammalarsi.

L'incidenza cumulativa, o rischio nel periodo, considera i nuovi casi tra le persone inizialmente a rischio:

NOTA

incidenza cumulativa = nuovi casi nel periodo / popolazione a rischio all'inizio

La densità di incidenza usa invece il tempo-persona effettivamente osservato:

NOTA

tasso di incidenza = nuovi casi / somma dei tempi-persona a rischio

Una proporzione è compresa tra zero e uno; un tasso incorpora il tempo e non va interpretato come una semplice percentuale. Il tasso d'attacco, spesso usato nell'indagine di un focolaio, è una proporzione di incidenza riferita a una popolazione e a un intervallo definiti.

Mortalità e letalità rispondono a domande differenti. La mortalità pone al denominatore la popolazione; la letalità considera, tra i casi, la quota di decessi attribuiti alla condizione secondo la definizione adottata. Confonderle altera il significato epidemiologico.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La prevalenza descrive i casi presenti e il carico. L'incidenza descrive i nuovi casi. Il rischio usa persone a rischio; il tasso usa tempo-persona. La mortalità riguarda la popolazione, la letalità i casi. Nessuna misura è interpretabile senza popolazione, periodo e definizione dell'evento.

MISURE DI ASSOCIAZIONE

Il rischio relativo confronta il rischio negli esposti con quello nei non esposti. Un valore pari a 1 indica assenza di associazione nella misura osservata; maggiore di 1 indica un rischio più alto negli esposti; minore di 1 un rischio più basso. L'odds ratio confronta le odds e viene usato, tra l'altro, negli studi caso-controllo. Quando l'esito non è raro, l'odds ratio può allontanarsi sensibilmente dal rischio relativo e non deve essere presentato come se fosse la stessa misura.

La misura relativa descrive la forza dell'associazione; la differenza assoluta descrive quanto cambia il rischio. Per decidere occorrono entrambe, insieme all'incertezza. Un intervallo di confidenza indica un insieme di valori compatibili con dati e modello: non elimina bias, confondimento o errori nella definizione delle variabili.

Esempio guidato. In una coorte, 30 persone su 300 esposte sviluppano l'esito, contro 10 su 200 non esposte. I rischi sono 10% e 5%; il rischio relativo è 2 e la differenza assoluta è 5 punti percentuali. I dati mostrano un'associazione, non provano da soli che l'esposizione abbia causato l'esito.

Disegni di studio, bias e confondimento

È il quesito a orientare il disegno. Uno studio descrittivo rappresenta distribuzione e andamento per persona, luogo e tempo. Uno studio trasversale misura esposizione ed esito in un dato momento ed è adatto, per esempio, alla prevalenza; spesso non consente di stabilire quale dei due sia venuto prima.

Nello studio caso-controllo si parte da persone con e senza esito e si ricostruisce l'esposizione. È efficiente per esiti rari o a lunga latenza, ma richiede particolare attenzione alla selezione dei controlli e al ricordo dell'esposizione. Nello studio di coorte si parte dall'esposizione e si osserva l'insorgenza dell'esito; si possono stimare incidenza e rischio relativo, ma perdite al follow-up e cambiamenti dell'esposizione possono compromettere la validità.

Lo studio sperimentale assegna l'intervento secondo un protocollo; la randomizzazione, quando appropriata e correttamente realizzata, aiuta a bilanciare fattori prognostici noti e ignoti. Non rende però automaticamente lo studio privo di errori né sempre eticamente o organizzativamente praticabile.

Quesito	Disegno spesso pertinente	Limite da controllare
quanto è frequente oggi una condizione?	trasversale	temporalità
un'esposizione è associata a un esito raro?	caso-controllo	selezione e ricordo

Quesito	Disegno spesso pertinente	Limite da controllare
qual è il rischio nel tempo?	coorte	perdite e misclassificazione
quale effetto produce un intervento assegnabile?	sperimentale	aderenza, contaminazione, trasferibilità
come varia un fenomeno nel territorio?	descrittivo o ecologico	fallacia ecologica

Nello studio ecologico l'unità di analisi è un gruppo, non il singolo individuo: esposizione ed esito possono essere confrontati tra territori, popolazioni o periodi. Il disegno è utile per descrivere differenze e generare ipotesi, soprattutto quando sono disponibili dati aggregati. Non consente però di attribuire agli individui l'associazione osservata fra gruppi. Questa inferenza indebita è la fallacia ecologica; composizione delle popolazioni, confondimento e qualità non uniforme dei dati possono inoltre spiegare parte delle differenze.

Il bias è un errore sistematico. Il bias di selezione nasce quando inclusione, permanenza o confronto dei partecipanti producono gruppi non comparabili. Il bias di informazione riguarda misurazioni o classificazioni errate di esposizione, esito o covariate. Il confondimento si verifica quando un fattore associato sia all'esposizione sia all'esito distorce l'associazione osservata e non appartiene alla catena causale che si intende studiare.

La casualità campionaria riguarda invece la precisione. Può essere descritta con intervalli di confidenza e altre misure statistiche, ma una stima molto precisa può essere sistematicamente errata. Per sostenere una conclusione causale occorre considerare temporalità, plausibilità, coerenza, alternative esplicative, qualità del disegno e insieme delle evidenze. Il solo valore di significatività statistica non basta.

Sorveglianza epidemiologica

La sorveglianza è una raccolta sistematica e continuativa di informazioni, accompagnata da analisi, interpretazione e restituzione a chi deve agire. Si distingue da un'indagine occasionale, che risponde a un quesito circoscritto, e da un sistema informativo amministrativo, nato in primo luogo per documentare attività o prestazioni. Le stesse banche dati possono contribuire a più finalità, ma definizioni e qualità vanno valutate rispetto all'uso.

Per essere interpretabile, un sistema di sorveglianza deve dichiarare:

- popolazione e territorio coperti;
- definizione dell'evento o dell'indicatore;
- fonte e modalità di raccolta;
- tempestività, completezza e rappresentatività;

- procedura di analisi e diffusione;
- responsabilità e azioni attese;
- tutela dei dati e limiti.

PASSI è un esempio nazionale di sorveglianza di popolazione. Usa un disegno campionario e interviste per produrre stime su comportamenti, fattori di rischio e adesione a interventi preventivi nella popolazione prevista dal protocollo. I risultati richiedono pesi, definizioni operative e intervalli di confidenza. Non sono conteggi amministrativi degli inviti, delle prestazioni o delle diagnosi.

DAL SEGNALE ALLA RISPOSTA

Un aumento osservato non è ancora un focolaio confermato. Può riflettere variazioni diagnostiche, maggiore notifica, stagionalità, duplicazioni o concentrazioni casuali. In termini generali, un focolaio è un'aggregazione di casi collegati epidemiologicamente o un numero di casi superiore all'atteso in una popolazione, un luogo e un periodo definiti, secondo i criteri applicabili alla malattia e al sistema di sorveglianza. Per eventi rari o ad alto impatto anche un singolo caso può attivare un'allerta: non ne deriva una definizione universale di focolaio.

La definizione di sorveglianza applicabile a una malattia può combinare criteri clinici, di laboratorio ed epidemiologici. La definizione operativa di caso nell'indagine di focolaio serve invece a ricercare e classificare coerentemente le persone collegate all'evento; specifica tempo, luogo, persona o popolazione e criteri clinici, di laboratorio ed epidemiologici pertinenti. È una regola di inclusione aggiornabile: non definisce da sola il focolaio e non ne dimostra la causa.

La sequenza generale comprende:

1. verificare il segnale e confermare l'esistenza dell'evento;
2. definire e ricercare i casi;
3. costruire una lista dei casi e descriverli per tempo, luogo e persona;
4. formulare ipotesi e confrontarle con dati epidemiologici, clinici, di laboratorio e ambientali pertinenti;
5. adottare o proporre misure di controllo proporzionate senza attendere necessariamente ogni conferma, se il rischio lo richiede;
6. monitorare l'effetto delle misure e comunicare risultati e limiti.

Il decreto ministeriale 7 marzo 2022 disciplina il sistema PREMAL e il flusso di segnalazione delle malattie infettive. Definizioni specifiche, tempi, moduli e responsabilità territoriali devono essere controllati nella versione vigente e nella procedura applicabile. Il dirigente coordina informazione, competenze e decisioni; non sostituisce le funzioni attribuite ai soggetti responsabili.

Screening: test e programma

Lo screening propone un test a persone appartenenti a una popolazione bersaglio che non presentano, secondo i criteri del programma, la manifestazione clinica per la quale si effettua la ricerca. Non formula da solo una diagnosi: seleziona persone da avviare agli approfondimenti previsti.

La sensibilità è la quota di positivi al test tra le persone con la condizione. La specificità è la quota di negativi tra le persone senza la condizione. Il valore predittivo positivo è la probabilità di avere la condizione dato un test positivo; il valore predittivo negativo è la probabilità di non averla dato un test negativo.

Sensibilità e specificità descrivono la prestazione del test nelle condizioni studiate. I valori predittivi dipendono anche dalla prevalenza nella popolazione esaminata: a parità di test, quando la condizione è rara aumenta il peso dei falsi positivi tra i risultati positivi.

Esempio. Su 1.000 persone, 20 hanno la condizione. Un test con sensibilità 90% identifica 18 veri positivi e lascia 2 falsi negativi. Con specificità 95%, tra le 980 persone senza condizione si attendono 49 falsi positivi. Il valore predittivo positivo è quindi $18/(18+49)$, circa 27%: un buon risultato del test non equivale a diagnosi.

La qualità del test è solo una parte della qualità del programma. Occorre valutare invito, copertura, adesione, tempestività degli approfondimenti, capacità diagnostica e terapeutica, esiti, effetti indesiderati ed equità di accesso. Vanno inoltre considerati sovradiagnosi, anticipazione apparente della sopravvivenza dovuta alla diagnosi precoce e selezione di condizioni a decorso più lento.

Per i programmi oncologici, le stime PASSI di copertura organizzata e spontanea descrivono modalità riferite dagli intervistati secondo definizioni operative. Non sostituiscono i flussi gestionali del programma. Confronti geografici o temporali richiedono campione, pesi, intervalli di confidenza e coerenza delle definizioni.

Prevenzione: livelli, strategie e valutazione

La prevenzione comprende interventi diretti a evitare l'insorgenza di eventi di salute, riconoscerli precocemente o limitarne conseguenze e complicanze. Non coincide con la sola informazione e non è un elenco di iniziative: parte da un bisogno documentato, individua una popolazione, sceglie interventi sostenuti da evidenze e ne valuta benefici, rischi, accessibilità ed equità.

La classificazione per livelli aiuta a collocare l'intervento nella storia naturale della condizione:

- la prevenzione primaria agisce prima dell'insorgenza, riducendo esposizioni e fattori di rischio o rafforzando fattori protettivi;
- la prevenzione secondaria mira all'identificazione precoce in persone senza manifestazioni cliniche riconosciute, quando esistono un percorso appropriato e un beneficio atteso; i programmi di screening ne sono un'applicazione organizzata, non l'unica forma;
- la prevenzione terziaria interviene in presenza di malattia o danno per ridurre progressione, complicanze, recidive e perdita funzionale.

Le definizioni possono assumere sfumature diverse nelle singole discipline. In una risposta concorsuale è quindi più sicuro dichiarare obiettivo, destinatari e momento dell'intervento, anziché affidarsi alla sola etichetta.

Una strategia può rivolgersi all'intera popolazione oppure a gruppi selezionati in base a rischio, esposizione o barriera di accesso. L'approccio di popolazione può produrre un beneficio diffuso anche quando il vantaggio individuale è piccolo; l'approccio mirato concentra risorse dove il rischio è maggiore, ma dipende dalla capacità di identificare e raggiungere i destinatari senza ampliare le disuguaglianze. I due approcci possono essere complementari.

Sorveglianza e prevenzione hanno funzioni diverse. La sorveglianza produce e restituisce informazioni; l'intervento preventivo modifica una condizione, un'esposizione, un comportamento, l'accesso o un percorso. Per valutarlo non basta contare le attività svolte. Occorre misurare almeno popolazione raggiunta, adesione, qualità del processo, esiti attesi, effetti indesiderati e differenze tra gruppi.

Esempio. Un programma registra buona adesione complessiva, ma una copertura più bassa nelle aree con maggiore deprivazione. Aumentare indistintamente gli inviti potrebbe non rimuovere la barriera. Il dirigente verifica contatti, tempi, accessibilità e motivi di mancata adesione; introduce un'azione mirata, conserva l'offerta universale e controlla sia la copertura complessiva sia la riduzione del divario.

Il Piano nazionale della prevenzione 2026–2031 costituisce il quadro programmatico nazionale corrente. La risposta operativa deve comunque coordinarsi con il piano regionale, i LEA, le competenze istituzionali e le fonti specifiche dell'intervento.

Disuguaglianze di salute

Una media può nascondere gruppi che non raggiungono un servizio o presentano un rischio maggiore. Per questo i risultati vanno stratificati, quando pertinente e sostenibile dai dati, per caratteristiche come età, genere, istruzione, condizione economica, cittadinanza, territorio o livello di deprivazione. Le categorie devono essere motivate, rispettose e compatibili con finalità e tutela dei dati.

Il confronto grezzo risponde alla domanda: «che differenza osserviamo?». L'analisi aggiustata prova a separare, mediante un modello esplicito, il ruolo di variabili che differiscono tra i gruppi. Né l'una né l'altra autorizzano automaticamente conclusioni causali.

Una lettura dirigenziale segue quattro passaggi:

1. verificare definizioni, copertura e numerosità;
2. quantificare differenza assoluta e relativa con la relativa incertezza;
3. esplorare composizione, accesso, esposizioni e possibili confondenti;
4. progettare un intervento e verificare se riduce il divario senza peggiorare l'esito complessivo.

Uguaglianza ed equità non sono sinonimi. Offrire a tutti la stessa modalità può lasciare invariato un ostacolo che colpisce un gruppo specifico. L'equità orienta a riconoscere bisogni e barriere rilevanti; la valutazione deve però restare fondata su dati e criteri trasparenti.

Indicatori per la gestione

Un indicatore utile non è un numero decorativo. Deve collegare obiettivo, misura e possibile decisione. La sua scheda minima comprende nome, razionale, numeratore, denominatore, popolazione, periodo, fonte, frequenza di aggiornamento, responsabile, modalità di stratificazione, limiti e azione attesa.

Tipo	Domanda	Esempio
contesto	quale bisogno o vincolo caratterizza la popolazione?	prevalenza stimata del fattore di rischio
processo	l'attività prevista raggiunge i destinatari?	adesioni tra invitati eleggibili
esito	il risultato atteso cambia?	nuovi eventi nel periodo
qualità del dato	quanto è affidabile l'osservazione?	completezza dei campi essenziali
equilibrio	l'intervento produce effetti indesiderati?	ritardi negli approfondimenti

Il denominatore è una scelta gestionale: «residenti eleggibili», «invitati» e «persone raggiunte» misurano fenomeni diversi. Anche il target deve avere una fonte e un livello decisionale; una soglia didattica o locale non diventa uno standard nazionale.

Un cruscotto dovrebbe mostrare andamento nel tempo, confronto appropriato, incertezza e stratificazioni essenziali. Se un indicatore peggiora, la prima risposta non è cercare un colpevole: è verificare qualità del dato, variazioni della popolazione, cambiamenti organizzativi e ipotesi causali. L'indicatore orienta l'indagine e il miglioramento; raramente spiega da solo il fenomeno.

Caso decisionale

Un'azienda osserva una diminuzione della copertura riferita per un intervento preventivo. Il calo complessivo è di 4 punti percentuali; l'analisi per territorio mostra una riduzione più marcata in due aree. Nello stesso periodo è cambiata la modalità di contatto degli utenti.

Nella prova conviene rendere visibili sette passaggi:

1. Definisce la misura. Specifica popolazione eleggibile, numeratore, denominatore, periodo e fonte; distingue la stima di sorveglianza dai dati amministrativi.
2. Verifica il segnale. Controlla numerosità, intervalli di confidenza, pesi, completezza, modifiche nelle domande e andamento su più periodi.
3. Integra le fonti. Confronta inviti, contatti, adesioni e tempi del percorso senza aspettarsi valori identici da sistemi con finalità diverse.
4. Esplora il divario. Stratifica per territorio e caratteristiche pertinenti, verifica la composizione dei gruppi e ascolta servizi e destinatari.
5. Formula un'ipotesi verificabile. Il nuovo canale di contatto può aver creato una barriera, ma il dato non prova ancora causalità.
6. Propone un'azione proporzionata. Introduce, nelle aree interessate, un canale alternativo e un richiamo mirato, definendo responsabilità e tutela dei dati.
7. Valuta. Monitora copertura, raggiungibilità, adesione, tempi di approfondimento e un indicatore di equilibrio; confronta il divario prima e dopo.

Il dato, dunque, non coincide con la decisione. L'incertezza resta esplicita e il monitoraggio permette di ridurla.

Verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: Come imposteresti la lettura di un aumento di incidenza osservato da un sistema di sorveglianza?

Risposta modello: definirei evento, popolazione, periodo e denominatore; verificherei completezza, tempestività e cambiamenti diagnostici o di notifica; descriverei tempo, luogo e persona; confronterei il dato con periodi e popolazioni appropriati; valuterei casualità, bias e confondimento; se il segnale fosse plausibile, attiverei le competenze previste, proporrei misure proporzionate e ne monitorerei gli effetti.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: Un rischio relativo pari a 2 dimostra che l'esposizione causa l'esito?

Risposta: no. Indica che, nei dati e nel periodo studiati, il rischio negli esposti è doppio rispetto ai non esposti. Causalità e validità richiedono valutazione del disegno, temporalità, precisione, bias, confondimento e coerenza con le altre evidenze.

ERRORE TIPICO

Presentare una percentuale senza denominatore o confondere la copertura stimata da un'intervista con il conteggio delle prestazioni. La risposta corretta dichiara definizione operativa, fonte e incertezza.

MINI-ESERCIZIO

In una popolazione iniziale di 2.000 persone a rischio si osservano 80 nuovi casi in un anno. Supponendo una popolazione chiusa e nessuna perdita al follow-up, in 500 esposti si registrano 40 casi; nei 1.500 non esposti se ne registrano 40.

1. Incidenza cumulativa complessiva: $80/2.000 = 4\%$.
2. Rischio negli esposti: $40/500 = 8\%$.
3. Rischio nei non esposti: $40/1.500 = 2,67\%$ circa.
4. Rischio relativo: $8\%/2,67\% = 3$ circa.
5. Differenza assoluta: 5,33 punti percentuali circa.

Il risultato documenta un'associazione. Per interpretarla servono definizione dell'esposizione, comparabilità dei gruppi, precisione, perdite, bias e confondenti.

CHECKLIST FINALE

- ho definito evento, popolazione, luogo, periodo e fonte;
- ho scelto una misura coerente e mostrato il denominatore;
- ho distinto prevalenza, incidenza, rischio e tasso;
- ho separato associazione e causalità;
- ho riconosciuto disegno, bias, confondimento e incertezza;
- ho distinto sorveglianza, indagine e flusso amministrativo;
- ho separato prestazione del test e qualità del programma di screening;
- ho distinto prevenzione primaria, secondaria e terziaria e indicato come valutarle;
- ho letto le differenze tra gruppi senza conclusioni premature;
- ho collegato indicatore, decisione, responsabilità e verifica;
- ho dichiarato quali definizioni e procedure richiedono aggiornamento.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

- Istituto Superiore di Sanità, Schemi di epidemiologia di base, per misure, disegni, bias, confondimento e validità dei test.
- Istituto Superiore di Sanità, EpiCentro, Protocollo di studio PASSI, versione 8 febbraio 2023, per disegno e funzionamento della sorveglianza.
- Istituto Superiore di Sanità, EpiCentro, pagine sugli indicatori PASSI, sui programmi di screening e sulle disuguaglianze di salute.
- Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, per organizzazione e funzionamento del sistema PREMAL e modalità di segnalazione delle malattie infettive.
- Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, materiali sulla sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza e sulla prevenzione.
- Ministero della Salute, Piano nazionale della cronicità, per il quadro dei livelli di prevenzione.
- Ministero della Salute, Piano Nazionale della Prevenzione 2026–2031, pubblicato il 22 maggio 2026.

Limite e cut-off (31 luglio 2026): definizioni di caso, flussi PREMAL, protocolli di sorveglianza, programmi, indicatori, target e piani regionali devono essere verificati nella versione richiamata dal bando e nel contesto competente. Il capitolo fornisce metodo epidemiologico e gestionale; non autorizza diagnosi, provvedimenti o procedure operative per casi reali.

Dirigenza medica: discipline e casi

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Nei concorsi per dirigente medico la disciplina definisce il contenuto, ma la commissione valuta anche come il candidato organizza dati, priorità, alternative, sicurezza e motivazione. Non esiste un caso clinico universale: cambiano popolazione, setting, urgenza, fonti e competenze. Resta invece comune il bisogno di rendere il ragionamento leggibile e difendibile.

Identificare il perimetro della disciplina

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine saprai decodificare una traccia disciplinare, costruire un ragionamento differenziale, usare evidenze e contesto senza automatismi, gestire rischio e dati mancanti e presentare una soluzione nelle prove scritta, pratica illustrata e orale.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda	Risultato
Bando	Quale disciplina, prova e prodotto sono richiesti?	perimetro formale
Aree	Quali conoscenze cliniche, organizzative e di sicurezza entrano nel caso?	mappa
Nuclei	Quali dati, ipotesi, decisioni e verifiche sono indispensabili?	scaletta
Diario	Quali linee guida, protocolli o definizioni sono mobili?	controllo di versione
Output	Relazione, quesito, tecnica illustrata o colloquio?	forma corretta

I bandi esaminati mostrano una ricorrenza: la prova può chiedere una relazione su caso simulato, un argomento della disciplina, quesiti sintetici o l'illustrazione di tecniche e manualità. Questa ricorrenza non rende identiche le prove. Il candidato deve leggere il bando, la disciplina, il verbo della consegna e il prodotto richiesto.

Prima di risolvere, delimita profilo e disciplina, popolazione e problema, setting e risorse, fase del percorso, urgenza, output e tempo della prova, fonti e protocolli applicabili.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il metodo comune non sostituisce la specialità. La traccia stabilisce disciplina, setting e output. I dati certi vanno separati da quelli mancanti. Le ipotesi restano graduate finché non sono verificate. Ogni decisione deve mostrare sicurezza, fonte, limite e rivalutazione.

Costruire il ragionamento differenziale

Il differenziale non è un elenco di diagnosi ricordate. È un processo che organizza possibilità alternative rispetto ai dati disponibili e alle conseguenze del ritardo. Una buona risposta distingue rappresentazione sintetica del problema, ipotesi principali e alternative, dati che ne modificano la plausibilità, verifiche e decisioni.

La rappresentazione iniziale deve essere breve ma informativa: caratteristiche della persona, tempo di insorgenza, problema dominante, gravità e contesto. I dati mancanti non vanno inventati. Si dichiara quali informazioni servono e quali possono modificare subito la priorità.

Le ipotesi possono essere ordinate per probabilità, gravità e possibilità di intervento. Una condizione meno probabile può meritare attenzione immediata se ometterla comporta un rischio elevato. Questo non autorizza esami indiscriminati: ogni verifica deve rispondere a una domanda e avere conseguenze prevedibili sulla decisione.

Passaggio	Domanda guida	Errore da evitare
problema	qual è il dato dominante?	ricopiare tutta la traccia
priorità	che cosa non può attendere?	confondere frequenza e gravità
ipotesi	quali alternative spiegano i dati?	lista senza gerarchia
verifica	quale dato modifica davvero la scelta?	esami “a tappeto”
decisione	che cosa faccio e perché?	conclusione senza criterio
rivalutazione	quale esito controllo?	chiudere dopo la prima azione

Evidenze, setting e decisione

Una raccomandazione non è una frase isolata. Per applicarla occorre verificare popolazione, intervento, comparatore, esiti, forza, certezza delle prove, versione e contesto. Il metodo ISS-SNLG separa la qualità delle evidenze dalla forza della raccomandazione e considera benefici, effetti indesiderati, valori, equità, risorse, accettabilità e fattibilità.

DAL PROBLEMA AL QUESITO CLINICO

Il quesito clinico trasforma un problema in una domanda alla quale le evidenze possono rispondere. Non coincide con il “quesito sintetico” della prova, che è una forma di consegna. Può riguardare terapia o prevenzione, diagnosi, prognosi, eziologia o danno.

Per strutturarlo occorre specificare popolazione o problema; intervento, esposizione oppure test indice; comparatore pertinente; esiti rilevanti; orizzonte temporale, se modifica il significato.

Nel caso concorsuale, il passaggio dalle evidenze alla decisione segue cinque mosse: formulare il quesito; individuare la fonte pertinente e vigente; confrontarne popolazione e setting con il caso; esplicitare benefici, rischi, alternative e preferenze; motivare scelta e monitoraggio.

L'appropriatezza è la coerenza della decisione con indicazione, caratteristiche della persona, momento del percorso, setting, benefici e rischi, preferenze e risorse pertinenti. Non equivale alla semplice aderenza a una linea guida: una raccomandazione può richiedere adattamento motivato.

Protocollo locale e linea guida non sono sinonimi. La linea guida formula raccomandazioni attraverso un processo metodologico dichiarato; il protocollo traduce attività e responsabilità in un contesto organizzativo. Nessuno dei due annulla il giudizio sul caso o giustifica una deviazione non motivata.

Quando la traccia non identifica una linea guida, non inventare titolo, anno o forza. Descrivi i criteri con cui la cercheresti e segnala che la decisione definitiva dipende dalla fonte disciplinare corrente.

Rischio, limiti ed escalation

Il primo passaggio è riconoscere se il caso contiene una minaccia che richiede azione immediata. La risposta deve rendere visibili protezione iniziale, attivazione del supporto previsto, continuità e rivalutazione. Dosi, soglie e manovre vanno esposte soltanto quando la prova le richiede e quando sono sostenute dalla disciplina, dalla fonte vigente e dal setting; non vanno presentate come universali.

Per ogni rischio indica dato osservato, gravità possibile, misura immediata di competenza, criterio e destinatario dell'escalation, informazioni da comunicare, esito da sorvegliare e documentazione.

Escalation non significa soltanto “chiamo qualcuno”. Occorre dire perché, con quali dati e quale urgenza. Anche il limite va motivato: mancanza di risorsa, informazione decisiva, competenza specifica o condizione di sicurezza.

L'incertezza non è una scusa per restare immobili. Si può agire in modo proporzionato, proteggere la persona, raccogliere i dati decisivi e rivalutare. Allo stesso tempo, l'urgenza non autorizza a presentare come certo ciò che è soltanto ipotizzato.

Costruire il caso scritto

Una relazione efficace segue sette blocchi: inquadramento; dati presenti e mancanti; priorità; differenziale; decisione; comunicazione e documentazione; rivalutazione.

CASO GUIDATO

Durante una valutazione ambulatoriale specialistica, una persona adulta riferisce dispnea comparsa da circa un'ora e dolore toracico non ancora caratterizzato. La saturazione, abitualmente documentata al 97%, è ora 90%; la frequenza cardiaca è 118/min e la pressione è scesa rispetto ai controlli precedenti. Tre giorni prima è stata iniziata una nuova terapia. Non sono forniti temperatura, elettrocardiogramma, esame toracico né storia tromboembolica. Si chiede di impostare la gestione iniziale e il ragionamento differenziale.

Inquadramento. Il compito è gestire un cambiamento potenzialmente rilevante nella disciplina indicata, non indovinare una diagnosi con dati incompleti.

Dati. Il peggioramento respiratorio, il dolore, la tachicardia e la variazione pressoria impongono una valutazione tempestiva. Caratterizzo dolore e dispnea, verifico parametri e condizioni generali, raccolgo sintomi associati, terapie, comorbidità e fattori di rischio. Temperatura, esame obiettivo, tracciato e storia recente servono a discriminare le ipotesi; non li considero normali perché assenti dalla traccia.

Priorità e differenziale. La priorità è riconoscere e gestire una possibile compromissione acuta. Il differenziale comprende categorie cardiovascolari, respiratorie, tromboemboliche, infettive e iatrogene. Esordio e caratteri del dolore, reperti obiettivi, elettrocardiogramma, temperatura, fattori di rischio e relazione temporale con la nuova terapia aumentano o riducono la plausibilità delle ipotesi.

Il confronto può essere reso esplicito senza fingere una diagnosi certa:

Ipotesi	Elementi che la sostengono o la rendono urgente	Dati che servono a discriminarla
Embolia polmonare	dispnea acuta, ipossiemia, tachicardia e dolore; possibili conseguenze gravi	fattori di rischio, segni di trombosi, probabilità clinica e percorso diagnostico appropriato; un D-dimero isolato non conferma la diagnosi
Sindrome coronarica acuta	dolore toracico, variazione pressoria e dispnea	caratteri del dolore, ECG e biomarcatori nel percorso previsto; un primo ECG normale non basta a escluderla
Pneumotorace, anche iperteso se instabile	esordio acuto e compromissione respiratoria	asimmetria dei reperti e valutazione immediata; nell'instabilità il riconoscimento di una minaccia non deve attendere una routine diagnostica
Reazione anafilattica alla terapia	rapporto temporale con una dose e compromissione respiratoria/circolatoria	tempo dall'ultima esposizione, edema, broncospasmo e segni cutanei, che possono anche mancare; avere iniziato un farmaco tre giorni prima non dimostra il nesso
Infezione respiratoria con possibile sepsi	ipossiemia e compromissione generale possono essere compatibili	febbre o altri segni infettivi, reperti toracici, andamento e disfunzioni d'organo; la temperatura mancante non è temperatura normale

Non sono ipotesi equiprobabili né un elenco esaustivo. Il dato disponibile non permette di escluderle; la gerarchia cambia quando arrivano anamnesi, esame e verifiche. La nuova terapia è una pista da esaminare, non una spiegazione che chiuda il caso.

Decisione. Interrompo l'attività non prioritaria, attivo il percorso previsto per il deterioramento e richiedo il supporto appropriato, comunicando dati e andamento. Scelgo verifiche capaci di modificare la gestione. Trattamenti e dettagli tecnici dipendono dalla valutazione, dalla disciplina e dal protocollo vigente.

Comunicazione e verifica. Informo la persona in modo proporzionato, condivido dati e urgenza con l'équipe, documento ragionamento e decisioni e definisco che cosa rivalutare.

La prova pratica richiede la stessa logica, ma può comprendere una componente esecutiva. Nei concorsi disciplinati dal D.P.R. 483/1997 verte su tecniche e manualità proprie della disciplina; per l'area chirurgica può svolgersi anche su cadavere o materiale anatomico, oppure con altra modalità stabilita dalla commissione. La prova deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto. Bando e commissione definiscono modalità concrete. Nella preparazione occorre padroneggiare indicazione, condizioni di arresto, sicurezza, sequenza, complicanze, documentazione e controllo dell'esito secondo la fonte specialistica vigente.

Difendere la decisione all'orale

All'orale la risposta iniziale dovrebbe rendere evidente il filo logico in uno o due minuti: inquadramento, dati che cambiano la priorità, condizioni a maggior rischio, alternative, verifiche, fonte, decisione e rivalutazione.

Se la commissione introduce un nuovo dato, non ripartire da zero. Spiega quale ipotesi cambia, quale decisione ne consegue e che cosa resta incerto. Se contesta la scelta, confronta l'alternativa usando benefici, rischi, applicabilità e preferenze; non difendere automaticamente la prima risposta.

La frase “dipende dal protocollo” è incompleta. Occorre indicare quale parte dipende dal protocollo e quale principio resta valido: sicurezza, identificazione del rischio, tracciabilità e rivalutazione.

Verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposta un caso clinico con dati incompleti?

Risposta modello: definisco problema, disciplina e setting; separo dati certi e mancanti; riconosco i rischi che non possono attendere; costruisco ipotesi gerarchizzate; richiedo soltanto dati capaci di modificare la scelta; applico fonti pertinenti al caso; agisco entro competenza, comunico e rivaluto.

DOMANDA-TRAPPOLA

La diagnosi più probabile deve sempre essere trattata per prima?

No. Probabilità e priorità non coincidono. Una condizione meno frequente può richiedere verifica o intervento immediato se le conseguenze dell'omissione sono gravi e tempo-dipendenti.

ERRORE TIPICO

Scrivere una pagina di nozioni della specialità senza risolvere la consegna. La commissione deve poter riconoscere problema, priorità, alternative, decisione, limite e verifica.

MINI-ESERCIZIO

Riprendi il caso guidato e scrivi sette frasi, una per ciascun blocco del caso scritto. Indica poi due dati che cambierebbero la priorità, due che discriminerebbero le ipotesi e un dettaglio clinico da verificare nella fonte aggiornata.

CHECKLIST FINALE

- ho identificato disciplina, setting, popolazione e output;
- ho distinto dati certi, mancanti e ipotesi;
- ho separato probabilità, gravità e priorità;
- ho costruito un differenziale gerarchizzato;
- ho collegato ogni verifica a una decisione;
- ho controllato fonte, versione e applicabilità;
- ho esplicitato rischio, limite ed escalation;
- ho previsto comunicazione, documentazione e rivalutazione;
- ho evitato algoritmi, dosi e soglie non sostenuti;
- ho risposto al verbo della consegna.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

- D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, nel testo vigente e per quanto applicabile al profilo e alla disciplina.
- Bando specifico, per forma delle prove, materie, criteri e output richiesti.
- Istituto Superiore di Sanità, Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica, versione 2.0, dicembre 2024.
- Sistema Nazionale Linee Guida, per identificare linee guida pubblicate e relativo stato.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, e legge 22 dicembre 2017, n. 219, nei testi vigenti, per sicurezza delle cure, responsabilità professionale e decisione informata.
- Linea guida, protocollo e documenti della disciplina e del setting identificati nel caso.

Limite e cut-off (31 luglio 2026): requisiti, prove, linee guida, protocolli e contenuti clinici variano per disciplina e bando. Questo capitolo insegna il metodo di risposta; la preparazione specialistica richiede fonti verticali aggiornate per la disciplina considerata.

Dirigenza sanitaria non medica: discipline e casi

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

La dirigenza sanitaria non medica non è una disciplina unica. Un dirigente biologo di patologia clinica, un dirigente farmacista e un dirigente psicologo operano nel Servizio sanitario nazionale (SSN), ma affrontano oggetti professionali, metodi, responsabilità e prove differenti. Il candidato che studia una generica “area sanitaria” rischia quindi di preparare una risposta formalmente ordinata ma estranea al profilo messo a concorso.

La regola di fondo è semplice: prima si identifica il profilo, poi la disciplina, quindi il servizio e il problema affidato; soltanto dopo si sceglie il metodo di risposta. La parte comune riguarda lettura del bando, qualità, sicurezza, uso dei dati, collaborazione e responsabilità. Il contenuto tecnico resta proprio della professione e della disciplina.

Mappa dei profili della dirigenza sanitaria non medica

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

- Al termine saprai:
- distinguere profilo professionale, disciplina concorsuale, incarico e competenza effettiva;
 - riconoscere il nucleo comune e il delta di biologo, farmacista e psicologo;
 - impostare una prova scritta o pratica illustrata senza trasferire tecniche tra professioni;
 - collegare il sapere specialistico a qualità, sicurezza e governo dell'organizzazione;
 - risolvere casi con dati concreti dichiarando fonti, limiti e verifiche;
 - difendere all'orale una decisione professionale coerente con il bando.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda	Prodotto
Bando	Quali profilo, disciplina, requisiti e prove sono indicati?	perimetro formale
Aree	Quali nuclei tecnici, deontologici e organizzativi sono richiesti?	programma pertinente

Passaggio	Domanda	Prodotto
Nuclei	Quali concetti e passaggi non possono mancare nella risposta?	scaletta
Diario	Quali requisiti, metodi, codici o procedure devono essere ricontrollati?	elenco delle parti mobili
Output	Tema, quesito, caso, tecnica illustrata o colloquio?	forma di allenamento

Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 disciplina separatamente i concorsi per i diversi profili della dirigenza del SSN. Nei bandi ordinari esaminati ricorrono titoli, prova scritta, prova pratica e prova orale, ma contenuti e modalità dipendono dal profilo e dalla disciplina. Un avviso temporaneo o una procedura speciale può avere una struttura diversa: vale sempre il testo della procedura concreta.

La prova pratica non è soltanto una risposta teorica chiamata “pratica”. Per il dirigente farmacista riguarda tecniche e manualità proprie della disciplina e deve essere illustrata schematicamente per iscritto. Per il dirigente biologo può consistere nell'esecuzione di misure strumentali o prove di laboratorio, oppure nella soluzione di un test su tecniche e manualità, con relazione sul procedimento seguito. Per il dirigente psicologo può riguardare l'esame di un soggetto, la raccolta dell'anamnesi e la discussione del caso, oppure l'esame dei risultati di test diagnostici e la diagnosi psicologica; anche qui è prevista l'illustrazione schematica scritta. Bando e commissione definiscono le modalità concrete.

Profilo	Centro della preparazione	Domande preliminari
biologo	processo biologico o analitico, qualità del dato, rischio, interpretazione nel perimetro della disciplina	quale matrice, metodo, fase, standard e responsabilità?
farmacista	medicinale, appropriatezza, sicurezza, continuità, tracciabilità e impiego delle risorse	quale servizio, percorso del farmaco, dato e decisione?

Profilo	Centro della preparazione	Domande preliminari
psicologo	domanda psicologica, mandato, valutazione o intervento, metodo, relazione e tutela delle informazioni	chi chiede, per chi, con quale finalità e quali limiti?
altri profili	oggetto tecnico proprio della disciplina indicata	quale articolo applicabile, bando, fonte professionale e contesto?

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Non esiste una prova sanitaria non medica universale. Profilo e disciplina definiscono il sapere tecnico; il bando definisce la procedura e il prodotto richiesto. Titolo professionale, ammissione al concorso e competenza sul caso sono piani diversi. La parte comune è un metodo di ragionamento, non una licenza a scambiare attività tra professioni. Ogni risposta deve mostrare oggetto, fonte, decisione, limite e verifica.

Confini di competenza e responsabilità

Per delimitare correttamente competenza e responsabilità occorre distinguere cinque livelli.

1. Profilo professionale. Identifica la professione e il relativo ordine. Non descrive, da solo, ogni attività esercitabile in qualunque contesto.
2. Disciplina concorsuale. Delimita il settore per il quale il posto è bandito e incide su requisiti e materie. Equipollenze, affinità e titoli ammessi non si deducono dal nome: si verificano negli atti richiamati dal bando.
3. Incarico e servizio. Chiariscono obiettivi, struttura, popolazione, tecnologie, équipe e responsabilità assegnate nell'organizzazione.
4. Competenza sul problema. Richiede preparazione specifica, metodo appropriato, aggiornamento e mezzi adeguati. Il possesso del titolo non rende automaticamente competente per qualsiasi attività della stessa professione.
5. Regola operativa. Traduce il sapere in un determinato setting attraverso normativa, linee guida, metodi validati, procedure, sistemi qualità e istruzioni applicabili.

Questi livelli impediscono due errori opposti. Il primo è attribuire tutto al dirigente perché “responsabile”; il secondo è ridurre il dirigente a un controllore distante dal contenuto tecnico. La funzione dirigenziale integra competenza professionale e responsabilità organizzativa, ma la distribuzione degli atti deve essere ricostruita, non immaginata.

UNA GRIGLIA COMUNE, TRE CONTENUTI DIVERSI

Per qualunque caso usa la sequenza P-F-D-L-V:

- P — Perimetro: profilo, disciplina, servizio, mandato e output;
- F — Fatti: dati disponibili, qualità del dato e informazioni mancanti;
- D — Decisione: scelta motivata, alternative e priorità;
- L — Limiti: competenza, incertezza, risorsa, conflitto o procedura;
- V — Verifica: esito, indicatore, documentazione e rivalutazione.

La griglia è comune; ciò che riempie le cinque caselle cambia. In laboratorio il fatto può essere uno scostamento del processo analitico; in farmacia un segnale di consumo o continuità; in psicologia una domanda formulata da utente e committente. Usare le stesse parole senza cambiare il contenuto produce soltanto genericità.

I codici deontologici di biologo, farmacista e psicologo convergono su competenza, autonomia, responsabilità, correttezza e tutela delle informazioni. Non sono però intercambiabili. Ogni codice disciplina rapporti, strumenti e doveri della propria professione e deve essere letto nella versione vigente.

Biologo e laboratorio: leggere il processo

Nel laboratorio la qualità non coincide con il solo momento analitico. Il processo comprende fase preanalitica, analitica e postanalitica. Un risultato affidabile richiede identificazione e idoneità del campione, metodo e apparecchiatura sotto controllo, gestione dei dati, validazione secondo le responsabilità previste, comunicazione e tracciabilità.

Il candidato deve saper collocare un problema nella fase corretta. Se aumenta l'emolisi dei campioni, il punto di partenza è preanalitico; se un controllo segnala uno scostamento, il problema riguarda la fase analitica fino a verifica; se un esito non raggiunge in tempo il destinatario previsto, entra in gioco la fase postanalitica e organizzativa. La classificazione orienta le verifiche, ma non anticipa la causa.

Una non conformità si affronta con una sequenza leggibile:

1. definire il fatto e proteggere le attività potenzialmente interessate secondo la procedura;
2. verificare dato, periodo, denominatore, metodo di rilevazione e ampiezza del problema;
3. localizzare fase, processo, sedi e gruppi coinvolti;
4. cercare fattori plausibili senza attribuire colpe premature;
5. stabilire correzione immediata e azione correttiva;
6. assegnare responsabilità e tempi;
7. controllare efficacia e possibili effetti indesiderati.

Correzione e azione correttiva non sono sinonimi. La prima gestisce il problema osservato; la seconda interviene sulle cause per ridurne la ricorrenza. Anche il risultato dell'azione va verificato: una formazione erogata è un'attività, non ancora la prova che il processo sia migliorato.

La biosicurezza segue una valutazione del rischio collegata ad agente, attività, probabilità e conseguenze. Non basta nominare dispositivi di protezione o livelli di contenimento. Nella prova, concentrazioni, tempi, settaggi e sequenze si espongono soltanto quando sono sostenuti dal metodo validato, dalla procedura operativa standard, dal manuale dell'apparecchiatura e dalle competenze previste.

Il dirigente biologo non va confuso con il tecnico sanitario di laboratorio biomedico. I due profili possono concorrere allo stesso processo con competenze e responsabilità differenti. Nella prova si descrive chi decide, chi esegue, chi verifica e chi riceve l'informazione soltanto se questi ruoli risultano dalla traccia o dalla disciplina applicabile.

Farmacista: appropriatezza, sicurezza e governo del farmaco

Il governo del farmaco collega bisogno di salute, scelta e disponibilità del medicinale, sicurezza d'uso, continuità, dati di consumo e sostenibilità. Non coincide né con il solo acquisto né con il solo magazzino. Il dirigente farmacista legge l'intero percorso pertinente al servizio messo a concorso e individua dove una decisione professionale può migliorare esiti, rischio e impiego delle risorse.

Un segnale di consumo non prova da solo inappropriatezza. Prima di concludere occorre controllare:

- popolazione e attività del periodo;
- unità di misura e denominatore;
- variazioni di casistica, indicazioni o organizzazione;
- disponibilità e sostituzioni;
- qualità del dato e possibili duplicazioni;
- confronto temporale o tra unità realmente comparabili;
- eventi di sicurezza, interruzioni o criticità documentate.

Il sistema OsMed dell'Agenzia Italiana del Farmaco monitora consumi e spesa dei medicinali erogati a carico del SSN integrando più fonti informative. Questo sostiene l'uso gestionale dei dati, ma non trasforma una media nazionale in una soglia automatica per ogni azienda. Il dato apre una domanda; l'analisi ne verifica il significato.

Per la sicurezza della terapia sono centrali identificazione dei rischi, correttezza dell'informazione, ricognizione e riconciliazione nei passaggi di cura, tracciabilità, gestione delle segnalazioni e comunicazione tra professionisti. Le raccomandazioni ministeriali offrono principi e barriere di sicurezza; le modalità concrete devono essere raccordate alla versione corrente e alla procedura aziendale.

Nel governo del farmaco vanno distinti:

- continuità, cioè capacità del sistema di rendere disponibile ciò che serve nel momento pertinente;
- appropriatezza, cioè coerenza dell'impiego con indicazione, persona, setting, benefici, rischi e alternative;
- sicurezza, cioè prevenzione, intercettazione e gestione degli errori e degli eventi;
- tracciabilità, cioè possibilità di ricostruire dati, decisioni e passaggi rilevanti;
- sostenibilità, cioè uso responsabile delle risorse senza ridurre la decisione al prezzo.

Il codice deontologico del farmacista orienta competenza, autonomia, aggiornamento, segreto professionale e tutela della collettività. Nel caso concorsuale questi principi diventano domande concrete: l'informazione è corretta? la scelta è motivata? esiste un conflitto? i dati sono protetti? l'azione migliora davvero sicurezza e continuità?

Psicologo: valutazione, intervento e contesto

In psicologia il primo errore è rispondere alla tecnica prima di aver chiarito la domanda. Occorre distinguere:

- chi formula la richiesta;
- chi riceve la prestazione;
- chi è il committente;
- quale finalità è dichiarata;
- quale decisione potrebbe dipendere dall'esito;
- quali informazioni sono necessarie e a chi possono essere comunicate.

Utente e committente possono non coincidere. Un'azienda può chiedere una valutazione, ma la presenza di un committente non elimina dignità, autodeterminazione, informazione, riservatezza e limiti del mandato. Il candidato deve rendere esplicito ciò che verrà raccolto, per quale scopo, con quale metodo, come sarà custodito e quale restituzione è prevista.

Colloquio, osservazione, test, valutazione psicologica, diagnosi e psicoterapia non sono sinonimi. Ogni strumento risponde a una domanda e richiede competenza, appropriatezza e condizioni d'uso. L'esito di un test non è autosufficiente: va interpretato rispetto a finalità, popolazione, attendibilità, validità, contesto e limiti. La disponibilità dello strumento non ne giustifica l'uso per uno scopo diverso.

Il codice deontologico vigente richiede informazioni comprensibili su prestazione, finalità, modalità e limiti giuridici della riservatezza; tutela segreto professionale e documentazione; nella collaborazione consente di condividere soltanto le informazioni necessarie; vieta l'uso improprio degli strumenti diagnostici e valutativi. Questi principi incidono direttamente sulla qualità tecnica della risposta.

Una buona impostazione segue sei passaggi:

1. chiarire domanda, mandato e possibili conflitti;
2. definire il costrutto o problema da valutare;
3. scegliere metodi pertinenti e proporzionati;
4. informare la persona e gestire il consenso o altra condizione applicabile;
5. integrare dati e formulare conclusioni entro i loro limiti;
6. restituire e documentare soltanto ciò che è pertinente alla finalità.

Se emergono bisogni diversi dal mandato iniziale, non si amplia automaticamente la prestazione. Si valuta come proteggere la persona, quali informazioni sono indispensabili e quale percorso o invio è appropriato, rispettando competenza e contesto.

Il contributo professionale alla governance

La governance non cancella le discipline: le mette in relazione con obiettivi e responsabilità dell'organizzazione. Biologo, farmacista e psicologo possono contribuire a qualità, sicurezza, dati, formazione e miglioramento, ma ciascuno porta un punto di vista professionale specifico.

Passaggio	Laboratorio/biologia	Farmacia	Psicologia
problema	affidabilità del processo o del dato	impiego, rischio o continuità del farmaco	accesso, esito o appropriatezza della prestazione
indicatore	non conformità per fase e denominatore	consumo, scostamento, interruzione o segnalazione	attesa, adesione, esito o abbandono con definizione esplicita
verifica	metodo, controlli, processo e tracciabilità	casistica, denominatore, percorso e procedura	mandato, metodo, popolazione e qualità del dato
azione	correzione e prevenzione della ricorrenza	barriera di sicurezza o miglioramento del percorso	modifica del processo o dell'intervento entro competenza

Passaggio	Laboratorio/biologia	Farmacia	Psicologia
esito	riduzione dello scostamento senza nuovi rischi	maggiore sicurezza/continuità con uso appropriato	miglioramento pertinente senza violare diritti o riservatezza

Un indicatore deve dichiarare definizione, numeratore, denominatore, fonte, periodo, responsabile, frequenza e limite. Un aumento può riflettere un peggioramento reale, una migliore capacità di rilevare o un cambiamento del denominatore. Per questo la decisione non si fonda su un numero isolato.

La risposta dirigenziale termina con una verifica: quale risultato ci aspettiamo, entro quando, con quale indicatore e quale possibile effetto indesiderato? Senza questo passaggio, l'azione resta un'intenzione.

COME TRATTARE GLI ALTRI PROFILI

Il D.P.R. 483/1997 contempla anche altri profili, tra cui veterinario e fisico, oltre alle articolazioni previste dalla disciplina. Per questi profili non esiste un programma residuale valido per tutti. Si riapplica il metodo: identificare articolo e bando pertinenti, ricostruire requisiti e prova, selezionare fonti tecniche e deontologiche proprie e costruire casi del setting. Le lacune non si colmano trasferendo esempi di biologia, farmacia o psicologia.

Tre casi, tre lenti professionali

I dati dei casi sono didattici. Le percentuali descrivono gli scenari e non costituiscono soglie nazionali.

CASO 1 — NON CONFORMITÀ NEL PROCESSO DI LABORATORIO

In un laboratorio ospedaliero la quota mensile di campioni non utilizzabili per emolisi passa dal 2,1% al 3,6% e poi al 5,4% in tre mesi. Due unità operative raggiungono insieme il 7,8%; le altre si attestano al 2,9%. Non risultano variazioni del metodo analitico, ma è cambiato il personale addetto al trasporto in alcune fasce orarie. La direzione chiede un piano.

Impostazione. Delimito il problema alla fase preanalitica, verificando definizione di emolisi, denominatore, completezza e comparabilità dei tre mesi. Stratifico per unità, fascia, tipo di campione, modalità di prelievo e trasporto senza concludere che il personale sia la causa. Valuto l'impatto sui tempi, sulle ripetizioni e sul rischio di risultati non affidabili; applico le misure di contenimento previste.

Ricostruisco il processo con i professionisti coinvolti, verifico cambiamenti e aderenza alle procedure, individuo fattori modificabili e scelgo azioni mirate. Definisco responsabili, tempi e re-audit usando lo stesso indicatore, affiancato da una misura di equilibrio, per esempio ritardi o ripetizioni. Metodi, criteri tecnici e attribuzioni dipendono dal sistema qualità e dalla procedura del laboratorio.

CASO 2 — SEGNALE NEL GOVERNO DEL FARMACO

In un trimestre il consumo di una classe di medicinali aumenta del 38% rispetto al trimestre corrispondente, mentre i ricoveri crescono del 4%. Due unità hanno effettuato richieste urgenti e sono documentate tre interruzioni evitate grazie a trasferimenti interni. Il costo medio è aumentato, ma non sono ancora disponibili dati per indicazione.

Impostazione. Il 38% è un segnale, non una prova di spreco. Verifico unità di misura, perimetro, denominatore, acquisti e consumi effettivi, variazioni di casistica, disponibilità, sostituzioni e qualità del dato. Distinguo il problema di continuità da quello di appropriatezza e da quello economico.

Coinvolgo i referenti pertinenti per ricostruire percorso, indicazioni e criticità. Le azioni possono riguardare previsione del fabbisogno, scorte e allerta, qualità delle richieste, revisione degli impieghi o informazione, ma vanno scelte dopo la verifica. Monitoro consumo normalizzato, richieste urgenti, interruzioni, esiti di sicurezza e costo, evitando che la riduzione della spesa produca indisponibilità o uso meno appropriato.

CASO 3 — MANDATO E RISERVATEZZA IN PSICOLOGIA

Un servizio psicologico aziendale ha somministrato a 120 utenti uno strumento di screening per rilevare un bisogno assistenziale. La direzione chiede ora i nominativi delle persone “meno motivate” per decidere l'accesso a un diverso percorso. L'informazione iniziale riguardava finalità di cura; lo strumento non è stato scelto per una decisione selettiva.

Impostazione. Non trasformo il punteggio in una lista. Chiarisco nuova domanda, finalità, base applicabile, destinatari, conseguenze e compatibilità con il mandato originario. Verifico che “motivazione” sia definita e che il metodo sia idoneo allo scopo: uno screening per bisogno assistenziale non diventa automaticamente uno strumento di selezione.

Tutelo persone e dati, comunico alla direzione i limiti tecnici e deontologici e valuto quali informazioni aggregate possano sostenere la programmazione senza riutilizzi impropri. Se serve una nuova valutazione, occorrono mandato chiaro, metodo pertinente, informazione adeguata e regole di restituzione. Documento decisione e limiti. L'obiettivo organizzativo non autorizza scorciatoie metodologiche.

Difendere la risposta all'orale

All'orale, l'esposizione iniziale può seguire questa struttura:

1. identifico profilo, disciplina, servizio e domanda;
2. indico i dati che possiedo e quelli che devo verificare;
3. definisco il principio professionale e deontologico rilevante;
4. propongo una decisione proporzionata;
5. dichiaro competenze, incertezze e parti dipendenti dalla procedura;
6. chiudo con documentazione, indicatore e rivalutazione.

Se la commissione modifica un dato, spiega quale passaggio cambia. Se nel caso di laboratorio lo scostamento compare anche nei controlli analitici, il perimetro non è più solo preanalitico. Se nel caso farmaceutico emergono nuove indicazioni cliniche documentate, cambia l'interpretazione del consumo. Se nel caso psicologico la finalità e l'informazione iniziale includevano una valutazione definitiva, resta comunque da verificare appropriatezza del metodo e proporzionalità della comunicazione.

La prima risposta non va difesa a ogni costo. La capacità dirigenziale comprende la revisione della decisione quando cambiano i dati.

Verifica dell'apprendimento

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il nucleo comune della dirigenza sanitaria non medica e che cosa resta specifico?

Risposta modello: il nucleo comune comprende lettura del bando, responsabilità, competenza, qualità, sicurezza, tracciabilità, uso dei dati, collaborazione e verifica degli esiti. Restano specifici l'oggetto professionale, i metodi, gli strumenti, i requisiti, le fonti e il contenuto delle prove. Il metodo comune organizza la risposta, ma non rende intercambiabili biologo, farmacista, psicologo o altri profili.

DOMANDA-TRAPPOLA

Poiché tutti i dirigenti sanitari contribuiscono al governo clinico, possono usare la stessa griglia tecnica nella prova pratica?

No. Possono condividere una griglia di ragionamento — problema, dati, decisione, limiti e verifica — ma la prova pratica riguarda tecniche e manualità della disciplina indicata dal bando. Trasferire una tecnica da un profilo all'altro è un errore di perimetro.

ERRORE TIPICO

Scrivere “si applicano le linee guida e i protocolli aziendali” senza specificare quale decisione dipende da essi. La formula corretta indica il principio già certo, il documento da verificare e la conseguenza: per esempio, “contengo lo scostamento secondo il sistema qualità; metodo di conferma, responsabilità e criteri di riavvio dipendono dalla SOP vigente”.

MINI-ESERCIZIO

Per ciascuna traccia scrivi cinque righe usando P-F-D-L-V.

1. Aumento di campioni respinti in una sola fascia oraria.
2. Crescita di richieste urgenti di un medicinale con dati di consumo incompleti.
3. Richiesta di comunicare a un committente risultati psicologici raccolti per un'altra finalità.

Poi controlla:

- ho identificato profilo e disciplina;
- ho separato segnale, causa e decisione;
- ho indicato il dato mancante che può cambiare la scelta;
- ho rispettato competenza, mandato e riservatezza;
- ho distinto principio generale e procedura locale;
- ho previsto indicatore, esito e rivalutazione.

CHECKLIST FINALE

- ho letto profilo, disciplina e forma della procedura;
- ho verificato requisiti e titoli sugli atti richiamati dal bando;
- ho costruito un programma tecnico proprio del profilo;
- ho distinto titolo, incarico, competenza e procedura;
- ho collegato ogni dato a una domanda decisionale;
- ho evitato soglie e tecniche non sostenute;
- ho reso visibili sicurezza, deontologia e limiti;
- ho indicato comunicazione e documentazione;
- ho scelto un indicatore con denominatore e periodo;
- ho allenato separatamente scritto, pratica illustrata e orale;
- ho verificato le fonti specialistiche vigenti pertinenti alla disciplina.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, nel testo vigente e nella sezione applicabile al profilo.
- D.P.R. 483/1997, artt. 34, 42 e 54, rispettivamente per le prove di farmacista, biologo e psicologo.
- Bando, allegati, avvisi e comunicazioni ufficiali della procedura concreta.
- CCNL Area Sanità 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 27 febbraio 2026, per il rapporto di lavoro, distinto dai requisiti di accesso.

- Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, Codice deontologico, pubblicato il 31 ottobre 2024.
- Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Codice deontologico del farmacista e commentario.
- Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Codice deontologico vigente, testo vigente indicato dal CNOP e nuovamente applicabile dal 24 dicembre 2024, verificato il 3 ottobre 2026.
- Organizzazione Mondiale della Sanità, Laboratory Quality Management System e Laboratory Biosafety Manual, per principi di qualità e rischio.
- Agenzia Italiana del Farmaco, OsMed, per monitoraggio di consumi e spesa farmaceutica.
- Ministero della Salute, raccomandazioni sulla sicurezza della terapia, nella versione applicabile.

M-SA04

Tecnici sanitari e prevenzione

Sezione interna del volume VOL-07 — Sanità amministrativa e professioni sanitarie.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	22 TSLB e TSRM: profili, requisiti, prove e responsabilità
Sviluppo	23 TSLB: processo di laboratorio, qualità e biosicurezza
Allenamento	24 TSRM: imaging, dosimetria e radioprotezione
Strumenti	25 Tecnologie, dispositivi, apparecchiature e rischio tecnologico

TSLB e TSRM: profili, requisiti, prove e responsabilità

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico e tecnico sanitario di radiologia medica appartengono entrambi all'area tecnico-sanitaria, ma non sono due varianti dello stesso mestiere. Cambiano il profilo professionale, l'oggetto dell'attività, le tecnologie, i rischi e le conoscenze che la commissione può verificare.

La distinzione va fatta prima di iniziare a studiare. Se il candidato prepara un programma tecnico-sanitario generico, finisce per conoscere molti termini senza saper rispondere alla traccia del proprio profilo. Il metodo corretto parte dalla denominazione del posto, collega la fonte professionale, verifica i requisiti del bando e traduce ogni prova in un output allenabile.

Il quadro ordinario del D.P.R. 220/2001

Nei concorsi per titoli ed esami con tre prove, l'art. 8 ripartisce 100 punti in 30 per i titoli, 30 per la scritta, 20 per la pratica e 20 per l'orale. L'art. 14 richiede almeno 21/30 nella scritta e 14/20 sia nella pratica sia nell'orale. Nei concorsi per i quali sono previste soltanto pratica e orale, il quadro è diverso: 40 punti ai titoli, 30 a ciascuna prova e soglia di 21/30 per entrambe.

Il bando ripartisce i punti dei titoli fra carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni/titoli scientifici e curriculum. Occorre identificare la procedura e le norme speciali applicabili: il medesimo nome di una prova non implica il medesimo punteggio. Esempio: una pratica da 15/20 supera la soglia del concorso a tre prove, mentre una pratica da 20/30 non supera quella del concorso a due prove. I titoli non compensano l'insufficienza.

L'art. 37 del D.Lgs. 165/2001 prevede l'accertamento delle conoscenze informatiche diffuse e dell'inglese; modalità e livello si ricavano dalla disciplina e dal bando. Altre lingue possono essere aggiunte in relazione al profilo. Per gli OSS si identifica prima la disciplina di accesso effettivamente applicata, evitando di trasferire automaticamente le regole delle professioni sanitarie laureate.

Obiettivo del capitolo

Al termine saprai:

- distinguere il tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB) dal tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM);
- collegare profilo, titolo, albo e requisiti della procedura;
- riconoscere quali dati sono relativamente stabili e quali devono essere ricontrollati nel singolo bando;
- comprendere che cosa cambia tra prova scritta, pratica e orale;

- descrivere responsabilità, collaborazione e limiti senza attribuire a un professionista le competenze di un altro;
- costruire una Mappa BANDO specifica per il concorso scelto.

Le tecniche analitiche, la qualità e la biosicurezza di laboratorio saranno approfondite nel capitolo dedicato al TSLB. Imaging, dosimetria e radioprotezione saranno trattati nel capitolo dedicato al TSRM. Qui si costruisce la base necessaria per leggere il concorso e rispondere correttamente sui profili.

La mappa fondamentale: dal profilo all'output

La preparazione segue una sequenza precisa:

profilo professionale → requisito del bando → materia → forma della prova → output richiesto.

Il profilo delimita il campo professionale. Il bando stabilisce chi può partecipare e che cosa viene verificato. La materia indica il contenuto da studiare. La forma della prova stabilisce come dimostrare la conoscenza. L'output è il prodotto valutabile: una risposta sintetica, un elaborato, una descrizione tecnica, l'analisi di un caso o un'esposizione orale.

Saltare uno di questi passaggi genera errori prevedibili. Conoscere una tecnica di laboratorio non basta se la traccia chiede di spiegare le responsabilità nelle diverse fasi del processo. Conoscere la radioprotezione non basta se all'orale non si distingue il compito del TSRM da quello del medico specialista o dello specialista in fisica medica.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

TSLB e TSRM sono professioni distinte e non intercambiabili. Il titolo posseduto va confrontato con la formula esatta del bando. L'iscrizione all'albo e il momento in cui deve sussistere si verificano nella procedura concreta. Scritta, pratica e orale richiedono prestazioni diverse. Autonomia significa responsabilità nel proprio campo, non isolamento né estensione delle competenze.

Due professioni, due perimetri

I D.M. 26 settembre 1994, n. 745 e n. 746 individuano rispettivamente il profilo del TSLB e quello del TSRM. Le leggi successive sulle professioni sanitarie completano il quadro: il campo proprio di attività e responsabilità si legge coordinando profilo professionale, ordinamento didattico e codice deontologico, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.

Elemento	TSLB	TSRM
Centro dell'attività	analisi e ricerca biomedica e biotecnologica	atti tecnici con radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e altre energie previste dal profilo
Processo prevalente	percorso del campione e affidabilità del risultato analitico	percorso tecnico dell'esame o del trattamento nel setting radiologico pertinente
Qualità	procedure analitiche, indicatori, standard, controlli e tracciabilità	programmi di verifica e garanzia della qualità, adeguatezza tecnica e apparecchiature
Apparecchiature	controllo del funzionamento e manutenzione ordinaria nei limiti di competenza	controllo del funzionamento, interventi per eliminare inconvenienti di modesta entità e programmi di qualità nei limiti del profilo
Collaborazione	professionisti del laboratorio, clinici, personale tecnico e organizzazione	medico specialista, specialista in fisica medica, esperto di radioprotezione, équipe e organizzazione secondo il caso
Limite da ricordare	il profilo non assorbe diagnosi clinica, responsabilità mediche o ogni attività svolta nel laboratorio	il profilo non assorbe prescrizione, giustificazione clinica, controllo fisico o manutenzione specialistica

La tabella serve a classificare, non a descrivere procedure. Un'attività concreta dipende anche dal setting, dall'organizzazione del servizio, dai protocolli applicabili, dalle istruzioni dell'apparecchiatura e dalle responsabilità degli altri soggetti coinvolti.

IL TSLB

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche. Il profilo comprende la responsabilità del corretto adempimento delle procedure analitiche, la verifica della corrispondenza delle prestazioni erogate a indicatori e standard predefiniti e il controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature impiegate.

In una prova, ridurre il profilo alla formula «esegue analisi» lascia fuori la parte decisiva. La risposta deve collegare almeno cinque elementi:

1. oggetto del processo, cioè il campione e il quesito analitico;
2. procedura applicabile e corretto adempimento;
3. controlli, indicatori, standard e tracciabilità;
4. apparecchiature e segnalazione delle anomalie;
5. collaborazione, documentazione e limiti professionali.

La responsabilità sulle procedure di competenza non equivale alla responsabilità esclusiva di tutto ciò che avviene in laboratorio. La decisione clinica, la validazione o interpretazione attribuita ad altri professionisti, la manutenzione specialistica e le responsabilità organizzative seguono le rispettive fonti e attribuzioni.

IL TSRM

Il tecnico sanitario di radiologia medica compie gli atti di propria competenza con le tecnologie e le energie indicate dal profilo, su prescrizione e secondo i protocolli definiti nel contesto applicabile. Il D.M. 746/1994 collega il ruolo anche alla programmazione e organizzazione del lavoro, alla qualità delle prestazioni e al controllo delle apparecchiature.

Anche la formula «esegue esami radiologici» è troppo povera. La risposta deve ordinare:

1. prescrizione e inquadramento dell'attività;
2. protocollo applicabile e identificazione corretta della prestazione;
3. preparazione tecnica e controlli previsti;
4. qualità, sicurezza e tracciabilità;
5. riconoscimento dell'anomalia, comunicazione ed eventuale sospensione o escalation secondo il rischio e le procedure.

Il TSRM risponde degli atti di propria competenza, ma non assume automaticamente le responsabilità del medico specialista, dello specialista in fisica medica, dell'esperto di radioprotezione, dell'ingegneria clinica o del manutentore. La collaborazione non elimina i confini: li rende operativi.

CHE COSA CONDIVIDONO

I due profili condividono alcuni principi di lavoro: responsabilità tecnico-professionale, qualità, sicurezza, tracciabilità, uso appropriato delle apparecchiature, aggiornamento e collaborazione multiprofessionale. Questi elementi comuni non rendono comuni le tecniche.

Davanti a una traccia trasversale, è utile seguire questo ordine:

oggetto del lavoro → regola o procedura → controllo → comunicazione/documentazione → limite.

Questo ordine rende riconoscibile il ragionamento professionale senza inventare una sequenza esecutiva universale.

Requisiti: titolo, albo e bando concreto

Nel campione di dieci bandi ufficiali esaminati, cinque TSLB e cinque TSRM, ricorrono per entrambi i profili la laurea della classe L/SNT3 o un titolo ammesso e l'iscrizione all'albo. La ricorrenza orienta le priorità di studio, ma non diventa una regola generale: il candidato deve verificare la formula della procedura alla quale intende partecipare.

TITOLO ABILITANTE E DENOMINAZIONE DEL PROFILO

La classe di laurea non sostituisce la denominazione professionale richiesta. TSLB e TSRM possono appartenere alla stessa classe, ma il percorso abilitante e il profilo sono diversi. Non basta quindi leggere «L/SNT3» e concludere che ogni laurea della classe consenta l'accesso a ogni posto tecnico-sanitario.

La verifica deve mettere a confronto:

Voce	Domanda
posto	qual è la denominazione completa del profilo messo a concorso?
titolo richiesto	quale laurea, diploma universitario o titolo pregresso è indicato?
titolo posseduto	la denominazione coincide oppure serve una fonte di equipollenza o equivalenza?
abilitazione	il titolo è abilitante per il profilo richiesto?
albo	quale iscrizione è richiesta e in quale momento deve essere posseduta?

Equipollenza ed equivalenza non significano semplice somiglianza tra corsi. Sono qualificazioni giuridiche da dimostrare con la fonte pertinente. Lo stesso vale per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero: una traduzione del certificato non sostituisce il provvedimento richiesto.

ISCRIZIONE ALL'ALBO

La legge 3/2018 ha riordinato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie. Ai fini della domanda, il requisito non si presume né si parafrasa: si copia la formula del bando, si verifica l'albo pertinente, si controlla il momento del possesso e si conservano i dati necessari.

Il sistema ordinistico non determina da solo il programma del concorso. Profilo, bando, fonti tecniche e organizzazione della procedura restano distinti.

ELEMENTI STRUTTURALI E MOBILI

Sono relativamente stabili la fonte che individua il profilo e il suo perimetro essenziale. Sono mobili posti, riserve, scadenze, modalità della domanda, punteggi, soglie, calendario, eventuale preselezione, modalità delle verifiche linguistiche e informatiche, banca dati, tecnologie richiamate e forma concreta delle prove.

Alcuni elementi sono contemporaneamente strutturali e da verificare. Titolo e albo appartengono alla struttura professionale, ma la loro formulazione, i titoli pregressi ammessi e il momento del possesso si leggono nel bando vigente. La categoria corretta non è quindi «lo so già», ma «so quale controllo devo fare».

Scritta, pratica e orale: come cambia la prestazione

Il D.P.R. 220/2001 offre il contesto speciale dei concorsi del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (SSN). La disciplina generale e il singolo bando completano il quadro. Nei dieci bandi TSLB e TSRM esaminati ricorrono prova scritta, pratica e orale, ma contenuto, modalità e criteri si verificano sempre negli atti della procedura.

PROVA SCRITTA

La scritta può chiedere quesiti, risposte sintetiche o un elaborato tecnico-professionale. Il candidato deve dimostrare conoscenza ordinata e lessico preciso.

Per una risposta sintetica sul profilo usa quattro passaggi:

1. definizione e fonte del profilo;
2. attività o responsabilità centrali;
3. collaborazione e qualità;
4. limite o distinzione decisiva.

Una risposta TSLB che parla genericamente di «esami diagnostici» perde precisione. Una risposta TSRM che elenca apparecchiature senza collegarle a prescrizione, protocolli, qualità e responsabilità non mostra il quadro professionale.

PROVA PRATICA O PRATICA ILLUSTRATA

La prova pratica non coincide necessariamente con l'esecuzione manuale di una tecnica. Può chiedere di riconoscere una situazione, descrivere un processo, analizzare un'anomalia, proporre controlli, ordinare azioni o spiegare una procedura.

Per il TSLB, la traccia può riguardare fasi del processo di laboratorio, campione, qualità, biosicurezza o problema tecnico. Per il TSRM, può riguardare una tecnica di imaging, qualità dell'immagine, apparecchiatura, radioprotezione o gestione di un'anomalia. Il dettaglio deve provenire dal programma del bando e dalle fonti tecniche pertinenti.

Quando mancano dati indispensabili, la risposta professionale non inventa un parametro. Dichiara ciò che occorre verificare: identificazione, procedura, protocollo, istruzioni del fabbricante, condizioni del paziente o del campione, stato dell'apparecchiatura e soggetti da coinvolgere.

PROVA ORALE

L'orale verifica la capacità di spiegare, distinguere e sostenere domande successive. Una risposta efficace dura quanto richiesto, ma mantiene una struttura riconoscibile:

inquadramento → regola → applicazione → collaborazione → limite → verifica finale.

La commissione può partire dal profilo e spostarsi su qualità, sicurezza, organizzazione del SSN, deontologia, informatica e inglese secondo le modalità previste. Il candidato deve mantenere il confine del profilo anche quando la domanda diventa interdisciplinare.

Responsabilità, collaborazione e limiti

Nel linguaggio concorsuale «responsabilità» non significa automaticamente responsabilità civile o penale. Può indicare il dovere professionale di compiere correttamente un atto, verificare un controllo, documentare un evento, comunicare un'anomalia o riconoscere un limite.

Per analizzare un'attività usa cinque domande:

Passaggio	Domanda di controllo
atto	che cosa deve essere fatto o valutato?
responsabile	quale soggetto assume la decisione o l'adempimento di competenza?
collaboratori	quali altri professionisti o servizi intervengono?
limite	quale decisione, tecnica o manutenzione appartiene ad altri?
fonte	quale profilo, norma, protocollo, procedura o istruzione regola il passaggio?

La matrice evita due errori opposti: descrivere il tecnico come un mero esecutore privo di autonomia oppure trasformare l'autonomia in competenza illimitata. Il professionista esercita autonomia e responsabilità nel proprio campo, dentro un sistema organizzato e multiprofessionale.

UN'ANOMALIA NON CANCELLA I CONFINI

Di fronte a un'anomalia, il candidato deve mostrare una sequenza prudente:

1. riconoscere il problema e valutarne l'impatto nel proprio campo;
2. evitare la prosecuzione automatica se può compromettere sicurezza o affidabilità;
3. applicare i controlli e le misure previsti dalla procedura;
4. documentare e comunicare ai soggetti competenti;

5. riprendere l'attività soltanto quando sussistono le condizioni previste.

La sequenza è un modello di ragionamento, non una procedura tecnica. Nel laboratorio cambiano campione, metodo, analizzatore e rischio. In radiologia cambiano tecnologia, prestazione, paziente, protocollo e tipo di esposizione. Per questo non esiste un comando operativo valido per ogni caso.

DUE ATTI PROFESSIONALI A CONFRONTO

La matrice atto-responsabile-collaboratori-limite-fonte diventa utile quando viene compilata su fatti concreti. I due scenari seguenti partono entrambi da una discordanza, ma conducono ad atti professionali diversi.

SCENARIO TSLB: CAMPIONE E RICHIESTA NON CONCORDANO

All'accettazione di un campione, l'identificativo riportato sul contenitore non coincide con quello associato alla richiesta. L'anomalia può compromettere la riferibilità del risultato alla persona corretta.

Passaggio	Applicazione al caso
atto	verificare la conformità del campione e della richiesta prima di proseguire il processo analitico
responsabile	il TSLB svolge i controlli e gli adempimenti che rientrano nella procedura analitica e nel proprio operato
collaboratori	unità che ha inviato il campione, professionisti responsabili del prelievo o dell'invio e responsabile del laboratorio secondo l'organizzazione
limite	non ricostruire l'identità per supposizione, non modificare la richiesta e non decidere fuori dalle attribuzioni definite
fonte	profilo professionale, procedura di accettazione e non conformità, sistema qualità e regole di tracciabilità del laboratorio

La risposta di prova deve fermarsi prima della tecnica analitica. Il TSLB riconosce la non conformità, evita che il campione entri automaticamente nel flusso, esegue le verifiche previste, registra l'evento e comunica con i soggetti competenti. Accettazione condizionata, rigetto o nuova raccolta dipendono dalla procedura, dal tipo di campione, dal rischio e dalle responsabilità definite: non si inventano dalla traccia.

SCENARIO TSRM: RICHIESTA E PRESTAZIONE PROGRAMMATA NON CONCORDANO

Prima della prestazione, il distretto indicato nella richiesta non coincide con quello riportato nella programmazione. Mancano elementi per stabilire se si tratti di un errore di registrazione o di una diversa indicazione.

Passaggio	Applicazione al caso
atto	verificare identità, richiesta e corrispondenza della prestazione prima di compiere l'atto tecnico
responsabile	il TSRM risponde delle verifiche e degli atti tecnici che rientrano nella propria competenza
collaboratori	medico richiedente, medico specialista responsabile della prestazione e personale che gestisce richiesta e programmazione, secondo il setting
limite	non modificare autonomamente la prescrizione, non scegliere una diversa prestazione clinica e non improvvisare un protocollo
fonte	profilo professionale, prescrizione valida, protocollo applicabile e procedura di identificazione e gestione delle discordanze

Anche qui la prosecuzione automatica è l'errore da evitare. Il TSRM sospende il passaggio incompatibile con una verifica sicura, chiarisce la discordanza attraverso i canali previsti, documenta quanto richiesto e riprende l'attività solo dopo che richiesta, prestazione e protocollo risultano coerenti. La decisione clinica resta al soggetto competente; al TSRM appartengono la corretta gestione dell'atto tecnico e il riconoscimento del limite.

Il confronto mostra la differenza. Nel primo caso il centro è l'integrità del percorso campione-risultato; nel secondo è la corrispondenza tra persona, richiesta e prestazione tecnica. Sono comuni prudenza, tracciabilità e comunicazione, non l'atto professionale né la fonte operativa.

La Mappa BANDO per TSLB e TSRM

Passaggio	Domanda specifica	Prodotto di studio
B — Bando	qual è il profilo esatto? quali titolo, albo, materie e prove?	scheda della procedura
A — Aree	quali nuclei sono comuni e quali appartengono solo alla preparazione TSLB o TSRM?	mappa delle aree
N — Nuclei	quali concetti e distinzioni devono diventare risposta o caso?	elenco prioritizzato
D — Diario	l'errore nasce da fonte, profilo, contenuto, applicazione o forma della risposta?	diario degli errori
O — Output	devo riconoscere, spiegare, confrontare, descrivere o gestire un caso?	prova allenabile

B — COPIA PRIMA DI INTERPRETARE

Registra la denominazione del posto, i requisiti specifici, il programma e la sequenza delle prove. Non sostituire le parole del bando con una sintesi fino a quando non hai chiuso la verifica su titolo e albo.

A — SEPARA IL NUCLEO COMUNE DALLE MATERIE DEL PROFILO

Qualità, sicurezza, tracciabilità e responsabilità sono assi comuni. Processo di laboratorio e discipline analitiche appartengono al TSLB. Imaging, dosimetria e radioprotezione appartengono al TSRM. Apparecchiature e rischio tecnologico sono trasversali, ma cambiano tecnologia, rischio e soggetti responsabili.

N — TRASFORMA LE MATERIE IN NUCLEI

«Legislazione professionale» è un'area. «Campo proprio di attività e responsabilità» è un nucleo. «Tecniche di laboratorio» è un'area. «Fasi del processo, controlli e punti di errore» è un insieme di nuclei. «Radioprotezione» è un'area. «Giustificazione, ottimizzazione, limiti e responsabilità» contiene nuclei distinti.

D — CORREGGI LA CAUSA

Se confondi TSLB e TSRM, non serve ripetere più quiz: devi ricostruire i due profili. Se conosci la regola ma la esponi senza ordine, devi allenare l'output. Se usi una procedura locale come norma nazionale, devi correggere la fonte.

O — PRODUCI CIÒ CHE SARÀ VALUTATO

Accanto a ogni nucleo scrivi il prodotto: definizione in quattro righe, confronto, risposta orale di due minuti, analisi di un'anomalia, schema di processo o checklist. Lo studio diventa verificabile quando produce una prestazione.

Caso guidato: due avvisi, una lettura corretta

Considera due procedure didattiche costruite sulle ricorrenze del campione. La prima riguarda un posto TSLB e richiede titolo abilitante, albo, prova scritta, pratica e orale; tra le materie indica tecniche di laboratorio, qualità e biosicurezza. La seconda riguarda un posto TSRM, con requisiti e sequenza delle prove simili, ma indica imaging, radioprotezione, qualità dell'immagine e apparecchiature.

PASSAGGIO 1 — NON FERMARSI AGLI ELEMENTI COMUNI

La presenza, in entrambi gli avvisi, della classe L/SNT3 non rende intercambiabili i titoli. Occorre leggere la denominazione del profilo, la formulazione completa del titolo ammesso e l'albo richiesto.

PASSAGGIO 2 — SEPARARE IL NUCLEO COMUNE

Entrambi i candidati studieranno profilo, ordinamento professionale, qualità, sicurezza e responsabilità. Il TSLB applicherà questi concetti al processo di laboratorio; il TSRM al processo tecnico-radiologico. Anche quando le parole coincidono, l'applicazione cambia.

PASSAGGIO 3 — TRADURRE LE PROVE

Il candidato TSLB prepara risposte sulle fasi analitiche e casi su campione, controllo o non conformità, nei limiti delle fonti tecniche. Il candidato TSRM prepara risposte sulle tecniche richieste e casi su qualità, apparecchiatura o radioprotezione, senza inventare parametri.

PASSAGGIO 4 — REGISTRARE I DATI MOBILI

Punteggi, soglie, date, sedi, eventuale banca dati, criteri della pratica e modalità dell'orale restano nella scheda della singola procedura. Una variazione comunicata dall'ente aggiorna il piano di prova, non il profilo professionale.

PASSAGGIO 5 — COSTRUIRE IL PIANO MINIMO

Per ogni materia crea quattro colonne: nucleo, fonte, prova, output. Se la riga «responsabilità professionale» non indica quale distinzione deve essere spiegata e in quale formato, il piano è ancora troppo generico.

Domanda da commissario

Quali sono le principali differenze tra il profilo del TSLB e quello del TSRM?

Una risposta completa può essere organizzata così:

Il TSLB, individuato dal D.M. 745/1994, opera nelle attività di laboratorio biomedico e biotecnologico ed è responsabile del corretto adempimento delle procedure analitiche di competenza, dei controlli collegati a indicatori e standard e del funzionamento delle apparecchiature nei limiti del profilo. Il TSRM, individuato dal D.M. 746/1994, compie gli atti tecnico-sanitari di competenza con le tecnologie previste dal profilo, su prescrizione e secondo protocolli definiti, contribuendo alla qualità e al controllo delle apparecchiature.

Entrambi esercitano responsabilità professionale, collaborano con l'équipe e devono riconoscere i propri limiti. Non sono però intercambiabili: cambiano oggetto, tecniche, rischi, fonti specialistiche e soggetti con cui si raccordano.

In questo modo la commissione ritrova fonte, oggetto, responsabilità, elemento comune e distinzione decisiva.

Domanda-trappola

Poiché TSLB e TSRM appartengono alla stessa classe di laurea L/SNT3, un titolo consente di partecipare a entrambi i concorsi?

No. L'appartenenza alla stessa classe non rende equivalenti i percorsi abilitanti né i profili. Occorre verificare la denominazione professionale richiesta, il titolo posseduto, le eventuali norme su equipollenza o equivalenza e l'albo indicato dal bando.

La trappola consiste nel confondere una classificazione universitaria con l'abilitazione a una specifica professione.

Errore tipico: il «tecnico sanitario generico»

Il candidato studia qualità, sicurezza e apparecchiature come se avessero lo stesso significato in ogni servizio. Poi, nella risposta, attribuisce al TSLB attività radiologiche o descrive il TSRM con il linguaggio del laboratorio.

Per correggere l'errore, costruisci due colonne separate e completa per ciascun profilo:

1. oggetto dell'attività;
2. fonte del profilo;
3. processo prevalente;
4. rischio caratteristico;
5. collaboratori;
6. limite da dichiarare.

Gli elementi comuni vanno aggiunti soltanto dopo. In questo modo la somiglianza non cancella la differenza.

Mini-esercizio: profilo, requisito o dato mobile?

Classifica ogni affermazione con P se riguarda il profilo, R se richiede la verifica dei requisiti e M se è un dato mobile della procedura.

1. Il TSLB opera nelle attività di laboratorio biomedico.
2. Uno specifico diploma pregresso è equipollente al titolo richiesto.
3. La prova orale si svolgerà il 18 novembre.
4. Il TSRM compie gli atti tecnici di propria competenza secondo il quadro applicabile.
5. L'iscrizione all'albo deve essere posseduta entro il termine indicato dal bando.
6. La commissione userà quesiti a risposta multipla.
7. Il numero dei posti è cinque.
8. Il titolo conseguito all'estero è stato riconosciuto per il profilo richiesto.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. P: deriva dal profilo professionale.
2. R: serve la fonte giuridica pertinente al titolo concreto.
3. M: il calendario può essere fissato o modificato con avviso ufficiale.
4. P: descrive il perimetro generale del profilo, da applicare al contesto.
5. R: albo e momento del possesso si verificano nella formula del bando.
6. M: la modalità effettiva deriva dagli atti della procedura.
7. M: vale per quel concorso.
8. R: il riconoscimento non si presume dalla traduzione del titolo.

Mini-esercizio: atto, responsabile, limite

Per ciascuno scenario scrivi cinque righe: atto, responsabile, collaboratori, limite e fonte da controllare.

- un campione presenta un'anomalia che può compromettere l'affidabilità del risultato;
- prima di una prestazione radiologica emerge una discordanza tra richiesta e dati disponibili;
- un'apparecchiatura segnala un funzionamento anomalo durante l'attività.

Una risposta adeguata non inventa la soluzione tecnica. Identifica il profilo, mette al centro sicurezza e affidabilità, richiama la procedura applicabile, prevede documentazione e comunicazione e assegna la decisione fuori competenza al soggetto corretto.

Checklist del capitolo

Prima di iniziare il piano di studio, controlla:

- ☐ ho identificato la denominazione completa del profilo;
- ☐ ho collegato il profilo al D.M. 745/1994 o al D.M. 746/1994;
- ☐ ho copiato la formula esatta del titolo richiesto;
- ☐ ho verificato eventuali equipollenze, equivalenze o riconoscimenti;
- ☐ ho controllato albo e momento del possesso;
- ☐ ho distinto dati stabili e dati mobili della procedura;
- ☐ ho trascritto materie e prove nell'ordine del bando;
- ☐ ho separato il nucleo comune dalle materie specifiche TSLB e TSRM;
- ☐ ho associato ogni nucleo a un output;
- ☐ so spiegare autonomia, collaborazione e limite;
- ☐ evito di attribuire a un profilo le competenze dell'altro;
- ☐ verifico avvisi, calendario e istruzioni ufficiali prima della prova.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.M. 26 settembre 1994, n. 745, profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
- D.M. 26 settembre 1994, n. 746, profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.
- Legge 26 febbraio 1999, n. 42, disciplina delle professioni sanitarie.
- Legge 10 agosto 2000, n. 251, disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
- Legge 1 febbraio 2006, n. 43, professioni sanitarie e formazione.
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3, riordino degli ordini delle professioni sanitarie.
- D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN.

Il quadro è verificato al 31 luglio 2026. Requisiti, titoli ammessi, prove, punteggi, calendario, tecnologie e modalità operative devono essere controllati nel bando e negli avvisi ufficiali della procedura scelta.

TSLB: processo di laboratorio, qualità e biosicurezza

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Un risultato di laboratorio non nasce nel momento in cui uno strumento produce un numero o un segnale. Comincia dal quesito che motiva l'esame, attraversa identificazione, raccolta, trasporto, accettazione, preparazione e analisi, quindi prosegue con controllo, validazione, comunicazione e conservazione delle informazioni. Un errore in uno solo di questi passaggi può rendere inutilizzabile anche un'analisi tecnicamente corretta.

Nei concorsi per tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB), la commissione verifica perciò una competenza più ampia della conoscenza di singole tecniche. Il candidato deve saper ricostruire il processo, riconoscere dove può fallire, collegare qualità e biosicurezza e proporre una risposta prudente quando i dati non permettono di applicare una procedura specifica.

Obiettivo del capitolo

Al termine saprai:

- distinguere fase preanalitica, analitica e postanalitica;
- spiegare il ruolo della tracciabilità lungo il percorso del campione;
- distinguere dato analitico, validazione e refertazione senza attribuire responsabilità universali;
- orientarti tra biochimica, microbiologia, ematologia, immunologia e patologia;
- valutare a livello concettuale l'appropriatezza di un metodo rispetto al quesito;
- distinguere sistema di gestione della qualità, controllo qualità e valutazione esterna;
- impostare la gestione di una non conformità e di un'azione correttiva;
- applicare una valutazione di biosicurezza basata su pericolo, attività, esposizione, probabilità e conseguenze;
- strutturare una prova pratica illustrata senza inventare parametri o istruzioni operative.

Mappa BANDO del laboratorio

Passaggio	Domanda per il candidato	Prodotto di studio
B — Bando	quali discipline, fasi, sistemi qualità e rischi compaiono nel programma?	scheda delle materie e delle prove
A — Aree	il nucleo riguarda processo, disciplina, qualità o biosicurezza?	mappa delle aree

Passaggio	Domanda per il candidato	Prodotto di studio
N — Nuclei	quale definizione, distinzione o decisione deve essere dimostrata?	elenco prioritizzato
D — Diario	l'errore nasce da fase, identificazione, metodo, controllo, documento o rischio?	diario degli errori
O — Output	devo ricostruire un flusso, analizzare un evento, spiegare un controllo o valutare un rischio?	risposta o caso allenabile

Nel campione di cinque bandi TSLB esaminati ricorrono tecniche di laboratorio, fasi preanalitica, analitica e postanalitica, qualità, biosicurezza e discipline come biochimica, microbiologia ed ematologia. La ricorrenza orienta lo studio; il programma effettivo resta quello del singolo bando.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il processo di laboratorio è una catena e la qualità riguarda ogni anello. Il controllo qualità non coincide con l'intero sistema qualità. Una non conformità richiede contenimento, registrazione, analisi e verifica delle azioni. In biosicurezza il pericolo non è il rischio: contano anche attività, esposizione, probabilità e conseguenze. Parametri, DPI e procedure si scelgono sulla valutazione del setting, non per memoria astratta.

Il ruolo del TSLB nel processo

Il D.M. 26 settembre 1994, n. 745 individua il TSLB e collega il profilo alle attività di analisi e ricerca biomedica e biotecnologica. Il tecnico è responsabile del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato nell'ambito delle funzioni attribuite; verifica inoltre la corrispondenza delle prestazioni a indicatori e standard e controlla il funzionamento delle apparecchiature nei limiti di competenza.

Questa responsabilità non rende il TSLB responsabile di ogni passaggio che precede o segue l'analisi. Prelievo, indicazione clinica, interpretazione, rilascio, manutenzione specialistica e organizzazione del servizio possono coinvolgere soggetti diversi. Nella risposta concorsuale occorre quindi distinguere:

1. attività svolta dal TSLB;
2. procedura o criterio applicabile;
3. controllo di competenza;
4. collaborazione necessaria;

5. decisione che appartiene ad altro soggetto.

Il confine non riduce la responsabilità professionale. La rende precisa.

Il percorso dal quesito al risultato

La suddivisione in fase preanalitica, analitica e postanalitica serve a localizzare attività, controlli ed errori. Le tre fasi sono collegate: una non conformità preanalitica può produrre un dato analiticamente stabile ma riferito al campione sbagliato; un errore postanalitico può compromettere la comunicazione di un dato tecnicamente corretto.

FASE PREANALITICA

La fase preanalitica comprende ciò che prepara l'analisi. Inizia con il quesito e la richiesta, prosegue con identificazione, preparazione della persona quando prevista, raccolta, contenitore, etichettatura, trasporto, ricezione, accettazione e trattamento iniziale del campione.

Non tutte queste attività si svolgono nel laboratorio o sono compiute dal TSLB. Il laboratorio deve però governare i requisiti che rendono il campione utilizzabile e tracciabile. In prova, il candidato deve riconoscere almeno quattro gruppi di rischio:

- discordanza tra persona, richiesta e campione;
- campione raccolto, conservato o trasportato in condizioni non conformi ai requisiti applicabili;
- quantità, contenitore o integrità non adeguati;
- informazioni mancanti che impediscono una decisione sicura.

La risposta non deve inventare criteri di accettazione. Deve indicare che tali criteri derivano dal metodo, dalla procedura e dal tipo di campione; l'evento va riconosciuto, registrato e gestito prima della prosecuzione automatica.

FASE ANALITICA

La fase analitica trasforma il campione in un dato attraverso un metodo definito. Comprende preparazione prevista, esecuzione, controlli, gestione dei reagenti e dei materiali, funzionamento dell'apparecchiatura e verifica delle condizioni che rendono il risultato tecnicamente affidabile.

La qualità analitica non dipende da un solo controllo. Richiede personale competente, metodo adatto, apparecchiatura idonea, materiali gestiti, documentazione disponibile, registrazioni complete e risposta agli scostamenti. Un segnale anomalo non si gestisce ripetendo automaticamente l'analisi: prima si deve capire quale parte del sistema può averlo prodotto.

FASE POSTANALITICA

La fase postanalitica riguarda il passaggio dal dato prodotto alla sua disponibilità per l'uso previsto. Può comprendere revisione dei dati, livelli di validazione, rilascio o refertazione, comunicazione, gestione di risultati che richiedono un percorso specifico, archiviazione e conservazione delle informazioni.

Ruoli e firme non si deducono dalla parola «postanalitica». Dipendono da profilo, organizzazione, disciplina, procedura e sistema informativo. Il TSLB deve saper riconoscere la correttezza tecnica del proprio operato e segnalare ciò che esce dai limiti; non deve appropriarsi dell'interpretazione clinica o di attribuzioni assegnate ad altri.

TRACCIABILITÀ

La tracciabilità permette di ricostruire chi ha fatto che cosa, su quale campione, con quale metodo, materiale, apparecchiatura, controllo, data e risultato. Non è una raccolta indiscriminata di dati. Registra le informazioni necessarie a collegare evento, decisione e responsabilità.

Una catena tracciabile consente di:

- seguire il campione lungo le tre fasi;
- delimitare i risultati potenzialmente interessati da un problema;
- ricostruire cause e fattori contribuenti;
- dimostrare che controlli e comunicazioni sono avvenuti;
- verificare l'efficacia di un'azione correttiva.

VALIDAZIONE E REFERTAZIONE

Validazione e refertazione non sono sinonimi. La validazione indica il processo con cui si verifica che dati e condizioni soddisfino i criteri previsti prima del rilascio; può avere livelli tecnico-analitici e professionali differenti. La refertazione è la produzione e messa a disposizione del documento o risultato secondo regole, responsabilità e modalità del servizio.

La distinzione da usare in prova è questa:

Passaggio	Domanda
dato	che cosa ha prodotto il metodo?
controllo tecnico	le condizioni analitiche e i controlli previsti sono accettabili?

Passaggio	Domanda
validazione	chi può autorizzare il passaggio successivo e secondo quali criteri?
interpretazione	quale significato può essere attribuito e da quale professionista?
refertazione/comunicazione	come e da chi il risultato viene rilasciato secondo il sistema applicabile?

La tabella impedisce di attribuire automaticamente al TSLB ogni livello di validazione o refertazione. Se la traccia non specifica il ruolo, la risposta deve indicare che l'attribuzione dipende dalla fonte organizzativa applicabile.

Le discipline applicate: una mappa per orientarsi

Le discipline di laboratorio non sono un elenco di strumenti. Ognuna collega un quesito a una matrice biologica, a un principio di misura o identificazione, a controlli e a limiti. Nei bandi il livello di dettaglio cambia; la prima competenza consiste nel classificare correttamente il problema.

Disciplina	Oggetto prevalente	Domanda iniziale del candidato
biochimica clinica	componenti e processi chimico-biologici misurabili nelle matrici pertinenti	quale analita o processo si vuole valutare e con quale principio?
microbiologia	ricerca, rilevazione o caratterizzazione di microrganismi e loro componenti	quale agente o segnale si cerca, in quale campione e con quali limiti?
ematologia	cellule del sangue, parametri correlati ed emostasi nei limiti del programma	quale componente o funzione è oggetto dell'esame?
immunologia	componenti e reazioni del sistema immunitario, inclusi antigeni e anticorpi	il metodo rileva una componente, una risposta o un'interazione?
patologia, istologia e citologia	cellule e tessuti preparati per osservazione e valutazione nel percorso diagnostico	quali passaggi preservano identità, rappresentatività e qualità del preparato?

Questa è una mappa di orientamento, non un criterio per scegliere una tecnica. Microbiologia non è sinonimo di coltura; immunologia non coincide con un solo tipo di reazione; patologia non attribuisce al TSLB la diagnosi. Metodo, responsabilità e profondità dipendono dalla traccia e dalle fonti della disciplina.

PRINCIPI ANALITICI DA RICONOSCERE

In biochimica clinica si misura un analita, per esempio glucosio o creatinina, collegando una proprietà osservabile alla sua quantità. Nella spettrofotometria il segnale è l'assorbimento di luce a una determinata lunghezza d'onda; entro le condizioni e l'intervallo del metodo, la relazione con la concentrazione consente la misura. Nei metodi elettrochimici il segnale deriva da proprietà elettriche, come la differenza di potenziale in un elettrodo selettivo. Il metodo non misura «la malattia»: produce un risultato che va interpretato nel contesto clinico. Emolisi, lipemia o ittero possono interferire in modo diverso secondo analita e tecnologia; non tutti i risultati dello stesso campione sono automaticamente invalidi.

In microbiologia, coltura, ricerca antigenica e amplificazione di acidi nucleici rispondono a domande diverse. La coltura dimostra crescita nelle condizioni adottate e può fornire un isolato per identificazione e studio della sensibilità agli antimicrobici. Un test molecolare cerca una sequenza bersaglio: rilevarla non prova da solo vitalità del microorganismo o malattia attiva. Un risultato negativo può dipendere da assenza del bersaglio, quantità sotto il limite di rilevazione, campione non rappresentativo o inibizione.

Il controllo interno aiuta a distinguere alcune di queste condizioni; non rende irrilevante la qualità del prelievo. Nell'antibiogramma si interpreta la sensibilità rispetto a criteri aggiornati e al microorganismo, senza scegliere la terapia al posto del clinico.

In ematologia, l'emocromo quantifica popolazioni cellulari e parametri correlati. Conta mediante impedenza e analisi ottica sono principi differenti; la citometria a flusso studia cellule in sospensione attraverso segnali di diffusione della luce e, quando previsti, marcature fluorescenti. Uno striscio consente la valutazione morfologica e integra l'informazione numerica. Un flag strumentale indica un approfondimento previsto dal percorso, non equivale già a una diagnosi. Nell'emostasi, esami come PT e aPTT misurano tempi di formazione del coagulo in condizioni definite: la loro alterazione non identifica da sola una specifica causa e risente anche di problemi preanalitici.

In immunologia, molti saggi sfruttano il riconoscimento tra antigene e anticorpo, reso misurabile mediante un segnale enzimatico, luminoso o fluorescente. Si può cercare un antigene oppure la risposta anticorpale; una positività anticorpale non coincide sempre con un'infezione attiva. Cross-reattività e interferenze possono modificare il segnale. La soglia di positività, il periodo dall'esposizione e lo scopo del test incidono sull'interpretazione. La sensibilità analitica, cioè la capacità di rilevare piccole quantità del bersaglio, non coincide con la sensibilità diagnostica, cioè la quota di malati correttamente identificati.

In istologia e citologia, fissazione e preparazione conservano quanto possibile strutture e componenti da osservare. Nell'istologia si studia anche l'architettura del tessuto; nella citologia prevalgono le caratteristiche delle cellule. Un campione mal identificato, non rappresentativo o alterato nella preparazione può compromettere la successiva valutazione. Il TSLB assicura la qualità tecnica nel proprio ruolo; la diagnosi resta attribuita al professionista competente.

Verifica. Un test molecolare è positivo e la coltura è negativa: è necessariamente un errore? No. Le due tecniche rilevano proprietà diverse; occorre considerare vitalità, terapie precedenti, qualità del campione, quantità del bersaglio e condizioni di coltura. La discordanza va analizzata, non eliminata scegliendo il risultato preferito.

LA GRIGLIA QUESITO-CAMPIONE-METODO-CONTROLLI-LIMITI

Per affrontare una domanda tecnica senza perdersi nei dettagli, usa cinque passaggi:

1. quesito: quale informazione deve produrre l'esame?
2. campione o matrice: è pertinente e adeguato allo scopo?
3. metodo o principio: che cosa rileva o misura e in quale intervallo di applicazione?
4. controlli: quali evidenze mostrano che il processo ha funzionato come previsto?
5. limiti: quali interferenze, incertezze o condizioni impediscono una conclusione automatica?

L'appropriatezza del metodo è la corrispondenza tra quesito, campione, prestazione richiesta e capacità del metodo. Non significa scegliere la tecnologia più complessa. Un metodo può essere accurato nel proprio campo e inadatto al quesito, al campione o alla tempestività richiesta.

In una prova pratica illustrata, il candidato può motivare il percorso senza fornire parametri:

- definisce il quesito;
- verifica campione e tracciabilità;
- identifica il principio pertinente;
- richiama controlli e criteri di accettabilità;
- dichiara limiti e dati mancanti;
- indica chi valida, interpreta o decide il passaggio successivo.

Il sistema di gestione della qualità

La qualità di laboratorio è la capacità del sistema di produrre risultati accurati, affidabili e tempestivi, adatti all'uso previsto. Il sistema di gestione della qualità, spesso indicato con QMS, coordina persone, processi, risorse, informazioni e miglioramento. Non coincide con il controllo eseguito durante una singola analisi.

Il manuale dell'Organizzazione mondiale della sanità organizza il QMS in dodici elementi essenziali.

Elemento essenziale	Funzione nel sistema
organizzazione	definisce governance, responsabilità, politiche e coordinamento
personale	assicura competenza, formazione, autorizzazioni e aggiornamento
apparecchiature	governa selezione, installazione, uso, controlli e gestione delle anomalie
acquisti e inventario	rende disponibili materiali idonei, identificati e gestiti
controllo dei processi	mantiene sotto controllo le attività preanalitiche, analitiche e postanalitiche
gestione delle informazioni	protegge integrità, disponibilità, correttezza e tracciabilità dei dati
documenti e registrazioni	distingue ciò che prescrive il lavoro da ciò che prova che è stato svolto
gestione delle non conformità	rileva, contiene, analizza e tratta gli scostamenti
valutazione	usa audit, riesami e altre verifiche per conoscere il funzionamento reale
miglioramento continuo	trasforma dati e problemi in azioni verificabili
attenzione all'utente	considera bisogni, comunicazioni, reclami e adeguatezza del servizio
strutture e sicurezza	collega ambienti, flussi, condizioni di lavoro e controllo dei rischi

I dodici elementi funzionano come un sistema. Un controllo analitico può segnalare un problema, mentre la causa può trovarsi nella formazione, nell'inventario, nella manutenzione, nel documento usato o nel sistema informativo. Fermarsi al segnale significa trattare il sintomo.

QMS, CONTROLLO QUALITÀ E VALUTAZIONE ESTERNA

Strumento	Domanda alla quale risponde	Limite
QMS	come si governa l'intero laboratorio e il suo miglioramento?	non è una singola prova o un singolo indicatore
controllo qualità interno, QC	il processo analitico mostra prestazioni accettabili durante l'attività?	non dimostra da solo che tutto il sistema sia efficace
valutazione esterna della qualità, EQA	come si colloca la prestazione rispetto a un esercizio o confronto esterno organizzato?	non sostituisce il controllo quotidiano né corregge automaticamente le cause

QC ed EQA sono complementari. Il primo offre segnali vicini all'attività analitica; la seconda aggiunge un punto di confronto esterno. Un buon esito EQA non cancella una non conformità interna, e un QC accettabile non prova che identificazione, trasporto o comunicazione siano corretti.

PRECISIONE, ESATTEZZA E CALIBRAZIONE

La precisione descrive quanto concordano misure ripetute nelle condizioni dichiarate. Una serie molto raccolta può essere precisa ma sistematicamente spostata rispetto al riferimento. L'esattezza riguarda la vicinanza della media di molte misure al valore di riferimento; lo scostamento sistematico è il bias. L'accuratezza esprime complessivamente la vicinanza del risultato al riferimento e non si dimostra con la sola ripetibilità. La deviazione standard descrive la dispersione; il coefficiente di variazione la rapporta alla media: $CV = \text{deviazione standard} / \text{media} \times 100$, quando questo rapporto è appropriato.

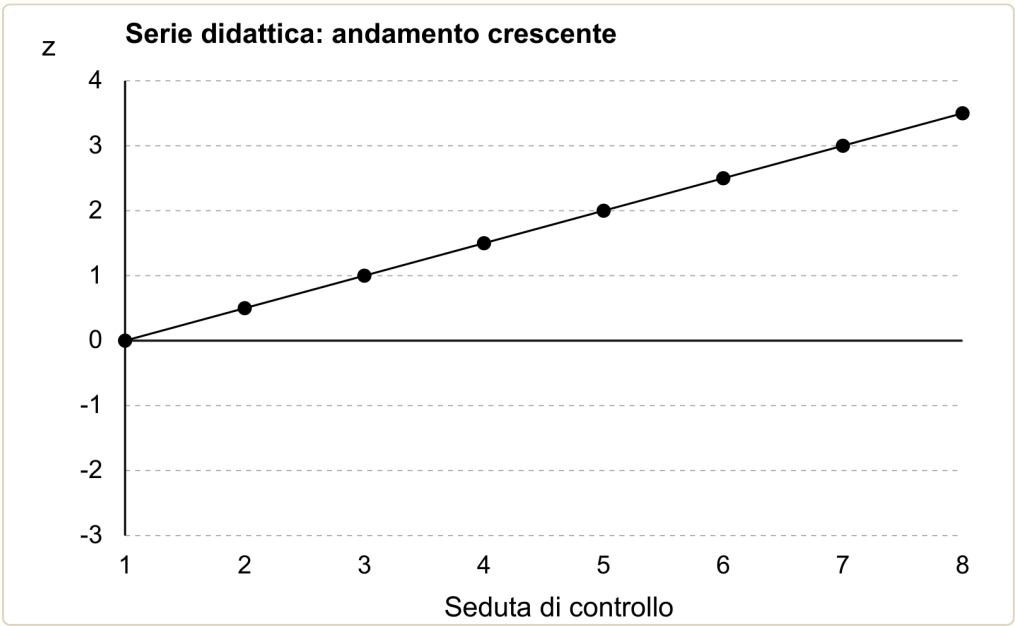
La calibrazione stabilisce la relazione tra segnale e valori assegnati a materiali di riferimento o calibratori. Il controllo qualità verifica che il sistema continui a fornire prestazioni accettabili: usa materiali e criteri predisposti a questo scopo e non coincide con il calibratore. Ricalibrare per far rientrare un controllo, senza indagare la causa e senza seguire il metodo, può mascherare un problema.

Esempio: un materiale ha riferimento 100 unità. Misure ripetute 109, 110 e 111 sono vicine tra loro, ma la loro media 110 è spostata di +10. Non basta quindi dire «le repliche concordano». Vanno considerate sia dispersione sia scostamento dal riferimento, insieme all'incertezza e ai criteri del metodo.

LEGGERE UNA SERIE DI CONTROLLO

Un grafico di Levey–Jennings riporta in ascissa la successione delle sedute e in ordinata il risultato del controllo; linee orizzontali indicano media e multipli della deviazione standard. Per confrontare la posizione dei risultati possiamo usare $z = (\text{valore} - \text{media}) / \text{deviazione standard}$. La tabella seguente contiene dati interamente didattici, riferiti a un solo materiale con media 100 e deviazione standard 2.

Seduta	Risultato	Posizione z
1	100	0
2	101	+0,5
3	102	+1
4	103	+1,5
5	104	+2
6	105	+2,5
7	106	+3
8	107	+3,5



Serie di controllo: otto sedute con z da 0 a 3,5 e andamento crescente

Figura — Serie didattica di controllo: andamento crescente rispetto alla media. I valori standardizzati permettono di osservare il trend; le decisioni dipendono dalle regole del piano QC. Non sono risultati di un paziente.

Domanda. La sesta seduta può essere considerata affidabile solo perché il risultato non supera ancora +3 deviazioni standard?

Soluzione. No: esiste già un andamento progressivamente crescente. Il trend suggerisce una variazione sistematica da indagare, per esempio nei reagenti, nella calibrazione o nel sistema, senza attribuire una causa certa dalla sola forma. Un improvviso assestamento su una nuova media sarebbe invece uno shift. Il singolo limite non sostituisce le regole del piano QC: queste devono essere definite per metodo e prestazioni richieste. Prima del rilascio dei risultati interessati si applica il percorso documentato di valutazione e gestione della non conformità; ripetere finché compare un valore favorevole non risolve il problema.

DOCUMENTI E REGISTRAZIONI

Un documento prescrive o guida: politica, procedura, istruzione, criterio o modulo. Una registrazione dimostra che un'attività o una decisione è avvenuta: risultato di controllo, manutenzione eseguita, formazione, non conformità, comunicazione o autorizzazione.

La distinzione ha conseguenze pratiche. Se una procedura cambia, occorre governarne versione, approvazione, distribuzione e ritiro delle copie superate. Se una registrazione è incompleta, manca un'evidenza del processo. Non basta affermare che «si è sempre fatto così».

INDICATORI E STANDARD

Un indicatore trasforma un aspetto del processo in informazione osservabile nel tempo. Lo standard o criterio stabilisce il riferimento con cui interpretarlo. Il candidato deve distinguere numero, indicatore e decisione: un valore isolato non spiega una causa e non determina automaticamente un'azione.

Una risposta ordinata specifica:

1. che cosa viene misurato;
2. con quale popolazione o denominatore quando pertinente;
3. quale periodo e fonte dei dati;
4. quale criterio attiva l'analisi;
5. chi valuta e quale verifica segue l'intervento.

Non conformità, azioni e miglioramento

Una non conformità è il mancato rispetto di un requisito. Può emergere in qualunque fase: richiesta incompleta, campione non idoneo, controllo fuori dai criteri, documento superato, registrazione mancante, comunicazione tardiva o condizione di sicurezza non rispettata.

La gestione segue una logica, non un modulo compilato per abitudine:

1. rilevare e descrivere i fatti;
2. contenere l'effetto e mettere in sicurezza processo, persone e risultati interessati;
3. correggere il problema immediato quando possibile e autorizzato;
4. valutare estensione, impatto e necessità di comunicazione;
5. analizzare causa e fattori contribuenti;
6. definire azione, responsabile, scadenza ed evidenza attesa;
7. verificare l'efficacia;
8. aggiornare rischio, documenti, formazione o controlli se necessario.

CORREZIONE E AZIONE CORRETTIVA

La correzione tratta la non conformità osservata. L'azione correttiva interviene sulla causa per ridurre il rischio che il problema si ripeta. Sono due livelli diversi.

Se un modulo è stato compilato in modo errato, correggere il dato risolve il caso immediato. Se l'errore deriva da campi ambigui, versioni diverse o formazione insufficiente, occorre intervenire sulla causa e poi verificare se l'azione ha funzionato.

L'acronimo CAPA viene usato in molti sistemi per azioni correttive e preventive. Il candidato non deve però trasformarlo in una formula automatica. Prima si definiscono requisito, evento, causa e rischio; poi si sceglie l'azione coerente con il sistema applicabile.

ANALISI DELLA CAUSA

La causa non coincide sempre con l'ultima persona che ha toccato il campione. Possono contribuire progettazione del flusso, carico di lavoro, interfaccia informatica, documento, addestramento, ambiente, materiale o apparecchiatura.

Una buona analisi separa:

- fatto osservato;
- effetto reale o potenziale;
- condizioni presenti;
- causa o fattori contribuenti supportati da evidenze;

- barriere che hanno funzionato o fallito.

La finalità è migliorare il sistema, non anticipare una responsabilità giuridica senza istruttoria.

AUDIT E VERIFICA DI EFFICACIA

L'audit confronta evidenze del lavoro reale con criteri definiti. Non serve soltanto a trovare errori: verifica se il sistema è applicato e se produce le evidenze attese.

La chiusura amministrativa di un'azione non ne dimostra l'efficacia. Occorre stabilire prima quale risultato sarà osservato, per quanto tempo, su quali dati e da chi. Se l'evento si ripete o l'indicatore non cambia, l'azione va rivalutata.

Biosicurezza: ragionare sul rischio

La biosicurezza applica principi, pratiche e misure per prevenire o ridurre esposizione e rilascio di agenti biologici durante le attività di laboratorio. Si integra con il sistema qualità e con la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma conserva un oggetto specifico: il rischio biologico prodotto dall'incontro tra agente, attività e contesto.

La quarta edizione del Laboratory Biosafety Manual dell'Organizzazione mondiale della sanità usa un approccio basato su rischio ed evidenze. Non assegna automaticamente una misura a un microrganismo considerato in astratto. Valuta ciò che viene fatto, come può avvenire l'esposizione o il rilascio, quanto è probabile e quali conseguenze può produrre.

PERICOLO E RISCHIO

Il pericolo è la capacità intrinseca di causare un danno. Il rischio considera la probabilità che il danno si verifichi e la gravità delle conseguenze nel contesto reale.

Lo stesso agente può generare rischi differenti se cambiano:

- quantità e caratteristiche del materiale;
- attività svolta e possibilità di aerosol, schizzi, tagli o dispersione;
- competenza del personale;
- apparecchiature e dispositivi di contenimento;
- ambiente, flussi e presenza di persone;
- misure già attive e capacità di risposta all'incidente.

In prova, pericolo e rischio vanno sempre separati. Il solo pericolo non permette di scegliere DPI, contenimento o decontaminazione.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Una valutazione non esecutiva può essere ordinata così:

1. identificare il pericolo e il materiale;
2. descrivere l'attività, non solo il nome dell'agente;
3. individuare le vie plausibili di esposizione o rilascio;
4. stimare probabilità e conseguenze con le informazioni disponibili;
5. considerare i controlli già presenti;
6. selezionare ulteriori misure proporzionate;
7. valutare il rischio residuo e decidere se l'attività può iniziare o proseguire;
8. documentare, comunicare e riesaminare quando cambiano attività, dati o condizioni.

L'ordine aiuta a rispondere. La valutazione reale può essere iterativa e deve rispettare norme, requisiti nazionali e procedure dell'istituzione.

BUONE PRATICHE E PROCEDURE MICROBIOLOGICHE

Le buone pratiche e procedure microbiologiche, indicate dall'OMS con la sigla GMPP, costituiscono la base della biosicurezza. Comprendono comportamenti, organizzazione e tecniche professionali che proteggono personale, campioni e ambiente da esposizione o rilascio.

In un manuale concorsuale è corretto spiegare le funzioni generali:

- preparare l'attività e limitare ciò che non serve;
- mantenere identificazione e ordine del flusso;
- ridurre gesti o condizioni che favoriscono dispersione;
- usare correttamente dispositivi e contenimento previsti;
- segnalare subito incidenti, anomalie e malfunzionamenti;
- formarsi, esercitarsi e rispettare le procedure applicabili.

Le sequenze tecniche dipendono da agente, attività, attrezzatura e setting. Non si deducono dalla sola sigla GMPP.

CONTENIMENTO E DPI

Il contenimento comprende misure fisiche, organizzative e operative che limitano esposizione o rilascio. Può riguardare progettazione degli spazi, dispositivi primari, flussi, accessi, procedure e comportamenti.

I dispositivi di protezione individuale sono una componente del sistema, non la risposta unica al rischio. La scelta richiede attività, via di esposizione, compatibilità, corretto uso, limiti, rimozione e smaltimento previsti. Indicare un DPI senza valutazione può essere tanto improprio quanto non indicarlo.

DECONTAMINAZIONE E RIFIUTI

La decontaminazione mira a rendere materiale, superficie o attrezzatura gestibili secondo lo scopo e il rischio. Metodo, agente, concentrazione, tempo di contatto, compatibilità e verifica non sono universali. Devono derivare dalla procedura validata e dalle istruzioni applicabili.

Anche i rifiuti seguono identificazione, separazione, contenimento, movimentazione e destino previsti dalla normativa e dall'organizzazione. «Rifiuto di laboratorio» non è una categoria sufficiente per decidere il trattamento.

INCIDENTI ED ESPOSIZIONI POTENZIALI

Un incidente richiede una risposta prevista, non improvvisata. In termini generali il professionista deve interrompere ciò che aumenta il rischio, mettere in sicurezza nei limiti della competenza, avvisare i soggetti previsti, attivare il percorso dell'istituzione, registrare i fatti e collaborare alla valutazione e al follow-up.

La risposta sanitaria alla persona, la bonifica e la ripresa dell'attività dipendono dal tipo di evento e dalle procedure competenti. Il candidato deve riconoscere questi limiti e non trasformare una domanda d'esame in consiglio sanitario personale.

Casi guidati

CASO 1 — CAMPIONE CON CONFORMITÀ NON DIMOSTRATA

Un campione arriva al laboratorio con contenitore integro e identificazione leggibile, ma la documentazione non permette di verificare una condizione di trasporto richiesta dal metodo. L'analisi è programmata come urgente.

Inquadramento. Il problema è preanalitico. L'urgenza non elimina il requisito di affidabilità e non autorizza a considerare conforme un dato mancante.

Risposta strutturata.

1. identificare il requisito non dimostrato e la fonte che lo stabilisce;
2. evitare la prosecuzione automatica;
3. preservare campione e informazioni secondo la procedura;
4. verificare se il dato può essere recuperato in modo attendibile;
5. coinvolgere il responsabile previsto per accettazione, rigetto o eventuale gestione condizionata;
6. registrare non conformità, decisione e comunicazione;
7. valutare se il caso segnala un problema ricorrente di trasporto o documentazione.

Non servono temperature, tempi o criteri di rigetto inventati: questi dati dipendono dal campione e dal metodo.

CASO 2 — SEGNALE DI CONTROLLO FUORI DAI CRITERI

Durante l'attività analitica, un controllo non soddisfa i criteri previsti. Alcuni campioni sono già stati processati, ma i risultati non sono ancora stati rilasciati.

Inquadramento. Il segnale riguarda il controllo del processo analitico. Prima di ripetere o rilasciare risultati bisogna valutarne significato ed estensione.

Risposta strutturata.

1. contenere i risultati potenzialmente interessati;
2. confermare e documentare il segnale secondo la procedura;
3. esaminare metodo, materiali, apparecchiatura, controlli, ambiente, passaggi e registrazioni pertinenti;
4. identificare l'intervallo di attività che può essere coinvolto;
5. applicare la correzione autorizzata e verificare il ripristino dei criteri;
6. decidere con i soggetti previsti quali campioni richiedono ripetizione o altra gestione;
7. se emerge una causa sistemica, aprire un'azione correttiva e verificarne l'efficacia.

La semplice ripetizione non è una soluzione se non chiarisce perché il controllo si è discostato e quali risultati possono esserne influenzati.

CASO 3 — EVENTO CON POTENZIALE ESPOSIZIONE

Durante un'attività, un contenitore si danneggia all'interno di un'apparecchiatura. Il tipo di materiale e l'operazione fanno ritenere plausibile un'esposizione o un rilascio. La procedura dell'istituzione è disponibile.

Inquadramento. Il candidato deve riconoscere un incidente di biosicurezza e attivare il sistema previsto, non improvvisare la bonifica.

Risposta strutturata.

1. interrompere i comportamenti che possono aumentare il rischio;
2. evitare l'apertura o la manipolazione non prevista;
3. delimitare e comunicare l'evento secondo il piano dell'istituzione;
4. attivare i soggetti competenti per valutazione, gestione dell'esposizione e decontaminazione;
5. registrare fatti, persone potenzialmente coinvolte e condizioni note;
6. riprendere l'attività solo dopo i controlli previsti e l'autorizzazione del soggetto competente individuato dalla procedura;
7. analizzare cause, barriere e necessità di azioni correttive.

La traccia non indica agente, apparecchiatura e procedura. Prescrivere un disinfettante, un tempo o un DPI specifico senza questi dati sarebbe arbitrario; occorre dichiarare il limite e attivare il percorso applicabile.

Biosicurezza: obblighi nazionali e scelta delle barriere

Il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi. Il gruppo non coincide automaticamente con la valutazione di ogni attività: quantità, procedure, aerosol e vie di esposizione incidono sul rischio. La valutazione, però, non può disapplicare le misure minime previste dalla legge.

Gruppo	Significato essenziale
1	Poco probabile che causi malattie nell'uomo.
2	Può causare malattie e rischio per i lavoratori; diffusione nella comunità poco probabile; normalmente disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci.
3	Può causare malattie gravi e serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità; normalmente disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci.
4	Può causare malattie gravi e serio rischio; può presentare elevato rischio di diffusione; di norma mancano misure profilattiche o terapeutiche efficaci.

L'art. 275 prevede, per l'uso deliberato in laboratorio, livelli di contenimento almeno 2, 3 e 4 per agenti dei rispettivi gruppi. Per materiali potenzialmente contaminati da patogeni per l'uomo, il minimo è il livello 2; per agenti non ancora classificati il cui uso può comportare grave rischio, almeno il livello 3. Classificazione e misure vanno lette con gli allegati XLVI e XLVII e con la valutazione specifica.

CAPPE: PROTEZIONI DIVERSE

Una cappa di sicurezza biologica di classe I protegge operatore e ambiente, ma non garantisce la protezione del prodotto dall'aria in ingresso. La classe II protegge anche il prodotto mediante flussi e filtrazione progettati a questo scopo. La classe III costituisce un sistema chiuso con manipolazione attraverso guanti integrati. Tipo, installazione, manutenzione e impiego devono essere appropriati all'attività: il numero della cappa non coincide con il gruppo biologico dell'agente.

Un banco a flusso laminare destinato alla protezione del prodotto può convogliare aria verso l'operatore e non sostituisce una cappa biologica. La cappa chimica è progettata per captare contaminanti chimici secondo le sue caratteristiche; non si presume idonea al contenimento biologico. Analogamente, un filtro HEPA per particelle non trattiene automaticamente gas e vapori chimici.

DETERSIONE, DISINFEZIONE, STERILIZZAZIONE E RIFIUTI

La deterzione rimuove sporco e materiale organico. La disinfezione inattiva microrganismi con efficacia dipendente da agente, prodotto, superficie e condizioni; non equivale necessariamente all'eliminazione delle spore. La sterilizzazione è un processo validato finalizzato a eliminare microrganismi vitali, comprese le spore. Per scegliere il processo occorrono compatibilità del materiale, efficacia attesa e verifica: non basta aumentare arbitrariamente concentrazione o tempo di contatto.

Il D.P.R. 254/2003 distingue rifiuti sanitari non pericolosi, pericolosi non a rischio infettivo, pericolosi a rischio infettivo e categorie con particolari sistemi di gestione. Un reagente chimico pericoloso non è automaticamente un rifiuto infettivo; un tagliente contaminato richiede attenzione sia al rischio biologico sia alla puntura; medicinali citotossici o citostatici seguono il proprio percorso. L'origine sanitaria, da sola, non assegna ogni rifiuto alla stessa categoria. Identificazione, separazione all'origine, contenitori idonei e tracciabilità precedono il conferimento al circuito previsto.

Caso. Un operatore propone di manipolare campioni potenzialmente infettivi su un banco che protegge soltanto il prodotto. La proposta è adeguata? No. Proteggere il campione dalla contaminazione non garantisce la protezione dell'operatore. Occorre verificare valutazione del rischio, contenimento minimo e idoneità della barriera prima di iniziare; non si corregge il problema aggiungendo soltanto guanti.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra sistema di gestione della qualità e controllo qualità in laboratorio?

Il sistema di gestione della qualità governa l'intero laboratorio: organizzazione, personale, apparecchiature, acquisti, processi, informazioni, documenti, non conformità, valutazione, miglioramento, attenzione all'utente, strutture e sicurezza. Il controllo qualità è uno degli strumenti del controllo dei processi e fornisce evidenze sulla prestazione analitica durante l'attività. Un QC accettabile non dimostra che identificazione, trasporto, refertazione o gestione delle informazioni siano corretti. Il candidato deve quindi collocare il controllo dentro il sistema, non usarlo come sinonimo di qualità.

Domanda-trappola

Se il laboratorio ottiene un buon risultato in una valutazione esterna, può ridurre il controllo qualità interno?

No. La valutazione esterna offre un confronto periodico secondo il programma applicabile; il controllo interno sorveglia il processo durante l'attività. Hanno finalità e tempi diversi. Nessuno dei due sostituisce il QMS, e un buon esito esterno non autorizza a ignorare segnali interni.

Errore tipico: scegliere la misura dal nome dell'agente

Il candidato riconosce un agente biologico e indica subito livello di contenimento, DPI e decontaminante. Salta attività, quantità, via di esposizione, probabilità, conseguenze e misure già presenti.

Per correggere l'errore, usa questa sequenza:

pericolo → attività → esposizione o rilascio → probabilità → conseguenze → controlli → rischio residuo.

Solo dopo si può motivare una categoria di misura. La scelta operativa resta subordinata alla valutazione e alla procedura del laboratorio.

Mini-esercizio: ricostruire flusso e barriere

Un risultato è stato rilasciato per un campione correttamente analizzato, ma associato a una richiesta duplicata nel sistema informativo. Ricostruisci il caso indicando:

1. fase nella quale nasce il problema;
2. fase nella quale viene rilevato;
3. risultati o comunicazioni da contenere;
4. registrazioni da consultare;
5. correzione immediata;
6. possibile azione correttiva;
7. indicatore per verificare l'efficacia.

SOLUZIONE RAGIONATA

L'origine è preanalitica o informativa, mentre la rilevazione può avvenire in postanalitica. Occorre delimitare richieste, campioni, risultati e destinatari interessati; consultare tracciati del sistema, registrazioni di accettazione, validazione e comunicazione; correggere l'associazione secondo autorizzazioni e procedura; valutare le comunicazioni necessarie. L'azione correttiva dipende dalla causa: regola di identificazione, configurazione del sistema, flusso, formazione o altro fattore dimostrato. Un indicatore utile deve misurare il ripetersi delle duplicazioni su una popolazione e un periodo definiti, non il solo numero assoluto.

Mini-esercizio: valutare il rischio

Una nuova attività manipola materiale potenzialmente infettivo con una fase che può generare aerosol. Non sono ancora definiti dispositivi, collocazione e addestramento.

Costruisci la valutazione senza scegliere una procedura:

Passaggio	Contenuto atteso
pericolo	caratteristiche del materiale e informazioni mancanti
attività	operazioni, quantità, frequenza e condizioni
esposizione/rilascio	vie plausibili e persone o ambienti coinvolti
stima	probabilità e conseguenze prima dei nuovi controlli
controlli	GMPP, organizzazione, contenimento, apparecchiature, DPI, formazione e risposta
residuo	rischio dopo i controlli e decisione motivata su avvio o modifica
riesame	eventi che impongono una nuova valutazione

La valutazione completa deve permettere al responsabile previsto di scegliere misure proporzionate e verificabili; il solo nome di un dispositivo non risolve il caso.

Checklist del capitolo

Prima della prova, controlla:

- ☐ so ricostruire preanalitica, analitica e postanalitica;
- ☐ distinguo origine, rilevazione ed effetto di un errore;
- ☐ collego ogni passaggio a tracciabilità e responsabilità;
- ☐ distinguo dato, controllo tecnico, validazione, interpretazione e refertazione;
- ☐ so classificare le principali discipline senza confonderle con una singola tecnica;
- ☐ uso la griglia quesito-campione-metodo-controlli-limiti;
- ☐ conosco i dodici elementi essenziali del QMS;
- ☐ distinguo QMS, QC ed EQA;

- ☐ distinguo documento e registrazione;
- ☐ distinguo correzione e azione correttiva;
- ☐ collego audit, indicatore e verifica di efficacia;
- ☐ distinguo pericolo e rischio;
- ☐ valuto attività, esposizione, probabilità, conseguenze e rischio residuo;
- ☐ non prescrivo DPI, contenimento o decontaminazione senza il contesto necessario;
- ☐ nei casi indico fatti, azioni, responsabili, documenti, limiti e verifica.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.M. 26 settembre 1994, n. 745, profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
- World Health Organization, Laboratory quality management system: handbook, 2011.
- World Health Organization, Laboratory Biosafety Manual, quarta edizione, 2020.
- World Health Organization, A guide for the practical implementation of the WHO Laboratory Biosafety Manual Fourth Edition, 2024.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo vigente.

Il quadro è verificato al 31 luglio 2026. Metodi, valori, criteri di accettazione, materiali, apparecchiature, livelli di validazione, DPI, decontaminazione e gestione degli incidenti devono essere verificati sulle fonti tecniche vigenti, sul sistema qualità e sulle procedure del laboratorio. Il capitolo prepara il ragionamento concorsuale e non sostituisce addestramento o istruzioni operative.

TSRM: imaging, dosimetria e radioprotezione

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Un'immagine tecnicamente riuscita non è necessariamente adeguata allo scopo. Può raffigurare bene una regione diversa da quella richiesta, contenere un artefatto che nasconde l'informazione utile oppure essere stata ottenuta con un'esposizione non giustificata. Allo stesso modo, una dose bassa non dimostra da sola che la prestazione sia stata ottimizzata: se l'informazione non è sufficiente e l'esame deve essere ripetuto, il risultato è contrario alla qualità e alla protezione del paziente.

Nei concorsi per tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), conoscere i nomi delle apparecchiature non basta. La commissione può chiedere di collegare una modalità al suo scopo, alla qualità richiesta, all'esposizione e alle responsabilità coinvolte. Serve anche riconoscere il limite della risposta: senza prescrizione, protocollo, apparecchiatura e dati del caso non si inventano parametri tecnici.

Obiettivo del capitolo

Al termine saprai:

- ricostruire il percorso dalla richiesta alla disponibilità dell'immagine o all'erogazione del trattamento;
- distinguere radiografia, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, medicina nucleare e radioterapia;
- spiegare che cosa rende un'immagine adeguata rispetto al quesito;
- classificare un artefatto e impostare una risposta che eviti ripetizioni automatiche;
- distinguere attività, dose assorbita, dose equivalente e dose efficace;
- applicare correttamente giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi;
- spiegare funzione e limiti dei livelli diagnostici di riferimento;
- distinguere esposizione medica, professionale e della popolazione;
- collocare TSRM, medico prescrivente, medico specialista, responsabile dell'impianto radiologico, specialista in fisica medica, esperto di radioprotezione ed esercente;
- affrontare un caso pratico descrivendo fatti, rischi, decisioni, comunicazioni e registrazioni senza sostituirti ai soggetti competenti.

Map pa BANDO

Passaggio	Domanda di studio	Output da allenare
Bando	quali modalit�, norme, rischi e prove sono nominati?	elenco circoscritto delle materie effettivamente richieste
Aree	il quesito riguarda tecnica, qualit�, dose, sicurezza o responsabilit�?	classificazione del problema prima della risposta
Nuclei	quali concetti spiegano la decisione?	definizione, distinzione, attore, conseguenza e limite
Diario	quale errore ho commesso nel ragionamento?	scheda errore con regola corretta e caso di richiamo
Output	che cosa chiede la prova?	risposta sintetica, esposizione orale o soluzione motivata di uno scenario

Nei bandi recenti per TSRM ricorrono prove scritte, pratiche e orali. Le materie tecniche possono comprendere diagnostica per immagini, radioterapia, medicina nucleare, radioprotezione, qualit , apparecchiature e sicurezza. La formulazione concreta varia: il programma va sempre ricavato dal bando scelto.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il TSRM opera sugli atti di propria competenza, su prescrizione e secondo protocolli definiti. Radiografia e TC usano raggi X; la RM usa campi magnetici e radiofrequenza; la medicina nucleare impiega radiofarmaci; la radioterapia ha finalit  terapeutica. Nelle esposizioni mediche il paziente non   sottoposto a un limite di dose: valgono giustificazione e ottimizzazione. I livelli diagnostici di riferimento sono strumenti di confronto e indagine, non soglie individuali. Qualit  significa informazione adeguata allo scopo, non immagine semplicemente gradevole.

Il TSRM nel percorso radiologico

Il D.M. 26 settembre 1994, n. 746 individua il profilo del tecnico sanitario di radiologia medica. Il TSRM svolge gli atti di competenza con autonomia professionale e responsabilit , su prescrizione medica e secondo protocolli definiti. Il profilo comprende l'impiego di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, energie termiche e ultrasoniche e attivit  collegate alla risonanza magnetica.

Questa definizione non trasforma il TSRM nell'unico responsabile del percorso. La prestazione radiologica è multiprofessionale e organizzata. Prescrizione, giustificazione clinica, esecuzione tecnica, valutazione dell'immagine, refertazione, dosimetria, controllo fisico e sorveglianza della radioprotezione appartengono a funzioni diverse. La risposta da concorso deve mostrare la collaborazione senza cancellare i confini.

DAL QUESITO ALLA PRESTAZIONE

Un percorso ordinato comprende, con adattamenti legati al setting:

1. richiesta e informazioni cliniche pertinenti;
2. identificazione della persona, della prestazione e della regione interessata;
3. verifica delle condizioni richieste dal percorso applicabile;
4. scelta e applicazione del protocollo autorizzato;
5. preparazione, posizionamento e acquisizione o erogazione;
6. controllo tecnico e verifica dell'adeguatezza secondo competenza;
7. gestione di anomalie, artefatti o scostamenti;
8. archiviazione, tracciabilità e disponibilità dei dati;
9. comunicazione e refertazione da parte dei soggetti competenti;
10. registrazione delle informazioni dosimetriche e di qualità previste.

L'ordine è utile per ricostruire i punti di controllo. Non è una procedura universale. In medicina nucleare, radioterapia, radiologia interventistica o RM cambiano materiali, tecnologie, rischi, attori e verifiche.

I CONTROLLI CHE PRECEDONO IL GESTO TECNICO

Prima dell'acquisizione non basta leggere il nome dell'esame. Bisogna verificare la coerenza tra persona, richiesta, distretto, lato quando pertinente, quesito, modalità e protocollo. Le informazioni mancanti o discordanti non vanno colmate per intuizione.

Il candidato può usare cinque domande:

- chi è la persona e qual è la prestazione richiesta?
- qual è il quesito o la finalità dichiarata?
- quale protocollo approvato è applicabile?
- quali condizioni richiedono una verifica o un coinvolgimento ulteriore?
- quali dati devono essere registrati per rendere la prestazione tracciabile?

Questa griglia protegge da due errori frequenti: eseguire correttamente la prestazione sbagliata e trasformare un dubbio in una decisione non attribuita al proprio ruolo.

Mappa delle modalità

Le modalità non si distinguono soltanto per il nome dell'apparecchiatura. Cambiano il fenomeno fisico, il tipo di informazione, il percorso e il rischio da governare.

Modalità	Principio essenziale	Informazione o finalità	Punto di attenzione
radiografia	attenuazione di raggi X lungo una proiezione	rappresentazione bidimensionale	posizionamento, copertura, sovrapposizione e relazione qualità-esposizione
TC	acquisizioni con raggi X e ricostruzione di sezioni o volumi	informazione anatomica stratificata	protocollo, estensione, movimento, ricostruzione e indicatori dosimetrici
RM	campo magnetico, gradienti e radiofrequenza	informazione anatomica o funzionale dipendente dalla sequenza	compatibilità, accessi, oggetti, movimento, radiofrequenza, rumore e criogeni
medicina nucleare	radiofarmaco e rilevazione della radiazione emessa	informazione funzionale, metabolica o terapia in specifiche applicazioni	attività, identificazione, tempo, contaminazione e protezione
radioterapia	radiazioni ionizzanti con finalità terapeutica	erogazione della dose prescritta al bersaglio	identificazione, piano, posizionamento, verifica ed esposizione diversa da quella prevista

RADIOGRAFIA

La radiografia produce un'immagine proiettiva. Strutture poste lungo il fascio si sovrappongono e vengono rappresentate in relazione alla loro attenuazione. Questa caratteristica spiega perché proiezione, centratura, collimazione, posizione e movimento influenzano ciò che l'immagine permette di vedere.

In una prova non serve elencare valori tecnici universali. È più utile spiegare la relazione: la geometria modifica rappresentazione e distorsione; il movimento può ridurre la nitidezza; una copertura incompleta può rendere l'esame inadeguato; un'esposizione non ottimizzata può compromettere informazione o protezione.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA

La tomografia computerizzata usa raggi X e ricostruisce sezioni e volumi a partire dai dati acquisiti. Rispetto alla radiografia riduce il problema della sovrapposizione, ma introduce una maggiore dipendenza da protocollo, estensione dell'acquisizione, movimento, ricostruzione e gestione di grandi quantità di dati.

In prova, la TC va collegata all'ottimizzazione. Nessun parametro isolato dimostra la qualità dell'intero esame. Occorre considerare compito clinico, caratteristiche della persona, regione, apparecchiatura, protocollo, indicatori disponibili e qualità ottenuta. Gli indicatori dosimetrici non sono tutti equivalenti e non vanno trasformati automaticamente nella dose individuale a un organo o nel rischio della singola persona.

RISONANZA MAGNETICA

La risonanza magnetica non impiega radiazioni ionizzanti. Usa un campo magnetico statico, gradienti e radiofrequenza per generare segnali dai quali si ricavano immagini. Questa distinzione è spesso oggetto di domanda-trappola: l'assenza di radiazioni ionizzanti non significa assenza di rischio.

La sicurezza RM richiede controllo degli accessi, valutazione della compatibilità di persone e oggetti, attenzione a dispositivi e materiali, gestione del rumore, della radiofrequenza e delle condizioni legate ai magneti e ai criogeni. I dettagli dipendono dal sito e dalla tecnologia. Un oggetto non deve essere dichiarato compatibile sulla base del solo materiale apparente o di un ricordo: servono identificazione certa e percorso previsto.

Anche la qualità è specifica. Movimento, scelta della sequenza, campo di vista, ricostruzione e presenza di materiali possono produrre artefatti. Senza il protocollo e il caso non si suggerisce una modifica tecnica; si descrive invece come riconoscere il problema, valutarne l'effetto e attivare il soggetto competente.

MEDICINA NUCLEARE

Nella medicina nucleare diagnostica viene somministrato un radiofarmaco e si rileva la radiazione emessa dal corpo per ottenere informazioni soprattutto funzionali o metaboliche. In alcune applicazioni i radionuclidi sono usati con finalità terapeutica.

La grandezza iniziale da distinguere è l'attività, espressa in becquerel. Attività e dose non sono sinonimi: dalla trasformazione nucleare all'energia assorbita intervengono caratteristiche del radionuclide, distribuzione, tempo e dati del caso. Per questo una risposta corretta non converte automaticamente un'attività in una dose.

Il percorso richiede identificazione, tracciabilità, corretto abbinamento tra persona, radiofarmaco e prestazione, gestione dei tempi e protezione da esposizione e contaminazione. Preparazione, somministrazione, acquisizione, dosimetria e gestione dei materiali seguono responsabilità e procedure definite.

RADIOTERAPIA

La radioterapia usa radiazioni ionizzanti con finalità terapeutica. L'obiettivo non è produrre soltanto un'immagine, ma erogare una distribuzione di dose prescritta al bersaglio limitando l'esposizione dei tessuti non bersaglio secondo il piano e le verifiche previste.

Il percorso comprende più fasi e più professionisti: identificazione, simulazione, pianificazione, controlli, posizionamento, verifica ed erogazione. Il TSRM svolge gli atti tecnici di competenza entro questo sistema. Non definisce autonomamente prescrizione, dose terapeutica o piano.

Una variazione apparentemente piccola può assumere significato perché il trattamento è frazionato o perché la riproducibilità è essenziale. In prova, la risposta deve quindi partire dall'identificazione dello scostamento, evitare l'erogazione automatica, coinvolgere i soggetti previsti e preservare dati e registrazioni.

Qualità dell'immagine

La qualità dell'immagine è l'adeguatezza dell'informazione rispetto allo scopo. Non coincide con la bellezza visiva, con la massima nitidezza possibile o con l'assenza assoluta di rumore. Dipende da ciò che l'immagine deve consentire di riconoscere, misurare, confrontare o guidare.

UNA GRIGLIA DI ADEGUATEZZA

Per analizzare un'immagine senza sostituirsi al giudizio diagnostico, il candidato può verificare:

1. identificazione e corrispondenza con richiesta, regione e lato;
2. completezza della copertura richiesta;
3. rappresentazione e posizionamento coerenti con il protocollo;
4. presenza di movimento, sovrapposizioni o altri artefatti;
5. contrasto, rumore, risoluzione e visualizzazione adeguati al compito;
6. integrità di dati, marcatori, serie e metadati;
7. disponibilità di informazioni dosimetriche quando previste;
8. necessità di confronto, escalation o decisione del soggetto competente.

Questi criteri non sono identici per ogni modalità. La loro funzione è ordinare il ragionamento e impedire che la decisione dipenda da un'impressione generica.

QUALITÀ E DOSE

Nelle modalità con radiazioni ionizzanti, qualità dell'immagine e dose sono collegate. Aumentare l'esposizione può ridurre alcuni tipi di rumore, ma non corregge ogni errore; può essere inutile se il problema è movimento, distretto sbagliato, ricostruzione o identificazione. Ridurre l'esposizione senza considerare lo scopo può produrre un'immagine insufficiente.

Ottimizzare significa cercare l'informazione necessaria con un'esposizione ragionevolmente ottenibile e compatibile con il fine medico. Non significa scegliere sempre la dose più bassa in assoluto né ottenere la qualità tecnica massima indipendentemente dalla dose.

ARTEFATTO, ANOMALIA E LIMITE

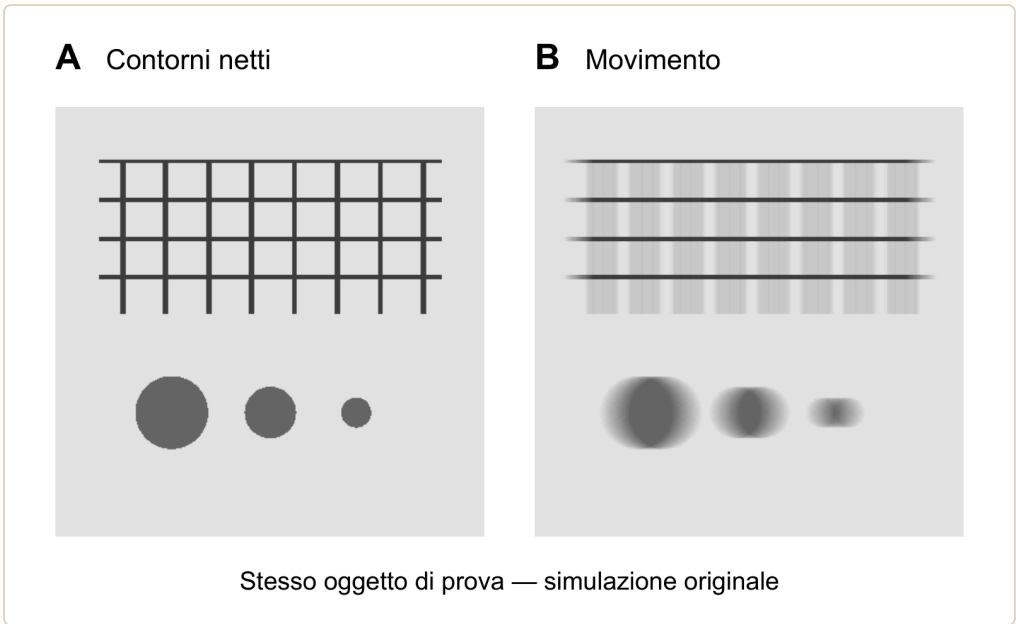
Un artefatto è un'informazione o un aspetto dell'immagine che non rappresenta fedelmente ciò che si intende osservare e che può derivare da persona, movimento, oggetto, geometria, acquisizione, ricostruzione, apparecchiatura o trattamento dei dati.

Una classificazione utile distingue:

- origine legata alla persona o al movimento;
- origine da oggetti, materiali o preparazione;
- origine geometrica o di posizionamento;
- origine da acquisizione o ricostruzione;
- origine da apparecchiatura o sistema;
- origine informatica, di trasferimento o visualizzazione.

La classificazione non attribuisce automaticamente la causa. Indica quali evidenze cercare.

DUE CONFRONTI VISIVI: MOVIMENTO E RUMORE

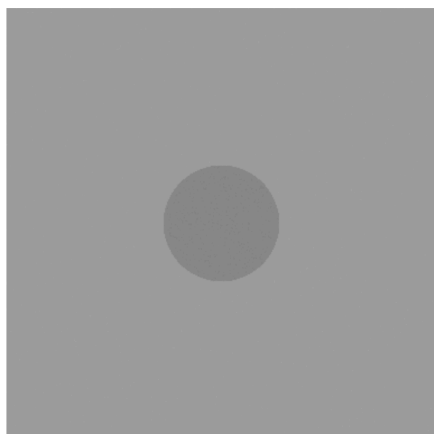
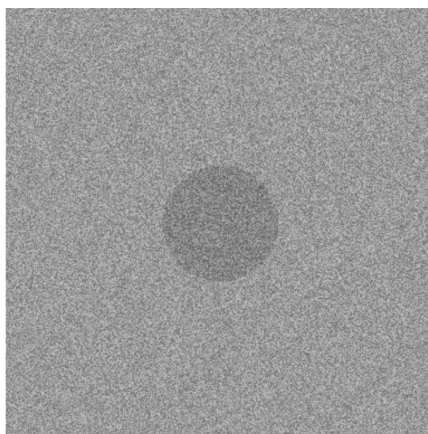


Oggetto di prova: pannello A con contorni netti, pannello B con sfocatura direzionale

Figura — Effetto schematico del movimento sul dettaglio. A: contorni netti; B: contorni allargati e sfocati. Oggetto di prova originale, senza valore diagnostico. Il confronto illustra una causa di perdita di qualità, non la diagnosi di un artefatto in un paziente.

Domanda. Nel pannello B il dettaglio è meno distinguibile. Questo basta a giustificare una nuova esposizione? Indica due verifiche preliminari.

Soluzione. No. Occorre valutare se l'immagine sia adeguata al quesito e identificare la causa del difetto. Si controllano dati della prestazione e condizioni di acquisizione, quindi si condivide la decisione secondo responsabilità e procedura. Una ripetizione non motivata aggiunge esposizione senza un beneficio dimostrato.

A Rumore basso**B** Rumore maggiore

Stesso contrasto medio — simulazione originale

Disco a basso contrasto: contrasto medio identico nei pannelli, rumore maggiore nel pannello B

Figura — Rumore e riconoscibilità di un dettaglio a basso contrasto. I due pannelli hanno lo stesso contrasto medio; nel pannello B il rumore rende il disco meno distinguibile. Simulazione originale per lo studio della qualità, non test diagnostico né calibrazione di un sistema.

Domanda. Perché aumentare indiscriminatamente l'esposizione non è la risposta generale al pannello B? Quale obiettivo guida l'ottimizzazione?

Soluzione. L'obiettivo è ottenere qualità sufficiente per il quesito con un'esposizione appropriata. Rumore e qualità dipendono anche da persona, tecnica, ricostruzione e apparecchiatura; il solo schema non consente di scegliere nuovi parametri. Il TSRM applica il protocollo appropriato e collabora alla verifica della qualità entro le proprie competenze.

LA RIPETIZIONE NON È AUTOMATICA

Davanti a un'immagine imperfetta, la prima domanda non è "come la ripeto?", ma "l'informazione è adeguata allo scopo e quale decisione è prevista?". Una ripetizione può aggiungere esposizione, tempo, rischio e disagio. Nelle modalità non ionizzanti può comunque comportare altri rischi o ritardi.

Prima di decidere se ripetere:

- 1. riconoscere e descrivere l'anomalia;
- 2. valutare l'impatto sull'adeguatezza entro la propria competenza;
- 3. controllare identità, richiesta, protocollo, dati e condizioni note;
- 4. evitare modifiche o ripetizioni non autorizzate;
- 5. coinvolgere il soggetto previsto quando la decisione supera il proprio ruolo;
- 6. documentare decisione, eventuale ripetizione e motivo;
- 7. segnalare ricorrenze che richiedono analisi di qualità.

Dose e grandezze: parole simili, funzioni diverse

Nel linguaggio comune "dose" viene spesso usato per qualunque numero associato alle radiazioni. Nel linguaggio tecnico le grandezze rispondono a domande differenti. Confonderle porta a confronti privi di significato.

Grandezza	Che cosa descrive	Unità	Limite interpretativo
attività	numero di trasformazioni nucleari nell'unità di tempo	becquerel (Bq)	non è la dose assorbita dalla persona
dose assorbita	energia impartita dalla radiazione per unità di massa	gray (Gy)	non incorpora da sola la diversa efficacia biologica e la sensibilità dei tessuti
dose equivalente	dose assorbita ponderata per il tipo di radiazione	sievert (Sv)	è una grandezza di radioprotezione, non un'immagine del danno individuale certo
dose efficace	somma ponderata delle dosi ai tessuti secondo la loro radiosensibilità	sievert (Sv)	è utile per la protezione e il confronto, ma non descrive in modo completo il rischio clinico del singolo

Le apparecchiature mostrano anche indicatori specifici della modalità. Un valore di TC, un prodotto dose-area, un'attività somministrata e una dose assorbita in radioterapia non sono numeri intercambiabili. Prima di interpretarli occorre dire quale grandezza è, a quale procedura si riferisce, come è stata ottenuta e quale decisione deve sostenere.

DOSE AL PAZIENTE E DOSE AL LAVORATORE

La dose al paziente deriva da un'esposizione medica con una finalità diagnostica o terapeutica. La dose al lavoratore appartiene all'esposizione professionale e serve a governare la protezione nello svolgimento dell'attività. Non si applicano le stesse regole.

Questo punto risolve una domanda tipica: il paziente non è un lavoratore esposto solo perché si trova nello stesso ambiente e il lavoratore non riceve un'esposizione medica solo perché opera vicino al paziente. Categoria, finalità, soggetto esposto e responsabilità devono essere identificati prima di citare un principio o un limite.

INDICATORI DOSIMETRICI E UNITÀ

Il CTDIvol, espresso in mGy, è un indice standardizzato della dose in TC basato su misure in fantocci. Descrive l'uscita dell'apparecchiatura nelle condizioni di riferimento; non è la dose assorbita da ogni organo della persona esaminata. Il DLP, in mGy·cm, tiene conto anche della lunghezza acquisita: per una serie si ricava dal prodotto CTDIvol × lunghezza. Nell'esame con più serie occorre considerare i contributi pertinenti, evitando di confrontare il valore di una sola serie con quello dell'intero esame.

Il prodotto kerma-area, spesso indicato come prodotto dose-area o DAP, combina il kerma in aria con l'area del fascio; l'unità comunemente usata è Gy·cm². È utile in radiografia e fluoroscopia, ma non coincide con la dose cutanea massima né con la dose efficace. Due esposizioni con uguale DAP possono distribuirsi diversamente sulla cute.

Esempio numerico. CTDIvol 8 mGy e lunghezza 30 cm producono DLP 240 mGy·cm. Se una seconda serie nelle stesse condizioni copre 10 cm, aggiunge 80 mGy·cm: totale 320. Questi dati, da soli, non permettono di assegnare un rischio individuale o di decidere una ripetizione. Dimensioni del paziente, distretto, geometria e protocollo incidono sulle valutazioni dosimetriche; la conversione in dose efficace non è un semplice cambio di unità.

EFFETTI E PROTEZIONE: COLLEGARE LA FISICA AL RISCHIO

Le reazioni tissutali possono comparire sopra una soglia, dipendente da tessuto e condizioni di esposizione; oltre la soglia la gravità tende a crescere con la dose. Gli effetti stocastici, come l'induzione di tumori, sono trattati in radioprotezione con un modello prudenziale in cui cresce la probabilità con la dose, senza assumere una soglia sicura; non si confonde probabilità con gravità del singolo effetto.

Ridurre il tempo di esposizione, aumentare la distanza e usare schermature appropriate sono principi di protezione per le persone esposte. Nel modello di una sorgente puntiforme, senza attenuazione o diffusione, raddoppiare la distanza riduce l'intensità a un quarto. Una sala reale, con paziente come sorgente di radiazione diffusa, geometrie e barriere, richiede la valutazione dell'esperto: non si trasferisce quel rapporto a ogni situazione. La schermatura va scelta per tipo ed energia della radiazione e percorso di esposizione.

LIMITI PER LAVORATORI E POPOLAZIONE

Il quadro dell'art. 146 del D.Lgs. 101/2020 distingue dose efficace e dose equivalente ai tessuti. La tabella riguarda lavoratori esposti e individui della popolazione nelle condizioni ordinarie previste dalla norma; apprendisti, studenti ed esposizioni particolari richiedono la disciplina specifica.

Grandezza, per anno solare	Lavoratori esposti	Popolazione
Dose efficace	20 mSv	1 mSv
Dose equivalente al cristallino	20 mSv	15 mSv
Dose equivalente alla pelle	500 mSv	50 mSv
Dose equivalente alle estremità	500 mSv	Non indicata qui come limite autonomo

Per la pelle il limite si riferisce alla media su qualsiasi superficie di 1 cm², indipendentemente dall'area complessivamente esposta. Questi limiti non sono obiettivi da raggiungere e non sostituiscono l'ottimizzazione. Non si applica il limite della popolazione di 1 mSv alla prestazione medica del paziente: quest'ultima si governa con giustificazione, ottimizzazione e strumenti pertinenti, inclusi i DRL.

Principi e quadro teorico della radioprotezione

Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 disciplina la protezione dai rischi connessi alle radiazioni ionizzanti e attua la Direttiva 2013/59/Euratom. Il sistema si basa su giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. I tre principi non si applicano in modo identico a ogni esposizione.

GIUSTIFICAZIONE

Una pratica o un'esposizione è giustificata quando il beneficio atteso prevale sul detrimento che può causare. Per l'esposizione medica si considerano la finalità diagnostica o terapeutica, le caratteristiche della persona, le informazioni già disponibili e le alternative che possono raggiungere lo stesso obiettivo senza radiazioni ionizzanti o con una minore esposizione.

Il TSRM non trasforma la giustificazione in una decisione tecnica autonoma. Contribuisce al percorso con le informazioni di competenza, rileva incoerenze o condizioni che richiedono verifica e coinvolge il medico specialista o il soggetto previsto. La prescrizione non elimina ogni controllo: identità, prestazione e coerenza devono comunque essere verificate.

OTTIMIZZAZIONE

L'ottimizzazione mantiene l'esposizione al livello ragionevolmente ottenibile compatibile con il fine medico. Nel caso del paziente non si persegue la dose minima astratta, ma l'equilibrio tra informazione o risultato terapeutico e protezione.

L'ottimizzazione coinvolge:

- appropriatezza e adeguatezza del protocollo;
- apparecchiatura e suo stato di controllo;
- competenza e formazione;
- identificazione, preparazione e posizionamento;
- parametri e modalità di acquisizione o erogazione;
- qualità ottenuta e necessità di ripetizione;
- indicatori dosimetrici, registrazioni e confronto nel tempo;
- analisi di eventi, scostamenti e opportunità di miglioramento.

Una parte di queste decisioni appartiene al TSRM, altre al medico specialista, allo specialista in fisica medica, al responsabile dell'impianto radiologico, all'esperto di radioprotezione, all'esercente o ad altri soggetti. L'organizzazione deve rendere chiari ruoli e interfacce.

LIMITAZIONE DELLE DOSI

La limitazione impedisce che, nelle esposizioni pianificate, siano superati i limiti fissati per le esposizioni professionali o della popolazione. Le esposizioni mediche del paziente non sono soggette a limiti di dose.

Per il paziente, la protezione non dipende da un limite rigido, che potrebbe impedire una procedura clinicamente necessaria o una terapia. Dipende da giustificazione, ottimizzazione, responsabilità, garanzia della qualità, livelli diagnostici di riferimento quando applicabili e gestione degli eventi.

LE TRE CATEGORIE DA DISTINGUERE

Categoria	Esempio	Principi centrali
esposizione medica	paziente sottoposto a esame o trattamento; altri soggetti previsti dalla definizione normativa	giustificazione e ottimizzazione; nessun limite di dose al paziente
esposizione professionale	lavoratore esposto nell'ambito dell'attività	giustificazione della pratica, ottimizzazione e limiti di dose
esposizione della popolazione	persona del pubblico esposta da una pratica o situazione pertinente	giustificazione, ottimizzazione e limiti o livelli previsti dal quadro applicabile

La classificazione viene prima del calcolo. Se la traccia non dice chi è esposto e perché, la risposta deve chiedere o dichiarare l'informazione mancante.

Livelli diagnostici di riferimento

I livelli diagnostici di riferimento, spesso indicati con la sigla DRL, sono livelli di dose o, per i radiofarmaci, di attività riferiti a esami tipici su gruppi di pazienti di dimensioni standard o su fantocci standard, per categorie ampie di apparecchiature e procedure. Aiutano a individuare pratiche che meritano un approfondimento.

CHE COSA FANNO

I DRL:

- permettono confronti coerenti su procedure definite;
- evidenziano valori tipici insolitamente alti;
- sostengono la revisione dei protocolli e l'ottimizzazione;
- devono essere riesaminati quando cambiano pratica, tecnologia o conoscenze;
- si usano insieme alla valutazione della qualità dell'immagine.

La Raccomandazione (Euratom) 2026/403 promuove un quadro di buona pratica per definizione, revisione e impiego dei DRL. Sottolinea governance, responsabilità, qualità dei dati, terminologia coerente e collegamento con il compito clinico. È una raccomandazione europea: non sostituisce la disciplina nazionale.

CHE COSA NON FANNO

Un DRL non è:

- un limite di dose per il singolo paziente;
- una soglia che rende automaticamente ingiustificato un esame;
- un valore obiettivo da raggiungere in ogni persona;
- una misura completa della qualità;
- una prova automatica di errore individuale o responsabilità.

Un valore sopra il DRL non dimostra da solo che la singola prestazione sia scorretta. Se l'andamento tipico di una procedura supera il riferimento, però, occorre analizzare popolazione, indicazione, protocollo, apparecchiatura, qualità e dati. Anche valori molto bassi meritano attenzione se le immagini non forniscono l'informazione necessaria.

COME RISPONDERE A UN SUPERAMENTO

La sequenza concorsuale è:

1. verificare che procedura, gruppo, grandezza e riferimento siano confrontabili;
2. controllare qualità e completezza dei dati;
3. distinguere il singolo caso dall'andamento tipico;
4. analizzare protocollo, apparecchiatura, popolazione, indicazione e qualità;
5. coinvolgere i soggetti competenti;
6. definire un intervento proporzionato se emerge uno scostamento;
7. verificare l'efficacia con dati successivi.

Abbassare un parametro senza analisi non è ottimizzazione. Può spostare il problema dalla dose alla qualità e produrre ripetizioni.

Attori e responsabilità

La radioprotezione funziona quando ogni decisione ha un titolare e ogni interfaccia è riconoscibile. Le denominazioni e le attribuzioni puntuali devono essere lette nel D.Lgs. 101/2020, nel profilo professionale e nell'organizzazione applicabile.

Attore	Funzione essenziale nel ragionamento	Errore da evitare
esercente	assicura organizzazione, risorse, adempimenti e condizioni per la pratica secondo il quadro applicabile	ridurlo al proprietario materiale dell'apparecchiatura
medico prescrivente	formula la richiesta e fornisce le informazioni cliniche pertinenti secondo competenza	considerare la richiesta sufficiente anche se identità o prestazione sono incoerenti

Attore	Funzione essenziale nel ragionamento	Errore da evitare
medico specialista	assume le decisioni cliniche e le responsabilità attribuitegli per l'esposizione medica	attribuire diagnosi o giustificazione clinica al TSRM
responsabile dell'impianto radiologico	svolge le funzioni di responsabilità previste per l'impianto e il programma di qualità	confonderlo automaticamente con il manutentore
specialista in fisica medica	contribuisce a dosimetria, ottimizzazione, qualità e valutazioni fisiche secondo il livello richiesto	sostituirne le valutazioni con la lettura di un solo indicatore
esperto di radioprotezione	cura le valutazioni e la sorveglianza fisica della protezione di lavoratori e popolazione secondo attribuzione normativa	attribuirgli in modo generico la giustificazione clinica del paziente
TSRM	esegue gli atti tecnici di competenza, applica protocolli, controlla il processo, documenta e collabora alla qualità	attribuirgli prescrizione, refertazione o manutenzione specialistica

La tabella non sostituisce le definizioni normative. Serve a evitare l'errore più comune: rispondere che "il responsabile" deve decidere senza specificare quale funzione è in gioco.

IL CONFINE DEL CONTROLLO SULLE APPARECCHIATURE

Il D.M. 746/1994 comprende il controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature e la manutenzione ordinaria nei limiti della competenza. Questo non coincide con collaudo, accettazione, manutenzione specialistica, riparazione, controllo fisico o valutazioni proprie di ingegneria clinica, fisica medica ed esperto di radioprotezione.

Se un'apparecchiatura mostra un'anomalia, il TSRM non deve improvvisare un intervento tecnico. Riconosce il segnale, protegge paziente e operatori, interrompe o non avvia l'uso quando richiesto dalla sicurezza e dalla procedura, identifica le prestazioni potenzialmente coinvolte, segnala, registra e collabora alla verifica.

Garanzia della qualità

La garanzia della qualità è un sistema organizzato di azioni che dà ragionevole fiducia che strutture, processi e risultati soddisfino requisiti definiti. In imaging non coincide con il controllo di una singola immagine o con una prova periodica dell'apparecchiatura.

Un programma comprende, secondo il contesto:

- responsabilità e linee di comunicazione;
- protocolli e documenti controllati;
- formazione, abilitazione e aggiornamento;
- verifiche e controlli sulle apparecchiature;
- criteri di qualità dell'immagine e valutazione degli scarti;
- registrazione e analisi degli indicatori dosimetrici;
- gestione di non conformità, incidenti ed esposizioni non intenzionali;
- audit, indicatori e verifica degli interventi;
- coordinamento con manutenzione, fisica medica, ingegneria clinica e radioprotezione.

DOCUMENTI, REGISTRAZIONI E TRACCIABILITÀ

Il protocollo o l'istruzione descrive come deve essere svolta un'attività autorizzata. La registrazione dimostra che un controllo, una prestazione, una decisione o una comunicazione sono avvenuti. Confondere i due piani indebolisce il sistema.

La tracciabilità permette di ricostruire:

- persona, richiesta e prestazione;
- operatori e tempi;
- apparecchiatura, protocollo e serie quando pertinenti;
- indicatori e controlli disponibili;
- anomalie, decisioni, comunicazioni e ripetizioni;
- archiviazione e accesso ai dati.

Una registrazione completa non rende corretta una decisione sbagliata, ma consente di valutarla. Una decisione corretta non registrata può risultare impossibile da dimostrare o riesaminare.

DALLO SCOSTAMENTO AL MIGLIORAMENTO

Uno scostamento isolato richiede contenimento e valutazione. Una ricorrenza può indicare un problema di protocollo, formazione, organizzazione, apparecchiatura, comunicazione o dati. L'analisi deve separare il fatto dalla causa presunta.

Il ciclo è:

evento o indicatore → delimitazione → analisi delle evidenze → causa o fattori contribuenti → azione → responsabile e scadenza → verifica di efficacia.

La finalità è ridurre la probabilità di ripetizione e migliorare qualità e sicurezza, non attribuire colpe prima dell'istruttoria.

Sicurezza RM e gravidanza

La risonanza magnetica non utilizza radiazioni ionizzanti. Il campo statico può però attrarre oggetti ferromagnetici, trasformandoli in proiettili; l'assenza di acquisizione non garantisce l'assenza del campo. Per accesso di persone, barelle, bombole, strumenti e dispositivi occorre il percorso di controllo del sito RM.

Per un impianto non basta chiedere se sia «metallico». Servono identificazione univoca e documentazione: MR Safe indica assenza di rischi noti negli ambienti RM previsti dalla classificazione; MR Conditional consente l'impiego soltanto nelle condizioni specificate; MR Unsafe indica rischio inaccettabile nell'ambiente RM. Un dispositivo conditional non è compatibile senza condizioni con ogni apparecchiatura o sequenza. La valutazione segue il modello organizzativo della struttura e coinvolge i responsabili previsti dal D.M. 14 gennaio 2021.

Le radiofrequenze possono produrre riscaldamento e ustioni, anche per configurazioni di contatto o circuiti conduttivi. I gradienti variabili producono rumore e possono indurre stimolazione periferica; la protezione uditiva segue il protocollo del sito. Nei sistemi con criogeni, il rilascio di gas può ridurre l'ossigeno disponibile e generare pressioni pericolose: ventilazione, evacuazione e risposta al quench appartengono al piano di sicurezza, senza manovre improvvisate. Campo statico, radiofrequenze, gradienti e criogeni richiedono controlli diversi.

Gravidanza. Prima di una prestazione con radiazioni ionizzanti occorre accertare la possibile gravidanza e informare i professionisti responsabili. Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 101/2020, giustificazione e ottimizzazione considerano donna e nascituro, urgenza, distretto, alternative e possibilità di rinvio. La gravidanza non determina da sola un divieto assoluto, ma nemmeno autorizza a procedere senza valutazione. In medicina nucleare anche l'allattamento richiede considerazione specifica del radiofarmaco. Per la RM, il D.M. 14 gennaio 2021 richiede particolare attenzione alla giustificazione e all'ottimizzazione e informazione della paziente. Le regole delle pazienti non vanno confuse con la tutela lavorativa delle operatrici gestanti.

Verifica. «Il paziente ha già effettuato una RM con quel dispositivo, quindi può entrare senza nuovi controlli»: affermazione errata. Vanno verificati dispositivo, condizioni e documentazione rispetto al sito e all'esame attuale; un precedente esame non dimostra che tutte le condizioni odierne coincidano.

Casi guidati

CASO 1 — IMMAGINE CON ARTEFATTO E RICHIESTA DI RIPETIZIONE

Al termine di un esame con radiazioni ionizzanti, il TSRM osserva un artefatto su una parte della serie. L'area richiesta è rappresentata, ma non è chiaro se l'artefatto comprometta l'informazione necessaria. La persona è ancora presente.

Inquadramento. Il problema riguarda l'adeguatezza dell'immagine e la possibile ripetizione. Ripetere senza valutazione aggiungerebbe un'esposizione; considerare automaticamente sufficiente la serie potrebbe lasciare incompleta la prestazione.

Risposta strutturata.

1. verificare identità, richiesta, regione, lato e protocollo applicato;
2. descrivere posizione ed estensione dell'artefatto senza anticiparne la causa;
3. controllare le condizioni note di acquisizione, movimento, oggetti, ricostruzione e sistema;
4. valutare l'adeguatezza tecnica entro la competenza del TSRM;
5. coinvolgere il medico specialista o il soggetto previsto per la decisione che eccede il controllo tecnico;
6. se la ripetizione è indicata e autorizzata, applicare il protocollo previsto evitando di riprodurre la causa riconosciuta;
7. registrare anomalia, decisione, motivo ed eventuale ripetizione;
8. segnalare l'evento al sistema qualità se l'artefatto è ricorrente o suggerisce un problema più ampio.

Qui non è possibile indicare un parametro da cambiare: la traccia non fornisce modalità, apparecchiatura, protocollo, quesito o causa dimostrata.

CASO 2 — VALORI TIPICI SOPRA IL DRL

Il monitoraggio periodico mostra che, per una procedura TC definita, il valore tipico dell'indicatore selezionato è superiore al livello diagnostico di riferimento pertinente. Le immagini sono considerate adeguate.

Inquadramento. Il DRL non è un limite per il singolo paziente. Il dato segnala però la necessità di verificare il processo di ottimizzazione.

Risposta strutturata.

1. verificare che procedura, indicazione o regione, gruppo di pazienti, grandezza, periodo e DRL siano confrontabili;
2. controllare completezza e qualità della raccolta dei dati;
3. distinguere casi eccezionali dall'andamento tipico;
4. esaminare protocolli, estensione, caratteristiche della popolazione, apparecchiatura, ricostruzione e qualità;

5. coinvolgere responsabile dell'impianto radiologico, specialista in fisica medica, TSRM e altri soggetti previsti;
6. definire interventi soltanto dopo aver individuato i fattori pertinenti;
7. verificare che l'intervento mantenga l'informazione richiesta;
8. ripetere la misura su un periodo e una popolazione adeguati per valutarne l'efficacia.

La conclusione corretta non è "la dose del paziente ha superato il limite". Il dato riguarda un livello di riferimento usato per l'ottimizzazione di una pratica tipica.

CASO 3 — ESPOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA

Durante una procedura con radiazioni ionizzanti emerge una discordanza tra la prestazione programmata e una parte dell'esposizione già eseguita. Non sono ancora noti estensione, conseguenze e causa.

Inquadramento. Si tratta di un possibile evento o di un'esposizione non intenzionale. La priorità è interrompere l'ulteriore scostamento, proteggere le persone e attivare il percorso previsto.

Risposta strutturata.

1. non proseguire automaticamente con la parte discordante;
2. mettere in sicurezza la situazione nei limiti della competenza e della procedura;
3. verificare identità, richiesta, protocollo, dati e fatti disponibili;
4. informare tempestivamente i soggetti competenti secondo il percorso dell'organizzazione;
5. preservare immagini, registrazioni, indicatori e configurazioni utili alla ricostruzione;
6. demandare valutazione clinica e dosimetrica ai professionisti competenti;
7. registrare evento, comunicazioni e decisioni senza formulare diagnosi o attribuire responsabilità;
8. collaborare all'analisi di cause, barriere e azioni correttive;
9. riprendere l'attività soltanto dopo le verifiche e l'autorizzazione previste.

La gestione reale dipende dal tipo di esposizione e dalle procedure. La prova valuta metodo, tempestività e rispetto dei ruoli.

Domanda da commissario

Perché i livelli diagnostici di riferimento non sono limiti di dose al paziente?

I DRL descrivono livelli di dose o attività per esami tipici su gruppi standardizzati e servono a individuare pratiche che richiedono analisi e ottimizzazione. Non stabiliscono la dose massima consentita al singolo paziente. Il caso clinico può richiedere una procedura più complessa o condizioni diverse da quelle del gruppo di riferimento. Per le esposizioni mediche la protezione si fonda su giustificazione e ottimizzazione, non su un limite individuale rigido. Un superamento ricorrente del DRL richiede revisione della pratica; non dimostra automaticamente un errore nella singola prestazione.

Domanda-trappola

Poiché la risonanza magnetica non usa radiazioni ionizzanti, è una procedura priva di rischi radiologici e tecnici?

No. La RM non comporta l'esposizione a radiazioni ionizzanti propria della radiografia o della TC, ma presenta rischi specifici legati a campo magnetico, oggetti e dispositivi, radiofrequenza, gradienti, rumore, criogeni e organizzazione del sito. Il percorso di sicurezza resta necessario. Non si applicano alla RM i concetti dosimetrici delle radiazioni ionizzanti come se fossero universali, ma non si può concludere che la modalità sia priva di rischio.

Errore tipico: usare un numero senza nominarne la grandezza

Il candidato legge un valore e parla genericamente di "dose alta". Non chiarisce se si tratta di attività, dose assorbita, dose efficace, indicatore dell'apparecchiatura o DRL. In questo modo non può stabilire che cosa sia confrontabile né quale decisione sia giustificata.

La correzione segue cinque passaggi:

grandezza → unità → soggetto o popolazione → procedura e contesto → decisione che il dato può sostenere.

Solo dopo questa classificazione si confrontano valori omogenei. Un numero isolato non prova l'esistenza di un rischio, di una non conformità o di una responsabilità.

Mini-esercizio: classificare modalità, informazione e rischio

Per ciascuna situazione indica modalità, tipo di informazione prevalente, presenza di radiazioni ionizzanti e primo rischio da governare.

1. immagine proiettiva ottenuta con raggi X;
2. studio che ricostruisce sezioni anatomiche da acquisizioni con raggi X;
3. esame basato su campo magnetico e radiofrequenza in persona con dispositivo impiantabile;
4. studio funzionale dopo somministrazione di radiofarmaco;
5. erogazione terapeutica secondo un piano prescritto.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Radiografia: informazione anatomica proiettiva, radiazioni ionizzanti; controllare identità, regione, geometria, qualità ed esposizione.
2. TC: informazione anatomica stratificata, radiazioni ionizzanti; collegare protocollo, estensione, qualità e indicatori dosimetrici.
3. RM: informazione dipendente dalla sequenza, senza radiazioni ionizzanti; verificare compatibilità e percorso di sicurezza del sito, senza dedurre l'esito dal solo nome del dispositivo.
4. Medicina nucleare: informazione funzionale o metabolica, radiazioni ionizzanti emesse dal radiofarmaco; governare identificazione, attività, tracciabilità, esposizione e contaminazione.
5. Radioterapia: finalità terapeutica con radiazioni ionizzanti; garantire corrispondenza tra persona, piano, posizionamento, verifica ed erogazione.

Mini-esercizio: costruire una risposta sui DRL

Una commissione chiede: "Il reparto supera il DRL in alcuni casi. Che cosa deve fare il TSRM?"

Costruisci una risposta in sette righe includendo:

- distinzione fra caso individuale e andamento tipico;
- verifica della confrontabilità;
- qualità dell'immagine;
- soggetti da coinvolgere;
- analisi del processo;
- intervento proporzionato;
- verifica di efficacia.

CRITERI DI CORREZIONE

La risposta è completa se non tratta il DRL come limite individuale e non attribuisce al TSRM una decisione isolata. Deve spiegare che il professionista contribuisce alla verifica di dati, protocollo, qualità e condizioni tecniche, segnala lo scostamento e collabora con responsabile dell'impianto radiologico, specialista in fisica medica e altri soggetti previsti. L'intervento va deciso dopo l'analisi e verificato con nuovi dati.

Checklist del capitolo

Prima della prova, controlla:

- ☐ so ricostruire il percorso dalla richiesta all'immagine o al trattamento;
- ☐ distinguo radiografia, TC, RM, medicina nucleare e radioterapia;
- ☐ non confondo modalità ionizzanti e non ionizzanti;
- ☐ definisco la qualità come adeguatezza al compito;

- ☐ classifico gli artefatti senza inventare subito una causa;
- ☐ evito la ripetizione automatica;
- ☐ distinguo attività, dose assorbita, equivalente ed efficace;
- ☐ associo becquerel, gray e sievert alle grandezze corrette;
- ☐ applico giustificazione e ottimizzazione alle esposizioni mediche;
- ☐ ricordo che il limite di dose non si applica al paziente;
- ☐ distinguo esposizione medica, professionale e della popolazione;
- ☐ spiego perché il DRL non è un limite individuale;
- ☐ collego DRL, qualità dell'immagine e miglioramento;
- ☐ distinguo TSRM, medico specialista, fisica medica ed esperto di radioprotezione;
- ☐ non attribuisco al TSRM refertazione o manutenzione specialistica;
- ☐ in un evento preservò sicurezza, dati, comunicazioni e tracciabilità;
- ☐ dichiaro i limiti quando mancano protocollo, apparecchiatura o informazioni del caso.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.M. 26 settembre 1994, n. 746, profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, protezione dai rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, nel testo vigente.
- Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, norme fondamentali di sicurezza contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
- Raccomandazione (Euratom) 2026/403 della Commissione, definizione, revisione e impiego dei livelli diagnostici di riferimento.
- WHO e IAEA, Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation, 2018.
- Ministero della Salute, indicazioni per la raccolta degli indicatori dosimetrici delle esposizioni mediche, 2024.
- INAIL, documentazione tecnica sulla sicurezza e qualità nei siti di risonanza magnetica.

Il quadro è verificato al 1° agosto 2026. Protocolli, parametri, indicatori, apparecchiature, sequenze RM, attività di radiofarmaco, piani terapeutici, valori dosimetrici e gestione degli eventi devono essere controllati sulle fonti vigenti, sui documenti della struttura e sulle responsabilità applicabili. Il capitolo prepara il ragionamento concorsuale e non sostituisce addestramento, prescrizione, giudizio clinico o valutazione specialistica.

Tecnologie, dispositivi, apparecchiature e rischio tecnologico

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Un'apparecchiatura può accendersi, superare un controllo iniziale e produrre comunque un risultato inattendibile. Un dispositivo conforme può essere inadatto al bisogno della struttura. Un allarme può dipendere dal prodotto, ma anche dal consumabile, dal software, dall'ambiente, dalla manutenzione o dal modo in cui il processo è organizzato. Per questo la sicurezza tecnologica non coincide con la riparazione del guasto.

Nei concorsi per TSLB e TSRM la commissione valuta soprattutto il metodo. Occorre riconoscere la tecnologia, ricostruirne il ciclo di vita e distinguere i controlli di propria competenza dagli interventi specialistici. Durante la gestione dell'anomalia bisogna conservare le evidenze e collegare vigilanza, HTA, analisi del rischio e miglioramento.

Obiettivo del capitolo

Al termine saprai:

- distinguere dispositivo medico, dispositivo medico-diagnostico in vitro, accessorio, apparecchiatura e software;
- spiegare perché la destinazione d'uso del fabbricante orienta classificazione e impiego;
- ricostruire il ciclo della tecnologia dal bisogno alla dismissione;
- separare accettazione, controlli dell'utilizzatore, controllo di qualità e manutenzione;
- attribuire correttamente le principali responsabilità fra professionista, servizio, ingegneria clinica, fabbricante e sistema di vigilanza;
- impostare una risposta sicura a guasto, allarme o prestazione anomala;
- distinguere incidente, incidente grave, reclamo, non conformità e near miss;
- spiegare scopo e limiti dell'HTA;
- analizzare il rischio tecnologico con fatti, fattori contribuenti, barriere e indicatori;
- applicare il metodo a casi TSLB e TSRM senza fondere i due profili.

Mappa BANDO delle tecnologie sanitarie

Passaggio	Domanda per il candidato	Prodotto di studio
B - Bando	quali dispositivi, apparecchiature, controlli, obblighi di vigilanza e prove pratiche sono richiesti?	scheda delle materie e delle forme di prova
A - Aree	il quesito riguarda ciclo di vita, funzionamento, manutenzione, vigilanza, HTA o rischio?	mappa delle aree
N - Nuclei	quale definizione, distinzione, attore o decisione devo dimostrare?	elenco dei nuclei prioritari
D - Diario	ho confuso uso e manutenzione, segnalazione interna ed esterna, guasto e incidente, conformità e appropriatezza?	diario degli errori
O - Output	devo spiegare un concetto, analizzare un'anomalia, proporre un mini-HTA o costruire un piano di miglioramento?	risposta allenabile

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La destinazione d'uso definisce ciò che il fabbricante prevede per il dispositivo. La marcatura CE non sostituisce valutazione del bisogno, accettazione, formazione, manutenzione e vigilanza. Il professionista controlla e usa la tecnologia entro competenza, istruzioni e procedure; non improvvisa riparazioni. Davanti a un'anomalia protegge persone e processo, conserva le evidenze, segnala e documenta. Il miglioramento si dimostra con una verifica di efficacia, non con la sola dichiarazione che il problema è stato risolto.

Quadro teorico: concetti e confini

DISPOSITIVO MEDICO E DESTINAZIONE D'USO

Il Regolamento (UE) 2017/745 definisce il dispositivo medico attraverso due elementi: che cosa è il prodotto e per quale finalità medica il fabbricante lo destina all'uso. La categoria può comprendere strumenti, apparecchiature, software, impianti, reagenti, materiali e altri articoli. L'azione principale prevista non deve essere ottenuta mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, anche se tali mezzi possono assistere la funzione.

La destinazione d'uso è l'impiego previsto dal fabbricante nelle informazioni che accompagnano il prodotto e nella relativa valutazione. Non è un dettaglio commerciale. Serve per comprendere:

- a quale scopo il prodotto può essere usato;
- quali persone, campioni o condizioni sono previste;
- quali prestazioni e limiti sono dichiarati;
- quali accessori, consumabili, software e ambienti sono compatibili;
- quali istruzioni, avvertenze e controlli devono essere rispettati.

Usare un prodotto fuori dalla destinazione prevista non diventa corretto perché l'operatore conosce bene la tecnologia. Un caso del genere richiede un inquadramento specifico, responsabilità definite e valutazioni che il candidato non può presumere.

DISPOSITIVO MEDICO-DIAGNOSTICO IN VITRO

Il Regolamento (UE) 2017/746 disciplina i dispositivi medico-diagnostici in vitro, indicati spesso con la sigla IVD. Sono prodotti destinati all'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano per fornire informazioni previste dal regolamento. Analizzatori, reagenti, calibratori, materiali di controllo, contenitori per campioni e software possono rientrare nel sistema IVD in relazione alla loro destinazione d'uso.

Per il TSLB la distinzione ha un effetto pratico: apparecchiatura, reagente, calibratore, controllo e software formano spesso un sistema. Un risultato anomalo non può essere attribuito subito all'analizzatore. La causa può trovarsi nel campione, nel lotto del reagente, nella calibrazione, nel controllo, nell'interfaccia informatica, nell'ambiente o nell'operazione eseguita.

ACCESSORIO, SOFTWARE E APPARECCHIATURA

Un accessorio è destinato dal fabbricante a permettere o assistere in modo specifico la funzionalità di uno o più dispositivi secondo la loro destinazione d'uso. Non è quindi un componente irrilevante: una incompatibilità può cambiare prestazione e rischio.

Il software può essere parte di una tecnologia o costituire esso stesso un dispositivo quando ricorrono i presupposti regolatori. Un aggiornamento può correggere un difetto, modificare un algoritmo, cambiare un'interfaccia o introdurre una nuova incompatibilità. Versione, configurazione e collegamenti devono essere tracciabili quanto l'apparecchiatura fisica.

Nel linguaggio organizzativo, apparecchiatura indica spesso un bene tecnologico utilizzato nel processo sanitario. Non ogni apparecchiatura è necessariamente un dispositivo medico e non ogni dispositivo è una grande apparecchiatura. In prova conviene partire dalla destinazione e dalla funzione, non dalla dimensione o dal costo.

QUATTRO DISTINZIONI DA RICORDARE

Concetto	Domanda corretta	Errore frequente
conformità regolatoria	il prodotto soddisfa i requisiti applicabili per essere immesso sul mercato o messo in servizio?	concludere che è automaticamente adatto a ogni struttura
appropriatezza	risponde al bisogno e produce un beneficio proporzionato nel contesto?	ridurla alla presenza della marcatura CE
prestazione tecnica	il sistema opera secondo i requisiti e i controlli pertinenti?	dedurla dal solo fatto che il dispositivo si accende
sicurezza d'uso	rischio residuo, competenze, ambiente e processo sono governati?	attribuirla soltanto al fabbricante o all'operatore

CLASSI DI RISCHIO E IDENTIFICAZIONE

Il MDR suddivide i dispositivi nelle classi I, IIa, IIb e III; l'IVDR usa A, B, C e D. La progressione esprime una diversa rilevanza regolatoria del rischio e incide sulla valutazione della conformità. Non è una graduatoria di prezzo o di utilità clinica: contano destinazione d'uso e regole dell'allegato VIII del rispettivo regolamento. Nel MDR assumono rilievo, fra gli altri aspetti, invasività, durata del contatto e funzioni del dispositivo; nell'IVDR conta anche l'impatto di un risultato errato sulla persona e sulla salute pubblica. Le due serie di classi non si scambiano e un analizzatore non riceve automaticamente la stessa classe di ogni test che vi si esegue.

L'UDI sostiene identificazione e tracciabilità. L'UDI-DI identifica il dispositivo in relazione a fabbricante e modello; l'UDI-PI ne identifica la produzione, per esempio mediante lotto o seriale secondo il prodotto. L'UDI-DI di base raggruppa dispositivi ai fini della documentazione e della banca dati ed è distinto dal codice del singolo lotto. UDI, numero d'inventario aziendale e marcatura CE hanno funzioni diverse: il primo non sostituisce l'etichetta, il secondo localizza il bene nell'organizzazione, la terza esprime conformità al quadro applicabile.

Esempio. Un avviso riguarda il modello X, lotti 12 e 13. Trovare in inventario «modello X» non basta per escludere o includere tutti gli esemplari: occorre risalire alla produzione interessata, alla collocazione e agli utilizzatori secondo i dati dell'avviso.

Il ciclo di vita della tecnologia

Il ciclo di vita collega decisioni che spesso appartengono a uffici e professionisti diversi. La sequenza seguente è una mappa concettuale: documenti, nomi degli atti e responsabili dipendono dal prodotto e dall'organizzazione.

Fase	Domanda di controllo	Evidenza attesa
bisogno	quale problema deve essere risolto e per chi?	fabbisogno motivato e risultati attesi
valutazione	quali alternative esistono e con quali effetti?	confronto clinico-tecnico, organizzativo ed economico
acquisizione	quali requisiti devono entrare nella specifica e nel contratto?	requisiti, responsabilità, servizi, formazione e manutenzione
consegna e installazione	quanto ricevuto corrisponde a quanto previsto ed è integrabile nel sito?	identificazione, documenti, installazione e verifiche previste
accettazione e messa in servizio	il sistema può essere impiegato nel processo autorizzato?	esito delle verifiche e autorizzazione secondo l'assetto locale
inventario e tracciabilità	come si ricostruiscono identità, configurazione e ubicazione?	inventario, identificativi, lotto o seriale, versione e sede
formazione e abilitazione	chi può usare il sistema e con quali competenze?	formazione documentata e condizioni di accesso
uso e controlli	la tecnologia continua a operare entro i requisiti?	controlli, registrazioni, indicatori e gestione degli scostamenti
manutenzione e aggiornamento	quali interventi sono previsti e chi li esegue?	piano, rapporti tecnici, modifiche e verifica successiva
sorveglianza e vigilanza	sono emersi incidenti, reclami, segnali o avvisi di sicurezza?	segnalazioni, avvisi, azioni e tracciabilità dei dispositivi coinvolti

Fase	Domanda di controllo	Evidenza attesa
ritiro o dismissione	perché e come termina l'uso?	decisione, messa fuori servizio, dati, materiali e smaltimento governati

DAL BISOGNO ALLA SCELTA

Descrivere il bisogno prima del prodotto evita di acquistare una soluzione tecnicamente interessante ma poco utile. Il fabbisogno comprende volume e tipo di attività, popolazione o campioni, risultati attesi, spazi, impianti, integrazioni informatiche, competenze, consumabili, manutenzione, continuità operativa e costi lungo il ciclo.

In una prova tecnico-sanitaria non serve ricostruire l'intera procedura di gara. Bisogna mostrare il contributo professionale: tradurre il processo in requisiti verificabili, riconoscere i rischi d'uso, valutare l'impatto sul lavoro e distinguere un requisito essenziale da una preferenza.

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ACCETTAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

La consegna materiale non autorizza automaticamente l'uso. Occorre verificare ciò che il sistema applicabile richiede: corrispondenza con l'ordine, integrità, documentazione, identificativi, accessori, collegamenti, condizioni ambientali, installazione, sicurezza, prestazioni iniziali, formazione e integrazione con il processo.

Termini come collaudo, accettazione e verifica iniziale possono avere significati contrattuali e tecnici precisi. Non vanno usati come sinonimi. Nella risposta concorsuale si può scrivere che la messa in servizio segue le verifiche previste e l'esito documentato dei soggetti competenti, senza attribuire tutto al TSLB o al TSRM.

INVENTARIO, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE

La tracciabilità deve permettere di rispondere ad alcune domande: quale dispositivo? quale modello, seriale o lotto? dove era collocato? con quale software e quali accessori? quale intervento aveva ricevuto? chi lo ha usato? quali attività possono essere coinvolte?

La formazione non è una firma raccolta una sola volta. Deve essere coerente con ruolo, complessità, rischio, aggiornamenti e cambiamenti del processo. Un aggiornamento rilevante, un nuovo accessorio o una nuova destinazione organizzativa possono richiedere una nuova valutazione della competenza.

Controlli e manutenzione

CONTROLLO DELL'UTILIZZATORE

Prima o durante l'uso, il professionista esegue i controlli previsti da profilo, istruzioni, programma di qualità e procedura. Può verificare integrità visibile, identificazione, stato del sistema, scadenze o lotti pertinenti, messaggi, controlli di qualità e condizioni dell'ambiente. L'elenco concreto cambia con la tecnologia.

Un controllo dell'utilizzatore non è una riparazione. Se emerge uno scostamento, il professionista applica il percorso autorizzato: non apre parti protette, non modifica configurazioni e non azzerà allarmi per tentativi se queste azioni non rientrano nelle istruzioni e nella competenza.

CONTROLLO DI QUALITÀ E MANUTENZIONE

Il controllo di qualità verifica, con metodi e responsabilità definiti, se una prestazione soddisfa criteri stabiliti. La manutenzione conserva o ripristina le condizioni operative. I due processi comunicano, ma non coincidono. Un controllo fuori criterio può richiedere manutenzione; un intervento di manutenzione può richiedere una verifica prima della ripresa.

Attività	Finalità	Confine da esplicitare
controllo prima dell'uso	riconoscere condizioni incompatibili con l'impiego sicuro	dipende da istruzioni, procedura e profilo
controllo di qualità	verificare prestazioni rispetto a criteri definiti	metodo, frequenza e responsabile non sono universali
manutenzione ordinaria	svolgere attività previste entro competenza	non equivale a qualunque intervento semplice
manutenzione programmata	prevenire degrado e verificare componenti secondo piano	può richiedere personale tecnico autorizzato
manutenzione correttiva	diagnosticare e correggere un guasto	non autorizza l'utilizzatore alla riparazione
verifica dopo intervento	dimostrare che il sistema può rientrare nel processo	rimessa in servizio decisa dai soggetti previsti

Il D.M. 745/1994 collega il TSLB al controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature e alla manutenzione ordinaria nei limiti della competenza. Il D.M. 746/1994 collega il TSRM al controllo delle apparecchiature affidate, agli interventi per eliminare inconvenienti di modesta entità e ai programmi di verifica e garanzia della qualità. In entrambi i casi il profilo va letto insieme a evoluzione professionale, istruzioni, formazione, organizzazione e normativa tecnica. Nessuna delle due formulazioni rende il professionista un manutentore universale.

ATTORI E INTERFACCE

Attore	Contributo tipico	Limite da non superare
TSLB	controlla processo analitico, sistema IVD e prestazione nei limiti di competenza; riconosce e documenta scostamenti	non assume automaticamente validazione clinica, riparazione o rimessa in servizio specialistica
TSRM	controlla il processo tecnico, l'apparecchiatura e la qualità nei limiti di competenza; riconosce e segnala anomalie	non assume refertazione, prescrizione, manutenzione specialistica o valutazioni fisiche riservate
responsabile o coordinamento del servizio	organizza risorse, turni, procedure, comunicazioni e continuità	non sostituisce competenze tecniche o cliniche attribuite ad altri
ingegneria clinica o funzione tecnica	governa il patrimonio tecnologico e le attività tecniche secondo assetto aziendale	non decide da sola l'appropriatezza clinica o analitica
fabbricante, mandatario e assistenza autorizzata	forniscono informazioni, indagano eventi e svolgono attività previste dal proprio ruolo	non sostituiscono gli obblighi della struttura e degli operatori
responsabile locale della vigilanza	raccorda la segnalazione nel sistema nazionale secondo organizzazione regionale	non coincide necessariamente con chi ha rilevato l'evento

Attore	Contributo tipico	Limite da non superare
qualità e risk management	analizzano processi, eventi, barriere e azioni di miglioramento	non stabiliscono da soli cause tecniche o responsabilità giuridiche

Guasto, allarme e prestazione anomala

Il guasto è una perdita della capacità di svolgere una funzione richiesta. L'allarme è un segnale del sistema e deve essere interpretato nel contesto. La prestazione anomala può manifestarsi anche senza guasto evidente: risultati incoerenti, immagini degradate, errori intermittenti, ritardi, dati mancanti o comportamenti inattesi dopo un aggiornamento.

LA SEQUENZA DI RISPOSTA

In prova conviene ordinare la risposta in dieci passaggi:

1. proteggere persona, operatore, campione, dati e ambiente;
2. interrompere o non avviare l'uso quando la sicurezza o la procedura lo richiedono;
3. impedire un riutilizzo non autorizzato, identificando lo stato del sistema;
4. descrivere i fatti senza anticipare la causa;
5. conservare messaggi, orari, identificativi, lotti, versioni e altre evidenze utili;
6. delimitare attività, risultati, immagini o persone potenzialmente coinvolti;
7. informare i soggetti competenti e attivare assistenza, qualità, vigilanza o valutazione clinica quando pertinenti;
8. registrare evento, comunicazioni e decisioni;
9. collaborare all'analisi e alle eventuali segnalazioni esterne;
10. riprendere l'uso soltanto dopo le verifiche e l'autorizzazione previste.

La sequenza non ordina di spegnere sempre l'apparecchiatura o di conservarla sempre nello stesso modo. Alcune tecnologie sostengono funzioni essenziali, alcuni campioni richiedono contenimento biologico e alcune evidenze possono essere perse con un riavvio. La decisione dipende dal rischio e dalle istruzioni applicabili.

PRESERVARE LE EVIDENZE

Riavviare più volte, eliminare un messaggio, smaltire subito il consumabile o pulire il dispositivo può cancellare informazioni utili. Anche lasciare tutto invariato può essere pericoloso. La priorità resta la sicurezza; le evidenze vanno conservate per quanto compatibile con protezione, biosicurezza, riservatezza e procedura.

La tracciabilità dell'evento può comprendere:

- identificativo del dispositivo, lotto o seriale;
- versione software e configurazione pertinente;
- accessori, reagenti o consumabili coinvolti;
- data, ora, fase del processo e operatore;
- messaggio, manifestazione e conseguenze osservate;
- risultati, immagini o attività da sottoporre a verifica;
- interventi precedenti, comunicazioni e decisioni;
- esito dei controlli prima della ripresa.

Dispositivo-vigilanza

INCIDENTE E INCIDENTE GRAVE

Nel quadro MDR e IVDR, un incidente riguarda un malfunzionamento o deterioramento delle caratteristiche o prestazioni, un errore d'uso dovuto a caratteristiche ergonomiche, un'inadeguatezza delle informazioni del fabbricante o altri eventi previsti dalle definizioni applicabili. L'incidente grave è un evento che ha causato, può avere causato o può causare, direttamente o indirettamente, morte, grave deterioramento temporaneo o permanente della salute oppure una grave minaccia per la salute pubblica. Non occorre quindi attendere che il danno si sia effettivamente prodotto.

Se mancano informazioni su conseguenze, rischio, dispositivo e nesso plausibile, non è possibile classificare l'evento con sicurezza. Va trattato come possibile incidente, attivando il percorso e fornendo gli elementi necessari alla valutazione.

I decreti del Ministro della salute del 1° luglio 2025, in vigore nel 2026, stabiliscono per dispositivi medici e IVD che l'operatore sanitario segnali al Ministero un incidente grave, anche solo sospetto, tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni da quando ne viene a conoscenza. Un incidente diverso da quello grave può essere segnalato al Ministero entro trenta giorni. Le comunicazioni al fabbricante o mandatario e il passaggio attraverso i referenti seguono il quadro e l'organizzazione applicabili.

Il termine massimo non è un tempo di attesa. La sicurezza immediata, la comunicazione interna e la preservazione delle evidenze iniziano in rapporto al rischio.

RECLAMO, NON CONFORMITÀ E NEAR MISS

Un reclamo segnala una carenza riferita a identità, qualità, durabilità, affidabilità, usabilità, sicurezza o prestazioni del dispositivo o di un servizio che ne influenza le prestazioni. Può accompagnare un incidente, ma non coincide sempre con esso.

La non conformità è il mancato soddisfacimento di un requisito del sistema qualità. Il near miss è un evento che avrebbe potuto produrre danno ma non lo ha prodotto, per caso o per l'intervento di una barriera. L'incident reporting interno raccoglie eventi per apprendere e migliorare. Queste categorie rispondono a domande diverse:

Categoria	Domanda	Sistema principale
possibile incidente di dispositivo	il dispositivo può essere collegato a un evento previsto dalla vigilanza?	dispositivo-vigilanza
reclamo	è stata segnalata una carenza di prodotto o servizio?	fabbricante e percorso ministeriale applicabile
non conformità	quale requisito non è stato soddisfatto?	sistema qualità
near miss	quale barriera ha evitato il danno e che cosa si può imparare?	sicurezza e gestione del rischio

Uno stesso fatto può attivare più percorsi. La segnalazione interna non sostituisce quella di vigilanza, e la segnalazione al fabbricante non chiude automaticamente l'analisi organizzativa.

AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA E AVVISO

La FSCA è l'azione correttiva di sicurezza intrapresa dal fabbricante per motivi tecnici o medici per prevenire o ridurre il rischio di un incidente grave relativo a un dispositivo disponibile sul mercato. Può comportare interventi sul prodotto, aggiornamenti, richiamo o altre misure appropriate: non è sempre un ritiro fisico.

La FSN è l'avviso di sicurezza con cui il fabbricante comunica agli utilizzatori o clienti l'azione e le indicazioni pertinenti. Ricevere l'avviso non equivale ad aver completato l'azione: la struttura identifica prodotti e lotti coinvolti, informa i destinatari, esegue le attività richieste nel proprio ruolo e ne conserva evidenza. Non si estendono le istruzioni a modelli diversi né si sostituisce la FSCA con una riparazione non autorizzata.

Verifica. Un avviso richiede di identificare un lotto e sospenderne l'uso fino a una verifica autorizzata. La FSN è il documento ricevuto; la FSCA comprende le misure attuate sul campo. Archiviare il messaggio senza controllare la presenza del lotto lascia incompleta la gestione.

HTA: valutare prima di adottare

L'Health Technology Assessment valuta una tecnologia sanitaria nel processo in cui sarà usata. Supporta decisioni nazionali, regionali e aziendali. Il PNHTA-DM 2026-2028, entrato nella fase operativa nel 2026, riguarda il sistema nazionale di HTA dei dispositivi medici.

Un mini-HTA concorsuale può seguire questa griglia:

1. bisogno e popolazione o attività interessata;
2. tecnologia e destinazione d'uso;
3. comparatore reale, compresa l'opzione di non cambiare;
4. benefici, prestazioni ed esiti rilevanti;
5. rischi e sicurezza;
6. qualità e trasferibilità delle evidenze;
7. costi lungo il ciclo, non soltanto prezzo d'acquisto;
8. impatti su organizzazione, competenze, spazi, dati e continuità;
9. aspetti etici, sociali, equità e accettabilità quando pertinenti;
10. incertezza, condizioni di adozione e piano di monitoraggio.

La marcatura CE risponde al quadro regolatorio del prodotto. L'HTA pone una domanda diversa: conviene adottare questa tecnologia, per questo bisogno, rispetto alle alternative, a quali condizioni e con quale monitoraggio? La valutazione informa la decisione, ma non la sostituisce.

Rischio tecnologico e miglioramento

PERICOLO, SITUAZIONE PERICOLOSA, DANNO E RISCHIO

Il pericolo è una potenziale fonte di danno. La situazione pericolosa espone persone, processo, campione, dati o ambiente al pericolo. Il danno è la conseguenza negativa. Il rischio combina probabilità e gravità secondo il metodo adottato.

La tecnologia non agisce isolatamente. Il rischio può nascere dall'interazione fra:

- caratteristiche del dispositivo e destinazione d'uso;
- operatore, competenza, carico di lavoro e comunicazione;
- persona assistita o campione;
- ambiente, impianti e condizioni di funzionamento;
- accessori, consumabili, reagenti e materiali;
- software, rete, interfacce e dati;
- manutenzione, aggiornamenti e modifiche;
- procedure, responsabilità e continuità operativa.

Attribuire l'evento a un generico "errore umano" chiude l'analisi troppo presto. Occorre cercare le condizioni che hanno reso l'errore possibile, probabile o non intercettato.

DALL'EVENTO ALL'AZIONE

L'analisi delle cause profonde, spesso indicata come RCA, ricostruisce fatti e fattori contribuenti per individuare interventi di sistema. Non è un processo sommario per attribuire colpa. Una traccia completa contiene:

evento e conseguenze -> delimitazione -> evidenze -> fattori contribuenti -> barriere presenti o mancanti -> azioni -> responsabili e scadenze -> indicatori -> verifica di efficacia.

Le barriere possono prevenire l'evento, intercettarlo o ridurne le conseguenze. Un controllo automatico, una doppia verifica, un blocco software, la separazione fisica, una formazione mirata o una procedura possono essere barriere. La loro efficacia va dimostrata nel contesto.

Un'azione debole ricorda agli operatori di prestare attenzione. Un'azione più robusta modifica il sistema: elimina una scelta ambigua, impedisce una combinazione incompatibile, migliora la tracciabilità, cambia un'interfaccia o ridefinisce responsabilità e controlli. Anche l'azione robusta deve avere un responsabile, una scadenza e una misura.

INDICATORI, AUDIT E RE-AUDIT

Un indicatore rende osservabile un fenomeno. Può misurare disponibilità, guasti, tempi di ripristino, controlli fuori criterio, ripetizioni, campioni o immagini coinvolti, segnalazioni, completamento della formazione o ricorrenza di uno specifico evento. Deve specificare numeratore, denominatore quando utile, fonte, periodo, responsabile e soglia decisionale.

L'audit confronta la pratica con criteri espliciti. Il re-audit verifica se l'intervento ha prodotto il cambiamento atteso. Chiudere un'azione perché è stata emanata una procedura non dimostra che il rischio sia diminuito.

Applicazioni distinte per TSLB e TSRM

CASO TSLB: RISULTATI INCOERENTI DOPO UN AGGIORNAMENTO

Dopo un aggiornamento software di un sistema IVD, alcuni risultati mostrano una distribuzione inattesa. I controlli disponibili non permettono ancora di stabilire se il problema riguarda campioni, reagenti, calibrazione, algoritmo, interfaccia o trasmissione dei dati.

Inquadramento. È una prestazione anomala potenzialmente collegata alla tecnologia. Non basta ripetere un campione e non è corretto dichiarare subito un guasto software.

Risposta strutturata.

1. sospendere la prosecuzione automatica delle attività potenzialmente interessate secondo procedura;
2. proteggere campioni, dati e continuità del servizio;
3. delimitare periodo, analiti o esami, lotti, versioni e sistemi coinvolti;
4. conservare controlli, calibrazioni, messaggi, registri, interfacce e risultati pertinenti;
5. informare responsabili del laboratorio, qualità, assistenza autorizzata e altri soggetti previsti;
6. verificare se risultati già prodotti richiedano valutazione, blocco o comunicazione da parte dei responsabili competenti;
7. non modificare configurazioni o applicare correzioni non autorizzate;
8. valutare non conformità, possibile incidente o reclamo e attivare i percorsi applicabili;
9. riprendere soltanto dopo verifica documentata delle prestazioni e autorizzazione prevista;
10. controllare l'efficacia su dati successivi.

Il TSLB contribuisce con la conoscenza del processo analitico. L'indagine tecnica, la validazione clinica, la gestione informatica e la vigilanza coinvolgono ruoli distinti.

CASO TSRM: ALLARME INTERMITTENTE E QUALITÀ VARIABILE

Un'apparecchiatura radiologica presenta un allarme intermittente. In alcuni esami la qualità tecnica appare variabile. Non sono ancora note causa, estensione e conseguenze.

Inquadramento. L'evento riguarda funzionamento, qualità e possibile impatto sulle prestazioni. Dose, adeguatezza clinica e rischio non possono essere dedotti dal solo allarme.

Risposta strutturata.

1. non proseguire automaticamente con l'uso nelle condizioni dubbie;
2. mettere in sicurezza persona e area secondo procedura;
3. descrivere allarme, tempi, modalità, protocollo, accessori e circostanze note;
4. identificare esami o immagini potenzialmente coinvolti senza dichiararli inadeguati prima della valutazione competente;
5. preservare log, immagini, indicatori e configurazioni utili;
6. informare responsabili del servizio, ingegneria clinica, assistenza, medico specialista, fisica medica o altri soggetti secondo il problema;
7. impedire una rimessa in uso non autorizzata;
8. valutare i percorsi di qualità, rischio e dispositivo-vigilanza;
9. documentare intervento tecnico e verifiche successive;
10. riprendere l'uso soltanto dopo l'esito previsto e monitorare la ricorrenza.

Il TSRM riconosce e governa la parte tecnica di competenza. Non ripara l'apparecchiatura, non sostituisce la valutazione diagnostica e non attribuisce da solo la causa.

CASO DI MIGLIORAMENTO: ANOMALIA RICORRENTE DOPO MANUTENZIONE

Tre eventi simili compaiono nelle settimane successive a interventi di manutenzione su dispositivi dello stesso tipo. Ogni singolo evento è stato chiuso dopo il ripristino.

La ricorrenza mostra che il ripristino non basta. Occorre confrontare dispositivi, tecnici, componenti, versioni, verifiche di rientro, condizioni ambientali e modalità di comunicazione. Le azioni potrebbero riguardare il contratto, la checklist di rimessa in servizio, la prova funzionale, la formazione o la tracciabilità. La scelta dipende dalle evidenze.

Un indicatore utile può essere il numero di anomalie dello stesso tipo entro un periodo definito dopo manutenzione, riportato agli interventi eseguiti. Il re-audit verifica se la frequenza diminuisce senza introdurre nuovi problemi.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra marcatura CE, accettazione della tecnologia e HTA?

La marcatura CE riguarda la conformità del prodotto al quadro regolatorio applicabile. L'accettazione comprende le verifiche previste prima dell'impiego nella specifica organizzazione e deve essere documentata dai soggetti competenti. L'HTA valuta se la tecnologia risponde a un bisogno rispetto alle alternative, considerando evidenze, sicurezza, prestazioni, costi e impatti organizzativi, etici e sociali. Sono tre piani collegati ma diversi: la marcatura non garantisce appropriatezza locale, l'accettazione non sostituisce la valutazione del valore e l'HTA non autorizza da solo l'uso.

Domanda-trappola

Se il dispositivo ha la marcatura CE e il controllo iniziale è regolare, l'operatore può continuare a usarlo nonostante un allarme intermittente?

No. Marcatura e controllo precedente non neutralizzano un segnale nuovo. L'operatore valuta il rischio immediato, applica la procedura, interrompe o non avvia l'uso quando necessario, conserva le evidenze, segnala e documenta. La ripresa richiede le verifiche e l'autorizzazione previste. Non si deve però concludere automaticamente che l'allarme dimostri un guasto grave: servono analisi e soggetti competenti.

Errore tipico: chiamare manutenzione e fermarsi lì

La risposta "metto fuori uso e chiamo la manutenzione" è incompleta. Non dice che cosa accade a persone, campioni, immagini o risultati già coinvolti; non conserva le evidenze; non distingue assistenza tecnica, qualità e vigilanza; non prevede verifica dopo l'intervento.

La correzione usa sei domande:

chi o che cosa devo proteggere -> quale uso devo sospendere -> quali evidenze devo conservare -> quali attività devo delimitare -> chi devo informare -> che cosa dimostra la possibilità di riprendere.

Mini-esercizio: classificare l'evento

Associa ogni situazione al primo percorso da considerare, ricordando che più percorsi possono coesistere.

1. Un controllo di qualità non rientra nei criteri, senza conseguenze note e senza evidenza di malfunzionamento.
2. Un connettore si rompe durante l'uso e l'evento avrebbe potuto causare un grave deterioramento della salute.
3. Un utente segnala che l'interfaccia è poco leggibile, senza evento o conseguenze.
4. Un operatore intercetta prima dell'uso un accessorio incompatibile preparato per errore.
5. Dopo un aggiornamento, più sistemi trasmettono dati incompleti.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Non conformità del sistema qualità da analizzare; se emergono elementi riferibili al dispositivo, si valuta anche vigilanza o reclamo.
2. Possibile incidente grave, anche solo sospetto: sicurezza immediata, conservazione delle evidenze e attivazione tempestiva della dispositivo-vigilanza.
3. Possibile reclamo relativo all'usabilità; va verificato se la carenza abbia prodotto o possa produrre un incidente.
4. Near miss e non conformità organizzativa; occorre capire quale barriera ha intercettato l'errore e perché l'incompatibilità era possibile.
5. Prestazione anomala potenzialmente sistemica: contenimento, delimitazione dei dati, verifica tecnica e valutazione di non conformità, reclamo e possibile incidente.

Mini-esercizio: costruire un mini-HTA

Una struttura valuta l'acquisto di una nuova piattaforma automatizzata. La proposta promette maggiore velocità, ma richiede nuovi consumabili, integrazione informatica, formazione e un contratto di assistenza diverso.

In otto righe indica:

- bisogno e attività interessata;
- tecnologia e comparatore;
- risultati attesi;
- rischi e qualità delle evidenze;
- impatto su persone, spazi, dati e continuità;
- costi lungo il ciclo;
- incertezze;
- condizioni di adozione e monitoraggio.

CRITERI DI CORREZIONE

La risposta è completa se non confonde velocità dichiarata con beneficio dimostrato, include l'alternativa attuale, considera consumabili e assistenza, descrive integrazione e formazione e propone un monitoraggio. Prezzo e marcatura CE, da soli, non costituiscono un HTA.

Checklist del capitolo

Prima della prova, controlla:

- [] parto dalla destinazione d'uso e non dal solo nome del prodotto;
- [] distinguo dispositivo medico e IVD;
- [] riconosco il ruolo di accessori, software, reagenti e consumabili;
- [] non confondo marcatura CE, appropriatezza, prestazione e sicurezza d'uso;

- ☐ ricostruisco il ciclo dal bisogno alla dismissione;
- ☐ distinguo consegna, installazione, accettazione e messa in servizio;
- ☐ separo controllo dell'utilizzatore, controllo di qualità e manutenzione;
- ☐ rispetto i limiti di competenza TSLB o TSRM;
- ☐ davanti a un'anomalia proteggerò, delimito, conservo, segnalo e documento;
- ☐ non attribuisco la causa prima dell'analisi;
- ☐ distinguo incidente, incidente grave, reclamo, non conformità e near miss;
- ☐ ricordo la segnalazione tempestiva e il termine massimo di dieci giorni per l'incidente grave;
- ☐ non uso il termine di dieci giorni per rinviare la sicurezza immediata;
- ☐ distinguo dispositivo-vigilanza e incident reporting interno;
- ☐ spiego l'HTA senza ridurlo a prezzo o marcatura;
- ☐ analizzo dispositivo, persona, ambiente, software, manutenzione e organizzazione;
- ☐ propongo azioni con responsabile, scadenza e indicatore;
- ☐ verifico l'efficacia con dati o re-audit;
- ☐ mantengo distinti TSLB e TSRM nei casi applicativi;
- ☐ dichiaro i limiti quando mancano modello, istruzioni, procedura o setting.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, dispositivi medici, nel testo vigente.
- Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, dispositivi medico-diagnostici in vitro, nel testo vigente.
- D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 e n. 138, adeguamento nazionale ai regolamenti MDR e IVDR.
- D.M. 31 marzo 2022, rete nazionale della dispositivo-vigilanza e relativo sistema informativo.
- D.M. 1° luglio 2025, termini e modalità di segnalazione degli incidenti con IVD.
- D.M. 1° luglio 2025, termini e modalità di segnalazione degli incidenti con dispositivi medici e prodotti dell'allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745.
- D.M. 26 settembre 1994, n. 745 e n. 746, profili professionali TSLB e TSRM.
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, sicurezza delle cure e responsabilità professionale.
- AGENAS, Programma nazionale HTA dispositivi medici 2026-2028.

Il quadro è verificato al 1° agosto 2026. Versioni consolidate dei regolamenti, disposizioni transitorie, moduli, canali di segnalazione, software, manuali, contratti, frequenze di controllo e procedure locali possono cambiare. Queste pagine preparano il ragionamento concorsuale; non sostituiscono istruzioni del fabbricante, formazione, procedura aziendale, valutazione di ingegneria clinica, controllo specialistico o decisione clinica.